Prefeitura da Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Secretaria-Executiva de Atenção Hospitalar
Coordenadoria de Urgências e Emergências
Departamento de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

SAMU 192

Manual de protocolos operacionais do SAMU 192 SÃO PAULO para as equipes de URAM, SBV e SBV-E

2026

Manual de protocolos operacionais do SAMU 192 SÃO PAULO para as equipes de URAM, SBV e SBV-E

Prefeito do Município de São Paulo
Ricardo Nunes

Secretário Municipal da Saúde
Dr. Luiz Carlos Zamarco

Secretário Adjunto da Saúde
Dr. Maurício Serpa

Chefe de Gabinete
Luiz Artur Vieira Caldeira

Secretário-Executiva de Atenção Hospitalar
Dr. José Carlos Ingrund

Coordenadora Geral do SAMU 192 São Paulo
Drª Nadia Afif Francis Wassef

2026

Manual de protocolos operacionais do SAMU 192 SÃO PAULO para as equipes de URAM, SBV e SBV-E

Equipe Técnica Responsável

Enf. Lia Midori Straceri Rosa - Coordenadora do Núcleo de Qualidade

Dra. Bárbara de Souza – Enfermeira Coordenadora do NEPP

Enf. Simone Cedano Ramos -Analista de Qualidade

Enf. Elaine Cristina dos Santos Melo Machado – Analista de Qualidade

Validação

Enf. Amanda de Ornelas Carvalho – Coordenadora de Enfermagem

Enf. Joênia Santana Moreira – Coordenadora Operacional

Dr. Mateus Domingues Miachon – Coordenador Médico do NEPP

Aprovação

Dra. Nadia Afif Francis Wassef – Coordenadora Geral do SAMU 192 São Paulo

Dr. Admilson Máximo dos Santos – Assessor Médico do SAMU 192 São Paulo

Enf. Justino Pedro da Silva – Assessor Técnico do SAMU 192 São Paulo

Colaboradores

Amanda de Fátima Portugal Rocha

Adriana Aparecida dos Santos

Adriana Carla Ferreira de Moura

Alexsandro de Paula

Aline Braga da Silva

Aline Cristina Ramos da Silva Carvalhaes

Ana Midori Harada

Andrea Christina Costa Simões

Bruno Luiz da Silva

Camila Mayumi Okiyama

Carla Cristine Andrade Bezerra

Carlos Odércio Zanquetta

Celina Hiromi Hoshino Vasconcelos

Célio Gouveia

Daiane Campos de Moraes

Daiane Marta Ferreira de Souza

Dermival Oliveira Xavier

Dumara Maria Dias Hasckel de Lima

Edson Barbosa dos Santos Junior

Eline Prisca da Silva

Fabiana Amparo Ferraz

Fabiana Lima Ribeiro

Fátima Sanchez Mesquita

Fernanda Vaz Tostes

Flávia Guedes Araújo

Francis Albert Fuji

Gabriel Martinez

Henrique Cesar Saraiva de Area Leão Costa Filho

Iraci Azarias da Silva

Ivone Fernandes Alves

Jaqueline Flor da França

Karen Cristina Pizani

Karen Gisele da Silva Guerreiro

José Caruso

Leonardo Santos da Silva

Lidinaide Maria da Costa

Lilian Maria de Oliveira

Lilian Prestes

Lucélia Fernandes dos Santos

Lucio da Silva Ferreira

Luis Cássio Carneiro Leão

Lydia dos Santos Manhães

Maíra Costa Ferreira

Maíra Peloso Bello

Marcia Cristina Leão Barreiros

Marcia Martiniano Cardoso

Marcia Rosa de Souza Lopes

Marco Antônio Barbosa Coelho

Marcus Vinícius da Rocha

Maria Carolina Tufolo

Maria Claudinéa Antunes Reis

Maria Jalva de Moraes

Marisa Aparecida Amaro Malvestio

Miriam Kelly Braga

Naiane Clara Clemento

Natália Aline da Silva

Patrícia Caroline Alves de Sousa

Raquel Jacobs de Lima

Reinaldo Cirilo dos Santos

Renan de Sousa Messias Gonçalves

Renata Santini Paulino

Rita de Cassia Gaudencio Batista

Ronaldo Batista Castelo Branco

Roselândia Souza Bezerra

Sérgio José da Silva

Sidnei Couto Silva

Simone Martins Dorna de Paula

Silvio Alves Barbosa

Thiago Quaglietta Lopes Rodrigues

Victor Bezerra de Souza

Vitor Roberto de Souza Martins

Viviane Soares de Freitas

Wanderson da Silva Rosa

Wesley Almeida Santos

Zulmira de Fatima Bismarck Asciutti

Ficha Catalográfica

São Paulo (Cidade). Secretaria da Saúde. Secretaria-Executiva de Atenção Hospitalar. Coordenadoria de Urgências e Emergências. Departamento de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Manual de protocolos operacionais do SAMU 192 São Paulo para as equipes de URAM, SBV e SBV-E / Departamento de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. - São Paulo: SMS, 2026.

700p.

1.Suporte Básico de Vida. 2.Suporte Básico de Vida com Enfermeiro. 3.Pré-hospitalar. 4.SAMU. I.Título.

INTRODUÇÃO

Este Manual constitui a 1ª edição do documento unificado que consolida os Protocolos de SBV – Suporte Básico de Vida (8ª edição) e de SIV – Suporte Intermediário de Vida (5ª edição), integrando-os em um único instrumento normativo e operacional.

A unificação decorreu da necessidade de aprimorar a organização assistencial.

A partir dessa unificação, o suporte anteriormente denominado SIV passa a ser designado como SBV-E – Suporte Básico de Vida com Enfermeiro, promovendo alinhamento conceitual e padronização terminológica.

Este Manual unificado passa a constituir referência oficial para as equipes de intervenção do SAMU 192 São Paulo, devendo nortear as práticas, condutas e fluxos de atendimento.

Sua elaboração foi fruto de muito trabalho, dedicação e compromisso do Núcleo de Qualidade e do Núcleo de Educação Permanente e Pesquisa (NEPP), contando com o apoio integral das Coordenações Médica, de Enfermagem, Operacional e da Coordenação Geral, que contribuíram ativamente para o fortalecimento deste material.

A revisão e atualização deste documento foram fundamentadas em diretrizes científicas reconhecidas, evidências atualizadas e boas práticas em saúde, garantindo respaldo técnico, segurança, orientação e padronização dos atendimentos realizados.

Este manual tem como objetivo principal oferecer suporte aos profissionais, promovendo a qualidade da assistência, a valorização do trabalho em equipe e a melhoria contínua dos serviços prestados à população, sempre com foco no cuidado humanizado, ético e responsável.

Enf. Lia Midori Straceri Rosa
Coordenadora do Núcleo de Qualidade do SAMU 192 São Paulo

Considerações Gerais do NEPP

O presente documento "Intervenções em atendimento pré-hospitalar em SBV e SBV-E" foi revisado e atualizado de forma colaborativa por profissionais altamente qualificados nas áreas de docência, pesquisa e intervenção em atendimento pré-hospitalar, a partir de discussões embasadas nas melhores práticas e fundamentadas nos protocolos e diretrizes mais atuais.

Este material contempla as normas, rotinas institucionais e procedimentos que devem ser seguidos nos atendimentos pré-hospitalares, de acordo com sua natureza: clínico, trauma, pediátrico, obstétrico ou saúde mental, com o objetivo de orientar a tomada de decisão e respaldar o profissional na prestação de uma assistência de maior qualidade, garantindo maior segurança ao munícipe.

O propósito deste protocolo é, aliado à capacitação teórico-prática periódica, fornecer subsídios aos profissionais para o reconhecimento do agravo a partir dos sinais e sintomas apresentados pela vítima, bem como para a realização das intervenções essenciais que minimizam danos e sofrimento ao paciente, contribuindo para maior resolutividade e excelência do atendimento pré hospitalar.

Os profissionais que desejarem compartilhar conhecimento ou esclarecer dúvidas podem entrar em contato conosco pelo e-mail: *samueducacao@prefeitura.sp.gov.br*.

Reafirmamos nosso compromisso com a atualização contínua e com a construção coletiva das melhores práticas em atendimento pré-hospitalar, sempre pautados pelos valores éticos, pelo profissionalismo, pelas Diretrizes do SUS e pela Política Nacional de Atenção às Urgências do Ministério da Saúde.

Prof.ª Doutora Bárbara de Souza
Núcleo de Educação Permanente e Pesquisa do SAMU192 São Paulo

Aos profissionais de Enfermagem do SAMU 192 São Paulo

Com grande satisfação, cumprimentamos a todos que compõem as equipes de Suporte Básico de Vida (SBV) e Suporte Básico de Vida com Profissional Enfermeiro (SBV-E) do SAMU 192 São Paulo. Profissionais de enfermagem fazem parte deste time tão importante, que é responsável por mais da metade de todos os atendimentos realizados pelo SAMU 192 São Paulo, que é um dos maiores serviços de Atendimento Pré-Hospitalar do mundo.

A Coordenação de Enfermagem participou ativamente da construção e consolidação desta nova versão do Protocolo de SBV e SBV-E, que traz inúmeras atualizações imprescindíveis que, além de aumentar a autonomia dos profissionais, também traz mais resolutividade em diversos tipos de atendimento e fortalece a segurança e a qualidade da assistência prestada por nossa equipe.

Sabemos que, em situações de urgência e emergência, o tempo e a conduta adequadas fazem toda a diferença, e estar preparado é um compromisso que assumimos diariamente enquanto profissionais. Por isso, este material é um apoio essencial e mais do que um conjunto de orientações técnicas, ele representa valorização profissional e é um instrumento que promove padronização, reduz riscos e reforça a atuação segura e integrada da equipe.

Reforçamos, portanto, a importância da capacitação contínua e da aplicação deste conteúdo nas rotinas de trabalho.

Contem sempre com a Coordenação de Enfermagem, pois seguimos juntos na construção deste processo de melhoria e aprendizado contínuos, atuando com empatia, competência, ética e responsabilidade.

Enf. Amanda de Ornelas
Coordenadora de Enfermagem do SAMU 192 São Paulo

Aos profissionais Condutores do SAMU 192 São Paulo

A engrenagem do SAMU 192 São Paulo é movida por mãos que dominam muito mais do que o volante. Este Manual não é apenas um guia técnico; é o reconhecimento do rigor, da agilidade e da responsabilidade que definem a missão dos nossos Condutores de Veículos de Emergência.

Em uma metrópole com os desafios geográficos e de mobilidade de São Paulo, o condutor é o primeiro estrategista da cena. Dele depende o "tempo-resposta", aquela fração de minutos que separa o desfecho favorável da fatalidade. No entanto, sua importância transcende a condução segura e a destreza no tráfego. O condutor é parte integrante e indissociável da célula de atendimento.

A integração entre o condutor e a equipe assistencial (enfermeiros, médicos, técnicos e auxiliares) é o que transforma uma ambulância em uma unidade de salvamento eficiente. No cenário de urgência, a integração manifesta-se no apoio logístico, na segurança da cena, no suporte ao manejo de equipamentos e na postura resiliente que sustenta o equilíbrio da equipe em momentos críticos.

Ser condutor no SAMU 192 São Paulo é compreender que cada curva acentuada, cada frenagem e cada escolha de rota impacta diretamente na estabilidade do paciente que luta pela vida no compartimento posterior. É ser o guardião da segurança de todos: da equipe que confia em sua perícia e do munícipe que aguarda, com esperança, pelo som da sirene.

Dedicamos nossa participação na revisão deste protocolo a vocês, profissionais que dão movimento à nossa missão. Que este documento sirva como alicerce para a excelência e como lembrete de que, sem o seu compromisso e sua integração, a corrente da sobrevivência não se completa.

Enf. Joênia Santana Moreira
Coordenadora Operacional do SAMU 192 São Paulo

Sumário

INTRODUÇÃO **6**

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS **14**

NORMAS, ROTINAS E PROCEDIMENTOS **18**

001 - PAPÉIS E RESPONSABILIDADES DA EQUIPE DE INTERVENÇÃO NO SBV E SBV-E DO SAMU192 SÃO PAULO 19

002 – RESPONSABILIDADES COMPLEMENTARES DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DA INTERVENÇÃO 33

003 – PREENCHIMENTO DA FICHA DE ATENDIMENTO PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM 39

004- RESPONSABILIDADES COMPLEMENTARES DOS CONDUTORES DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA 52

005 – REGRAS GERAIS DE CONDUÇÃO/ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA 64

006 – REGRAS DE BIOSSEGURANÇA 71

007 – AVALIAÇÃO DA CENA 75

008 - OCORRÊNCIA ENVOLVENDO PRODUTOS PERIGOSOS 79

009 – SEGURANÇA DO PACIENTE 84

010 - ACIDENTE COM A EQUIPE NA AMBULÂNCIA 96

011 - ACIDENTE DE TRABALHO COM MATERIAL BIOLÓGICO 100

012 - ACIDENTE DE TRABALHO 114

013 – ATENDIMENTO À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, CRIANÇAS E IDOSOS 121

014 – ATENDIMENTO À VÍTIMA ACOMPANHADA DE ANIMAIS (CÃO GUIA OU OUTROS) 129

015 – ABORDAGEM À VÍTIMA QUE RECUSA ATENDIMENTO E/OU ENCAMINHAMENTO PARA UNIDADE DE SAÚDE 134

016- PRONTIDÃO OPERACIONAL 139

017- AUTORIDADES NO LOCAL DA OCORRÊNCIA 147

018- ATENDIMENTO À VÍTIMA NA PRESENÇA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE EXTERNOS 150

019 – OCORRÊNCIAS COM INDÍCIO DE CRIME COM MORTE 153

020- PREENCHIMENTO DE CHECKLIST DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 158

021- REGRAS GERAIS PARA ENCAMINHAMENTO AO TRANSPORTE AEROMÉDICO 169

022 – ABORDAGEM DE EVENTOS ENVOLVENDO: ATENDIMENTO EM VIA PÚBLICA/ PRESENÇA DE IMPRENSA NA CENA/ PRESENÇA DE TUMULTO OU AGITAÇÃO SOCIAL 173

023 – EVIDÊNCIA DE MORTE ÓBVIA NO LOCAL DA OCORRÊNCIA 178

024 – PASSAGEM DE CASO PARA O MÉDICO REGULADOR 183

025 – CUIDADOS COM PERTENCES DA VÍTIMA 186
026 – TRANSIÇÃO DE CUIDADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE 190
027 – AVALIAÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DA VÍTIMA COM AGRAVO CLÍNICO 194
028 – OBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS POR CORPO ESTRANHO (OVACE) NO ADULTO 201
029 – RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR (RCP) NO ADULTO 207
030 – INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA 218
031 – EXACERBAÇÃO DA ASMA NO ADULTO 225
032 – EXACERBAÇÃO DA DPOC 232
033 – DOR TORÁCICA DE ORIGEM CARDÍACA 239
037 - CETOACIDOSE 246
038 – HIPOGLICEMIA NO ADULTO 252
039 - CRISE CONVULSIVA NO ADULTO 257
040- ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 263
042 – HIPOTERMIA 274
043 – ANAFILAXIA NO ADULTO 278
045 – AVALIAÇÃO E MANEJO DA DOR E VÔMITOS 285
046 – INTOXICAÇÕES AGUDAS 299
047 – ATENDIMENTO DA VÍTIMA DE TRAUMA 310
048 – CHOQUE HEMORRÁGICO 317
049 – TRAUMA RAQUIMEDULAR 324
050 – TRAUMA CRANIOENCEFÁLICO 331
051 – TRAUMA OCULAR 338
052 - TRAUMA DE TÓRAX 343
053 – TRAUMA ABDOMINAL 350
054 – TRAUMA MUSCULOESQUELÉTICO 356
055 – ATENDIMENTO À VÍTIMA DE QUEIMADURA 364
056 – ATENDIMENTO À VÍTIMA DE AFOGAMENTO 372
057 – OBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS POR CORPO ESTRANHO (OVACE) NA CRIANÇA 378
058 – RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR (RCP) EM PEDIATRIA 387
059 – EXACERBAÇÃO DA ASMA NO RN, NO LACTENTE E NA CRIANÇA 398
060 – ANAFILAXIA NA CRIANÇA 404
061 – DESIDRATAÇÃO NA CRIANÇA 412
062 – HIPOGLICEMIA NO RN, NO LACTENTE E NA CRIANÇA 418

063 – CRISE CONVULSIVA NA CRIANÇA 424
065 – TRABALHO DE PARTO 428
066 – ASSISTÊNCIA AO RECÉM-NASCIDO (RN) QUE NASCE BEM 441
067 – ASSISTÊNCIA AO RECÉM-NASCIDO (RN) QUE NÃO APRESENTA BOA VITALIDADE 447
068 – TRAUMA EM GESTANTE 455
069 – DOENÇA HIPERTENSIVA ESPECÍFICA DA GESTAÇÃO 461
070 – SÍNDROME HEMORRÁGICA NA GESTAÇÃO E PÓS-PARTO 468
071 – EMERGÊNCIAS PSIQUIÁTRICAS 477
072 - COMUNICAÇÃO DE ÓBITO 485
073 – LIMPEZA DE SUPERFÍCIE DA AMBULÂNCIA COM PRESENÇA DE MATERIAL BIOLÓGICO 488
074 – LIMPEZA CONCORRENTE E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIE DA AMBULÂNCIA 491
075 – LIMPEZA TERMINAL DA AMBULÂNCIA 495
076 – MANOBRA MANUAL DE ABERTURA DE VIAS AÉREAS NO TRAUMA 502
077 - MANOBRA MANUAL PARA ABERTURA DAS VIAS AÉREAS NO PACIENTE CLÍNICO 506
078 – ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES NAS VIAS AÉREAS 509
079 – TÉCNICAS PARA USO DE CÂNULA OROFARÍNGEA 516
080 – PASSAGEM DE DISPOSITIVO SUPRAGLÓTICO 523
081 – INSTALAÇÃO DO CATETER NASAL 531
082 – INSTALAÇÃO DA MÁSCARA NÃO REINALANTE COM RESERVATÓRIO 534
083 - OXIMETRIA DE PULSO 538
084 - VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS: PRESSÃO ARTERIAL 541
085 - VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS: FREQUÊNCIA CARDÍACA 545
086 - VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS: FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA 548
087 - VERIFICAÇÃO DA GLICEMIA CAPILAR 551
088 – DIMENSIONAMENTO E APLICAÇÃO DO COLAR CERVICAL 555
089 – RETIRADA DE CAPACETE NA VÍTIMA COM SUSPEITA DE TRAUMA 562
091 – CONTROLE DE HEMORRAGIA EXTERNA 568
092 – RETIRADA RÁPIDA DA VÍTIMA 578
093 – USO DO KED NA VÍTIMA DE TRAUMA 591
094 – IMOBILIZAÇÃO DA PELVE 603
096 – IMOBILIZAÇÃO DE EXTREMIDADES 610
097 – ROLAMENTO EM BLOCO 90º E 180º 620

098 – CONTENÇÃO FÍSICA E MECÂNICA 629
099 – ACESSO VENOSO PERIFÉRICO 645
100 – ACESSO VASCULAR INTRAÓSSEO 649
103 - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES COMPLEMENTARES DO CONDUTOR DA URAM 659
104 – LIMPEZA TERMINAL DA URAM 667
105 - SEGURANÇA OPERACIONAL E USO DE EPIS PARA CONDUTORES DA URAM .. 673
106 - REGRAS DE DESLOCAMENTO DA URAM 681
JUSTIFICATIVA PARA ALTERAÇÃO E EXCLUSÃO DE PROTOCOLOS OPERACIONAIS 690
GLOSSÁRIO DE TERMOS INSTITUCIONAIS 692
Atualização realizada em 10 de março de 2026: 697
VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO 698
APROVAÇÃO INSTITUCIONAL 699

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

AAS – Ácido Acetilsalicílico
AD – Água Destilada
AESP – Atividade Elétrica Sem Pulso
AHA – American Heart Association
AIT – Ataque Isquêmico Transitório
AM – Ambulância
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária
APH – Atendimento Pré-Hospitalar
AT BIO – Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico
AVE – Acidente Vascular Encefálico
AVC – Acidente Vascular Cerebral
BEFAST – Balance, Eyes, Face, Arms, Speech, Time
BPM – Batimentos por Minuto
BVM – Bolsa-Válvula-Máscara
CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho
CET – Companhia de Engenharia de Tráfego
CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
CM – Centímetros
CMH2O – Centímetros de Água
CME – Central de Material e Esterilização
CNH – Carteira Nacional de Habilitação
COF – Cânula Orofaríngea
COFEN – Conselho Federal de Enfermagem
COGESS – Coordenadoria de Gestão de Saúde do Servidor
COMGÁS – Companhia de Gás de São Paulo
CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito
CORE – Coordenação Regional de Enfermagem
COREN – Conselho Regional de Enfermagem
COVISA – Coordenadoria de Vigilância em Saúde
CRM – Conselho Regional de Medicina
CRU – Central de Regulação de Urgências
CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento
CTB – Código de Trânsito Brasileiro
CTVE – Capacitação para Condutores de Veículo de Emergência
COVID-19 – Coronavirus Disease 2019
DDH – Decúbito Dorsal Horizontal
DEA – Desfibrilador Externo Automático
DLE – Decúbito Lateral Esquerdo
DM – Diabetes Mellitus
DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
DPP – Data Provável de Parto
DUM – Data da Última Menstruação

ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente
END – Escala Numérica de Dor
ENEL – Entidade Nacional de Energia Elétrica
EPI – Equipamento de Proteção Individual
EVA – Escala Visual Analógica
EV – Endovenoso
FC – Frequência Cardíaca
FR – Frequência Respiratória
FV – Fibrilação Ventricular
G – Grama
GCM – Guarda Civil Metropolitana
GPS – Global Positioning System
GRAU – Grupo de Resgate e Atendimento às Urgências
GTS – Gotas
HIV – Vírus da Imunodeficiência Humana
HT – Handie-Talkie
IAM – Infarto Agudo do Miocárdio
IAPH – Intervenções em Atendimento Pré-Hospitalar
IM – Intramuscular
IML – Instituto Médico Legal
IO – Intraóssea
IOT – Intubação Orotraqueal
KG – Quilograma
KED – Kendrick Extrication Device
MCG – Microgramas
MG – Miligramas
MG/DL – Miligramas por Decilitro
MG/KG – Miligramas por Quilo
MG/ML – Miligramas por Mililitro
ML – Mililitros
ML/H – Mililitros por Hora
ML/HORA – Mililitros por Hora
ML/KG – Mililitros por Quilo
MMHG – Milímetros de Mercúrio
MMII – Membros Inferiores
MMSS – Membros Superiores
MR – Médico Regulador
MRPM – Movimentos Respiratórios por Minuto
MS – Ministério da Saúde
NEPP – Núcleo de Educação Permanente e Pesquisa
NR – Norma Regulamentadora
OMS – Organização Mundial da Saúde
ONU – Organização das Nações Unidas
OS – Organização Social

OVACE – Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho
PA – Pressão Arterial
PAD – Pressão Arterial Diastólica
PAINAD – Pain Assessment in Advanced Dementia
PALS – Pediatric Advanced Life Support
PAS – Pressão Arterial Sistólica
PCR – Parada Cardiorrespiratória
PMV – Para Manter Veia
POP – Procedimento/Protocolo Operacional Padrão
PPR – Pausa para Refeição
PR – Parada Respiratória
PVPI – Polivinil Pirrolidona Iodo
RCE – Retorno da Circulação Espontânea
RCP – Ressuscitação Cardiopulmonar
RF – Registro Funcional
RH – Recursos Humanos
RN – Recém-Nascido
SAE – Sistematização da Assistência de Enfermagem
SAE IST/AIDS – Serviço de Atendimento Especializado em IST/AIDS
SAMU 192 – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
SAV – Suporte Avançado de Vida
SBV – Suporte Básico de Vida
SBV-E – Suporte Básico de Vida com Enfermeiro
SCQ – Superfície Corporal Queimada
SF – Solução Fisiológica
SHPP – Síndrome Hemorrágica Pós-Parto
SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação
SpO2 – Saturação Periférica de Oxigênio
SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
STA – Supervisão Técnica Administrativa
STO – Supervisão Técnica Operacional
TCE – Traumatismo Cranioencefálico
TOT – Tubo Orotraqueal
TVSP – Taquicardia Ventricular Sem Pulso
URAM – Unidade Rápida de Atendimento por Motocicletas
VA – Via Aérea
VAS – Vias Aéreas
VIR – Veículo de Intervenção Rápida
VNI – Ventilação Não Invasiva
VPM – Ventilações por Minuto
VPP – Ventilação com Pressão Positiva

Atualização realizada em 10 de março de 2026:

Foram incluídas observações referentes à administração de medicamentos sujeitos a controle especial, conforme regulamentação da Portaria nº 344/1998, nos seguintes protocolos assistenciais:

- 039 – Crise convulsiva no adulto
- 045 – Avaliação e manejo da dor e vômitos
- 046 – Intoxicações agudas

Adicionalmente, foram incluídas orientações referentes à administração de sulfato de magnésio e ao uso de gluconato de cálcio como antídoto, no protocolo:

- 069 – Doença hipertensiva específica da gestação

MANUAL DE PROTOCOLOS OPERACIONAIS DO SAMU 192 SÃO PAULO PARA AS EQUIPES DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA, SUPORTE BÁSICO DE VIDA COM ENFERMEIRO E URAM

NORMAS, ROTINAS E PROCEDIMENTOS

1. DEFINIÇÃO

1.1. Papéis e responsabilidades: atribuições descritas de maneira clara e organizada que servem de base para nortear a equipe na execução de suas atividades no atendimento do SBV e SBV-E;

2. OBJETIVO

2.1. Descrever as ações que deverão ser exercidas pelos profissionais de enfermagem e condutores que constituem as equipes do SAMU 192 São Paulo.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e CRU.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

Aspectos gerais de conduta pessoal:

4.1. Cumprir com pontualidade e assiduidade a escala de trabalho;

4.1.1. Quando necessária entrada tardia, saída antecipada ou ausências para consultas e exames, a chefia imediata deverá ser comunicada com no mínimo 24 horas de antecedência;

4.2. Permanecer de prontidão atendendo aos chamados com presteza e agilidade;

4.3. Manter-se continuamente atualizado, acompanhando e aplicando as recomendações contidas nas publicações científicas pertinentes à área de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), bem como observando e cumprindo rigorosamente os protocolos e diretrizes institucionais vigentes;

4.3.1. É obrigatória a recertificação periódica dos cursos obrigatórios conforme programação do NEPP;

4.4. Apresentar-se e dar QAP uniformizado (POP Central de Regulação e Intervenção 6-013- Intervenção- Uso de Equipamento de Proteção Individual EPI);

4.4.1. Uniforme completo e padronizado fornecido pela instituição;

4.4.2. Manter-se uniformizado durante todo o período de trabalho;

4.4.3. Seguir NR 32 no tocante à proibição no uso de adornos (cabelos soltos, unhas longas, brincos grandes, relógios, anéis, pulseiras e correntes, crachá com cordão de pescoço);

4.5. Adequar hábitos e asseio pessoais, linguagem e atitude ao ambiente de trabalho;

4.6. Não portar armas brancas ou de fogo durante o horário de trabalho;

4.7. Não fumar, nem permitir que fumem dentro da base e/ou dentro da AM conforme legislação federal;

4.8. Não é permitido consumir alimentos e bebidas (exceto água) dentro da ambulância;

4.9. Zelar pelo cumprimento do protocolo institucional, Estatuto do Funcionalismo Público Municipal ou demais normas trabalhistas aplicáveis;

4.10. Relacionar-se de forma ética com os diferentes profissionais envolvidos no atendimento;

4.11. Tratar com urbanidade o cidadão e demais membros da equipe;

4.12. Proibido fazer registros e/ou compartilhar imagens (foto e/ou vídeo) de pacientes ou acompanhantes;

4.13. Zelar pela imagem do serviço;

4.14. Utilizar o "Alfabeto Fonético" (Anexo 7.1) e "Código Q" (Anexo7.2) na comunicação com a CRU;

Aspectos operacionais

4.15. O profissional do SAMU poderá ser remanejado de base para cumprimento da sua carga horária, conforme necessidade de serviço, respeitando o horário de início e término de seu plantão, conforme previsto em Portaria nº 598/2019 SMS (POP Central de Regulação e Intervenção 6-003- Intervenção- Remanejamento de Pessoal para Composição de Equipe);

4.15.1. Por necessidade do serviço, o profissional poderá ser escalado em base diferente da sua unidade de lotação;

4.16. O condutor escalado em uma AM sem Enfermagem poderá realizar o transporte de um profissional de outra base no início e/ou final do plantão, segundo a determinação do CORE;

Atuação da equipe na base operacional

4.17. Dar QAP individualmente (nome completo e RF) para a CRU no início do plantão;

4.17.1. Em casos de plantão de 24 horas, a equipe deverá informar novo QAP no intervalo de 12 horas;

4.18. Permanecer durante o plantão com os dispositivos de comunicação disponibilizados pela instituição ligados, carregados, audíveis e em funcionamento (HT, rádio fixo da base, tablet e celular);

4.19. A passagem de plantão entre as equipes é obrigatória e deve ser feita por rendição, na viatura, para evitar a descontinuidade do trabalho, e verificar as condições de materiais e equipamentos;

4.19.1. O profissional somente poderá se ausentar do plantão sem rendição com anuência prévia do CORE;

4.20. Realizar o Checklist dos insumos utilizando o impresso padronizado e seguindo orientações em protocolo: POP IAPH SBV E SBV-E 020 – Preenchimento de Checklist de Materiais e Medicamentos;

4.21. Realizar a limpeza concorrente e terminal da AM, motos e dos equipamentos conforme protocolos específicos (POP IAPH SBV E SBV-E 75 e 104 – Limpeza terminal da ambulância e da URAM);

4.22. Zelar pela ordem da base operacional.

Atuação da equipe no recebimento do chamado

4.23. Receber, anotar o chamado e comunicar imediatamente demais membros da equipe (qualquer integrante da equipe);

4.24. Atentar-se para as informações relacionadas à vítima;

4.25. A CRU informará: endereço, queixa principal, nome da vítima e idade;

4.25.1. Informações adicionais e questionamentos poderão ser passadas pelos radio operadores durante o trajeto, para favorecer a prontidão e tempo resposta

4.26. O tempo para saída da base após a recepção do chamado deve ser imediato.

Atuação da equipe na cena do atendimento

Toda a Equipe no atendimento à vítima

4.27. Avaliar segurança da cena;

4.28. Apresentar-se como profissional do SAMU 192;

4.29. Utilizar EPI (POP Central de Regulação e Intervenção 6-013 Uso de Equipamento de Proteção Individual) durante todo o atendimento;

4.30. Manter o controle da situação, estabelecendo prioridades;

4.31. Apoiar, orientar e acalmar familiar/acompanhante da vítima;

4.32. Contactar MR, reportando o caso e seguindo as orientações determinadas.

Condutor

4.33. Garantir a segurança da equipe, circundantes e da vítima;

4.34. Acompanhar e auxiliar a equipe de saúde durante todo o atendimento a vítima;

4.35. E demais funções descritas em POP IAPH SBV E SBV-E 004 – Responsabilidades complementares dos condutores de veículo de emergência.

Equipe de enfermagem

4.36. Avaliar a vítima e realizar as intervenções necessárias previstas em protocolo, dentro dos limites ético profissionais;

4.37. E demais intervenções previstas em protocolos relacionados (SBV e SBV-E).

Atuação da equipe durante o transporte da vítima até a unidade de saúde

Condutor

4.38. Transportar a vítima de forma segura, com cinto de segurança da maca afivelados, para a unidade de saúde determinada pelo MR;

4.39. Utilizar e exigir a utilização do cinto de segurança a todos os tripulantes;

4.40. Transportar o acompanhante no banco da frente.

Equipe de enfermagem

4.41. Permanecer no salão da AM durante o transporte, garantindo a continuidade da assistência;

4.42. Manter o cinto de segurança afivelado durante o trajeto;

4.43. Preencher todos os campos, assinar e carimbar a ficha de atendimento em duas vias com letra legível;

4.43.1. O uso do carimbo é obrigatório, pessoal e intransferível.

Atuação da equipe na unidade de saúde

Equipe de enfermagem

4.44. Informar à equipe da unidade de saúde: tipo de ocorrência, condições da vítima e os procedimentos realizados;

Toda a equipe

4.45. Transmitir ao rádio operador os dados referentes ao atendimento, utilizando o recurso de comunicação portátil disponível;

4.46. Realizar a limpeza concorrente da AM na unidade de saúde precocemente;

4.47. Comunicar à CRU sua disponibilidade, imediatamente após o término da limpeza;

4.48. Se necessário repor materiais para novas ocorrências, comunicar ao CORE previamente;

4.49. Informar ao CORE sobre qualquer intercorrência relacionada ao equipamento (maca retida), e seguir orientações POP Central de Regulação e Intervenção 6-002 – Intervenção – Maca oficial retida em unidade de saúde.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. No transporte, o número de acompanhantes está condicionado ao número de cintos de segurança da AM;

5.2. O paciente deverá ser acomodado e transportado em decúbito horizontal, salvo quando essa posição puder acarretar agravamento do quadro clínico ou for contraindicado;

5.3. Se houver mais de uma vítima na cena, comunicar o MR e solicitar apoio;

5.4. A ambulância não deverá deixar o local da ocorrência sem a autorização do MR, até a chegada da equipe de apoio, de modo a garantir que nenhuma vítima permaneça sozinha na cena;

5.5. Em casos de múltiplas vítimas seguir o Plano de Assistência Médica a Eventos com Múltiplas Vítimas e Desastres do SAMU 192 da Cidade de São Paulo, disponível no site da prefeitura: *https://prefeitura.sp.gov.br/web/saude/w/documentos-tecnicos-samu-192;*

5.6. O transporte de acompanhantes deverá seguir as orientações do POP Central de Regulação e Intervenção 6-009 – Transporte de Acompanhante de Paciente;

5.7. As orientações de PPR devem seguir instruções POP Central de Regulação e Intervenção 6-004 Intervenção- Pausa para Refeição;

5.8. Fica expressamente vedado, em qualquer hipótese, a todos os profissionais do SAMU192 São Paulo o registro, divulgação ou compartilhamento de imagens, vídeos ou qualquer informação que permita a identificação de pacientes, colaboradores ou ambientes assistenciais. Tal conduta constitui infração à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), que protege o direito à privacidade e à confidencialidade das informações pessoais e sensíveis, e à Resolução COFEN nº 554/2017, a qual estabelece, em seu Art. 4º, ser proibido expor imagens de pacientes em redes sociais, aplicativos de mensagens ou outros grupos sociais, bem como divulgar imagens da face ou do corpo que não tenham finalidade acadêmica, previamente autorizada e com respeito ao sigilo profissional.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP Central de Regulação e Intervenção 6-002 Intervenção- Maca Retida em Unidade de Saúde;

6.2. POP Central de Regulação e Intervenção 6-004 Intervenção- Pausa para Refeição;

6.3. POP Central de Regulação e Intervenção 6-003 Intervenção- Remanejamento de Pessoal para Composição de Equipe;

6.4. POP IAPH SBE E SBV-E 020 – Preenchimento de Checklist de Materiais e Medicamentos.

6.5. POP Central de Regulação e Intervenção 6-013- Intervenção- Uso de Equipamento de Proteção Individual EPI;

6.6. POP Central de Regulação e Intervenção 6-003- Intervenção- Remanejamento de Pessoal para Composição de Equipe);

6.7. POP IAPH SBV E SBV-E 75 – Limpeza terminal da ambulância;

6.8. POP IAPH SBV E SBV-E 104 – Limpeza terminal da URAM;

6.9. POP Central de Regulação e Intervenção 6-009 – Transporte de Acompanhante de Paciente.

7. ANEXOS –

7.1. Alfabeto Fonético

ALFABETO FONÉTICO		
LETRA	**PALAVRA**	**PRONÚNCIA**
A	ALFA	AL-FA
B	BRAVO	BRA-VO
C	CHARLIE	CHAR-LI
D	DELTA	DEL-TA
E	ECHO	E-CO
F	FOXTROT	FOX-TROT
G	GOLF	GOLF
H	HOTEL	O-TEL
I	INDIA	IN-DIA
J	JULIET	DJU-LIET
K	KILO	KI-LO
L	LIMA	LI-MA
M	MIKE	MAIK
N	NOVEMBER	NO-VEM-BER
O	OSCAR	OS-CAR
P	PAPA	PA-PA
Q	QUEBEC	QUE-BEC
R	ROMEU	RO-MEU
S	SIERRA	SI-E-RRA
T	TANGO	TAN-GO
U	UNIFORM	IU-NI-FORM
V	VICTOR	VIC-TOR
W	WHISKEY	UIS-QUI
X	X-RAY	EKS-RAY
Y	YANKEE	IAN-QUE
Z	ZULU	ZU-LU

7.2. Código Q mais utilizados

CÓDIGO Q	
QSL	ENTENDIDO
QAP	NA ESCUTA
QRV	ESPERANDO RESPOSTA; AS ORDENS
QRA	NOME
QRT	FORA DO AR
QTA	CANCELAR MENSAGEM
QAR	DESLIGAR
QRX	ESPERE; ESTOU FIXOEM UM LOCAL
QSM	RESPETIR MENSAGEM
QSO	CONVERSA; CONTATO ENTRE OPERADORES
QSP	PONTE, RECADO

QTC	MENSAGEM PRIORITÁRIA; MENSAGEM
QTH	LOCAL; ENDEREÇO
QTR	HORA EXATA
QTU	HORA
QRL	OCUPADO
QRU	PROBLEMA
QRN	INTERFERÊNCIA
QRM	INTERFERÊNCIA HUMANA
QRZ	FALA QUEM CHAMOU
QSA	COMO ESTÁ RECEBENDO?
QSV	VIATURA
QSD	MOTORISTA
QSJ	DINHEIRO

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 2048, de 5 de novembro de 2002. Aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. Diário Oficial da União, Brasília, 12 nov. 2002. Seção 1, p. 32-54.

9.2. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 1010, de 21 de maio de 2012. Redefine as diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 98, v. 1, p. 34-36, 22 maio 2012.

9.3. CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (Brasil). Resolução COFEN nº 554, de 17 de maio de 2017. Atualiza norma para uso das redes sociais pelos profissionais de enfermagem. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 102, p. 130, 30 maio 2017. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-05542017_52030.html. Acesso em: 27 ago. 2025.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Alteração e padronização do nome do protocolo 2. Unificação dos protocolos de SBV e SIV 3. Atualização do escopo e do público-alvo 4. Reorganização da definição, objetivos e estrutura do documento 5. Padronização das normas de conduta pessoal 6. Atualização dos aspectos operacionais 7. Padronização de QAP e passagem de plantão 8. Atualização dos procedimentos de checklist 9. Reorganização das responsabilidades na cena, transporte e unidade de saúde 10. Inclusão e vinculação a POPs institucionais vigentes 11. Reforço das diretrizes legais e éticas 12. Atualização das observações e recomendações

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cássia Oliveira Lopes	Daiane M. F. Souza Simone Dorna Elaine C. S. M. Machado Fernanda Vaz Tostes Sérgio José da Silva Marcia C. Leão Barreiros	Amanda de Ornelas Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. Responsabilidades complementares: as atribuições específicas descritas servem de base para nortear a equipe de enfermagem na execução de suas atividades no atendimento do SBV e SBV-E;

1.2. Unidade de Suporte Básico de Vida Terrestre - SBV: tripulada por no mínimo 2 (dois) profissionais, sendo um condutor de veículo de urgência e um técnico ou auxiliar de enfermagem;

1.3. Unidade de Suporte Básico de Vida com Enfermeiro (SBV-E): tripulada por 1 enfermeiro acompanhado por um técnico ou auxiliar de enfermagem, além de condutor de veículo de urgência.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever as responsabilidades complementares da equipe de enfermagem que compõe as equipes de Suporte Básico de Vida, Suporte Básico de Vida com Enfermeiro e Suporte Avançado de Vida.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, SAV, URAM e CRU.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

Ao enfermeiro, adicionalmente a NR SAMU192 SP 001, segundo Portaria MS 2048/2002 e resoluções COFEN relacionadas, compete:

Ao enfermeiro:

4.1. O enfermeiro é responsável por todos os membros da equipe de enfermagem de sua base durante o plantão;

4.2. Supervisionar, auxiliar e avaliar as ações de enfermagem da equipe no Atendimento Pré-hospitalar Móvel, sendo o enfermeiro responsável pela vítima quando o atendimento for iniciado pelo SBV;

4.3. O enfermeiro deverá acompanhar a equipe de SBV até a unidade de saúde sempre que necessário;

4.4. Executar prescrições médicas por telemedicina conforme protocolos institucionais;

4.4.1. Resolução COFEN nº 689 de 03 de fevereiro de 2022, que normatiza a atuação da equipe de enfermagem no cumprimento de prescrições a distância, através de meios eletrônicos;

4.5. Prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves e com risco de vida, que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas;

4.6. Prestar a assistência de enfermagem à gestante, a parturiente e ao recém-nascido;

4.7. Realizar partos;

4.8. Participar nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde em urgências, particularmente nos programas de educação continuada;

4.8.1. É obrigatória a recertificação periódica dos cursos obrigatórios conforme programação do NEPP;

4.9. Identificar e informar ao interlocutor sobre as necessidades de educação continuada da equipe;

Ao técnico e auxiliar de enfermagem:

4.10. Prestar cuidados diretos de enfermagem a vítima grave, sob supervisão direta (SBV-E/SAV) ou à distância do profissional enfermeiro (CORE);

4.11. Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro;

4.12. Participar de programas de treinamento e aprimoramento profissional em urgências/emergências;

4.13. Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação;

4.14. Ministrar medicamentos por via oral e parenteral mediante prescrição do MR e protocolo institucional;

4.15. Realizar limpeza e cobertura em feridas;

4.16. Aplicar oxigenioterapia;

4.17. Realizar teste de glicemia capilar e proceder à sua leitura;

4.18. Prestar cuidados de conforto a vítima e zelar por sua segurança;

4.19. Realizar manobras de extração manual de vítimas;

4.20. Alternar padrão sonoro da sirene de acordo com a gravidade da vítima;

4.21. Auxiliar o condutor na localização do endereço da ocorrência S/N;

4.22. Realizar atendimento a família da vítima em morte óbvia.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não há.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. NR001, resoluções, portaria 2048 e Protocolos Operacionais Padrão.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 2048, de 5 de novembro de 2002. Aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. Diário Oficial da União, Brasília, 12 nov. 2002. Seção 1, p. 32-54.

9.2. CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (Brasil). Resolução COFEN nº 713, de 4 de novembro de 2022. Atualiza a norma de atuação dos profissionais de enfermagem no Atendimento Pré-hospitalar (APH) móvel terrestre e aquaviário, quer seja na assistência direta, no

gerenciamento e/ou na CRU, em serviços públicos e privados, civis e militares. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 9 nov. 2022.

9.3. CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). Resolução nº 487, de 25 de agosto de 2015. Veda aos profissionais de enfermagem o cumprimento da prescrição médica à distância, exceto em situações de urgência e emergência. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2015.;

9.4. CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). Resolução nº 655, de 12 de março de 2020. Normatiza a atuação da enfermagem na prescrição e cumprimento de prescrições à distância no atendimento pré-hospitalar. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2020.

9.5. CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). Resolução nº 688, de 16 de junho de 2022. Atualiza normas sobre o cumprimento de prescrições à distância pelos profissionais de enfermagem. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2022.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
06	02/02/2026	Atualização 1. Atualização e padronização do nome e das definições 2. Adequação do escopo para o modelo SIV, para Suporte Básico com Enfermeiro (SBV-E) 3. Revisão das áreas envolvidas 4. Atualização do objetivo do protocolo 5. Reorganização e detalhamento das responsabilidades do enfermeiro 6. Atualização das referências normativas (Portaria MS 2048/2002 e resoluções COFEN vigentes) 7. Atualização das regras para execução de prescrições médicas por telemedicina 8. Ampliação e padronização das atribuições assistenciais 9. Inclusão de responsabilidades relacionadas à gestão da equipe e educação continuada 10. Atualização das competências técnicas conforme resoluções COFEN recentes

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cássia Oliveira Lopes	Daiane M. F. Souza Simone Dorna Edson Barbosa S. Junior Rita de Cassia G. Batista Maria Carolina Tufolo Maira Peloso Bello Miriam Kelly Braga	Amanda de Ornelas Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE): metodologia utilizada para planejar, executar e avaliar o cuidado, constituindo ferramenta fundamental do trabalho do enfermeiro (Chaves & Solai, 2013).

1.1.1. Segundo a Resolução COFEN nº 358/2009, para a realização da SAE deve-se adotar um método científico que fundamente o cuidado, baseado em teorias e no Processo de Enfermagem;

1.1.2. De acordo com os níveis de atenção à saúde, o SAMU 192 São Paulo está inserido no nível secundário, cujo foco assistencial é o tratamento. Dessa forma, a teoria que norteará a conduta de atendimento será a das Necessidades Humanas Básicas, proposta por Wanda Horta.

1.1.3. O artigo 2º da Resolução COFEN nº 358/2009 estabelece que o Processo de Enfermagem se organiza em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes: coleta de dados de enfermagem (ou histórico de enfermagem), diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem. Esse processo deve ser descrito por meio de uma determinada taxonomia.

1.1.4. O SBV-E do SAMU 192 São Paulo realizará o Processo de Enfermagem conforme as etapas descritas acima, utilizando instrumento específico elaborado pela Coordenação de

Enfermagem vigente, assegurando uma assistência respaldada em conhecimento científico e pensamento crítico, com uso da taxonomia segundo a CIPE, 2019;

1.2. Ficha de atendimento em SBV: quando em suporte básico de vida, o profissional utiliza a ficha de atendimento exposta em anexo 1. Com todas as etapas essenciais ao profissional de nível médio.

2. OBJETIVOS

2.1. Descrever para a enfermagem como será realizado a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) no SAMU 192 São Paulo, através da apresentação da ficha e o manual para sua utilização.

2.2. Essa orientação visa descrever os campos disponíveis para o registro das ações realizadas pela equipe de enfermagem, os conceitos associados e nortear o preenchimento de acordo com raciocínio lógico.

3. EQUIPES ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, SAV e URAM.

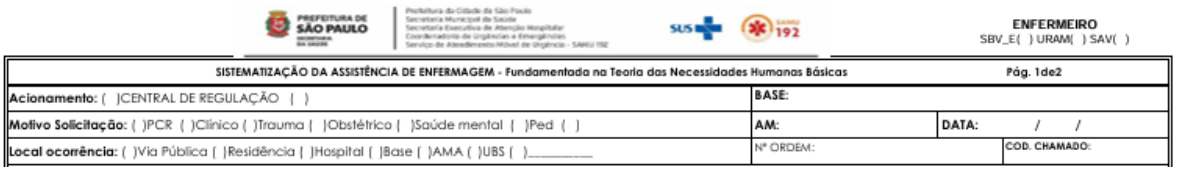
4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Há dois modelos de impressos: um para profissionais de nível médio (auxiliares e técnicos) e outro para equipe que será composta por profissional enfermeiro.

DESCRIÇÃO PARA PREENCHIMENTO

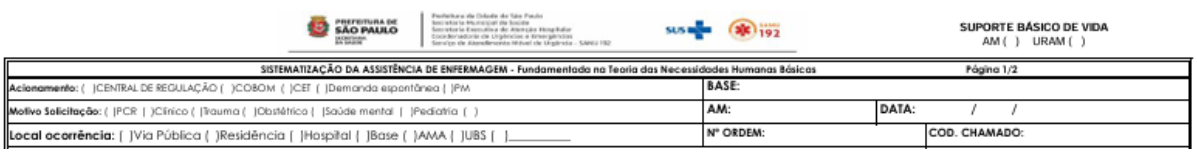
Cabeçalho da ficha

Modalidade e descrição da ocorrência



ENFERMEIRO
SBV_E( ) URAM( ) SAV( )

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM - Fundamentada na Teoria das Necessidades Humanas Básicas		Pág. 1de2
Acionamento: ( )CENTRAL DE REGULAÇÃO ( )	**BASE:**	
Motivo Solicitação: ( )PCR ( )Clínico ( )Trauma ( )Obstétrico ( )Saúde mental ( )Ped ( )	**AM:**	**DATA:** / /
Local ocorrência: ( )Via Pública ( )Residência ( )Hospital ( )Base ( )AMA ( )UBS ( )_____	**Nº ORDEM:**	**COD. CHAMADO:**



SUPORTE BÁSICO DE VIDA
AM ( ) URAM ( )

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM - Fundamentada na Teoria das Necessidades Humanas Básicas			Página 1/2
Acionamento: ( )CENTRAL DE REGULAÇÃO ( )COBOM ( )CET ( )Demanda espontânea ( )PM	**BASE:**		
Motivo Solicitação: ( )PCR ( )Clínico ( )Trauma ( )Obstétrico ( )Saúde mental ( )Pediatria ( )	**AM:**	**DATA:** / /	
Local ocorrência: ( )Via Pública ( )Residência ( )Hospital ( )Base ( )AMA ( )UBS ( )_____	**Nº ORDEM:**	**COD. CHAMADO:**	

4.2. A 1ª linha deve ser preenchida pela equipe conforme a modalidade de atendimento em que atua, garantindo que as condutas estejam compatíveis com essa modalidade. Conforme a Resolução COFEN nº 358/2009, a SAE deve conter data, tornando esse campo de preenchimento obrigatório;

4.3. No quadro destacado, deve-se registrar o numeral de ordem (respaldo legal da saída da ambulância), contendo no mínimo os seis últimos dígitos da ocorrência, além da base em que o enfermeiro está lotado e o prefixo da ambulância;

4.4. O código do chamado ou a queixa principal também deve ser registrado (ex.: quase desmaio ou 31), sendo essa informação essencial, pois o início do chamado será validado apenas ao final, quando o profissional descrever o motivo definitivo da ocorrência;

4.5. Na 3ª linha deve-se registrar o meio de acionamento e, na 4ª, o tipo de atendimento: PCR, Clínico, Trauma, Obstétrico, Saúde Mental, Pediatria ou outro;

4.6. Tipo de chamado: deve ser assinalado conforme o atendimento realizado no local, independentemente da informação inicial da Central de Operações (ex.: clínico/pediátrico);

4.7. A SAE será aplicada conforme o tipo de ocorrência, estando dividida em quatro categorias:

4.7.1. Traumático;

4.7.2. PCR;

4.7.3. Obstétrico e RN;

4.7.4. Não traumático (clínico, psiquiátrico, pediátrico).

4.8. Nos atendimentos clínicos, assinalar "não se aplica" nos demais tipos. Recomenda-se registrar ao final da ocorrência todos os atendimentos efetivamente realizados, considerando que, por exemplo, um caso clínico pode evoluir para PCR.

Respaldados pela Teoria das Necessidades Humanas Básicas, a Sistematização utilizada no SAMU192 São Paulo será realizada através da avaliação primária e secundária, de acordo com a especificidade do serviço de APH.

Avaliação Primária – Mnemônico XABCDE/ABCDE

4.9. Seguir a divisão apresentada na ficha:

4.9.1. Lado esquerdo: problemas relacionados a cada foco de prioridade;

4.9.2. Lado direito: intervenções correspondentes, incluindo abordagens medicamentosas previstas em protocolos específicos;

4.9.3. Na ficha específica do enfermeiro, no rodapé da página: Diagnósticos de Enfermagem relacionados aos problemas identificados;

4.9.4. Caso não haja alterações em determinado segmento, assinalar "sem anormalidades".

Uso de Medicações

4.10. As medicações descritas na ficha estão contempladas neste protocolo de Intervenções em Atendimento Pré-hospitalar;

4.11. Quando em modalidade SAV, o enfermeiro poderá registrar novos itens nos campos de preenchimento manual.

Responsabilidades da Equipe

4.12. Técnicos/auxiliares de enfermagem podem realizar intervenções medicamentosas descritas no protocolo sob solicitação do enfermeiro e/ou após autorização do médico regulador;

4.13. Essas ações devem ser registradas na ficha da SAE, que será assinada conjuntamente pelo enfermeiro e pelo técnico/auxiliar;

4.14. Algumas escalas foram colocadas para auxiliar a equipe na verificação precisa do nível de consciência (Escala de Glasgow, BEFAST, Apgar).

Avaliação Secundária

4.15. Realizar e registrar a avaliação secundária;

4.16. Registrar sinais vitais e aplicar a entrevista SAMPLER;

4.17. Caso necessário, utilizar o espaço "Anotações de Enfermagem" para outras informações relevantes;

4.18. Sinais vitais coletados na chegada à Unidade de Saúde também devem ser registrados nesse campo.

4.19. Todas as intervenções listadas correspondem à modalidade SBV-E; em modalidade SAV, descrever condutas específicas adicionais.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. A SAE deverá ser feita em duas vias, sendo que a via carbonada fica com a Unidade de Saúde.

5.2. Em qualquer modalidade que o enfermeiro estiver (SBV, SBV-E, SAV, URAM) deverá ser preenchida pela equipe apenas a ficha com descrição "ENFERMEIRO" no cabeçalho.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

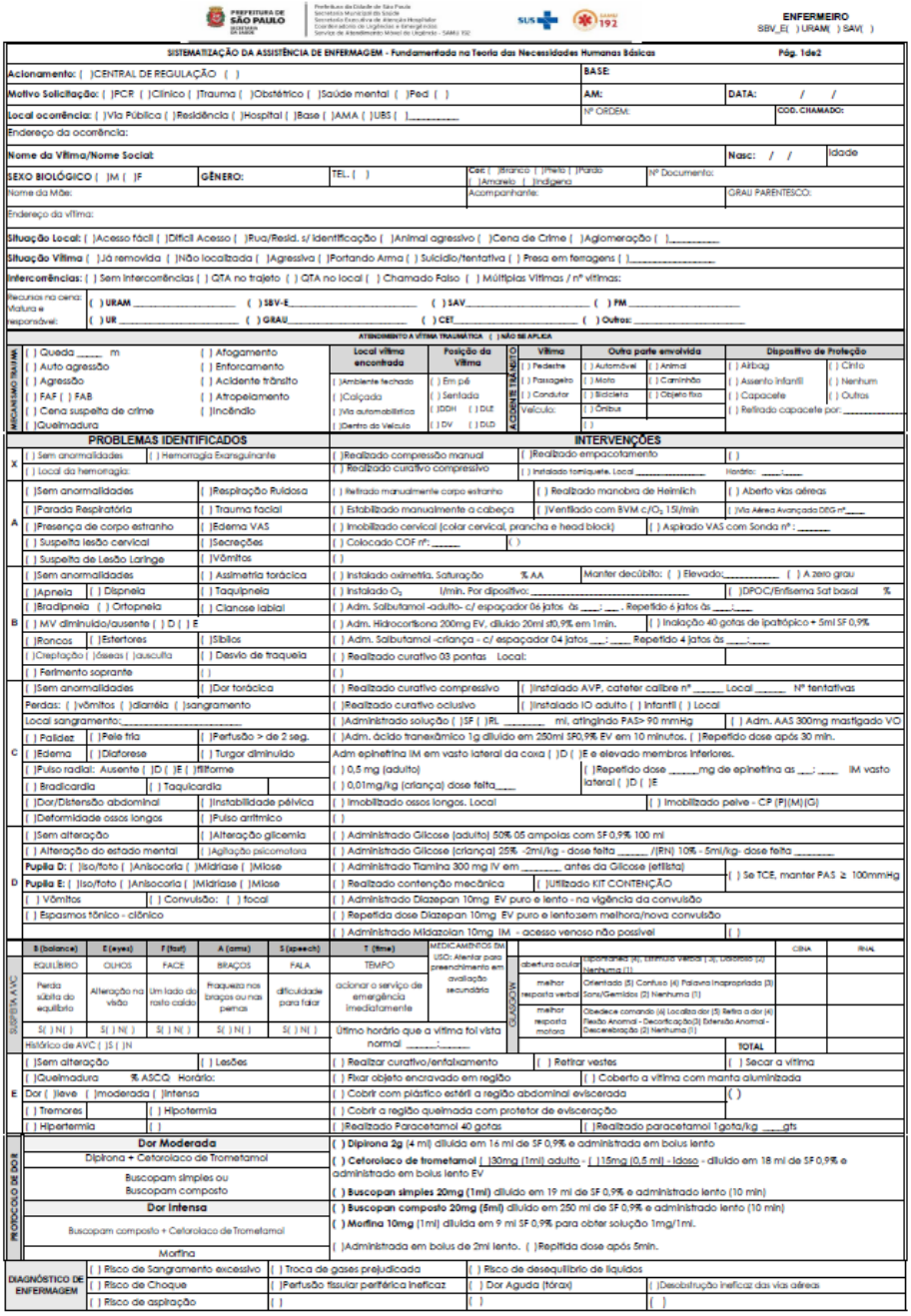
6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. ABREVIATURAS PRESENTES NA FICHA DA SAE

ADM	Administrar.	DV	Decúbito Ventral.	PA	Pressão Arterial.
AMA	Assistência Médica Ambulatorial	E	Esquerdo.	PAS	Pressão Arterial Sistólica.
AM	Ambulância.	EV	Endovenoso.	PC	Parto Cesárea.
ASCQ	Área da Superfície Corpórea Queimada.	FAB	Ferimento Arma Branca.	PCR	Parada Cardiorrespiratória
AVP	Acesso Venoso Periférico.	FAF	Ferimento Arma de Fogo.	PM	Polícia Militar.
AVC	Acidente Vascular Cerebral.	FC	Frequência Cardíaca.	PMV	Para Manter Veia.
BPM	Batimentos por Minuto.	FR	Frequência Respiratória.	QTA	Cancele a Última Mensagem.
BVM	Bolsa-Válvula-Máscara.	GRAU	Grupo de Resgate e Atendimento à Urgências.	RL	Ringer Lactato.
CET	Companhia de Engenharia de Tráfego.	IG	idade gestacional.	RN	Recém-Nascido.
COBOM	Corpo de Bombeiro.	IM	Intramuscular.	SAE	Sistematização da Assistência de Enfermagem.
COF	Cânula Orofaríngea.	IO	Intraóssea.	Sat. O2	Saturação de Oxigênio.
D	Direito.	MID	Membro Inferior Direito.	SAV	Suporte Avançado de Vida.
DDH	Decúbito Dorsal Horizontal.	MIE	Membro Inferior Esquerdo.	SF	Soro Fisiológico.
DEA	Desfibrilador Externo automático.	MMII	Membros Inferiores.	SIV	Suporte Intermediário de Vida.
DEG	Dispositivo Extra-Glótico.	MMSS	Membros Superiores.	TCE	Traumatismo Cranioencefálico.
DLD	Decúbito Lateral Direito.	MNR	Máscara Não-Reinalante.	Transp	Transporte.
DLE	Decúbito Lateral Esquerdo.	MSD	Membro Superior Direito.	UBS	Unidade Básica de Saúde
DN	Data de Nascimento.	MSE	Membro Superior Esquerdo.	URAM	Unidade Rápida de Atendimento de
DPOC	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.	NSA	Não se Aplica.	UR	Unidade de Resgate.
DPP	Data Provável do Parto.	OVACE	Obstrução de Via Aérea por Corpo Estranho.	US	Unidade de Sáude.
DUM	Data da Última Menstruação.	O2	Oxigênio.	VA	Via Aérea

7.2. Imagem da SAE para Enfermeiro. Frente:



SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM - Fundamentada na Teoria das Necessidades Humanas Básicas — Pág. 1de2

ENFERMEIRO
SBV_E( ) URAM( ) SAV( )

Acionamento: ( )CENTRAL DE REGULAÇÃO ( ) — BASE:
Motivo Solicitação: ( )PCR ( )Clínico ( )Trauma ( )Obstétrico ( )Saúde mental ( )Ped ( ) — AM: — DATA: / /
Local ocorrência: ( )Via Pública ( )Residência ( )Hospital ( )Base ( )AMA ( )UBS ( )_____ — Nº ORDEM: — COD. CHAMADO:
Endereço da ocorrência:
Nome da Vítima/Nome Social: — Nasc: / / — Idade
SEXO BIOLÓGICO ( )M ( )F — GÊNERO: — TEL. ( ) — Cor ( )Branco ( )Preto ( )Pardo ( )Amarelo ( )Indígena — Nº Documento:
Nome da Mãe: — Acompanhante: — GRAU PARENTESCO:
Endereço da vítima:
Situação Local: ( )Acesso fácil ( )Difícil Acesso ( )Rua/Resid. s/ identificação ( )Animal agressivo ( )Cena de Crime ( )Aglomeração ( )_____
Situação Vítima ( )Já removida ( )Não localizada ( )Agressiva ( )Portando Arma ( ) Suicídio/tentativa ( ) Presa em ferragens ( )_____
Intercorrências: ( ) Sem Intercorrências ( ) QTA no trajeto ( ) QTA no local ( ) Chamado Falso ( ) Múltiplas Vítimas / nº vítimas:
Recursos na cena: Matura e responsável: ( ) URAM _____ ( ) SBV-E _____ ( ) SAV _____ ( ) PM _____ ( ) UR _____ ( ) GRAU _____ ( ) CET _____ ( ) Outros: _____

ATENDIMENTO A VÍTIMA TRAUMÁTICA ( ) NÃO SE APLICA

MECANISMO TRAUMA: ( ) Queda _____ m; ( ) Auto agressão; ( ) Agressão; ( ) FAF ( ) FAB; ( ) Cena suspeita de crime; ( )Queimadura; ( ) Atropelamento; ( ) Enforcamento; ( ) Acidente trânsito; ( ) Atropelamento; ( )Incêndio

Local vítima encontrada: ( )Ambiente fechado; ( )Calçada; ( )Via automobilística; ( )Dentro do Veículo
Posição da Vítima: ( ) Em pé; ( ) Sentada; ( )DDH ( ) DLE; ( ) DV ( ) DLD

ACIDENTE TRÂNSITO — Vítima: ( ) Pedestre; ( ) Passageiro; ( ) Condutor; Veículo: ( ) Automóvel; ( ) Moto; ( ) Bicicleta; ( ) Ônibus; ( ) Animal; ( ) Caminhão; ( ) Objeto fixo; ( )
Outra parte envolvida: ( )
Dispositivo de Proteção: ( ) Airbag; ( ) Cinto; ( ) Assento infantil; ( ) Nenhum; ( ) Capacete; ( ) Outros; ( ) Retirado capacete por: _____

PROBLEMAS IDENTIFICADOS	INTERVENÇÕES
X: ( ) Sem anormalidades; ( ) Hemorragia Exsanguinante; ( ) Local da hemorragia:	( )Realizado compressão manual; ( )Realizado empacotamento; ( ) Realizado curativo compressivo; ( ) Instalado torniquete. Local _____ Horário: ____:____
A: ( )Sem anormalidades; ( )Respiração Ruidosa; ( ) Parada Respiratória; ( ) Trauma facial; ( )Presença de corpo estranho; ( )Edema VAS; ( ) Suspeita lesão cervical; ( )Secreções; ( ) Suspeita de Lesão Laringe; ( )Vômitos	( ) Retirado manualmente corpo estranho; ( ) Realizado manobra de Heimlich; ( ) Aberto vias aéreas; ( ) Estabilizado manualmente a cabeça; ( )Ventilado com BVM c/O_2 15l/min; ( )Via Aérea Avançada DEG nº____; ( ) Imobilizado cervical (colar cervical, prancha e head block); ( ) Aspirado VAS com Sonda nº : _____; ( ) Colocado COF nº: _____; ( )
B: ( )Sem anormalidades; ( ) Assimetria torácica; ( )Apneia; ( ) Dispneia; ( ) Taquipneia; ( )Bradipneia; ( ) Ortopneia; ( ) Cianose labial; ( ) MV diminuído/ausente ( ) D ( ) E; ( )Roncos; ( )Estertores; ( )Sibilos; ( )Creptação ( )Ósseas ( )ausculta; ( ) Desvio de traqueia; ( ) Ferimento soprante	( ) Instalado oximetria. Saturação % AA; Manter decúbito: ( ) Elevado:_____ ( ) A zero grau; ( ) Instalado O_2 l/min. Por dispositivo: _____; ( )DPOC/Enfisema Sat basal %; ( ) Adm. Salbu/tamol -adulto- c/ espaçador 06 jatos ás ____, ____. Repetido 6 jatos ás ____,____; ( ) Adm. Hidrocortisona 200mg EV, diluído 20ml s10,9% em 1min.; ( ) Inalação 40 gotas de Ipatrópico + 5ml SF 0,9%; ( ) Adm. Salbutamol -criança - c/ espaçador 04 jatos ____; ____ Repetido 4 jatos ás ____;____; ( ) Realizado curativo 03 pontas Local:
C: ( )Sem anormalidades; ( )Dor torácica; Perdas: ( )vômitos ( )diaméia ( )sangramento; Local sangramento:_____; ( ) Palidez; ( )Pele fria; ( )Pertusão > de 2 seg.; ( )Edema; ( )Diaforese; ( ) Turgor diminuído; ( )Pulso radial: Ausente ( )D ( )E ( )filiforme; ( ) Bradicardia; ( ) Taquicardia; ( )Dor/Distensão abdominal; ( )Instabilidade pélvica; ( )Deformidade ossos longos; ( )Pulso arrítmico	( ) Realizado curativo compressivo; ( )Instalado AVP, cateter calibre nº _____ Local _____ Nº tentativas; ( ) Realizado curativo oclusivo; ( )Instalado IO adulto ( ) Infantil ( ) Local; ( ) Administrado solução ( )SF ( )RL _____ ml, atingindo PAS> 90 mmHg; ( ) Adm. AAS 300mg mastigado VO; ( ) Adm. ácido tranexâmico 1g diluído em 250ml SF0,9% EV em 10 minutos. ( )Repetido dose após 30 min.; Adm epinefrina IM em vasto lateral da coxa ( )D ( )E e elevado membros inferiores.; ( ) 0,5 mg (adulto); ( ) 0,01mg/kg (criança) dose feita____; ( )Repetido dose _____mg de epinefrina as ____; ____ IM vasto lateral ( )D ( )E; ( ) Imobilizado ossos longos. Local; ( ) Imobilizado pelve - CP (P)(M)(G)
D: ( )Sem alteração; ( )Alteração glicemia; ( )Alteração do estado mental; ( )Agitação psicomotora; Pupila D: ( )Iso/foto ( )Anisocoria ( )Midríase ( )Miose; Pupila E: ( )Iso/foto ( )Anisocoria ( )Midríase ( )Miose; ( ) Vômitos; ( ) Convulsão: ( ) focal; ( ) Espasmos tônico - clônico	( ) Administrado Glicose (adulto) 50% 05 ampolas com SF 0,9% 100 ml; ( ) Administrado Glicose (criança) 25% -2ml/kg - dose feita _____ /(RN) 10% - 5ml/kg- dose feita _____; ( ) Administrado Tiamina 300 mg IV em _____ antes da Glicose (etilista); ( ) Realizado contenção mecânica; ( )Utilizado KIT CONTENÇÃO; ( ) Administrado Diazepan 10mg EV puro e lento - na vigência da convulsão; ( ) Repetida dose Diazepan 10mg EV puro e lento:sem melhora/nova convulsão; ( ) Administrado Midazolan 10mg IM - acesso venoso não possível; ( ) Se TCE, manter PAS ≥ 100mmHg

B (balance)	E (eyes)	F (face)	A (arms)	S (speech)	T (time)
EQUILÍBRIO	OLHOS	FACE	BRAÇOS	FALA	TEMPO
Perda súbita do equilíbrio	Alteração na visão	Um lado da rosto caído	Fraqueza nos braços ou nas pernas	dificuldade para falar	acionar o serviço de emergência imediatamente
S( ) N( )	S( ) N( )	S( ) N( )	S( ) N( )	S( ) N( )	Último horário que a vítima foi vista normal _____:_____

Histórico de AVC ( )S ( )N

MEDICAMENTOS EM USO: Alertar para preenchimento em avaliação secundária

GLASGOW: abertura ocular: Espontânea (4); Estímulo Verbal (3); Estímulo (2) Nenhuma (1); melhor resposta verbal: Orientado (5) Confuso (4) Palavra Inapropriada (3) Sons/Gemidos (2) Nenhuma (1); melhor resposta motora: Obedece comando (6) Localiza dor (5) Retira a dor (4) Flexão Anormal - Decorticação(3) Extensão Anormal - Descerebração (2) Nenhuma (1)

	CENA	FINAL
TOTAL		

E	
( )Sem alteração; ( )Lesões; ( ) Realizar curativo/enfaixamento; ( ) Retirar vestes; ( ) Secar a vítima	
( )Queimadura % ASCQ Horário:	( ) Fixar objeto encravado em região; ( ) Coberto a vítima com manta aluminizada
Dor ( )leve ( )moderada ( )intensa	( ) Cobrir com plástico estéril a região abdominal eviscerada; ( )
( ) Tremores; ( ) Hipotermia	( ) Cobrir a região queimada com protetor de evisceração
( ) Hipertermia; ( )	( )Realizado Paracetamol 40 gotas; ( )Realizado paracetamol 1gota/kg ____gts

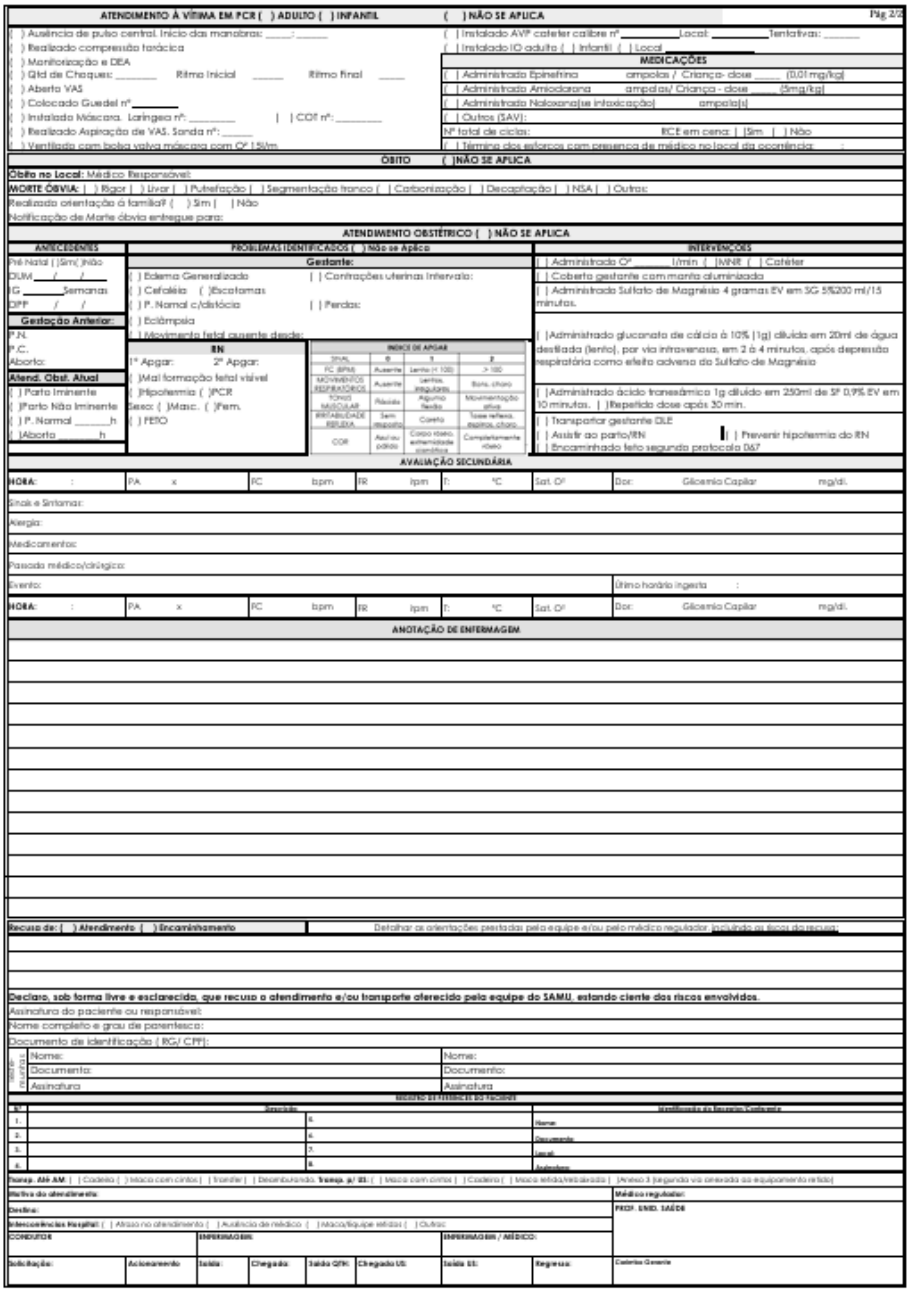
PROTOCOLO DE DOR

Dor Moderada	
Dipirona + Cetorolaco de Trometamol; Buscopam simples ou Buscopam composto	**( ) Dipirona 2g** (4 ml) diluída em 16 ml de SF 0,9% e administrada em bolus lento **( ) Cetorolaco de trometamol** ( )30mg (1ml) adulto - ( )15mg (0,5 ml) - Idoso - diluído em 18 ml de SF 0,9% e administrado em bolus lento EV **( ) Buscopan simples 20mg (1ml)** diluído em 19 ml de SF 0,9% e administrado lento (10 min)
Dor Intensa	
Buscopam composto + Cetorolaco de Trometamol; Morfina	**( ) Buscopan composto 20mg (5ml)** diluído em 250 ml de SF 0,9% e administrado lento (10 min) **( ) Morfina 10mg** (1ml) diluída em 9 ml SF 0,9% para obter solução 1mg/1ml. ( )Administrada em bolus de 2ml lento. ( )Repitida dose após 5min.

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM

( ) Risco de Sangramento excessivo	( ) Troca de gases prejudicada	( ) Risco de desequilíbrio de líquidos	
( ) Risco de Choque	( )Perfusão tissular periférica ineficaz	( ) Dor Aguda (tórax)	( )Desobstrução ineficaz das vias aéreas
( ) Risco de aspiração	( )	( )	( )

7.3. Imagem da SAE para Enfermeiro. Verso:



ATENDIMENTO À VÍTIMA EM PCR ( ) ADULTO ( ) INFANTIL ( ) NÃO SE APLICA

ÓBITO ( ) NÃO SE APLICA

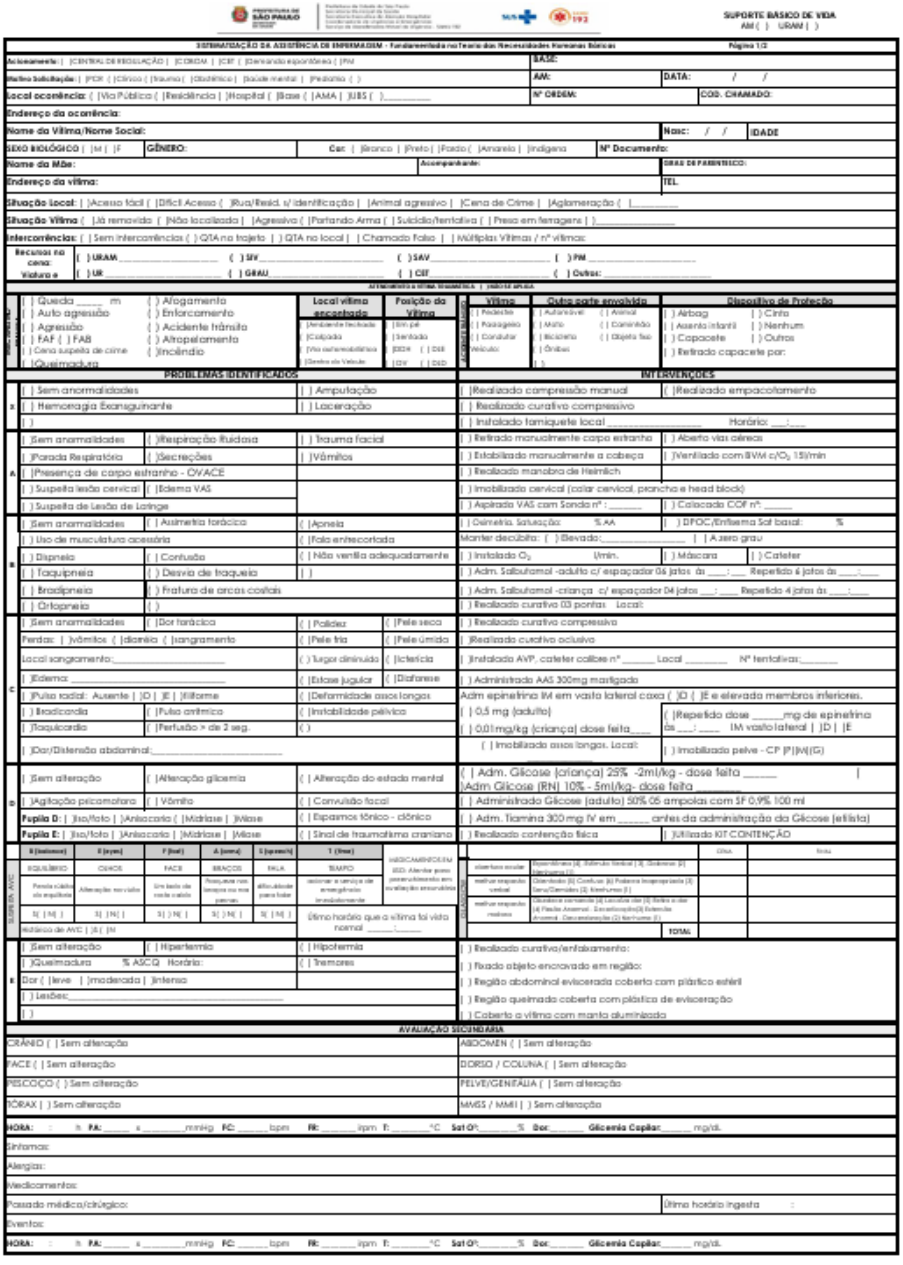
ATENDIMENTO OBSTÉTRICO ( ) NÃO SE APLICA

ANTECEDENTES | PROBLEMAS IDENTIFICADOS ( ) Não se Aplica | INTERVENÇÕES

AVALIAÇÃO SECUNDÁRIA

ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM

7.4. Imagem do impresso para auxiliares e técnicos de enfermagem. Frente:



SUPORTE BÁSICO DE VIDA
AM ( ) URAM ( )

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM - Fundamentada na Teoria das Necessidades Humanas Básicas — Página 1/2

Acionamento: ( ) CENTRAL DE REGULAÇÃO ( ) CBMSP ( ) CIP ( ) Bombeiro especializado ( ) PM

Motivo Solicitação: ( ) PCR ( ) Clínico ( ) Trauma ( ) Obstétrico ( ) Saúde mental ( ) Pediátrico ( )

Local ocorrência: ( ) Via Pública ( ) Residência ( ) Hospital ( ) Base ( ) AMA ( ) UBS ( )

BASE:
AM:
DATA: / /
Nº ORDEM:
COD. CHAMADO:

Endereço da ocorrência:

Nome da Vítima/Nome Social:
Nasc: / / IDADE

SEXO BIOLÓGICO ( ) M ( ) F
GÊNERO:
Cor: ( ) Branco ( ) Preto ( ) Pardo ( ) Amarelo ( ) Indígena
Nº Documento:

Nome da Mãe:
Acompanhante:
GRAU DE PARENTESCO:

Endereço da vítima:
TEL.

Situação Local: ( ) Acesso fácil ( ) Difícil Acesso ( ) Rua/Resid. s/ identificação ( ) Animal agressivo ( ) Cena de Crime ( ) Aglomeração ( )

Situação Vítima: ( ) Já removido ( ) Não localizado ( ) Agressiva ( ) Portando Arma ( ) Suicídio/tentativa ( ) Preso em ferragens ( )

Intercorrências: ( ) Sem intercorrências ( ) QTA no local ( ) QTA no trajeto ( ) Chamado Falso ( ) Múltiplas Vítimas / nº vítimas:

Recursos na cena: Vinham e
( ) URAM ( ) SIV ( ) SAV ( ) PM
( ) UR ( ) GRAU ( ) CIF ( ) Outros:

Atendimento a Vítima Traumática ( ) Suporte Básico

MECANISMO DE TRAUMA
( ) Queda ____ m
( ) Auto agressão
( ) Agressão
( ) FAF ( ) FAB
( ) Cena suspeita de crime
( ) Queimadura
( ) Afogamento
( ) Enforcamento
( ) Acidente hímido
( ) Atropelamento
( ) Incêndio

Local vítima encontrada: (Ambiente fechado) (Calçada) (Via automobilística) (Dentro do Veículo)
Posição da Vítima: (Em pé) (Sentado) (DDH ( ) DSD) (DV ( ) DSD)

Vítima: ( ) Pedestre ( ) Passageiro ( ) Condutor Veículo
Outra parte envolvida: ( ) Automóvel ( ) Animal ( ) Moto ( ) Caminhão ( ) Bicicleta ( ) Objeto fixo ( ) Ônibus ( )
Dispositivo de Proteção: ( ) Airbag ( ) Cinto ( ) Assento infantil ( ) Nenhum ( ) Capacete ( ) Outros ( ) Retirado capacete por:

PROBLEMAS IDENTIFICADOS				INTERVENÇÕES
a	( ) Sem anormalidades		( ) Amputação	( )Realizado compressão manual ( )Realizado empacotamento
	( ) Hemorragia Exsanguinante		( ) Laceração	( ) Realizado curativo compressivo
	( )			( ) Instalado torniquete local _____ Horário: ___:___
A	( )Sem anormalidades	( )Aspiração fluidosa	( ) Trauma facial	( ) Retirado manualmente corpo estranho ( ) Aberto vias aéreas
	( )Parada Respiratória	( )Secreções	( ) Vômitos	( ) Estabilizado manualmente a cabeça ( )Ventilado com BVM c/O_2 15l/min
	( )Presença de corpo estranho - OVACE			( ) Realizada manobra de Heimlich
	( ) Suspeita lesão cervical ( )Edema VAS			( ) Imobilizado cervical (colar cervical, prancha e head block)
	( ) Suspeita de Lesão de Laringe			( ) Aspirado VAS com Sonda nº : _____ ( ) Colocada COF nº: _____
B	( )Sem anormalidades	( ) Assimetria torácica	( )Apneia	( ) Oximetria. Saturação: %AA ( ) DPOC/Enfisema Sat basal: %
	( ) Uso de musculatura acessória		( )Tórax estabilizado	Manter decúbito: ( ) Elevado:_____ ( ) A zero grau
	( ) Dispneia	( ) Confusão	( ) Não ventila adequadamente	( ) Instalada O_2 l/min. ( ) Máscara ( ) Cateter
	( ) Taquipneia	( ) Desvio de traqueia	( )	( ) Adm. Salbutamol -adulto c/ espaçador 06 jatos às ___:___ Repetido 6 jatos às ___:___
	( ) Bradipneia	( ) Fratura de arcos costais		( ) Adm. Salbutamol -criança c/ espaçador 04 jatos ___:___ Repetido 4 jatos às ___:___
	( ) Ortopneia	( )		( ) Realizado curativo 03 pontas Local:
C	( )Sem anormalidades	( )Dor torácica	( ) Palidez ( ) Pele seca	( ) Realizado curativo compressivo
	Perdas: ( )Vômitos ( )Diarréia ( )sangramento		( ) Pele fria ( ) Pele úmida	( )Realizado curativo oclusivo
	Local sangramento:_____		( ) Turgor diminuído ( ) Icterícia	( )Instalada AVP. cateter calibre nº _____ Local _____ Nº tentativas:_____
	( )Edema: _____		( ) Edose jugular ( ) Diaforese	( ) Administrado AAS 300mg mastigado
	( )Pulso radial: Ausente ( )D ( )E ( )Filiforme		( )Deformidade eixos longos	Adm epinefrina IM em vasto lateral coxa ( )D ( )E e elevado membros inferiores.
	( ) Bradicardia	( )Pulso arítmico	( )Instabilidade pélvica	( ) 0,5 mg (adulto) ( )Repetido dose _____mg de epinefrina às ___:___ IM vasto lateral ( )D ( )E
	( )Taquicardia	( )Perfusão > de 2 seg.	( )	( ) 0,01mg/kg (criança) dose feita____
	( )Dor/Distensão abdominal:_____			( ) Imobilizado eixos longos. Local: ( ) Imobilizado pelve - CP)P)M(G)
D	( )Sem alteração	( )Alteração glicemia	( ) Alteração do estado mental	( ) Adm. Glicose (criança) 25% -2ml/kg - dose feita _____ ( )Adm Glicose (RN) 10% - 5ml/kg- dose feita _____
	( )Agitação psicomotora	( ) Vômito	( ) Convulsão focal	( ) Administrado Glicose (adulto) 50% 05 ampolas com SF 0,9% 100 ml
	Pupila D: ( )Iso/Moto ( )Anisocoria ( )Midríase ( )Miose		( ) Espasmos tônico - clônico	( ) Adm. Tiamina 300 mg IV em _____ antes da administração da Glicose (etilista)
	Pupila E: ( )Iso/Moto ( )Anisocoria ( )Midríase ( )Miose		( ) Sinal de trauma/lesão craniana	( ) Realizado contenção física ( )Utilizado KIT CONTENÇÃO
E	( )Sem alteração	( ) Hipertermia	( ) Hipotermia	( ) Realizado curativo/enfaixamento:
	( )Queimadura % ASCQ Horário:		( ) Tremores	( ) Fixado objeto encravado em região:
	Dor ( ) leve ( )moderada ( )intensa			( ) Região abdominal eviscerada coberta com plástico estéril
	( ) Lesões:_____			( ) Região queimada coberta com plástica de evisceração
	( )			( ) Coberto a vítima com manta aluminizada

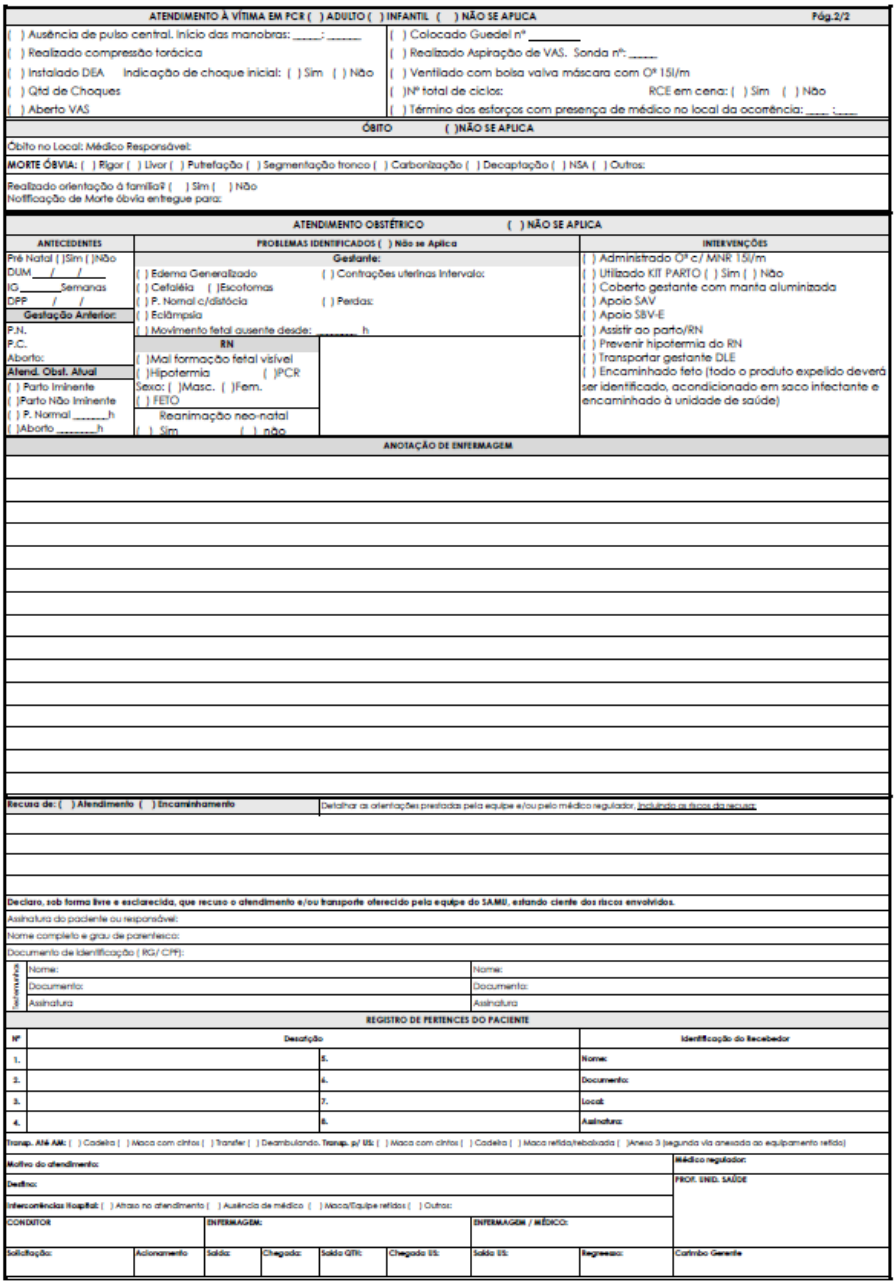
AVALIAÇÃO SECUNDÁRIA	
CRÂNIO ( ) Sem alteração	ABDOMEN ( ) Sem alteração
FACE ( ) Sem alteração	DORSO / COLUNA ( ) Sem alteração
PESCOÇO ( ) Sem alteração	PELVE/GENITÁLIA ( ) Sem alteração
TÓRAX ( ) Sem alteração	MMSS / MMII ( ) Sem alteração

HORA: : h PA: _____ a _____mmHg FC: _____bpm FR: _____ipm T: _____°C Sat O²: _____% Dor: _____ Glicemia Capilar: _____ mg/dL

Sinais vitais:
Alergias:
Medicamentos:
Passado médico/cirúrgico:
Último horário ingesta :
Eventos:

HORA: : h PA: _____ a _____mmHg FC: _____bpm FR: _____ipm T: _____°C Sat O²: _____% Dor: _____ Glicemia Capilar: _____ mg/dL

7.5. Imagem do impresso para auxiliares e técnicos de enfermagem. Verso:



ATENDIMENTO À VÍTIMA EM PCR ( ) ADULTO ( ) INFANTIL ( ) NÃO SE APLICA — Pág.2/2

( ) Ausência de pulso central. Início das manobras: _____: _____
( ) Realizado compressão torácica
( ) Instalado DEA Indicação de choque inicial: ( ) Sim ( ) Não
( ) Qtd de Choques
( ) Aberto VAS
( ) Colocado Guedel nº _____
( ) Realizado Aspiração de VAS. Sonda nº: _____
( ) Ventilado com bolsa valva máscara com O² 15l/m
( )Nº total de ciclos: RCE em cena: ( ) Sim ( ) Não
( ) Término dos esforços com presença de médico no local da ocorrência: ____ ____

ÓBITO ( )NÃO SE APLICA

Óbito no Local: Médico Responsável:
MORTE ÓBVIA: ( ) Rigor ( ) Livor ( ) Putrefação ( ) Segmentação tronco ( ) Carbonização ( ) Decaptação ( ) NSA ( ) Outros:
Realizado orientação à família? ( ) Sim ( ) Não
Notificação de Morte óbvia entregue para:

ATENDIMENTO OBSTÉTRICO ( ) NÃO SE APLICA

ANTECEDENTES	PROBLEMAS IDENTIFICADOS ( ) Não se Aplica	INTERVENÇÕES
Pré Natal ( )Sim ( )Não DUM __/__/__ IG ____Semanas DPP __/__/__ **Gestação Anterior:** P.N. P.C. Aborto: **Atend. Obst. Atual** ( ) Parto Iminente ( )Parto Não Iminente ( ) P. Normal _____h ( )Aborto _____h	**Gestante:** ( ) Edema Generalizado ( ) Contrações uterinas Intervalo: ( ) Cefaléia ( )Escotomas ( ) P. Normal c/distócia ( ) Perdas: ( ) Eclâmpsia ( ) Movimento fetal ausente desde: _____ h **RN** ( )Mal formação fetal visível ( )Hipotermia ( )PCR Sexo: ( )Masc. ( )Fem. ( ) FETO Reanimação neo-natal ( ) Sim ( ) não	( ) Administrado O² c/ MNR 15l/m ( ) Utilizado KIT PARTO ( ) Sim ( ) Não ( ) Coberto gestante com manta aluminizada ( ) Apoio SAV ( ) Apoio SBV-E ( ) Assistir ao parto/RN ( ) Prevenir hipotermia do RN ( ) Transportar gestante DLE ( ) Encaminhado feto (todo o produto expelido deverá ser identificado, acondicionado em saco infectante e encaminhado à unidade de saúde)

ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM

Recusa de: ( ) Atendimento ( ) Encaminhamento — Detalhar as orientações prestadas pela equipe e/ou pelo médico regulador, incluindo os riscos da recusa.

Declaro, sob forma livre e esclarecida, que recuso o atendimento e/ou transporte oferecido pela equipe do SAMU, estando ciente dos riscos envolvidos.
Assinatura do paciente ou responsável:
Nome completo e grau de parentesco:
Documento de identificação (RG/ CPF):

Testemunhas		
	Nome:	Nome:
	Documento:	Documento:
	Assinatura	Assinatura

REGISTRO DE PERTENCES DO PACIENTE

Nº	Descrição		Identificação do Recebedor
1.		5.	Nome:
2.		6.	Documento:
3.		7.	Local:
4.		8.	Assinatura:

Transp. Alvo AM: ( ) Cadeira ( ) Maca com cintos ( ) Transfer ( ) Deambulando. **Transp. p/ UTs** ( ) Maca com cintos ( ) Cadeira ( ) Maca refrida/rebaixada ( )Anexo 3 (segunda via anexada ao equipamento retido)

Motivo do atendimento: — **Médico regulador:**
Destino: — **PROF. UNID. SAÚDE**
Intercorrências Hospital: ( ) Atraso no atendimento ( ) Ausência de médico ( ) Maca/Equipe retidos ( ) Outros:

CONDUTOR		ENFERMAGEM:				ENFERMAGEM / MÉDICO:		
Solicitação:	Acionamento:	Saída:	Chegada:	Saída QTH:	Chegada US:	Saída US:	Regresso:	Carimbo Gerente

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 2048, de 5 de novembro de 2002. Aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. Diário Oficial da União, Brasília, 12 nov. 2002. Seção 1, p. 32-54.

9.2. CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). Resolução Cofen nº 713, de 3 de novembro de 2022. Atualiza a norma de atuação dos profissionais de enfermagem no Atendimento Pré-Hospitalar (APH) móvel terrestre e aquaviário, bem como nas Centrais de Regulação das Urgências (CRU), em serviços públicos e privados, civis e militares. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 4 nov. 2022. Disponível em: https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-713-2022/. Acesso em: 26 ago. 2025.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
02	02/02/2026	Atualização 1. Alteração do título, passando de "Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAMU 192" para "Preenchimento da Ficha de Atendimento pela Equipe de Enfermagem". 2. Reorganização do conteúdo, com detalhamento da SAE no campo de definição e maior foco no registro assistencial. 3. Ampliação das equipes envolvidas, para SBV, SBV-E, SAV e URAM. 4. Atualização das referências normativas, com reforço da Resolução COFEN nº 358/2009. 5. Inclusão da definição da ficha de atendimento em SBV, diferenciando atribuições por modalidade. 6. Ampliação dos objetivos, incluindo a padronização do raciocínio lógico no preenchimento. 7. Detalhamento técnico do preenchimento da ficha, com orientações linha a linha e por campo. 8. Organização da SAE por categorias de ocorrência (traumático, PCR, obstétrico/RN e não traumático). 9. Padronização da avaliação primária (XABCDE/ABCDE) e secundária (SAMPLER). 10. Inclusão de orientações sobre uso de medicações e registros em modalidade SAV. 11. Definição clara das responsabilidades entre enfermeiros, técnicos e auxiliares. 12. Inserção de escalas clínicas padronizadas (Glasgow, BEFAST, Apgar). 13. Estabelecimento de regras formais para assinatura, guarda e destino da ficha.

Última validação	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes	Elaine C. S. M. Machado Fabiana Amparo Ferraz Lilian Maria de Oliveira Miriam Kelly Braga Wesley Almeida Santos	Amanda de Ornelas Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. Responsabilidades dos condutores: as responsabilidades descritas servem para nortear os condutores na execução de suas atividades complementares;

1.2. Carteira Nacional de Habilitação na categoria D: categoria obrigatória para condutores de veículos de emergência segundo o Código de Trânsito Brasileiro;

1.3. Curso de Capacitação para Condutores de Veículo de Emergência (CTVE): curso obrigatório para capacitar profissionais que conduzem veículos de emergência;

1.4. Exame toxicológico: exame realizado a cada 2 anos e 6 meses por determinação do CONTRAN, que detecta o uso de substâncias psicoativas por meio da análise de cabelo, pelos ou unhas;

1.5. TWI: o Indicador de Desgaste da Banda de Rodagem, trata-se de um sinal visual no pneu que indica o limite de uso e necessidade de troca.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever as responsabilidades complementares do condutor de veículo de emergência que constituem as equipes do SAMU 192 São Paulo.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, SAV, VIR, CRU e Frota.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

Ao condutor do veículo de emergência compete, adicionalmente ao previsto na NR 001:

4.1. Conhecer o protocolo institucional do SAMU192 São Paulo;

4.2. Respeitar as regras de trânsito previstas no CTB para veículos de emergência;

4.3. Realizar o preenchimento do impresso OSE e checklist nos primeiros 20 minutos do início do plantão, a fim de garantir segurança assistencial. Consultar POP Central de Regulação e Intervenção 7-005 Frota – Preenchimento da Ordem de Serviço Externo;

4.4. Portar, durante todo o plantão, os documentos pessoais e da ambulância, incluindo CNH e certificado do CTVE;

4.5. Manter em dia a validade de todos os documentos exigidos: CNH, exame toxicológico e certificado do CTVE;

4.6. Ter conhecimento da malha viária da região de atuação, bem como das principais referências e rotas alternativas;

4.7. Utilizar corretamente os sistemas de comunicação disponíveis, como rádio, tablet ou celular;

4.7.1. Ao condutor fica proibido o uso desses dispositivos enquanto o veículo estiver em movimento, ficando sob responsabilidade de outro membro da equipe;

4.7.2. Utilizar o código "Q" e "Alfabeto Fonético" -POP IAPH SBV E SBV-E 001- Papéis e Responsabilidades complementares da equipe de intervenção no SBV e SBV-E do SAMU192 São Paulo;

4.8. Acionar sinais sonoros (sirene) e luminosos (high light) no início do deslocamento da AM para ocorrência;

4.9. Manter os faróis acesos durante todo o deslocamento, inclusive durante o dia;

4.10. Manter sempre as luzes do salão da ambulância acesas durante o plantão diurno e noturno, enquanto estiver em deslocamento;

4.11. Estacionar sempre de ré, garantindo condições para uma saída imediata;

4.12. Informar à CRU, por rádio ou dispositivo institucional, os seguintes momentos:

4.12.1. Início do deslocamento da AM;

4.12.2. Chegada ao local da ocorrência;

4.12.3. Saída do local de ocorrência;

4.12.4. Chegada à unidade de saúde;

4.12.5. Saída da unidade de saúde;

4.12.6. Retorno à base e o encerramento do deslocamento.

4.12.7. Importante: comunicar qualquer parada não programada durante o trajeto, pois o GPS registrará a pausa e informará automaticamente ao CORE;

4.13. Informar à CRU e solicitar autorização para abastecimento quando o nível de combustível atingir 1/4 do tanque.

4.13.1. O abastecimento deverá ser realizado após o término da ocorrência em andamento;

4.13.2. Ao final do abastecimento, comunicar ao CORE a quantidade de litros abastecidos.

4.14. No início do plantão, se houver necessidade de empenho, em caso de chamado de complexidade Charlie, Delta e Echo, a equipe deverá realizar checklist "*TOP Five*" e seguir em atendimento;

4.15. Realizar a checagem do checklist TOP 05 nos chamados priorizados pelo MR:

TOP FIVE – SBV		
Veículo Ambulância	1	Água do radiador / Óleo do motor e hidráulico
	2	Fluído do freio e pedal
	3	Pneus
	4	Luzes e parte elétrica
	5	Combustível

4.15.1. Água do radiador (líquido de arrefecimento do radiador), óleo hidráulico (painel) e óleo do motor: verificar níveis e possíveis vazamentos;

4.15.2. Fluido do freio/ pedal: testar e confirmar eficiência;

4.15.3. Pneus: avaliar visualmente se está cheio ou vazio;

4.15.4. Luzes: avaliar o funcionamento do giroflex, Luzes externas e strobos / parte elétrica (luzes do farol, lanterna, lâmpada do freio e das setas)

4.15.5. Combustível: verificar se está com nível de pelo menos de 1/4 do tanque.

4.16. A conferência do checklist deve ser registrada em impresso próprio (Anexo 1). Verificar presença e integridade:

Cabine

4.16.1. Documentos do veículo;

4.16.2. Cartão de abastecimento da viatura;

4.16.3. Buzina;

4.16.4. Módulo da sirene- verificar os sons;

4.16.5. Rádio fixo: realizar o teste de sinal com a CRU utilizando o código Q;

4.16.6. Rádio móvel (HT), celular da ambulância e tablet - verificar o nível de bateria e se houve algum dano;

4.16.7. Limpador de para-brisas: avaliar o funcionamento, nível de água, jato de água e o desgaste da borracha;

4.16.8. Funcionamento do ar-condicionado;

4.16.9. Chave de roda e chave de boca;

4.16.10. Extintor 1 kg na cabine (verificar validade e lacre);

4.16.11. Macaco e cabo;

4.16.12. Triângulo de sinalização;

Salão

4.16.13. Verificar funcionamento de luzes internas e ventilador do salão;

4.16.14. Cilindros de oxigênio -2 unidades;

4.16.15. Cintas e fixação dos cilindros de oxigênio;

4.16.16. Oxigênio portátil (1metro);

4.16.17. Extintor Salão ABC 6kg: verificar validade e o lacre;

4.16.18. Prancha rígida para o atendimento 2 unidades;

4.16.19. KED;

4.16.20. Colchonete;

4.16.21. Maca: retirar a maca e testar o mecanismo completo se arma/desarma, a integridade das rodas e o funcionamento das grades;

4.16.22. Cadeira de rodas: verificar se tem no mínimo uma cadeira de rodas com alça lateral íntegra;

4.16.23. Cones: cinco unidades para sinalização;

Área externa

4.16.24. Faróis, lanternas dianteiras e lanternas traseiras: avaliar se há danificações físicas das peças;

4.16.25. Retrovisor: avaliar posicionamento e a integridade da peça;

4.16.26. Pneus dianteiros, traseiros e estepe: verificar o estado de

conservação dos pneus, vazamento e calibragem;

4.16.27. Calotas;

4.16.28. Placas- verificar se a placa está legível;

4.16.29. Vidros- verificar a integridade dos vidros;

4.17. Verificar durante o deslocamento da AM: ruídos anormais, eventuais peças soltas, estado dos freios, funcionamento do rádio fixo;

4.18. Manter as portas e janelas da ambulância trancadas durante atendimentos externos, quando não houver equipe próxima, a fim de garantir a segurança da equipe, do paciente, dos materiais e do próprio veículo;

4.19. Realizar coberturas ou mesmo auxiliar demais membros da equipe, conforme solicitação e orientação da gestão imediata;

4.20. Identificar todos os tipos de materiais existentes na AM, a fim de auxiliar a equipe de saúde, a realizar manobras de reanimação cardiorrespiratória e ações de sua competência.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. No transporte, o paciente deverá ser acomodado em decúbito horizontal, salvo quando essa posição puder acarretar agravamento do quadro clínico, devendo o condutor seguir as orientações da equipe médica e/ou de enfermagem;

5.2. Se houver mais de uma vítima na cena, comunique o MR e solicite apoio;

5.3. A ambulância não deverá deixar o local da ocorrência até a chegada da equipe de apoio, de modo a garantir que nenhuma vítima permaneça sozinha na cena;

5.4. O número de transporte de pessoas está condicionado ao número de cintos de segurança da AM;

5.5. O transporte de acompanhantes deverá seguir as orientações do POP Central de Regulação e Intervenção 6-009 – transporte de acompanhante de paciente;

5.6. As orientações de PPR devem seguir instruções POP Central de Regulação e Intervenção 6-004 Intervenção- Pausa para Refeição;

5.7. No caso de maca retida seguir instruções em POP Central de Regulação e Intervenção 6-002 Intervenção- Maca Retida em Unidade de Saúde;

5.8. Para troca de cilindros de oxigênio seguir POP Central de Regulação e Intervenção 6-011 Intervenção – Troca de cilindros de Oxigênio;

5.9. No caso de transporte de acompanhante de pacientes, seguir o POP Central de Regulação e Intervenção 6-009 – Transporte de acompanhante de paciente;

5.10. A qualidade dos pneus (TWI) das ambulâncias será verificada na revisão periódica pela oficina contratada;

5.11. É proibido manter as viaturas com o motor ligado enquanto não estiverem em deslocamento para atendimento ou prestando assistência direta a pacientes, exceto nas seguintes situações:

5.11.1. Quando o funcionamento contínuo do motor for necessário para manter equipamentos médicos operacionais carregados (durante atendimento), que estejam sendo utilizados em suporte à vida;

5.11.2. Durante checagens operacionais breves, realizadas sob supervisão, que requeiram o acionamento do motor do veículo.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP Central de Regulação e Intervenção 6-002 Intervenção- Maca Retida em Unidade de Saúde;

6.2. POP Central de Regulação e Intervenção 7-005 Frota – Preenchimento da ordem de serviço externo;

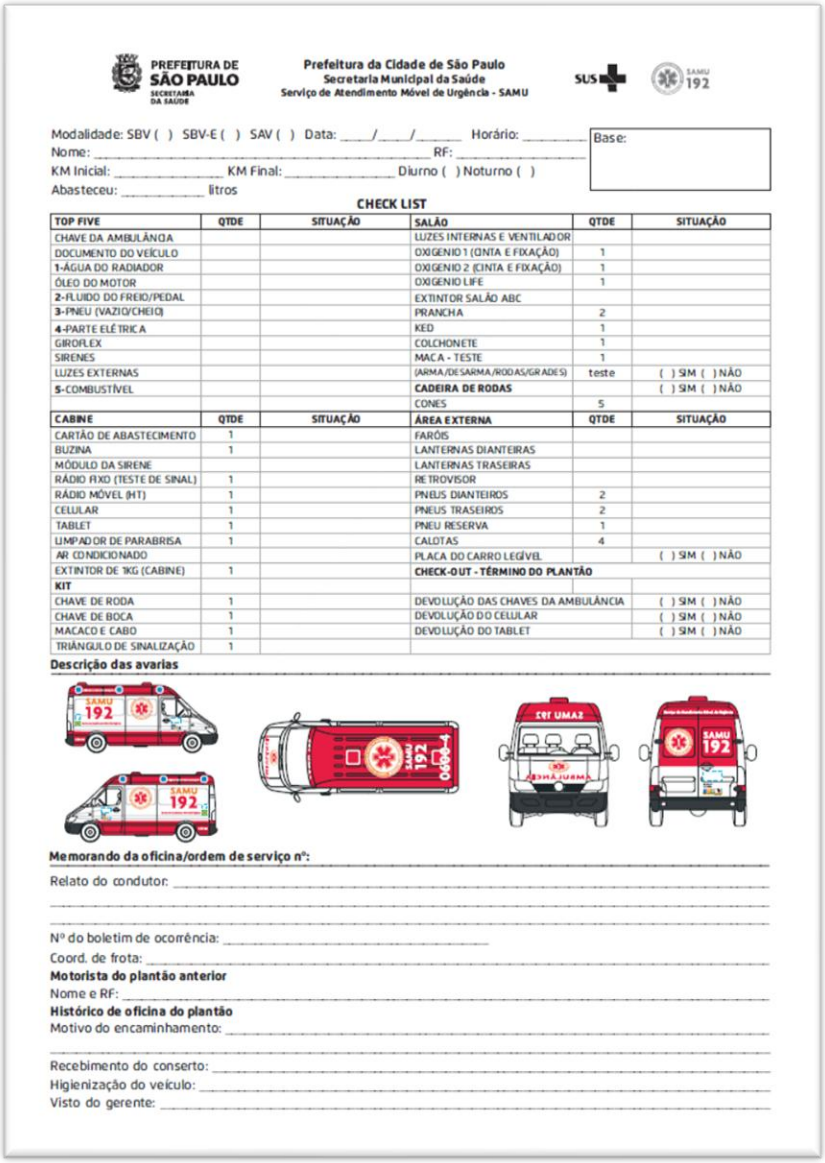
6.3. POP Central de Regulação e Intervenção 6-004 Intervenção- Pausa para Refeição;

6.4. POP Central de Regulação e Intervenção 6-009 – transporte de acompanhante de paciente;

6.5. POP Central de Regulação e Intervenção 6-009 – Transporte de acompanhante de paciente.

7. ANEXOS

7.1. Checklist das ambulâncias



PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

Prefeitura da Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU

SUS

Modalidade: SBV ( ) SBV-E ( ) SAV ( ) Data: ____/____/_____ Horário: _____
Nome: _____ RF: _____
KM Inicial: _____ KM Final: _____ Diurno ( ) Noturno ( )
Abasteceu: _____ litros

Base:

CHECK LIST

TOP FIVE	QTDE	SITUAÇÃO	SALÃO	QTDE	SITUAÇÃO
CHAVE DA AMBULÂNCIA			LUZES INTERNAS E VENTILADOR		
DOCUMENTO DO VEÍCULO			OXIGENIO 1 (CINTA E FIXAÇÃO)	1	
1-ÁGUA DO RADIADOR			OXIGENIO 2 (CINTA E FIXAÇÃO)	1	
ÓLEO DO MOTOR			OXIGENIO LIFE	1	
2-FLUIDO DO FREIO/PEDAL			EXTINTOR SALÃO ABC		
3-PNEU (VAZIO/CHEIO)			PRANCHA	2	
4-PARTE ELÉTRICA			KED	1	
GIROFLEX			COLCHONETE	1	
SIRENES			MACA - TESTE	1	
LUZES EXTERNAS			(ARMA/DESARMA/RODAS/GRADES)	teste	( ) SIM ( ) NÃO
5-COMBUSTÍVEL			**CADEIRA DE RODAS**		( ) SIM ( ) NÃO
			CONES	5	
CABINE	**QTDE**	**SITUAÇÃO**	**ÁREA EXTERNA**	**QTDE**	**SITUAÇÃO**
CARTÃO DE ABASTECIMENTO	1		FARÓIS		
BUZINA	1		LANTERNAS DIANTEIRAS		
MÓDULO DA SIRENE			LANTERNAS TRASEIRAS		
RÁDIO FIXO (TESTE DE SINAL)	1		RETROVISOR		
RÁDIO MÓVEL (HT)	1		PNEUS DIANTEIROS	2	
CELULAR	1		PNEUS TRASEIROS	2	
TABLET	1		PNEU RESERVA	1	
LIMPADOR DE PARABRISA	1		CALOTAS	4	
AR CONDICIONADO			PLACA DO CARRO LEGÍVEL		( ) SIM ( ) NÃO
EXTINTOR DE 1KG (CABINE)	1		**CHECK-OUT - TÉRMINO DO PLANTÃO**		
KIT					
CHAVE DE RODA	1		DEVOLUÇÃO DAS CHAVES DA AMBULÂNCIA		( ) SIM ( ) NÃO
CHAVE DE BOCA	1		DEVOLUÇÃO DO CELULAR		( ) SIM ( ) NÃO
MACACO E CABO	1		DEVOLUÇÃO DO TABLET		( ) SIM ( ) NÃO
TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO	1				

Descrição das avarias _____

Memorando da oficina/ordem de serviço nº: _____
Relato do condutor: _____
_____
_____
Nº do boletim de ocorrência: _____
Coord. de frota: _____
Motorista do plantão anterior
Nome e RF: _____
Histórico de oficina do plantão
Motivo do encaminhamento: _____
_____
Recebimento do conserto: _____
Higienização do veículo: _____
Visto do gerente: _____

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 2048, de 5 de novembro de 2002. Aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. Diário Oficial da União, Brasília, 12 nov. 2002. Seção 1, p. 32-54.

9.2. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 1010, de 21 de maio de 2012. Redefine as diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 98, v. 1, p. 34-36, 22 maio 2012.

9.3. BRASIL. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Código de Trânsito Brasileiro. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 set. 1997. Art. 29, inciso VII. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm. Acesso em: 20 ago. 2025.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Atualização e padronização do nome e das definições 2. Ampliação do escopo para todas as equipes operacionais (SBV, SBV-E, SAV e VIR) 3. Atualização do objetivo do protocolo 4. Inclusão de novos conceitos técnicos e legais (CNH categoria D, CTVE, exame toxicológico e TWI) 5. Revisão e detalhamento das responsabilidades do condutor 6. Padronização dos procedimentos operacionais e de comunicação 7. Atualização e formalização dos checklists operacionais (OSE e TOP Five) 8. Ampliação e organização das rotinas de checagem da viatura 9. Reforço das normas de segurança, trânsito e uso de dispositivos eletrônicos 10. Vinculação a POPs institucionais vigentes 11. Atualização das observações e recomendações operacionais

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cássia Oliveira Lopes	Célio Gouveia Marco Antônio B. Coelho Ronaldo Castelo Branco	Bárbara de Souza Joênia S. Moreira Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Responsabilidades dos condutores: as responsabilidades descritas servem para nortear os condutores na execução de suas atividades complementares, pertinentes a condução e ao estacionamento do veículo de emergência.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever as regras de condução e estacionamento para os condutores de veículo de emergência que constituem as equipes de SBV, SBV-E, SAV e VIR.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, SAV, VIR Frota e CRU.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

Regras fundamentais de condução de veículos de emergência

4.1. A sua segurança, de sua equipe e do cidadão é prioritária sempre;

4.2. O condutor deve seguir as regras previstas no CTB;

4.3. O número de passageiros permitido deve corresponder ao número de cintos de segurança disponíveis e em condições de uso, incluindo a vítima, que deverá permanecer prioritariamente na maca;

4.4. Dispositivos sonoros e de iluminação devem ser utilizados somente em efetiva prestação de serviço de emergência (CTB artigo 29);

4.5. O veículo de emergência não tem direito a ultrapassar a velocidade permitida pela via e pode sofrer sanções punitivas, mesmo se comprovada à efetiva prestação de serviços de urgência/emergência. Se ocorrer excesso de velocidade e houver acidentes, o condutor será responsabilizado;

4.6. O veículo de emergência tem o privilégio de solicitar passagem e ultrapassar sempre pela esquerda. Para isso, o condutor deve utilizar os recursos sonoros e de iluminação, incluindo os faróis, para alertar os outros condutores de sua aproximação e já posicionar a ambulância na faixa de rolamento à esquerda. O veículo de emergência não deve ser conduzido no espaço entre faixas de rolamento;

<u>Para elevar a segurança nas situações acima, o condutor deve:</u>

4.7. Solicitar apoio de policiais ou de agentes do trânsito presentes no local;

4.8. Manter sirene ligada;

4.9. Acidentes durante trajeto são de responsabilidade do condutor, bem como recebimento de multas;

4.10. O condutor deverá autorizar o desembarque da equipe.

<u>Comportamento de segurança no trânsito</u>

4.11. Evitar freadas e acelerações bruscas;

4.12. Evitar mudanças desnecessárias de faixa de rolamento (evite "costurar");

4.13. Não usar pisca - alerta quando em movimento;

4.14. Utilizar velocidade compatível com o procedimento necessário à vítima;

4.15. Posicionar corretamente a viatura na cena (protocolo de segurança de cena);

4.16. Sinalizar adequadamente a viatura e a via quando parado (protocolo de segurança de cena);

4.17. Estacionar antes do evento e sinalize o local, se o veículo for o primeiro a chegar à cena, deve:

Figura vetorizadas a partir dos desenhos originais elaborados por Dr. Carlos Alberto Guglielmi Eid.

4.17.1. Estacionar em 45 ° com as rodas esterçadas ao lado contrário da cena.

4.17.2. Não sair da cena até a chegada de apoio (POP IAPH SBV E SBV-E 007 - Avaliação da Cena);

4.18. Estacionar após o evento, se a cena já estiver sinalizada:

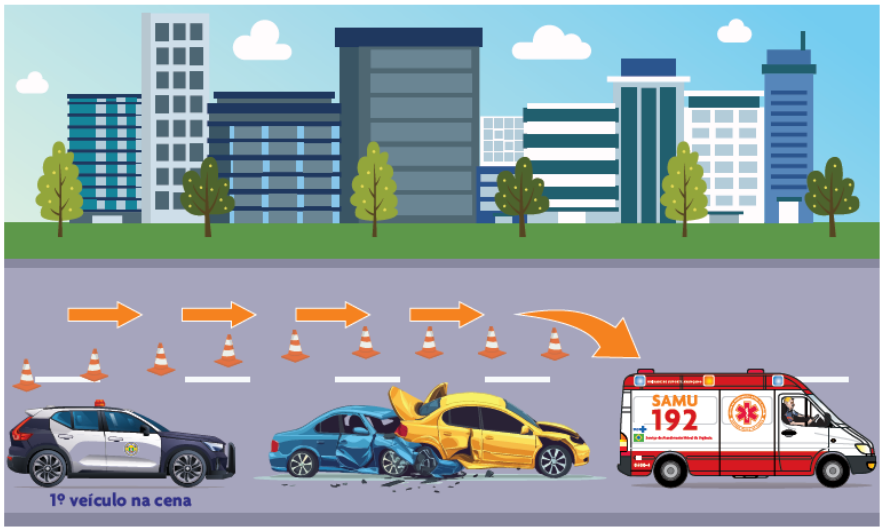


Figura vetorizadas a partir dos desenhos originais elaborados por Dr. Carlos Alberto Guglielmi Eid.

4.19. A ambulância deve ser parada no sentido da via, com os sinais luminosos ligados e a uma distância segura do evento;

4.20. Para decidir pela distância segura, observar a existência de vazamento de óleo, combustível, gases, fumaça, fogo, entre outros;

4.21. Na presença de fumaça ou produtos perigosos, manter distância mínima de 300 metros, sempre a favor do vento (POP IAPH 008-Ocorrências Envolvendo Produtos Perigosos) A sinalização pode ser realizada com cones ou similar;

4.22. Solicitar à CRU que acione apoio da CET, ou da Concessionária, em caso de rodovias, caso a equipe não tenha condições de efetivar a sinalização;

4.23. Estabelecer a distância para a primeira sinalização, usando a velocidade máxima permitida para a via como referência:

DISTÂNCIA DO ACIDENTE PARA INÍCIO DA SINALIZAÇÃO			
Tipo da via	Velocidade máxima permitida	Distância para início da sinalização (pista seca)	Distância para início da sinalização (chuva, neblina, fumaça, noite)
Via local	30 km/h	30 passos longos	60 passos longos
Via coletora	40 km/h	40 passos longos	80 passos longos
Via arterial	60 km/h	60 passos longos	120 passos longos
Via de trânsito rápido	80 km/h	80 passos longos	160 passos longos
Rodovia de pista simples	100 km/h	100 passos longos	200 passos longos
Rodovia de pista dupla	110 km/h	110 passos longos	220 passos longos
Estrada (não pavimentada)	60 km/h	60 passos longos	120 passos longos

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não há.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP IAPH SBV e SBV-E 007 - Avaliação da Cena;

6.2. POP IAPH SBV e SBV-E 008 - Ocorrências Envolvendo Produtos Perigosos.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. Código de Trânsito Brasileiro, 2020. Disponível em < *https://dhg1h5j42swfq.cloudfront.net/2021/01/11120314/codigo-de-transito-atualizado-lei-14-071-20-* para-prf-2021.pdf> Acesso em 20/12/2021.

9.2. Lei nº 9503, de 23 de setembro de 1997. Disponível em < *https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1997/lei-9503-23-setembro-1997-372348-publicacaooriginal-1-* pl.html > Acesso em 20/12/2021.

9.3. Portaria nº. 2048/2002 - SMS G/CR. Disponivel em< *https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html*> Acesso em 20/12/2021.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Atualização do objetivo do protocolo, com abrangência institucional ampliada 2. Unificação dos protocolos de SBV e SIV 3. Padronização das definições e responsabilidades do condutor 4. Ajuste das orientações sobre transporte da vítima 5. Reforço da responsabilização do condutor em acidentes e infrações 6. Detalhamento e padronização das regras de segurança viária 7. Inclusão de orientações operacionais específicas para estacionamento antes e após o evento 8. Definição de posicionamento seguro da viatura 9. Inclusão de protocolos institucionais correlatos 10. Ampliação das diretrizes para acionamento de apoio externo

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes	Célio Gouveia Elaine C. S. M. Machado Marco Antônio B. Coelho Simone Cedano Ramos	Bárbara de Souza Joênia S. Moreira Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. A biossegurança é definida como a condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever as ações voltadas para a prevenção e proteção dos profissionais, da vítima e do meio ambiente em relação aos riscos presentes no atendimento pré-hospitalar.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e CRU.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Avaliar a segurança da cena e solicitar apoio à CRU se for necessário de acordo com o que foi encontrado;

4.2. Realizar a higienização das mãos e punhos com álcool gel antes de se paramentar;

4.3. Utilizar os EPIs obrigatórios: macacão de manga longa, botas, luvas, máscara e óculos de proteção;

4.3.1. Usar avental descartável, se risco de respingos;

4.4. Desprezar os materiais perfurocortantes no coletor apropriado da ambulância;

4.5. Caso ocorrer um acidente de trabalho durante o atendimento, siga os protocolos POP IAPH SBV E SBV-E 012 - acidente de trabalho e POP IAPH SBV E SBV-E 013 - acidente de trabalho com material biológico;

4.6. Recolher todo o lixo produzido durante o atendimento e descarte na lixeira da ambulância;

4.7. Desprezar todo o material utilizado no atendimento (invólucros, lençóis descartáveis, gazes, luvas etc.) no coletor de lixo hospitalar específico (saco branco leitoso infectante), exceto, os perfurocortantes;

4.8. Utilizar a caixa de materiais perfurocortante até atingir três quartos de sua capacidade e fechar de acordo com as instruções dos fabricantes;

4.9. Desprezar os coletores de perfurocortante nas unidades de saúde, seguindo orientações do local;

4.10. Realizar a higienização das mãos e antebraços com água e sabão;

4.10.1. Na impossibilidade de uso de água e sabão, utilizar álcool gel;

4.11. Realizar a limpeza concorrente da ambulância e dos equipamentos utilizados, conforme o POP IAPH SBV E SBV-E 071- limpeza concorrente da ambulância.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. A equipe deve portar obrigatoriamente os óculos de proteção em todos os atendimentos;

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

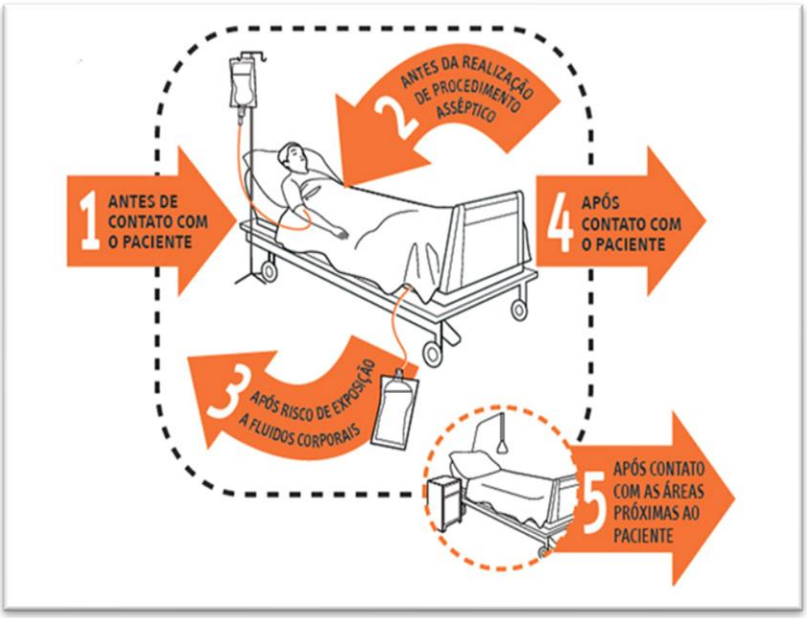
6.1. POP IAPH SBV E SBV-E 071- Limpeza concorrente da ambulância;

6.2. POP IAPH SBV E SBV-E 012 - Acidente de trabalho;

6.3. POP IAPH SBV E SBV-E 013 - Acidente de trabalho com material biológico.

7. ANEXOS

7.1. Figura1: Os cinco momentos para higiene das mãos:



8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. ANVISA. Biossegurança. Conceitos e Definições. Disponível em <https://antigo.anvisa.gov.br/> consultado em 12 de dezembro de 2021.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Unificação dos protocolos de SBV e SIV 2. Atualização da definição e do objetivo do protocolo. 3. Padronização e detalhamento das medidas de biossegurança durante e após o atendimento. 4. Inclusão e reforço do uso obrigatório de EPIs. 5. Atualização dos fluxos de descarte de resíduos e perfurocortantes. 6. Inclusão de referência a POPs institucionais para acidentes de trabalho e limpeza da ambulância.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Daiane M. F. Souza Simone Dorna Elaine C. S. M. Machado Fernanda Vaz Tostes	Amanda de Ornelas Bárbara de Souza Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. A avaliação da cena consiste na procura por situações que possam ocasionar risco para os profissionais que atuam no atendimento à vítima.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever as regras gerais para os profissionais do serviço, a fim de avaliar a segurança da cena antes de iniciar qualquer atendimento à vítima.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e CRU.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Antes de iniciar o atendimento à vítima, avaliar a situação no momento:

4.1.1. Considerar as informações passadas pela CRU, por outras equipes no local e/ou por testemunhas;

4.1.2. Ao chegar na cena, observar imediatamente o mecanismo envolvido e situações de risco para as equipes como: fogo, fumaça, animais, produtos perigosos, inundação, instabilidade de estruturas, fios elétricos energizados, acesso difícil, tráfego intenso na via, armamento, aglomeração, número de vítimas, presença de outros serviços, entre outros;

4.2. Ficar atento para onde a situação pode evoluir:

4.2.1. Considerar a evolução da situação nos próximos minutos e horas, por exemplo: explosão, intoxicação por fumaça, rompimento de estrutura, choque elétrico, violência interpessoal, vazamento de produtos, vazamento de gás, contaminação do ambiente, engavetamento, aumento do número de vítimas, entre outros;

4.3. Comunicar a CRU e solicitar os apoios necessários: corpo de bombeiros, policiamento, controle de tráfego (CET), Defesa Civil, Cetesb, Enel, Comgás, entre outros;

4.4. Seguir as regras gerais de estacionamento da ambulância (POP IAPH SBV E SBV-E 005 – Regras gerais de condução - estacionamento de veículo de emergência);

4.5. Seguir as regras gerais de biossegurança (POP IAPH SBV E SBV-E 006 – Regras de biossegurança);

4.6. Diante de riscos óbvios, posicionar-se em local seguro e próximo da ocorrência, atentando-se para:

4.6.1. Rede elétrica envolvida: posicionar a ambulância após os postes intactos;

4.6.2. Fumaça tóxica: posicionar com o vento batendo nas costas;

4.6.3. Presença de fogo: manter distância superior a 35 metros;

4.6.4. Vazamento de substância tóxica: manter-se na direção contrária ao escoamento.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Toda a equipe deve estar envolvida na avaliação da cena;

5.2. Somente equipes empenhadas pela CRU devem se deslocar para eventos de múltiplas vítimas e de repercussão midiática;

5.3. A equipe deverá deslocar-se até a cena portando as mochilas devidamente equipadas, e não apenas materiais para aferição de sinais vitais, a fim de evitar o retorno à ambulância para coleta de equipamentos necessários e, consequentemente, prevenir perda de tempo no atendimento ao paciente.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP IAPH SBV E SBV-E 005 – Regras gerais de condução - estacionamento de veículo de emergência.

6.2. POP IAPH SBV E SBV-E 006 – Regras de biossegurança.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. (NAEMT), National Association of Emergency Medical Technicians. PHTLS: Prehospital Trauma Life Support: Suporte de vida pré-hospitalar em trauma. 10ª edição 2023.

9.2. (NAEMT), National Association of Emergency Medical Technicians. AMLS: Advanced Medical Life Support: Atendimento Pré-Hospitalar às Emergências Clínicas. Porto Alegre: Artmed, 2022. Ebook.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Unificação dos protocolos de SBV e SIV 2. Atualização da definição e do objetivo do protocolo. 3. Ampliação e atualização das áreas envolvidas. 4. Padronização da avaliação da segurança da cena. 5. Ampliação dos riscos considerados na análise da cena. 6. Inclusão da obrigatoriedade de comunicação e acionamento de apoios. 7. Vinculação a protocolos institucionais de estacionamento e biossegurança

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Marisa A. Amaro Malvestio Amanda de F. P. Rocha Carlos Odercio Zanquetta Naiane Clara Clemento Luís Cássio Carneiro Leão Patrícia C. Alves de Sousa	Amanda de Ornelas Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Produtos perigosos: substâncias e/ou artefatos que em contato com seres humanos e animais podem provocar risco para a saúde e danos para o meio ambiente e podem ser classificados em: químicos, inflamáveis, radioativos, biológicos, entre outros.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever as regras gerais para os profissionais do SAMU 192 São Paulo diante de ocorrência envolvendo produtos perigosos.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, SAV, VIR, URAM e CRU.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Não se aproximar sem saber a natureza do produto;

4.2. Avaliar se há risco imediato de explosão, incêndio, vazamento ou contaminação;

4.3. Identificar o número ONU do painel de segurança e os dados do rótulo de segurança, caso sejam os primeiros a chegar à cena (Anexo 1);

4.3.1. Se não for possível identificar, considerar o produto como altamente perigoso;

4.4. Posicionar-se com o vento batendo nas costas, evitando assim inalação do produto;

4.5. Aproximar-se mantendo distância segura suficiente para identificar o produto nas placas fixadas no veículo (POP IAPH SBE E SBV-E 005 Regras gerais de condução/ estacionamento de veículo de emergência);

4.6. Informar ao MR as características do produto identificado;

4.7. Manter-se em local seguro até a chegada de autoridade local (Bombeiro/Polícia);

4.8. Acessar a vítima somente depois de autorizado por autoridade na cena (Bombeiro ou Policial Militar).

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Atente-se ao uso de EPI, incluindo os óculos de proteção.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP Central de Regulação e Intervenção 6-013 Uso de equipamentos de proteção individual (EPI);

6.2. POP IAPH SBE E SBV-E 005 - Regras gerais de condução/ estacionamento de veículo de emergência.

7. ANEXOS

7.1. Anexo 1- Imagens de identificação dos produtos:

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. Normatização Operacional 31/03/2015. Pacientes envolvidos em acidentes com produtos perigosos transportados em vias públicas.

9.2. UNITED NATIONS. Recommendations on the Transport of Dangerous Goods: Model Regulations. 21. rev. ed. New York; Geneva: United Nations, 2019.

9.3. Portarian°.2048/2002. Disponível em< https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html> Acesso em 20/12/2021.

9.4. PHTLS. Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado. National Association of Emergency Medical Technician, 2021. 9ª edição. 762 páginas.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Unificação dos protocolos de SBV e SIV 2. Atualização da definição de produtos perigosos, com ampliação dos tipos envolvidos. 3. Padronização e reorganização das etapas de abordagem da ocorrência. 4. Inclusão da orientação de não aproximação sem identificação prévia do produto. 5. Detalhamento da avaliação inicial de riscos (explosão, incêndio, vazamento e contaminação). 6. Inclusão de diretriz para considerar o produto altamente perigoso quando não identificado. 7. Vinculação do procedimento a POP institucional de condução e estacionamento. 8. Inclusão de recomendações explícitas quanto ao uso de EPI.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Célio Gouveia Marco Antônio B. Coelho Ronaldo Castelo Branco	Bárbara de Souza Joênia S. Moreira Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Segurança do paciente: conjunto estruturado de ações e atividades organizadas que promove a criação e o fortalecimento de culturas, processos, procedimentos, comportamentos, tecnologias e ambientes na área da saúde, com o objetivo de, de forma consistente e sustentável, reduzir riscos, minimizar a ocorrência de danos evitáveis, tornar o erro menos provável e mitigar seus impactos quando ocorrerem.

2. OBJETIVO

2.1. Padronizar as práticas da equipe de enfermagem no atendimento pré-hospitalar móvel, assegurando a segurança da vítima durante todo o processo assistencial.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, SAV, URAM e CRU.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. De acordo com a Nota Técnica de 2025 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), para a segurança do paciente no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel (APH) é necessário:

- Identificação correta do paciente;

- Comunicação clara e assertiva entre profissionais e serviços de saúde;
- Prevenção de lesões;
- Risco de queda;
- Administração segura de medicação;
- Controle de infecção.

Identificação correta da vítima:

4.2. Identificar o nome da vítima por completo em letra legível na ficha de atendimento, data de nascimento e idade;

4.3. Registrar o nome da mãe, independentemente da idade;

4.4. Confirmar identificação por meio de documentos e anotar o tipo de documento e seu número;

4.5. Encorajar a presença de familiares durante o atendimento e o acompanhamento para unidade de saúde;

4.5.1. Recomenda-se 1(um) acompanhante. Em casos excepcionais, um acompanhante extra pode ser autorizado, mediante avaliação da equipe, não excedendo o limite de cintos de segurança disponíveis;

4.6. Encorajar a vítima ou familiar a transportar pelo menos 01 documento pessoal durante o atendimento e o encaminhamento para unidade de saúde;

4.7. Vítimas com identidade desconhecida inconscientes ou confusas, o profissional do SAMU deve:

4.7.1. Buscar nos bolsos ou mochilas a procura de documentos;

4.7.2. Na ausência de documentos, utilizar como descrição para preenchimento da ficha características físicas (idade aproximada, sexo, cor da pele, altura aproximada), presença de cicatrizes, tatuagens, entre outros achados que julgar importante;

4.7.3. Anotar com exatidão o local/endereço onde a vítima se encontrava na chegada da equipe;

Pulseira de identificação

4.8. Verificar se o paciente possui documento de identificação oficial e, se possível, confirmar verbalmente o nome completo e a data de nascimento. Essa conferência é essencial para garantir que as informações registradas correspondam ao paciente atendido;

4.9. Quando o paciente estiver inconsciente ou sem identificação, deve ser atribuído um código provisório, utilizando a expressão "Paciente não identificado" acompanhada do número da ocorrência do SAMU;

4.10. Preencher a pulseira de forma legível, sem rasuras, utilizando letra de forma e tinta permanente. Devem constar o nome completo (ou identificação provisória), a data de nascimento e o número da ocorrência;

4.11. A pulseira deve ser colocada preferencialmente no punho do paciente, ajustando-se de forma firme e confortável. Se o membro estiver

impossibilitado por trauma, acesso venoso ou outro motivo, a pulseira pode ser fixada no tornozelo;

4.12. Garantir que a pulseira permaneça visível, legível e resistente durante todo o atendimento e transporte. A pulseira não deve ser removida até a entrega formal do paciente na unidade receptora;

4.13. Confirmar as informações da pulseira com o paciente, quando consciente, ou com o acompanhante, assegurando a veracidade dos dados;

Comunicação clara e assertiva entre profissionais e serviços de saúde

4.14. Solicitar à CRU informações previstas sobre a ocorrência;

4.15. Manter comunicação ativa com seus colegas de equipe, confirmando procedimentos ordenados e efetuados, garantindo que todos tenham acesso às informações;

4.16. Atualizar status de atendimento em tempo real junto à Central;

4.17. Executar a passagem de dados na unidade de saúde (POP IAPH SBV E SBV-026 – Passagem do Caso na Unidade de Saúde);

Prevenção de lesões

4.18. Fazer a checagem dos materiais e equipamentos diariamente mediante checklist e registro;

4.19. Realizar a escolha do local e do dispositivo adequados para a via medicamentosa;

4.20. Inspecionar regularmente dispositivos para detectar falhas ou sinais de desvio para a realização da troca, caso necessário;

4.21. Realizar a fixação correta de dispositivos, usados no paciente, para evitar deslocamentos e traumas;

4.22. Atentar para a prevenção de lesões durante a assistência;

Administração segura de medicamentos

4.23. Verificar a validade dos medicamentos e dos equipamentos e reportar ao setor competente;

4.24. Observar as condições de armazenamento dos insumos, prazo de validade e integridade de invólucros;

4.25. A administração de medicamentos deve ser realizada conforme protocolo institucional, capacitação e somente após regulação médica;

4.26. Usar a regra dos 13 certos;

4.26.1. Paciente certo;

4.26.2. Medicamento certo;

4.26.3. Via de administração certa;

4.26.4. Prescrição certa;

4.26.5. Horário certo;

4.26.6. Dose certa;

4.26.7. Ação certa;

4.26.8. Tempo de administração certa;

4.26.9. Compatibilidade certa;

4.26.10. Registro certo da administração;

4.26.11. Orientação certa;

4.26.12. Forma certa;

4.26.13. Resposta certa.

4.27. Identificar alergias medicamentosas ou doenças pré-existentes antes de administrar qualquer medicamento;

4.28. Realizar a técnica de antissepsia com álcool a 70% nas seguintes situações: punção venosa e administração de medicamentos ou soluções EV;

4.29. Realizar a antissepsia em conexões e injetores laterais com álcool e gaze antes de utilizá-los, fazendo movimentos circulares por 03 vezes;

4.30. Avaliar a permeabilidade dos cateteres intravenosos e a presença de complicações como infiltrações antes da administração de medicamentos e soluções EV;

4.31. Observar a ocorrência de eventos adversos após administração de medicamentos e soluções e se houver, comunicar à CRU;

4.32. Registrar na ficha de atendimento: medicação/solução administrada (nome, dose ou volume, horário da administração, local anatômico, o calibre e tipo de dispositivo) conforme protocolo institucional e o nome do MR;

4.33. Anotar na ficha o horário da realização de procedimentos invasivos;

4.34. Registrar toda e qualquer intercorrência ou evento adverso no uso de dispositivos e medicações.

Prevenção de Queda:

4.35. Atentar para os fatores de risco de queda: idade < 5 ou > 65 anos; presença de agitação e/ou confusão mental e déficits sensoriais; uso de calmantes; visão reduzida; dificuldade de marcha; mobiliário e acessos: berço, camas, escadas, tapetes, macas, iluminação inadequada, pisos escorregadios, superfícies irregulares; calçados, vestuário, bengalas ou andadores não apropriados;

4.36. Sempre manusear e travar a maca ou cadeira de rodas corretamente, garantindo que esteja posicionada até o nível do chão para atender ou transferir o paciente;

4.37. Transportar em prancha longa e/ou maca com utilização de cintos de segurança e grades de proteção elevadas;

4.37.1. Os cintos devem ser afivelados antes da elevação da maca;

4.37.2. Em terrenos acidentados, transportar o paciente com a maca rebaixada;

4.38. Auxiliar no deslocamento da vítima que deambula;

4.39. Considerar necessidade de contenção física em caso de agitação ou confusão mental conforme POP IAPH SBV e SBV-E 098 – Contenção Física e Mecânica;

4.40. Registrar na ficha ocorrência de queda com a equipe de APH, se houver;

4.41. Informar o MR e equipe na unidade de saúde em casos de queda;

4.42. Rebaixar a maca e manter grades elevadas quando essa for permanecer retida na unidade de saúde.

Controle de infecção

4.43. Seguir rigorosamente o protocolo de biossegurança e de limpeza da AM, equipamentos e artigos reprocessáveis; citar protocolos

4.44. Executar a higienização das mãos adequadamente por meio da lavagem ou com álcool gel 70%;

4.45. Realizar fixação adequada do cateter para evitar risco de nova punção;

4.46. Utilizar luvas de procedimento descartáveis durante o cuidado com o paciente, reduzindo o risco de contaminação e infecção cruzada.

Vítima envolvida com a segurança: Práticas cotidianas na minimização de erros

4.47. Informar sobre todos os procedimentos que serão realizados, potenciais benefícios e riscos;

4.48. Utilizar linguagem apropriada e confirmar se a informação passada foi compreendida. Se necessário, repetir;

4.49. Abrir espaço para a apresentação de dúvidas e respeitar pausas silenciosas;

4.50. Manter atenção à vítima que se enquadre dentro dos protocolos de situações especiais.

Segurança na utilização de tecnologias: Práticas cotidianas na minimização de erros

4.51. Fazer a checagem por turno, no início de cada plantão, dos equipamentos da ambulância e avaliar condições de funcionamento: DEA, oxímetro, aparelho PA, fluxômetro, aspiradores, entre outros;

4.52. Informar a CRU e a chefia sobre a ~~da~~ anormalidade detectada no(s) equipamento(s).

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

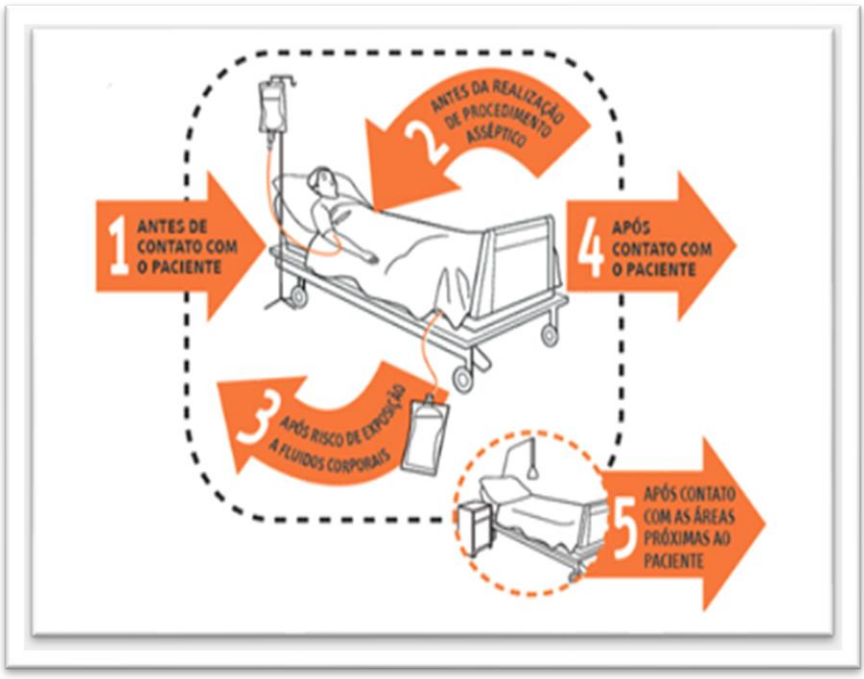
5.1. Não há.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP IAPH SBV e SBV-E 098 – Contenção Física e Mecânica

7. ANEXOS

7.1. Figura1: Os cinco momentos para higiene das mãos:



8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. Portaria nº. 2048/2002-SMS G/CR. Disponível em <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html> Acesso em 20/12/2021.

9.2. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM (COREN). Nota Técnica nº 1/2025/Plenário. Processo nº 00196.004879/2023-13. Nota técnica sobre segurança do paciente no atendimento pré-hospitalar móvel (APH): contextos; conceitos; aspectos éticos; gerenciamento de riscos e manejo seguro do paciente. Brasília, 2025.

9.3. World Health Organization (WHO). Global patient safety action plan 2021–2030: towards eliminating avoidable harm in health care [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2021 [cited 2021 Jun 09]. Disponível: https://www.who.int/teams/ integrated-health-services/patient-safety/policy/global-patient-safety-action-plan

9.4. COREN/ REBRAENSP, 2010. Disponível em <http://enfermagemesaude.com.br/downloads/124/cartilha-10-passos-para-a-seguranca-do-paciente> Acesso em 20/12/2021.

9.5. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 36, de 25 de julho de 2013. Institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 143, p. 32–33, 26 jul. 2013.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
06	02/02/2026	Atualização 1. Atualização do conceito de "Segurança da Vítima" para "Segurança do Paciente", alinhado às diretrizes nacionais e à Nota Técnica COFEN (2025). 2. Ampliação do escopo do POP, estruturando práticas de segurança no APH móvel. 3. Inclusão dos principais eixos de segurança do paciente: identificação correta, comunicação, prevenção de lesões e quedas, administração segura de medicamentos e controle de infecção. 4. Inclusão e padronização do uso de pulseiras de identificação, com critérios para preenchimento, colocação, manutenção e identificação provisória do paciente. 5. Detalhamento dos procedimentos, registros e responsabilidades da equipe assistencial. 6. Ampliação das áreas envolvidas, contemplando todas as modalidades operacionais do SAMU e a CRU.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Elaine C. S. M. Machado Simone Cedano Ramos Edson Barbosa S. Junior Rita de Cassia G. Batista	Amanda de Ornelas Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nádia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Acidente com a equipe na ambulância: qualquer evento inesperado ocorrido durante o deslocamento ou atendimento, envolvendo a viatura do SAMU 192 e que resulte, ou possa resultar, em lesão física, dano material, exposição ao risco biológico ou comprometimento da segurança dos profissionais, pacientes ou terceiros.

2. OBJETIVO

2.1. Estabelecer os procedimentos a serem seguidos quando a equipe da ambulância do SAMU 192 São Paulo se envolver em um acidente durante o atendimento, com ou sem vítima a bordo, visando garantir a segurança da equipe e de terceiros.

3. EQUIPES ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e CRU.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

Acidente que ocorre durante o deslocamento para o chamado ou no retorno à base:

4.1. Informar imediatamente ao Médico Regulador (MR) o local exato do acidente, a existência de vítimas (da equipe ou de terceiros), e a situação geral da cena;

4.2. Sinalizar adequadamente o local para garantir a segurança da equipe e dos demais envolvidos; caso não seja possível, solicitar apoio para a sinalização;

4.3. Prestar atendimento às vítimas conforme os protocolos estabelecidos;

4.4. O MR deve tomar as decisões operacionais e acionar os recursos necessários para o atendimento da equipe envolvida no acidente;

4.5. Comunicar ao CORE, informando o tipo de acidente, eventuais avarias na ambulância (AM) e a necessidade de remoção por guincho.

ATENÇÃO

4.6. CORE entrará em contato com o coordenador de frota, STA e/ ou condutor administrativo;

4.7. CORE será responsável pela liberação da equipe para:

4.7.1. Avaliação médica em pronto atendimento;

4.7.2. Registro do boletim de ocorrência (B.O.);

4.7.3. Abertura da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT);

4.7.4. Troca da ambulância, se necessário.

Acidente ocorrido durante o deslocamento para a unidade de saúde com vítima embarcada:

4.8. Sinalizar o local do acidente para garantia de segurança;

4.9. Avaliar e tranquilizar a vítima/ acompanhante (já embarcada) na AM;

4.10. Atender às vítimas do acidente, conforme protocolo;

4.11. Comunicar ao CORE e solicitar apoio necessário;

4.12. No caso de acidente sem vítimas na cena, sendo apenas pequenas avarias aos veículos e AM em condições de transporte, comunicar ao MR e prosseguir para a unidade de saúde;

4.13. Comunicar o CORE sobre: o tipo de acidente, danos na ambulância e, se aplicável, a necessidade de guincho.

ATENÇÃO

4.14. CORE entrará em contato com o coordenador de frota;

4.15. CORE irá liberar equipe para realizar boletim de ocorrência (BO) e troca de AM se necessário.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Para a realização do BO, a equipe deverá se deslocar com a própria AM, se houver condições. Caso não seja possível, comunicar CORE para as devidas providências.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. SÃO PAULO (Município). Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Paulo. Lei nº 8.989, de 29 de outubro de 1979. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos. Disponível em: *https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/*.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Atualização e ampliação da definição 2. Padronização do objetivo 3. Reorganização e detalhamento do fluxo de comunicação 4. Inclusão explícita das responsabilidades do CORE após o acidente 5. Maior clareza nos procedimentos em acidentes com e sem vítima embarcada. 6. Padronização das orientações operacionais e administrativas pós-acidente. 7. Inclusão de observações/recomendações para registro de BO e logística da ambulância.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cássia Oliveira Lopes	Daiane M. F. Souza Simone Dorna Elaine C. S. M. Machado Fernanda Vaz Tostes Marcia C. Leão Barreiros Maria Claudinea A. Reis Sérgio José da Silva	Amanda de Ornelas Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Acidente de trabalho com material biológico é todo evento ocorrido durante o exercício profissional, envolvendo exposição direta ou indireta do trabalhador a material biológico potencialmente contaminado por microrganismos patogênicos (vírus, bactérias, fungos, príons ou protozoários), por meio de material perfurocortante ou por contato com pele não íntegra, mucosas ou outras vias de exposição.

1.2. As exposições ocupacionais podem ser:

1.2.1. Exposições percutâneas: penetração através da pele de instrumentos perfurantes ou cortantes (agulha, bisturis, vidrarias) e mordedura humana contaminados com sangue ou outros líquidos orgânicos potencialmente infectantes (p.ex. agulhas, bisturi, vidrarias);

1.2.2. Exposições em mucosas: contato direto da mucosa (olho, nariz, boca ou genitália) com sangue ou outros líquidos orgânicos potencialmente infectantes;

1.2.3. Exposições cutânea (pele não íntegra): contato direto da pele com solução de continuidade (ex.: pele com dermatite ou feridas abertas) com sangue ou outros líquidos orgânicos potencialmente infectantes;

1.2.4. Exposições cutânea (pele íntegra): Contato da pele sem solução de continuidade com sangue ou outros líquidos orgânicos potencialmente infectantes.

1.3. Unidade tipo A: unidade que recebe a vítima, que irá prestar o primeiro atendimento ao acidentado;

1.4. Unidade tipo B unidade que fará o acompanhamento – SAE/IST AIDS.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever as condutas imediatas e administrativas que deverão ser tomadas aos profissionais do SAMU 192 São Paulo em caso de acidente de trabalho com material biológico.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e CRU.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Realizar as medidas imediatas abaixo de acordo com o tipo de contaminação:

<u>Se houve exposição em mucosas</u>

4.2. Lavar com soro fisiológico ou água corrente em abundância;

<u>Se exposição percutânea</u>

4.3. Lavar imediatamente com água e sabão ou solução antisséptica com detergente (PVPI, clorexidina);

4.4. Não espremer o local;

4.5. Não utilizar produtos irritantes para evitar aumentar a área de exposição;

Se exposição cutânea

4.6. Lavar imediatamente com água e sabão ou solução antisséptica com detergente (PVPI, clorexidina)

4.7. Comunicar o acidente ao MR e ao CORE;

4.8. O acidente de trabalho com material biológico é classificado como atendimento de urgência. Portanto, na passagem do caso ao CORE, deve-se avaliar a situação do atendimento à vítima, verificando se este poderá ser concluído pela própria equipe ou se será necessário encaminhar uma equipe ou colaborador de apoio, a fim de que o profissional acidentado seja liberado para atendimento na unidade de referência.

4.9. O ideal é que o CAT seja aberto na mesma unidade em que o paciente fonte deu entrada (tipo A), de modo que, havendo consentimento do paciente, as sorologias (HIV, Hepatites B e C) deste paciente possam ser realizadas imediatamente, permitindo que o funcionário já possua os resultados para apresentar na unidade de referência (tipo B).

4.10. Na impossibilidade de remoção do paciente para a unidade de saúde, este caso será classificado como "fonte desconhecida", e o acidentado pode ir direto para a unidade tipo B;

4.11. Ao chegar à unidade de saúde com a vítima, comunicar a equipe médica informando sobre o acidente com material biológico para a solicitação de um teste rápido ou sorologia do paciente fonte, seguindo as rotinas internas da unidade (tipo A);

4.11.1. Se for possível, a sorologia do acidentado também será realizada na unidade que recebeu a vítima e o acidentado;

4.11.2. Além da abertura do CAT, será realizada a notificação em ficha SINAN;

4.11.2.1. O SINAN gera uma numeração específica para cada ficha de notificação, permitindo identificar, rastrear e acompanhar cada caso registrado no sistema. Essa numeração assegura organização, controle e continuidade da investigação epidemiológica.

4.12. O funcionário deve procurar uma unidade de saúde (tipo B), de preferência, um Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) ou Serviço de Atendimento Especializado (SAE/DST/AIDS) no município de São Paulo. (Lista dos endereços da rede municipal especializada em IST/ AIDS- anexo 6.2), com a numeração informada do SINAN;

4.13. A profilaxia pós-exposição deve ser o mais rápido possível, tendo como limite o prazo de 72 horas em casos de paciente fonte desconhecido ou HIV positivo;

4.14. Na unidade tipo B, comunicar ao médico que ocorreu o acidente com material biológico, levando informações sobre os dados do paciente-fonte (se identificado) e o tipo de material envolvido;

4.15. Atentar-se ao aconselhamento ofertado da unidade de saúde, com relação a necessidade de coleta de sorologia, da quimioprofilaxia e do esquema de vacinação.

Procedimentos administrativos:

4.16. O Acidente de Trabalho deverá ser comunicado imediatamente, pelo acidentado ou qualquer pessoa que dele tiver conhecimento, à chefia imediata do servidor acidentado;

4.17. O chefe imediato deverá comunicar o acidente à unidade de gestão de pessoas a que estiver vinculado, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contadas do conhecimento do fato, sob pena de responsabilidade;

4.18. O servidor deve comparecer no seu RH de referência, dentro do prazo para assinatura e retirada das quatro vias da CAT. Caso o servidor não esteja em boas condições de saúde para assinar a CAT, deve ser assinada por uma testemunha do acidente.

4.19. Em caso de funcionário de empresa terceirizada, este deve comunicar o ocorrido à coordenadora da empresa, seguindo os protocolos e fluxogramas internos da contratada;

4.20. Siga o POP IAPH SBV E SBV-E 012- Acidente de Trabalho.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. O acidentado deve evitar: manter relações sexuais sem o uso de preservativo, engravidar, amamentar, doar sangues, órgãos e sêmen até o final do acompanhamento até 180 dias após exposição (janela imunológica).

5.2. Não há obrigatoriedade de abertura de CAT nos casos de contaminação cutânea por secreção biológica em pele íntegra, desde que não haja lesão, ferimento, corte, dermatite ou outra solução de continuidade.

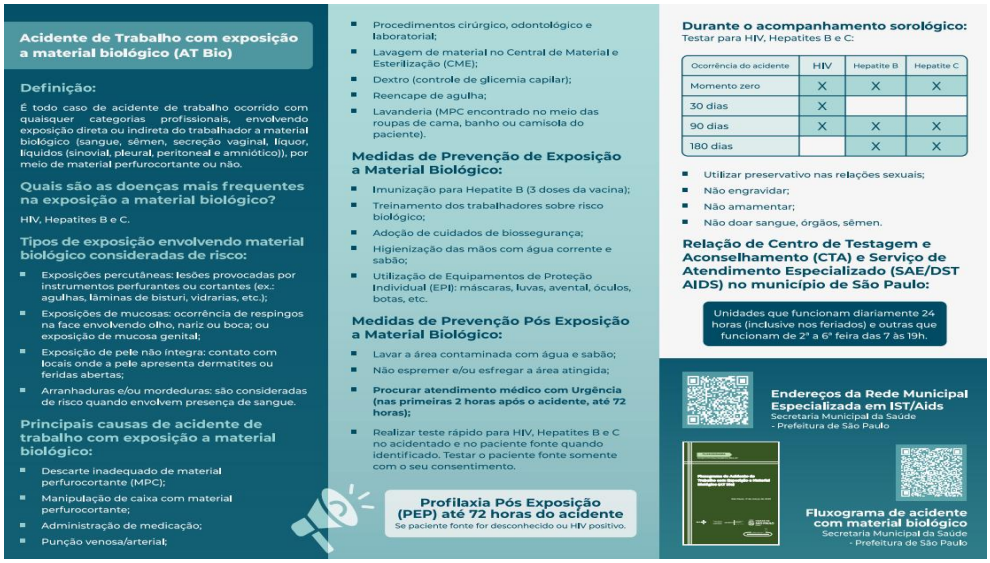
5.2.1. Isso porque, tecnicamente, a pele íntegra funciona como barreira de proteção, não configurando, por si só, exposição ocupacional com risco significativo.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP IAPH 012 - Acidente de Trabalho.

7. ANEXOS

7.1. Folder de Acidente de Trabalho com exposição a material biológico (AT BIO) da COVISA



7.2 Endereços de Rede Municipal Especializada em IST/ AIDS

ENDEREÇOS DA REDE MUNICIPAL ESPECIALIZADA EM IST/AIDS		
Região Central		
CTA HENFIL	R. do Tesouro, 39 - Centro	Tel.:(11)5128-6186 (11) 9 7744-8964
SAE Campos Elíseos	Al. Cleveland, 374 - Santa Cecília	(11) 5237-7551 e (11) 5237-7552 (11) 97744-5452
AMA SÉ	R. FREDERICO ALVARENGA, 259 – TÉRREO	TEL.: 3101-8841 / 3101-8833
UPA VERGUEIRO	R. VERGUEIRO, 613 - LIBERDADE	TEL.: 4040-1067
Região Norte		
SAE NOSSA SENHORA DO Ó	Av. Itaberaba, 1.377 - Freguesia do Ó	Tel.: (11) 5237-6016 (11) 9 5898-8741
CTA PIRITUBA	Av. Dr. Felipe Pinel, 12 - Pirituba	Tel.: (11) 5237-6395 | 5237-6397/ (11) 9 5254-3211
SAE SANTANA	R. Dr. Luís Lustosa da Silva, 339 - Mandaqui	Tel.: (11) 5237-7566 | 5237-7565/ (11) 9 5898-9122
UPA JAÇANÃ	R. ESTER ELISA, 229 - VILA NILO	TEL.: 95943-5289
UPA PIRITUBA	AV. MENOTTI LAUDISIO, 100 - PIRITUBA	TEL.: 3974-8726

Região SUL		
SAE SANTO AMARO	R. Padre José de Anchieta, 640 – Santo Amaro	Tel.: (11) 5283-8330 WhatsApp: (11) 9 7744-1580
CTA SANTO AMARO	R. Mário Lopes Leão, 240 – Santo Amaro	Tel.: (11) 5686-5342 WhatsApp: (11) 9 7744-5151
CTA JOSÉ ARAUJO FILHO	R. Louis Boulanger,120, Jardim Bom Refúgio	Tel.: (11) 5897-4832 | 5891-6604/ (11) 9 4947-0385
SAE JARDIM MITSUTANI	R. Vittório Emanuele Rossi, 97 – Jd. Bom Refúgio	Tel.: (11) 5841-5376 (11) 9 7744-1630
SAE CIDADE DUTRA	R. Cristina de Vasconcelos Ceccato, 109 – Cidade Dutra	Tel.: (11) 5666-8301 (11) 9 7744-8288
SAE M'BOI MIRIM	R. Deocleciano de Oliveira Filho, 641 – Pq. Santo Antônio	Tel.: (11) 5108-7320 / (11) 9 5898-8499
AMA 24 HORAS CAPÃO REDONDO	AV. Comendador, 774 Santana	TEL.: 5872-9900
UPA SANTO AMARO - DR. JOSÉ SYLVIO DE CAMARGO	R. CARLOS GOMES, 661 - SANTO AMARO	TEL.: 5525-8700
UPA DONA MARIA ANTONIETA F BARROS	R. ANTONIO FELIPE FILHO, 180 - GRAJAÚ	TEL.: 5972-9883 / 5928-0345 / 5927-4938

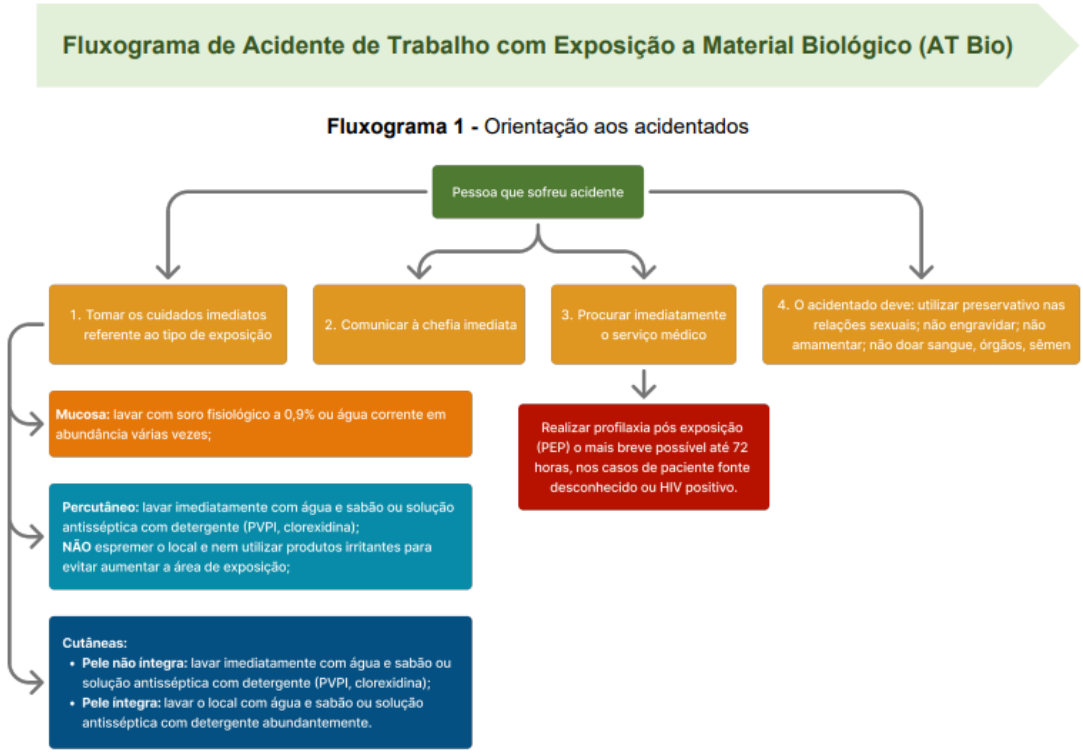
Região Sudeste		
SAE JABAQUARA	Rua dos Comerciários, 236 - Jabaquara	Tel.: (11) 5237-8845 (11) 9 5254-2431
SAE VILA PRUDENTE	Pça. Centenário de Vila Prudente, 108 - Vila Prudente	Tel.: (11) 5237-8480 | 5237-8480/ (11) 9 7744-1359

	Região Sudeste - continuação	
SAE PENHA	Pça. Nossa Senhora da Penha, 55 - Penha	Tel.: (11) 5237-8881 | 5237-8880 (11) 9 7744-4500
SAE HERBERT DE DOUZA	Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 515 - Teotônio Vilela	Tel.: (11) 5237-5992 (11) 9 5254-1211
SAE IPIRANGA	R. Gonçalves Ledo, 606 - Ipiranga	Tel.: (11) 5237-8861 | 5237-8860 WhatsApp: (11) 9 7744-5614
CTA MOOCA	R. Taquari, 549 — salas 9 e 10 - Mooca	Tel.: (11) 5237-8606 WhatsApp: (11) 9 7744-8200
UPA MOOCA	R. DR. FOMM, 261 - BELENZINHO	TEL.: 3245-9020
UPA VILA MARIANA	R. DR. DIOGO DE FARIA, 609 - VILA CLEMENTINO	TEL.: 3245-9010
AMA SACOMÃ	ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 1403 - IPIRANGA	TEL.: 2591-2016
AMA JARDIM NORDESTE	R. NICOLO TARTÁGLIA, 145 - ARTUR ALVIM	TEL.: 2280-6211

	Região Leste	
CTA CIDADE TIRADENTES	R. Milagre dos Peixes, 357 - Cidade Tiradentes	Tel.: (11) 5237-8585/ (11) 9 4947-6346
CTA DR SERGIO AROUCA	R. Valente Novais, 131 - Itaim Paulista	Tel.: (11) 5237-8635 | 5237-8636/ (11) 9 7744-1756
SAE SÃO MATHEUS	R. José Aldo Piassi, 85 - São Miguel Paulista	Tel.: (11) 5237-8626 | 5237-8621/ (11) 9 7744-8253

Região Leste - continuação		
CTA GUAIANASES	R. Centralina, 168 - Guaianases	Tel.: (11) 5237-8596 (11) 9 5898-2728
SAE CIDADE LÍDERII	R. Médio Iguaçu, 86 - Cidade Líder	Tel.: (11) 5237-8892 | 5237-8893/ (11) 9 5254-0599
SAE FIDÉLIS RIBEIRO	R. Peixoto, 100 - Vila Fidélis Ribeiro	Tel.: (11) 5237-8932 (11) 9 5898-4962
UPA CIDADE TIRADENTES	Rua Igarapé da Diana, 1- Cidade Tiradentes	
UPA TITO LOPES	AV. Pires do Rio, 294- Vila Americana	TEL.: (11) 4780-5114
UPA ERMELINO MATARAZZO	R.Miguel Novais , 113 Vila Paranaguá	TEL.: 2574-3258
Região Oeste		
SAE BUTANTÃ	Rua Dr. Bernardo Guertzenstein, 45 - Jardim Sarah	Tel.: (11) 5239-0228 | 5239-0234 | 5239-0235 (11) 9 7744-4984
SAE LAPA	Rua Tome de Souza, 30 - Lapa	Tel.: (11) 3832-8618 (11) 9 5898-5432
AMA SOROCABANA	R. Catão ,380- Romana	TEL.: 3879-3090
PSM DR. CAETANO VIRGÍLIO NETTO	R. Augsto Farina, 1125- Butantã	TEL.: 3731-6018
PS MUNICIPAL PROF. JOÃO CATARIN MEZOMO	Av Queiroz Filho, 313- Vila Hamburguesa	TEL.: 4878-1722

8. FLUXOGRAMA



https://prefeitura.sp.gov.br/documents/d/saude/fluxograma-pdf

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Paulo (Lei nº. 8.989, de 29 de outubro de 1979).

9.2. BRASIL. Ministério da Saúde. Exposição a materiais biológicos. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2006. (Série A. Normas e Manuais Técnicos).

9.3. Portaria nº. 2048/2002-SMS G/CR. Disponível em <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html> Acesso em 20/12/2021.

9.4. SÃO PAULO (Município). Decreto nº 64.014, de 24 de janeiro de 2025. Regulamenta a concessão de licenças médicas, readaptação funcional, horário-amamentação, benefício assistencial, exame médico admissional e demais disposições relacionadas à saúde do servidor público municipal. Diário Oficial da Cidade de São Paulo, São Paulo, 27 jan.2025.Disponívelem:*https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto- 64014 -de-24-de-janeiro-de-2025*. Acesso em: 04 set. 2025.

9.5. SÃO PAULO (Município). Coordenadoria de Gestão de Saúde do Servidor – COGESS. Comunicado nº 003/COGESS/2025, de 23 de junho de 2025. Informa a publicação da versão atualizada dos Protocolos Técnicos Periciais da COGESS. Diário Oficial da Cidade de São Paulo, São Paulo, 23 jun. 2025. Disponível em: *https://prefeitura.sp.gov.br/documents/d/gestao/18-06-protocolos-tecnicos-cogess-pdf*.Acesso em: 04 set. 2025.

9.6. SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal da Saúde. Coordenadoria de Vigilância em Saúde – COVISA. Divisão de Vigilância em Saúde do Trabalhador –DVISAT. Fluxograma de Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico(ATBio).São Paulo: COVISA/SMS-SP, 11 de março de 2025.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
06	02/02/2026	Atualização 1. Atualização do título e do objetivo, direcionando o documento para exposições ocupacionais a material biológico. 2. Inclusão de definições técnicas detalhadas, com classificação dos tipos de exposição (percutânea, mucosa, cutânea íntegra e não íntegra). 3. Ampliação das áreas envolvidas, passando a contemplar SBV, SBV-E, URAM e CRU. 4. Detalhamento das condutas imediatas pós-exposição, conforme tipo de contaminação. 5. Inclusão de fluxo assistencial estruturado, com definição de unidade tipo A (paciente-fonte) e tipo B (SAE/CTA). 6. Padronização das responsabilidades administrativas, incluindo abertura de CAT, notificação no SINAN e prazos legais. 7. Incorporação das diretrizes de profilaxia pós-exposição, com prazos e orientações de acompanhamento. 8. Inclusão de orientações comportamentais ao trabalhador acidentado durante o período de janela imunológica. 9. Vinculação a POP correlato e inclusão de anexos e fluxograma, fortalecendo o respaldo técnico e operacional.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cássia Oliveira Lopes	Fatima Sanchez Mesquita Vitor Roberto de S Martins Reinaldo Cirilo dos Santos Simone Cedano Ramos	Amanda de Ornelas Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. Acidente de trabalho: de acordo com o art. 19 da Lei nº 8.213/91, considera-se acidente de trabalho aquele que ocorre pelo exercício da atividade a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 da mesma lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que resulte em morte, perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho;

1.2. Consideram-se acidentes de trabalho aqueles ocorridos:

1.2.1. Durante o período destinado à refeição ou descanso, no local de trabalho ou durante sua execução;

1.2.2. Os relacionados ao trabalho, ainda que não sejam a causa única, mas tenham contribuído diretamente para a morte, redução da capacidade laboral ou ocasionado lesão que exija atenção médica;

1.2.3. Por agressão física, sabotagem ou ato de terrorismo praticado por terceiros no local de trabalho;

1.2.4. Por ofensa física decorrente de disputa relacionada ao trabalho;

1.2.5. Por imprudência, negligência ou imperícia de colega de trabalho;

1.2.6. Durante a execução de ordem ou serviço realizado sob autoridade da empresa;

1.2.7. No trajeto entre a residência e o local de trabalho (ou do local de trabalho para a residência), desde que sem desvios ou interrupções alheias à atividade laboral.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever as condutas e responsabilidades que devem ser adotadas após a ocorrência de acidente de trabalho com profissionais do SAMU 192 São Paulo.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. Todos os profissionais do SAMU, CRU, Recursos Humanos, COGESS.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

Conduta em caso de acidente durante o horário de trabalho:

4.1. Comunicar o acidente ao CORE e ao Gerente de Base imediatamente;

4.2. A própria equipe deve prestar os primeiros socorros, conforme a gravidade, ou solicitar apoio e aguardar a chegada de outra equipe de socorro;

4.3. O Médico Regulador orientará quanto ao encaminhamento à unidade de saúde, sendo obrigatório, independentemente da gravidade do acidente;

4.4. O servidor deverá comunicar o acidente à unidade de gestão de pesoas (RH) ao qual estiver vinculado, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contadas da ocorrência;

4.5. Em caso de funcionário de empresa terceirizada, organização social (OS), este deve comunicar o ocorrido à coordenadora da empresa, seguindo os protocolos e fluxogramas internos da contratada;

4.6. O servidor deve comparecer, dentro do prazo para assinatura e retirada das quatro vias do CAT; caso o servidor não esteja em boas condições de saúde para assinar a CAT, ela deve ser assinada por uma testemunha do acidente;

4.7. O RH deve enviar solicitação de agendamento ao COGESS, anexando o CAT e os documentos médicos;

4.8. O COGESS agenda a perícia, sendo a data, o local e o horário publicados no Diário Oficial;

4.9. No dia da perícia, o servidor deve comparecer com:

4.9.1. CAT devidamente preenchido e impresso em quatro vias, assinada pela chefia e pelo servidor;

4.9.2. Documento de identificação com foto;

4.9.3. Último holerite;

4.9.4. Todos os subsídios médicos, inclusive novos, se houver;

4.10. Nas situações em que houver internação hospitalar do servidor, um familiar ou representante deverá comparecer à respectiva coordenação regional para receber orientações sobre os procedimentos cabíveis.

4.11. A licença produzirá efeitos a partir da data do acidente ou do diagnóstico da doença profissional ou do trabalho, constatada mediante avaliação pericial;

4.12. Documentos obrigatórios a serem apresentados no ato pericial em acidente de trajeto:

4.12.1. Prontuário e demais documentos relativos ao atendimento médico realizado logo após o acidente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;

4.12.2. Boletim de ocorrência policial, se houver;

4.12.3. Identificação de eventuais testemunhas do acidente, se existirem.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. O servidor afastado por acidente de trabalho só pode reassumir suas atividades após a expedição de laudo de alta médica pelo COGESS, independente dos dias de afastamento;

5.2. Todo acidente de trabalho deve ser registrado, mesmo que não haja necessidade de atestado médico. O atendimento deve ser comprovado por meio de ficha de atendimento, comprovante de horário, receituário médico ou documento equivalente;

5.3. Colaboradores da organização social (SPDM ou outra), devem comunicar a chefia direta sobre o andamento do processo junto a empresa.

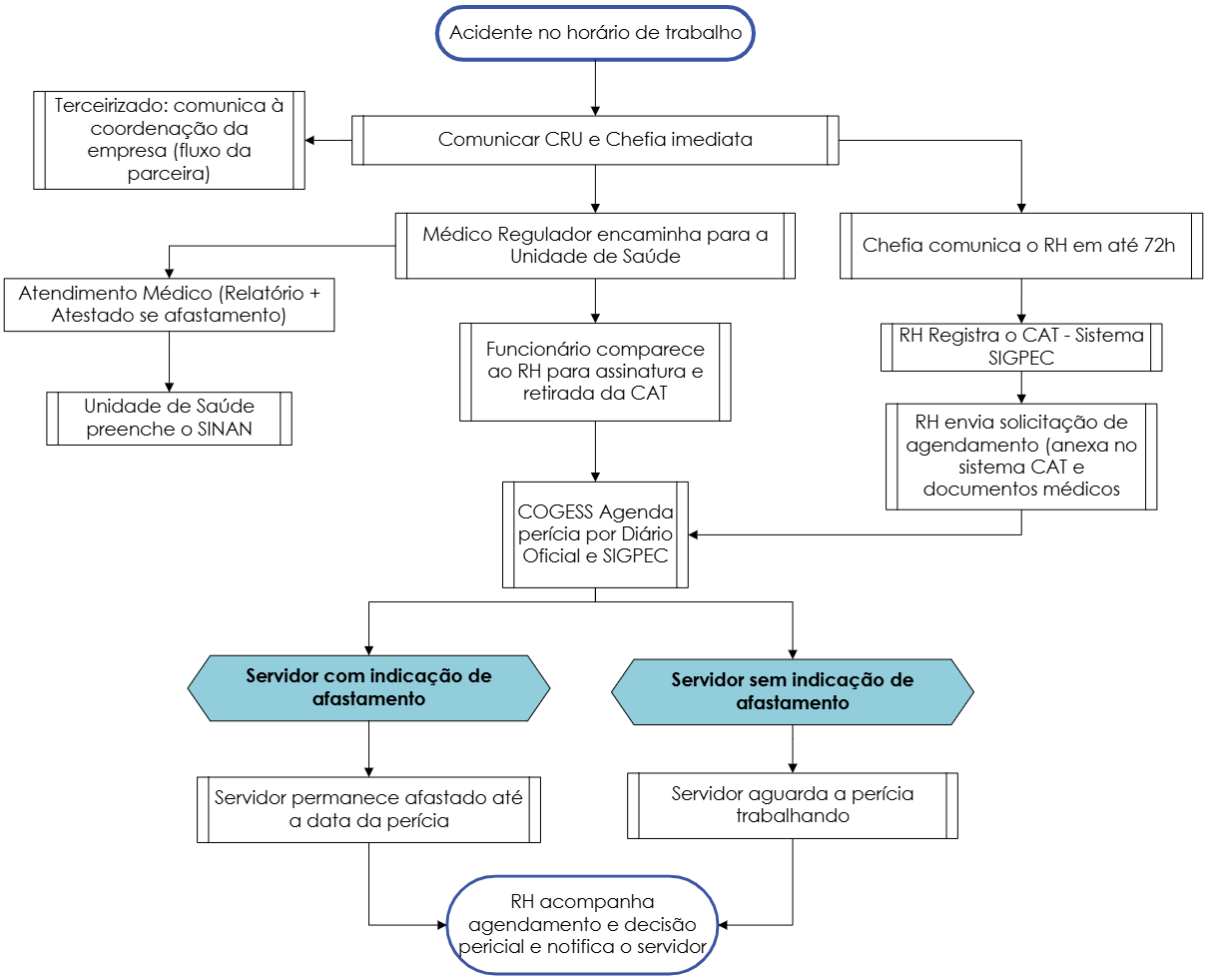
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA - ACIDENTE DE TRABALHO



9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Paulo (Lei nº. 8.989, de 29 de outubro de 1979).

9.2. Portaria nº. 2048/2002- SMS G/CR. Disponível em<https:// bvsms.saude .gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html> Acesso em 20/12/2021.

9.3. SÃO PAULO (Município). Decreto nº 64.014, de 24 de janeiro de 2025. Regulamenta a concessão de licenças médicas, readaptação funcional, horário-amamentação, benefício assistencial, exame médico admissional e demais disposições relacionadas à saúde do servidor público municipal. Diário Oficial da Cidade de São Paulo, São Paulo, 27 jan.2025.Disponívelem:*https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto- 64014 -de-24-de-janeiro-de-2025*. Acesso em: 04 set. 2025.

9.4. SÃO PAULO (Município). Coordenadoria de Gestão de Saúde do Servidor – COGESS. Comunicado nº 003/COGESS/2025, de 23 de junho de 2025. Informa a publicação da versão atualizada dos Protocolos Técnicos Periciais da COGESS. Diário Oficial da Cidade de São Paulo, São Paulo, 23 jun. 2025. Disponível em: *https://prefeitura.sp.gov.br /documents/d/gestao/18-06-protocolos-tecnicos-cogess-pdf*.Acesso em: 04 set. 2025.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Atualização e ampliação da definição de acidente de trabalho com detalhamento das situações caracterizadas em lei 2. Padronização do objetivo 3. Ampliação das áreas envolvidas. 4. Detalhamento e organização do fluxo de comunicação, com inclusão do Gerente de Base e RH. 5. Inclusão de prazos formais para comunicação do acidente e abertura do CAT. 6. Maior clareza nas responsabilidades do servidor, da chefia, do RH e do COGESS. 7. Padronização do processo de perícia médica, documentação exigida e publicação oficial. 8. Inclusão de orientações específicas para servidores terceirizados/OS. 9. Consolidação das regras para retorno ao trabalho 10. Inclusão de observações para registro obrigatório de todo acidente.

Última validação	Revisão	Validação	Aprovação
Cássia Oliveira Lopes	Simone Cedano Fatima Sanchez Mesquita Vitor Roberto de S Martins Reinaldo Cirilo dos Santos	Amanda de Ornelas Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. Pessoas com Deficiência: a Organização Mundial da Saúde (2001) define como pessoas com impedimentos de longo prazo que, em interação com as barreiras do ambiente, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.

1.2. Pessoa com Deficiência: o Ministério da Saúde, por meio da Lei Brasileira de Inclusão, define pessoa com deficiência como aquela que possui impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.

1.3. Idoso: pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003);

1.4. Classificação de faixa etária pelo PALS (Pediatric Advanced Life Support):

1.4.1. Recém-nascido: do nascimento até 28 dias de vida;

1.4.2. Lactente: entre 29 dias e 1 ano incompleto;

1.4.3. Criança: de 1 ano até o início da puberdade.

2. OBJETIVO

2.1. Estabelecer diretrizes, orientações e condutas para os profissionais do SAMU 192 São Paulo quanto à abordagem, comunicação e atuação nos atendimentos realizados a pessoas com deficiência, idosos e crianças, visando à promoção do cuidado seguro, humanizado, inclusivo e respeitoso.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, SAV, URAM e CRU

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

Para todas as vítimas com deficiência

4.1. Identifique-se pelo nome e função;

4.2. Transmita segurança;

4.3. Solicite a presença de um familiar ou responsável durante o atendimento;

4.4. Explique para a vítima ou familiar, os procedimentos a serem realizados;

4.5. Use palavras simples e de fácil compreensão, repetindo sempre que necessário.

Pessoa com deficiência auditiva

4.6. Fale pausadamente para que ele possa fazer leitura labial;

4.7. Utilize à escrita, se necessário.

Pessoa com deficiência visual

4.8. Verbalize os procedimentos a serem realizados;

4.9. Mantenha contato físico constante (com o braço sobre o ombro da vítima).

Pessoa com deficiência intelectual

4.10. Mantenha comunicação constante;

4.11. Dê tempo para que ele responda suas perguntas.

Idoso

4.12. Respeite suas limitações;

4.13. Compreenda os sentimentos de angústia e medo;

4.14. Evite exposição/pudor (Estatuto do Idoso).

Criança

4.15. É direito da criança ser acompanhada por um dos pais ou responsável legal durante o atendimento, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, Lei nº 8.069/1990, art. 12);

4.16. Na ausência de responsável legal no momento do atendimento, este fato deve ser imediatamente comunicado ao médico regulador (MR), sem prejuízo da realização do atendimento, garantindo a prioridade absoluta do direito à saúde da criança (ECA, art. 4º e art. 11, §2º);

4.17. Caso o responsável presente recuse-se a acompanhar a criança durante o atendimento, a situação deve ser encaminhada ao médico regulador para avaliação da conduta adequada, podendo, se necessário, ser comunicada à rede de proteção (ex.: Conselho Tutelar), conforme previsto no art. 98 do ECA;

4.18. Permita que a criança leve um objeto de estimação;

4.19. Utilize linguagem adequada para cada faixa etária, se possível, mantenha-se na mesma altura;

4.20. No caso de paciente sem condições de decidir e presença de acompanhante menor:

4.20.1. O menor é encaminhado junto com a vítima e deixado sob tutela do serviço social da unidade receptora. Registrar todos os dados do menor e do profissional que o recebeu na instituição.

<u>Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA):</u>

4.21. Antes de chegar no local de atendimento, desligue sirenes e luzes;

4.22. Observe o comportamento da pessoa antes de intervir;

4.23. Apresente-se e faça contato com a própria pessoa ou acompanhante;

4.24. Afaste objetos que possam trazer riscos;

4.25. Mantenha distância física respeitosa;

4.26. Evite tocar a pessoa sem consentimento, se precisar tocar, avise e explique antes de realizar o procedimento;

4.27. Se possível, encaminhe a pessoa para um local mais calmo, familiar e que traga segurança;

4.28. Use frases curtas e mantenha o tom de voz calmo;

4.29. Evite perguntas abertas ou ordens complexas;

4.30. Dê tempo para a pessoa responder/processar;

4.31. Não discuta, não eleve o tom de voz, não tente "convencer" a pessoa;

4.32. Evite julgamentos;

4.33. Se a pessoa usar estratégias para se regular, não impeça (se não houver risco);

4.34. Entenda que a crise não é proposital.

Pessoas em situação de rua

4.35. Permita que leve os pertences mínimos, desde que não comprometa o atendimento e não coloque a equipe em situação de risco ou exposição à contaminação.

Vítimas sem condições de decidir (inconsciente, sob efeito de substância) e/ou acompanhado de menor de 18 anos de idade, ou por pessoa outra pessoa igualmente sem condições de decidir

4.36. Informar ao Médico Regulador (MR) que a vítima está acompanhada por pessoa sem condições legais ou cognitivas de decidir;

4.37. Encaminhe o acompanhante junto à vítima quando não houver responsável legal presente para menor de idade, idoso vulnerável e/ou pessoa com deficiência. Não abandone a vítima;

4.38. Solicite apoio caso a situação cause atraso no atendimento;

4.39. Registre na ficha de APH o nome completo do acompanhante, endereço e o telefone de contato;

4.40. Anote todos os dados obtidos e orientações dadas na ficha de atendimento;

4.41. Informe ao enfermeiro ou médico da unidade de saúde que recebeu o paciente, para avaliação da necessidade de acionamento do serviço social do hospital;

4.42. Registre o nome completo e o número do Conselho do profissional que recebeu as informações sobre o acompanhante;

4.43. Comunique a CRU sobre o fechamento do chamado e o nome do profissional que recebeu a vítima.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Quando o paciente for cadeirante ou fizer uso de dispositivo auxiliar de locomoção (como bengala, muleta, andador ou cadeira de rodas), a equipe deverá transportar o referido recurso junto na viatura do SAMU e entregá-lo ao serviço hospitalar, garantindo que o paciente mantenha sua acessibilidade após possível alta;

5.2. É de competência da unidade de saúde de destino a localização do familiar, bem como, o acionamento do conselho tutelar para menores;

5.3. Situações de risco ou abandono devem ser comunicadas imediatamente a unidade de saúde na passagem de plantão e para CRU.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP Central de Regulação e Intervenção 6-009 – Transporte de Acompanhante de Paciente.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). OMS, 2001 Disponível em *https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42407/9788531407840_por.pdf?sequence=111*> Acesso em 16/01/2026.

9.2. Linha de Cuidado para Atenção às Pessoas com TEA e suas famílias na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Ministério da Saúde. Brasília: MS, 2015.

9.3. Estatuto da Criança e Adolescente. Lei 8069/1990. Disponível em < https://www.gov.br/mdh/ptbr/centrais-de-conteudo/crianca-e-adolescente/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-versao-2019.pdf > Acesso em 16/01/2026.

9.4. Estatuto do Idoso. Lei 10.741/ 2003. Disponível em <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estatuto_idoso_3edicao.pdf > Acesso em 16/01/2026.

9.5. Portarian°.2048/2002. Disponível em< https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html> Acesso em 16/01/2026.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
06	02/02/2026	Atualização 1. Adequação da terminologia para Pessoas com Deficiência, conforme Lei Brasileira de Inclusão e OMS. 2. Atualização conceitual para o modelo biopsicossocial da deficiência. 3. Ampliação das áreas envolvidas (SBV, SBV-E, SAV, URAM e CRU). 4. Padronização da estrutura do POP e maior clareza das responsabilidades. 5. Atualização das condutas para crianças, alinhadas ao ECA e à atuação do Médico Regulador. 6. Inclusão de orientações específicas para pessoas autistas. 7. Aprimoramento das condutas para vítimas sem condições de decidir, com reforço dos registros e da comunicação institucional. 8. Inclusão de recomendações de acessibilidade, garantindo continuidade do cuidado.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna Barbosa da Silva	Lilian Maria de Oliveira Fabiana Amparo Ferraz Jaqueline Flor da França Elaine C. S. M. Machado	Amanda de Ornelas Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. Animais de assistência ou de serviço: animais treinados para realizar tarefas específicas em benefício de uma pessoa com deficiência. Exemplos: cães-guia (para pessoas com deficiência visual), cães-ouvintes (para surdos), cães de alerta médico (para crises epilépticas ou hipoglicêmicas) e cães de suporte à mobilidade, entre outros;

1.2. Cão-guia: animal especialmente treinado para auxiliar pessoas com deficiência visual (cegueira total ou baixa visão), facilitando sua mobilidade e segurança no deslocamento;

1.3. Animal de estimação (ou animal doméstico) é aquele mantido pelo ser humano, principalmente por companhia, afeto ou lazer, e não por finalidade de trabalho, consumo ou pesquisa;

1.4. Acesso de animais acompanhantes: no Brasil, a Lei nº 11.126/2005 e o Decreto nº 5.904/2006 regulamentam o direito de acesso de cães-guia e cães de assistência a locais públicos e de uso coletivo.

1.5. Na cidade de São Paulo, a Lei Municipal nº 18.387/2026 reconhece cães de assistência de todas as categorias (cão-guia, cão-ouvinte, cão-alerta médico, cão de assistência ao autista e cão de apoio emocional) e garante acesso a locais públicos ou privados e transporte remunerado.

2. OBJETIVO

2.1. Estabelecer diretrizes para o atendimento de vítimas acompanhadas de animais pelos profissionais do SAMU 192 São Paulo, garantindo segurança à equipe, à vítima e ao animal, além de conformidade com a legislação vigente.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e CRU.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Durante o atendimento do chamado, a prioridade é o atendimento à vítima. Na presença do animal, deve-se usar o bom senso e avaliar se o tempo perdido com o animal não será atraso de atendimento à vítima. Caso a equipe identifique que haverá prejuízo ao atendimento, deve priorizar integralmente o cuidado à vítima, mantendo a segurança e o foco na assistência;

4.2. Na presença de cães de assistência, seguir as regras gerais feitas na abordagem de pessoas com deficiência;

4.3. Avaliar a presença de animais agressivos que representem risco à segurança da equipe. Caso identificar um animal agressivo, não se aproximar e solicitar apoio;

4.4. Em via pública, sem outra autoridade presente (Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, Zoonoses ou outros), caso o paciente indique alguém presente na cena para ficar com o animal, anotar os dados pessoais do indicado (nome completo, documento de identificação e telefone) e informar a CRU via rádio;

4.5. Se a vítima estiver sozinha com o animal de estimação em via pública e precisar ser removida, caso não se identifique alguém para cuidar do animal, a equipe deve comunicar a situação à CRU, que providenciará o acionamento de apoio externo (Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros ou setor de Zoonoses);

4.6. Se não houver quem se responsabilize pelo animal, verificar a possibilidade de deixá-lo preso, mantendo a segurança e conforto (se for possível) e comunicar a CRU para enviar apoio ao animal (Bombeiros, GCM ou Zoonose);

4.7. Em casos que envolvam pessoa com deficiência acompanhada de animal de assistência (como cão-guia), todos os esforços devem ser feitos para manter o animal junto à vítima;

4.8. Registrar na ficha de atendimento o destino do animal.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não é recomendado que a equipe realize o transporte de animais na ambulância (com exceção do cão-guia e cães de assistência). Essa prática pode representar risco à segurança da equipe;

5.2. O cão-guia deve ser transportado de forma segura e sem comprometer a atenção do condutor.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens. OMS, 1989. Disponível em < https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42407/9788531407840_por.pdf?sequence=111> Acesso em 16/01/2026.

9.2. Protocolo de Atendimento Pré-Hospitalar: Suporte Intermediário de Vida. São Paulo: Secretaria Municipal de Saúde – SAMU, 2022; 5ª edição. 391 p.

9.3. BRASIL. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 24 set. 1997.

9.4. São Paulo. Lei nº 18.387, de 09 de janeiro de 2026. Assegura e amplia o direito de ingresso e permanência de pessoas com deficiência acompanhadas de cães de assistência em locais de uso público ou privado no Município de São Paulo.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Atualização e ampliação das definições, diferenciando animais de assistência, cão-guia e animais de estimação, com alinhamento à legislação federal e municipal vigente. 2. Adequação do objetivo do POP, incorporando diretrizes de segurança para a vítima, equipe e animal. 3. Detalhamento das condutas operacionais, com priorização do atendimento à vítima, avaliação de risco, registro formal e acionamento de apoio externo quando necessário. 4. Padronização do manejo de animais de assistência, reforçando a permanência do cão-guia junto à vítima sempre que possível. 5. Inclusão de orientações restritivas quanto ao transporte de animais, visando à segurança da equipe e da operação

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna Barbosa da Silva	Lilian Maria de Oliveira Fabiana Amparo Ferraz Jaqueline Flor da França Elaine C. S. M. Machado	Amanda de Ornelas Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. Recusa de atendimento: a recusa de atendimento e/ou transporte a unidade de saúde é direito do cidadão, salvo vítimas incapazes de tomar decisões em virtude do quadro apresentado, considerando Resolução nº 2.232, de 17 de julho de 2019 - Diário Oficial da União.

1.2. Recusa de encaminhamento: quando a vítima, após avaliação e cuidados recusa ser encaminhado para uma unidade de saúde;

1.3. Dispensa da vítima: mesmo avaliada pela equipe de enfermagem, a dispensa da vítima na cena não é autorizada pelo Conselho Regional da Enfermagem.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever como os profissionais devem proceder à frente da recusa de atendimento e/ou transporte.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e CRU.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. A dispensa da vítima só é permitida mediante plena capacidade de discernimento da vítima;

4.2. Informar ao MR, após ter realizado avaliação primária e secundária da vítima, que as mesmas com condições de decisão, e sem risco de morte, recusaram o atendimento e/ou encaminhamento;

4.3. Informar ao paciente ou responsável legal sobre os riscos da recusa, incluindo as orientações do médico regulador;

4.4. Caso a recusa persistir, a equipe deverá entrar em contato com o MR pelo celular corporativo para que o mesmo confirme a decisão com a vítima;

4.5. Caso ocorra liberação do MR para manter vítima no local, registrar detalhadamente todas as informações sobre o fato;

4.6. Preencher a ficha de atendimento com atenção a parte da recusa e solicitar a assinatura do paciente ou responsável e de possíveis testemunhas (POP IAPH SBV E SBV-E 003 – Preenchimento da ficha de atendimento pela equipe de enfermagem);

4.7. Solicitar a assinatura da vítima e de alguma pessoa que tenha testemunhado a recusa.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Caso haja médico externo, proceder conforme protocolo específico (POP IAPH SBV E SBV-E 018 – Atendimento à vítima na presença de médicos e enfermeiros externos no local da ocorrência).

5.2. Plena capacidade: considera-se que pessoas sob efeito de drogas ilícitas ou de álcool não estão em plenas condições de capacidade para tomada de decisão ou participação segura em atendimentos.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP Intervenções em Atendimento Pré-Hospitalar 018 – Médicos e Enfermeiros externos no local da ocorrência;

6.2. POP Intervenções em Atendimento Pré-Hospitalar 003 – Fichas de atendimento.

7. ANEXOS

7.1. Parte da ficha de atendimento que faz referência a recusa:

Recusa de Atendimento/Encaminhamento:	Detalhar as orientações prestadas pela equipe e/ou pelo médico regulador, incluindo os riscos da	
Declaro, sob forma livre e esclarecida, que recuso o atendimento e/ou transporte oferecido pela equipe do SAMU, estando ciente dos riscos envolvidos.		
Assinatura do paciente ou responsável:		
Nome completo e grau de parentesco:		
Documento de identificação (RG/ CPF):		
Testemunhas	Nome:	Nome:
	Documento:	Documento:
	Assinatura	Assinatura

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens. OMS, 1989. Disponível em < *https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42407/9788531407840_por.pdf?sequence=111*> Acesso em 20/12/2021.

9.2. Estatuto da Criança e Adolescente. Lei 8069/1990. Disponível em < *https://www.gov.br/mdh/ptbr/* centrais-de-conteudo/crianca-e-adolescente/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-versao-2019.pdf > Acesso em 20/12/2021.

9.3. Estatuto do Idoso. Lei 10.741/ 2003. Disponível em < https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estatuto_idoso_3edicao.pdf > Acesso em 20/02/2021.

9.4. Portaria n°.2048/2002. Disponivel em< https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html> Acesso em 20/12/2021.

9.5. PARECER COREN SP nº. 006/2020. Disponível em < *https://portal.coren-sp.gov.br/wpcontent/* uploads/2020/06/Parecer-006.2020-Possibilidade-de-dispensa-de-paciente-comclassifica% C3%A7%C3%A3o-de-risco-nas-cores-azul-e-verde-pelo-Enfermeiro-2020-jun-rev.pdf

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Inclusão e padronização de definições claras sobre recusa de atendimento, recusa de encaminhamento e dispensa da vítima. 2. Atualização do objetivo 3. Reorganização do fluxo de procedimento. 4. Reforço da obrigatoriedade de comunicação com o Médico Regulador. 5. Inclusão da orientação obrigatória à vítima ou responsável quanto aos riscos da recusa. 6. Padronização do registro documental. 7. Inclusão de critérios de capacidade de decisão, com restrições para álcool, drogas e gestantes. 8. Inserção de observações e protocolos complementares, garantindo respaldo técnico, ético e legal à equipe.

Última validação	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna Barbosa da Silva	Lilian Maria de Oliveira Fabiana Amparo Ferraz Jaqueline Flor da França	Henrique CSAL Costa Filho Bárbara de Souza Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. Prontidão é o estado de disponibilidade total da equipe e dos recursos operacionais do SAMU para o atendimento imediato às ocorrências de urgência e emergência.

1.2. Tempo de prontidão: intervalo compreendido entre o momento em que a equipe finaliza o recebimento do chamado pela CRU e o instante em que ocorre o início do deslocamento.

2. OBJETIVOS

2.1. Estabelecer diretrizes e responsabilidades para garantir a prontidão operacional das equipes e dos recursos do SAMU 192 São Paulo, assegurando resposta imediata, organizada e eficiente às situações de urgência e emergência.

3. EQUIPES ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM, OD, SAV, VIR e CRU

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Portar obrigatoriamente celular, HT e tablet ligados e carregados, junto com a equipe, assegurando disponibilidade de todos os meios de comunicação oficiais;

4.1.1. O rádio deverá ficar na canaleta correta, conforme a região de atuação.

4.2. Manter o rádio sempre ligado em volume audível;

4.3. O profissional deve manter-se uniformizado, com o uniforme completo e padronizado, fornecido pela instituição, durante todo o período de trabalho;

4.4. O profissional deve dar QAP no rádio já uniformizado informando o nome completo, registro funcional e número da ambulância na qual está escalado;

4.5. Permanecer em QAP (À disposição / em escuta ativa) sempre que não estiver em atendimento, assegurando pronta resposta a qualquer chamado;

4.6. Responder prontamente às chamadas da CRU, utilizando vocabulário padronizado, técnico e objetivo;

4.7. Manter um ambiente silencioso na base sempre que o rádio ou outro meio de comunicação institucional estiver ativo ou houver chamada da CRU, garantindo boa qualidade na comunicação e evitando perda de informações

4.8. Manter caneta e bloco de anotações sempre à mão, registrando os chamados passados pela CRU (endereço, identificação do solicitante e identificação da queixa principal;

4.9. Informações adicionais e questionamentos sobre a ocorrência poderão ser passadas pelo rádio operador durante o trajeto;

4.10. Reportar imediatamente qualquer falha técnica no rádio ou outro meio de comunicação institucional à Coordenação de Base e à CRU;

4.11. Usar o tablet e celular para o recebimento dos chamados, em casos excepcionais, ou quando houver falhas técnicas comprovadas no rádio.

4.12. A prontidão operacional deve ser imediata após o recebimento do chamado;

4.12.1. O início do deslocamento será monitorado pelo CORE, podendo a equipe ser contatada para verificação se o sistema não acusar saída imediata;

4.12.2. Falhas no sistema deverão ser registradas pelo CORE e encaminhadas ao PATE;

4.12.3. Em situações em que o estacionamento da viatura fique distante da base, o tempo de prontidão será considerado de acordo com esse deslocamento;

4.12.4. Para fins de medição de indicador, será considerado o tempo máximo de 2 (dois) minutos entre a finalização do recebimento do chamado e o deslocamento de 200 (duzentos) metros da AM.

4.13. Manter o posicionamento estratégico da ambulância, estacionando o veículo em local de fácil saída e que permita deslocamento imediato;

4.14. Após o transporte do paciente ao hospital, realizar imediatamente a higienização da ambulância e verificar o "Top Five", conforme POP IAPH SBV e SBV-E 020 – Preenchimento de Checklists de Materiais e Medicamentos;

4.15. Realizar a higienização da ambulância e repor os materiais da mochila utilizando o material reserva disponível na VTR, na própria unidade de saúde onde o paciente foi deixado, garantindo que tudo esteja preparado para o próximo atendimento;

4.15.1. Assegurar o retorno à prontidão após esse procedimento informando à Central sua liberação e prontidão após o procedimento;

4.16. Comunicar imediatamente ao CORE caso não seja possível o retorno à prontidão, informando a necessidade de:

4.16.1. Retorno à base para reposição de materiais essenciais (pás de DEA, cilindro de oxigênio, ambu, EPI); ou

4.16.2. Realização de limpeza terminal da ambulância, quando houver presença de grande quantidade de matéria orgânica.

4.17. Manter o HT próximo, durante o PPR, para caso haja um atendimento de alta prioridade a equipe poderá ser solicitada a interromper o PPR e o tempo restante será realizado após atendimento da ocorrência;

4.18. Em chamados nos quais não for encontrada a vítima ou houve recusa de atendimento, a equipe deve registrar o caso no MR (Módulo de Regulação) e manter a prontidão imediatamente após o encerramento do chamado;

4.19. Ao assumir o plantão, a equipe deve verificar imediatamente a situação da maca da ambulância;

4.19.1. Caso a maca esteja retida no hospital, a equipe deve deslocar-se o quanto antes para regularizar a situação e comunicar ao CORE.

4.20. Ao finalizar o plantão, caso a maca esteja retida, informar a situação ao CORE.

4.21. O profissional deverá manter-se em prontidão até o término do seu plantão.

4.21.1. Se ao término do plantão não houver a chegada de outra equipe para rendição, comunicar o CORE;

4.21.2. Somente o CORE está autorizado a liberar o profissional sem passagem de plantão.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1 O rádio é um canal oficial de comunicação, destinado à transmissão de orientações e informações essenciais. Deve ser utilizado com responsabilidade, evitando brincadeiras ou uso inadequado que possa gerar congestionamento e comprometer a clareza e a segurança das comunicações;

5.1.1 O uso inadequado será analisado e poderá ser classificado como indisciplina, sendo passível de punição conforme a legislação vigente;

5.2 O funcionário deve realizar o QAP pessoal e individual, confirmando sua própria presença para a CRU, não podendo outro profissional fazê-lo em seu lugar;

5.3 O início do deslocamento e todos os trajetos da ambulância durante o atendimento são monitorados por GPS ou outro equipamento adquirido pelo serviço, garantindo rastreabilidade, segurança da equipe e otimização do tempo de deslocamento;

5.4 Os chamados serão monitorados pelo CORE ou seu auxiliar, para o cumprimento da meta de tempo estabelecida, portanto, a equipe será monitorada e acionada pelo CORE no não cumprimento da meta.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1 IAPH SBV e SBV-E 20 – Preenchimento de Checklists de Materiais e Medicamentos;

7. ANEXOS

7.1 Não há

8. FLUXOGRAMA

8.1 Não se aplica

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1 Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.048, de 5 de novembro de 2002. Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência.

9.2 Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.010, de 21 de maio de 2012. Reestrutura o componente móvel da Rede de Atenção às Urgências (RAU) e estabelece diretrizes para o SAMU 192

9.3 Prefeitura Municipal de Fortaleza. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 Regional Fortaleza. Protocolos de Regulação das Urgências – Normas de Conduta Técnica e Gestora, Volume 2, RM4 – Tempo Resposta e Respostas ao Solicitante. Núcleo de Educação Permanente (NEP) SAMUFor; 5ª Revisão (maio de 2023

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
01	02/02/2026	Elaboração

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Lia Midori Straceri Simone Cedano	Andrea Christina Simões Simone Dorna	Amanda de Ornelas Henrique CSAL Costa Filho	Nádia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO:

1.1. Autoridade: Direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar; entidade que detém este direito ou poder. Alguns representantes de autoridades a que se refere este documento são: autoridades militares (exército, marinha e aeronáutica), autoridades federais (legislativo, executivo e judiciário) e autoridades policiais (civil e militar);

2. OBJETIVO

2.1. Descrever como os profissionais do SAMU 192 São Paulo devem proceder na presença de autoridades no local da cena.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, SAV, URAM e CRU

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Informar ao MR da presença de autoridade e conduta solicitada;

4.2. Esclarecer a autoridade, quando a ordem ferir o regulamento do SAMU 192 São Paulo;

4.3. Acatar a determinação somente se a ordem estiver de acordo com o protocolo institucional;

4.4. Aguardar orientação do MR;

4.5. Registrar detalhadamente a decisão tomada na ficha de atendimento.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Toda e qualquer intercorrência ou conflito com demais autoridades deve ser registrada no corpo do chamado.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP Central de Regulação e Intervenção 5-021 MR – Autoridades no local da ocorrência.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. Protocolo de Atendimento Pré-Hospitalar: Suporte Intermediário de Vida. São Paulo: Secretaria Municipal de Saúde – SAMU, 2022; 5ª. Edição.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Alteração do título do protocolo, de "ordens de autoridade policial" para autoridades no local da ocorrência. 2. Ampliação e detalhamento da definição de autoridade. 3. Atualização do objetivo, com foco na atuação da equipe diante da presença de autoridades na cena. 4. Padronização e manutenção do fluxo de condutas. 5. Inclusão de orientação para registro formal de intercorrências ou conflitos.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna Barbosa da Silva	Daiane C. de Moraes Lilian Maria de Oliveira Jaqueline Flor da França Fabiana Amparo Ferraz	Henrique C.S. Costa Filho Bárbara de Souza Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Intervenção de profissional externo: presença de médicos e/ou enfermeiros que não sejam do SAMU 192 São Paulo, mas que estejam no local da cena e que se prontifiquem a prestar atendimento à vítima, ou já tenham prestado os primeiros atendimentos até chegada da equipe.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever como os profissionais do SAMU 192 São Paulo devem proceder frente aos profissionais de saúde externos.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, SAV, URAM e CRU

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Comunicar ao MR, a presença do profissional médico, enfermeiro ou outro profissional de saúde externo na ocorrência;

4.2. Solicitar apresentação de documento comprobatório (registro do Conselho de Classe);

4.3. Aguardar a liberação do MR para seguir as orientações/procedimentos do profissional de saúde externo;

4.4. Registrar detalhadamente os fatos na ficha de atendimento e coloque nome e número do Conselho de Classe;

4.5. Registrar a intervenção executada na ficha de atendimento.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Em caso de atendimento simultâneo com equipe de ambulância particular, a equipe do SAMU 192 São Paulo deve se colocar à disposição para assumir o caso, com o aceite do MR, priorizando o melhor atendimento à vítima;

5.2. Atuação do profissional externo deve restringir-se às condutas estabelecidas pelos protocolos SAMU 192 São Paulo;

5.3. Este documento não se aplica a casos em que há a presença de equipes do GRAU em apoio às equipes SBV ou SBV-E.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. Protocolo de Atendimento Pré-Hospitalar: Suporte Intermediário de Vida. São Paulo: Secretaria Municipal de Saúde – SAMU, 2022; 5ª. Edição.

9.2. Protocolo de Atendimento Central de Regulação e Intervenção. São Paulo: Secretaria Municipal de Saúde – SAMU, 2024; 1ª Edição.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Alteração do título do protocolo, ampliando de médico externo para profissionais de saúde externos. 2. Ampliação da definição, incluindo médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde externos. 3. Atualização do objetivo, adequando a terminologia ao novo escopo multiprofissional. 4. Padronização do fluxo de comunicação com o Médico Regulador. 5. Atualização dos critérios de identificação profissional, passando de CRM para registro no Conselho de Classe. 6. Reforço da obrigatoriedade de registro das intervenções realizadas na ficha de atendimento. 7. Inclusão de observações operacionais.

Última validação	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna Barbosa da Silva	Lilian Maria de Oliveira Henrique CSAL Costa Filho Fabiana Amparo Ferraz Jaqueline Flor da França	Amanda de Ornelas Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Ocorrências com indício de crime com morte: Situações de atendimento pré-hospitalar em que a vítima é encontrada sem sinais vitais e apresenta circunstâncias, achados ou lesões sugestivas de prática criminosa, tais como agressões, ferimentos incompatíveis com causa natural ou sinais de violência, exigindo preservação do local, do corpo e das evidências, conforme o disposto no Código de Processo Penal.

Nos termos do art. 239 do Código de Processo Penal, considera-se indício "a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias"

2. OBJETIVO

2.1. Descrever as ocorrências com indício de crime e quais as condutas do profissional SAMU 192 São Paulo frente a esta ocorrência.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, SAV, URAM e CRU

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Garantir a segurança da equipe;

4.2. Manter distância segura;

4.3. Comunicar a CRU;

4.4. Se necessário, solicitar recursos como: policiamento, bombeiros, entre outros, e se possível, aguarde a chegada dos mesmos;

4.5. Evitar alterar a cena;

4.6. Não tocar nos objetos sem luva;

4.7. Não tocar em nenhum local e/ou objeto com as luvas sujas de sangue;

4.8. Movimentar a vítima apenas para avaliar e descrever lesões;

4.9. Descrever na ficha de atendimento as lesões e posição encontrada, bem como características da cena;

4.10. Se a vítima se encontrar em via pública e sem acompanhante, os pertences devem ser arrolados e entregues ao policial responsável pela ocorrência;

4.11. Registrar na ficha de atendimento o nome, RF e prefixo da viatura do policial que recebeu os pertences;

4.12. Nos ferimentos penetrantes, retirar as vestes evitando cortar sobre a perfuração no tecido;

<u>Cuidados em relação à cena</u>

4.13. Não tocar e nem movimentar armas na cena e não permitir que nenhum integrante da equipe o faça;

4.14. Informar sobre a luminosidade encontrada na cena e se houve necessidade de acender dispositivos luminosos e/ou abrir janela;

4.15. Recolher da cena todo o material hospitalar utilizado no atendimento, como luvas, invólucros, entre outros;

4.16. Não limpar e nem retirar objetos do local;

4.17. Circular na cena apenas o necessário para prestar o atendimento;

4.18. Se a sua equipe for a primeira a chegar, não permitir a presença de familiares e/ou curiosos na cena do crime;

4.19. Anotar todos os horários com exatidão;

4.20. Anotar nomes das instituições presentes na cena, incluindo prefixos de viaturas;

4.21. Descrever com exatidão a posição em que o corpo foi encontrado e da necessidade de movimentá-lo;

4.22. Descrever com exatidão os procedimentos invasivos realizados;

4.23. Anotar o nome do policial para o qual foram passadas as informações relacionadas ao atendimento.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Atentar-se para o registro completo e detalhado em ficha de atendimento;

5.2. Em caso de enforcamento sem sinais de morte óbvia, retire a vítima da forca para iniciar reanimação, evitando cortar no local do nó, tentando preservar o instrumento usado como: fios, cordas etc.

5.3. Indícios de violência consultar POP Central de Regulação e Intervenção 6-018 Intervenção – Ocorrência com Indício de Violência.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP Central de Regulação e Intervenção 6-018 Intervenção – Ocorrência com Indício de Violência.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. Protocolo de Atendimento Pré-Hospitalar: Suporte Intermediário de Vida. São Paulo: Secretaria Municipal de Saúde – SAMU, 2022; 5ª. Edição.

9.2. BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Diário Oficial da União, 1941.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
06	02/02/2026	Atualização 1. Adequação do título e escopo do POP, delimitando explicitamente as ocorrências com indício de crime com morte, conferindo maior clareza operacional. 2. Atualização e qualificação da definição, com alinhamento ao Código de Processo Penal e maior precisão conceitual sobre indícios de crime. 3. Ampliação das áreas envolvidas, incluindo SBV, SBV-E, SAV e URAM, além da CRU. 4. Reorganização e padronização das condutas assistenciais e de preservação da cena, reforçando a segurança da equipe, a minimização de interferências e o correto registro dos achados. 5. Detalhamento dos registros obrigatórios, incluindo descrição da cena, lesões, pertences, horários e identificação das autoridades envolvidas.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna Barbosa da Silva	Lilian Maria de Oliveira Fabiana Amparo Ferraz Jaqueline Flor da França Elaine C. S. M. Machado	Amanda de Ornelas Bárbara de Souza Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. O checklist do SAMU 192 São Paulo é um instrumento de conferência padronizado, destinado ao registro da quantidade, validade e integridade dos materiais e medicamentos que compõem as mochilas, o salão da ambulância e os baús das URAMs das equipes de atendimento pré-hospitalar.

2. OBJETIVO

2.1. Estabelecer o procedimento para preenchimento, conferência e controle dos checklists das mochilas, do salão da AM e do baú da URAM, utilizados pelas equipes de Suporte Básico de Vida (SBV) e Suporte Básico de Vida com Enfermeiro (SBV-E), garantindo a padronização, e disponibilidade adequada de materiais e medicamentos.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. Enfermagem das equipes de SBV, SBV-E, SAV e URAM.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Realizar checklist nos primeiros 15 minutos do início do plantão, a fim de garantir segurança assistencial;

4.2. No início do plantão, se houver necessidade de empenho, em caso de chamado de complexidade Charlie, Delta e Echo, a equipe deverá realizar checklist "*TOP Five*" e seguir em atendimento;

4.3. Realizar a checagem do checklist TOP 05 nos chamados priorizados pelo MR:

TOP FIVE - SBV		
Assistência ventilatória, circulatória, abordagem do trauma, segurança da viatura	1	DEA e eletrodo adesivo;
	2	Máscara de O2, dispositivo bolsa-válvula-máscara (BVM) e cilindro de oxigênio;
	3	Luvas, gazes e ataduras;
	4	Prancha longa, protetor de cabeça e colar cervical;
	5	Certificar que o TOP 5 dos condutores foi realizado

TOP FIVE - SBV-E e SAV		
Assistência ventilatória, circulatória, abordagem do trauma, segurança da viatura	1	Desfibrilador/DEA e eletrodo adesivo/pás;
	2	Máscara de O2, dispositivo bolsa-válvula-máscara, laringoscópio, cânulas IOT/ máscara laríngea e cilindro de oxigênio;
	3	Luvas, gazes e ataduras;
	4	Prancha longa, protetor de cabeça e colar cervical;
	5	Certificar que o TOP 5 dos condutores foi realizado

4.3.1. Checar o DEA conforme orientação do fabricante e conferir eletrodos/adesivos (01 adulto e 01 pediátrico);

4.3.2. Conferir cilindro de oxigênio e acessórios (máscara de oxigênio, dispositivo bolsa-válvula-máscara e extensão);

4.3.3. Conferir os insumos: luvas, máscara descartável, gazes e ataduras;

4.3.4. Conferir se a prancha longa está com a base e os protetores de cabeça e colar cervical;

4.3.5. Informar o CORE caso identificado necessidade de reparos da AM;

4.3.6. Atentar na realização do checklist quanto aos insumos da AM, da oxigenoterapia fixo e portátil e equipamentos de comunicação, conforme Anexo;

4.3.7. Verificar com o condutor se foi checado condições dos pneus, óleo e combustível da AM.

4.4. As padronizações da guarda dos materiais nas mochilas e dos demais materiais dentro do salão da AM e baús das URAMs devem ser seguidas;

4.5. A enfermagem irá utilizar o mesmo instrumento para compor a equipe tanto de SBV-E quanto SBV. Os itens de SBV- E estão indicados no impresso;

4.6. Em SBV a equipe deve utilizar a mochila vermelha e verde (trauma). Em SBV-E utilizar a mochila verde e a azul com laranja;

4.7. A reposição de insumos deverá ser feita no início do plantão e /ou após cada atendimento;

4.8. O checklist poderá ser digital ou impresso;

4.9. Cabeçalho do impresso: todos os campos devem ser preenchidos de forma legível;

4.10. Itens da mochila: registrar a quantidade e a validade de cada material e medicamento;

4.10.1. A validade deverá ser registrada pela equipe que estiver de plantão no último dia do mês, conforme rotina estabelecida pela região;

4.11. Assinaturas:

4.11.1. Profissional responsável: assinar e carimbar ao final da conferência;

4.11.2. Supervisor: carimbar em campo específico, validando a conferência.

4.12. Mochilas Pediátricas:

4.12.1. Devem conter lacre numerado;

4.12.2. No checklist, registrar o número do lacre;

4.12.3. Em caso de uso (rompimento do lacre), registrar no checklist os itens utilizados e preencher o novo número de lacre;

4.13. Registro de Atendimento:

4.13.1. Na terceira página do checklist, deve ser registrado o número do chamado e o nome da vítima. Também deve ser registrado as intercorrências do plantão referentes aos equipamentos, materiais e medicamentos.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não há uma bolsa pequena padronizada contendo apenas os materiais para aferição de sinais vitais. Por esse motivo, deve-se levar a mochila completa, a fim de evitar perda de tempo ao precisar retornar à ambulância para buscá-la;

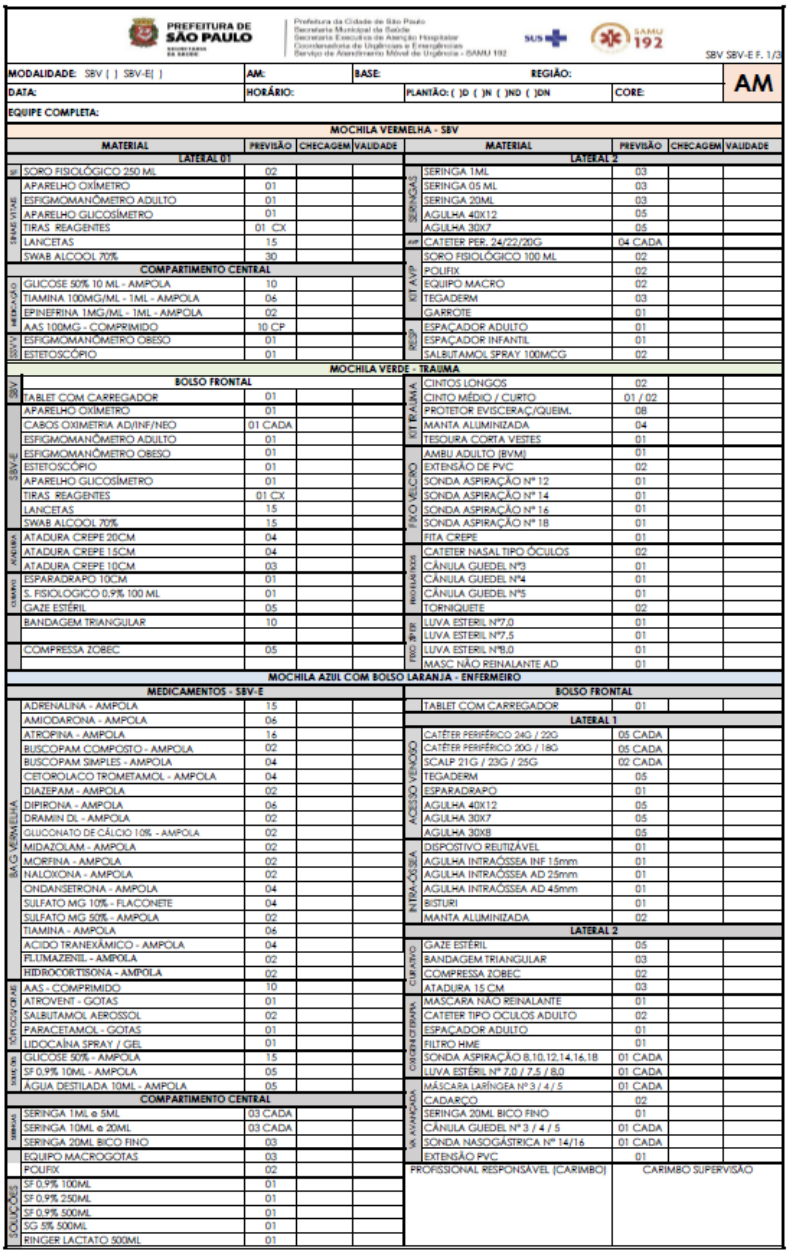
5.2. Qualquer inconformidade (faltas, validade expirada, danos em materiais) deve ser comunicada imediatamente ao gerente de base.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Checklist SBV – SBV/E Página 1/3



PREFEITURA DE SÃO PAULO — Prefeitura da Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Executiva de Atenção Hospitalar, Coordenadoria de Urgências e Emergências, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 — SUS — SAMU 192 — SBV SBV-E F. 1/3

MODALIDADE: SBV ( ) SBV-E( ) | AM: | BASE: | REGIÃO: | AM

DATA: | HORÁRIO: | PLANTÃO: ( )D ( )N ( )ND ( )DN | CORE:

EQUIPE COMPLETA:

MOCHILA VERMELHA - SBV

MATERIAL	PREVISÃO	CHECAGEM	VALIDADE
LATERAL 01			
SORO FISIOLÓGICO 250 ML	02		
APARELHO OXÍMETRO	01		
ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	01		
APARELHO GLICOSÍMETRO	01		
TIRAS REAGENTES	01 CX		
LANCETAS	15		
SWAB ALCOOL 70%	30		
COMPARTIMENTO CENTRAL			
GLICOSE 50% 10 ML - AMPOLA	10		
TIAMINA 100MG/ML - 1ML - AMPOLA	06		
EPINEFRINA 1MG/ML - 1ML - AMPOLA	02		
AAS 100MG - COMPRIMIDO	10 CP		
ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	01		
ESTETOSCÓPIO	01		

MATERIAL	PREVISÃO	CHECAGEM	VALIDADE
LATERAL 2			
SERINGA 1ML	03		
SERINGA 05 ML	03		
SERINGA 20ML	03		
AGULHA 40X12	05		
AGULHA 30X7	05		
CATETER PER. 24/22/20G	04 CADA		
SORO FISIOLÓGICO 100 ML	02		
POLIFIX	02		
EQUIPO MACRO	02		
TEGADERM	03		
GARROTE	01		
ESPAÇADOR ADULTO	01		
ESPAÇADOR INFANTIL	01		
SALBUTAMOL SPRAY 100MCG	02		

MOCHILA VERDE - TRAUMA

BOLSO FRONTAL	PREVISÃO	CHECAGEM	VALIDADE
TABLET COM CARREGADOR	01		
APARELHO OXÍMETRO	01		
CABOS OXIMETRIA AD/INF/NEO	01 CADA		
ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	01		
ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	01		
ESTETOSCÓPIO	01		
APARELHO GLICOSÍMETRO	01		
TIRAS REAGENTES	01 CX		
LANCETAS	15		
SWAB ALCOOL 70%	15		
ATADURA CREPE 20CM	04		
ATADURA CREPE 15CM	04		
ATADURA CREPE 10CM	03		
ESPARADRAPO 10CM	01		
S. FISIOLOGICO 0,9% 100 ML	01		
GAZE ESTÉRIL	05		
BANDAGEM TRIANGULAR	10		
COMPRESSA ZOBEC	05		

MATERIAL	PREVISÃO	CHECAGEM	VALIDADE
CINTOS LONGOS	02		
CINTO MÉDIO / CURTO	01 / 02		
PROTETOR EVISCERAÇ/QUEIM.	08		
MANTA ALUMINIZADA	04		
TESOURA CORTA VESTES	01		
AMBU ADULTO (BVM)	01		
EXTENSÃO DE PVC	02		
SONDA ASPIRAÇÃO Nº 12	01		
SONDA ASPIRAÇÃO Nº 14	01		
SONDA ASPIRAÇÃO Nº 16	01		
SONDA ASPIRAÇÃO Nº 18	01		
FITA CREPE	01		
CATETER NASAL TIPO ÓCULOS	02		
CÂNULA GUEDEL Nº3	01		
CÂNULA GUEDEL Nº4	01		
CÂNULA GUEDEL Nº5	01		
TORNIQUETE	02		
LUVA ESTERIL Nº7,0	01		
LUVA ESTERIL Nº7,5	01		
LUVA ESTERIL Nº8,0	01		
MASC NÃO REINALANTE AD	01		

MOCHILA AZUL COM BOLSO LARANJA - ENFERMEIRO

MEDICAMENTOS - SBV-E			
ADRENALINA - AMPOLA	15		
AMIODARONA - AMPOLA	06		
ATROPINA - AMPOLA	16		
BUSCOPAM COMPOSTO - AMPOLA	02		
BUSCOPAM SIMPLES - AMPOLA	04		
CETOROLACO TROMETAMOL - AMPOLA	04		
DIAZEPAM - AMPOLA	02		
DIPIRONA - AMPOLA	06		
DRAMIN DL - AMPOLA	02		
GLUCONATO DE CÁLCIO 10% - AMPOLA	02		
MIDAZOLAM - AMPOLA	02		
MORFINA - AMPOLA	02		
NALOXONA - AMPOLA	02		
ONDANSETRONA - AMPOLA	04		
SULFATO MG 10% - FLACONETE	04		
SULFATO MG 50% - AMPOLA	02		
TIAMINA - AMPOLA	06		
ACIDO TRANEXÂMICO - AMPOLA	04		
FLUMAZENIL - AMPOLA	02		
HIDROCORTISONA - AMPOLA	02		
AAS - COMPRIMIDO	10		
ATROVENT - GOTAS	01		
SALBUTAMOL AEROSSOL	02		
PARACETAMOL - GOTAS	01		
LIDOCAÍNA SPRAY / GEL	01		
GLICOSE 50% - AMPOLA	15		
SF 0,9% 10ML - AMPOLA	05		
ÁGUA DESTILADA 10ML - AMPOLA	05		
COMPARTIMENTO CENTRAL			
SERINGA 1ML e 5ML	03 CADA		
SERINGA 10ML e 20ML	03 CADA		
SERINGA 20ML BICO FINO	03		
EQUIPO MACROGOTAS	03		
POLIFIX	02		
SF 0,9% 100ML	01		
SF 0,9% 250ML	01		
SF 0,9% 500ML	01		
SG 5% 500ML	01		
RINGER LACTATO 500ML	01		

MATERIAL	PREVISÃO	CHECAGEM	VALIDADE
BOLSO FRONTAL			
TABLET COM CARREGADOR	01		
LATERAL 1			
CATÉTER PERIFÉRICO 24G / 22G	05 CADA		
CATÉTER PERIFÉRICO 20G / 18G	05 CADA		
SCALP 21G / 23G / 25G	02 CADA		
TEGADERM	05		
ESPARADRAPO	01		
AGULHA 40X12	05		
AGULHA 30X7	05		
AGULHA 30X8	05		
DISPOSITIVO REUTIZÁVEL	01		
AGULHA INTRAÓSSEA INF 15mm	01		
AGULHA INTRAÓSSEA AD 25mm	01		
AGULHA INTRAÓSSEA AD 45mm	01		
BISTURI	01		
MANTA ALUMINIZADA	02		
LATERAL 2			
GAZE ESTÉRIL	05		
BANDAGEM TRIANGULAR	03		
COMPRESSA ZOBEC	02		
ATADURA 15 CM	03		
MASCARA NÃO REINALANTE	01		
CATETER TIPO OCULOS ADULTO	02		
ESPAÇADOR ADULTO	01		
FILTRO HME	01		
SONDA ASPIRAÇÃO 8,10,12,14,16,18	01 CADA		
LUVA ESTÉRIL Nº 7,0 / 7,5 / 8,0	01 CADA		
MÁSCARA LARÍNGEA Nº 3 / 4 / 5	01 CADA		
CADARÇO	02		
SERINGA 20ML BICO FINO	01		
CÂNULA GUEDEL Nº 3 / 4 / 5	01 CADA		
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14/16	01 CADA		
EXTENSÃO PVC	01		

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL (CARIMBO) | CARIMBO SUPERVISÃO

PREFEITURA DE SÃO PAULO — Prefeitura da Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Executiva de Atenção Hospitalar, Coordenadoria de Urgências e Emergências, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 — SUS — SAMU 192

SBV SBV-E F. 2/3

MOCHILA INFANTIL / PARTO

	MATERIAL	PREVISÃO	CHECAGEM	VALIDADE
LACRE NUMÉRICO:				
	ESFIGMOMANÔMETRO PED	01		
VIA AÉREA	AMBU COMPLETO INFANTIL	01		
	AMBU COMPLETO NEO	01		
	EXTENSÃO DE PVC	01		
	CÂNULA GUEDEL Nº 00 e 0	01 CADA		
	CÂNULA GUEDEL Nº 1 e 2	01 CADA		
	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INF	01		
	MASCARA NÃO REINALANTE PED	01		
	SONDA ASPIRAÇÃO Nº 08	01		
	SONDA ASPIRAÇÃO Nº 10	01		
	ESPAÇADOR INFANTIL	01		
KIT PARTO	KIT PARTO	01		
	BISTURI Nº 22	01		
	LUVA ESTÉRIL Nº 7	01		
	LUVA ESTÉRIL Nº 7,5	01		
	LUVA ESTÉRIL Nº 8	01		
	COMPRESSA ZOBEC	02		
EPI	AVENTAL DESCARTÁVEL	02		
	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	01		
	TOUCA CIRÚRGICA	05		
	TALAFIX 30x8 (PP)	01		
	PROTETOR EVISCERAÇ/QUEIM.	04		

	MATERIAL	PREVISÃO	CHECAGEM	VALIDADE
	MATERIAIS ADICIONAIS EM SBV-E			
SBV-E	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1	01		
	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1,5	01		
	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2	01		
	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2,5	01		
	CADARÇO	03		
	SERINGA 20ML - BICO FINO	02		
	AGULHA INTRAÓSSEA INF 15mm	01		
	CATÉTER PERIFÉRICO 24G / 22G	03 CADA		
	SCALP 23G / 25G	02 CADA		
	TEGADERM	05		
	SF 0,9% 100ML	01		
	SF 0,9% 250ML	01		
	SG 10% 250ML	01		
	EQUIPO MACRO	02		
	EQUIPO MICRO	02		
	SERINGA 1 ML	05		
	SERINGA 10 ML	05		
	AGULHA 30X7	05		
	AGULHA 30X8	05		
	AGULHA 40X12	05		
	XYLOCAINA SPRAY	01		
	XYLOCAINA GEL	01		

SALÃO DA AMBULÂNCIA

	MATERIAL	PREVISÃO	CHECAGEM	VALIDADE
GAVETA 1	TOUCA CIRÚRGICA	05		
	MASCARA N95	03		
	MÁSCARA NÃO REINALANTE AD	02		
	CATETER NASAL TIPO OCULOS	02		
	MANTA ALUMINIZADA	05		
GAVETA 2	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL	05 PCT		
	COMPRESSA ZOBEC	05		
	BANDAGEM TRIANGULAR	05		
	ATADURA CREPE 10 CM E 15 CM	03 CADA		
	ATADURA CREPE 20 CM	03		
SUP FECHADO	DEA FUNCIONAL ( )SIM ( )NÃO	01		
	ELETRODO DEA ADULTO	02		
	ELETRODO DEA INFANTIL	01		
	CINTA PÉLVICA P/M/G	01 CADA		
	EXTENSÃO PVC	02		
	PROTOCOLO OPERACIONAL	01		
SUP ABERTO	KED C/ CAPA ( ) SIM ( ) NÃO	01		
	LONA TRANSFER	01		
	CINTO ARANHA	01		
	BAG PRANCHA PEDIÁTRICA	01		
SALÃO	PRANCHA RÍGIDA LONGA	02		
	MACA C/ COLCHONETE E 3 CINTOS	01		
	CADEIRA DE RODAS	02		
	CILINDRO DE OXIGÊNIO 2,5 M³	02	Vol:	
	MOCHILA DE O²	01		
	CONES	05		
ASPIRAR	FRASCO RÍGIDO DE ASPIRAÇÃO	01		
	FLUXÔMETRO C/ BICO	01		
CARNE	CELULAR CORPORATIVO	01		
	HT C/BATERIA E BASE	01		
	PRANCHETA COM IMPRESSOS	01		
	BALCÃO			
SBV	CARREGADOR DO OXÍMETRO	01		
	MOCHILA VERMELHA - SBV	01		
	LUVA DE PROC. P/M/G	01 CADA		
	MÁSC. FACIAL CIRÚRGICA	01 CX		
	ALMOTOLIA / ALCOOL GEL	01		
SBV-E	ASPIRADOR PORTÁTIL	01		
	FRASCO ASPIRAÇÃO FLOVAC (RESERVA)	01		
	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	01		
	ELETRODO MONITORIZAÇÃO	30		
	LÂMINA DE TRICOTOMIA	2		
	PAPEL DE ECG	01		
	CAPNÓGRAFO	01		

	MATERIAL	PREVISÃO	CHECAGEM	VALIDADE
	COMPARTIMENTO 1 - MATERIAIS ADICIONAIS EM SBV-SE			
SOLUÇÕES	SF 0,9% 100ML	02		
	SF 0,9% 250ML	02		
	SF 0,9% 500ML	03		
	RINGER LACTATO 500ML	02		
	SG 5% 500ML	01		
	EQUIPO MACROGOTAS	05		
	POLIFIX	02		
ACESSO VENOSO	CATÉTER PERIFÉRICO 24G / 22G	05 CADA		
	CATÉTER PERIFÉRICO 20G / 18G	05 CADA		
	TEGADERM	5		
	SERINGA 1 ML e 5ML	05 CADA		
	SERINGA 10 ML e 20ML	05 CADA		
	SERINGA 20 ML COM BICO FINO	05		
	AGULHA 30x70	05		
	AGULHA 30x80	05		
	AGULHA 40x12	05		
	COMPARTIMENTO 2			
	MOCHILA DE TRAUMA	01		
	MOCHILA INFANTIL / PARTO	01		
	BAÚ			
TRAUMA	COLAR CERVICAL ADULTO	05		
	COLAR CERVICAL PEDIÁTRICO	03		
	TALA 30X8 CM (S)	04		
	TALA 53X8 CM (P)	04		
	TALA 63X8 CM (M)	04		
	TALA 86X10 CM (G)	04		
	TALA 120X12 CM (GG)	04		
	HEAD BLOCK COMPLETO	02 CONJ		
PERFURO CORTANTE	AVENTAL DESCARTÁVEL	03		
	LENÇOL DESCARTÁVEL	01 PCT		
	LUVA DE EXPURGO	01		
	DETERGENTE SPRAY	02		
	PANO DE LIMPEZA	20		
	SACO DE LIXO INFECTANTE	05		
	CAIXA DE PERFURO 3L	01		
RESG	KIT CONTENÇÃO	01		
	MOCHILA VERDE - OXIGÊNIO			
	CILINDRO DE O² PORTÁTIL	01	Vol:	
	AMBU ADULTO	01		
	MÁSCARA NÃO REINALANTE AD	01		
	EXTENSÃO PVC	01		
	SONDA ASPIRAÇÃO 8,10,12,14,16,18	01 CADA		

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL (CARIMBO) | CARIMBO SUPERVISÃO

7.3. Checklist SBV – SBV/E Página 3/3

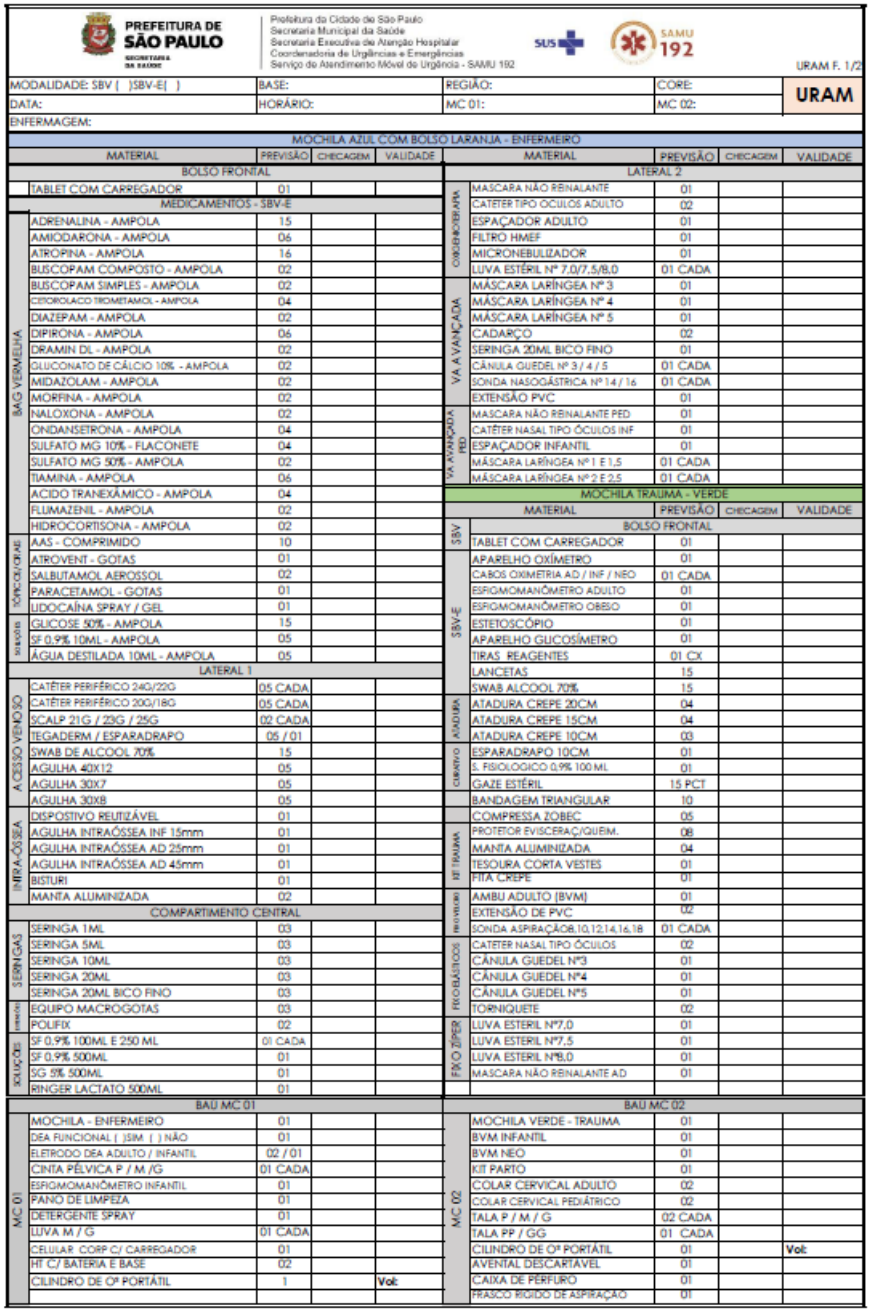
PREFEITURA DE SÃO PAULO SECRETARIA DA SAÚDE | Prefeitura da Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Executiva de Atenção Hospitalar, Coordenadoria de Urgências e Emergências, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | SUS | SAMU 192

3/3

REGISTRO DE ATENDIMENTOS
OBSERVAÇÕES:

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL (CARIMBO)	RF/MATRÍCULA: DATA: / /	CARIMBO DA SUPERVISÃO / GERENTE

7.4. Checklist URAM Página 1/2:



PREFEITURA DE SÃO PAULO — Prefeitura da Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Executiva de Atenção Hospitalar, Coordenadoria de Urgências e Emergências, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 — SUS — SAMU 192 — URAM F. 1/2

MODALIDADE: SBV ( )SBV-E( ) | BASE: | REGIÃO: | CORE: | **URAM**

DATA: | HORÁRIO: | MC 01: | MC 02:

ENFERMAGEM:

MOCHILA AZUL COM BOLSO LARANJA - ENFERMEIRO

MATERIAL	PREVISÃO	CHECAGEM	VALIDADE
BOLSO FRONTAL			
TABLET COM CARREGADOR	01		
MEDICAMENTOS - SBV-E			
ADRENALINA - AMPOLA	15		
AMIODARONA - AMPOLA	06		
ATROPINA - AMPOLA	16		
BUSCOPAM COMPOSTO - AMPOLA	02		
BUSCOPAM SIMPLES - AMPOLA	02		
CETOROLACO TROMETAMOL - AMPOLA	04		
DIAZEPAM - AMPOLA	02		
DIPIRONA - AMPOLA	06		
DRAMIN DL - AMPOLA	02		
GLUCONATO DE CÁLCIO 10% - AMPOLA	02		
MIDAZOLAM - AMPOLA	02		
MORFINA - AMPOLA	02		
NALOXONA - AMPOLA	02		
ONDANSETRONA - AMPOLA	04		
SULFATO MG 10% - FLACONETE	04		
SULFATO MG 50% - AMPOLA	02		
TIAMINA - AMPOLA	06		
ACIDO TRANEXÂMICO - AMPOLA	04		
FLUMAZENIL - AMPOLA	02		
HIDROCORTISONA - AMPOLA	02		
AAS - COMPRIMIDO	10		
ATROVENT - GOTAS	01		
SALBUTAMOL AEROSSOL	02		
PARACETAMOL - GOTAS	01		
LIDOCAÍNA SPRAY / GEL	01		
GLICOSE 50% - AMPOLA	15		
SF 0,9% 10ML - AMPOLA	05		
ÁGUA DESTILADA 10ML - AMPOLA	05		
LATERAL 1			
CATÉTER PERIFÉRICO 24G/22G	05 CADA		
CATÉTER PERIFÉRICO 20G/18G	05 CADA		
SCALP 21G / 23G / 25G	02 CADA		
TEGADERM / ESPARADRAPO	05 / 01		
SWAB DE ALCOOL 70%	15		
AGULHA 40X12	05		
AGULHA 30X7	05		
AGULHA 30X8	05		
DISPOSITIVO REUTIZÁVEL	01		
AGULHA INTRAÓSSEA INF 15mm	01		
AGULHA INTRAÓSSEA AD 25mm	01		
AGULHA INTRAÓSSEA AD 45mm	01		
BISTURI	01		
MANTA ALUMINIZADA	02		
COMPARTIMENTO CENTRAL			
SERINGA 1ML	03		
SERINGA 5ML	03		
SERINGA 10ML	03		
SERINGA 20ML	03		
SERINGA 20ML BICO FINO	03		
EQUIPO MACROGOTAS	03		
POLIFIX	02		
SF 0,9% 100ML E 250 ML	01 CADA		
SF 0,9% 500ML	01		
SG 5% 500ML	01		
RINGER LACTATO 500ML	01		

MATERIAL	PREVISÃO	CHECAGEM	VALIDADE
LATERAL 2			
MÁSCARA NÃO REINALANTE	01		
CATÉTER TIPO ÓCULOS ADULTO	02		
ESPAÇADOR ADULTO	01		
FILTRO HMEF	01		
MICRONEBULIZADOR	01		
LUVA ESTÉRIL Nº 7,0/7,5/8,0	01 CADA		
MÁSCARA LARÍNGEA Nº 3	01		
MÁSCARA LARÍNGEA Nº 4	01		
MÁSCARA LARÍNGEA Nº 5	01		
CADARÇO	02		
SERINGA 20ML BICO FINO	01		
CÂNULA GUEDEL Nº 3 / 4 / 5	01 CADA		
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14 / 16	01 CADA		
EXTENSÃO PVC	01		
MÁSCARA NÃO REINALANTE PED	01		
CATÉTER NASAL TIPO ÓCULOS INF	01		
ESPAÇADOR INFANTIL	01		
MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1 E 1,5	01 CADA		
MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2 E 2,5	01 CADA		

MOCHILA TRAUMA - VERDE

MATERIAL	PREVISÃO	CHECAGEM	VALIDADE
BOLSO FRONTAL			
TABLET COM CARREGADOR	01		
APARELHO OXÍMETRO	01		
CABOS OXIMETRIA AD / INF / NEO	01 CADA		
ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	01		
ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	01		
ESTETOSCÓPIO	01		
APARELHO GLICOSÍMETRO	01		
TIRAS REAGENTES	01 CX		
LANCETAS	15		
SWAB ALCOOL 70%	15		
ATADURA CREPE 20CM	04		
ATADURA CREPE 15CM	04		
ATADURA CREPE 10CM	03		
ESPARADRAPO 10CM	01		
S. FISIOLOGICO 0,9% 100 ML	01		
GAZE ESTÉRIL	15 PCT		
BANDAGEM TRIANGULAR	10		
COMPRESSA ZOBEC	05		
PROTETOR EVISCERAÇ/QUEIM.	08		
MANTA ALUMINIZADA	04		
TESOURA CORTA VESTES	01		
FITA CREPE	01		
AMBU ADULTO (BVM)	01		
EXTENSÃO DE PVC	02		
SONDA ASPIRAÇÃO8,10,12,14,16,18	01 CADA		
CATÉTER NASAL TIPO ÓCULOS	02		
CÂNULA GUEDEL Nº3	01		
CÂNULA GUEDEL Nº4	01		
CÂNULA GUEDEL Nº5	01		
TORNIQUETE	02		
LUVA ESTERIL Nº7,0	01		
LUVA ESTERIL Nº7,5	01		
LUVA ESTERIL Nº8,0	01		
MÁSCARA NÃO REINALANTE AD	01		

	PREVISÃO	CHECAGEM	VALIDADE
BAU MC 01			
MOCHILA - ENFERMEIRO	01		
DEA FUNCIONAL ( )SIM ( ) NÃO	01		
ELETRODO DEA ADULTO / INFANTIL	02 / 01		
CINTA PÉLVICA P / M /G	01 CADA		
ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	01		
PANO DE LIMPEZA	01		
DETERGENTE SPRAY	01		
LUVA M / G	01 CADA		
CELULAR CORP C/ CARREGADOR	01		
HT C/ BATERIA E BASE	02		
CILINDRO DE O² PORTÁTIL	1		Vol:

	PREVISÃO	CHECAGEM	VALIDADE
BAU MC 02			
MOCHILA VERDE - TRAUMA	01		
BVM INFANTIL	01		
BVM NEO	01		
KIT PARTO	01		
COLAR CERVICAL ADULTO	02		
COLAR CERVICAL PEDIÁTRICO	02		
TALA P / M / G	02 CADA		
TALA PP / GG	01 CADA		
CILINDRO DE O² PORTÁTIL	01		Vol:
AVENTAL DESCARTÁVEL	01		
CAIXA DE PERFURO	01		
FRASCO RÍGIDO DE ASPIRAÇÃO	01		

7.5. Checklist URAM Página 2/2:

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

Prefeitura da Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Secretaria Executiva de Atenção Hospitalar
Coordenadoria de Urgências e Emergências
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192

SUS

SAMU 192

URAM F. 2/2

MOCHILA VERMELHA - SBV

	MATERIAL	PREVISÃO	CHECAGEM	VALIDADE
	LATERAL 01			
SF	SORO FISIOLÓGICO 250 ML	02		
SINAIS VITAIS	APARELHO OXÍMETRO	01		
	CABOS OXIMETRIA AD / INF / NEO	01 CADA		
	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	01		
	APARELHO GLICOSÍMETRO	01		
	TIRAS REAGENTES	01 CX		
	LANCETAS	15		
	SWAB ALCOOL 70%	30		
	COMPARTIMENTO CENTRAL			
MEDICAMENTOS	GLICOSE 50% 10 ML - AMPOLA	10		
	TIAMINA 100MG/ML - 1ML AMPOLA	06		
	EPINEFRINA 1MG/ML - 1ML AMPOLA	02		
	AAS 100MG COMPRIMIDO	10 CP		
SF	CATETER PERIFÉRICO 24/22/20G	04 CADA		

	MATERIAL	PREVISÃO	CHECAGEM	VALIDADE
	LATERAL 2			
SERINGAS	SERINGA 5ML	03		
	SERINGA 20ML	03		
	AGULHA 40X12	05		
	AGULHA 30X8	05		
KIT AVP	SORO FISIOLÓGICO 100 ML	02		
	POLIFIX	02		
	EQUIPO MACRO	02		
	TEGADERM	05		
	GARROTE	01		
RESP	ESPAÇADOR ADULTO	01		
	ESPAÇADOR INFANTIL	01		
	SALBUTAMOL SPRAY 100MCG	01		
SSVV	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	01		
	ESTETOSCÓPIO	01		

REGISTRO DE ATENDIMENTOS

OBSERVAÇÕES:

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL (CARIMBO)	RF/MATRÍCULA: DATA: ____ / ____ / ____	CARIMBO DA SUPERVISÃO / GERENTE ____ / ____ / ____

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 2048, de 5 de novembro de 2002. Aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. Diário Oficial da União, Brasília, 12 nov. 2002. Seção 1, p. 32-54.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
01	02/02/2026	Elaboração

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Miriam Kelly Barga Sérgio José da Silva Thiago Quaglietta Lopes Wesley Almeida Santos	Ana Midori Harada Andrea Chistina Bruno Luiz da Silva Dumara Maria D. H. Lima Fabiana Amparo Ferraz Iraci Azarias da Silva Karen Cristina Pizani Lydia dos Santos Manhaes Lúcio da Silva Ferreira Marcia M. Cardoso Marcus Vinicius da Rocha Natalia Aline da Silva Roselândia Souza Beserra Wanderson S. Rosa	Amanda de Ornelas Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nádia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Transporte aeromédico no Atendimento Pré-Hospitalar (APH): é o deslocamento de pacientes em situação de urgência ou emergência por meio de aeronaves, devidamente equipadas com suporte avançado de vida e tripuladas por equipe multiprofissional, tendo como finalidade garantir rapidez, segurança e assistência contínua durante o trajeto, especialmente em casos em que o transporte terrestre é inviável ou demoraria, podendo comprometer o prognóstico do paciente.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever as indicações para solicitação do apoio aeromédico e a atuação das equipes de enfermagem até o embarque da vítima.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, SAV, URAM e CRU.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

Indicações para solicitação de apoio aeromédico

4.1. Vítima com sinais de trauma raquimedular;

4.2. Vítima grave nas seguintes situações: congestionamento, grandes distâncias para o hospital de referência, alagamentos e interdições de vias;

Acionamento do transporte aeromédico

4.3. Passe o caso para o MR sugerindo a solicitação do recurso de acordo com as indicações acima descritas;

4.4. Informe o MR quando o acionamento foi feito pelas equipes do Corpo de Bombeiros e/ou da Polícia Militar;

Regras específicas de segurança para aproximação e embarque da vítima na aeronave:

4.5. Realize cobertura das lesões;

4.6. Na ausência do apoio militar, aguarde orientação do rádio operador ou MR para o deslocamento da AM até o local de embarque na aeronave;

4.7. Na presença do apoio militar, aguarde junto à vítima a chegada da equipe aeromédica;

4.8. Permita à avaliação e realização dos procedimentos a vítima pela equipe aeromédica;

4.9. Após a autorização do piloto, aproxime-se pela frente, no campo visual do mesmo;

4.10. Mantenha distância segura da AM durante o embarque e o desembarque;

4.11. Aproximar-se da aeronave com o tronco ligeiramente encurvado para frente;

4.12. Aproximar-se sempre no mesmo plano da aeronave;

4.13. Mantenha o cabelo preso e não usar adereços e bonés;

4.14. Realize a transição de cuidados à equipe aeromédica;

4.15. Mantenha as portas e janelas da AM fechadas no momento do pouso e decolagem;

4.16. Informe à CRU o nome do médico tripulante, o prefixo da aeronave e a unidade de saúde para onde a vítima foi transportada.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não há.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. PHTLS. Atendimento Pré Hospitalar ao Traumatizado. 9ª edição. NAEMT. SP, 2021.

9.2. Portarian°.2048/2002. Disponível em< https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html> Acesso em 20/12/2021.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Alteração do nome do protocolo; 2. Atualização do objetivo, delimitando as indicações e a atuação das equipes até o embarque. 3. Ampliação das áreas envolvidas, incluindo SBV, SBV-E, SAV, URAM e CRU. 4. Padronização das indicações para solicitação do apoio aeromédico. 5. Organização do fluxo de acionamento junto ao Médico Regulador (MR). 6. Reorganização e detalhamento das regras de segurança para aproximação e embarque na aeronave. 7. Atualização das informações obrigatórias a serem comunicadas à Central após o transporte.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna Barbosa da Silva	Camila M. Okiyama Daiane M. F. Souza Dermival O. Xavier Fabiana Lima Ribeiro Fernanda Vaz Toste Márcia Cristina L Barreiros Maria Carolina Tufolo Renan de S. M. Gonçalves	Amanda de Ornelas Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. Atendimento de ocorrências em via pública com presença de imprensa, aglomeração e/ou tumulto social;

1.2. Exposição da vítima: toda situação em que informações, imagens ou dados pessoais identificáveis sejam tornados públicos sem finalidade assistencial imediata ou sem a devida autorização. Isso inclui a visualização indevida do corpo ou pertences da vítima por terceiros, a divulgação de fotografias, vídeos ou registros em redes sociais, aplicativos de mensagens ou outros meios de comunicação, bem como a exposição física desnecessária durante o atendimento, que possa comprometer sua dignidade, privacidade e segurança;

1.3. Presença de tumulto ou agitação social: ocorrência, em determinado local e momento, de desordem coletiva caracterizada por aglomeração de pessoas cuja conduta gera confusão, agitação, risco à segurança ou interrupção da normalidade do ambiente.

2. OBJETIVO

2.1. Padronizar a abordagem profissional, garantindo a segurança da equipe, do paciente e da população, bem como a preservação da ética, do sigilo e da integridade do atendimento, conforme normas legais e institucionais vigentes.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM, Frota e CRU.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

Atendimento em via pública

4.1. Observar as regras gerais de avaliação da segurança da cena;

4.2. Realizar avaliação primária e executar as ações necessárias;

4.3. Finalizar os procedimentos dentro da ambulância, com as portas fechadas;

4.4. Solicitar o isolamento da área, na presença de policiamento na cena.

Presença da imprensa na cena

4.5. Observar as regras gerais de avaliação da segurança da cena, conforme POP IAPH SBV e SBV-E- 007 - Avaliação da Cena;

4.6. Tratar os profissionais da imprensa com urbanidade e educação;

4.7. Não conceder entrevistas nem autorizar a captação de imagens;

4.8. Não agir de forma a impedir ou obstruir a filmagem realizada em local público;

4.9. Solicitar o isolamento da área, na presença de policiamento na cena;

4.10. Não fornecer informações relacionadas à vítima e/ou ao caso;

4.11. Realizar os procedimentos dentro da ambulância, com as portas fechadas.

Presença de tumulto ou agitação social com risco para a equipe

4.12. Observar as regras gerais de avaliação da segurança da cena;

4.13. Comunicar o MR sobre a situação e a necessidade de apoio;

4.14. Considerar as orientações do policiamento na cena sobre: manutenção de distâncias seguras, aproximação e estacionamento da viatura;

4.15. Realizar os procedimentos dentro da ambulância, com as portas fechadas;

4.16. Não circular na cena;

4.17. Não manifestar suas opiniões sobre os fatos do conflito.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Os atendimentos em que a vítima inicialmente é exposta, por atendimento urgente é justificável, porém sua exposição desnecessária fere o princípio constitucional federal no Artigo 5º, inciso X: "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, sendo passível de punição de quem o infringir";

5.2. Fica expressamente vedado, em qualquer hipótese, aos profissionais do SAMU 192 São Paulo o registro, divulgação ou compartilhamento de imagens de pacientes atendidos (de frente, perfil, costas ou em qualquer ângulo). Tal conduta infringe a Resolução COFEN nº 554/2017,

a qual estabelece, em seu Art. 4º, que é proibido expor imagens de pacientes em redes sociais, aplicativos de mensagens ou outros grupos sociais, bem como divulgar imagens da face ou do corpo que não tenham finalidade acadêmica;

5.3. Preferencialmente e se possível, realize os procedimentos dentro da ambulância, com as portas fechadas.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP IAPH SBV e SBV-E- 007 - Avaliação da Cena.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. Constituição Federal Artigo 05, inciso X/ 88. Disponível em < *https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10730704/inciso-x-do-artigo-5-da-constituicao-federal-de-1988*>

9.2. Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Resolução COFEN nº 567/2018. Disponível em < *http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofenno-567-2018_60340.html*>

9.3. CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (Brasil). Resolução COFEN nº 554, de 17 de maio de 2017. Atualiza norma para uso das redes sociais pelos profissionais de enfermagem. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 102, p. 130, 30 maio 2017.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Atualização e ampliação das definições conceituais 2. Detalhamento do conceito de exposição da vítima 3. Inclusão da definição de tumulto ou agitação social 4. Reformulação e padronização do objetivo do protocolo 5. Reorganização e padronização dos procedimentos assistenciais 6. Vinculação da avaliação de cena a POP institucional específico 7. Clareza normativa sobre a atuação frente à imprensa 8. Padronização das condutas em situações de tumulto ou agitação social 9. Inclusão de vedações explícitas quanto ao registro e divulgação de imagens 10. Alinhamento às normativas legais e resoluções do COFEN

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna Barbosa da Silva	Camila M. Okiyama Fabiana Lima Ribeiro Maria Carolina Tufolo Renan de S. M. Gonçalves Sérgio José da Silva	Amanda de Ornelas Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Morte óbvia: caracterizada por sinais de morte ocorridos por um período superior à 01 hora e/ou onde há constatação evidente de morte.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever os sinais de morte óbvia e a atuação da equipe de enfermagem frente à família e ao corpo.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e CRU

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

A morte óbvia é caracterizada pelos sinais:

4.1. Evidente estado de decomposição;

4.2. Decapitação;

4.3. Segmentação do tronco;

4.4. Esmagamento total ou dilaceramento completo do crânio e/ou tronco (não confundir o esmagamento total do crânio com trauma de crânio com perda de massa encefálica, situação em que deve ser tentada a reanimação);

4.5. Carbonização total do corpo;

4.6. Presença de "*rigor mortis*" (rigidez dos músculos da mastigação que inicia entre 1 a 6 horas após a morte e avança no sentido craniocaudal);

4.7. Presença de "*livor mortis*" (estase sanguínea que se apresenta de acordo com a posição do corpo, inicia entre 1:30 a 2 horas, atingindo o máximo entre 8 a 12 horas).

Ações da equipe de enfermagem

4.8. Preencha, em duas vias, a ficha de atendimento com descrição detalhada do fato e a ficha de "Evidência de Morte Óbvia na Cena";

4.9. Comunique ao MR;

4.10. Entregue a primeira via da ficha preenchida de "Evidência de Morte Óbvia na Cena" para familiares;

4.11. Nos casos de dificuldade de identificação do corpo através do documento apresentado, comunique o MR;

4.12. Solicitar à CRU a presença do policiamento na ausência de familiar, ou quando for percebido que o familiar não possui capacidade de discernimento (por exemplo: quando estiver muito abalado, for menor de idade ou apresentar deficiência intelectual).

4.13. Caso haja outros achados que considere importante (hematomas, escoriações, deformidades), anote na ficha de atendimento;

4.14. Anote o nome do familiar que recebeu a ficha e o número da identidade, e siga com as orientações abaixo:

4.14.1. O familiar deve dirigir-se à delegacia mais próxima portando seu documento próprio, documento de identificação da vítima, ambos com foto e a ficha de "Evidência de Morte Óbvia";

4.14.2. Caso a família tenha um médico responsável pela vítima, poderá acioná-lo para fornecer a declaração de óbito, desde que não tenha evidência de morte suspeita. Neste caso, comunicar MR para pedir apoio policial;

4.15. No caso de médico da família, passar o caso para o MR, com as identificações do profissional (CRM e nome completo);

ATENÇÃO

4.16. Informar os familiares que a ficha de evidência de morte óbvia não se trata de um atestado de óbito;

4.17. Caso haja algum risco à integridade física da equipe, transporte a vítima, mesmo em morte óbvia, à unidade de saúde;

4.18. Coloque o corpo na cama ou sofá, caso a vítima esteja ao solo e seja solicitado pela família e a cena não seja suspeita de crime;

4.19. Utilize protocolo específico nos indícios de crime POP Intervenções em Atendimento Pré-hospitalar 019 – Ocorrências com indício de crime;

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

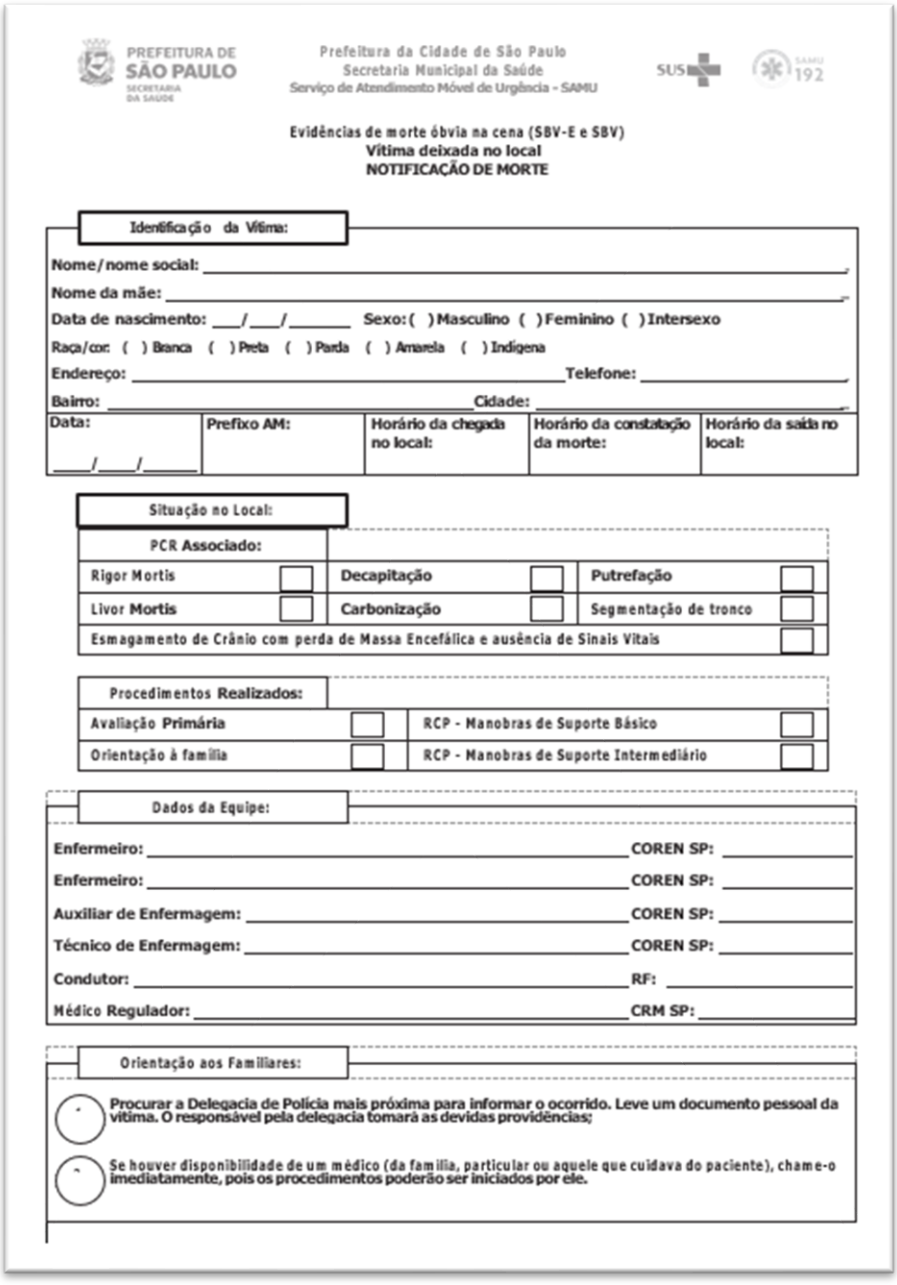
5.1. Não há.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP Intervenções em Atendimento Pré-hospitalar 019 – Ocorrências com indício de crime.

7. ANEXOS

7.1. Impresso – Evidência de Morte Óbvia:



PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

Prefeitura da Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU

SUS

SAMU 192

Evidências de morte óbvia na cena (SBV-E e SBV)
Vítima deixada no local
NOTIFICAÇÃO DE MORTE

Identificação da Vítima:

Nome/nome social: _____

Nome da mãe: _____

Data de nascimento: ___/___/_____ Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino ( ) Intersexo

Raça/cor: ( ) Branca ( ) Preta ( ) Parda ( ) Amarela ( ) Indígena

Endereço: _____ Telefone: _____

Bairro: _____ Cidade: _____

Data: ___/___/_____	Prefixo AM:	Horário da chegada no local:	Horário da constatação da morte:	Horário da saída no local:

Situação no Local:

PCR Associado:

Rigor Mortis	☐	Decapitação	☐	Putrefação	☐
Livor Mortis	☐	Carbonização	☐	Segmentação de tronco	☐
Esmagamento de Crânio com perda de Massa Encefálica e ausência de Sinais Vitais					☐

Procedimentos Realizados:

Avaliação Primária	☐	RCP - Manobras de Suporte Básico	☐
Orientação à família	☐	RCP - Manobras de Suporte Intermediário	☐

Dados da Equipe:

Enfermeiro: _____ COREN SP: _____

Enfermeiro: _____ COREN SP: _____

Auxiliar de Enfermagem: _____ COREN SP: _____

Técnico de Enfermagem: _____ COREN SP: _____

Condutor: _____ RF: _____

Médico Regulador: _____ CRM SP: _____

Orientação aos Familiares:

- Procurar a Delegacia de Polícia mais próxima para informar o ocorrido. Leve um documento pessoal da vítima. O responsável pela delegacia tomará as devidas providências;
- Se houver disponibilidade de um médico (da família, particular ou aquele que cuidava do paciente), chame-o imediatamente, pois os procedimentos poderão ser iniciados por ele.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. COFEN – Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN nº 653, de 26 de outubro de 2020. Normatiza a prerrogativa de identificação de morte óbvia por profissionais de Enfermagem em serviços públicos e privados de atendimento pré-hospitalar móvel.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
07	02/02/2025	Atualização 1. Reorganização estrutural do POP, com padronização da numeração, definições e fluxos operacionais. 2. Atualização da atuação profissional, passando da atuação exclusiva do enfermeiro para a equipe de enfermagem. 3. Padronização das condutas e registros, com detalhamento das ações, comunicação ao Médico Regulador e orientações aos familiares. 4. Inclusão do impresso de "Evidência de Morte Óbvia na Cena", com definição de preenchimento em duas vias, entrega controlada ao familiar e registro formal das informações. 5. Integração com protocolos correlatos, especialmente para ocorrências com indícios de crime e situações de risco à equipe.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna Barbosa da Silva	Fabiana Amparo Ferraz Jaqueline Flor da França Elaine C. S. M. Machado	Amanda de Ornelas Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nádia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Passagem de caso ou transição de cuidados consiste na transmissão sistematizada das informações referentes ao atendimento prestado à vítima, pela equipe de atendimento pré-hospitalar, ao Médico Regulador (MR).

1.2. A comunicação efetiva possibilita uma assistência contínua, segura e individualizada, o que melhora os desfechos em saúde.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever os dados que deverão ser transmitidos ao MR, de forma sistematizada e objetiva, incluindo desde os achados até as intervenções realizadas à vítima pela equipe de enfermagem.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e CRU.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Ao final da avaliação primária e secundária da vítima (POP IAPH SBV e SBV-E- 027 - Avaliação Primária e Secundária da Vítima com Agravo Clínico e POP IAPH SBV E SBV-E 047 Atendimento a Vítima de Trauma), a equipe deve passar o caso para o MR informando:

4.1.1. Identificação da equipe;

4.1.2. Sexo e idade da vítima;

4.1.3. Motivo do chamado;

4.1.4. O que foi encontrado na cena incluindo (queixa e/ ou mecanismo da lesão);

4.1.5. Problemas identificados na avaliação primária e secundária;

4.1.6. Procedimentos realizados;

4.1.7. Autorização para abordagem medicamentosa (se necessário);

4.1.8. Confirmação da unidade de destino para transporte da vítima.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. A passagem de caso deve ser realizada, preferencialmente, pelo médico no SAV, pelo enfermeiro nas equipes de SBV-E, pelo técnico/auxiliar de enfermagem nas equipes de SBV, e, na impossibilidade, pelo condutor socorrista, que fará o contato com o Médico Regulador (MR).

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP IAPH SBV e SBV-E- 027 - Avaliação Primária e Secundária da Vítima com Agravo Clínico.

6.2. POP IAPH SBV E SBV-E 047 Atendimento a Vítima de Trauma

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. Protocolo de Atendimento Pré-Hospitalar: Suporte Intermediário de Vida. São Paulo: Secretaria Municipal de Saúde – SAMU, 2022; 5ª. Edição.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Atualização e padronização conceitual da passagem de caso 2. Inclusão do conceito de transição de cuidados e comunicação efetiva 3. Revisão e ampliação do objetivo do protocolo 4. Atualização das áreas e estruturas operacionais envolvidas 5. Reorganização e detalhamento dos procedimentos de passagem de caso 6. Ampliação do rol de informações obrigatórias ao Médico Regulador 7. Inclusão da identificação da equipe na comunicação 8. Inclusão da solicitação de autorização para abordagem medicamentosa 9. Inclusão da confirmação da unidade de destino 10. Padronização do profissional responsável pela passagem de caso conforme o tipo de equipe

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Edna B da Silva Cassia Oliveira Lopes	Camila M. Okiyama Fabiana Lima Ribeiro Fernanda Vaz Toste Márcia Cristina L Barreiros Miriam Kelly Barga Maria Carolina Tufolo Renan de S. M. Gonçalves Sérgio José da Silva	Amanda de Ornelas Bárbara de Souza Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Pertences da vítima: são todos os bens e objetos que acompanham o paciente no momento do atendimento, como documentos, celulares, roupas, óculos, órteses e próteses, dispositivos de mobilidade (bengala, muleta, cadeira de rodas), bem como itens de maior porte ou uso específico, como motocicleta, bicicleta, capacete, entre outros.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever a atuação da equipe do SAMU 192 São Paulo frente aos pertences da vítima.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e Central de Regulação.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

Vítimas desacompanhadas e com alteração do nível de consciência ou que não são capazes de responder por si mesmas.

4.1. Todos os pertences pessoais (bolsa, mochila, carteira, celular etc.) devem ser transportados junto com a vítima;

4.2. Na presença de pertences, faça o registro de cada item na ficha de atendimento no campo "REGISTRO DE PERTENCES DO PACIENTE", e entregue a segunda via na unidade de saúde;

4.3. Os pertences da vítima devem ser entregues ao profissional responsável pelo seu recebimento na unidade de saúde de destino, devendo ser registrado o nome desse profissional, bem como colhida sua assinatura e carimbo, para comprovação da entrega;

4.4. Caso vítima grave: realizar o rol de pertences na unidade de saúde após a passagem do caso;

4.5. Nos casos em que o paciente estiver acompanhado de pertences que não podem ser transportados na viatura (ex.: motocicleta, bicicleta, entre outros), comunicar imediatamente o médico regulador para solicitação de apoio (Polícia, CET ou órgão competente) e registrar na ficha de atendimento;

4.5.1. Na impossibilidade de aguardar, devido ao quadro clínico do paciente, informar ao médico regulador quanto à remoção sem a chegada do apoio;

4.5.2. As situações devem ser avaliadas individualmente, com o apoio da CRU.

Vítimas acompanhadas

4.6. Entregar os pertences pessoais ao acompanhante e registrar o nome do portador na ficha de atendimento;

Vítimas conscientes/ orientadas

4.7. Registrar os pertences na ficha de atendimento e mantê-los com o paciente.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Quando o paciente for cadeirante ou fizer uso de dispositivo auxiliar de locomoção (como bengala, muleta, andador ou cadeira de rodas), a equipe deverá transportar o referido recurso junto na viatura do SAMU e entregá-lo ao serviço hospitalar, registrando em ficha de atendimento, garantindo que o paciente mantenha sua acessibilidade;

5.2. Em caso de cão-guia, consultar POP IAPH SBV e SBV-E- 014 – Atendimento à Vítima Acompanhada de Animais (Cão-Guia ou Outros).

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP IAPH SBV e SBV-E- 014 – Atendimento à Vítima Acompanhada de Animais (Cão-Guia ou Outros)

7. ANEXOS

7.1. Campo da ficha de atendimento, para registro dos pertences do paciente:

REGISTRO DE PERTENCES DO PACIENTE		
Nº	Descrição	Identificação do Recebedor
1		Nome:
2		Documento:
3		Local:
4		Assinatura:

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. Protocolo de Atendimento Pré-Hospitalar: Suporte Básico de Vida. São Paulo: Secretaria Municipal de Saúde – SAMU, 2022. 8ª. Edição. 322 p

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Atualização e ampliação da definição de pertences da vítima 2. Reformulação do objetivo com foco institucional (SAMU 192 São Paulo) 3. Reorganização e detalhamento dos procedimentos para vítimas desacompanhadas 4. Padronização do registro de pertences na ficha de atendimento 5. Inclusão de exigência de identificação, assinatura e carimbo do responsável pelo recebimento 6. Ampliação das orientações para manejo de pertences de grande porte 7. Inclusão da comunicação obrigatória com o Médico Regulador para apoio intersetorial 8. Atualização das condutas 9. Inclusão de orientações para dispositivos auxiliares de locomoção 10. Inclusão de referência a POP específico para atendimento com cão-guia

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Edna Barbosa da Silva	Daiane C. de Moraes Lilian Maria de Oliveira Jaqueline Flor da França Fabiana Amparo Ferraz	Amanda de Ornelas Henrique CSA Leão Filho Bárbara de Souza Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. A transição de cuidados é o processo estruturado de transferência da responsabilidade assistencial do paciente entre profissionais, equipes, serviços ou níveis de atenção para garantir a continuidade, segurança e qualidade do atendimento;

1.2. A transição de cuidados envolve a comunicação clara, completa e oportuna das informações clínicas essenciais sempre que o paciente muda de local, equipe ou fase do tratamento;

1.3. SBAR: ferramenta de comunicação padronizada, utilizada na transição de cuidados, que organiza as informações de forma clara, objetiva e segura.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever o uso da ferramenta SBAR para a transição de cuidados do paciente à unidade de saúde.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E e URAM.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

O profissional líder da equipe deve passar o caso para o profissional que recepciona a vítima na unidade de saúde, utilizando a sequência descrita na ferramenta SBAR:

4.1. **S** (situação) – Quem é o paciente e qual é a situação no momento;

4.1.1. Nome da vítima e idade aproximada;

4.1.2. Causa/motivo do atendimento;

4.1.3. Em caso de trauma, mecanismo e energia envolvida;

4.2. **B** (breve histórico) – Informações clínicas relevantes do passado médico e do evento atual;

4.2.1. Doenças prévias;

4.2.2. Uso de medicações;

4.2.3. Detalhes relevantes do caso;

4.3. **A** (avaliação) – Informações sobre o quadro atual da vítima;

4.3.1. Problemas identificados;

4.3.2. Sinais vitais;

4.3.3. Procedimentos realizados;

4.4. **R** (recomendações) – O que precisa ser feito em seguida;

4.4.1. Próximos passos no cuidado da vítima;

4.4.2. Exames necessários;

4.4.3. Encaminhamentos/ intervenções.

4.5. Informar a presença ou ausência de familiar/acompanhante;

4.6. Solicitar assinatura do receptor das informações na ficha de atendimento.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Nos casos em que a equipe hospitalar se recusar a assinar a ficha de atendimento do SAMU, siga orientações do POP Central de Regulação e Intervenção 6-012- Passagem de caso à equipe do hospital e recusa de assinatura (em vítimas sem risco iminente de vida).

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP Central de Regulação e Intervenção 6-012 Passagem de caso à equipe do hospital e recusa de assinatura (em vítimas sem risco iminente de vida).

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. MÜLLER, M. et al. Impact of the communication and patient hand-off tool SBAR patient safety: Open 2018;8:e022202. Disponível a systematic review. BMJ em: *https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/8/8/e022202.full.pdf. Acesso em 18/12/2025*

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Alteração do nome do POP, de **"Passagem do Caso na Unidade de Saúde"** para **"Transição de Cuidados para a Unidade de Saúde"**, adequando a terminologia ao conceito atual de continuidade e segurança do cuidado. 2. Atualização do conceito de passagem de caso para transição de cuidados. 3. Inclusão de definições ampliadas. 4. Padronização da comunicação por meio da ferramenta SBAR. 5. Ampliação das áreas envolvidas, contemplando SBV, SBV-E e URAM. 6. Organização das informações clínicas em etapas lógicas (Situação, Histórico, Avaliação e Recomendações), substituindo a listagem descritiva anterior. 7. Inclusão de orientações sobre próximos passos assistenciais, exames e encaminhamentos necessários.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Edna Barbosa da Silva	Camila M. Okiyama Dermival O. Xavier Fabiana Lima Ribeiro Fernanda Vaz Toste Márcia Cristina L Barreiros Maria Carolina Tufolo Renan de S. M. Gonçalves	Amanda de Ornelas Bárbara de Souza Matheus D. Miachon	Nádia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. A avaliação primária identifica as condições que ameaçam a vida e estabelece estratégias terapêuticas imediatas;

A avaliação secundária consiste na realização da anamnese e do exame físico mais detalhado, que deve ser feito de maneira sequencial, da cabeça aos pés.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever as etapas da avaliação primária e secundária, bem como a abordagem pré-hospitalar realizada pelas equipes de enfermagem do SAMU à vítima com agravo clínico.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E e URAM

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

Vítima Responsiva ao estímulo verbal e tátil;

Avaliação Primária (utilize o mnemônico ABCDE)

4.1. **A** – Verifique a permeabilidade das vias aéreas (vítima consegue falar? Há algum sinal de obstrução?);

4.2. **B** – Verifique a qualidade da respiração (velocidade, profundidade e simetria do tórax);

4.3. **C** – Verifique a circulação (pele, pulso e perfusão);

4.4. **D** – Verifique o nível de consciência (pergunte o nome da vítima, o que aconteceu e onde ela está – localização, tempo e espaço);

4.5. **E** – Verifique a necessidade de exposição da vítima e preserve sua temperatura.

Avaliação secundária

4.6. Verifique os sinais vitais, incluindo: frequência respiratória, saturação de oxigênio, pressão arterial, frequência cardíaca, glicemia capilar;

4.7. Realize a entrevista utilizando o mnemônico SAMPLER:

4.7.1. **S** – Sinais e sintomas;

4.7.2. **A** – Alergias;

4.7.3. **M** – Medicamentos em uso;

4.7.4. **P** – Passado médico;

4.7.5. **L** – Líquidos e alimentos ingeridos;

4.7.6. **E** – Eventos precedentes;

4.7.7. **R** – Riscos (fatores);

4.8. Realize o exame físico direcionado a queixa da vítima;

<u>Vítima NÃO responsiva ao estímulo verbal e tátil</u>;

Avaliação Primária (utilize o mnemônico ABCDE)

4.9. **A** – Verifique a permeabilidade das vias aéreas;

<u>Abordagem para os problemas encontrados:</u>

4.9.1. Obstrução das vias aéreas: aspire a cavidade oral se presença de líquidos ou secreções; realize a técnica de elevação do mento para abertura das vias aéreas; aplique o dispositivo cânula orofaríngea se necessário;

4.10. **B** – Verifique a qualidade da respiração (velocidade, profundidade e simetria do tórax);

<u>Abordagem para os problemas encontrados:</u>

4.10.1. Ausência de respiração (com pulso central presente): utilize o dispositivo bolsa-válvula-máscara conectado ao cilindro de oxigênio 10 a 15l/min e realize 1 ventilação a cada 6 segundos durante 2 minutos, e após reavalie;

4.10.2. Na presença de respiração muito rápida (FR > 30 mrpm) ou muito lenta (FR < 10 mrpm) utilize o dispositivo bolsa-válvula-máscara conectado ao cilindro de oxigênio 10 a 15l/min e realize 1 ventilação a cada 6 segundos durante 2 minutos, e após reavalie;

4.10.3. Na presença de respiração com FR < 30 ou > 10 mrpm instale oxigenoterapia se necessário. Seguir orientações POP IAPH SBV e SBV-E 030 – Insuficiência Respiratória.

4.11. **C** – Verifique a circulação (pele, pulso e perfusão);

Abordagem para os problemas encontrados:

4.11.1. Ausência de pulso central: inicie as manobras de ressuscitação cardiopulmonar conforme POP IAPH SBV e SBV-E 029 – Ressuscitação Cardiopulmonar no adulto;

4.12. **D** – Verifique o nível de consciência utilizando a Escala de Coma de Glasgow (pontuação mínima de 3 pontos e máxima de 15 pontos) ou o mnemônico AVDN;

Escala de Coma de Glasgow

Itens	Resposta	Pontuação
Abertura Ocular	Espontânea	4
	À voz	3
	À dor	2
	Nenhuma	1
Resposta Verbal	Orientada	5
	Confusa	4
	Palavras inapropriadas	3
	Sons incompreensíveis	2
	Nenhuma	1
Resposta Motora	Obedece a comandos	6
	Localiza a dor	5
	Movimentos de retirada	4
	Flexão normal	3
	Extensão anormal	2
	Nenhuma	1

Escala AVDN

AVDN	
A	Alerta
V	Responde a comandos verbais
D	Responde a estímulo doloroso
N	Nenhuma resposta

4.13. **E** – Verifique a necessidade de exposição da vítima e preserve sua temperatura com manta aluminizada ou cobertor.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. A equipe deverá deslocar-se até a cena portando as mochilas devidamente equipadas, e não apenas materiais para aferição de sinais vitais, a fim de evitar o retorno à ambulância para coleta de equipamentos necessários e, consequentemente, prevenir perda de tempo no atendimento ao paciente;

5.2. Relatórios, exames de imagem, receitas recentes, caixa de medicamentos e tudo que esteja relacionado com a doença atual, deve acompanhar a vítima à unidade de saúde de destino;

5.3. A avaliação secundária não deve retardar o transporte da vítima para unidade de saúde, podendo ser realizada durante o deslocamento.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

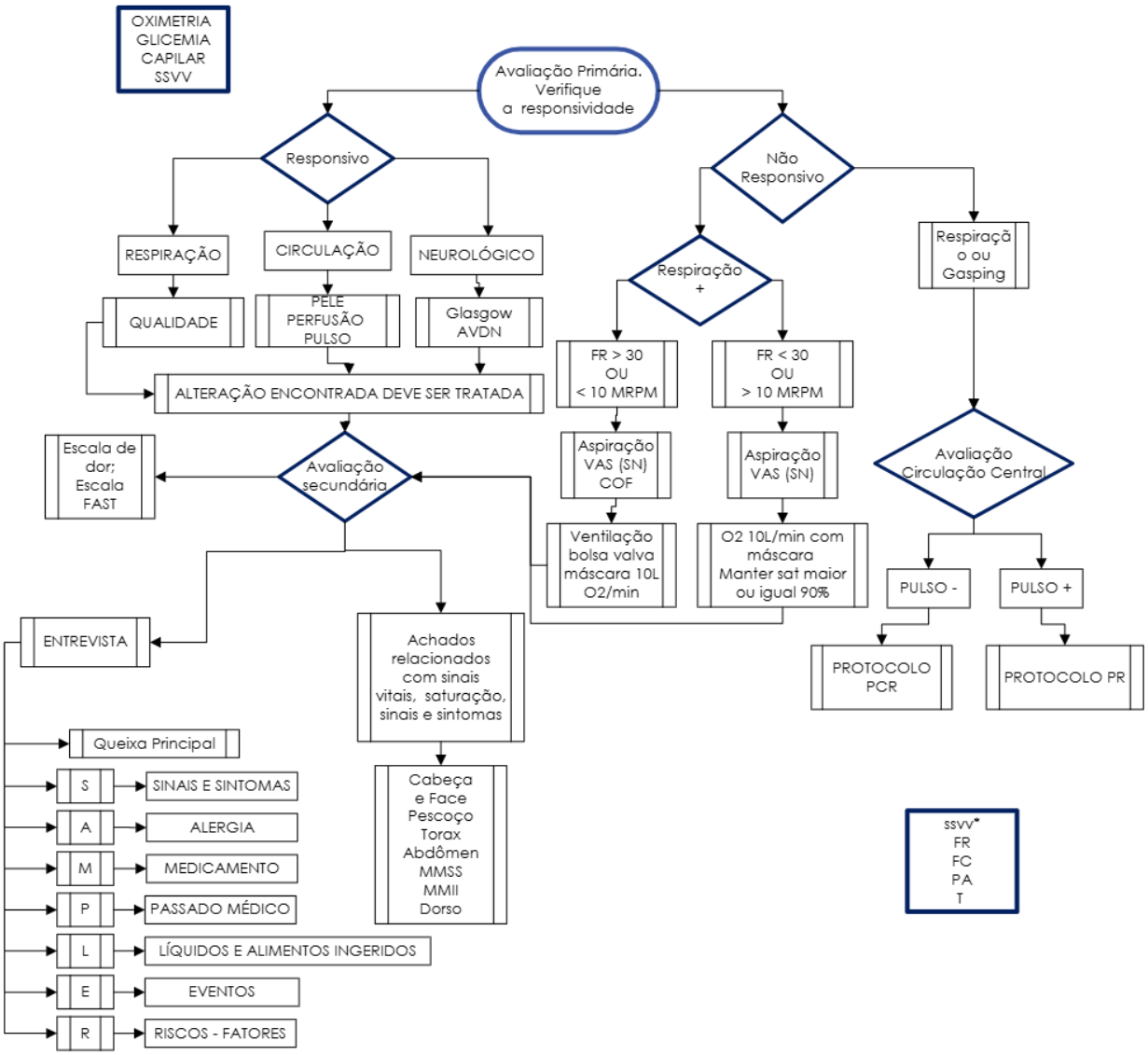
6.1.1. POP IAPH 030 – Insuficiência Respiratória.

6.1.2. POP IAPH 029 – Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) no Adulto;

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA



9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. (NAEMT), National Association of Emergency Medical Technicians. AMLS: Advanced Medical Life Support: Atendimento Pré-Hospitalar às Emergências Clínicas. Porto Alegre: Artmed, 2022. Ebook.

9.2. Velasco, IT, Brandão Neto, RA, Souza, HP, *et al.* Emergências Clinicas: Abordagem Prática 14ª Ed. Manole, Barueri-SP, 2020.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Reestruturação do documento. 2. Ampliação das equipes envolvida. 3. Atualização do objetivo: adequação do foco para a abordagem pré-hospitalar da vítima clínica. 4. Padronização da avaliação primária: adoção do mnemônico ABCDE como método único de avaliação. 5. Separação por responsividade da vítima: definição de condutas distintas para vítimas responsivas e não responsivas. 6. Atualização das condutas assistenciais. 7. Padronização da avaliação secundária. 8. Inclusão de orientações operacionais. 9. Atualização da ilustração do fluxo de atendimento

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Marisa A. Amaro Malvestio Adriana Ap. dos Santos Flávia Guedes Araújo Ivone Fernandes Alves Marcia Rosa de Souza Lopes Amanda de Fatima P. Rocha Carlos Odercio Zanquetta Naiane Clara Clemento Luís Cássio Carneiro Leão Patrícia Caroline Alves de Sousa	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. A obstrução das vias aéreas por corpo estranho (OVACE) consiste na obstrução da passagem de ar pelas vias aéreas, causada pela aspiração de um corpo estranho, geralmente localizada na laringe ou traqueia. Essa obstrução pode ser classificada como parcial (leve) ou total (grave):

1.1.1. Obstrução parcial: a vítima apresenta alguma troca gasosa e ainda consegue tossir;

1.1.2. Obstrução total: não há mais passagem de ar, a troca gasosa torna-se ineficaz, a vítima apresenta tosse ineficaz, ruídos respiratórios estridentes, dificuldade respiratória acentuada e cianose.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever os sinais, sintomas e a abordagem pré-hospitalar realizada pelas equipes do SAMU à vítima com OVACE.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e CRU.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Realize a avaliação da segurança da cena;

4.2. Realize avaliação primária e intervenha conforme achados:

Se obstrução parcial:

4.3. Não interfira e estimule a vítima a tossir até que haja a desobstrução;

4.4. Se saturação < 94%, oferte oxigênio por máscara ou cateter nasal;

Se obstrução total em vítima consciente:

4.5. Explique o procedimento à vítima e inicie ciclos repetidos de 5 golpes nas costas, seguidos de 5 compressões abdominais, até que que ocorra a desobstrução ou a vítima se torne inconsciente (Figura 1);

4.5.1. Posicione-se atrás da vítima, levemente lateralizado, apoiando o tórax anterior com uma das mãos e aplique 5 golpes (tapas) na região interescapular, utilizando a região central da mão;

4.5.2. Posicione uma das mãos fechada, com a parte lateral voltada para a parede abdominal da vítima, entre o apêndice xifoide e a cicatriz umbilical, e realize 5 compressões com movimento de fora para dentro e de baixo para cima, simultaneamente;

Figura 1: Sequência de manobras para desobstrução da via aérea por corpo estranho no adulto consciente.

Fonte: https://depositphotos.com/br/illustrations/engasgo.html

ATENÇÃO

4.6. Em vítimas obesas e gestantes no último trimestre, o posicionamento das mãos deve ser realizado sobre o esterno, na linha axilar média (Figura 2);

Figura 2: Posicionamento das mãos em gestantes

Fonte: *https://sanarmed.com/resumo-de-ovace-epidemiologia-fisiopatologia-diagnostico-e-tratamento/*

Se obstrução total em vítima inconsciente:

4.7. Posicione a vítima em decúbito dorsal horizontal em superfície rígida;

4.8. Realize 30 compressões torácicas;

4.9. Realize abertura das vias aéreas e observe a cavidade oral: se visualizar o corpo estranho e se este estiver acessível, remova-o com os dedos em forma de pinça. Se nada for visualizado, realize uma ventilação com bolsa-válvula-máscara; se o ar não passar ou o tórax não expandir, reposicione a cabeça e realize outra ventilação com bolsa-válvula-máscara; se o ar ainda não passar, realize 30 compressões torácicas;

4.10. Repita as manobras até que o corpo estranho seja expelido ou a via aérea se torne pérvia;

4.11. Quando as vias aéreas se tornarem pérvias, coloque a vítima em decúbito lateral e oferte oxigênio 10 a 15l/min por máscara não-reinalante;

4.12. Realize o SAMPLER, com ênfase para pesquisa dos sinais e sintomas, alergias, histórico de saúde e medicamentos em uso;

4.13. Realize contato com a Regulação Médica para a passagem sistematizada das informações;

4.14. Siga as orientações da Regulação Médica para procedimentos e/ou transporte para unidade de saúde de destino;

4.15. Realize o transporte para a unidade de saúde de destino indicada pela Regulação Médica, com a vítima em decúbito elevado;

4.16. Registre os achados e procedimentos realizados na Ficha de Atendimento.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não há.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. AMERICAN HEART ASSOCIATION. Destaques das Diretrizes para Ressuscitação Cardiopulmonar e Atendimento Cardiovascular de Emergência de 2025. [s.l.], 2025.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Atualização do título: padronização da nomenclatura para Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho (OVACE) no adulto. 2. Ampliação da definição: inclusão da classificação da OVACE em obstrução parcial e total, com descrição clínica associada. 3. Atualização do objetivo. 4. Ampliação das áreas envolvidas: inclusão de SBV, SBV-E, URAM e CRU. 5. Padronização da abordagem inicial. 6. Organização das condutas por tipo de obstrução. 7. Atualização das manobras de desobstrução. 8. Alinhamento com protocolos de RCP. 9. Inclusão de cuidados pós-desobstrução. 10. Atualização dos registros assistenciais. 11. Inclusão de ilustrações orientativas: apoio visual para padronização das manobras.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Andrea Christina Simões Marcia Rosa de S. Lopes Patrícia C. A. de Souza Victor Bezerra de Souza	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. A parada cardiorrespiratória (PCR) é a cessação súbita e completa da função cardíaca e da respiração. É caracterizada por inconsciência, ausência de respiração e ausência de pulso central.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever os sinais que determinam a PCR e a abordagem pré-hospitalar realizada pela equipe assistencial à vítima nesta condição.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e CRU.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Realize a avaliação da segurança de cena;

4.2. Realize avaliação primária e intervenha conforme achados:

4.2.1. Avalie a responsividade;

4.2.2. Verifique se há presença do pulso carotídeo e movimentos respiratórios por 5 a 10 segundos e confirme a PCR (afaste sinais de morte óbvia);

4.3. Deite a vítima em uma estrutura plana e rígida;

4.4. Inicie as compressões/ventilações na relação de 30:2;

4.4.1. Realize as compressões com as mãos entrelaçadas e os braços formando um ângulo de 90º em relação à vítima;

4.4.2. Comprima o tórax de 5 a 6 cm de profundidade;

4.4.3. Permita o completo retorno do tórax;

4.4.4. Minimize as interrupções nas compressões;

4.4.5. Mantenha frequência de 100 a 120 compressões por minuto;

4.4.6. Realize o revezamento do profissional que aplica a compressão a cada 2 minutos;

4.5. Solicite apoio à CRU;

4.6. Abra a via aérea com a inclinação da cabeça e elevação do mento;

4.7. Retire prótese frouxa/ solta, restos de alimentos e aspire secreções;

4.8. Instale a cânula orofaríngea;

4.9. Acople a bolsa-valva-máscara na face da vítima;

4.10. Evite escape de ar pelo dispositivo durante a ventilação;

4.11. Comprima a bolsa-valva-máscara em duração de 1 segundo;

4.12. Ventile, mantendo sincronismo 30 compressões e 2 ventilações;

4.13. Instale as pás do DEA assim que disponível;

4.14. Ligue o aparelho;

4.15. Durante a análise do ritmo, não toque no paciente;

4.16. Siga a orientação sonora do DEA

4.17. Se choque indicado, certifique-se de que todos estão afastados antes de administrar a carga;

4.18. Realize as compressões torácicas e ventilações na relação de 30:2, quando não houver via aérea avançada OU 1 ventilação a cada 6 segundos, assíncronas com as compressões torácicas, assim que a via aérea avançada for estabelecida;

<u>Abordagem medicamentosa somente quando na presença do Enfermeiro:</u>

Ritmo não chocável (AESP e Assistolia):

4.19. Puncione acesso venoso periférico com cateter n ° 18 <u>OU</u>, na impossibilidade, utilize a via intraóssea (privativo do enfermeiro);

4.20. Administre Epinefrina 1 mg EV ou IO;

4.21. Administre flush de 20 ml de SF 0,9%, após infusão da Epinefrina;

4.22. Eleve o membro após administrar o flush, se via EV;

4.23. Retorne a RCP por mais 2 minutos;

4.24. Considere via aérea avançada com máscara laríngea (privativo do enfermeiro);

4.25. Repita a administração de Epinefrina a cada 3 a 5 minutos e flush com 20 ml de SF 0,9%, elevando o membro;

4.26. Após 2 ciclos de RCP e 2 doses de Epinefrina, busque as causas reversíveis da PCR e fatores contribuintes (5H e 5T)**

4.27. Continue a RCP de alta qualidade (Figura 1);

** CAUSAS REVERSÍVEIS			
H	HIPOVOLEMIA	**T**	TÓXICOS
	HIPÓXIA		TAMPONAMENTO CARDÍACO
	HIDROGÊNIO (ÍON): ACIDOSE		TENSÃO NO TÓRAX
	HIPER/HIPOCALEMIA		TROMBOSE CORONÁRIA
	HIPOTERMIA		TROMBOEMBOLISMO PULMONAR

Abordagem medicamentosa somente quando na presença do Enfermeiro: Ritmo chocável (FV e TVSP):

4.28. Puncione acesso venoso periférico com cateter n ° 18 OU, na impossibilidade, utilize a via intraóssea (privativo do enfermeiro);

4.29. Administre Epinefrina 1 mg EV, após o segundo choque;

4.30. Administre flush de 20 ml de SF 0,9% após infusão do Epinefrina;

4.31. Eleve o membro após administrar o flush, se via EV;

4.32. Repita a administração de Epinefrina a cada 3 a 5 minutos e flush com 20 ml de SF 0,9%, elevando o membro;

4.33. Considere via aérea avançada com máscara laríngea (ação privativa do enfermeiro);

4.34. Administre a 1ª dose de Amiodarona 300 mg EV, após o terceiro choque;

4.35. Administre flush de 20 ml de SF 0,9%;

4.36. Eleve o membro após administrar o flush, se via EV;

4.37. Busque as causas reversíveis da PCR e fatores contribuintes (5H e 5T)**;

4.38. Administre a 2ª dose de Amiodarona 150 mg EV, após o quinto choque;

Abordagem medicamentosa somente quando na presença do Enfermeiro na suspeita de PCR por intoxicação por opioide:

4.39. Após o retorno da circulação espontânea (RCE) e na suspeita de intoxicação por opioide, administre uma ampola de Naloxona (0,4 mg/ml) diluída em 10ml de SF0,9% EV lenta e de forma titulada;

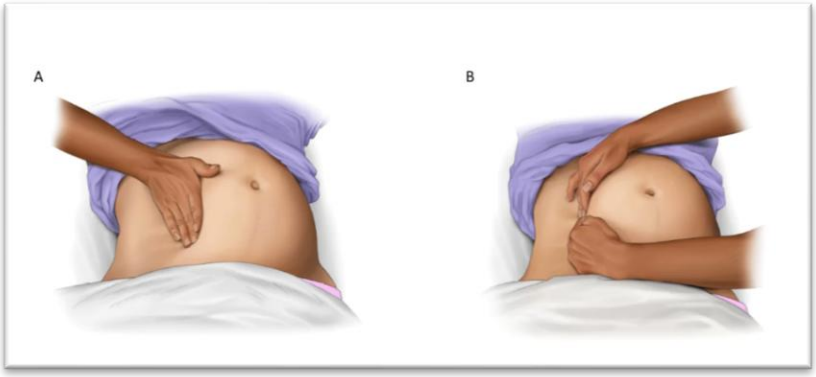
4.40. Sinais e sintomas de intoxicação por opioides: desconforto respiratório; miose (pupilas puntiformes); rebaixamento do nível de consciência; bradicardia; hipotensão; hipotermia; pele fria e pegajosa;

4.41. Quando suspeitar de intoxicação por opioides: achados clínicos compatíveis e contexto sugestivo, como presença de ampolas, comprimidos ou seringas; histórico pregresso de uso de opioides;

4.42. Avalie se a vítima acorda;

4.43. Em casos de PCR em gestante, ao iniciar a RCP em DDH realize manualmente o deslocamento lateral do útero para a esquerda.

Deslocamento uterino manual durante RCP na gestante



Fonte: nucleodoconhecimento.com.br/saude/circunstancias-especiais

Critérios para suspender os esforços da RCP

4.44. Retorno da circulação espontânea;

4.45. Decisão do médico regulador;

4.46. Decisão do médico do SAV e/ou GRAU na cena;

4.47. Decisão do médico no hospital de destino;

4.48. Exaustão da equipe;

4.49. Cena insegura: condições ambientais insalubres ou de agressão direcionada à equipe.

Regras gerais para deslocamento da vítima em PCR

4.50. Cabe ao médico regulador decidir junto à equipe se deve aguardar apoio do SAV ou realizar transporte imediato;

4.51. Planeje o deslocamento, abrindo espaço suficiente para passagem da maca até a ambulância;

4.52. Realize o transporte do paciente sobre a prancha rígida posicionada na maca, utilizando os cintos de segurança;

4.53. Atente-se para não restringir a expansibilidade do tórax pelo uso do cinto;

4.54. Considere a melhor posição da vítima dentro de elevadores;

4.55. Finalize o ciclo de 2 minutos antes de interromper;

4.56. Retome a RCP entre um lance e outro quando necessitar usar escadas;

4.57. Garanta a segurança para o profissional que realiza as compressões durante deslocamento.

Cuidados pós-PCR

4.58. Mantenha a via aérea pérvia: avalie a necessidade de via aérea avançada ou uso de máscara de oxigênio 10 a 15 litros/minuto, se respiração espontânea;

4.59. Se parada respiratória ou respiração ineficaz: realize 1 ventilação a cada 6 segundos com bolsa-valva-máscara;

4.60. Mantenha os eletrodos do DEA no tórax da vítima;

4.61. Mantenha a monitorização contínua dos parâmetros vitais;

4.62. Realize glicemia capilar e corrija caso necessário;

4.63. Na recorrência de PCR, reinicie as manobras;

4.64. Mantenha o protetor lateral para apoio da cabeça da vítima;

4.65. Mantenha a vítima presa com os tirantes.

4.66. Realize o transporte para a unidade de saúde de destino indicada pela Regulação Médica;

4.67. Registre os achados e procedimentos realizados na Ficha de Atendimento.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

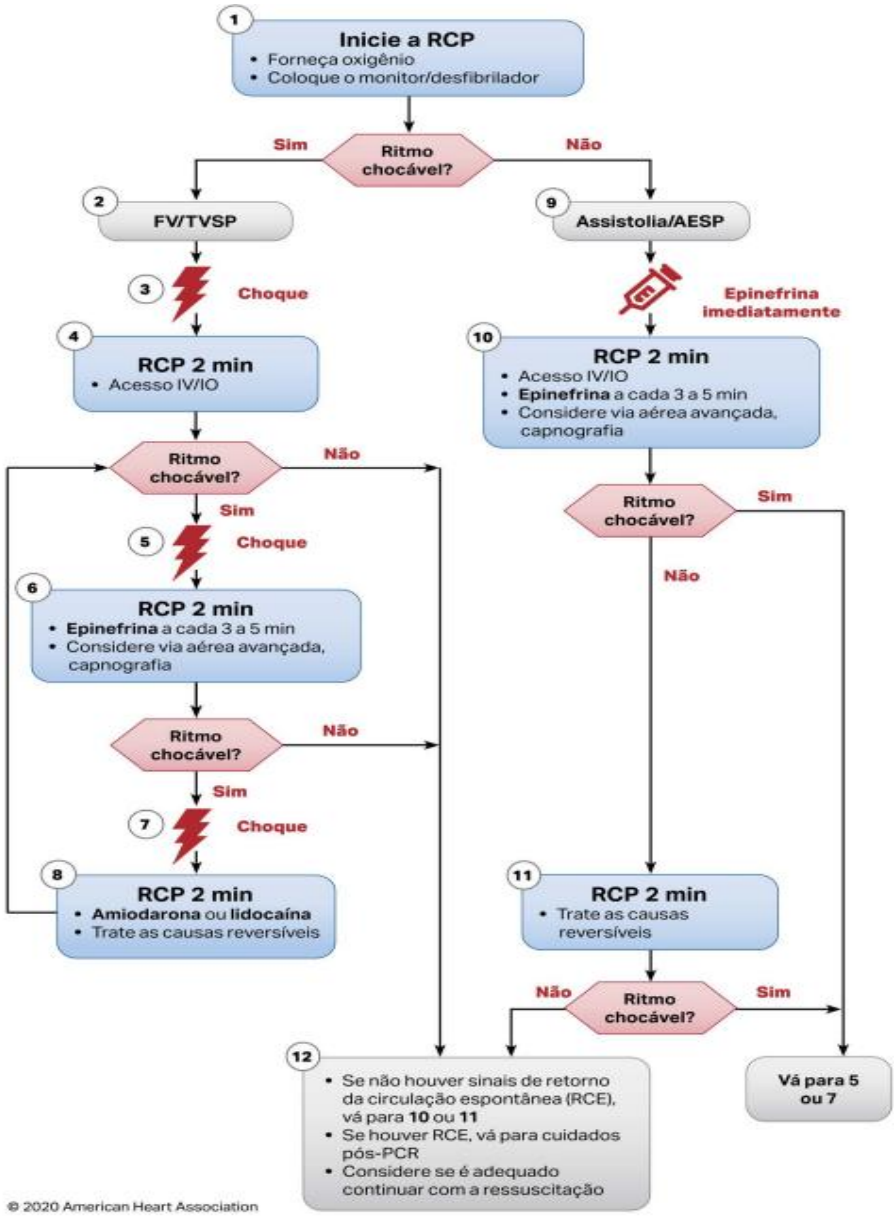
5.1. Não há.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

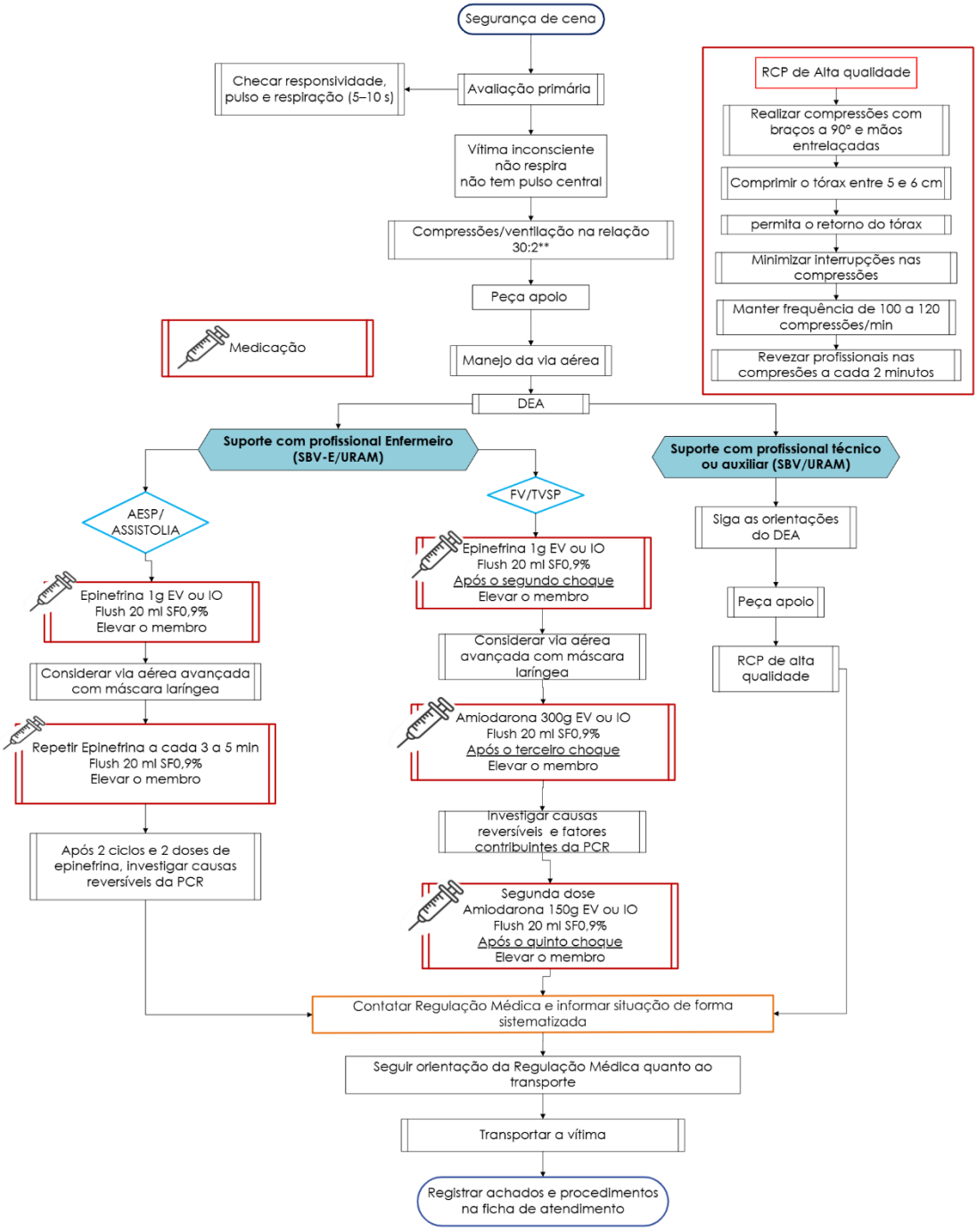
6.1. Não há.

7. ANEXOS

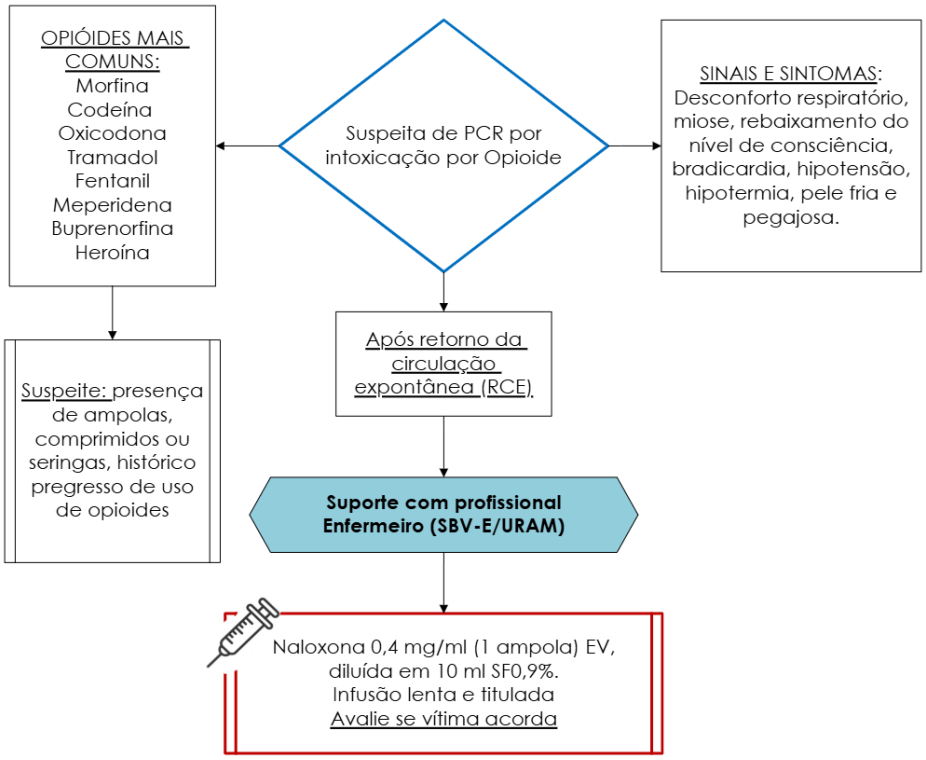
7.1. **Figura 1: Algoritmo de PCR para adultos – AHA**



8. FLUXOGRAMA -Atendimento PCR



8.1. Atendimento em suspeita de intoxicação por Opioide



9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. (NAEMT), National Association of Emergency Medical Technicians. AMLS: atendimento pré-hospitalar às emergências clínicas. Advanced Medical Life Support. Porto Alegre: ArtMed, 2022.

9.2. AMERICAN HEART ASSOCIATION. Advanced Cardiovascular Life Support: Provider Manual. Dallas, TX: American Heart Association, 2020. ISBN 978-1-61669-772-3

9.3. AMERICAN HEART ASSOCIATION. Destaques das Diretrizes para Ressuscitação Cardiopulmonar e Atendimento Cardiovascular de Emergência de 2025. [s.l.], 2025.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Alteração do nome do protocolo de "PCR em Adulto e RCP" para "Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) no Adulto", com padronização da nomenclatura técnica. 2. Atualização conceitual da definição de PCR, alinhada às diretrizes atuais. 3. Adequação das áreas envolvidas (SBV, SBV-E, URAM e CRU). 4. Padronização das etapas da RCP de alta qualidade (frequência, profundidade, ventilação e revezamento). 5. Organização da abordagem medicamentosa por tipo de ritmo (chocável e não chocável), com delimitação das ações privativas do enfermeiro. 6. Inclusão de critérios claros para suspensão da RCP, deslocamento, cuidados pós-PCR e situações especiais (gestante e suspeita de intoxicação por opioide).

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Carlos Odércio Zanquetta Elaine Machado Luís Cássio Carneiro Leão Patrícia C. Alves de Sousa Márcia Rosa de S. Lopes Flávia Guedes Araújo Karen G. da Silva Guerreiro	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Insuficiência respiratória: condição em que o sistema respiratório não consegue realizar trocas gasosas adequadas para suprir as necessidades do organismo, resultando em oxigenação insuficiente do sangue (hipoxemia), eliminação inadequada de dióxido de carbono (hipercapnia) ou ambas, podendo ocorrer de forma aguda ou crônica e geralmente associada a sinais como dispneia, alteração do ritmo respiratório e comprometimento do nível de consciência.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever os sinais e sintomas e a abordagem pré-hospitalar realizada pela equipe de enfermagem do SAMU à vítima com insuficiência respiratória.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E e URAM.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Realize a avaliação da segurança de cena;

4.2. Realize a avaliação primária e intervenha conforme achados:

4.2.1. Mantenha a vítima em decúbito elevado;

4.2.2. Reduza esforços e fatores estressores;

4.3. Realize a avaliação secundária com ênfase em:

4.3.1. Monitore sinais vitais e saturação;

4.4. Oferte oxigênio de acordo com a saturação, o desconforto respiratório e a causa (tabela orientativa em anexo 1):

<u>$SpO_2 \geq 94\%$ (adulto sem doença pulmonar crônica):</u>

4.4.1. Não iniciar oxigenoterapia de rotina. Manter monitorização;

<u>SpO_2 90–93%:</u>

4.4.2. Iniciar O_2 por cateter nasal a 1–6 L/min e reavaliar em 3–5 minutos;

4.4.3. Ajustar até atingir SpO_2 entre 94–98%;

<u>$SpO_2 < 90\%$:</u>

4.4.4. Iniciar com cateter de O2 1-6 L/min;

4.4.5. Reavaliar e ajustar para manter SpO_2 entre 94–98%;

<u>Desconforto importante, esforço respiratório, cianose, ou $SpO_2 < 85\%$:</u>

4.4.6. Máscara não reinalante (10–15 L/min);

Pacientes com risco de hipercapnia (ex.: DPOC):

4.4.7. Manter alvo entre 88–92%, preferindo cateter nasal 1-6L/min (24–40%). Evitar saturações > 94%;

4.5. Se não atingir alvo mesmo com alto fluxo:

4.5.1. Avaliar necessidade de VNI (quando indicada) ou suporte avançado via regulação médica.

4.6. Em caso de **parada respiratória:**

4.6.1. Realize a ventilação com bolsa -válvula-máscara à 15l/min, com frequência de 1ventilação a cada a cada 6 segundos;

4.6.2. Na presença do enfermeiro, instalar máscara laríngea e manter a frequência de 1ventilação a cada 6 segundos;

4.7. Realize o SAMPLER, com ênfase para pesquisa dos sinais e sintomas, alergias, medicamentos em uso, passado médico, eventos relacionados e fatores de risco;

4.8. Considere vítima grave se presença de um ou mais sinais e sintomas: taquipneia ou dispneia, taquicardia, cianose, alteração da perfusão periférica, alteração do nível de consciência;

4.9. Realize contato com a Regulação Médica para a passagem sistematizada das informações;

4.10. Siga as orientações da Regulação Médica para procedimentos e/ou transporte para a unidade de saúde de destino;

4.11. Realize o transporte da vítima para a unidade de saúde de destino indicada pela Regulação Médica;

4.12. Mantenha a vítima em repouso com decúbito elevado;

4.13. Registre os achados e procedimentos realizados na Ficha de Atendimento.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não há.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS Tabela orientativa de dosagem de oxigênio:

DISPOSITIVO	TOLERÂNCIA SATURAÇÃO	DOSAGEM	CONCENTRAÇÃO	INDICAÇÃO
Cateter nasal	< 88%	1 - 6 L/min.	24 - 40%	DPOC.
Cateter nasal	< 90%	1 - 6 L/min.	24 - 40%	IAM; Taquicardia sintomática; Bradicardia sintomática.
Cateter nasal ou máscara não reinalante	< 94%	10 -15 L/min.	24 - 40%	Para AVC
Máscara não reinalante com reservatório	< 94%	10 – 15L/min.	90 - 100%	Intoxicação por Monóxido de carbono mesmo com saturação de 100%; Trauma; Emergências clínicas.
Ressuscitador manual com reservatório	< 94%	10 – 15L/min.	90 - 100%	PR; PCR; FR > 28 mrpm ou FR < 10 mrpm com inconsciência. Insuflar reservatório com O2 antes da utilização
Máscara não reinalante com reservatório para RN e crianças	< 94%	8 L/min	90 - 100%	Intoxicação por Monóxido de carbono mesmo com saturação de 100%; Trauma; Emergências clínicas.
Ressuscitador manual com reservatório para RN e crianças	< 94%	8 L/min.	90 - 100%	PR; PCR; Respiração agônica (Gasping). Insuflar reservatório com O2 antes da utilização.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. (NAEMT), National Association of Emergency Medical Technicians. AMLS: Advanced Medical Life Support: Atendimento Pré-Hospitalar às Emergências Clínicas. Porto Alegre: Artmed, 2022. Ebook.

9.2. Pádua AI; Alvares F & Martinez Jab. Insuficiência respiratória. Medicina, Ribeirão Preto, 36: 205-213 abr./dez. 2003. Disponível em <https://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/549/549> Acesso em 20/05/2020.

9.3. Velasco, IT, Brandão Neto, RA, Souza, HP *et al*. Emergências Clinicas: Abordagem Prática 14ª Ed, Manole, Barueri-SP, 2020.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Atualização e ampliação da definição de insuficiência respiratória. 2. Adequação do objetivo para abordagem pré-hospitalar. 3. Ampliação das áreas envolvidas, incluindo SBV, SBV-E e URAM. 4. Inclusão da avaliação de segurança de cena e padronização da avaliação primária e secundária. 5. Detalhamento e padronização da oxigenoterapia conforme saturação, com metas terapêuticas específicas. 6. Inclusão de critérios diferenciados para pacientes com risco de hipercapnia (ex.: DPOC). 7. Definição de condutas em casos graves e parada respiratória. 8. Reforço da comunicação obrigatória com a Regulação Médica para decisões terapêuticas e transporte.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Marisa A. Amaro Malvestio José Caruso Adriana Ap. dos Santos Elaine C. S. Melo Machado Flávia Guedes Araújo Ivone Fernandes Alves Marcia Rosa de S. Lopes Adriana Carla F. da Silva Amanda de Fatima Portugal	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Asma é uma doença pulmonar inflamatória crônica, caracterizada pela contração da musculatura lisa dos brônquios, resultando em estreitamento brônquico, tosse, dispneia, opressão torácica e sibilos associados. A exacerbação da asma é a piora progressiva dos sintomas, podendo evoluir para parada respiratória/parada cardiorrespiratória.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever os sinais, sintomas e a abordagem pré-hospitalar realizada pela equipe de SBV e SBV-E à vítima com exacerbação da asma.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e CRU.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Realize a avaliação da segurança de cena;

4.2. Realize avaliação primária e intervenha conforme achados:

4.2.1. Mantenha a vítima em decúbito elevado;

4.2.2. Reduza esforços e fatores estressores;

4.3. Realize avaliação secundária com ênfase em:

4.3.1. Monitore sinais vitais e saturação;

4.3.2. Se saturação < 94%, administre O_2 de10 a15l/min por máscara não reinalante;

4.4. Realize o SAMPLER, com ênfase para pesquisa dos sinais e sintomas, alergias, histórico de saúde e medicamentos em uso;

4.5. Considere vítima grave se: histórico de asma, presença de tosse, dispneia ou taquipneia com uso da musculatura acessória, cianose, sudorese e/ou alteração de nível de consciência;

4.6. Realize contato com a Regulação Médica para a passagem sistematizado das informações;

4.7. Siga as orientações da Regulação Médica para procedimentos, abordagem medicamentosa e/ou transporte para a unidade de saúde de destino;

4.8. **<u>Abordagem medicamentosa em SBV- sob autorização da Regulação Médica</u>**

4.8.1. Administre Salbutamol 600mcg (6 puffs) nas vítimas em crise e que já façam uso de broncodilatador, com uso do espaçador;

4.8.2. **Após 20min, se não houver melhora** repetir a dose de 600mcg (6 puffs) de Salbutamol;

<u>Abordagem medicamentosa em SBV-E (com enfermeiro)</u>

4.8.3. Administre Salbutamol 600mcg (6 puffs) nas vítimas em crise e que já façam uso de broncodilatador, com uso do espaçador;

4.8.4. **Após 20min, se não houver melhora:**

4.8.4.1. Repita a dose de 600mcg (6 puffs) de Salbutamol;

4.8.4.2. Administre Hidrocortisona 200mg EV, diluído em SF0,9% 20ml, em um minuto;

4.8.4.3. Realize inalação com 40 gotas de ipratrópio (atrovent) e 5ml de SF 0,9%.

<u>ATENTE-SE ao uso do espaçador:</u>

4.8.5. Agite o inalador, encaixe-o no espaçador e libere 1 jato do medicamento para preenche-lo;

4.8.6. Posicione a máscara de forma vedada no rosto (nariz e boca) do paciente;

4.8.7. Peça para o paciente inspirar profundamente pela boca ao aplicar o salbutamol, mantendo o espaçador por 10 segundos no rosto do paciente;

4.8.8. Entre um jato e outro aguarde 30 segundos de intervalo.

4.9. Realize o transporte para a unidade de saúde de destino indicada pela Regulação Médica, com a vítima em decúbito elevado;

4.10. Registre os achados e procedimentos realizados na Ficha de Atendimento.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. A equipe de Suporte Básico de Vida (SBV) somente poderá intervir com ação medicamentosa após autorização do médico regulador;

5.2. Os inaladores de salbutamol são destinados apenas ao uso individual do paciente. A segurança do uso do mesmo inalador de salbutamol por vários pacientes não foi estabelecida.

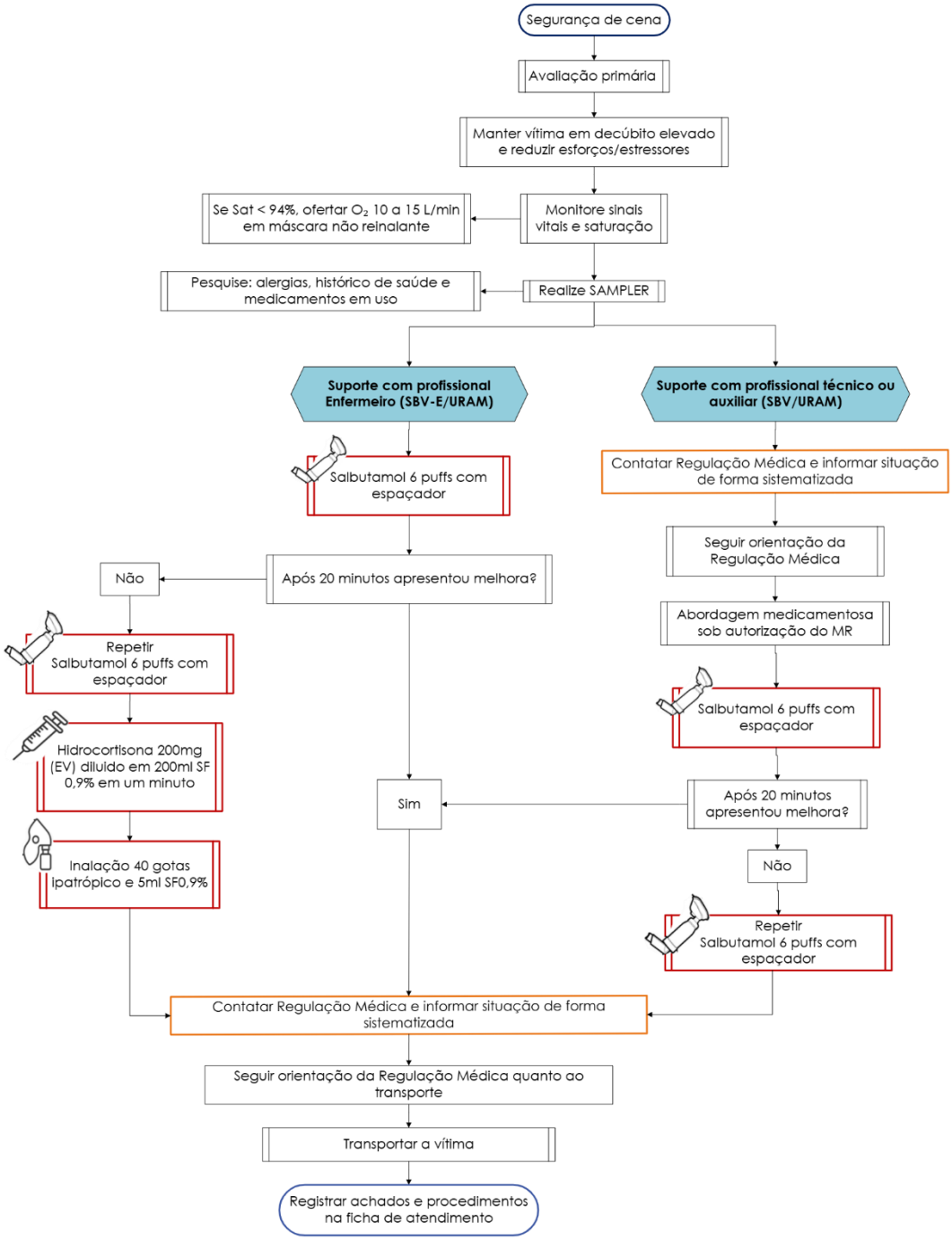
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA – exacerbação da asma no adulto



9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. Ministério da Saúde. Linhas de Cuidado: Manejo inicial/ conduta na exacerbação da asma. Disponível em:https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/asma/servico-de-atendimento-movel/manejo-inicial/ Acesso em 02/ 06/ 25.

9.2. Ludhmila, Abrahão Hajjar; Rodrigo Antonio Brandão Neto; Lucas Oliveira Marino; Julio Flávio Meirelles Marchini; Júlio César Garcia de Alencar; Karina Turaça, et al. Medicina de emergência: Abordagem Prática. 18. ed. Barueri: Manole, 2024.

9.3. GLAXOSMITHKLINE. Salbutamol Sulphate Inhaler: bula do usuário. Reino Unido: GlaxoSmithKline, 2025. Disponível em: https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.15454.pdf

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	<u>Atualização</u> 1. Atualização do nome do protocolo 2. Atualização e ampliação da definição clínica. 3. Atualização do objetivo com foco na abordagem pré-hospitalar. 4. Ampliação das áreas envolvidas (SBV, SBV-E e URAM). 5. Padronização da avaliação inicial (segurança de cena, avaliação primária e secundária). 6. Inclusão do uso do SAMPLER na avaliação. 7. Atualização dos critérios de gravidade. 8. Reorganização do fluxo de comunicação. 9. Atualização e diferenciação da abordagem medicamentosa entre SBV e SBV-E. 10. Alteração da dosagem e padronização do uso do salbutamol com espaçador. 11. Inclusão do uso de hidrocortisona EV e ipratrópio no SBV-E. 12. Padronização das orientações para transporte e registro em ficha de atendimento.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Aline Carvalho Daiane M. F Souza Flávia Guedes de Araújo Gabriel Martinez José Caruso Marisa A. Amaro Malvestio Silvio Alves Barbosa Wesley Almeida Santos Zulmira Bismarck	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) caracteriza-se pelo seu desenvolvimento progressivo de limitação ao fluxo de ar nos pulmões, associada a uma resposta inflamatória crônica (bronquite, enfisema). Os sintomas são parecidos com os da asma: sibilos, dispneia, tosse, opressão torácica.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever sinais, sintomas e a abordagem pré-hospitalar realizada pela equipe do SAMU à vítima com exacerbação da DPOC.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e Central de Regulação.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Realize a avaliação da segurança de cena;

4.2. Realize avaliação primária e intervenha conforme achados:

4.2.1. Mantenha a vítima em decúbito elevado;

4.2.2. Reduza esforços e fatores estressores;

4.3. Realize avaliação secundária com ênfase em:

4.3.1. Monitore sinais vitais e saturação;

4.3.2. Se saturação < 88%, administre O_2 até 6l/min por cateter nasal, para manter saturação alvo em torno de 92%;

4.4. Realize o SAMPLER, com ênfase para pesquisa de alergias, histórico de saúde e medicamentos em uso;

4.5. Considere vítima grave se: histórico de DPOC, presença de edema em membros inferiores, cianose, utilização de musculatura acessória, sudorese e/ou alteração do nível de consciência;

4.6. Realize contato com a Regulação Médica para a passagem sistematizada de informações;

4.7. Siga as orientações da Regulação Médica para procedimentos, abordagem medicamentosa e/ou transporte para a unidade de saúde de destino;

4.8. **Abordagem medicamentosa no SBV- sob autorização da Regulação Médica:**

4.8.1. Administre Salbutamol 600 mcg (06 puffs) nas vítimas em crise e que já façam uso de broncodilatador, com uso do espaçador;

4.8.2. **Após 20min, se não houver melhora** repetir a dose de 600mcg (6 puffs) de Salbutamol – não atrase o transporte.

4.9. **<u>Abordagem medicamentosa com a presença do enfermeiro:</u>**

4.9.1. Administre Salbutamol 600 mcg (06 puffs) nas vítimas em crise e que já façam uso de broncodilatador, com uso do espaçador;

4.9.2. Após 20min, se não houver melhora:

4.9.2.1. Repita a dose de 600mcg (6 puffs) de Salbutamol;

4.9.2.2. Administre Hidrocortisona 200mg EV, diluído em SF0,9% 20ml, em um minuto;

4.9.2.3. Realize inalação com 40 gotas de ipratrópio (atrovent) e 5ml de SF 0,9%.

4.10. **<u>ATENTE-SE ao uso do espaçador:</u>**

4.10.1. Agite o inalador, encaixe-o no espaçador e libere 1 jato do medicamento para preenche-lo;

4.10.2. Posicione a máscara de forma vedada no rosto (nariz e boca) do paciente;

4.10.3. Peça para o paciente inspirar profundamente pela boca ao aplicar o salbutamol, mantendo o espaçador por 10 segundos no rosto do paciente;

4.10.4. Entre um jato e outro aguarde 30 segundos de intervalo;

4.11. Realize o transporte para a unidade de saúde de destino indicada pela Regulação Médica, com a vítima em decúbito elevado;

4.12. Registre os achados e procedimentos realizados na Ficha de Atendimento;

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. A equipe de Suporte Básico de Vida (SBV) somente poderá intervir com ação medicamentosa após autorização do médico regulador;

5.2. Os inaladores de salbutamol são destinados apenas ao uso individual do paciente. A segurança do uso do mesmo inalador de salbutamol por vários pacientes não foi estabelecida;

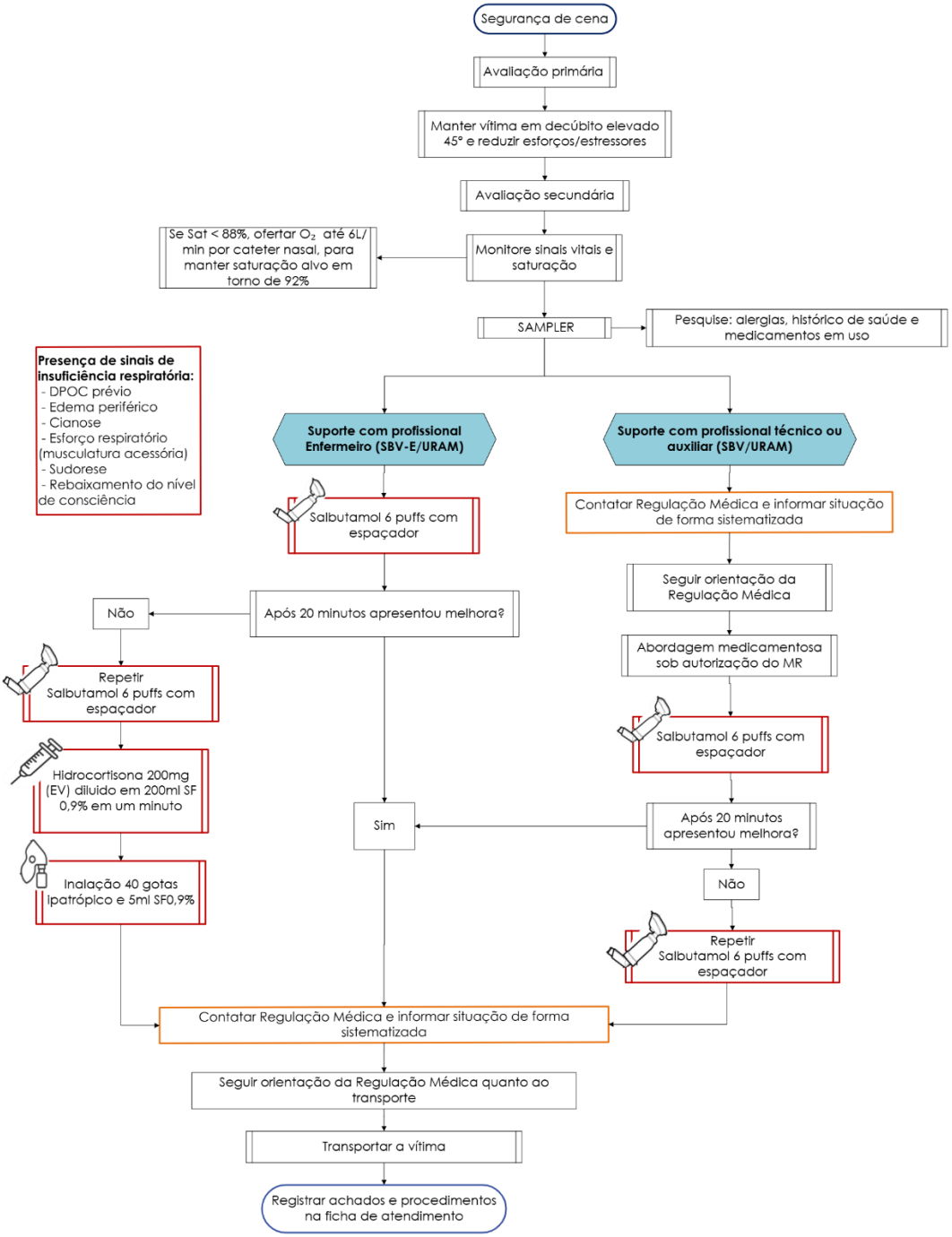
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA -Abordagem em SBV na Exacerbação da DPOC



9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. Ludhmila, Abrahão Hajjar; Rodrigo Antonio Brandão Neto; Lucas Oliveira Marino; Julio Flávio Meirelles Marchini; Júlio César Garcia de Alencar; Karina Turaça, et al. Medicina de emergência: Abordagem Prática. 18. ed. Barueri: Manole, 2024.

9.2. GOLD. Global Initiative for Chronic Obstrutive Lung Disease: Global Strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstrutive pulmonar disease, 2019. Disponível em: *https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2018/11/GOLD-2019-v1.7-FINAL-14Nov2018-WMS.pdf*.

9.3. GSK, Global Data Sheet for salbutamol (inhaled formulations), Version 029, June 28, 2023.

9.4. GSK, Global Data Sheet for salmeterol xinafoate, Version 30, September 24, 2020.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Unificação dos protocolos de SBV e SIV 2. Atualização da definição e do objetivo, com foco na abordagem pré-hospitalar 3. Padronização da avaliação de cena, primária e secundária 4. Definição de critérios de gravidade 5. Ajuste da oxigenoterapia (SpO_2 alvo ≈ 92%) 6. Padronização da abordagem medicamentosa, com doses atualizadas de salbutamol 7. Ampliação da conduta com enfermeiro 8. Reforço do contato com a Regulação Médica e do transporte em decúbito elevado

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Aline Carvalho Carlos Odercio Zanquetta Gabriel Martinez José Caruso Luiz Cassio Carneiro Leão Marisa A. Amaro Malvestio Silvio Alves Barbosa Wesley Almeida Santos Zulmira Bismarck	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Dor ou desconforto torácico de apresentação e sintomatologia variáveis que incluem: dor retroesternal, precordial, epigástrica e/ou abdominal, com irradiação para dorso, pescoço, ombro, mandíbula e/ou membros superiores, (principalmente o esquerdo), que pode ser acompanhada de náuseas, vômito, sudorese fria, dispneia, ansiedade e/ou sensação de morte.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever sinais, sintomas e a abordagem pré-hospitalar realizada pela equipe do SAMU192 São Paulo à vítima com dor torácica.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e CRU.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Realize a avaliação da segurança de cena;

4.2. Realize avaliação primária e intervenha conforme achados:

4.2.1. Mantenha a vítima em repouso, com decúbito elevado à 45º;

4.2.2. Reduza esforços e fatores estressores;

4.2.3. Avalie pele, pulso e perfusão. Verifique a presença de sinais de choque (palidez cutânea e sudorese, perfusão > 2 segundos, pulso rápido e filiforme).

4.3. Realize avaliação secundária com ênfase em:

4.3.1. Monitore sinais vitais e saturação;

4.3.2. Se monitor disponível, realize monitorização cardíaca;

4.3.3. Se saturação < 90%, administre O_2 até 6 l/min por cateter nasal;

4.3.4. Realize o SAMPLER, com ênfase para a pesquisa de alergia à medicamentos, presença de outros sinais e sintomas, história de sangramento gástrico ativo e características da dor:

4.3.5. Localização da dor: no centro do peito (precordial) ou epigástrica, dentre outras, com ou sem irradiação para regiões próximas;

4.3.6. Tipo de dor: em pontada ou constrição, em aperto, em queimação ou sem dor (surda);

4.3.7. Intensidade da dor: aplique a escala de dor;

4.3.8. Tempo de início e duração da dor;

4.3.9. Fatores desencadeantes da dor: esforço, repouso, estresse;

4.3.10. Ocorrências anteriores de dor: primeiro episódio, episódios anteriores;

4.3.11. Outros sinais e sintomas: sudorese fria, tontura, dispneia, náuseas, fraqueza, sangramento ativo, ansiedade e/ou sensação iminente de morte;

4.4. Considere vítima grave se: histórico de angina/IAM e/ou dor torácica que irradia para região dorsal, pescoço, ombro, mandíbula e/ou membros superiores, associados ou não, a dispneia, palidez, cianose de extremidades e/ou sudorese fria.

4.5. Realize contato com a Regulação Médica para a passagem sistematizada de informações;

4.5.1. Siga as orientações da Regulação Médica para procedimentos e/ou abordagem medicamentosa e/ou a transporte para a unidade de saúde de destino;

Abordagem medicamentosa:

4.6. **Em SBV-E/URAM (com enfermeiro):**

4.6.1. Administre 300mg de AAS infantil via oral, sob mastigação.

4.7. **SBV - sob autorização da Regulação Médica:**

4.7.1. Administre 300mg de AAS infantil via oral, sob mastigação.

4.8. São contraindicações para administração de AAS:

4.8.1. Alergia conhecida

4.8.2. Sangramento gástrico ativo ou suspeito.

4.9. Realize o transporte para a unidade de saúde de destino indicada pela regulação médica, sob as seguintes condições:

4.9.1. Minimize os estímulos de stress para vítima;

4.10. Registre os achados e procedimentos na Ficha de Atendimento.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. A equipe de Suporte Básico de Vida (SBV) somente poderá intervir com ação medicamentosa após autorização do médico regulador.

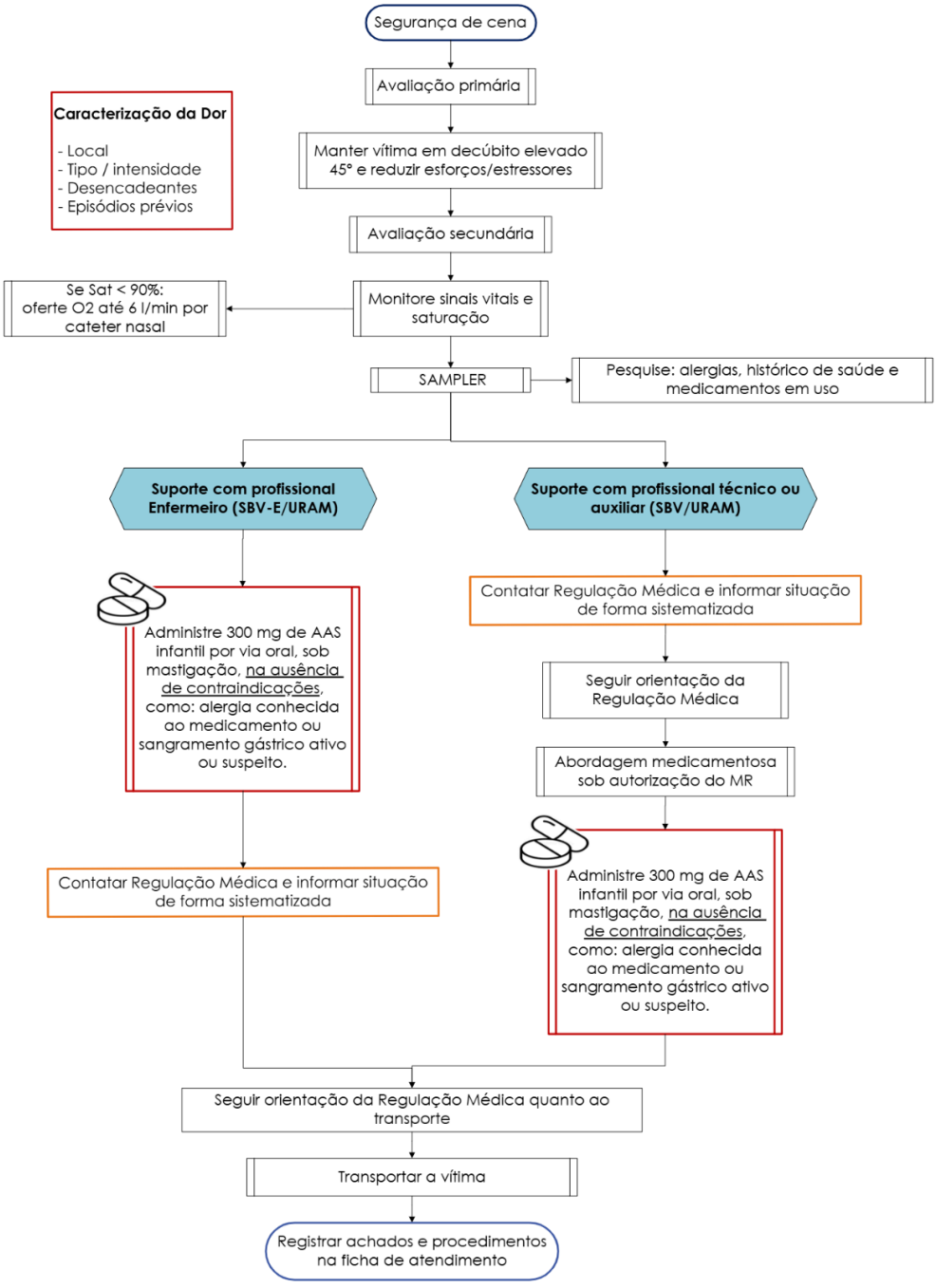
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA -Dor torácica de origem cardíaca



9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. (NAEMT), National Association of Emergency Medical Technicians. AMLS: Advanced Medical Life Support: Atendimento Pré-Hospitalar às Emergências Clínicas. Porto Alegre: Artmed, 2022. Ebook.

9.2. ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI Guideline for the Management of Patients With Acute Coronary Syndromes: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines;

9.3. Velasco, IT, Brandão Neto, RA, Souza, H. Petal. Emergências Clínicas: Abordagem Prática. 14ª edição. Manole, Barueri-SP, 2020.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Unificação dos protocolos de SBV e SIV 2. Atualização do título e padronização da nomenclatura do protocolo 3. Ampliação do escopo para abordagem pré-hospitalar 4. Inclusão da avaliação de segurança de cena como etapa inicial 5. Detalhamento da avaliação primária e secundária, com ênfase em sinais de gravidade 6. Inclusão do método SAMPLER e caracterização sistematizada da dor 7. Definição clara de critérios de gravidade 8. Padronização da abordagem medicamentosa com AAS, incluindo contraindicações 9. Separação das condutas por nível de suporte 10. Reforço da necessidade de contato com a Regulação Médica para condutas e destino 11. Atualização das orientações de transporte 12. Inclusão da obrigatoriedade de registro em ficha de atendimento

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Adriana Carla F. da Silva Aline Carvalho Amanda de Fátima P. Rocha Ana Midori Harada Gabriel Martinez Francis Albert Fuji Jose Caruso Silvio Alves Barbosa Wesley Almeida Santos Zulmira Bismarck	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. Cetoacidose: é uma condição metabólica grave, caracterizada pelo acúmulo de corpos cetônicos no sangue devido a oxidação aumentada de ácidos graxos devido à deficiência absoluta ou relativa de insulina. Essa deficiência leva o organismo a utilizar gorduras como principal fonte de energia, produzindo cetonas que causam acidose metabólica. Clinicamente, manifesta-se com náuseas, vômitos, dor abdominal difusa, desidratação, fadiga, taquicardia, respiração rápida (Kussmaul), hálito cetônico e alteração do nível de consciência;

1.2. Cetoacidose diabética: definida pela presença de hiperglicemia (glicemia acima de 200mg/dl), acidose metabólica e cetose. Os diagnósticos diferenciais incluem: cetoacidose alcoólica, cetose de jejum e acidose com anion gap elevado (acúmulo de ácidos orgânicos no plasma, como na toxicidade da aspirina);

1.3. Respiração de Kussmaul: é um tipo de respiração rápida, profunda e laboriosa, caracterizada por inspirações e expirações amplas e contínuas, sem pausas;

1.4. As causas mais comuns da acidose são: diabetes associado a infecções (pulmonares, urinárias, COVID-19) e descontinuação da terapia com insulina.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever o reconhecimento clínico e o manejo inicial da vítima com suspeita de cetoacidose no atendimento pré-hospitalar.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e Central de Regulação.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Realize avaliação da segurança de cena;

4.2. Realize avaliação primária e intervenha conforme achados;

4.2.1. Avalie a qualidade da respiração;

4.2.2. Aplique a Escala de Coma de Glasgow e avalie as pupilas;

4.3. Monitore sinais vitais e saturação;

4.4. Administre oxigênio por máscara, se saturação < 94%;

4.5. Avalie glicemia capilar;

4.5.1. Atente-se aos sinais: glicose > 200 mg/dL associada a respiração Kussmaul, hálito cetônico e desidratação indica suspeita de cetoacidose.

4.6. Realize SAMPLER com ênfase no histórico de DM e antecedentes familiares;

4.7. **<u>Abordagem medicamentosa na presença do enfermeiro (SBV-E/ URAM)</u>**

4.7.1. Puncione acesso venoso periférico;

4.7.2. Instale SF 0,9% 500 ml/hora, se glicemia capilar > 200 mg/dl associada a respiração Kussmaul, hálito cetônico, sinais de desidratação ou alteração do nível de consciência;

4.7.3. Se paciente apresentar náuseas intensas, administre medicamento antiemético conforme protocolo específico. (POP IAPH- SBV e SBV-E 45 – Avaliação e Manejo da Dor e vômitos);

4.8. Realize contato com a Regulação Médica para passagem sistematizada das informações;

4.9. Siga as orientações da Regulação Médica para procedimentos, abordagem medicamentosa e/ou transporte para a unidade de saúde de destino indicada.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Manter paciente em decúbito dorsal elevado;

5.2. A reposição volêmica tem como objetivo repor o déficit de água (que é estimado em 100 mL/Kg de peso), manter a pressão arterial, melhorar a perfusão tissular e renal e reduzir a glicemia

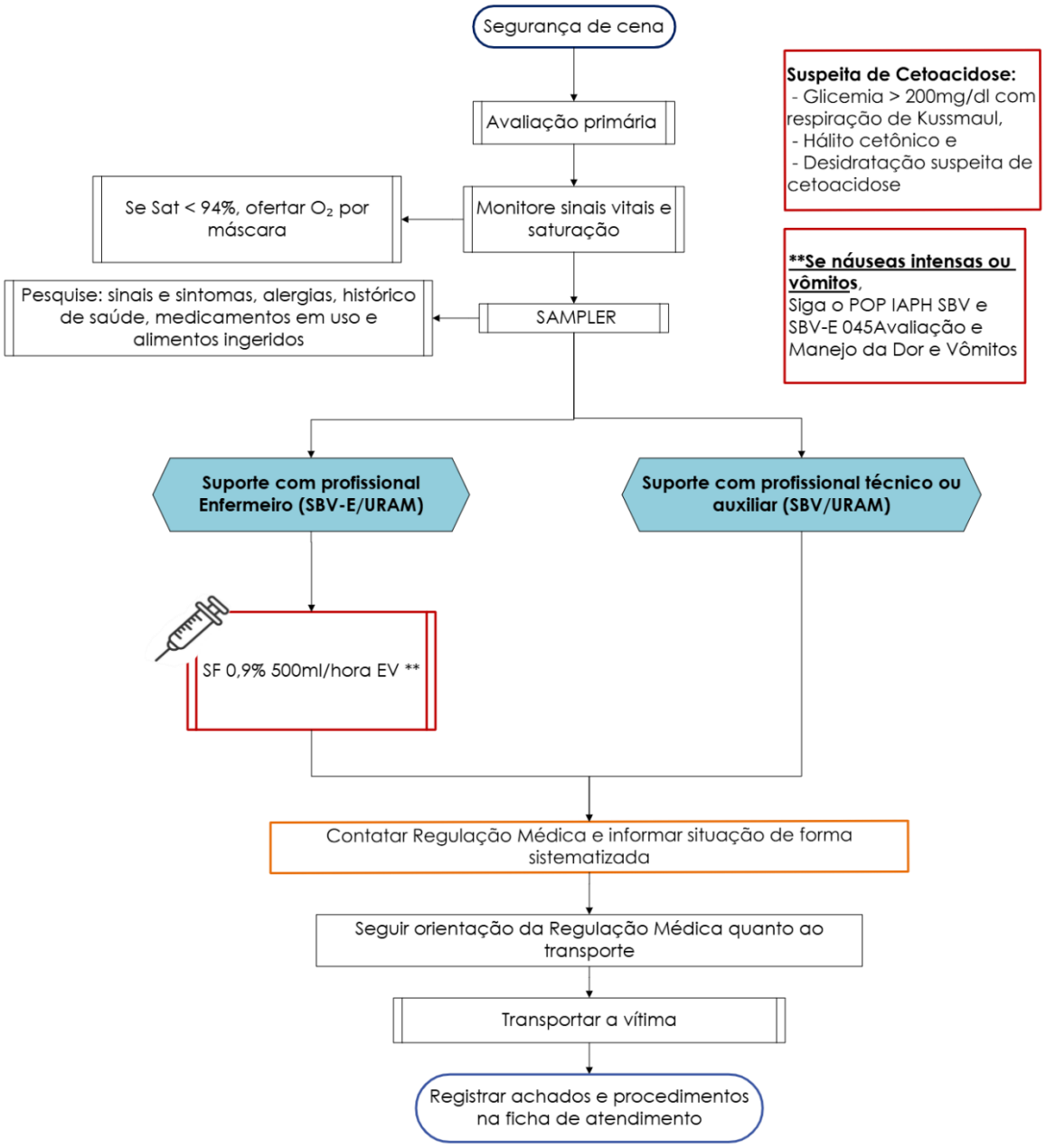
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP IAPH SBV E SBV-E 045 – Avaliação e Manejo da Dor e Vômitos

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA - Cetoacidose



9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. SANTOMAUR, Ana Teresa; SANTOMAUR, Augusto Cezar Jr; PESSANHA, Aline Bodart; RADUAN, Roberto Abrão; MARINO, Emerson Cestari; LAMOUNIER, Rodrigo Nunes. Diagnóstico e tratamento da cetoacidose diabética**.** O paciente com diabetes no hospital. Sociedade Brasileira de Diabetes, 2025. Publicado em 22 mar. 2023. Última modificação em 31 out. 2025.

9.2. AMLS: Atendimento Pré-Hospitalar às Emergências Clínicas/ Tradução Maria Esmene G. Comenale *et al.* 1ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2017. 545 páginas.

9.3. Sociedade Brasileira de Diabetes. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Editora Cientifica. Clannad. 2019-2020

9.4. Velasco, IT, Brandão Neto, RA, Souza, HP et al. Emergências Clinicas: Abordagem Prática 14ª Ed, Manole, Barueri-SP, 2020.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Mudança do título e foco clínico, passando de hiperglicemia aguda para cetoacidose. 2. Definições ampliadas, com descrição da cetoacidose e seus principais sinais. 3. Atualização dos critérios clínicos. 4. Adequação do objetivo, voltada ao reconhecimento e manejo pré-hospitalar. 5. Padronização da abordagem inicial, com inclusão da segurança de cena e avaliação neurológica. 6. Reorganização das condutas, priorizando avaliação respiratória e monitorização. 7. Ajuste da reposição volêmica, com critérios mais claros para hidratação. 8. Inclusão do manejo de náuseas e vômitos, conforme protocolo institucional. 9. Reforço da comunicação com a Regulação Médica.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Marisa A. Amaro Malvestio Gabriel Martinez Silvio Alves Barbosa Aline Carvalho Zulmira Bismarck Ivone Fernandes Alves Luís Cassio Carneiro Leão	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Hipoglicemia: redução anormal da glicose no sangue, definida como glicemia capilar menor que 70 mg/dl. Quando os níveis de glicose caem abaixo do necessário para suprir as necessidades metabólicas do organismo, especialmente do cérebro, surgem sinais e sintomas como: alteração do nível de consciência, sudorese, visão turva, palidez cutânea e tremores, podendo evoluir para convulsão.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever sinais, sintomas e a abordagem pré-hospitalar realizada pela equipe de SBV e SBV-E à vítima com hipoglicemia.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e CRU.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Realize a avaliação da segurança de cena;

4.2. Realize avaliação primária e intervenha conforme achados;

4.2.1. Se vítima inconsciente, posicione-a em local adequado e garanta a permeabilidade das vias aéreas;

4.3. Realize avaliação secundária com ênfase em:

4.3.1. Monitore sinais vitais e saturação;

4.3.2. Se saturação < 94%, administre O_2 por cateter ou máscara não reinalante, conforme a necessidade;

4.3.3. Verifique glicemia capilar;

4.3.4. Realize o SAMPLER com ênfase para os sinais e sintomas, alergias, medicamentos em uso, passado médico, líquidos e alimentos ingeridos;

4.4. Realize contato com a Regulação Médica para a passagem sistematizada de informações;

4.5. Siga as orientações da Regulação Médica para procedimentos, abordagem medicamentosa e/ou transporte para a unidade de saúde de destino;

Abordagem medicamentosa na presença do enfermeiro (SBV-E/URAM)

SBV sob autorização da Regulação Médica:

4.6. Se glicemia capilar <70mg/dl e sintomas associados de hipoglicemia;

4.7. Puncione acesso venoso com cateter 20 ou 22 (máximo 3 tentativas);

4.8. Questione ao acompanhante se a vítima possui histórico de uso crônico de álcool. Se a resposta for sim, administre 300 mg de tiamina EV (3 ampolas) pura, seguida de um flush com SF 0,9% antes da administração de glicose;

4.9. Administre 5 ampolas de glicose 50% EV diluídas em 100 ml de SF 0,9%;

4.10. Mantenha acesso venoso com SF 0,9% 250 ml pmv;Em caso de falha de acesso venoso, comunique o MR para tomada de decisão, ou na presença de enfermeiro, puncione acesso intraósseo;

4.11. Reavalie nível de consciência e glicemia capilar;

4.12. Realize o transporte para a unidade de saúde de destino indicada pela Regulação Médica;

4.13. Registre os achados e procedimentos realizados na Ficha de Atendimento.

ATENÇÃO:

- **A punção intraóssea é procedimento privativo do enfermeiro.**
- A equipe de enfermagem não tem respaldo legal para dispensa da vítima na cena, mesmo que haja melhora.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. A equipe de Suporte Básico de Vida (SBV) somente poderá intervir com ação medicamentosa após autorização do médico regulador.

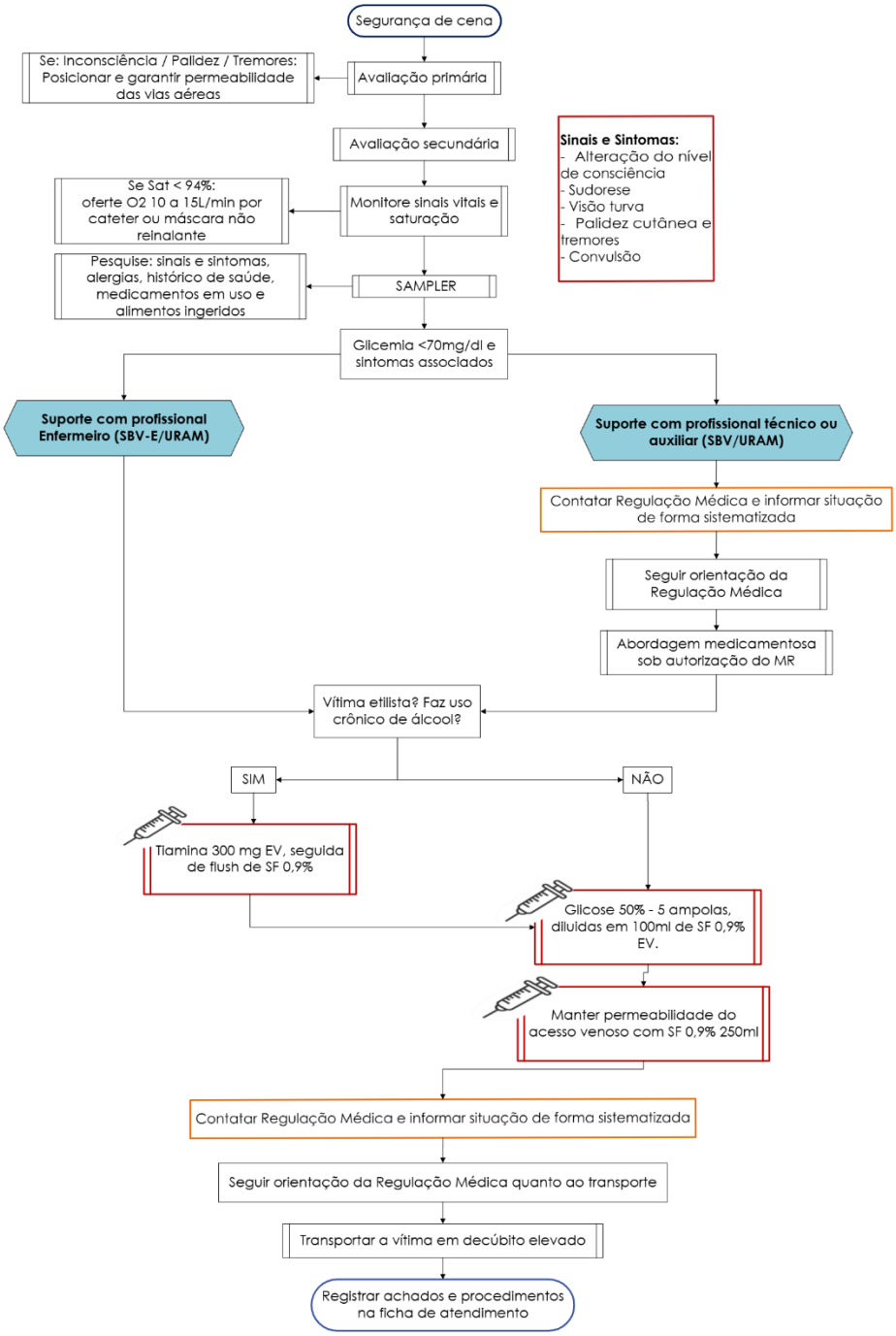
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA - Hipoglicemia no adulto



9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. Ludhmila, Abrahão Hajjar; Rodrigo Antonio Brandão Neto; Lucas Oliveira Marino; Julio Flávio Meirelles Marchini; Júlio César Garcia de Alencar; Karina Turaça, et al. Medicina de emergência: Abordagem Prática. 18. ed. Barueri: Manole, 2024.

9.2. Sociedade Brasileira de Diabetes. Diretriz Sociedade Brasileira de Diabetes. Editora Cientifica. Clannad. 2019-2020.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Alteração do título do protocolo, com padronização da nomenclatura para Hipoglicemia no Adulto. 2. Atualização e ampliação da definição de hipoglicemia. 3. Adequação do objetivo para a abordagem pré-hospitalar pelas equipes SBV, SBV-E e URAM. 4. Ampliação das áreas/equipes envolvidas. 5. Padronização da avaliação inicial. 6. Inclusão de avaliação clínica estruturada (SAMPLER) e monitorização contínua. 7. Reforço da comunicação obrigatória com a Regulação Médica antes das condutas, para o SBV. 8. Atualização da abordagem medicamentosa, com critérios claros para acesso venoso, uso de tiamina, glicose EV e alternativa de acesso intraósseo. 9. Definição de limites de atuação por categoria profissional, reforçando responsabilidades legais.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Marisa A. Amaro Malvestio Gabriel Martinez Silvio Alves Barbosa Aline Carvalho Zulmira Bismarck Wesley Almeida Santos José Caruso	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. A convulsão é definida como uma atividade elétrica excessiva e desorganizada em determinadas áreas no cérebro, que se manifesta frequentemente em decorrência de lesões ou doenças neurológicas e quando prolongada, costuma causar danos ao sistema nervoso central. Os sinais e sintomas incluem: perda da consciência, contrações musculares involuntárias (generalizadas ou focais), salivação excessiva, olhar fixo e liberação de esfíncter.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever os sinais, sintomas e a abordagem pré-hospitalar realizada pelas equipes do SAMU192 São Paulo à vítima em crise convulsiva.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e Central de Regulação.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Realize a avaliação da segurança de cena;

4.2. Realize avaliação primária e intervenha conforme achados;

Durante a crise:

4.3. Garanta a segurança da vítima - remova objetos perigosos que possam machucá-la durante as contrações musculares;

4.4. Proteja a cabeça da vítima - providencie acolchoamento;

4.5. Garanta a permeabilidade das vias aéreas;

4.6. Instale máscara não reinalante à 15l/min;

4.7. Não impeça os movimentos involuntários da vítima;

Após a crise:

4.8. Mantenha a permeabilidade das vias aéreas;

4.9. Avalie o nível de consciência;

4.10. Realize avaliação secundária com ênfase em:

4.10.1. Monitore sinais vitais e saturação;

4.10.2. Mantenha a máscara não reinalante;

4.10.3. Se glicemia < 70 mg/dl, realize a abordagem conforme protocolo: IAPH SBV E SBV-E 038 – Hipoglicemia no adulto;

4.11. Realize o SAMPLER (alergias, histórico de DM, epilepsia, tumor cerebral, uso de medicamentos ou outras substâncias, líquidos e/ou alimentos ingeridos);

Durante ou Após a crise:

4.12. Considere vítima grave se: convulsão com duração maior que 5 minutos ou mais de 2 convulsões sem recuperação da consciência;

4.13. Realize contato com a Regulação Médica para a passagem sistematizada das informações;

4.14. Siga as orientações da Regulação Médica para procedimentos, abordagem medicamentosa e/ou transporte para unidade de saúde de destino;

Abordagem medicamentosa somente na presença do Enfermeiro:

4.15. Na presença de crise convulsiva, crises reentrantes sem recuperação ou estado de mal epilético (convulsão com duração maior que 5 minutos):

4.15.1. Entre em contato com o MR e solicite autorização para abordagem medicamentosa;

4.15.2. Caso autorizado, administre Diazepam 10mg EV (puro e lento);

4.16. Se não houver melhora, ou ocorra nova convulsão, repetir a dose: Diazepan 10mg EV (puro e lento);

ou

4.17. **Na impossibilidade de acesso venoso**, durante a crise convulsiva, administre Midazolan 15mg IM (dose única) em músculo vasto lateral da coxa (após autorização do MR);

4.18. Após o encerramento da crise convulsiva, assim que possível, puncione e mantenha um acesso venoso;

4.19. Não repita a dose do Midazolan.

Atenção!

- Não administre Diazepam nos pacientes com história de infecção do sistema nervoso e em gestantes;
- Mantenha a vigilância constante do nível de consciência e da permeabilidade das vias aéreas.

4.20. Realize o transporte para a unidade de saúde de destino indicada pela Regulação Médica, com a vítima em decúbito lateral (exceto nos casos de trauma);

4.21. Nas vítimas com mecanismo de trauma associado, imobilize a coluna cervical manualmente, realize rolamento na prancha e instale colar cervical e head block assim que possível;

4.22. Registre os achados e procedimentos realizados na Ficha de Atendimento.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não administre diazepan na gestante.

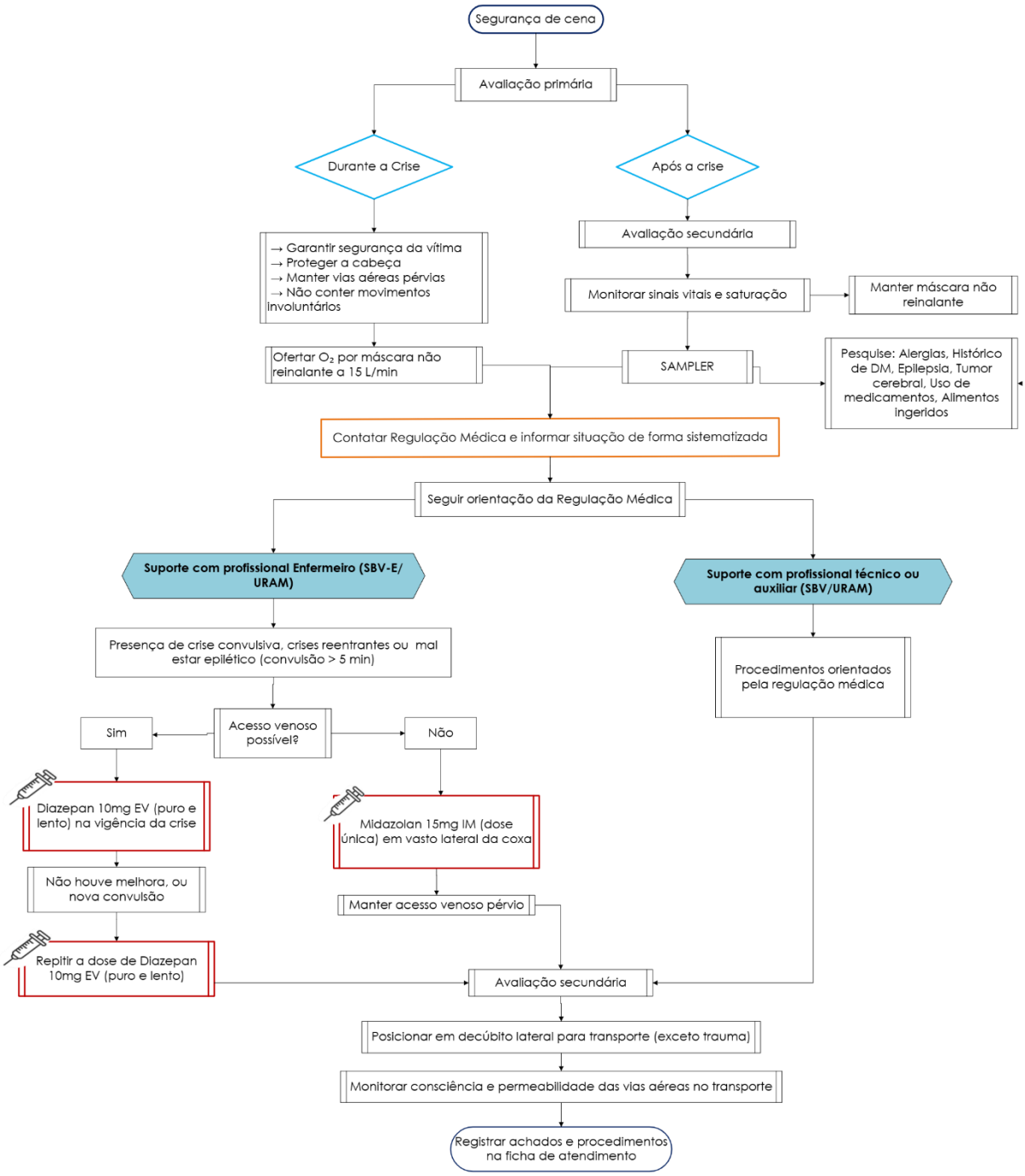
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Intervenção de Atendimento Pré-Hospitalar em SBV e SBV-E 038-Hipoglicemia no Adulto.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA - crise convulsiva no adulto



9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. Ludhmila, Abrahão Hajjar; Rodrigo Antonio Brandão Neto; Lucas Oliveira Marino; Julio Flávio Meirelles Marchini; Júlio César Garcia de Alencar; Karina Turaça, et al. Medicina de emergência: Abordagem Prática. 18. ed. Barueri: Manole, 2024.

9.2. Maia, Ian Ward A; Benincá, Vitor Machado; Schubert, Daniel Ujakow Correa; Cunha, Victor Paro; Lunardi, Maria Camila; Guimarães, Hélio Penna. Tratado de medicina de emergência Abramede. 1 ed. Barueri: Manole, 2024.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Unificação dos protocolos de SBV e SIV 2. Padronização da avaliação de cena, primária e secundária 3. Diferenciação das condutas durante e após a crise 4. Reforço da segurança da vítima e da proteção de vias aéreas 5. Definição de critérios de gravidade 6. Padronização da oxigenoterapia e avaliação de glicemia 7. Atualização da abordagem medicamentosa, restrita à presença do enfermeiro 8. Inclusão de midazolam IM na impossibilidade de acesso venoso

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Aline Carvalho Carlos Odercio Zanquetta Gabriel Martinez José Caruso Silvio Alves Barbosa Wesley Almeida Santos Zulmira Bismarck	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nádia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma condição grave causada pela interrupção do fluxo sanguíneo para uma área do cérebro, o que leva à falta de oxigênio e nutrientes e pode resultar em morte celular em pouco tempo. Existem duas formas principais de AVC:

1.1.1. AVC isquêmico – ocorre quando um vaso sanguíneo que leva sangue ao cérebro é obstruído por um coágulo. É o tipo mais comum de AVC e ocorre em cerca de 80% dos casos;

1.1.2. AVC hemorrágico – ocorre quando um vaso sanguíneo no cérebro se rompe, causando sangramento intracerebral e aumento da pressão intracraniana.

1.1.3. Ataque Isquêmico Transitório (AIT) – caracterizado pela interrupção do fluxo sanguíneo cerebral de forma temporária, e apesar de não causar dano permanente o AIT é um forte sinal de alerta, indicando alto risco de um AVC verdadeiro nas próximas horas ou dias.

1.2. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o AVC é considerado uma emergência neurológica passível de tratamento quando o atendimento ocorre nas primeiras 4 horas e meia, a contar do momento em que a vítima foi vista em condições normais.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever os sinais, sintomas e a abordagem pré-hospitalar realizada pela equipe à vítima com suspeita de AVC.

3. EQUIPES ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM, Central de Regulação.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Realize a avaliação da segurança da cena;

4.2. Realize avaliação primária e intervenha conforme achados:

- 4.2.1. Avalie a permeabilidade das vias aéreas;
- 4.2.2. Avalie a qualidade da respiração;
- 4.2.3. Mantenha a vítima em decúbito 30º;
- 4.2.4. Aplique a Escala BE FAST (anexo 1);
- 4.2.5. Pergunte para o acompanhante qual foi o último horário que a vítima foi vista assintomática;

4.3. Realize avaliação secundária com ênfase em:

- 4.3.1. Monitorize sinais vitais e saturação;
- 4.3.2. Se saturação < 94%, administre O_2 por cateter nasal ou máscara;
- 4.3.3. Verifique a glicemia capilar: se glicemia < 70 mg/dl, realize a correção conforme POP IAPH SBV E SBV-E 038 – Hipoglicemia;
- 4.3.4. Verifique a pressão arterial: está contraindicada a redução abrupta da pressão arterial;

4.3.5. Realize o SAMPLER, com ênfase para a pesquisa de sinais e sintomas, alergias, medicamentos em uso, histórico de hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, dislipidemia, ataque isquêmico transitório anterior, infarto do miocárdio ou cirurgia cardíaca e última vez que o paciente foi visto normal;

4.4. Considere vítima grave se: Escala BE FAST positiva, queixa de cefaleia intensa e súbita com alteração do nível de consciência, convulsões.

4.5. Realize contato com a Regulação Médica para a passagem sistematizada das informações;

4.6. Realize a pré-notificação em aplicativo específico (JOIN);

4.7. Siga as orientações da Regulação Médica para procedimentos, abordagem medicamentosa e/ou transporte para a unidade de saúde de referência;

4.8. Realize o transporte para a unidade de saúde de destino indicada pela Regulação Médica;

4.9. Registre os achados e procedimentos realizados na Ficha de Atendimento.

ATENÇÃO!

Não atrase o transporte. Tempo é cérebro!

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não atrase o transporte em detrimento de tentativas de acesso venoso e/ou outros procedimentos desnecessários;

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP IAPH SBV e SBV-E 038 – Procedimento Clínico – Hipoglicemia.

7. ANEXOS

7.1. **Anexo 1** - Escala BE FAST

- ***B****alance*: perda súbita de equilíbrio ou coordenação
- ***E****yes*: alterações visuais súbitas
- ***F****ace*: queda de um lado da face (assimetria facial)
- ***A****rms (and legs)*: fraqueza e/ou perda de sensibilidade em um dos lados dos membros superiores/inferiores
- ***S****peech*: alterações súbitas de fala (ex.: disartria, afasia)
- ***T****ime*: último horário em que a vítima foi vista sem sintomas

Ilustração: https://www.neuroskills.com/stroke/

A escala BE FAST consiste em um instrumento de triagem rápida, utilizada para identificar precocemente sinais e sintomas de AVC:

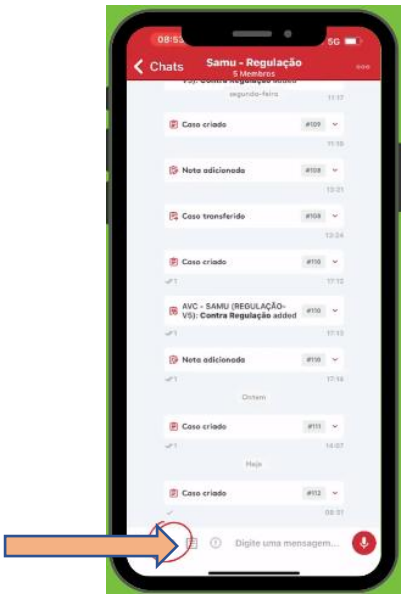
B – *BALANCE* (equilíbrio): pergunte a vítima ou ao acompanhante se houve perda súbita de equilíbrio, tontura intensa ou dificuldade para caminhar;
E – *EYES* (olhos): pergunte a vítima ou ao acompanhante se houve alteração visual súbita, como visão turva, visão dupla ou perda da visão em um ou ambos os olhos;
F – *FACE* (face): peça à vítima para sorrir e mostrar os dentes, e avalie se existe assimetria ou dormência em um lado do rosto. Considere normal quando ambos os lados da face se movem igualmente, e anormal, quando um dos lados move menos ou não se move, provocando uma assimetria da face;
A – *ARMS* (braços): peça à vítima para levantar ambos os braços e avalie se um dos braços está fraco ou dormente. Considere normal quando os dois braços se movem igualmente e se mantem erguidos por 10 segundos, e anormal quando um dos braços não se move ou cai, em comparação ao outro;
S – *SPEECH* (fala): peça à vítima para repetir uma frase simples e avalie se ela consegue repetir a frase corretamente ou se é incapaz de falar ou apresenta dificuldade em compreender. Considere normal quando a vítima fala corretamente todas as palavras e as pronuncia sem dificuldade, e anormal quando a vítima não consegue articular as palavras, ou é incapaz de falar;

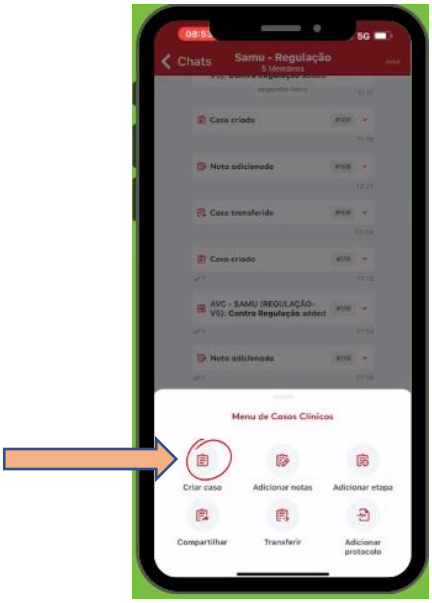
T – *TIME* (tempo): pergunte ao acompanhante o horário em que a vítima foi vista normal (assintomática) pela última vez. Lembre-se de que essa informação é primordial no atendimento do paciente com suspeita de AVC.

7.2. **Anexo 2** - Passo a passo – Pré-notificação no aplicativo JOIN

7.2.1. Acesse o aplicativo e clique na prancheta no canto inferior esquerdo do chat;

7.2.2. Clique em "criar caso"





7.2.3. Adicione o "protocolo AVC SAMU"

7.2.4. Identifique o paciente com os campos correspondentes:

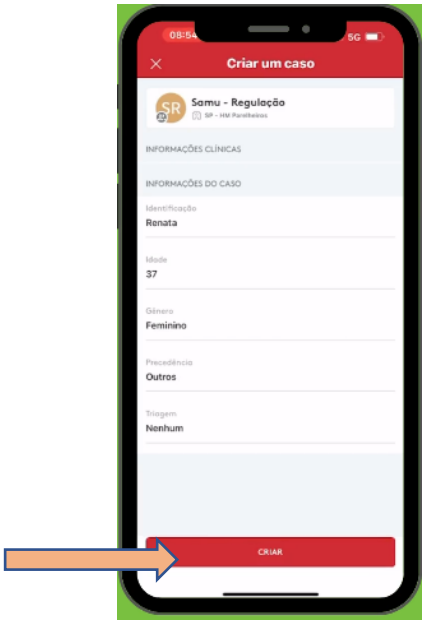
7.2.4.1. Identificação

7.2.4.2. Idade

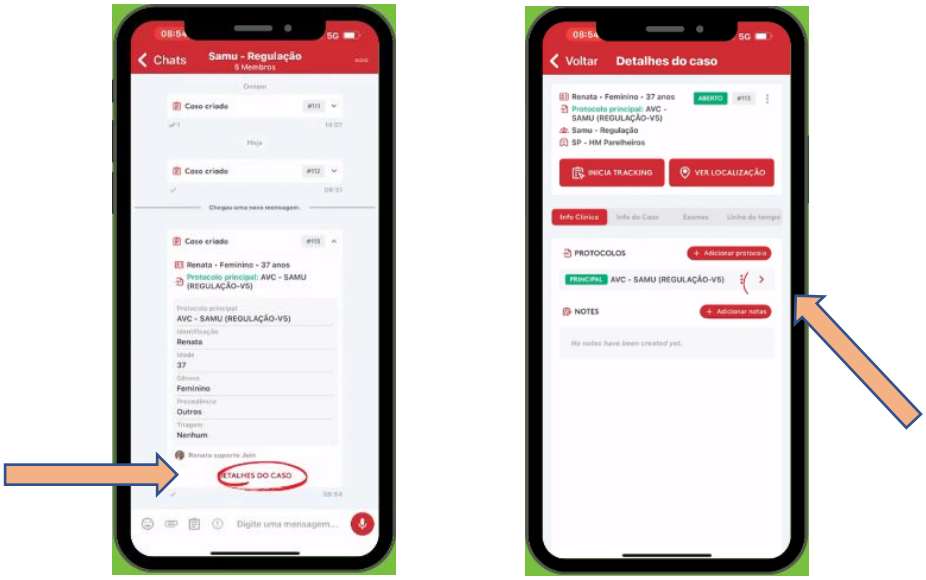
7.2.4.3. Gênero

7.2.4.4. Procedência - "APH"

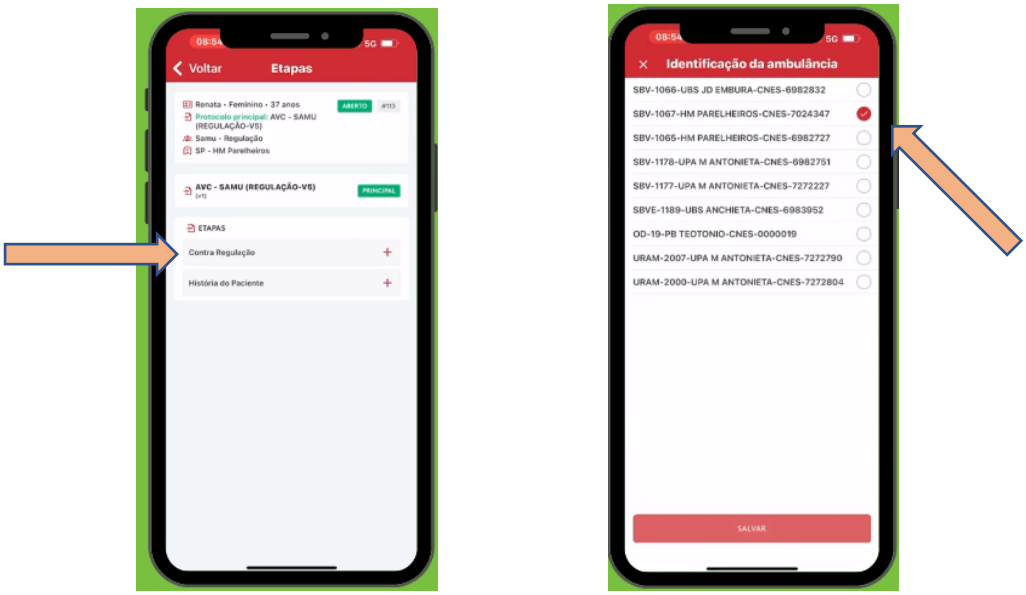
7.2.5. Clique para adicionar caso;



7.2.6. Na abertura do caso, clique em "detalhes do caso" e após clique na "setinha" para preencher mais detalhes do protocolo:

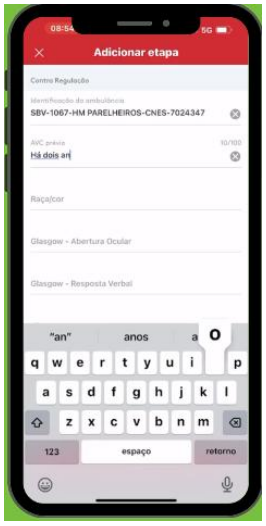


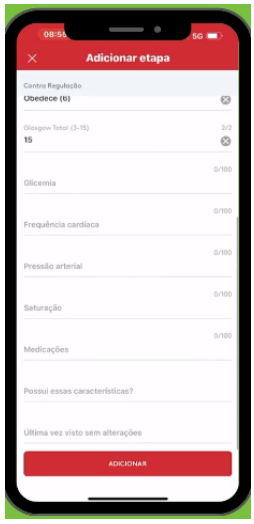
7.2.7. Clique em "contra regulação" e após faça a identificação da ambulância



7.2.8. Preencha todas as informações do protocolo, incluindo a escala de Glasgow e a pontuação final;

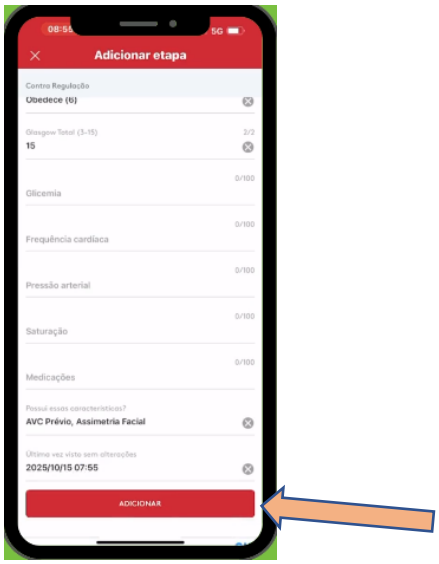
7.2.9. Finalize o preenchimento com os dados vitais do paciente;





7.2.10. Acrescente caso haja alguma medicação e a última vez que foi visto sem alterações;

7.2.11. Clique em "adicionar" para finalizar o caso;



8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS (NAEMT). *AMLS: Advanced Medical Life Support: atendimento pré-hospitalar às emergências clínicas.* Porto Alegre: Artmed, 2022. E-book.

9.2. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). *Manual de rotinas para atenção ao AVC.* 2013. Disponível em: *https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_rotinas_para_atencao_avc.pdf*. Acesso em: 02 jun. 2025.

9.3. VELASCO, I. T.; BRANDÃO NETO, R. A.; SOUZA, H. P. et al. *Emergências clínicas: abordagem prática.* 14. ed. Barueri, SP: Manole, 2020.

9.4. BRASIL. Ministério da Saúde. *Linhas de cuidado: AVC agudo (isquêmico ou hemorrágico)/ AIT.* Disponível em: *https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/acidente-vascular-cerebral-(AVC)-no-adulto/servico-atendimento-movel/avc-agudo/*. Acesso em: 02 jun. 2025.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Alteração do título: substituição de Acidente Vascular Encefálico (AVE) para Acidente Vascular Cerebral (AVC). 2. Ampliação e detalhamento das definições: inclusão da classificação do AVC (isquêmico, hemorrágico e AIT). 3. Atualização do objetivo: adequação para abordagem pré-hospitalar da suspeita de AVC. 4. Ampliação das equipes envolvidas: inclusão de SBV, SBV-E e URAM. 5. Padronização da abordagem inicial: inclusão da avaliação da segurança da cena. 6. Atualização da ferramenta de triagem: substituição da Escala de Cincinnati pela Escala BE FAST. 7. Reorganização das condutas assistenciais: estruturação das ações em avaliação primária e secundária mais objetivas. 8. Inclusão de critérios de gravidade: definição clara de sinais de alerta para AVC grave. 9. Incorporação da pré-notificação hospitalar: inclusão do uso do aplicativo JOIN. 10. Reforço da prioridade do tempo: destaque para transporte rápido.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes	Carla Cristine A. Bezerra Daiane C. de Moraes Elaine C. S. Melo Machado	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Hipotermia é definida como a temperatura corporal central < 35°C. O diagnóstico está associado à história de exposição a baixas temperaturas, submersão em águas frias, ou traumas com perda volêmica importante.

1.2. Grupos de risco para hipotermia: idosos, crianças, pessoas em vulnerabilidade social, alcoólatras, usuários de drogas ilícitas, vítimas de politraumatismo, grandes queimados, vítimas de afogamentos, diabéticos, tetraplégicos, pessoas expostas ao vento e a temperatura ambiental baixa.

2. OBJETIVOS

2.1. Descrever os sinais, sintomas e a abordagem pré-hospitalar realizada pela equipe de SBV e SBV-E à vítima com hipotermia.

3. EQUIPES ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e Central de Regulação.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Realize a avaliação da segurança de cena;

4.2. Realize avaliação primária e intervenha conforme achados:

4.2.1. Remova roupas molhadas;

4.2.2. Utilize a manta aluminizada para evitar perda de temperatura adicional;

4.2.3. Não massageie extremidades;

4.3. Manipule a vítima cuidadosamente, sem movimentos bruscos (para evitar arritmia cardíaca);

4.4. Mantenha a vítima em decúbito dorsal horizontal (a posição ortostática aumenta o risco de convulsão);

4.5. Realize avaliação secundária com ênfase em:

4.5.1. Monitore sinais vitais e saturação;

4.5.2. Se saturação < 94%, administre O_2 de10 à 15l/min por máscara não reinalante;

4.6. Realize o SAMPLER, com ênfase para pesquisa dos sinais e sintomas, alergias, histórico de saúde e medicamentos em uso, líquidos e alimentos ingeridos, eventos relacionados e riscos;

4.7. Realize contato com a Regulação Médica para a passagem sistematizado das informações;

4.8. Siga as orientações da Regulação Médica para procedimentos, abordagem medicamentosa e/ou transporte para a unidade de saúde de destino;

4.9. Realize o transporte para a unidade de saúde de destino indicada pela Regulação Médica, com a vítima em decúbito elevado;

4.10. Durante o transporte mantenha o ar-condicionado da ambulância desligado;

4.11. Registre os achados e procedimentos realizados na Ficha de Atendimento.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Vítimas em PCR por hipotermia poderão apresentar rigidez, portanto, não defina morte óbvia.

5.2. As manobras não deverão ser interrompidas até que a vítima esteja aquecida na unidade de saúde.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. AMLS: Atendimento Pré-Hospitalar às Emergências Clínicas/ Tradução Maria Esmene G. Comenale *et al.* 1ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2017. 545 páginas.

9.2. Velasco, IT, Brandão Neto, RA, Souza, HP et al. Emergências Clinicas: Abordagem Prática 14ª Ed, Manole, Barueri-SP, 2020.

9.3. GOLIN, V. et al. Hipotermia acidental em um país tropical. **Revista da Associação Médica Brasileira (RAMB)**, São Paulo, v. 49, n. 3, p. 261–265, set. 2003. DOI: 10.1590/S0104-42302003000300028

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Ampliação das definições, com inclusão dos principais grupos de risco para hipotermia. 2. Adequação do objetivo, direcionando para a abordagem pré-hospitalar pelas equipes SBV e SBV-E. 3. Ampliação das equipes envolvidas, com inclusão de SBV, SBV-E e URAM. 4. Padronização da abordagem inicial. 5. Reorganização das condutas assistenciais. 6. Inclusão do SAMPLER como ferramenta padronizada na avaliação secundária. 7. Reforço da comunicação com a Regulação Médica. 8. Manutenção e reforço das recomendações críticas.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Ana Midori Harada Elaine C.S.M Machado Luis Cassio Carneiro Leão Patrícia C. Alves de Sousa	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nádia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Anafilaxia é uma reação de hipersensibilidade aguda potencialmente fatal. Inclui sinais e sintomas, isolados ou combinados, que ocorrem em minutos ou em até poucas horas após a exposição ao agente causador, sendo eles: urticárias, angioedema, sintomas respiratórios, gastrintestinais, hipotensão arterial, síncope, dentre outros.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever os sinais, sintomas e a abordagem pré-hospitalar realizada pela equipe de SBV e SBV-E do SAMU 192 São Paulo à vítima em anafilaxia.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e Central de Regulação.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Realize a avaliação da segurança de cena;

4.2. Realize avaliação primária e intervenha conforme achados:

4.2.1. Afaste a vítima do agente desencadeante;

4.2.2. Atente-se para comprometimento das vias aéreas (estridor, dispneia, broncoespasmo, hipoxemia);

4.2.3. Não permita que a vítima sente ou levante rapidamente (síndrome do ventrículo vazio);

4.3. Realize avaliação secundária com ênfase em:

4.3.1. Monitore sinais vitais e saturação;

4.3.2. Se saturação < 94%, administre O_2 de10 a15l/min por máscara não reinalante;

4.4. Realize o SAMPLER, com ênfase para o tempo de início dos sinais e sintomas, agente causador, histórico de alergias, medicamentos em uso, passado médico e líquidos e alimentos ingeridos;

4.5. Considere vítima grave se houver: alteração na pele e/ou mucosas (urticárias, prurido, rubor, edema de lábios, língua) e/ou alteração respiratória (dispneia, estridor, broncoespasmo, hipoxemia) e/ou alteração circulatória (hipotensão arterial - PAS < 90 mmHg, síncope, hipotonia, sinais de choque) e/ou sintomas gastrintestinais (dor abdominal, náuseas, vômitos);

4.6. Realize contato com a Regulação Médica para a passagem sistematizado de informações;

4.7. Informe se houver comprometimento das vias aéreas e necessidade de procedimentos invasivos para apoio;

4.8. Siga as orientações da Regulação Médica para procedimentos, abordagem medicamentosa e/ou transporte para a unidade de saúde de destino;

4.9. **Abordagem medicamentosa em SBV sob autorização da Regulação Médica:**

4.9.1. Administre 0,5 mg de epinefrina IM, no músculo vasto lateral da coxa (figura 1), e após a administração eleve os membros inferiores;

4.9.2. Mantenha o paciente em decúbito dorsal com os membros inferiores elevados (Trendelenburg) se tolerado;

4.9.3. **Se não houver melhora dos sinais de choque:**

4.9.3.1. Após 10 minutos repita a dose epinefrina 0,5 mg IM no músculo vasto lateral da coxa.

4.10. **Abordagem medicamentosa na presença do enfermeiro (SBV-E):**

4.10.1. Administre 0,5 mg de epinefrina IM, no músculo vasto lateral da coxa (figura 1), e eleve os membros inferiores;

4.10.2. Administre Hidrocortisona 500 mg, via EV, diluída em SF0,9% 100ml, em (1) uma hora;

4.10.3. Mantenha o paciente em decúbito dorsal com os membros inferiores elevados (Trendelenburg) se tolerado;

4.10.4. Repita a dose epinefrina 0,5 mg IM no músculo vasto lateral da coxa se persistirem os sintomas.

4.11. **Efeitos transitórios esperados após aplicação da dose de epinefrina**

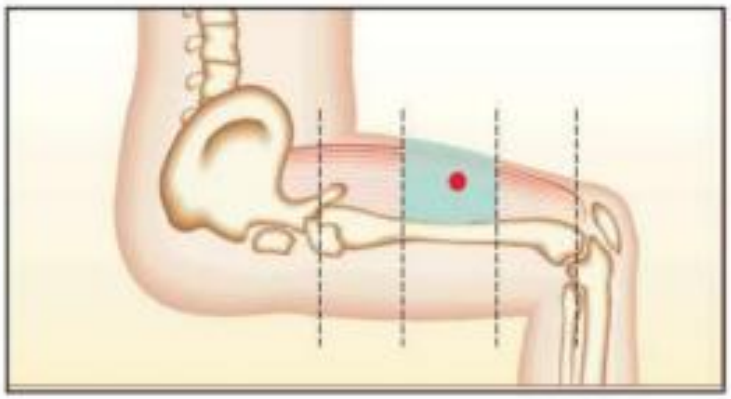
4.11.1. Palidez, tremores, ansiedade, palpitação, tontura e cefaleia;

4.11.2. Esses sinais indicam que a dose terapêutica foi ofertada;

4.12. Realize o transporte para a unidade de saúde de destino indicada pela Regulação Médica;

4.13. Registre os achados e procedimentos realizados na Ficha de Atendimento.

Figura 1 local de aplicação em músculo vasto-lateral na coxa:



Fonte: Google imagens< músculo vasto lateral>

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. A equipe de enfermagem não tem respaldo legal para dispensa da vítima na cena, mesmo que haja melhora.

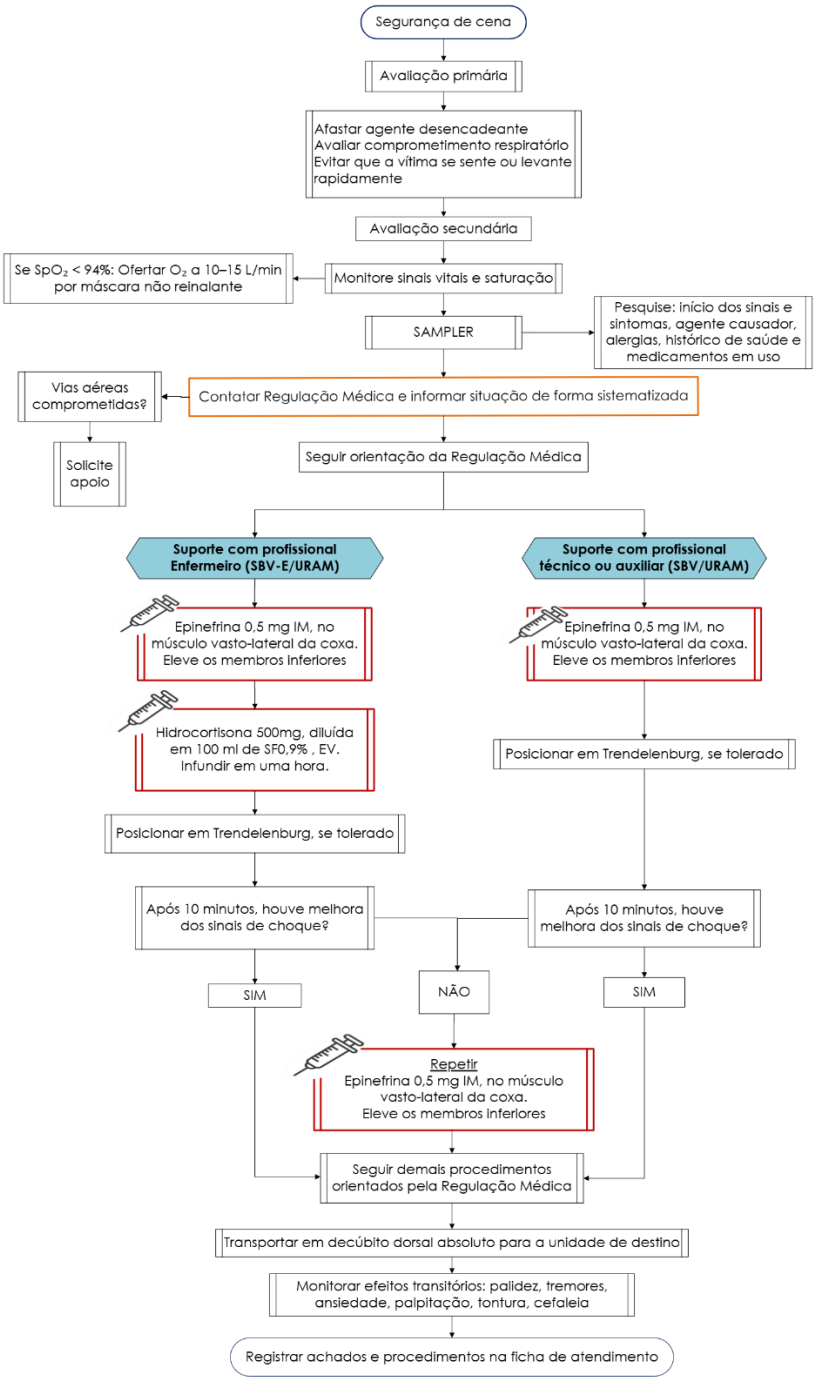
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA Anafilxia no adulto:



9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. Ludhmila, Abrahão Hajjar; Rodrigo Antonio Brandão Neto; Lucas Oliveira Marino; Julio Flávio Meirelles Marchini; Júlio César Garcia de Alencar; Karina Turaça, et al. Medicina de emergência: Abordagem Prática. 18. ed. Barueri: Manole, 2024.

9.2. ASBAI. Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Disponível em: http://www.sbai.org.br/imagebank/loreni_anafilaxia_revisado.pdf.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Adequação do nome do protocolo, antes como "Reação Anafilática" 2. Atualização da definição de anafilaxia e dos sinais e sintomas associados; 3. Adequação do objetivo 4. Padronização da avaliação de cena, avaliação primária e secundária; 5. Definição de critérios de gravidade; 6. Inclusão do SAMPLER como ferramenta de avaliação; 7. Padronização do uso de oxigênio conforme saturação; 8. Definição clara da abordagem medicamentosa com epinefrina IM, incluindo repetição de dose; 9. Inclusão da abordagem medicamentosa na presença do enfermeiro; 10. Reforço da necessidade de contato com a Regulação Médica;

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Aline Carvalho Daiane M. F. de Souza Gabriel Martinez Ivone Fernandes Alves José Caruso Luís Cassio Carneiro Leão Márcia Rosa de Souza Lopes Marisa A. Amaro Malvestio Silvio Alves Barbosa Wesley Almeida Santos Zulmira Bismarck	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a dano tecidual real ou potencial. A dor deve ser reconhecida como o quinto sinal vital e sua avaliação e manejo adequados são fundamentais para garantir conforto, segurança e prognóstico ao paciente. É subjetiva e, portanto, interpretada de modo individual. Requer avaliação sistemática por meio de instrumentos validados. Sendo assim, deve-se considerar:

1.1.1. Faixa etária;

1.1.2. Condição clínica do paciente;

1.1.3. Capacidade cognitiva;

1.1.4. Aspectos culturais dos indivíduos avaliados.

2. OBJETIVOS

2.1. Descrever a abordagem das equipes de intervenção (SBV e SBV-E) na avaliação da dor nos atendimentos pré-hospitalares;

2.2. Guiar a escolha terapêutica adequada a ser implementada pela equipe de SBV-E, conforme as características da dor, intensidade, faixa etária e condições do paciente, além do manejo na presença de vômitos.

2.3. Minimizar o sofrimento do paciente e oferecer cuidado humanizado, baseado em evidências, durante a assistência no atendimento pré-hospitalar.

3. EQUIPES ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e Central de Regulação.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Realize avaliação primária e intervenha conforme achados;

4.2. Monitore sinais vitais e saturação;

4.3. Realize avaliação semiológica da dor e identifique:

4.3.1. **Temporalidade:** Dor aguda/súbita, crônica ou exacerbação aguda de dor crônica;

4.3.2. **Localização:** Onde a dor está localizada;

4.3.3. **Qualidade/Caráter:** Como a dor é descrita (exemplo: pontada, queimação, cólica, em aperto, etc.);

4.3.4. **Intensidade:** o score álgico é medido em escalas;

4.3.5. **Duração:** Por quanto tempo a dor persiste;

4.3.6. **Evolução:** Como a dor se iniciou, se mudou com o tempo, se houve piora ou melhora;

4.3.7. **Irradiação:** Se a dor se espalha/irradia para outras áreas;

4.3.8. **Relação com as funções orgânicas:** Como a dor afeta as funções do corpo, limitações;

4.3.9. **Fatores desencadeantes:** O que causa ou piora a dor (exemplo: movimento, esforço);

4.3.10. **Fatores atenuantes:** O que alivia ou melhora a dor (exemplo: repouso, analgésicos, mudança de posição);

4.3.11. **Manifestações concomitantes:** Sintomas que acompanham a dor (ex.: febre, náuseas, vômitos, sudorese, síncope, alteração de esfíncteres, bexiga neurogênica, déficits neuro sensitivos/motor);

4.4. Parâmetros fisiológicos tais como, alterações cardiovasculares (hipertensão e taquicardia), frequência respiratória, saturação de oxigênio e sudorese têm sido utilizadas associados à observação do comportamento e podem ser úteis no processo de avaliação, já que na vigência de dor aguda intensa, respostas neurovegetativas oriundas da hiperatividade simpática podem ocorrer.

4.5. As respostas comportamentais devem ser avaliadas e podem incluir respostas verbais, vocalizações, expressões faciais, movimentos corporais e reações ao ambiente. As manifestações como choro, resmungo, gritos e proteção de partes (posição antálgica) do corpo sinalizam sofrimento e complementam a avaliação do quadro.

4.6. **Escalas de AUTOAVALIAÇÃO da dor**

4.6.1. Escala Visual Analógica (EVA)

População-alvo: Adultos e adolescentes com capacidade de abstração e compreensão verbal.

4.6.2. Escala Numérica de Dor (END)

População-alvo: Pacientes comunicativos, com boa cognição verbal e numérica.

Pergunta: "*De 0 a 10, quanto está sua dor agora? Sendo 0 nenhuma dor e 10 a pior dor possível.*

4.7. Escalas avaliação OBSERVACIONAL da dor

4.7.1. Escala PAINAD *(Pain Assessment in Advanced Dementia)*

Componente	Descrição do Comportamento	Pontuação (0–2)
Respiração	Respiração normal	0
	Respiração ofegante/ curta	1
	Respiração ruidosa, pausas	2
Vocalização	Sem vocalização	0
	Gemidos ocasionais	1
	Gritos / vocalizações frequentes	2
Expressão facial	Expressão relaxada	0
	Tensa, franzida	1
	Caretas, olhos fechados	2
Linguagem corporal	Relaxado	0
	Inquieto, mudanças de posição	1
	Rigidez, agitação, tremores	2
Consolabilidade	Sem necessidade de consolo	0
	Consolável por palavras / toque	1
	Difícil de consolar	2

População-alvo: Idosos acamados, com Alzheimer, deterioração cognitiva severa, sem comunicação verbal eficaz.

4.8. **Condutas farmacológicas em SBV-E**

Atenção!

Para administração de medicamentos sujeitos a controle especial (Morfina) o enfermeiro deverá entrar em contato previamente com MR e administrar somente após a autorização.

QUADRO 1 – CLASSIFICAÇÃO E MANEJO DA DOR

SCORE	CLASSIFICAÇÃO	ETIOLOGIA	MEDICAMENTO DE ESCOLHA
01 a 03	**LEVE**	Cefaleia Dores pelo corpo Contusões simples Febre	Paracetamol **ou** Dipirona
04 a 06	**MODERADA**	Cefaleia Lombalgia Fratura / Luxação Dor oncológica	Dipirona **e** Cetorolaco de Trometamol
		Dor abdominal Cólica renal	Buscopan simples **ou** Buscopan composto
07 A 10	**INTENSA**	Cólica renal	Buscopan composto **e** Cetorolaco de Trometamol
		Queimaduras Fratura exposta Politraumatizados Dor oncológica Crise falciforme	Morfina

4.8.1. Questione e valide ativamente histórico de **alergias e/ou contraindicações médicas** para uso dos medicamentos listados;

4.8.2. Atente-se à automedicação prévia à abordagem da equipe, considerando-se a dose e intervalo mínimo para nova administração, se necessário;

4.8.3. Puncione acesso venoso;

4.8.4. Administre analgesia, de acordo com a classificação da intensidade e etiologia da dor, conforme descrito a seguir:

MEDICAMENTO	DOSE VIA DE ADMINISTRAÇÃO	DILUIÇÕES E RECOMENDAÇÕES
PARACETAMOL **FRASCO** 200mg/ml – 15ml	**Adulto e Gestante:** Dose: 40gts Via: Oral **Pediatria:** Dose: 1 gota/kg Via: Oral	• **Não administre se:** Vítimas alérgicas ao corante amarelo de tartrazina na composição. Em pediatria: **Dose máxima 35 gotas/dose**
DIPIRONA **AMPOLA** 500mg/ml – 2ml	**Adulto:** Dose: 2g = 4 ml Via: EV Criança > 1 ano Dose: 10mg/kg Via: EV	• **Dilua** 2 ampolas (4 ml) de dipirona em 16 ml de SF 0,9% e administre em bolus lento Em pediatria: **não administrar em menores de 3 meses**

MEDICAMENTO	DOSE VIA DE ADMINISTRAÇÃO	DILUIÇÕES E RECOMENDAÇÕES
CETOROLACO DE TROMETAMOL **AMPOLA** 30mg/ml – 1ml	**Adulto: ≤ 65 anos** Dose: 30 mg = 1 ml Via: Endovenosa **Idosos: ≥ 65 anos** Dose: 15 mg = 0,5 ml Via: Endovenosa	• Dilua a dose indicada em SF 0,9%, para completar 20ml e administre em bolus lento • Não administre se: • História de sangramento digestivo ativo/úlcera péptica, coagulopatias.
BUSCOPAN SIMPLES (Escopolamina) **AMPOLA** 20mg/ml – 1ml	**Adulto e Gestante:** Dose: 20mg = 1ml Via: Endovenosa	• Dilua 1 ampola (1ml) de escopolamina em 19 ml de SF 0,9% e administre em bolus lento • Realizar a infusão lenta devido ao risco de hipotensão • Uso cauteloso em gestantes: **NÃO ADMINISTRAR A PARTIR DO 3° TRIMESTRE**
BUSCOPAN COMPOSTO (Escopolamina + Dipirona) **AMPOLA** 4mg/ml + 500mg/ml – 5ml	**Adulto:** Dose: 20mg/2500mg = 5ml Via: Endovenosa	• Dilua 1 ampola (5ml) de Buscopan composto em 250 ml de SF 0,9% e administre lento (10 min) • Realizar a infusão lenta devido ao risco de hipotensão • NÃO ADMINISTRAR EM GESTANTE

MEDICAMENTO	DOSE VIA DE ADMINISTRAÇÃO	DILUIÇÕES E RECOMENDAÇÕES
MORFINA **AMPOLA** 10mg/ml – 2ml	**Adulto:** Dose: 2 a 10mg Via: Endovenosa **Criança:** Dose: 0,1 mg/kg Via: Endovenosa	• Dilua 1 ampola (1 ml) de morfina em 9 ml SF 0,9% para obter solução 1mg/1ml. • Administre em bolus de 2 ml e avalie a resposta. • Repita a dose de 2 ml da solução após 10 minutos, se necessário. • Em caso de sobra da solução, despreze em recipiente adequado, na presença de outro profissional componente da equipe e registre em ficha de atendimento. • NÃO ADMINISTRAR EM GESTANTE

4.9. Administre SF 0,9% 250ml, p.m.v;

4.10. **Na ocorrência de vômitos incoercíveis podem ser utilizados:**

4.10.1. **ONDANSETRONA:** Ampola 2 mg/mL – 2ml.

- Adultos: 8 mg via endovenosa;
- Idosos ≥ 65 anos: 4 mg via endovenosa;
- Crianças: 0,1mg/kg via endovenosa.

Dilua a dose indicada em SF 0,9% para completar 20ml e administre lento (≥ 2 minutos);

- **Não administre em gestante;**

- **Evite a administração em cardiopatas:** risco de prolongamento do intervalo QT.

4.10.2. **DIMENIDRINATO:** Ampola 3mg/ml (30mg/10ml)

- Adultos, idosos e gestantes: 30 mg via endovenosa;

Dilua em 100ml de SF 0,9% e administre exclusivamente por via EV, por um período de no mínimo 5 minutos.

ATENÇÃO: evitar o uso de antieméticos em casos de **choque**, **rebaixamento do nível de consciência**, **suspeita de hipertensão intracraniana** ou **abdome agudo cirúrgico**, pois podem mascarar sinais clínicos importantes e retardar o diagnóstico. O uso deve ser avaliado cuidadosamente pelo médico responsável após estabilização inicial.

4.11. Realize contato com a Regulação Médica para passagem sistematizada das informações;

4.12. Registre a avaliação e reavaliação da dor na ficha de atendimento;

4.13. Realize o transporte para a unidade de saúde de destino indicada pela Regulação Médica;

4.14. Comunique a unidade de saúde medidas realizadas para o controle álgico, com a descrição de dose e horário da intervenção.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. A equipe de Suporte Básico de Vida (SBV) deverá solicitar apoio para intervenção medicamentosa.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

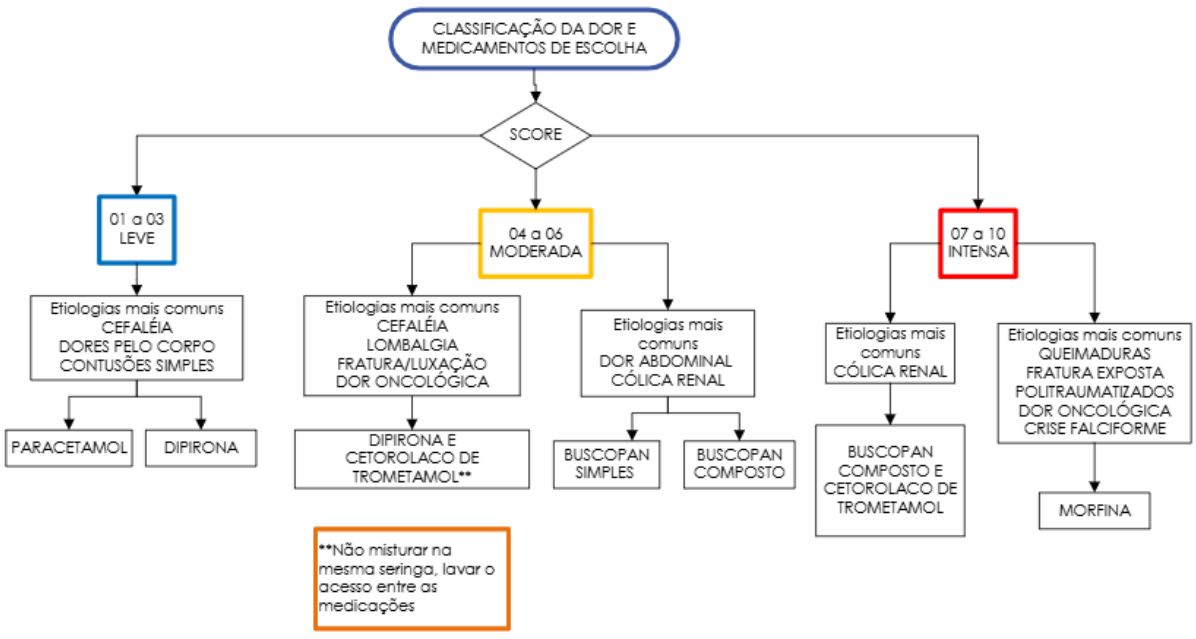
6.1. Não há

7. ANEXOS

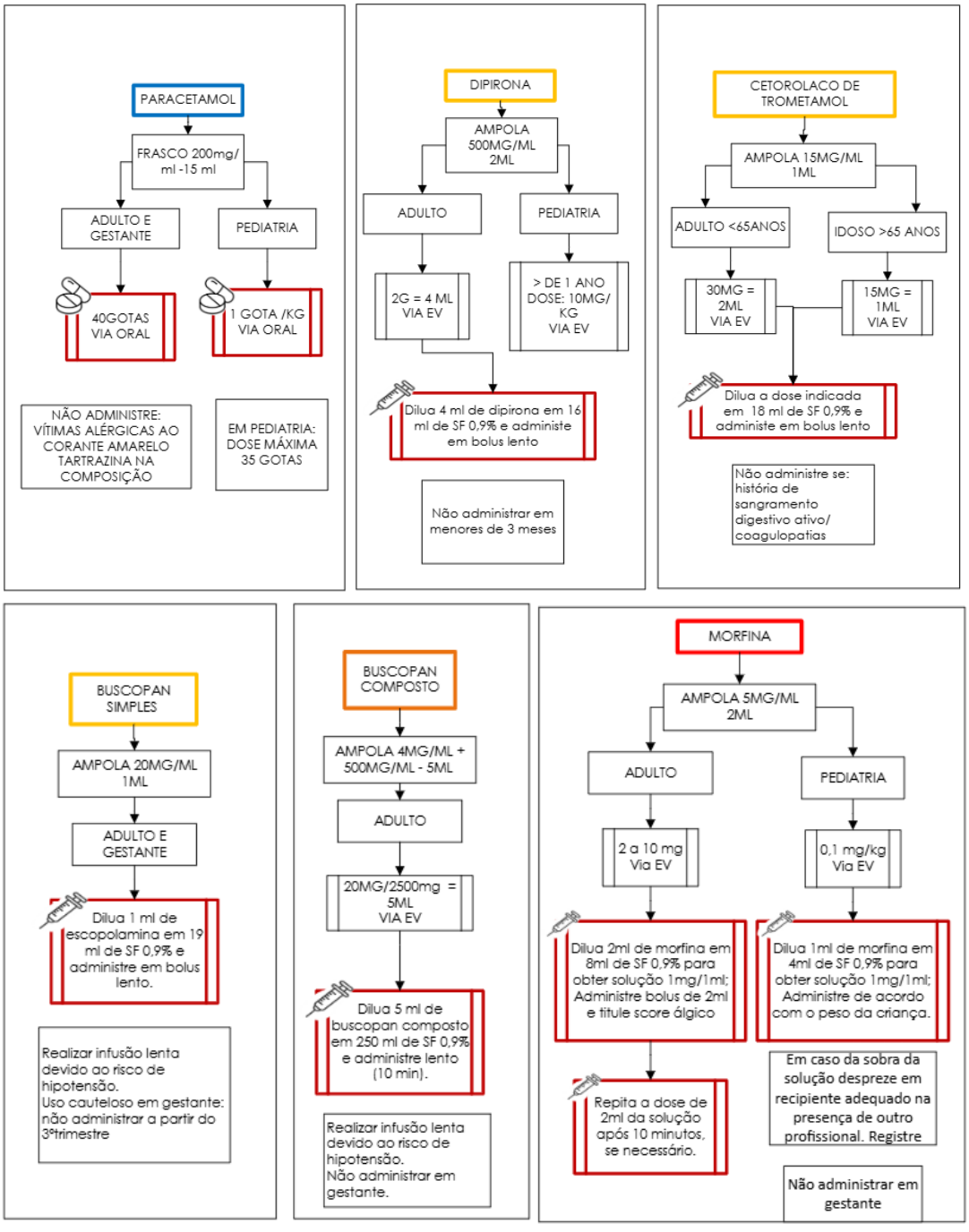
7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMAS

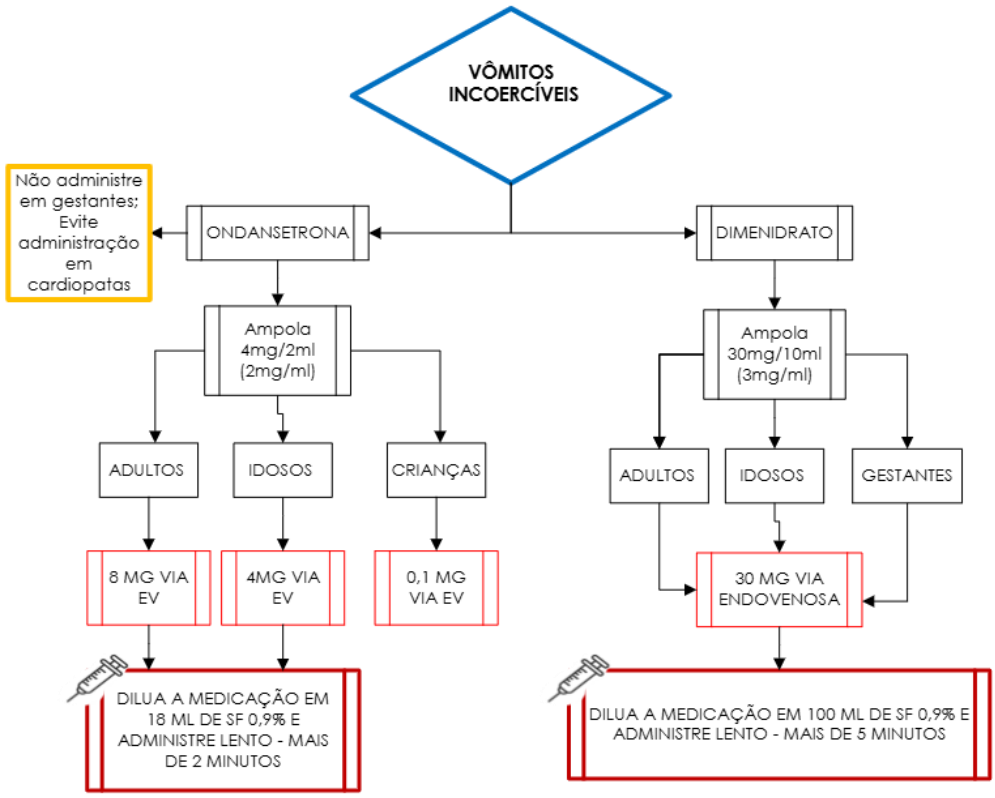
8.1. Classificação da dor e medicamentos de escolha:



8.2. Administração dos medicamentos de escolha:



8.3. Administração dos medicamentos de escolha para vômitos:



9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. PORTO, Celmo C.; PORTO, Arnaldo L. Semiologia médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

9.2. BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da dor crônica. Brasília: MS, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/dorcronica-1.pdf.

9.3. BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes para o manejo da dor no atendimento pré-hospitalar. Brasília: MS, 2024.

9.4. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Bulas de medicamentos. Disponível em: *https://consultas.anvisa.gov.br/*

9.5. IASP – International Association for the Study of Pain. *IASP Terminology*. 2023.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
01	02/02/2026	Elaborado Protocolo 045 – Avaliação e Manejo da Dor e Vômitos, com a retirada dos Protocolos 044 (Cólica Nefrética) e 045 (Crise Álgica na Anemia Falciforme)

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Wesley Almeida Santos	José Caruso Thiago Q. Lopes Rodrigues	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Intoxicação é a condição resultante do contato com substâncias tóxicas, de forma acidental ou intencional, seja por inalação, ingestão ou contato com a pele/mucosas. A gravidade dos sinais e sintomas podem variar conforme o tipo de substância, quantidade, tempo de exposição, idade da vítima e doenças pré-existentes.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever os sinais, sintomas e a abordagem pré-hospitalar realizada pela equipe de SBV e SBV-E à vítima com intoxicação aguda.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e Central de Regulação

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Realize a avaliação da segurança de cena;

4.2. Solicite apoio à Central de Regulação em caso de riscos para equipe;

4.3. Realize avaliação primária e intervenha conforme achados:

4.3.1. Afaste a vítima do agente causador;

4.3.2. Mantenha a vítima em decúbito elevado;

4.3.3. Avalie e mantenha permeabilidade das vias aéreas;

4.4. Realize a avaliação secundária com ênfase em:

4.4.1. Monitore sinais vitais e saturação;

4.4.2. Se saturação < 94%, administre O_2 de 10 a 15l/min por máscara não reinalante;

4.5. Realize o SAMPLER, com ênfase para a pesquisa dos sinais e sintomas, alergias, uso de medicamentos controlados, antecedentes psiquiátricos, tentativa de suicídio, uso de drogas ilícitas, tempo decorrido da intoxicação, via de absorção e substância (frascos vazios, embalagens etc.);

4.6. Considere vítima grave se: presença de alterações respiratórias e/ou cardiocirculatórias e/ou neurológicas;

4.7. Realize contato com a Regulação Médica para passagem sistematizada das informações;

4.8. Siga as orientações da Regulação Médica para procedimentos, abordagem medicamentosa e/ou transporte para unidade de saúde de destino;

4.9. Se possível, leve a substância suspeita junto com a vítima (frasco, produto, embalagem, outros);

4.10. Realize o transporte para a unidade de saúde de destino indicada pela Regulação Médica;

4.11. Registre os achados e procedimentos realizados na Ficha de Atendimento;

4.12. Comunique a unidade de saúde para notificação compulsória;

Medidas específicas para INTOXICAÇÃO INALATÓRIA

4.13. Considere intoxicação por monóxido de carbono quando a vítima apresentar história de inalação de fumaça e/ou apresentar os seguintes sinais e sintomas: cefaleia, fadiga, náuseas, vômitos, taquicardia, taquipneia, confusão, sonolência, convulsão e inconsciência;

4.14. Administre O_2 15l/min por máscara não reinalante, independente da saturação de 100%;

4.15. Se a vítima não melhorar após a administração do O_2, suspeite de intoxicação por cianeto e comunique imediatamente a Regulação Médica para orientação do local que dispõe do antídoto: *hidroxocobalamina*;

Medidas específicas para INTOXICAÇÃO DIGESTIVA

4.16. Considere intoxicação digestiva quando a vítima apresentar história de ingestão de carbamato "chumbinho", arsênio, alimentos, bebidas, organofosforados, substâncias químicas, plantas tóxicas, etc.;

4.17. Os principais sinais e sintomas da intoxicação incluem: miose, cefaleia, tontura, visão turva, sudorese excessiva, lacrimejamento, dispneia, sialorreia, náuseas e vômitos;

4.18. Se saturação < 94%, administre O_2 10 a 15l/min por máscara não reinalante;

4.19. Verifique glicemia capilar e se necessário realize a abordagem conforme o POP IAPH SBV E SBV-E 038 – Hipoglicemia no adulto;

Abordagem medicamentosa para intoxicação por carbamato "chumbinho" somente na presença do Enfermeiro (SBV-E/URAM).

4.20. Administre 2mg de Atropina EV sem diluição (08 ampolas de 0,25mg/ml) e em seguida faça um flush de 20 ml de SF 0,9%;

4.21. Repita após 2 minutos.

Medidas específicas para INTOXICAÇÃO TÓPICA

4.22. Se saturação < 94%, administre O_2 10 a 15l/min por máscara;

4.23. Se substâncias líquidas (gasolina, querosene, ácido fluorídrico e hipoclorito): remova a roupa e lave o local com grande quantidade de água ou soro fisiológico 0,9%;

4.24. Se substâncias em pó (cimento, cal): remova a roupa, retire o pó em excesso e lave o local com água ou soro fisiológico 0,9%.

Medidas específicas para INTOXICAÇÃO POR OPIÓIDES

4.25. Os principais sinais e sintomas de intoxicação por opioides incluem: desconforto respiratório; miose (pupilas puntiformes); rebaixamento do nível de consciência; bradicardia; hipotensão; hipotermia; pele fria e pegajosa;

4.26. Se vítima inconsciente e com obstrução de vias aéreas pela queda da língua, considerar a colocação de cânula orofaríngea;

4.27. Se saturação <94%, administre O_2 10 a 15l/min por máscara não reinalante;

4.28. Quando suspeitar de intoxicação por opioides: achados clínicos compatíveis e contexto sugestivo, como presença de ampolas, comprimidos ou seringas, histórico pregresso de uso de opioides;

4.28.1. Opioides mais comuns: Morfina, Codeína, Oxicodona, Tramadol, Fentanil, Meperidena, Buprenorfina, Heroína;

Abordagem medicamentosa para intoxicação por opioides somente na presença do Enfermeiro (SBV-E/URAM):

4.27. Entre em contato com o MR e solicite autorização para abordagem medicamentosa;

4.28. Caso autorizado, dilua Naloxona 0,4 mg/ml (1 ampola = 1ml), em 09ml de SF 0,9%.

4.28.1. Administre essa solução de 10ml, EV, lentamente, de 1 em 1 ml até o paciente acordar (administração máxima de 1ampola);

4.29. Caso não tenha resposta, considere intoxicação por outras drogas;

4.30. Solicite apoio do SAV;

Medidas específicas para INTOXICAÇÃO POR BENZODIAZEPÍNICOS

4.31. Os principais sinais os sinais e sintomas de intoxicação por benzodiazepínico: torpor, fala arrastada, depressão respiratória, hipotensão, hipotermia, ataxia, tremores e nistagmo. O uso associado ao álcool ou outras drogas depressoras pode potencializar ainda mais o efeito, levando a insuficiência respiratória e coma;

4.32. Se saturação < 94%, administre O_2 10 a 15l/min por máscara não reinalante;

4.33. Quando suspeitar de intoxicação por benzodiazepínico: achados clínicos compatíveis e contexto sugestivo, como presença de ampolas, comprimidos ou seringas; histórico pregresso de uso de benzodiazepínico;

4.33.1. Benzodiazepínicos mais comuns: Midazolam; Alprazolam, Lorazepam, Oxazepan, Diazepan (Calmociteno, Diempax, Kiatrium, Valium), Flurazepam (Dalmadorm, Lunipax).

Abordagem medicamentosa para intoxicação por benzodiazepínico somente na presença do Enfermeiro (SBV-E/URAM)

4.34. Entre em contato com o MR e solicite autorização para abordagem medicamentosa;

4.35. Caso autorizado, dilua Flumazenil 0,1mg/ml (1ampola = 5ml), em 05 ml de SF 0,9%.

4.35.1. Administre essa solução de 10ml, EV, lentamente, de 1 em 1ml. Administração máxima de 1 ampola.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não há.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

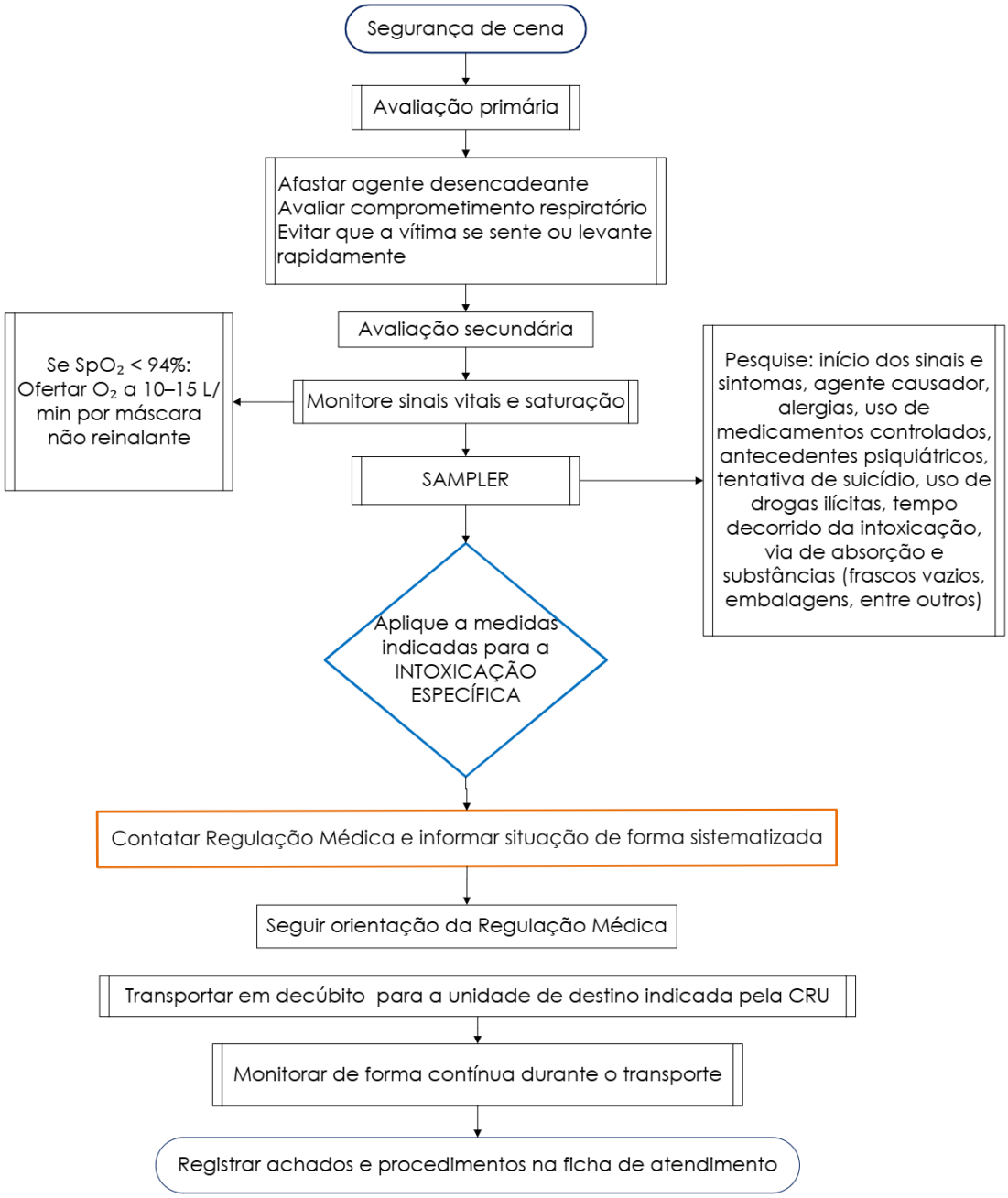
6.1. Não há.

7. ANEXOS

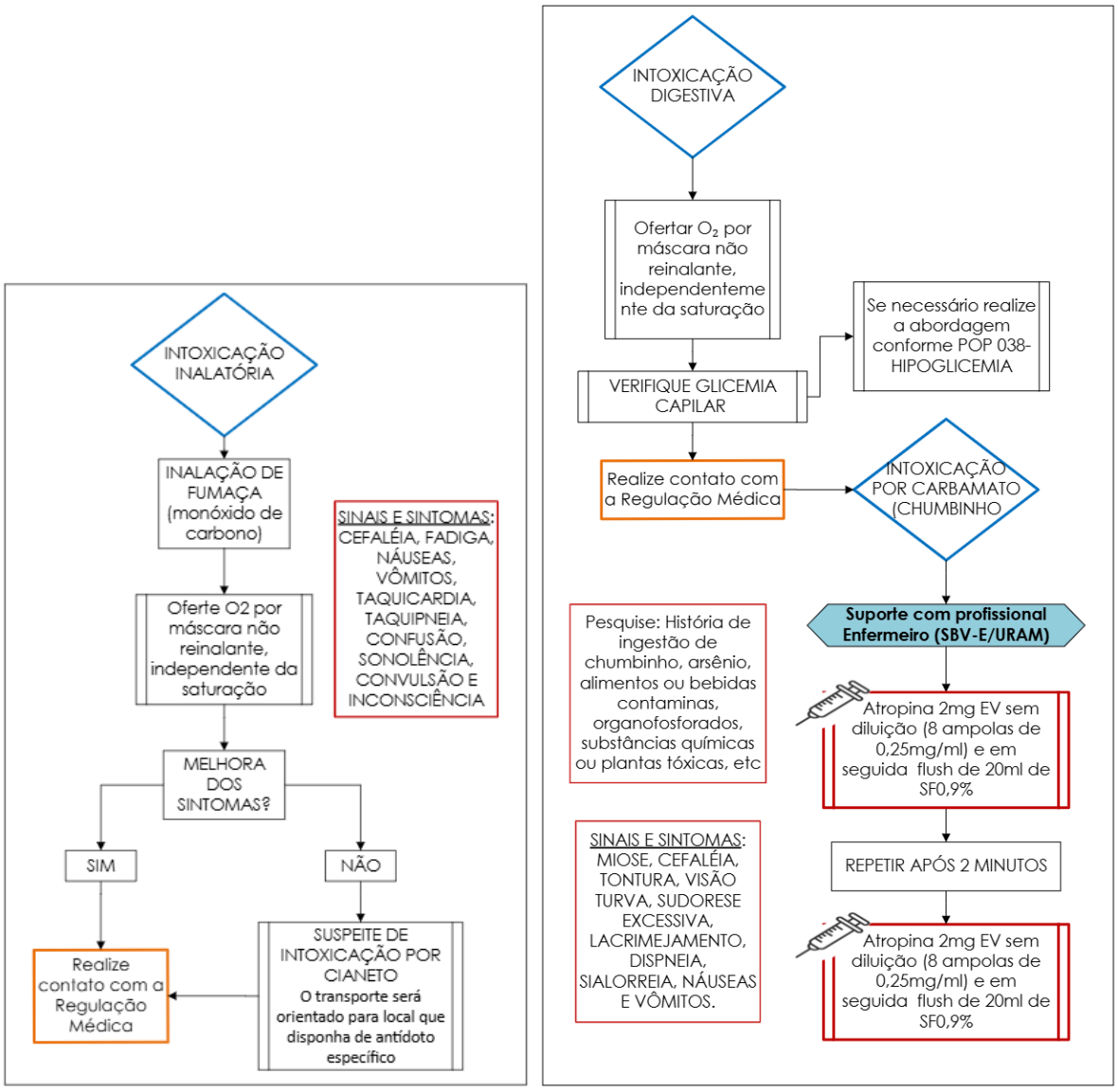
7.1. Não há.

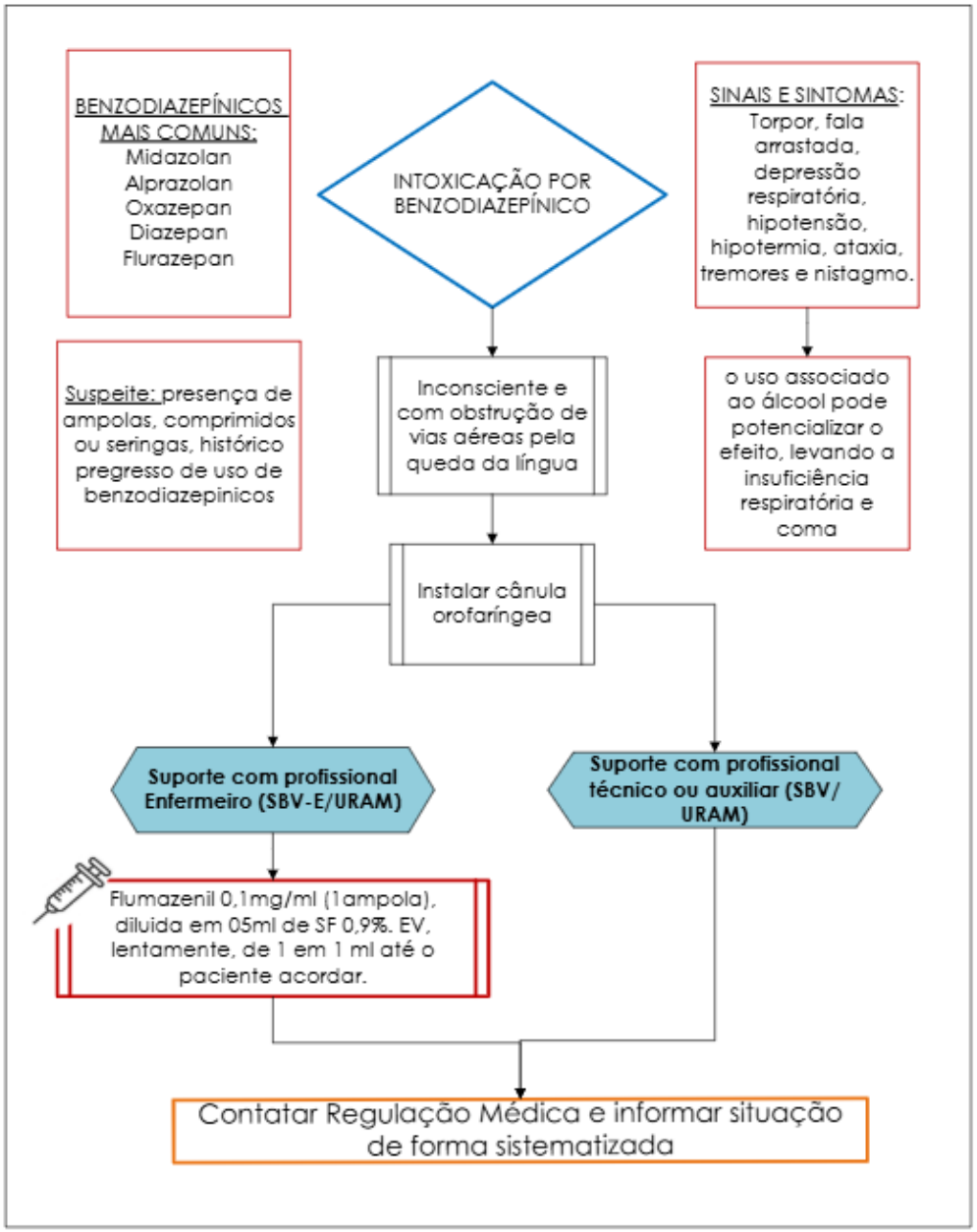
8. FLUXOGRAMAS

8.1. Fluxograma de atendimento às intoxicações agudas:



8.2. Fluxogramas específicos por intoxicação:




BENZODIAZEPÍNICOS MAIS COMUNS:
Midazolan
Alprazolan
Oxazepan
Diazepan
Flurazepan
INTOXICAÇÃO POR BENZODIAZEPÍNICO
SINAIS E SINTOMAS: Torpor, fala arrastada, depressão respiratória, hipotensão, hipotermia, ataxia, tremores e nistagmo.
Suspeite: presença de ampolas, comprimidos ou seringas, histórico pregresso de uso de benzodiazepinicos
Inconsciente e com obstrução de vias aéreas pela queda da língua
o uso associado ao álcool pode potencializar o efeito, levando a insuficiência respiratória e coma
Instalar cânula orofaríngea
Suporte com profissional Enfermeiro (SBV-E/URAM)
Suporte com profissional técnico ou auxiliar (SBV/ URAM)
Flumazenil 0,1mg/ml (1ampola), diluida em 05ml de SF 0,9%. EV, lentamente, de 1 em 1 ml até o paciente acordar.
Contatar Regulação Médica e informar situação de forma sistematizada

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. Ludhmila, Abrahão Hajjar; Rodrigo Antonio Brandão Neto; Lucas Oliveira Marino; Julio Flávio Meirelles Marchini; Júlio César Garcia de Alencar; Karina Turaça, et al. Medicina de emergência: Abordagem Prática. 18. ed. Barueri: Manole, 2024.

9.2. Maia, Ian Ward A; Benincá, Vitor Machado; Schubert, Daniel Ujakow Correa; Cunha, Victor Paro; Lunardi, Maria Camila; Guimarães, Hélio Penna. Tratado de medicina de emergência Abramede. 1 ed. Barueri: Manole, 2024.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Atualização do título. 2. Reformulação das definições, com maior clareza sobre tipos de intoxicação e fatores de gravidade. 3. Ampliação das equipes envolvidas, incluindo SBV, SBV-E e URAM. 4. Reorganização da abordagem inicial, com ênfase na segurança da cena e avaliação primária. 5. Padronização da avaliação secundária, com uso do SAMPLER ampliado. 6. Definição de critérios de gravidade para intoxicações. 7. Detalhamento das medidas específicas por tipo de intoxicação (inalatória, digestiva, tópica, opioides e benzodiazepínicos). 8. Inclusão de orientações sobre uso de antídotos, restritas à presença do enfermeiro. 9. Aprimoramento da comunicação com a Regulação Médica e do fluxo de transporte. 10. Inclusão da notificação compulsória e reforço do registro em ficha de atendimento

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia O. Lopes Edna B da Silva	Carla Cristine A. Bezerra Daiane Campos de Moraes Daiane M.F. de Souza Flávia Guedes Araújo Ivone Fernandes Alves José Caruso Luis Cássio Carneiro Leão Thiago Quaglietta L. Rodrigues Wesley Almeida Santos	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. Trauma: qualquer lesão resultante da exposição súbita a uma força externa que excede a capacidade fisiológica do organismo de suportá-la, podendo ser de origem mecânica, térmica, química, elétrica ou por radiação;

1.2. Atendimento ao trauma no Atendimento Pré-Hospitalar (APH): conjunto de ações sistematizadas realizadas por equipes de emergência fora do ambiente hospitalar, com o objetivo de identificar, estabilizar e tratar lesões potencialmente fatais, além de preparar o paciente para transporte seguro e rápido ao serviço de referência. Esse atendimento segue protocolos específicos que priorizam a avaliação rápida e intervenções imediatas para reduzir a mortalidade evitável.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever as ações no atendimento à vítima de trauma pelas equipes do SAMU 192 São Paulo.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e CRU;

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Realize a avaliação da cena e da cinemática do trauma;

4.1.1. Identifique possíveis riscos (trânsito, fogo, agressão, eletricidade, produtos químicos etc.);

4.1.2. Utilize todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários;

4.1.3. Mantenha distância segura até que os riscos sejam controlados;

4.1.4. Solicite apoio especializado caso haja perigo (bombeiros, polícia, defesa civil);

4.1.5. Estabeleça comunicação clara entre os membros da equipe;

4.1.6. Apenas aproxime-se da vítima após confirmar a segurança da cena;

Avaliação Primária e Tratamento da Vítima Traumatizada

4.2. **X** – Identifique lesões exsanguinantes e inicie tratamento:

4.3. Realize compressão direta nos ferimentos hemorrágicos;

4.4. Realize o preenchimento de lesões que apresentem cavidade aberta e prossiga com curativo compressivo conforme POP IAPH SBV e SBV-E 91 Controle de Hemorragias externas nas feridas abertas (cavidade) com sangramentos não controlados na compressão;

4.5. Se não houver controle do sangramento com as medidas anteriores, instale o torniquete conforme Protocolo específico- POP IAPH SBV e SBV-E 91- Controle de Hemorragia Externa - quando os procedimentos anteriores aplicados não obtiverem sucesso e estiverem localizados em extremidades (MMSS e MMII);

4.6. **A** – Avalie permeabilidade das VAS e estabilize a coluna cervical:

4.6.1. Estabilize manualmente a cabeça da vítima;

4.6.2. Retire próteses, restos alimentares e sangue da via aérea;

4.6.3. Aspire via aérea se necessário;

4.6.4. Instale cânula orofaríngea nas vítimas inconscientes;

4.6.5. Realize ventilação com bolsa válvula máscara conforme POP IAPH SBV e SBV-E 030 – Insuficiência Respiratória, em pacientes com parada respiratória ou respiração ineficaz;

4.6.6. Imobilize com colar cervical, assim que possível.

4.7. **B** – Avalie a qualidade da respiração (inspeção, ausculta (SBV-E) e palpação do tórax);

4.7.1. Administre oxigênio por máscara de 10 a 15 litros/minuto inicialmente a todas as vítimas com suspeita de lesão grave;

4.7.2. Aplique curativo de três pontas em ferimentos torácicos abertos com saída de ar;

4.8. **C** – Avalie pele, pulso e perfusão e atente-se para os sinais de choque (palidez cutânea, sudorese fria, pulso rápido e fino, perfusão >2 segundos);

4.8.1. Garanta que todos os ferimentos sangrantes estejam controlados;

4.8.2. Realize imobilização da pelve na suspeita de fratura;

4.8.3. Realize o alinhamento e imobilização nas fraturas de ossos longos (fêmur);

4.8.4. Na presença de choque hemorrágico realize a reposição volêmica permissiva conforme POP IAPH SBV e SBV-E 048 - Choque hemorrágico;

4.9. **D** – Aplique a Escala de Coma de Glasgow e avalie as pupilas.

4.9.1. Avalie dor e medique conforme POP IAPH SBV e SBV-E 045 – Avaliação e Manejo da Dor e Vômitos;

4.10. **E** – Realize a exposição da vítima, de preferência dentro da ambulância e utilize a manta aluminizada para prevenção de hipotermia;

Exposição com critério:

4.10.1. Vítimas conscientes: apenas se houver mecanismo grave e/ou sujidade de sangue nas roupas e/ou deformidade em estruturas anatômicas e referência de dor;

4.10.2. Vítimas inconscientes: realize exposição completa;

4.10.3. Retire roupas úmidas e/ou molhadas;

4.10.4. Aqueça com manta aluminizada;

ATENÇÃO

4.11. Nessa etapa da avaliação a exposição é necessária para busca de lesões potencialmente fatais.

Avaliação Secundária na Vítima de Trauma

4.12. A avaliação secundária consiste na realização do exame físico detalhado, com o objetivo de identificar problemas ou lesões não

percebidas na avaliação primária, como: perda de líquidos, afundamentos, desvios, hematomas, abrasões e deformidades:

4.13. Realize as imobilizações das lesões osteoarticulares quando indicadas;

4.14. Monitore sinais vitais e saturação;

4.15. Realize a entrevista SAMPLER e questione sobre:

S – Sintomas e Lesões;

A - Alergia a alguma substância ou medicamentos;

M - Medicamentos em uso;

P - Passado médico referente doenças e/ou antecedentes de cirurgias;

L - Líquidos e/ou alimentos (ingesta);

E - Evento relacionado ao trauma (atente-se ao uso de drogas ilícitas);

R – Riscos ou fatores de risco relacionados ao evento.

4.16. Imobilize a vítima com cintos na prancha;

4.17. Fixe a prancha na maca com os cintos de segurança;

4.18. Realize contato com a Regulação Médica para a passagem sistematizada das informações;

4.19. Passe o caso para o MR;

4.20. Transporte para a unidade de saúde conforme orientação do MR.

4.21. O deslocamento deve ser feito com rapidez, e com cuidado, evitando piora das lesões;

4.22. A equipe deve reavaliar constantemente a vítima durante o trajeto, identificando e corrigindo possíveis alterações;

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não há.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP IAPH e SBV e SBV-E 045 – Avaliação e Manejo da Dor e Vômitos;

6.2. POP IAPH SBV e SBV-E 91 Controle de Hemorragias externas

6.3. POP IAPH SBV e SBV-E 030 – Insuficiência Respiratória;

6.4. POP IAPH SBV e SBV-E 048 - Choque hemorrágico

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. PHTLS. Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado. National Association of Emergency Medical Technician, 2021. 9ª edição. 762 páginas.

9.2. Protocolo de Atendimento Pré-Hospitalar: Suporte Intermediário de Vida. São Paulo: Secretaria Municipal de Saúde – SAMU, 2022; 5ª. Edição 391 p.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Inclusão de definições conceituais sobre trauma e atendimento pré-hospitalar. 2. Atualização das equipes envolvidas, com ampliação para SBV, SBV-E e URAM. 3. Reorganização da avaliação da cena. 4. Padronização da abordagem XABCDE, alinhada aos POPs institucionais. 5. Atualização das condutas. 6. Aprimoramento da abordagem respiratória e ventilatória. 7. Inclusão do manejo da dor e reforço da prevenção da hipotermia. 8. Detalhamento da avaliação secundária.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cássia O. Lopes Edna B. da Silva	Alexsandro de Paula Ana Midori Harada Celina H. H. Vasconcelos Elaine C. S. M. Machado	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Matheus D. Miachon	Nádia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Choque hemorrágico: falência generalizada do sistema circulatório devido perda expressiva de sangue, resultando na perfusão tecidual inadequada de oxigênio, evoluindo para um metabolismo anaeróbico.

ATENÇÃO

1.2. Hemorragias nas cavidades torácicas, abdominal e pélvica podem justificar a instabilidade hemodinâmica na ausência de sangramentos visíveis.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever os sinais e sintomas e a abordagem pré-hospitalar realizada pela equipe do SAMU à vítima em choque hemorrágico.

3. EQUIPES ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM, Central de Regulação e Unidade de Saúde.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Realize a avaliação da segurança de cena;

4.2. **X** – Identifique lesões exsanguinantes e realize o controle da hemorragia;

4.2.1. Realize compressão direta nos ferimentos hemorrágicos;

4.2.2. Realize o preenchimento das lesões que apresentem cavidade aberta e prossiga com curativo compressivo conforme POP IAPH SBV e SBV-E 091 – Controle de Hemorragias Externas;

4.2.3. Se não houver controle do sangramento com as medidas anteriores, instale o torniquete conforme POP IAPH SBV e SBV-E 091- Controle de Hemorragia Externa – quando os procedimentos anteriores aplicados não obtiverem sucesso e estiverem localizados em extremidades (MMSS e MMII);

4.3. **A** – Mantenha permeabilidade da VA e estabilize a coluna cervical;

4.3.1. Estabilize manualmente a cabeça da vítima;

4.3.2. Retire próteses, restos alimentares e sangue da via aérea;

4.3.3. Aspire via aérea se necessário;

4.3.4. Instale cânula orofaríngea nas vítimas inconscientes;

4.3.5. Imobilize com colar, assim que possível.

4.4. **B** – Avalie respiração (inspeção, ausculta e palpação);

4.4.1. Vítimas com instabilidade hemodinâmica apresentam taquipneia indicando um mecanismo fisiológico compensatório. Oferte O2 por máscara não reinalante 10-15l/minuto independente da saturação, ou ventilação por bolsa-valva-máscara se respiração ineficaz ou parada respiratória;

4.5. **C** – Avalie pele, pulso e perfusão;

4.5.1. Vítimas com instabilidade hemodinâmica apresentam palidez, perfusão lentificada, pulso periférico fino ou ausente, pulso central fino e rápido, e referem sede intensa;

4.5.2. Garanta que todos os ferimentos sangrantes visíveis estejam controlados;

4.5.3. Realize imobilização da pelve na suspeita de fratura (POP IAPH SBV e SBV-E 094 Procedimento- Imobilização da Pelve);

4.6. Realize o alinhamento e imobilização nas fraturas de ossos longos (POP IAPH SBV e SBV-E 095 Procedimento - Imobilização de extremidades);

4.7. **Abordagem medicamentosa apenas na presença do enfermeiro em SBV-E/URAM:**

4.7.1. Puncione acesso venoso periférico ou IO (na impossibilidade do periférico);

4.7.2. Administre solução isotônica (Ringer Lactato ou Soro Fisiológico 0,9%), para manter PAS em 90 mmHg;

4.7.3. Administre Ácido Tranexâmico 1g, diluído em 100 ml de SF 0,9%, EV em 10 minutos;

4.7.3.1. Não atrase o transporte com tentativas de acesso venoso!

4.8. **D** – Aplique a Escala de Coma de Glasgow e avalie as pupilas;

4.9. Alterações neurológicas costumam cursar com hemorragias expressivas;

4.10. Avalie dor e medique conforme POP IAPH SBV e SBV-E 045 – Avaliação e Manejo da Dor e Vômitos;

4.11. **E** – Exponha e aqueça;

4.11.1. Vítimas com instabilidade hemodinâmica geralmente se encontram hipotérmicas;

4.11.2. Exposição com critério:

4.11.2.1. Vítimas conscientes: apenas se houver mecanismo grave e/ou sujidade de sangue nas roupas e/ou deformidade em estruturas anatômicas e referência de dor;

4.11.2.2. Vítimas inconscientes: realize exposição completa;

4.11.3. Utilize manta aluminizada;

4.12. Realize avaliação secundária:

4.13. Faça o exame físico detalhado, com o objetivo de identificar problemas ou lesões não percebidas na avaliação primária, como: perda de líquidos, afundamentos, desvios, hematomas, abrasões e deformidades:

4.14. Realize as imobilizações das lesões osteoarticulares quando indicadas;

4.15. Verifique sinais vitais e saturação;

4.16. Realize o SAMPLER com ênfase em:

S - Lesões e sintomas;

A - Alergias;

M - Medicamentos em uso

P - Passado médico e antecedentes cirúrgicos;

L - Última ingestão de líquidos e/ou alimentos;

E - Eventos relacionados ao trauma;

R – Riscos ou fatores de risco relacionados ao evento;

4.17. Imobilize a vítima com cintos de segurança na prancha;

4.18. Fixe a prancha na maca;

4.19. Realize contato com a Regulação Médica para a passagem sistematizada das informações;

4.20. Siga as orientações da Regulação Médica para procedimentos, abordagem medicamentosa e/ou transporte para a unidade de saúde de destino;

4.21. Transporte para a unidade de saúde conforme orientação do MR;

4.22. O deslocamento deve ser feito com agilidade, e com cuidado, evitando piora das lesões;

4.23. A equipe deve reavaliar constantemente a vítima durante o trajeto, identificando e corrigindo possíveis alterações;

4.24. Registre os achados e procedimentos realizados na Ficha de Atendimento.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não atrasar o transporte em detrimento de tentativas de acesso venoso.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP Intervenções em Atendimento Pré-Hospitalar 045 – Avaliação e Manejo da Do e Vômitos;

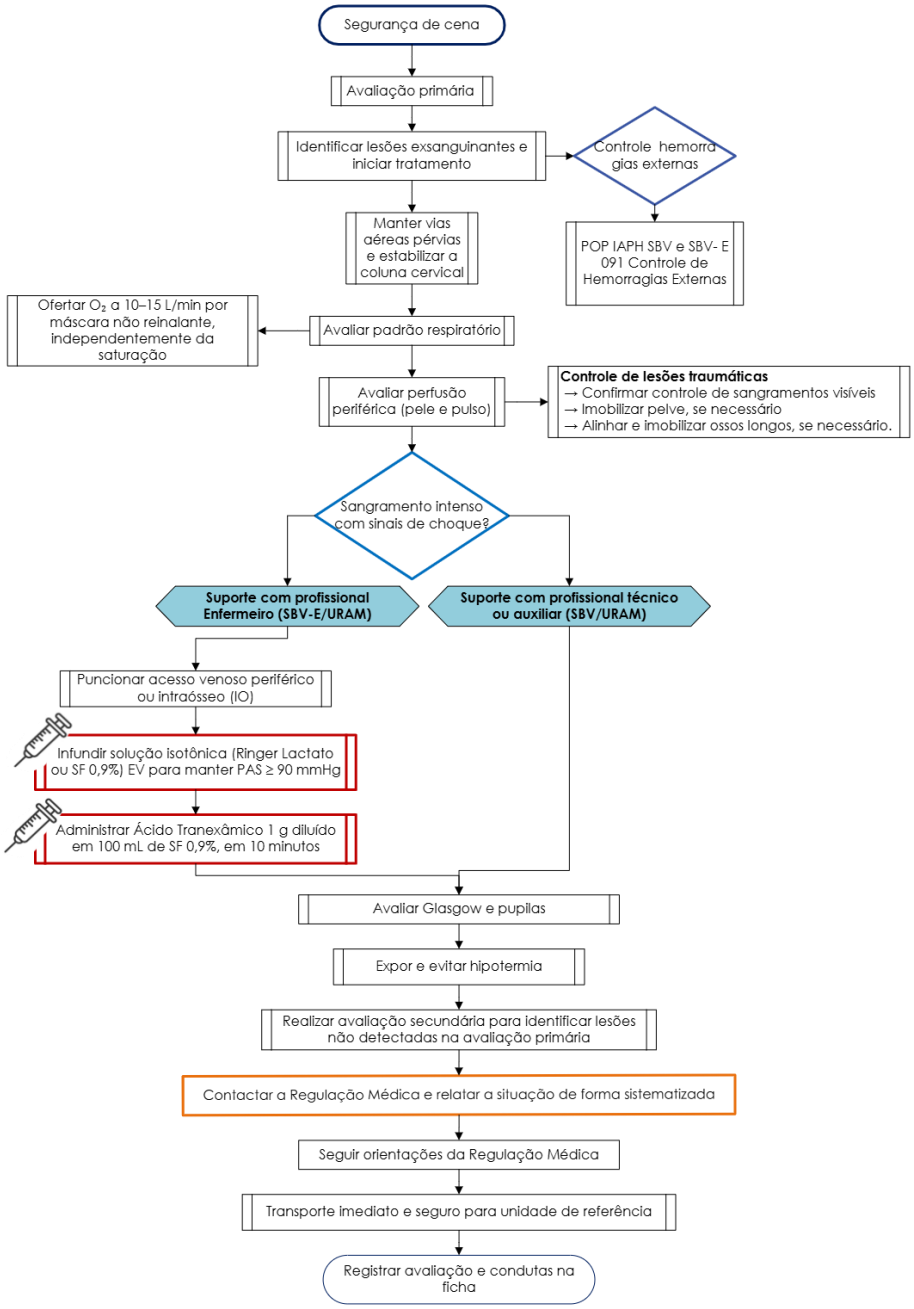
6.2. POP IAPH SBV e SBV-E 094 Procedimento- Imobilização da Pelve;

6.3. POP IAPH SBV e SBV-E 095 Procedimento - Imobilização de extremidades.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA – Choque hemorrágico



9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. PHTLS. Atendimento pré-hospitalar ao traumatizado. 10. ed. Burlington: Jones & Bartlett Learning; National Association of Emergency Medical Technicians, 2023. 824 p.

9.2. SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal de Saúde. *Protocolo de Atendimento Pré-Hospitalar: Suporte Intermediário de Vida*. 5. ed. São Paulo: SAMU, 2022. 391 p.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Reorganização e padronização do conteúdo. 2. Reforço da avaliação da segurança de cena e do ABCDE. 3. Padronização do controle de hemorragias, incluindo torniquete e preenchimento de cavidades. 4. Atualização da reposição volêmica, com meta de PAS e orientação para não atrasar o transporte. 5. Inclusão do uso de ácido tranexâmico. 6. Maior ênfase na prevenção da hipotermia. 7. Padronização da avaliação secundária, transporte e registro das informações.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Ana Midori Harada Daiane M. F. de Souza Elaine C. S. M. Machado José Caruso Simone Cedano Ramos Wesley Almeida Santos	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Matheus D. Miachon	Nádia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Trauma raquimedular: qualquer lesão que acomete a coluna vertebral e/ou a medula espinhal, resultando de uma força externa capaz de causar danos estruturais ou funcionais, podendo gerar déficits neurológicos temporários ou permanentes. Esse tipo de trauma pode envolver fraturas, luxações, compressões ou contusões na coluna, representando risco elevado de incapacidade devido à possível interrupção parcial ou total da condução nervosa. Na população idosa, as lesões podem estar presentes mesmo com mecanismo envolvendo baixa energia.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever o atendimento a vítima com suspeita de trauma raquimedular.

3. EQUIPES ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e Central de Regulação.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Realize a avaliação da segurança de cena;

4.2. Realize a avaliação da cinemática do trauma;

4.3. Solicite apoio à CRU em caso de riscos para equipe;

4.4. **X** – Identifique lesões exsanguinantes e controle a hemorragia;

4.5. **A** – Mantenha permeabilidade da VA e estabilize a coluna cervical;

4.5.1. Estabilize manualmente a cabeça da vítima;

4.5.2. Retire próteses, restos alimentares e sangue da via aérea;

4.5.3. Aspire via aérea se necessário;

4.5.4. Instale cânula orofaríngea nas vítimas inconscientes;

4.5.5. Imobilize com colar, assim que possível.

ATENÇÃO

4.6. O alinhamento da cabeça está contraindicado quando houver: referência de dor, piora do padrão respiratório, resistência ao movimento, aumento do déficit neurológico, espasmos na musculatura do pescoço, torcicolo congênito, malformação e deformidade degenerativa pré-existentes;

ATENÇÃO

4.7. Vítimas com suspeita de lesão raquimedular encontradas em:

4.7.1. Decúbito dorsal: imobilize manualmente a coluna e continue avaliação primária;

4.7.2. Decúbito ventral ou lateral: imobilize manualmente a coluna, realize o rolamento diretamente na prancha;

4.8. **B** – Avalie a qualidade da respiração (inspeção, ausculta e palpação);

4.8.1. Administre oxigênio por máscara de 10-15 litros/minuto, inicialmente para todas as vítimas com suspeita de lesão grave;

4.8.2. Nas vítimas adultas com FR < 10 irpm, utilize o dispositivo bolsa-válvula-máscara conectado ao cilindro de oxigênio 10 a 15l/min e realize 1 ventilação a cada 6 segundos;

4.8.3. Nas vítimas crianças com FR < 20 irpm utilize o dispositivo bolsa-válvula-máscara conectado ao cilindro de oxigênio à 8l/ minuto na frequência de 1 ventilação a cada 3 segundos;

4.8.4. Nas vítimas lactentes com FR < 25 irpm utilize o dispositivo bolsa-válvula-máscara conectado ao cilindro de oxigênio à 8l/ minuto na frequência de 1 ventilação a cada 2 segundos.

4.9. **C** – Avalie pele, pulso e perfusão e atente-se para os sinais de choque;

4.9.1. Vítimas com suspeita de trauma raquimedular com instabilidade hemodinâmica evoluem com piora do quadro devido a comprometimento de perfusão tecidual;

4.9.2. Avalie sinais sugestivos de choque medular: pele quente e seca, FC normal ou bradicardia, hipotensão arterial, saturação < 94% e paralisia flácida;

4.9.3. Garanta que todos os ferimentos sangrantes estejam controlados;

4.9.4. Realize imobilização da pelve na suspeita de fratura;

4.9.5. Realize o alinhamento e imobilização nas fraturas de ossos longos (fêmur);

4.9.6. Na presença de choque hemorrágico realize a reposição volêmica permissiva conforme POP IAPH SBV e SBV-E 048 - Choque hemorrágico;

4.10. **D** – Aplique a Escala de Coma de Glasgow e avalie as pupilas;

4.10.1. Considere a possibilidade de lesão medular todas as vítimas com alteração neurológica, intoxicadas por álcool e/ou drogas e déficit neurológico motores e sensitivos (paralisias, paresia e parestesia);

4.10.2. Avalie dor e medique conforme POP IAPH 045 – Avaliação e Manejo da Dor e Vômitos;

4.11. **E** – Realize a exposição da vítima, de preferência dentro da ambulância e utilize a manta aluminizada para prevenção de hipotermia;

4.11.1. Exposição com critério:

4.11.1.1. Vítimas conscientes: apenas se houver mecanismo grave e/ou sujidade de sangue nas roupas e/ou deformidade em estruturas anatômicas e referência de dor;

4.11.1.2. Vítimas inconscientes: realize exposição completa;

4.12. Retire roupas úmidas e/ou molhadas;

4.13. Aqueça com manta aluminizada;

4.14. A presença de priapismo é sugestiva de lesão medular.

<u>Avaliação Secundária na Vítima de Trauma</u>

4.15. A avaliação secundária consiste na realização do exame físico detalhado, com o objetivo de identificar problemas ou lesões não percebidas na avaliação primária, como: perda de líquidos, afundamentos, desvios, hematomas, abrasões e deformidades:

4.16. Realize as imobilizações das lesões osteoarticulares quando indicadas;

4.17. Monitorize sinais vitais e saturação;

4.18. Entrevista SAMPLER:

S - Lesões e sintomas;

A - Alergia a alguma substância ou medicamentos;

M - Medicamentos em uso

P - Passado médico referente doenças e/ou antecedentes de cirurgias;

L - Líquidos e/ou alimentos (ingesta);

E - Evento relacionado ao trauma (atente-se ao uso de drogas ilícitas);

R – Riscos ou fatores de risco relacionados ao evento.

4.19. Imobilize a vítima com cintos na prancha;

4.20. Fixe a prancha na maca com os cintos de segurança;

4.21. Realize contato com a Regulação Médica para passagem sistematizada das informações;

4.22. Passe o caso para o MR;

4.23. Realize transporte para a unidade de saúde de destino indicada pelo MR;

4.24. O deslocamento deve ser feito com rapidez, e com cuidado, evitando piora das lesões;

4.25. A equipe deve reavaliar constantemente a vítima durante o trajeto, identificando e corrigindo possíveis alterações.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não há

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP IAPH SBV e SBV-E 045 – Avaliação e Manejo da Dor e Vômitos;

6.2. POP IAPH SBV e SBV-E 048 - Choque hemorrágico

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. PHTLS. Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado. National Association of Emergency Medical Technician, 2021. 9ª edição. 762 páginas.

9.2. Protocolo de Atendimento Pré-Hospitalar: Suporte Intermediário de Vida. São Paulo: Secretaria Municipal de Saúde – SAMU, 2022; 5ª. Edição 391 p.

9.3. Protocolo Cuidados Intensivos do Trauma Raquimedular. Unidade São Joaquim. 2009

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Ampliação e atualização da definição de trauma raquimedular. 2. Atualização das equipes envolvidas, com inclusão de SBV, SBV-E e URAM. 3. Padronização da abordagem inicial. 4. Reorganização do atendimento pelo mnemônico XABCDE. 5. Detalhamento das condutas de via aérea e estabilização. 6. Atualização das condutas respiratórias. 7. Aprimoramento da abordagem circulatória. 8. Inclusão da avaliação e manejo da dor. 9. Estruturação da avaliação secundária, incluindo exame físico detalhado, SAMPLER e reforço das imobilizações.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Ana Midori Harada Celina H. H. Vasconcelos Elaine C. S. M. Machado	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Traumatismo Cranioencefálico (TCE): definido como qualquer agressão externa que cause impacto direto ou indireto ao crânio, levando a lesões no couro cabeludo, crânio, encéfalo ou em suas estruturas internas. Pode gerar alterações neurológicas temporárias ou permanentes, variando desde concussões leves até danos cerebrais graves, com risco significativo de morte ou incapacidades. O TCE é considerado uma das principais causas de morbimortalidade no trauma, exigindo abordagem rápida e sistematizada no atendimento pré-hospitalar.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever a abordagem pré-hospitalar realizada pela equipe do SAMU 192 São Paulo à vítima com trauma cranioencefálico.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e Central de Regulação.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Realize a avaliação da segurança de cena;

4.2. Realize a avaliação da cinemática do trauma;

4.3. Solicite apoio à Central de Regulação em caso de riscos para equipe;

Realize avaliação primária e intervenha conforme achados:

4.4. **X**- Realize o controle de hemorragias exsanguinantes, se presente;

4.5. **A**- Avalie e mantenha a permeabilidade das vias aéreas:

4.5.1. Realize a imobilização manual da coluna cervical e alinhamento da cabeça;

4.5.2. Utilize a manobra de anteriorização da mandíbula (Jaw Thrust);

4.5.3. Retire prótese dentária, se possível;

4.5.4. Remova restos de alimentos, líquidos ou secreções que possam obstruir as vias aéreas;

4.5.5. Realize aspiração da cavidade oral, se necessário. Não introduza a sonda nas narinas;

4.5.6. Utilize a cânula orofaríngea para vítimas inconscientes, exceto em casos de trauma de face;

4.5.7. Coloque o colar cervical em momento oportuno, atentando-se para não deixar muito apertado, de forma a não comprometer o fluxo sanguíneo cerebral;

4.6. **B**- Avalie o padrão respiratório e intervenha conforme as alterações:

4.6.1. Administre inicialmente O_2 de 10 a 15l/min por máscara não reinalante e titule conforme necessidade para manter saturação > 94%;

4.6.2. Nas vítimas com frequência respiratória < 10 irpm ou > 30 irpm, ventile com dispositivo bolsa-válvula-máscara: adulto – 10 vpm; criança – 20 a 25 vpm e lactente – 25 a 30 vpm;

4.6.3. Evite hiperventilação;

4.6.4. Solicite apoio à Central de Regulação;

4.7. **C-** Avalie pele, pulso e perfusão periférica em busca de sinais de choque;

4.7.1. Avalie a pelve, em uma única vez, e os ossos longos e intervenha se for encontrado sinais de fratura;

4.7.2. Realize imobilização da pelve e dos ossos longos conforme protocolo específico;

4.7.3. Vítimas com suspeita de TCE associado à instabilidade hemodinâmica evoluem com piora da isquemia cerebral, justificando a necessidade da manutenção da PAS entre 90 a 110 mmHg;

4.8. **D-** Avalie a presença de alterações neurológicas a partir da aplicação da Escala de Coma de Glasgow e avaliação pupilar bilateral;

4.8.1. Na impossibilidade de aplicação da Escala de Coma de Glasgow, utilize o mnemônico AVDN;

4.8.2. Alterações neurológicas observadas e/ou informadas (energia envolvida, perda de consciência, amnesia, vômitos, convulsão, déficits motores) estão associadas à piora do quadro da vítima;

4.8.3. Identifique sinais de fratura de base de crânio: rinorreia, epistaxe, otorragia, otorreia, sinal de Battle (equimose atrás da orelha) e olhos de guaxinim (equimose periorbital);

4.8.4. Se forem observados sinais de herniação, tais como pupilas dilatadas e fixas, postura em decorticação ou descerebração, hipertensão arterial, bradicardia ou bradipneia, deve-se realizar hiperventilação controlada, com frequência respiratória de 20 incursões por minuto em adultos, 25 em crianças e 30 em bebês;

4.9. **E-** Realize a exposição da vítima, de preferência dentro da ambulância e utilize a manta aluminizada para prevenção de hipotermia;

4.10. Avalie dor e medique conforme POP IAPH SBV E SBV-E 045 – Avaliação e Manejo da Dor e Vômitos;

4.11. Na presença de convulsão, medique conforme POP IAPH SBV E SBV-E 39 - Crise Convulsiva no Adulto;

4.12. Realize a avaliação secundária com ênfase em:

4.12.1. Monitore sinais vitais e saturação;

4.12.2. Verifique a glicemia capilar e corrija se necessário, conforme protocolo de hipoglicemia - POP IAPH SBV e SBV-E 038 – Hipoglicemia;

4.12.3. Realize o SAMPLER, com ênfase para a pesquisa dos sinais e sintomas, alergias, uso de anticoagulantes e/ou antiagregantes plaquetários, passado médico, líquidos e alimentos ingeridos e eventos relacionados ao trauma;

4.13. Considere vítima grave se: presença de alterações respiratórias e/ou cardiocirculatórias e/ou neurológicas;

4.14. Realize contato com a Regulação Médica para passagem sistematizada das informações;

4.15. Siga as orientações da Regulação Médica para procedimentos, abordagem medicamentosa e/ou transporte para unidade de saúde de destino;

4.16. Realize o transporte para a unidade de saúde de destino indicada pela Regulação Médica;

4.17. Lateralize a prancha em caso de vômitos durante o transporte;

4.18. Registre os achados e procedimentos realizados na Ficha de Atendimento.

ATENÇÃO

Pacientes agitados ou com comportamento alterado, que recusam tratamento e/ou transporte médico, mesmo sem sinais aparentes de comprometimento ou déficit neurológico no momento da avaliação, podem não reconhecer a gravidade de suas lesões até horas ou dias depois. É fundamental realizar uma avaliação completa, observando a capacidade do paciente de tomar decisões e monitorando sinais e sintomas como: pupilas desiguais, cefaleia intensa e progressiva, náuseas e vômitos, sonolência ou dificuldade para despertar, fala arrastada, confusão ou alteração de comportamento, perda de consciência, convulsões, dormência, diminuição da coordenação e dificuldade em reconhecer pessoas ou lugares.

Nesses casos, o atendimento deve ser imediatamente comunicado ao Médico Regulador, solicitando apoio para garantir a condução segura da vítima a uma unidade de saúde.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não há

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP IAPH SBV e SBV-E 045 – Avaliação e Manejo da Dor e Vômitos;

6.2. POP IAPH SBV e SBV-E 039 -Crise Convulsiva no Adulto;

6.3. POP IAPH SBV e SBV-E 038 – Hipoglicemia.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não há.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. Gentile JK, Himuro HS, Ordinola Rojas SS, et al. Condutas no paciente com trauma cranioencefálico. Bras. Clinica Médica. 2011; 09(1): 75.

9.2. PHTLS. Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado. National Association of Emergency Medical Technician, 2024. 10ª edição. 801 páginas.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Revisão da definição de TCE. 2. Adequação do objetivo para abordagem pré-hospitalar pelo SAMU 192. 3. Atualização das áreas envolvidas. 4. Inclusão da avaliação de segurança de cena e cinemática do trauma. 5. Padronização da avaliação primária pelo método XABCDE. 6. Atualização das condutas. 7. Inclusão do manejo da dor e vômitos conforme POP 045. 8. Padronização da conduta frente à crise convulsiva, com referência a POP específico.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Celina H. H. Vasconcelos Daiane M. F. de Souza Elaine Cristina S.M. Machado José Caruso Simone Cedano Ramos Wesley Almeida Santos	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Trauma ocular: qualquer lesão que acomete o globo ocular, seus anexos (pálpebras, conjuntiva, músculos extraoculares) ou estruturas orbitárias, resultante de agente mecânico, químico, térmico ou radiante. Pode variar de lesões superficiais, como escoriações e corpos estranhos, até danos graves como perfurações, rupturas, queimaduras químicas ou contusões que ameaçam a integridade visual. O trauma ocular exige avaliação imediata, pois intervenções rápidas podem prevenir perda parcial ou total da visão.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever a abordagem pré-hospitalar realizada pela equipe do SAMU 192 São Paulo à vítima com trauma ocular.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e Central de Regulação.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Realize a avaliação da segurança de cena;

4.2. Realize a avaliação da cinemática do trauma;

4.3. Solicite apoio à Central de Regulação em caso de riscos para equipe;

4.4. Realize avaliação primária e intervenha conforme achados:

4.4.1. Não pressione nem esfregue o olho, mesmo em caso de trauma ocular sangrante;

4.4.2. Avalie e mantenha permeabilidade das vias aéreas;

4.4.3. Tente acalmar a vítima, mantendo-a em posição confortável;

4.5. Realize a avaliação secundária com ênfase em:

4.5.1. Monitore sinais vitais e saturação;

4.5.2. Se saturação < 94%, administre O_2 de 10 a 15l/min por máscara não reinalante;

4.6. Realize o SAMPLER, com ênfase para a pesquisa dos sinais e sintomas, alergias, uso de medicamentos, passado médico, líquidos e alimentos ingeridos e eventos relacionados ao trauma;

4.7. Considere vítima grave se: presença de alterações respiratórias e/ou cardiocirculatórias e/ou neurológicas;

4.8. Realize contato com a Regulação Médica para passagem sistematizada das informações;

4.9. Siga as orientações da Regulação Médica para procedimentos, abordagem medicamentosa e/ou transporte para unidade de saúde de destino;

4.10. Avalie dor e medique conforme POP IAPH SBV E SBV-E 045 – Avaliação e Manejo da Dor e Vômitos;

4.11. Realize o transporte para a unidade de saúde de destino indicada pela Regulação Médica;

4.12. Registre os achados e procedimentos realizados na Ficha de Atendimento;

Medidas específicas para lesões por QUEIMADURA TÉRMICA

4.13. Realize a irrigação do olho lesionado com água destilada ou soro fisiológico em grande quantidade, iniciando o mais rápido possível, na tentativa de remover completamente o agente irritante;

4.14. Se possível, remova lentes de contato durante a irrigação;

4.15. Cubra os dois olhos com gaze umedecida em soro fisiológico, sem exercer pressão no local.

Medidas específicas para lesões por QUEIMADURA QUÍMICA

4.16. Na presença de agentes químicos particulados, como cal ou cimento, realize a remoção cuidadosa do excesso do produto na superfície ocular e periocular;

4.17. Evite fricção para não causar abrasão da córnea ou maior liberação de substâncias corrosivas;

4.18. Após a retirada do material visível, realize a irrigação do local com água ou soro fisiológico em grande quantidade;

Medidas específicas para LACERAÇÃO, ABRASÃO e/ou PERFURAÇÃO

4.19. Em caso de lesão ocular aberta, a irrigação está contraindicada;

4.20. Não realize curativo compressivo na presença de sangramento;

4.21. Evite qualquer toque, compressão ou tentativa de manipulação do globo ocular;

4.22. Não utilize gaze diretamente sobre o olho;

4.23. Proteja o olho lesionado com um escudo rígido (ex.: base de um copo descartável), evitando qualquer pressão sobre o globo ocular. Cubra os dois olhos;

4.24. Não remova objetos empalados /corpo estranho;

4.25. Estabilize o objeto;

4.26. Em caso de enucleação, não tente recolocar o globo ocular dentro da órbita.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. No trauma ocular o curativo é oclusivo, **NUNCA** compressivo!

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP IAPH SBV e SBV-E 045 – Avaliação e Manejo da Dor e Vômitos;

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN. PHTLS: atendimento pré-hospitalar ao traumatizado. 10. ed. 2024. 801 p.

9.2. TAKAHASHI, W. Y. Traumatismos e emergências oculares. São Paulo: Roca, 2003. (Atualidades em Oftalmologia USP, v. 5).

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Ampliação da definição de trauma ocular, incluindo estruturas anexas. 2. Inclusão de novas áreas envolvidas na assistência. 3. Padronização da avaliação inicial (segurança de cena e cinemática). 4. Inclusão da avaliação secundária e monitorização clínica. 5. Reestruturação das condutas. 6. Atualização da abordagem da dor, com referência a protocolo específico. 7. Reforço da comunicação com a Regulação Médica. 8. Padronização do transporte e registro do atendimento. 9. Reforço da orientação de curativo oclusivo.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Celina H. H. Vasconcelos Daiane M.F. de Souza José Caruso Wesley Almeida dos Santos	Bárbara de Souza Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. Trauma de tórax: consiste em lesões que acometem a estrutura óssea da parede torácica, as vísceras torácicas (coração, pulmões, diafragma e esôfago) e os grandes vasos do mediastino. Essas lesões podem provocar comprometimento ventilatório com consequente acidose respiratória, alterações na troca gasosa levando à acidose metabólica, disfunção cardíaca por danos estruturais ou elétricos e hemorragia maciça. Os mecanismos causais mais frequentes incluem traumas contusos, perfurantes, de esmagamento ou decorrentes de explosões;

1.2. Curativo de três pontas: trata-se de um curativo oclusivo fixado em apenas três de seus lados, permitindo que um dos bordos permaneça livre. Essa técnica impede a entrada de ar na cavidade torácica durante a inspiração e possibilita a saída do ar acumulado durante a expiração, contribuindo para prevenir a evolução para um pneumotórax hipertensivo.

1.3. Pneumotórax hipertensivo: caracteriza-se pelo acúmulo progressivo de ar no espaço pleural, sem possibilidade de escape, resultando no aumento da pressão intratorácica. Esse mecanismo compromete o retorno venoso e reduz o débito cardíaco, podendo evoluir rapidamente para choque grave.

2. OBJETIVOS

2.1. Descrever as ações no atendimento a vítima com trauma de tórax.

3. EQUIPES ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e CRU.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Realize a avaliação da segurança de cena;

4.2. Realize a avaliação da cinemática do trauma;

4.3. Solicite apoio à Central de Regulação em caso de riscos para equipe;

Realize avaliação primária e intervenha conforme achados:

4.4. **X –** Identifique as lesões exsanguinantes e controle o sangramento;

4.5. **A –** Avalie e mantenha permeabilidade das vias aéreas:

4.5.1. Realize a imobilização manual a coluna cervical e o alinhamento da cabeça;

4.5.2. Utilize a manobra de anteriorização da mandíbula (Jaw Thrust);

4.5.3. Coloque o colar cervical em momento oportuno, atentando-se para não deixar muito apertado, pois pode impedir a drenagem venosa para a cabeça;

4.6. **B –** Avalie o padrão respiratório e intervenha conforme as alterações:

4.6.1. Observe o tórax por meio da inspeção e atente-se para presença de equimoses, marcas de cinto ou pneu, ferimentos penetrantes e movimentos paradoxais;

4.6.2. Na presença do enfermeiro, e se possível, realize ausculta do tórax e atente-se para diminuição ou abolição dos murmúrios vesiculares, presença de sibilos ou outros sons anormais;

4.6.3. Realize a palpação do tórax em busca de crepitações ósseas, enfisema subcutâneo e reação dolorosa;

4.6.4. Identifique sinais de pneumotórax hipertensivo: ausência de sons respiratórios no lado afetado, hipotensão, taquicardia, taquipneia, redução da pressão arterial, distensão venosa jugular e desvio da traqueia para o lado não afetado (tardio);

4.6.5. Caso haja sinais de pneumotórax hipertensivo, solicite apoio imediato do SAV;

4.6.6. Aplique o curativo de três pontas se houver ferimento aberto (soprante) no tórax (Figura 1);

4.6.7. Em caso de objeto encravado no tórax, não o remova; apenas estabilize-o adequadamente para o transporte;

4.6.8. Administre oxigênio por máscara não reinalante de 10-15 litros/minutos independente da saturação;

4.6.9. Nas vítimas adultas com FR <10 irpm realize ventilação assistida com BVM e oxigênio complementar;

4.6.10. Nas vítimas crianças com FR < 20 irpm realize ventilação assistida com BVM e oxigênio complementar;

4.6.11. Nas vítimas lactentes com FR < 25 irpm realize ventilação assistida com BVM e oxigênio complementar;

4.7. **C –** Avalie pele, pulso e perfusão e identifique sinais de choque:

4.7.1. Vítimas com trauma de tórax podem ter comprometimento circulatório devido pneumotórax hipertensivo, hemotórax e tamponamento cardíaco;

4.7.2. Se sinais de choque (pele pálida, fria e pegajosa, pulso filiforme ou imperceptível e perfusão periférica > 2 segundos), proceda com as ações descritas em POP IAPH SBV e SBV-E 048 Choque Hemorrágico;

4.7.3. Acidentes de trânsito de impacto frontal e/ou de alta velocidade e em queda elevada de altura deve-se suspeitar de ruptura traumática da aorta, caracterizada por assimetria dos pulsos em membros superiores e/ou superiores e inferiores;

4.8. **D –** Aplique Escala de Glasgow e avalie as pupilas;

4.9. **E –** Realize a exposição da vítima, de preferência dentro da ambulância e utilize manta aluminizada;

Figura 1: Curativo de três pontas para ferimento soprante no tórax

Foto: https://pt.slideshare.net/slideshow/15-_trauma_de_torax-pdf/275165348?nway-content_model=A

Realize a avaliação secundária:

4.9.1. Monitorize sinais vitais e saturação;

4.9.2. Realize o SAMPLER com ênfase em sinais e sintomas, alergias, uso de anticoagulantes e/ou betabloqueadores, passado médico e cirúrgico, líquidos e alimentos ingeridos e eventos relacionados ao trauma;

4.9.3. Aplique a escala numérica de dor (consultar POP IAPH SBV E SBV-E 045 – Avaliação e Manejo da Dor e Vômitos);

4.10. Realize contato com a Regulação Médica para passagem sistematizada das informações;

4.11. Siga as orientações da Regulação Médica para procedimentos, abordagem medicamentosa e/ou transporte para unidade de saúde de destino;

4.12. Realize o transporte para a unidade de destino indicada pela Regulação Médica;

4.13. Lateralize a prancha em caso de vômitos durante o transporte;

4.14. Registre os achados e procedimentos realizados na Ficha de Atendimento.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não há

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP IAPH SBV e SBV-E 048 Choque Hemorrágico

6.2. POP IAPH EM SBV E SBV-E 045 – Avaliação e Manejo da Dor e Vômitos.

7. ANEXOS

7.1. Não há

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. PHTLS. Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado. National Association of Emergency Medical Technician, 2025. 10ª edição;

9.2. PHTLS: Atendimento pré-hospitalar ao traumatizado. 10. ed. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning, 2023;

9.3. AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS – COMMITTEE ON TRAUMA. ATLS: Advanced Trauma Life Support – 11th ed. Chicago, IL: American College of Surgeons, 2025;

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Ampliação e padronização das definições clínicas. 2. Inclusão de novas equipes envolvidas no atendimento. 3. Reorganização do fluxo conforme abordagem XABCDE. 4. Atualização das condutas respiratórias e de oxigenoterapia. 5. Padronização do manejo do pneumotórax hipertensivo e ferimentos soprantes. 6. Inclusão de orientações para ventilação assistida por faixa etária. 7. Aprimoramento da avaliação secundária e da avaliação da dor. 8. Fortalecimento da integração com a Regulação Médica

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Ana Midori Harada Celina H H Vasconcelos Simone Cedano Ramos	Bárbara de Souza Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. O trauma abdominal é definido como qualquer lesão que afeta os órgãos e estruturas localizadas na cavidade abdominal, resultante de uma força externa. Pode comprometer órgãos sólidos (fígado, baço e rins), órgãos ocos (estômago, intestino e bexiga), vasos sanguíneos e estruturas retroperitoneais. Classificado como: fechado (contuso) ou penetrante.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever a abordagem pré-hospitalar realizada pela equipe do SAMU 192 São Paulo à vítima com trauma abdominal.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e Central de Regulação.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Realize a avaliação da segurança de cena;

4.2. Realize a avaliação da cinemática do trauma;

4.3. Solicite apoio à Central de Regulação em caso de riscos para equipe;

Realize avaliação primária e intervenha conforme achados:

4.4. **X-** Identifique lesões exsanguinantes e controle a hemorragia;

4.5. **A-** Avalie e mantenha a permeabilidade das vias aéreas:

4.5.1. Realize a imobilização manual da coluna cervical e alinhamento da cabeça;

4.5.2. Utilize a manobra de anteriorização da mandíbula (Jaw Thrust);

4.5.3. Coloque o colar cervical em momento oportuno, atentando-se para não deixar muito apertado, pois pode impedir a drenagem venosa para a cabeça;

4.6. **B-** Avalie o padrão respiratório e intervenha conforme as alterações:

4.6.1. Administre inicialmente O_2 de 10 a 15l/min por máscara não reinalante e titule conforme necessidade para manter saturação > 94%;

4.7. **C-** Avalie pele, pulso e perfusão periférica em busca de sinais de choque;

4.7.1. Pele pálida, fria e pegajosa; perfusão periférica aumentada e pulso rápido e filiforme podem indicar sinais de choque hemorrágico mesmo após controle das lesões exsanguinantes. Suspeite de lesão fechada (tórax, abdome e pelve);

4.7.2. Se sinais de choque, siga o POP IAPH SBV E SBV-E 048 Choque Hemorrágico;

4.7.3. Solicite apoio do suporte avançado (SAV);

4.7.4. Avalie a pelve, em uma única vez, e os ossos longos e intervenha se for encontrado sinais de fratura;

4.7.5. Realize imobilização da pelve e dos ossos longos conforme protocolo específico;

4.8. **D-** Avalie a presença de alterações neurológicas a partir da aplicação da Escala de Coma de Glasgow e avaliação pupilar bilateral;

4.9. Alterações neurológicas como: ansiedade, agitação, rebaixamento de nível de consciência, podem indicar choque hemorrágico de origem desconhecida;

4.10. **E-** Realize a exposição da vítima, de preferência dentro da ambulância e procure por: equimose periumbilical ou em flancos, escoriações, objetos penetrantes, dor ou sensibilidade a palpação;

4.10.1. Utilize a manta aluminizada para prevenção de hipotermia;

<u>Realize a avaliação secundária com ênfase em:</u>

4.11. Inspecione o abdome e atente-se para a presença de distensão, equimoses, hematomas ou ferimentos penetrantes. Palpe cuidadosamente para identificar dor, rigidez, defesa ou massas;

4.12. Identifique sinais de hemorragia interna, como pele fria, palidez, taquicardia e hipotensão;

4.13. Verifique a presença de sensibilidade e dor referida;

4.14. Avalie a região lombar e flancos e atente-se na presença de hematomas ou aumento do volume;

4.15. Atente-se para sinais associados, como vômitos com sangue, hematúria ou saída de líquidos pelos orifícios naturais.

4.16. Se houver objeto empalado, não remover. Realize a estabilização do objeto para o transporte;

4.17. Se evisceração, não tentar recolocar os órgãos na cavidade abdominal. Irrigue com SF0,9% e cubra a área com plástico estéril (protetor de evisceração) para evitar ressecamento até a chegada no hospital;

4.18. Monitore a vítima de forma contínua das condições hemodinâmicas e do nível de consciência.

4.19. Realize o SAMPLER, com ênfase para a pesquisa dos sinais e sintomas, alergias, uso de betabloqueadores, anticoagulantes e/ou antiagregantes plaquetários, passado médico, líquidos e alimentos ingeridos e eventos relacionados ao trauma;

4.20. Realize contato com a Regulação Médica para passagem sistematizada das informações;

4.21. Siga as orientações da Regulação Médica para procedimentos, abordagem medicamentosa e/ou transporte para unidade de saúde de destino;

4.22. Realize o transporte para a unidade de saúde de destino indicada pela Regulação Médica;

4.22.1. Lateralize a prancha em caso de vômitos durante o transporte;

4.23. Registre os achados e procedimentos realizados na Ficha de Atendimento.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

Atenção!

5.1. Vítimas com instabilidade hemodinâmica sem causa aparente, suspeite de hemorragia abdominal. Os sinais e sintomas costumam ser tardios;

5.2. Atente-se para vítimas em intoxicação por álcool e/ou drogas e com lesão cerebral.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP IAPH SBV E SBV-E 048 Choque Hemorrágico.

6.2. POP IAPH SBV E SBV-E 045 Avaliação e Manejo da dor e Vômitos.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. PHTLS. Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado. National Association of Emergency Medical Technician, 2024. 10ª edição. 801 páginas.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Atualização da definição e do objetivo do protocolo. 2. Adequação das áreas envolvidas. 3. Inclusão da avaliação de segurança de cena e cinemática do trauma. 4. Padronização da avaliação primária (XABCDE). 5. Reforço da identificação e manejo do choque hemorrágico. 6. Atualização das condutas de vias aéreas, oxigenoterapia e imobilização. 7. Organização da avaliação secundária abdominal. 8. Padronização das condutas para objeto empalado e evisceração. 9. Atualização da abordagem medicamentosa e reposição volêmica. 10. Reforço da comunicação com a Regulação Médica, transporte e registro.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cássia O. Lopes Edna B. da Silva	Celina H H Vasconcelos Daiane M. F. de Souza José Caruso Wesley Almeida Santos	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. O trauma musculoesquelético é definido como qualquer lesão que afeta músculos, ossos, articulações, ligamentos, tendões e/ou cartilagens. Essas lesões podem ser causadas por impactos, quedas, esforços excessivos, acidentes ou movimentos repetitivos;

1.2. Síndrome do esmagamento: condição que ocorre quando massas musculares comprimidas liberam conteúdos intracelulares tóxicos na corrente sanguínea, dentre eles, mioglobina, potássio, fosfato, creatina quinase, durante a descompressão da estrutura afetada. As principais ocorrências relacionadas são: vítimas presas em ferragens ou escombros, vítimas de queda que permanecem por muito tempo na mesma posição.

1.3. Síndrome compartimental: condição caracterizada pelo aumento da pressão dentro de um compartimento muscular fechado, comprometendo a circulação sanguínea local e a função dos tecidos ao redor (músculos e nervos). As principais ocorrências relacionadas são: fraturas de perna ou antebraço, lesões por esmagamento, hematomas musculares profundos, queimaduras circunferenciais.

1.4. Extricação: processo de retirar com segurança uma vítima de um local onde ela está presa, confinada ou em situação de risco — como dentro de um veículo após um acidente — usando técnicas e equipamentos específicos.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever o atendimento à vítima com trauma musculoesquelético.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e Central de Regulação.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Realize a avaliação da segurança de cena;

4.2. Realize a avaliação da cinemática do trauma;

4.3. Solicite apoio à Central de Regulação em caso de riscos para equipe;

Realize avaliação primária e intervenha conforme achados:

4.4. **X-** Identifique lesões exsanguinantes e controle a hemorragias;

4.5. **A-** Avalie e mantenha a permeabilidade das vias aéreas:

4.5.1. Realize a imobilização manual da coluna cervical e alinhamento da cabeça;

4.5.2. Utilize a manobra de anteriorização da mandíbula (Jaw Thrust);

4.5.3. Coloque o colar cervical em momento oportuno, atentando-se para não deixar muito apertado, pois pode impedir a drenagem venosa para a cabeça;

4.6. **B-** Avalie o padrão respiratório e intervenha conforme as alterações:

4.6.1. Administre inicialmente O_2 de 10 a 15l/min por máscara não reinalante e titule conforme necessidade para manter saturação > 94%;

4.6.2. **C-** Avalie pele, pulso e perfusão periférica em busca de sinais de choque;

4.6.3. Se sinais de choque – pele pálida, fria e pegajosa, pulso filiforme ou imperceptível e perfusão periférica maior que dois segundos, proceda com ações descritas em POP IAPH SBV e SBV-E 048 Choque Hemorrágico;

4.6.4. Avalie a pelve, em uma única vez, e os ossos longos e intervenha se for encontrado sinais de fratura;

4.6.5. Realize imobilização da pelve e dos ossos longos conforme protocolo específico. POP IAPH SBV e SBV-E 94- Imobilização de pelve 094 e IAPH SBV e SBV-E 96- Imobilização de extremidades;

4.7. **D-** Avalie a presença de alterações neurológicas a partir da aplicação da Escala de Coma de Glasgow e avaliação pupilar bilateral;

4.7.1. Alterações neurológicas como: ansiedade, agitação, rebaixamento de nível de consciência, podem indicar choque hemorrágico de origem desconhecida;

4.8. **E-** Realize a exposição da vítima, de preferência dentro da ambulância, a avalie os locais onde há suspeição de lesão como por exemplo presença de dor e deformidades;

4.8.1. Nas vítimas graves, os curativos e imobilizações de ossos curtos deverão ser realizados durante o transporte;

4.8.2. Utilize a manta aluminizada para prevenção de hipotermia;

4.9. Realize a avaliação secundária com ênfase em:

4.9.1. Monitore sinais vitais e saturação;

4.9.2. Realize o SAMPLER, com ênfase para a pesquisa dos sinais e sintomas, alergias, uso de anticoagulantes e/ou antiagregantes plaquetários, passado médico, líquidos e alimentos ingeridos e eventos relacionados ao trauma;

4.10. Medidas específicas para SÍNDROME DO ESMAGAMENTO

4.10.1. Se vítimas presas em ferragens, encarceradas ou debaixo de escombros solicite apoio do corpo de bombeiros;

4.10.2. Solicite apoio do suporte avançado;

Abordagem medicamentosa apenas em SBV-E sob autorização da Regulação Médica:

4.10.3. Puncione acesso venoso (máximo 3 tentativas);

4.10.4. Em caso de falha de acesso venoso, utilize a via intraóssea;

4.10.5. Administre soro fisiológico 0,9% 1500 ml/h mesmo antes da extricação;

4.10.6. Após a extricação o volume pode ser reduzido para 500 ml/h;

4.10.7. Não utilizar ringer com lactato, devido a presença de potássio na solução.

4.11. Medidas específicas para SÍNDROME COMPARTIMENTAL

4.11.1. Avalie se há presença de dor desproporcional a lesão encontrada;

4.11.2. Avalie se há alteração de sensibilidade (aumento ou diminuição);

4.11.3. Ausência de pulso periférico e paralisia no membro afetado, pode indicar sinais tardios de síndrome compartimental com risco de morte do músculo;

4.11.4. No caso de membro inferior afetado, flexionar levemente o tornozelo (dorsiflexão) para imobilizar, a fim de reduzir a pressão do compartimento inferior anterior da perna;

4.11.5. Caso já tenha realizado a imobilização e a vítima apresente edema, dor no local e/ou ausência de pulso periférico, refaça o procedimento;

4.11.6. Realize avaliação e controle da dor conforme POP IAPH SBV E SBV-E 045 Avaliação e Manejo da dor e Vômitos.

4.12. Realize contato com a Regulação Médica para passagem sistematizada das informações;

4.13. Siga as orientações da Regulação Médica para procedimentos, abordagem medicamentosa e/ou transporte para unidade de saúde de destino;

4.14. Realize o transporte para a unidade de saúde de destino indicada pela Regulação Médica;

4.15. Lateralize a prancha em caso de vômitos durante o transporte;

4.16. Registre os achados e procedimentos realizados na Ficha de Atendimento;

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não há.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP IAPH SBV e SBV-E 94- Imobilização de pelve;

6.2. POP IAPH SBV e SBV-E 96- Imobilização de extremidades;

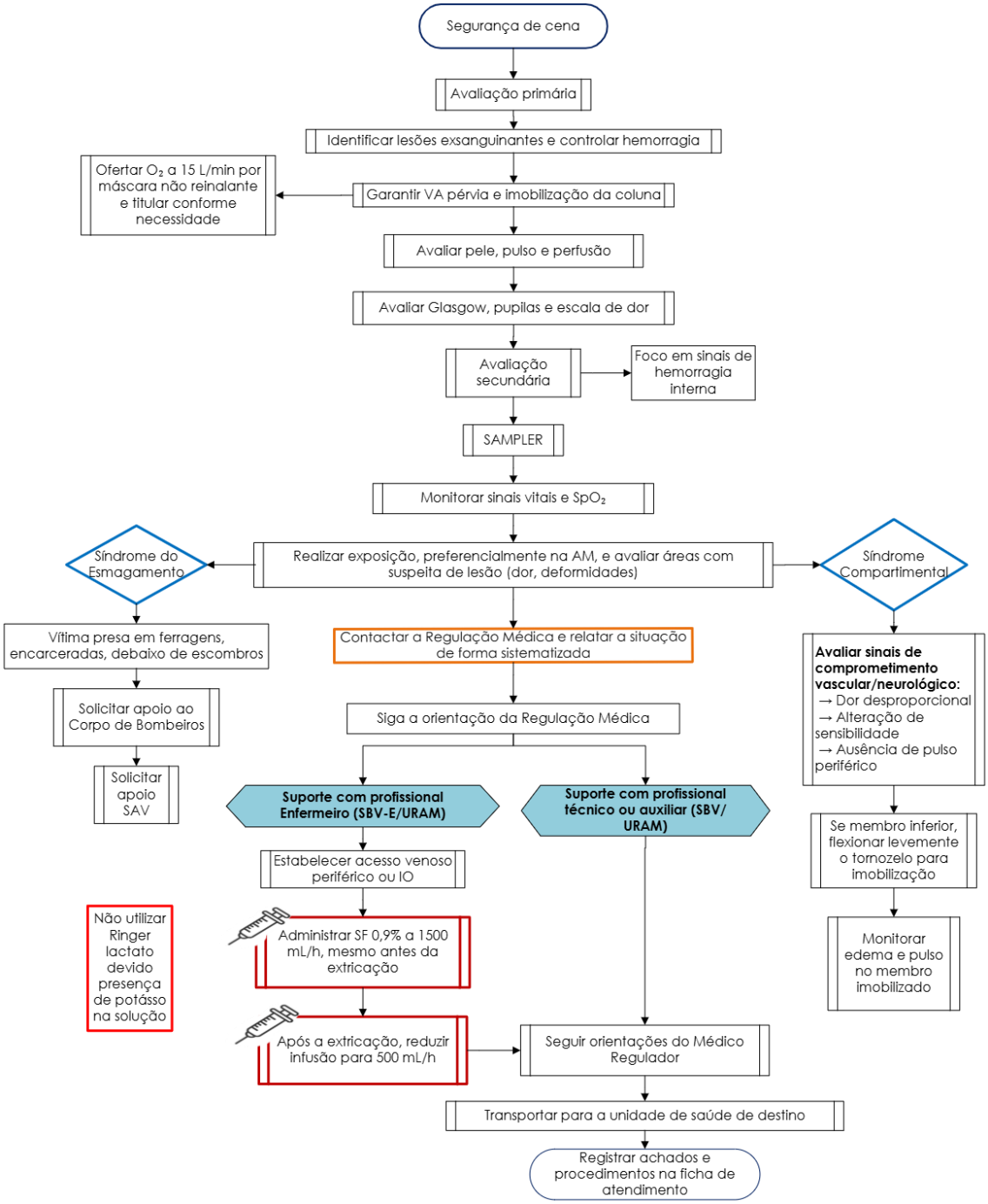
6.3. POP IAPH SBV E SBV-E 048 Choque Hemorrágico.

6.4. POP IAPH SBV E SBV-E 045 Avaliação e Manejo da dor e Vômitos.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA - TRAUMA MUSCULOESQUELÉTICO



9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. PHTLS. Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado. National Association of Emergency Medical Technician, 2021. 10ª edição. 801 páginas.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Ampliação e detalhamento das definições clínicas. 2. Inclusão do conceito e manejo inicial de extricação. 3. Atualização das equipes envolvidas no atendimento. 4. Reorganização do fluxo assistencial conforme abordagem XABCDE. 5. Padronização da avaliação da cinemática do trauma e segurança de cena. 6. Atualização das condutas de oxigenoterapia e avaliação de choque. 7. Inclusão de protocolos institucionais específicos para imobilização de pelve e extremidades. 8. Detalhamento do manejo específico da síndrome do esmagamento e síndrome compartimental. 9. Padronização da abordagem medicamentosa sob autorização da Regulação Médica.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Ana Midori Harada Celina H. H. Vasconcelos	Bárbara de Souza Mateus D. Miachon	Nádia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. Queimaduras são feridas traumáticas causadas, na maioria das vezes, por agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos. Atuam nos tecidos de revestimento do corpo humano, determinando destruição parcial ou total da pele e seus anexos, podendo atingir camadas mais profundas, como tecido subcutâneo, músculos, tendões e ossos.

Classificação:

1.2. Queimaduras Superficiais – atingem a epiderme, ocasionando hiperemia, dor e bolhas. Essa lesão não é incluída no cálculo de reposição volêmica.

1.3. Queimaduras de Espessura Parcial – atingem a epiderme e parte da derme, ocasionando bolhas ou áreas cruentas, base de aspecto brilhante ou úmido, hiperemia e dor.

1.4. Queimaduras de Espessura Completa – destruição completa da epiderme e derme (espessa, seca, branca e aspecto coriáceo). A dor pode estar presente.

1.5. Queimaduras Subdérmicas – atingem tecidos profundos como gordura, músculo, ossos e órgãos, podendo ocasionar necrose tecidual.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever a abordagem pré-hospitalar à vítima de queimadura.

3. EQUIPES ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e Central de Regulação.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Avalie a segurança da cena antes de acessar a vítima;

4.2. Solicite apoio do Corpo de Bombeiros em situação de risco para a equipe;

4.3. Afaste a vítima do agente causador e interrompa o processo de queimadura com irrigação abundante de água ou SF 0,9 % em temperatura ambiente.

4.4. Retire roupas e adereços que não estiverem grudados;

4.5. Realize avaliação primária e intervenha conforme achados:

4.6. **X –** Identifique e controle todas as lesões exsanguinantes (POP IAPH SBV E SBV-E 091 Controle de Hemorragia Externa);

4.7. **A –** Identifique a presença de rouquidão, fuligem no rosto e/ou escarro carbonáceo e considere a possibilidade de obstrução das vias aéreas por edema.

4.7.1. Administre oxigênio por máscara não reinalante 15l/min e observe a resposta;

4.7.2. Se suspeita de intoxicação inalatória por monóxido de carbono e/ou cianeto seguir POP IAPH SBV e SBV-E 046 Atendimento nas Intoxicações Agudas.

4.7.3. Solicite apoio do SAV;

4.7.4. Estabilize manualmente a coluna cervical nas vítimas de trauma.

ATENÇÃO

4.7.5. Vítimas com suspeita de lesão traumática encontrada em:

4.7.6. Decúbito dorsal: imobilize manualmente a coluna e continue avaliação primária.

4.7.7. Decúbito ventral ou lateral: imobilize manualmente a coluna, realize o rolamento diretamente na prancha.

4.8. **B –** Realize avaliação do tórax:

4.8.1. Na presença de lesões circunferenciais no tórax e/ou irregularidades do padrão respiratório no mecanismo associado ao trauma, solicite apoio do SAV.

4.9. **C –** Realize avaliação da circulação (pele, pulso e perfusão):

4.9.1. Identifique os sinais de choque hipovolêmico: palidez cutânea, sudorese fria, pulso rápido e fino e perfusão maior que dois segundos;

<u>Abordagem medicamentosa apenas na presença do enfermeiro (SBV-E/ URAM)</u>

4.9.2. Puncione acesso venoso periférico ou IO, se possível, fora da área lesionada;

4.9.3. Calcule a porcentagem da superfície corporal queimada (SCQ), utilizando a "regra dos 9": braço 9%, perna 18%, tronco 36%, cabeça 9%, períneo 1% (Figura 1);

4.9.4. Inicie a reposição volêmica conforme a fórmula de Parkland: **2 ml de Ringer Lactato x Peso do paciente (kg) x % SCQ.**

4.9.5. Administre metade do volume total nas primeiras 8 horas, e o volume restante nas 16 horas subsequentes;

4.9.6. Se dor, consultar Protocolo IAPH 045 Avaliação e Manejo da Dor e Vômitos.

4.9.7. Avalie o ritmo cardíaco nas vítimas de choque elétrico, através da palpação do pulso e posteriormente monitorização cardíaca;

4.10. **D –** Aplique a Escala de Coma de Glasgow e avalie as pupilas;

4.11. **E –** Realize a exposição da vítima, de preferência dentro da ambulância;

4.11.1. Cubra todas as lesões térmicas com plástico de evisceração;

4.11.2. Utilize o plástico de evisceração em sua totalidade (não corte);

4.11.3. Cubra a vítima com manta aluminizada;

4.12. Realize contato com a Regulação Médica para passagem sistematizada das informações;

4.13. Realize o transporte para a unidade de saúde de destino indicada pela Regulação Médica.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. A cobertura das lesões térmicas com o plástico de evisceração previne ressecamento, alivia a dor e reduz o risco de contaminação. É essencial que a mochila contenha quantidade suficiente desse material para atender a casos de queimaduras de grande extensão, inclusive de corpo inteiro. Portanto, verifique o tamanho e a quantidade dos protetores durante o checklist.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

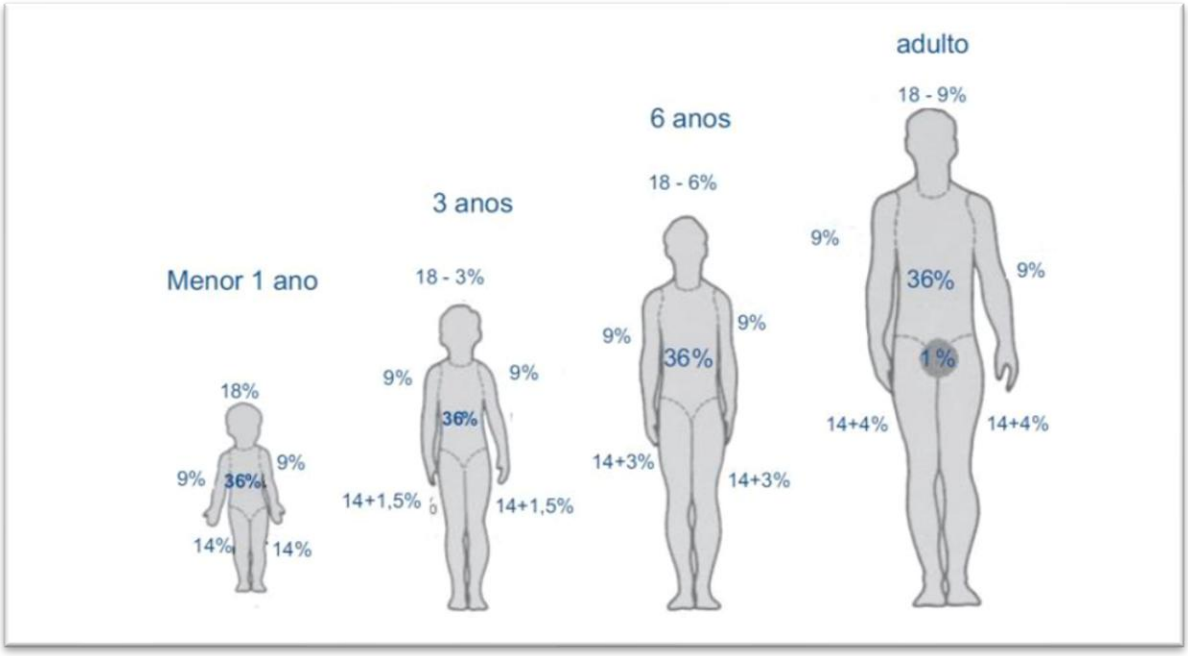
6.1. POP IAPH SBV E SBV-E 091 Controle de Hemorragia Externa

6.2. POP IAPH SBV e SBV-E 046 Atendimento nas Intoxicações Agudas

6.3. Protocolo IAPH 045 Avaliação e Manejo da Dor e Vômitos.

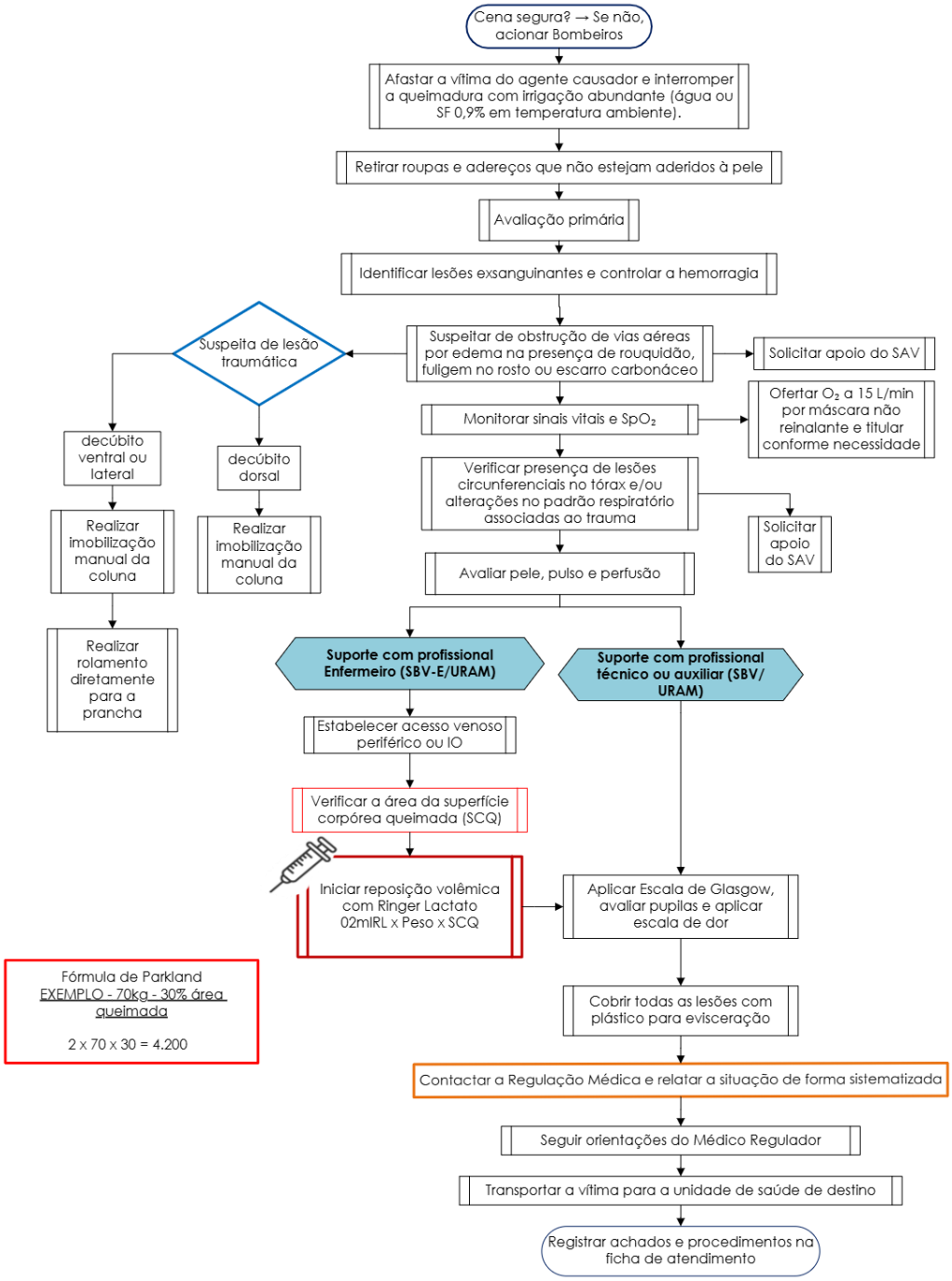
7. ANEXOS

7.1. **Figura 1**: Regra dos nove, esquema representativo de acordo com a idade



Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA PLÁSTICA (SBCP). Projeto Diretrizes. Queimaduras: Diagnóstico e Tratamento Inicial. 2008

8. **FLUXOGRAMA** Atendimento a vítima de queimadura



9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS (NAEMT). PHTLS — Atendimento Pré-hospitalar ao Traumatizado. 10. ed. São Paulo: Artmed (Jones & Bartlett), 2025. 864 p.

9.2. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA PLÁSTICA (SBCP). Queimaduras: Diagnóstico e Tratamento Inicial. Projeto Diretrizes: Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina. 2008.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Atualização do nome do protocolo, passando a denominar-se Atendimento à Vítima de Queimadura. 2. Padronização da abordagem pré-hospitalar, com sequência clara de segurança de cena, avaliação primária (XABCDE) e intervenções. 3. Maior detalhamento da avaliação das vias aéreas. 4. Aprimoramento da abordagem circulatória. 5. Organização da reposição volêmica, mantendo a fórmula de Parkland, porém com descrição mais clara do cálculo e do tempo de infusão. 6. Atualização da conduta analgésica. 7. Padronização da cobertura das lesões térmicas, com destaque para o uso correto do plástico de evisceração e suas finalidades. 8. Inclusão de observações operacionais, reforçando checklist de materiais e segurança assistencial.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Edna Barbosa da Silva	Ana Midori Harada Elaine C. S. M. Machado Marcia Rosa de S. Lopes Simone Cedano Ramos	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nádia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. A Organização Mundial de Saúde define afogamento como a aspiração de líquido não corporal causada por submersão ou imersão. Ocorre quando a vítima é incapaz de respirar adequadamente devido a presença de líquido nas vias aéreas, impedindo a troca gasosa e ocasionando hipóxia.

1.2. O manejo deve ser direcionado na reversão rápida da hipoxemia e subsequente hipóxia tecidual, especialmente cerebral, evitando parada cardíaca ou danos cerebrais;

2. OBJETIVO

2.1. Descrever os sinais, sintomas e a abordagem pré-hospitalar realizada pela equipe de SBV e SBV-E à vítima de afogamento.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e Central de Regulação.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Realize a avaliação da segurança de cena;

4.1.1. Não entre na água para realizar o atendimento;

4.1.2. Solicite apoio do Corpo de Bombeiros nos casos de vítimas ainda submersas;

4.2. Avalie a responsividade;

Vítima inconsciente:

4.3. Verifique se há presença do pulso carotídeo e movimentos respiratórios por 5 a 10 segundos;

4.4. Na ausência de pulso e respiração, inicie 5 ventilações de regaste com bolsa válvula máscara a 15l/min de oxigênio no adulto e 8l/min na criança, seguidas por 30 compressões torácicas continuando com duas ventilações depois disso (30:2) - Protocolo POP IAPH SBV e SBV-E - 029- Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) no adulto ou se criança, POP IAPH SBV e SBV-E- 058-Parada Respiratória e Cardiorrespiratória na Criança;

Vítima consciente ou inconsciente que respira e tem pulso central:

4.5. Realize avaliação primária e intervenha conforme achados:

4.6. **X –** Se presença de lesões exsanguinantes, controle a hemorragia;

4.7. **A –** Garanta a permeabilidade das vias aéreas;

4.8. Estabilize a coluna cervical e utilize os dispositivos para imobilização em vítimas com suspeita de lesão raquimedular (por exemplo: mergulho em águas rasas) ou outro tipo de trauma;

4.9. Atente-se para a ocorrência de regurgitação ou vômitos;

4.10. **B –** Avalie o padrão respiratório e intervenha conforme alterações:

4.11. Verifique se o paciente tosse e apresenta saída de espuma pela boca e nariz; se houver, administre oxigênio por máscara não reinalante para manter saturação acima de 94%;

4.12. Na presença do enfermeiro, realize a ausculta pulmonar e atente-se para estertores, devido ao risco de edema pulmonar agudo;

4.13. Na presença de estertores, mantenha oxigênio à 15l/min por máscara não reinalante;

4.14. **C –** Avalie pele, perfusão e pulso;

4.15. Atente-se para sinais de choque por hipotermia (pele fria, pálida, cianótica, enchimento capilar lentificado, pulso filiforme, taquicardia inicial seguido de bradicardia);

4.16. Inicie a reposição volêmica permissiva, de preferência com RL aquecido afim de manter uma PAS de 90 mmHg;

Atenção

4.17. Como os sinais vitais podem ter diminuído a um nível quase imperceptível, a impressão inicial dos pacientes hipotérmicos pode ser a de que estão mortos. Os profissionais de atendimento pré-hospitalar que cuidam de pacientes com hipotermia não devem interromper as intervenções de tratamento e declarar o paciente morto até que o paciente tenha sido reaquecido a mais de 35°C

4.18. **D –** Avalie o nível de consciência e as pupilas;

4.19. **E –** Evite ainda mais a perda de calor corporal;

4.19.1. Retire as roupas molhadas;

4.19.2. Seque a vítima;

4.19.3. Cubra com manta aluminizada ou cobertor seco;

4.20. Realize avaliação secundária com ênfase em:

4.20.1. Monitore sinais vitais e saturação;

4.20.2. Administre O_2 15l/min por máscara não-reinalante independente da saturação;

4.20.3. Se glicemia < 70mg/dl, realize a correção conforme POP IAPH SBV E SBV-E 038 – Hipoglicemia;

4.20.4. Realize o SAMPLER com ênfase na pesquisa de: alergias, medicamentos em uso, passado médico, líquidos e/ou alimentos ingeridos, eventos que precederam o afogamento e riscos associados;

4.21. Realize contato com a Regulação Médica para a passagem sistematizada das informações;

4.22. Siga as orientações da Regulação Médica para procedimentos, abordagem medicamentosa e/ou transporte para unidade de saúde de destino;

4.23. Realize o transporte para a unidade de saúde de destino indicada pela Regulação Médica, com a vítima em decúbito lateral (exceto nos casos de trauma);

4.23.1. Todas as vítimas de submersão, ainda que assintomáticas, deverão ser encaminhadas para a unidade de saúde;

4.23.2. Desligue o ar-condicionado da ambulância;

4.23.3. Informe o tempo de submersão da vítima na passagem de plantão à unidade de saúde;

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não há.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP IAPH SBV e SBV-E -029- Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) no adulto

6.2. POP IAPH SBV e SBV-E- 058-Parada Respiratória e Cardiorrespiratória na Criança;

6.3. POP IAPH SBV E SBV-E 038 – Hipoglicemia;

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. PHTLS. Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado. National Association of Emergency Medical Technician, 2021. 9ª edição. 762 páginas.

9.2. PHTLS. Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado. National Association of Emergency Medical Technician, 2023. 10ª edição. 811 páginas.

9.3. Protocolo de Atendimento Pré-Hospitalar: Suporte Intermediário de Vida. São Paulo: Secretaria Municipal de Saúde – SAMU, 2022; 5ª. Edição 391 p.

9.4. SZPILMAN, D. "Recommended technique for transportation of drowning victim from water and positioning on a dry site varies according to level of consciousness" recomendações mundiais em emergências junto a American Heart Association (AHA) e International Liaisson Comittee for ressuscitation (ILCOR), Budapest, Setembro de 2004.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Atualização da definição conforme Organização Mundial da Saúde, com foco na hipóxia como principal agravo. 2. Adequação do objetivo para contemplar sinais, sintomas e abordagem pré-hospitalar atual. 3. Padronização da segurança de cena e acionamento do Corpo de Bombeiros. 4. Estratificação da abordagem conforme nível de consciência, respiração e pulso. 5. Reforço das medidas de prevenção da hipotermia. 6. Qualificação da avaliação secundária e da monitorização contínua.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Elaine C. S. M. Machado Simone Cedano Ramos	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. A obstrução das vias aéreas por corpo estranho (OVACE) consiste na obstrução da passagem de ar pelas vias aéreas, causada pela aspiração de um corpo estranho, geralmente localizada na laringe ou traqueia. Essa obstrução pode ser classificada como parcial ou total:

1.1.1. Obstrução parcial: a vítima apresenta alguma troca gasosa e ainda consegue tossir (o ar ainda consegue passar);

1.1.2. Obstrução total: não há mais passagem de ar, a troca gasosa torna-se ineficaz, a vítima apresenta tosse ineficaz, ruídos respiratórios estridentes, dificuldade respiratória acentuada e cianose.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever os sinais, sintomas e a abordagem pré-hospitalar realizada pela equipe de SBV e SBV-E à vítima com OVACE.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e Central de Regulação.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Realize a avaliação da segurança da cena;

4.2. Realize avaliação primária e intervenha conforme achados:

Se obstrução parcial:

4.3. Não interfira e estimule a vítima a tossir;

4.4. Se saturação < 94%, oferte oxigênio 8l/min por máscara não reinalante;

Se obstrução total no bebê (até 1 ano) consciente:

4.5. Explique o procedimento ao responsável, e posicione o bebê em decúbito ventral (de bruços) no antebraço do socorrista;

4.6. Apoie o antebraço que está segurando o bebê na coxa do socorrista mantendo a cabeça do bebê mais baixa do que o corpo, atentando-se para abertura da boca (Figura 1);

4.7. Realize 5 golpes entre as escápulas (no meio das costas);

4.8. Vire o bebê de barriga para cima, no outro antebraço, e realize 5 compressões torácicas com a base de uma mão;

4.9. Repita as manobras até desobstrução ou o bebê tornar-se inconsciente.

Figura 1: Posicionamento do bebê para realização da manobra de desengasgo

Fonte: Reprodução/AHA

Se obstrução total para crianças maiores de 1 ano conscientes:

4.10. Explique o procedimento ao responsável e posicione-se atrás e na altura da criança;

4.11. Apoie uma das mãos no tórax anterior da criança e incline-a levemente para frente (Figura 2);

4.12. Aplique 5 golpes firmes entre as escápulas (no meio das costas);

4.13. Se o corpo estranho não sair, realize 5 compressões abdominais;

4.13.1. Envolva-a com os braços na altura da cintura;

4.13.2. Feche uma das mãos com a face do polegar voltado para a parede abdominal e posicione-a na região superior do abdome, entre o umbigo e a caixa torácica. A outra mão, espalmada, deve ser posicionada sobre a primeira;

4.13.3. Inicie as compressões com movimentos "para dentro e para fora" (como uma letra "J" invertida) (Figura 3);

4.13.4. As manobras devem ser repetidas até que ocorra a desobstrução ou que a vítima se torne inconsciente.

Figura 2: Posicionamento do socorrista para realização dos golpes dorsais

Figura 3: Posicionamento do socorrista para realização das compressões abdominais

Se obstrução total do bebê e da criança inconsciente:

4.14. Posicione o bebê ou a criança em decúbito dorsal horizontal em uma superfície rígida;

4.15. Realize 30 compressões torácicas (se apenas 1 socorrista) ou 15 compressões (se houver 2 socorristas);

4.16. Se bebê menor de 1 ano, realize compressões com dois polegares, com as mãos circundando o tórax. (Figura 4A);

4.17. Caso o socorrista não consiga envolver o tórax, deve comprimir com a base de uma das mãos (Figura 4B);

4.18. Criança com mais de 1 ano, utilize a técnica de compressão com a base de uma das mãos (Figura 5);

Figura 4: Posicionamento das mãos para compressão torácica no bebê

Figura 5: Posicionamento da mão para compressão torácica na criança maior de 1 ano.

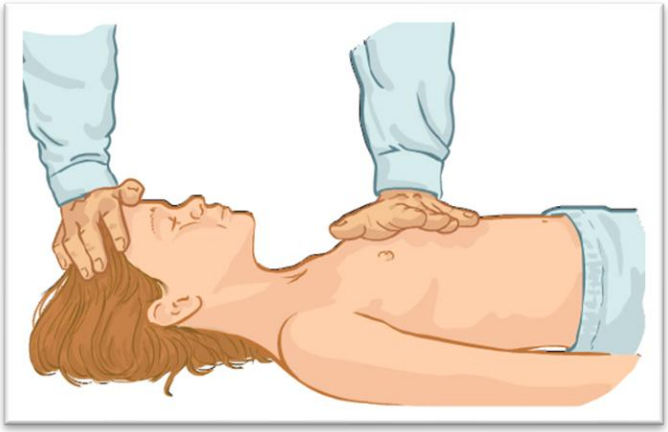


Figura: https://unasus2.moodle.ufsc.br/pluginfile.php/16346/mod_resource/content/1/un03/top01p02.html

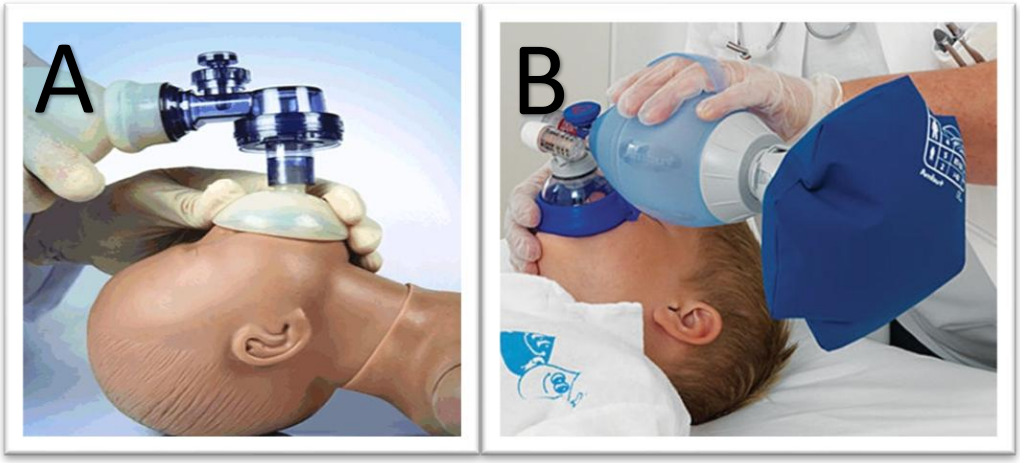
4.19. Realize abertura das vias aéreas e observe a cavidade oral:

4.19.1. Se visualizar o corpo estranho e se este estiver acessível, remova-o com os dedos em forma de pinça;

4.19.2. Se nada for visualizado, realize uma ventilação com bolsa-válvula-máscara (Figura 6); se o ar não passar ou o tórax não expandir, reposicione a cabeça e realize outra ventilação com bolsa-válvula-máscara; se o ar ainda não passar, realize 30 compressões torácicas (se apenas 1 socorrista) ou 15 compressões (se houver 2 socorristas);

4.20. Repita as manobras até que o corpo estranho seja expelido ou a via aérea se torne pérvia;

Figura 6: Ventilação com bolsa-válvula-máscara no bebê (A) e na criança maior de 1 ano (B).



4.21. Quando as vias aéreas se tornarem pérvias, coloque a vítima em decúbito lateral e oferte oxigênio 5 a 8l/min por máscara não reinalante;

4.22. Realize o SAMPLER, com ênfase para pesquisa dos sinais e sintomas, alergias, histórico de saúde e medicamentos em uso;

4.23. Realize contato com a Regulação Médica para a passagem sistematizada das informações;

4.24. Siga as orientações da Regulação Médica para procedimentos e/ou transporte para unidade de saúde de destino;

4.25. Realize o transporte para a unidade de saúde de destino indicada pela Regulação Médica, com a vítima em decúbito elevado;

4.26. Registre os achados e procedimentos realizados na Ficha de Atendimento.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não há.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

9.1. AMERICAN HEART ASSOCIATION; AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS. 2025 Guidelines for Pediatric Advanced Life Support (PALS). Dallas: AHA, 2025.

9.2. PALS. Suporte Avançado de Vida em Pediatria. Editora Elsevier. 5ª Edição. 2020. 528 páginas.

9.3. SBP. Sociedade Brasileira de Pediatria. Aspiração de corpo estranho. 2023. Disponível em: https://www.sbp.com.br/especiais/pediatria-para-familias/prevencao-de-acidentes/aspiracao-de-corpo-estranho/.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Alteração do nome do protocolo, passando de **"Atendimento da Criança Vítima de OVACE"** para **"Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho (OVACE) na Criança"**. 2. Atualização da definição, com classificação clara da OVACE em obstrução parcial e total. 3. Ampliação das equipes envolvidas, incluindo URAM. 4. Padronização da avaliação inicial, com ênfase em segurança de cena e avaliação primária. 5. Conduta mais conservadora na obstrução parcial, orientando não interferir e estimular a tosse. 6. Reorganização das manobras por faixa etária, diferenciando bebê até 1 ano e criança maior de 1 ano. 7. Padronização do número de golpes dorsais e compressões, conforme diretrizes atuais. 8. Atualização das condutas na inconsciência, alinhadas aos protocolos de RCP. 9. Inclusão do SAMPLER e reforço da comunicação com a Regulação Médica. 10. Padronização do transporte, oxigenoterapia e registro em ficha de atendimento.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Carla Cristine A. Bezerra Daiane C. de Moraes Elaine C. S. Melo Machado	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.2. Parada respiratória (PR) é a cessação súbita dos movimentos respiratórios ou respiração ineficaz (*gasping*), podendo ou não evoluir para parada cardíaca. Caracteriza-se pela ausência de respiração, presença de cianose e perda do nível de consciência.

1.3. Parada cardiorrespiratória (PCR) na criança é a interrupção súbita e simultânea da atividade respiratória e da circulação sanguínea eficaz, caracterizada por inconsciência, ausência de respiração ou respiração ineficaz e ausência de pulso palpável ou pulso ≤ 60 bpm com perfusão inadequada.

1.4. Cadeia de sobrevivência única na PCR

Fonte: Destaques das diretrizes para RCP e ACE de 2025 da American Heart Association.

2. OBJETIVO

2.2. Descrever os sinais que determinam a PR e a PCR na criança e a abordagem pré-hospitalar realizada pela equipe assistencial à vítima nessas condições.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.2. SBV, SBV-E, URAM e Central de Regulação.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

Parada respiratória

4.2. Realize avaliação da segurança de cena;

4.3. Realize a avaliação primária e intervenha conforme os achados;

4.4. Avalie a responsividade;

4.5. Deite a vítima em uma estrutura plana e rígida;

4.6. Realize a abertura das vias aéreas (utilize um coxim);

4.7. Identifique a ausência de respiração ou respiração ineficaz;

4.8. Instale a cânula orofaríngea se indicado;

4.9. Realize 1 ventilação com bolsa-válvula-mascara a cada 3 segundos com oxigênio de 5 a 8l/min;

4.10. Reavalie a cada 2 minutos.

Parada cardiorrespiratória

4.11. Realize avaliação da segurança de cena;

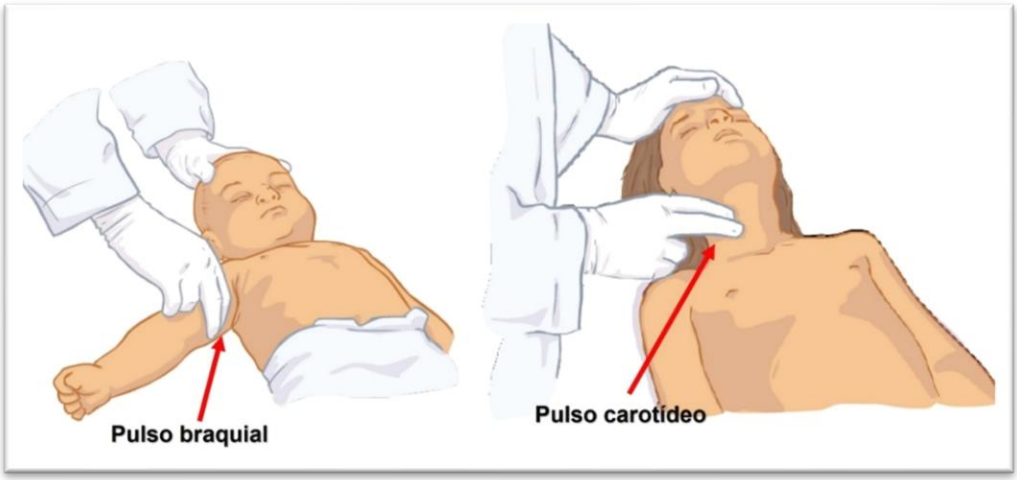
4.12. Realize a avaliação primária e intervenha conforme os achados;

4.13. Avalie a responsividade;

- Se criança < 1 ano: realize estímulo na planta do pé;
- Se criança > 1 ano: chame e toque nos ombros;

4.14. Verifique se há presença de pulso central (ou pulso central ≤ 60 bpm com perfusão inadequada) e movimentos respiratórios por 5 a 10 segundos, e confirme a PCR;

- Se criança < 1 ano: verifique o pulso braquial;
- Se criança > 1 ano: verifique o pulso carotídeo;



4.15. Deite a vítima em uma estrutura plana e rígida;

4.16. Inicie as compressões/ ventilações na relação 30:2 na presença de 2 socorristas ou 15:2 com 1 socorrista;

4.17. Comprima o tórax na profundidade ≥ 1/3 do diâmetro torácico anteroposterior;

4.18. Permita o completo retorno do tórax após cada compressão;

4.19. Minimize as interrupções nas compressões;

4.20. Mantenha frequência de 100 a 120 compressões por minuto;

4.21. Realize o revezamento do profissional que aplica a compressão a cada 2 minutos;

4.22. Ventile com bolsa-válvula-máscara ligada à fonte de oxigênio de 5 a 8l/min;

4.23. Solicite apoio à Central de Regulação;

4.24. Instale as pás do DEA assim que possível:

- 25 kg (> 8 anos) pás de DEA adulto;
- < 25 kg (1 a 8 anos de idade) pás de DEA infantil;
- < 1 ano: carga pediátrica (SAV – solicite apoio).

4.25. Ligue o equipamento e escute as orientações sonoras;

4.26. Se ritmo chocável: administre o choque de acordo com as instruções do DEA;

4.27. Reinicie a RCP imediatamente após o choque;

4.28. Se ritmo não chocável: verifique se há presença de pulso central;

4.29. Reinicie a RCP;

Manobras de compressão cardíaca

4.30. **Se criança < 1 ano**: com as duas mãos circule o tórax da criança e com um polegar sobre o outro realize as compressões, OU posicione uma das mãos no centro do tórax utilizando a região tênar e hipotênar;

4.31. **Se Criança > 01 ano:** posicione uma das mãos no centro do tórax (linha axiliar) e inicie as compressões;

Fonte: https://papodemae.uol.com.br/noticias/dicas-de-primeiros-socorros-para-salvar-vidas-de-bebes-e-criancas.html

<u>Na presença do enfermeiro no SBV-E/URAM</u>

4.32. Considere a instalação do dispositivo supra glótico e aplique 1 ventilação a cada 3 segundos;

4.33. Mantenha as compressões torácicas contínuas por 2 minutos;

4.34. Puncione acesso venoso e/ou IO para abordagem medicamentosa:

4.35. Prepare **solução de 10 ml (9 ml de SF 0,9% + 1mg de Epinefrina)**

4.35.16. **Administre 0,01 mg/kg** (repita a cada 3 a 5 minutos);

4.35.17. Administre flush de 10 ml de SF 0,9% após infusão da epinefrina e eleve o membro se infusão EV;

4.36. **Administre Amiodarona 5mg/Kg EV, em bolus** após o 3º choque:

4.36.16. Administre flush de 10 ml de SF 0,9% após infusão da amiodarona e eleve o membro se infusão EV;

4.36.17. A Amiodarona pode ser repetida até 3 (três) vezes se FVTV sem pulso refratárias ao choque.

4.37. Realize contato com o Médico Regulador (MR) para a passagem sistematizada das informações;

4.38. Transporte para a unidade de saúde conforme indicação do MR.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.2. Diluição da epinefrina:

Aspire 1 ml da epinefrina 1:1.000 (1 mg)

Adicione em 9 ml de SF 0,9%

Total: 10 ml → concentração = 0,1 mg/ml (1:10.000)

5.1.1. Fórmula:

Peso (kg) × 0,1 ml = dose em ml

5.1.2. Exemplos:

Peso	Dose (ml)	Dose (mg)
5 kg	0,5 ml	0,05 mg
10 kg	1,0 ml	0,1 mg
15 kg	1,5 ml	0,15 mg
20 kg	2,0 ml	0,2 mg
30 kg	3,0 ml	0,3 mg

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

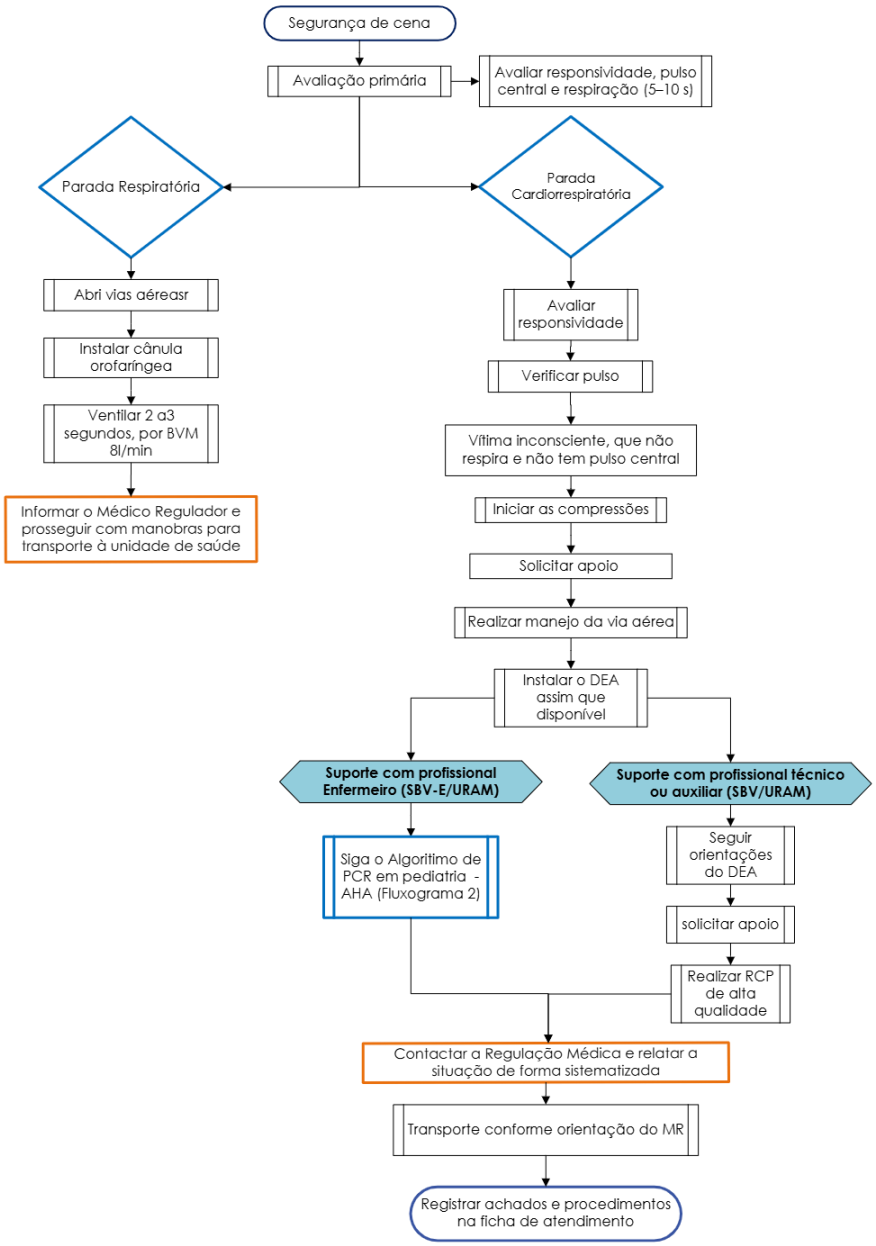
6.1. Não há.

7. ANEXOS

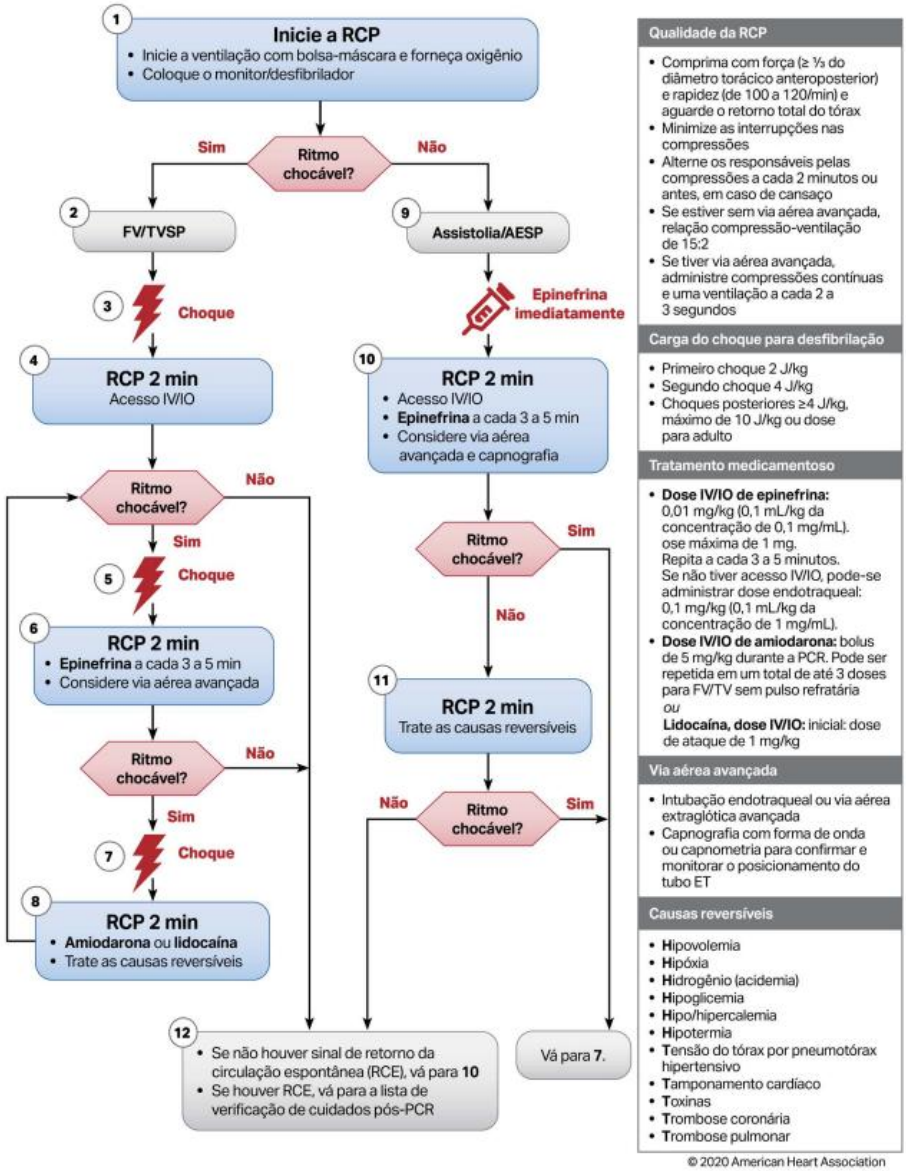
7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMAS

8.1. Fluxograma 1 – Parada Respiratória e Cardiorrespiratória na Criança



8.2. Fluxograma 2 - Algoritmo de PCR em pediatria.



Fonte da imagem do fluxograma: Retirada do site da **American Heart Association**, Diretrizes de Ressuscitação 2020. Disponível em: *https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/cpr-guidelines-files/highlights/hghlghts_2020eccguidelines_portuguese.pdf*. Acesso em 21 out. 2025.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. AMERICAN HEART ASSOCIATION. PALS: Suporte avançado de vida em pediatria. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020. 528 p.

9.2. LUCENA, Aline Thomaz da Conceição et al. Reanimação cardiopulmonar em pediatria e neonatal: a evolução dos cuidados ao longo da história. Research, Society and Development, v. 11, n. 14, p. e308111436313, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i14.36313.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Adequação do objetivo do protocolo. 2. Reorganização e padronização das definições de parada respiratória e parada cardiorrespiratória, alinhadas às diretrizes atuais do PALS. 3. Maior detalhamento da avaliação inicial. 4. Padronização das condutas na parada respiratória, com reforço da ventilação adequada por BVM, prevenção de hiperventilação e comunicação precoce com a Regulação Médica. 5. Atualização e detalhamento do atendimento à PCR, com ênfase no início imediato das compressões, uso correto do DEA conforme peso e idade, e manutenção da qualidade da RCP. 6. Atualização das técnicas de compressão torácica conforme faixa etária, alinhadas às recomendações atuais. 7. Padronização da atuação na presença do enfermeiro no SBV-E/URAM, com uso de dispositivo supraglótico, ventilação contínua e manutenção da frequência adequada de compressões. 8. Atualização da terapêutica medicamentosa.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Carla Cristine A. Bezerra Daiane C. de Moraes Daiane M.F. de Souza Henrique CSAL Costa Filho José Caruso Simone Cedano Ramos Wesley Almeida Santos	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Asma é uma doença pulmonar inflamatória crônica, caracterizada pela contração da musculatura lisa dos brônquios, resultando em estreitamento brônquico, tosse, dispneia, opressão torácica e sibilos associados. A exacerbação da asma é a piora progressiva dos sintomas, podendo evoluir para parada respiratória/parada cardiorrespiratória.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever os sinais, sintomas e a abordagem pré-hospitalar realizada pela equipe de SBV e SBV-E à criança com exacerbação da asma.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E e CRU.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Realize a avaliação da segurança de cena;

4.2. Realize avaliação primária e intervenha conforme achados:

4.2.1. Mantenha a criança em decúbito elevado;

4.2.2. Reduza esforços e fatores estressores;

4.2.3. Permita que a criança fique no local que se sente mais segura (ex.: colo do cuidador).

4.3. Realize avaliação secundária com ênfase em:

4.3.1. Monitore sinais vitais e saturação;

4.3.2. Se saturação < 94%, oferte O_2 8l/min por máscara não reinalante;

4.4. Realize o SAMPLER, com ênfase para pesquisa dos sinais e sintomas, alergias, histórico de saúde e medicamentos em uso;

4.5. Considere vítima grave se: histórico de asma, presença de tosse, dispneia ou taquipneia com uso da musculatura acessória, cianose, sudorese e/ou alteração de nível de consciência.

4.6. Realize contato com a Regulação Médica para a passagem sistematizado das informações;

4.7. Siga as orientações do Médico Regulador para procedimentos, abordagem medicamentosa e/ou transporte para a unidade de saúde de destino;

Abordagem medicamentosa em SBV-E

<u>SBV sob autorização da Regulação Médica:</u>

4.8. Administre Salbutamol 400 mcg (04 puffs) para crianças em crise e que já façam uso de broncodilatador, com uso do espaçador.

4.9. Após 20min, se não houver melhora repita a dose de 400mcg (4 puffs) de Salbutamol;

ATENTE-SE ao uso do espaçador:

4.10. Agite o inalador, encaixe-o no espaçador e libere 1 jato do medicamento para preenchê-lo;

4.11. Posicione a máscara de forma vedada no rosto (nariz e boca) do paciente;

4.12. Peça para o paciente inspirar profundamente pela boca ao aplicar o Salbutamol, mantendo o espaçador por 10 segundos no rosto do paciente;

4.13. Entre um jato e outro aguarde 30 segundos de intervalo.

Obs.: Se possível, solicite auxílio do cuidador para administrar a medicação

4.14. Realize o transporte para a unidade de saúde de destino indicada pela Regulação Médica;

4.15. Registre os achados e procedimentos realizados na Ficha de Atendimento.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. A equipe de Suporte Básico de Vida (SBV) somente poderá intervir com ação medicamentosa após autorização do médico regulador.

5.2. Os inaladores de salbutamol são destinados apenas ao uso individual do paciente. A segurança do uso do mesmo inalador de salbutamol por vários pacientes não foi estabelecida.

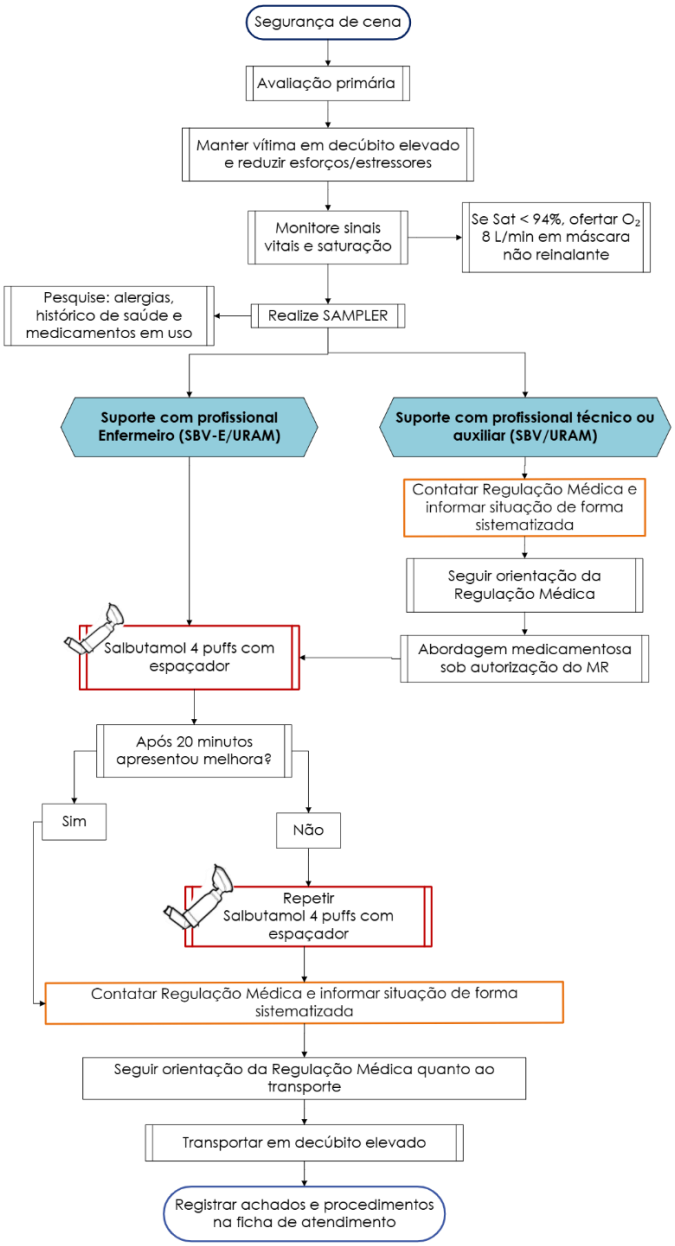
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA: Abordagem em SBV na Exacerbação da asma na criança



9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. PALS. Suporte Avançado de Vida em Pediatria. Editora Elsevier. 5ª Edição. 2020. 528 páginas.

9.2. Sociedade Brasileira de Pediatria – III Consenso Brasileiro no manejo da Asma – J. Pneumologia, 2002

9.3. GLAXOSMITHKLINE. Salbutamol Sulphate Inhaler: bula do usuário. Reino Unido: GlaxoSmithKline, 2025. Disponível em: https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.15454.pdf

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Ampliação do escopo do protocolo, que passou de crise asmática na criança para exacerbação da asma no recém-nascido, lactente e criança, com adequação às diretrizes pediátricas. 2. Atualização das áreas envolvidas, com adequação à organização operacional vigente (SBV, SBV-E e CRU). 3. Padronização da abordagem medicamentosa, com definição clara de dose, intervalo e técnica correta de administração do salbutamol com espaçador, alinhada às boas práticas. 4. Reforço da comunicação com a Regulação Médica, da necessidade de autorização para intervenção medicamentosa pelo SBV e da padronização do registro em ficha de atendimento.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Henrique CSAL Costa Filho José Caruso Simone Cedano Ramos Wesley Almeida Santos	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nádia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Anafilaxia é uma reação de hipersensibilidade aguda potencialmente fatal. Inclui sinais e sintomas, isolados ou combinados, que ocorrem em minutos ou em até poucas horas após a exposição ao agente causador, sendo eles: urticária, angioedema, sintomas respiratórios, gastrintestinais, hipotensão arterial, síncope, dentre outros.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever os sinais, sintomas e a abordagem pré-hospitalar realizada pela equipe de SBV e SBV-E à criança em anafilaxia.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e CRU.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Realize a avaliação da segurança de cena;

4.2. Realize avaliação primária e intervenha conforme achados:

4.2.1. Afaste a vítima do agente desencadeante;

4.2.2. Atente-se para comprometimento respiratório (estridor, dispneia, broncoespasmo, hipoxemia);

4.2.3. Mantenha a criança em decúbito elevado e no local que se sinta mais confortável (por exemplo: no colo da mãe ou do cuidador);

4.2.4. Observe a presença de: urticas, prurido e/ou rubor, inchaço de lábios, língua ou úvula;

4.2.5. Atente-se para alterações circulatórias: síncope, hipotonia e sinais de choque;

4.3. Realize avaliação secundária com ênfase em:

4.3.1. Monitore sinais vitais e saturação;

4.3.2. Administre O_2 8l/min por máscara não reinalante independente da saturação;

4.4. Realize o SAMPLER, com ênfase para o tempo de início dos sinais e sintomas, agente causador, histórico de alergias, medicamentos em uso, passado médico e líquidos e alimentos ingeridos;

4.5. Considere vítima grave se houver: alteração na pele e/ou mucosas (urticas, prurido, rubor, edema de lábios, língua) e/ou alteração respiratória (dispneia, estridor, broncoespasmo, hipoxemia) e/ou alteração circulatória (hipotensão arterial, síncope, hipotonia, sinais de choque) e/ou sintomas gastrintestinais (dor abdominal, náuseas, vômitos);

4.6. Realize contato com a Regulação Médica para a passagem sistematizado de informações;

4.6.1. Informe se houver comprometimento das vias aéreas e necessidade de procedimentos invasivos para apoio;

4.6.2. Siga as orientações da Regulação Médica para procedimentos, abordagem medicamentosa e/ou transporte para a unidade de saúde de destino;

Abordagem medicamentosa na presença do enfermeiro (SBV-E) e em SBV sob autorização da Regulação Médica:

Caso a anafilaxia seja fortemente suspeita:

4.7. Administre epinefrina 0,01 mg/kg, (0,01ml/kg) por via intramuscular (IM), no vasto lateral da coxa (Anexo 1), e eleve os membros inferiores se tolerado:

4.7.1. Calcule a dose considerando 0,01 mg por quilograma de peso corporal da criança;

4.7.1.1. Dose máxima de 0,3 mg para lactentes e crianças;

4.7.1.2. Dose máxima de 0,5 mg para adolescentes com sinais de puberdade.

4.8. Mantenha o paciente em decúbito dorsal, com os membros inferiores elevados (posição de Trendelenburg), se tolerado;

4.9. Se não houver melhora do quadro clínico, repita a mesma dose de epinefrina IM após 10 minutos.

Se broncoespasmo

4.10. Administre Salbutamol 400 mcg (04 puffs) nas crianças em crise e que já façam uso de broncodilatador, com uso do espaçador;

4.11. Após 20 min, se não houver melhora, administre mais 400 mcg (04 puffs) – não atrase o transporte.

ATENTE-SE ao uso do espaçador:

4.12. Agite o inalador, encaixe-o no espaçador e libere 1 jato do medicamento para preenche-lo;

4.13. Posicione a máscara de forma vedada no rosto (nariz e boca) do paciente;

4.14. Peça para o paciente inspirar profundamente pela boca ao aplicar o Salbutamol, mantendo o espaçador por 10 segundos no rosto do paciente;

4.15. Entre um jato e outro aguarde 30 segundos de intervalo.

4.16. Realize o transporte para a unidade de saúde de destino indicada pela Regulação Médica, com a vítima em decúbito elevado;

4.17. Registre os achados e procedimentos realizados na Ficha de Atendimento.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

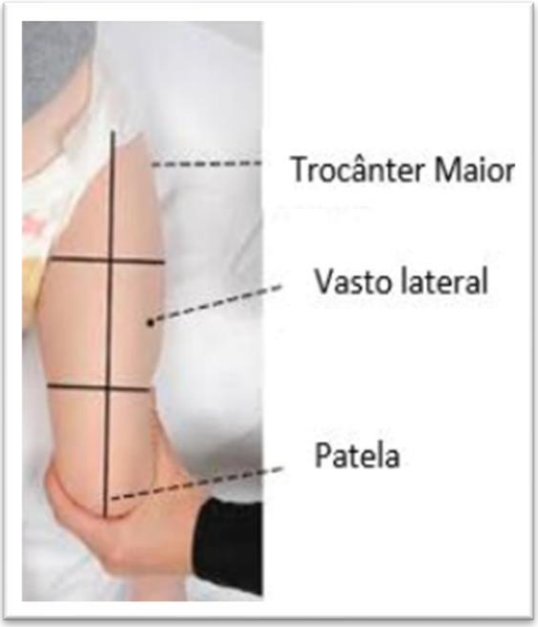
5.1. Não há.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

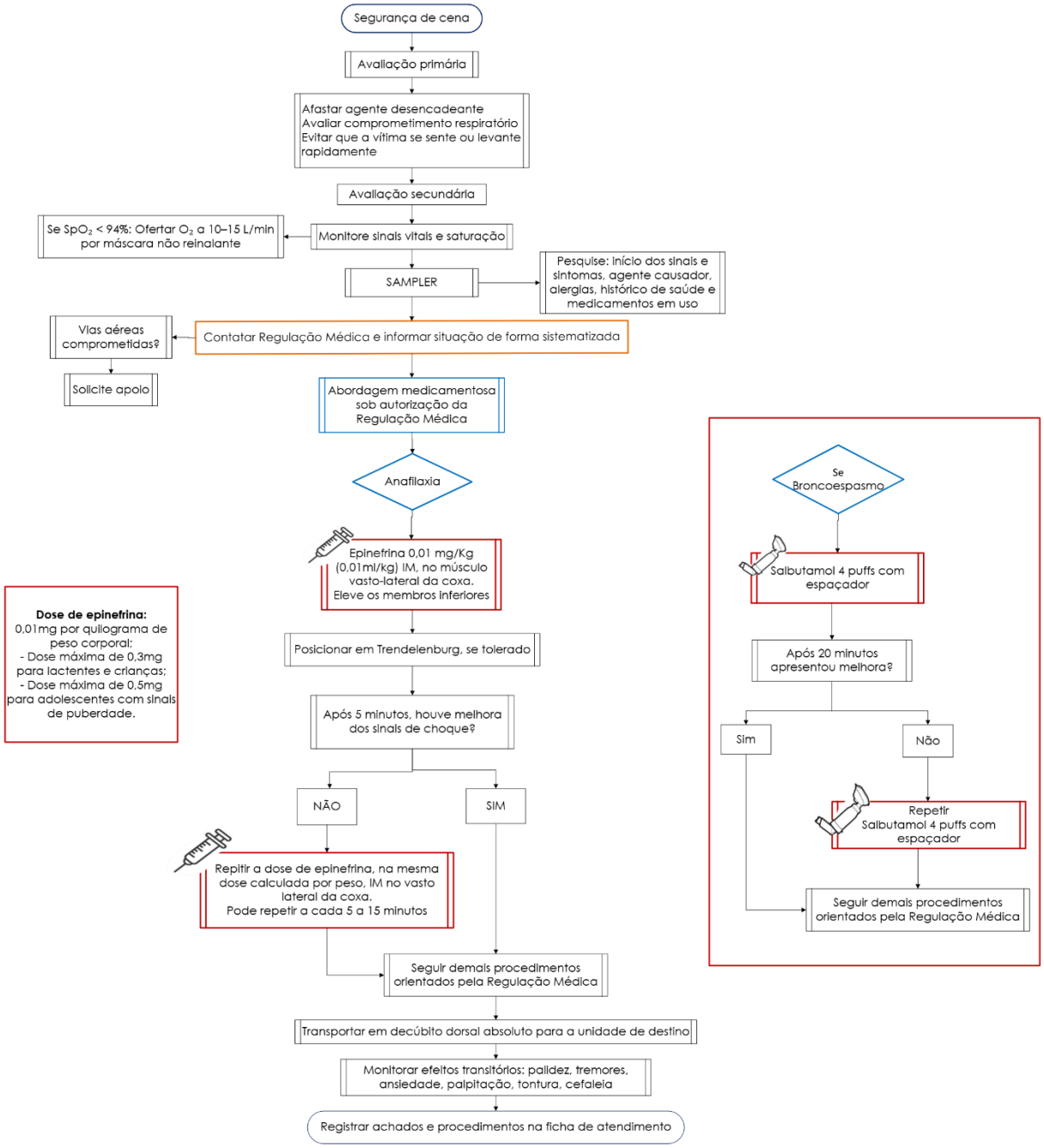
6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Imagens do local de aplicação em vasto lateral da coxa:



8. FLUXOGRAMA - Anafilaxia na criança.



9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. PALS. Suporte Avançado de Vida em Pediatria. Editora Elsevier. 5ª Edição. 2020. 528 páginas.

9.2. HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN. Anafilaxia pediátrica. São Paulo: Hospital Israelita Albert Einstein, [s.d.]. Disponível em: https://medicalsuite.einstein.br/pratica-medica/Pathways/Anafilaxia-Pedi%C3%A1trica.pdf. Acesso em: 22 jan. 2026.

9.3. Sociedade Brasileira de Pediatria – III Consenso Brasileiro no manejo da Asma – J. Pneumologia, Junho 2002.

9.4. Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 – Suporte Avançado de Vida. Brasília: Ministério da Saúde, 2ª Edição, 2016. 638 p.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
06	02/02/2026	Atualização 1. Atualização da definição de anafilaxia, com enfoque em reação aguda potencialmente fatal e ampliação dos sinais e sintomas clínicos. 2. Inclusão da classificação etária baseada no PALS, com definição da transição para protocolos do ACLS em adolescentes. 3. Adequação do objetivo, passando a contemplar a abordagem pré-hospitalar pelas equipes de SBV e SBV-E, e não apenas a atuação do enfermeiro. 4. Atualização das áreas envolvidas, conforme organização operacional vigente (SBV, SBV-E e Central de Regulação). 5. Reorganização da abordagem assistencial, com padronização da avaliação da segurança da cena, avaliação primária e secundária, monitorização contínua e uso estruturado do SAMPLER. 6. Padronização dos critérios de gravidade, com definição clara de sinais cutâneos, respiratórios, circulatórios e gastrintestinais. 7. Atualização da abordagem medicamentosa, com padronização do uso da epinefrina IM, definição de doses máximas por faixa etária, intervalos de repetição e necessidade de autorização da Regulação Médica. 8. Padronização do manejo do broncoespasmo, com uso do salbutamol por espaçador e orientação técnica detalhada para administração.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Daiane M.F. de Souza Henrique CSAL Costa Filho José Caruso Simone Cedano Ramos Wesley Almeida Santos	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nádia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Desidratação é a condição caracterizada pela perda excessiva de água e eletrólitos do organismo, quando essa perda não é adequadamente reposta, levando a um desequilíbrio hidroeletrolítico;

1.2. A desidratação em crianças ocorre, mais comumente, em situações associadas à diarreia, vômitos, febre, sudorese excessiva ou ingestão insuficiente de líquidos;

1.3. Sinais e sintomas: ausência de lágrimas, olhos fundos, redução da salivação (boca e língua secas), pele com aspecto murcho, fontanelas deprimidas, diminuição do volume urinário, respiração rápida e superficial, além de pulso fraco e extremidades frias.

2. OBJETIVOS

2.1. Descrever os sinais, sintomas e a abordagem pré-hospitalar realizada pela equipe de SBV e SBV-E à criança com desidratação.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e Central de Regulação.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Realize a avaliação da segurança de cena;

4.2. Realize avaliação primária e intervenha conforme os achados;

4.2.1. Realize a abordagem inicial a partir do Triângulo de Avaliação Pediátrica (Figura 1):

- Aparência: avalie a presença de choro, tônus muscular e olhar da criança;
- Respiração: avalie a postura, presença de ruídos respiratórios audíveis, tiragem intercostal, taquipneia, batimento de asa de nariz, retração de fúrcula;
- Circulação: avalie a coloração da pele e verifique se há presença de cianose labial, palidez, etc.

4.3. Se possível, permita que a criança permaneça no colo do cuidador;

4.4. Realize a avaliação secundária com ênfase em:

4.4.1. Realize o SAMPLER: sinais e sintomas, alergias, histórico de saúde, episódios de diarreia, vômitos, ultima micção, presença ou ausência de lágrimas ao chorar e uso de medicamentos;

4.4.2. Monitore sinais vitais e glicemia capilar;

4.4.3. Administre oxigênio 8l/min por máscara não reinalante se saturação < 94%;

Figura 1: Triângulo de Avaliação Pediátrica para triagem inicial de crianças potencialmente graves

GRAU DE DESIDRATAÇÃO	SINAIS CLINICOS
LEVE	• Bom estado geral • Sede normal ou levemente aumentada • Diurese normal ou discretamente reduzida
MODERADO	• Irritabilidade ou letargia • Sede aumentada • Olhos fundos • Mucosas secas • Turgor cutâneo diminuído • Fontanela ligeiramente deprimida • Diurese reduzida • Respiração rápida • Pulso rápido e fino
GRAVE	• Letargia ou inconsciência • Olhos muito fundos • Mucosas muito secas • Fontanelas deprimidas • Oliguria ou anuria • Pulso fraco e perfusão lentificada

Abordagem apenas na presença do enfermeiro em SBV-E:

Para casos de desidratação grau moderado e grave:

4.5. Puncione acesso venoso periférico;

4.6. Infunda SF 0,9%, na dose de 20 ml/ kg em 30 minutos, em bomba de infusão;

4.6.1. Na ausência da bomba de infusão, realize contato imediato com o Médico Regulador (MR) e agilize o transporte, mantendo monitorização contínua do paciente até a transferência.

4.7. Realize contato com a Regulação Médica para a passagem sistematizada das informações;

4.8. Transporte para a unidade de saúde conforme orientação do MR;

4.9. Registre os achados e procedimentos realizados na Ficha de Atendimento.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não há.

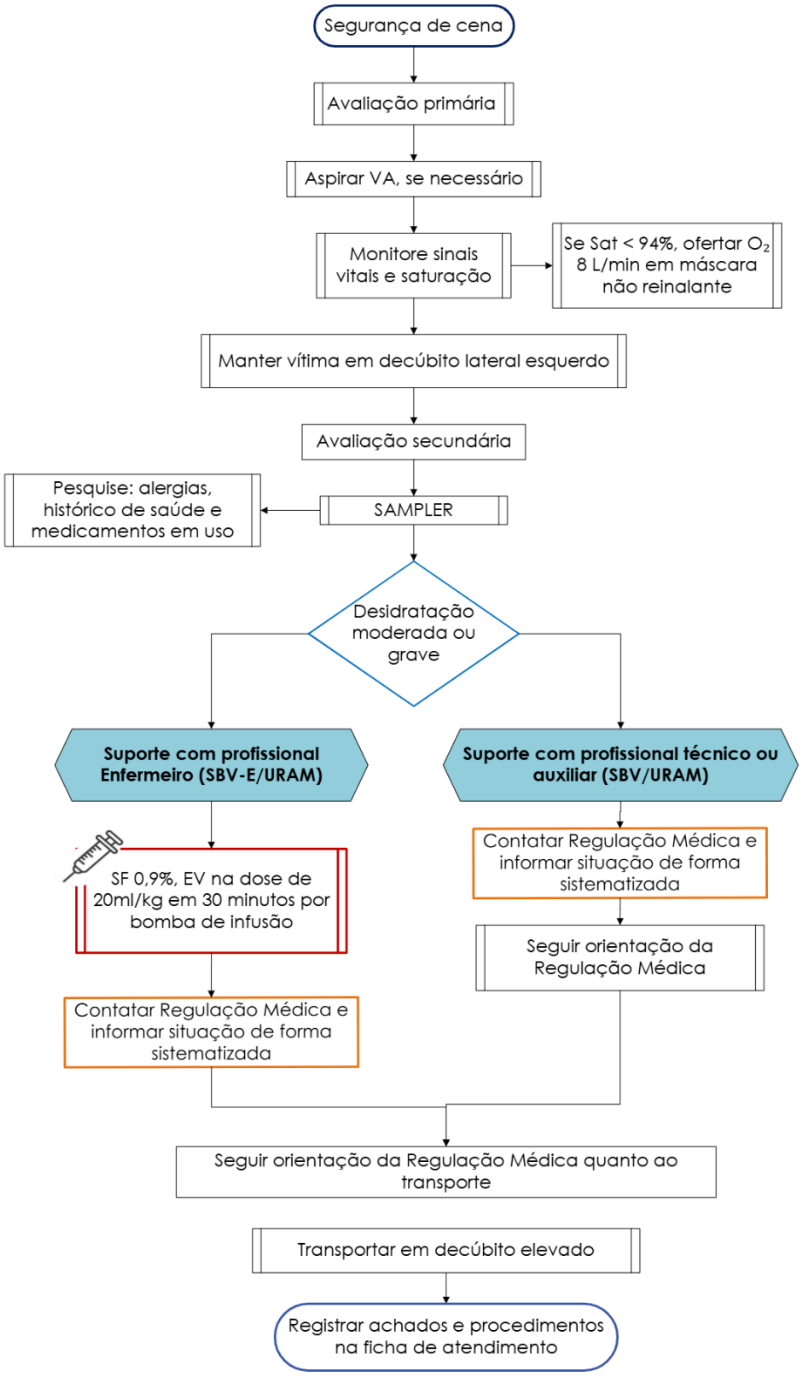
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA – Desidratação na criança



9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. PALS. Suporte Avançado de Vida em Pediatria. Editora Elsevier. 5ª Edição. 2020. 528 p.

9.2. Protocolo de Atendimento Pré-Hospitalar: Suporte Intermediário de Vida. São Paulo: Secretaria Municipal de Saúde – SAMU, 2022; 5ª. Edição 391 p.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
06	02/02/2026	Atualização 1. Atualização e padronização das definições de distúrbios hidroeletrolíticos e desidratação, com manutenção dos principais sinais clínicos e alinhamento à abordagem pediátrica atual. 2. Inclusão da classificação etária baseada no PALS. 3. Reorganização da abordagem assistencial, com reforço da avaliação primária e secundária, uso do SAMPLER direcionado à investigação de vômitos, diarreia, diurese e sinais de desidratação. 4. Padronização da classificação do grau de desidratação (leve, moderada e grave), com critérios clínicos objetivos para identificação de instabilidade hemodinâmica. 5. Definição clara da abordagem venosa restrita à presença do enfermeiro em SBV-E, com limitação de tentativas de punção e uso preferencial de bomba de infusão. 6. Atualização da fluidoterapia, com ajuste do tempo de infusão e orientação específica na ausência de bomba de infusão.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Daiane M.F. de Souza Henrique CSAL Costa Filho José Caruso Simone Cedano Ramos Wesley Almeida Santos	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nádia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. A hipoglicemia é definida pela redução da glicemia plasmática abaixo de valores considerados adequados para a idade e o contexto clínico, especialmente quando há risco de repercussões neurológicas.

1.1.1. Hipoglicemia no recém-nascido (RN): glicemia capilar < 45 mg/dl

1.1.2. Hipoglicemia em lactentes e crianças: glicemia capilar < 60 mg/dl

1.2. A presença de sintomas como letargia, irritabilidade, sudorese, rebaixamento do nível de consciência e convulsões indica tratamento imediato, independentemente do valor exato estabelecido. Crianças com doenças metabólicas, sepse, desnutrição, uso de insulina ou jejum prolongado podem apresentar hipoglicemia com valores limítrofes.

1.3. Classificação de faixa etária pelo PALS (Pediatric Advanced Life Support):

1.3.1. Recém-nascido: do nascimento até 28 dias de vida;

1.3.2. Lactente: entre 29 dias e 1 ano incompleto;

1.3.3. Criança: de 1 ano até o início da puberdade.

1.3.4. A partir da puberdade, o paciente é considerado adolescente, e sua abordagem passa a seguir os protocolos de adulto. A definição do ponto de transição baseia-se na presença de sinais de maturidade sexual, como desenvolvimento mamário nas meninas ou pelos axilares nos meninos.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever as ações da equipe de SBV e SBV-E no atendimento ao RN, lactente e à criança com quadro de hipoglicemia.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e Central de Regulação.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Realize a avaliação da segurança da cena;

4.2. Realize avaliação primária e intervenha conforme achados;

4.2.1. Garanta a permeabilidade das vias aéreas;

4.2.2. Identifique sinais: palidez cutânea, sudorese, pulso rápido e perfusão periférica lentificada;

4.2.3. Avalie o nível de consciente;

4.3. Realize avaliação secundária com ênfase para:

4.3.1. Monitore sinais vitais e glicemia capilar;

4.3.2. Oferte O_2 por máscara não reinalante à 8l /min, se SpO2 < 94%;

4.3.3. Realize o SAMPLER com ênfase para os sinais e sintomas, alergias, medicamentos em uso, histórico de doenças prévias, último horário de alimentação e fatores precipitantes;

4.4. Realize contato com o Médico Regulador para a passagem sistematizada das informações;

4.5. Siga as orientações do MR para procedimentos, abordagem medicamentosa e/ou transporte para a unidade de saúde de destino;

Abordagem medicamentosa na presença do enfermeiro (SBV-E/ URAM)

SBV sob autorização da Regulação Médica:

4.6. Puncione acesso venoso periférico;

4.7. Corrija a hipoglicemia conforme faixa etária:

RN sintomático (tremores, convulsão, hipotermia, taquipneia, taquicardia, cianose, sucção débil) com **glicemia ≤ 45mg/dl:**

4.8. **Administre glicose 10% 5 ml/kg**, EV puro e lento.

4.8.1. Realize a diluição da glicose 50% com água destilada (AD) ou SF 0,9% para obter a glicose 10%. A proporção é de 1:4 (uma parte de glicose 50% para quatro partes de AD ou SF) - Siga a tabela (Anexo 1) para realizar a conversão de glicose 50% em glicose10%;

Criança e Lactente sintomáticos com glicemia ≤ 60 mg/dl:

4.9. **Administre glicose 25%: 2 ml/kg**, EV puro e lento.

4.9.1. Realize a diluição da glicose 50% com água destilada (AD) ou SF 0,9% para obter a glicose 25%. A proporção é de 1:1 (uma parte de glicose 50% para uma parte de AD ou SF) - Siga a tabela (Anexo 1) para realizar a conversão de glicose 50% em glicose10%;

4.10. Reavalie nível de consciência e glicemia capilar;

4.11. Realize o transporte para a unidade de saúde de destino indicada pela Regulação Médica;

4.12. Registre os achados e procedimentos realizados na Ficha de Atendimento.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. A equipe de Suporte Básico de Vida (SBV) somente poderá intervir com ação medicamentosa após autorização do Médico Regulador.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

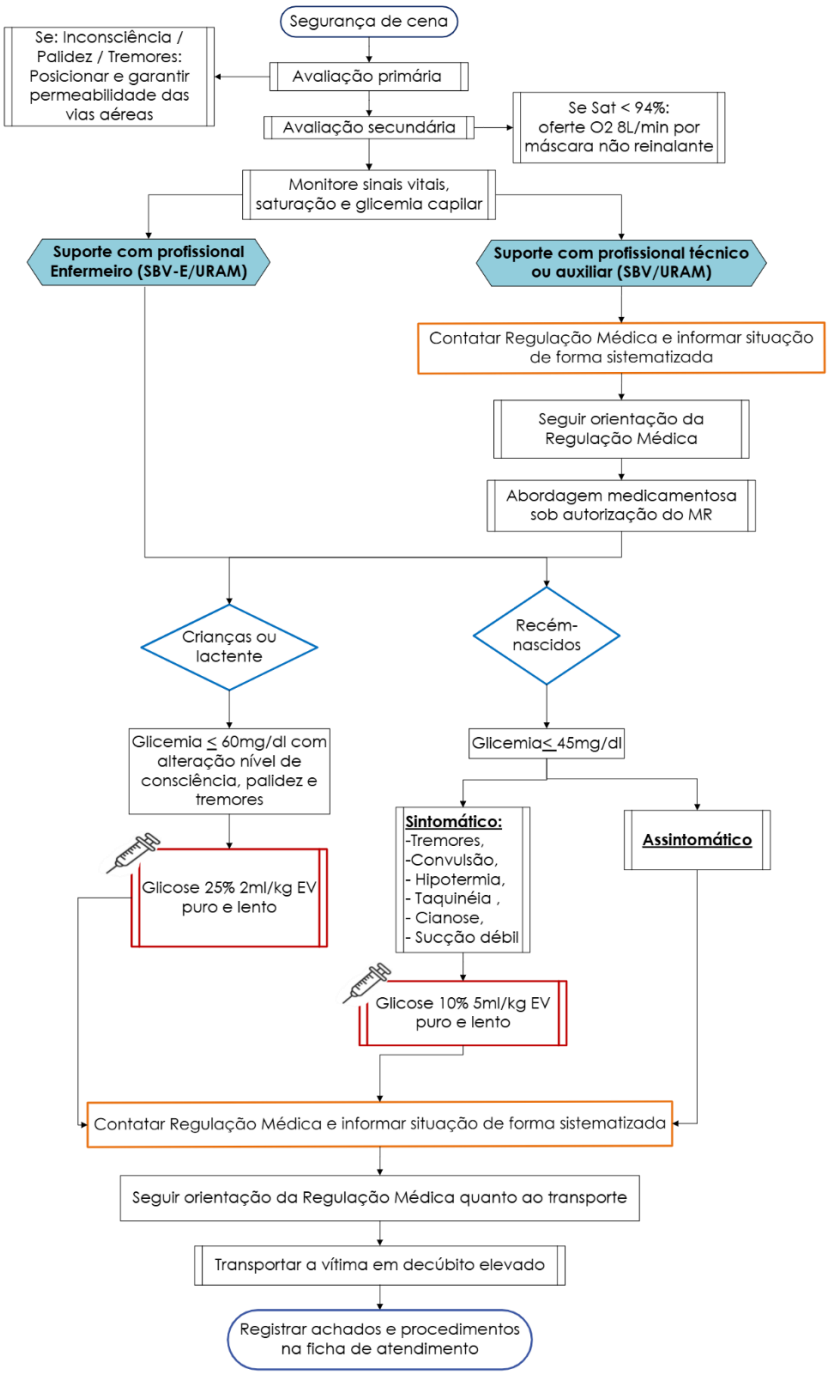
6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Anexo 1 - Tabela de diluição de conversão de glicose 50% para glicose10%

Conversão SG50% para SG10%			
Peso da Criança/RN (Kg)	Volume SG50% + Volume diluente	Volume final SG10%	Dose SG10% a administrar (5ml/kg)
1	1ml + 4ml	5ml	5ml
2	2ml + 8ml	10ml	10ml
3	3ml + 12ml	15ml	15ml
4	4ml + 16ml	20ml	20ml
5	5ml + 20ml	25ml	25ml
6	6ml + 24 ml	30ml	30ml

8. FLUXOGRAMA – Hipoglicemia no RN, no Lactente e na Criança



9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. PALS. Suporte Avançado de Vida em Pediatria. Editora Elsevier. 5ª Edição. 2020. 528 páginas.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Ampliação do escopo do protocolo, que passou de abordagem geral para hipoglicemia no recém-nascido, lactente e criança. 2. Atualização da definição de hipoglicemia, com valores glicêmicos diferenciados por faixa etária, incluindo critério específico para RN (≤ 45 mg/dl). 3. Inclusão da classificação etária baseada no PALS, com definição clara de transição para protocolos de adolescentes (ACLS). 4. Reorganização da abordagem assistencial. 5. Atualização da conduta medicamentosa, com tratamento específico por faixa etária, doses calculadas por peso e padronização das concentrações de glicose (G25% para criança/lactente e G10% para RN). 6. Inclusão de orientações claras sobre diluição da glicose, com tabela de conversão anexa, visando segurança e padronização da prática. 7. Reforço da necessidade de autorização do médico regulador para intervenção medicamentosa pelo SBV .

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Daiane M.F. de Souza Henrique CSAL Costa Filho José Caruso Simone Cedano Ramos Wesley Almeida Santos	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nádia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. A convulsão é definida como uma atividade elétrica excessiva e desorganizada em determinadas áreas no cérebro, que se manifesta frequentemente em decorrência de lesões ou doenças neurológicas e quando prolongada, costuma causar danos ao sistema nervoso central. Os sinais e sintomas incluem: perda da consciência, contrações musculares involuntárias (generalizadas ou focais), salivação excessiva, olhar fixo e incontinência urinária e/ou fecal.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever os sinais, sintomas e a abordagem pré-hospitalar realizada pela equipe de SBV à criança em crise convulsiva.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e CRU.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Realize a avaliação da segurança de cena;

4.2. Realize avaliação primária e intervenha conforme achados;

4.3. Administre O_2 de 5 a 8l/min por máscara não-reinalante independente da saturação;

<u>Durante a crise</u>:

4.4. Garanta a segurança da vítima - remova objetos perigosos que possam machucá-la durante as contrações musculares;

4.5. Proteja a cabeça - providencie acolchoamento;

4.6. Garanta a permeabilidade das vias aéreas;

4.7. Não impeça os movimentos involuntários da vítima;

<u>Após a crise</u>:

4.8. Mantenha a permeabilidade das vias aéreas;

4.9. Avalie o nível de consciência;

4.10. Realize avaliação secundária com ênfase em:

4.10.1. Monitore sinais vitais e saturação;

4.10.2. Mantenha a administração de O_2 de 5 a 8l/min por máscara não-reinalante independente da saturação;

4.11. Se glicemia $\leq$ 60mg/dl, realize a correção conforme protocolo institucional POP IAPH SBV e SBV-E 062 – Hipoglicemia no RN, no lactente e na Criança;

4.12. Realize o SAMPLER com ênfase na pesquisa de: alergias, histórico de DM, epilepsia, tumor cerebral, síndromes, uso de medicamentos, líquidos e/ou alimentos ingeridos, eventos que precederam a crise;

4.13. Considere vítima grave se: convulsão com duração maior que 5 minutos ou mais de 2 convulsões sem recuperação da consciência;

4.14. Realize contato com a Regulação Médica para a passagem sistematizada das informações;

4.15. Siga as orientações da Regulação Médica para procedimentos, abordagem medicamentosa e/ou transporte para unidade de saúde de destino;

4.9. Realize o transporte para a unidade de saúde de destino indicada pela Regulação Médica, com a vítima em decúbito lateral (exceto nos casos de trauma).

4.10. Nas vítimas com mecanismo de trauma associado, imobilize a coluna cervical manualmente, realize rolamento na prancha e instale colar cervical e head block assim que possível;

4.11. Registre os achados e procedimentos realizados na Ficha de Atendimento.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não há.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP IAPH SBV e SBV-E 062 – Hipoglicemia no RN, no lactente e na Criança;

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. PALS. Suporte Avançado de Vida em Pediatria. Editora Elsevier. 5ª Edição. 2020. 528 páginas.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
06	02/02/2026	Atualização 1. Atualização da definição de convulsão, com ampliação dos sinais e sintomas e ênfase nos possíveis danos neurológicos em crises prolongadas. 2. Reorganização da abordagem assistencial, com separação das condutas durante e após a crise, visando maior clareza operacional. 3. Padronização das medidas de segurança durante a convulsão. 4. Atualização da abordagem da hipoglicemia, com referência a protocolo institucional específico. 5. Reforço da comunicação com a Regulação Médica, da sistematização das informações, do transporte conforme orientação e do registro em ficha de atendimento.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Daiane M.F. de Souza Henrique CSAL Costa Filho José Caruso Simone Cedano Ramos Wesley Almeida Santos	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. Trabalho de parto: processo fisiológico que culmina no nascimento do bebê, caracterizado por contrações uterinas regulares e progressivamente mais intensas, que promovem o apagamento e a dilatação do colo do útero, permitindo a passagem do feto pelo canal de parto. Esse processo é dividido em fases — dilatação, expulsão e dequitação — e envolve complexas interações hormonais, musculares e emocionais que preparam o corpo materno para o parto e a expulsão da placenta.

1.2. Fase ativa: é caracterizada por contrações regulares e coordenadas, acompanhadas de dilatação progressiva do colo do útero**.** Na fase ativa o padrão contrátil inicial é, geralmente, de uma contração a cada 3-5 minutos e dura entre 20 e 60 segundos, evoluindo progressivamente para a dilatação progressiva do colo uterino;

1.3. Trabalho de parto iminente: apresenta contrações uterinas regulares de 2 em 2 minutos, ocorre a visualização das partes fetais, dilatação total do colo do útero e sensação de "puxo".

2. OBJETIVO

2.1. Descrever as ações da equipe de enfermagem no atendimento à gestante em trabalho de parto iminente.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e CRU

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

Cuidados gerais durante o atendimento

4.1. Avalie a segurança da cena;

4.2. Apresente-se à parturiente e ao seu acompanhante, dirigindo-se a ela pelo nome, ou conforme ela desejar ser chamada;

4.3. Forneça as orientações de forma clara e concisa;

4.4. Respeite e apoie as necessidades emocionais e dúvidas, acolhendo-a de forma positiva;

4.5. Atente-se para dificuldades na comunicação/compreensão (déficit auditivo, visual, intelectual, língua estrangeira, etc.);

4.6. Solicite o auxílio do acompanhante, de escolha da parturiente;

4.7. Atente-se a preservar a privacidade da parturiente, não expondo-a sem necessidade;

4.8. Explique os procedimentos a serem realizados e obtenha o consentimento da parturiente;

PARTO NÃO IMINENTE

4.9. Realize avaliação primária e intervenha conforme os achados;

4.10. Realize a avaliação secundária com ênfase em:

4.10.1. Monitorize sinais vitais e saturação;

4.10.2. Administre oxigênio se saturação < 94%;

4.10.3. Realize a anamnese e pergunte:

I. Realizou pré-natal? (solicite o cartão)

II. Sabe qual a data provável do parto?

III. Qual a frequência e duração das contrações?

IV. Perdeu líquido ou secreção por via vaginal?

V. Qual o número de gestações anteriores?

VI. O parto foi normal ou cesárea?

VII. Qual o número de filhos vivos?

VIII. Faz tratamento para alguma doença?

IX. Toma algum remédio?

4.11. Posicione a gestante em DLE;

4.12. Monitore a ocorrência das contrações uterinas;

4.13. Realize contato com a Regulação Médica para a passagem sistematizada das informações;

4.14. Siga as orientações do médico regulador para procedimentos e/ou transporte para a unidade de saúde de destino com a vítima em DLE.

PARTO IMINENTE

4.15. Atente-se para os sinais e sintomas:

4.15.1. Contrações de 2 em 2 minutos com duração de 30 a 60 segundos;

4.15.2. Vontade intensa de evacuar referida pela parturiente;

4.15.3. Presença de puxos involuntários;

4.15.4. Apresentação do polo cefálico (visível na via vaginal);

4.15.5. Presença ou ausência de bolsa "rota".

Medidas no atendimento

4.16. Tranquilize a gestante, explique o procedimento e realize a anamnese;

4.17. Solicite que o acompanhante permaneça durante todo o parto;

4.18. Garanta a privacidade e evite expor a parturiente sem necessidade;

4.19. Mantenha o controle da temperatura do ambiente evitando ar condicionado e correntes de ar;

4.20. Coloque os EPIs (óculos, máscara e luvas de procedimento);

4.21. Posicione a parturiente em decúbito dorsal com as pernas fletidas e afastadas, e os pés apoiados;

4.22. Realize a higienização do períneo com soro fisiológico 0,9%;

4.23. Abra o Kit parto;

4.24. Coloque o avental de mangas longas;

4.25. Troque as luvas de procedimento por luvas estéreis;

4.26. Posicione os campos estéreis sob o glúteo e sobre o abdome e as coxas da parturiente;

4.27. Oriente-a a respirar calmamente nos intervalos entre as contrações e realizar "força de puxo" nas contrações;

4.28. Proteja o períneo com o polegar e o indicador durante o desprendimento cefálico a fim de evitar lacerações;

4.29. Apoie o polo cefálico do recém-nascido (RN), com uma das mãos, enquanto se desprende;

4.30. Aguarde a rotação externa da cabeça para desprendimento do ombro anterior, abaixando-o, e após levante-o para o desprendimento do ombro posterior;

4.31. Apoie o RN no campo estéril após a expulsão;

4.32. Avalie a involução uterina palpando o fundo do útero após a saída do concepto e da dequitação da placenta;

4.33. Atente-se à presença de atonia uterina;

4.34. Quantifique a perda sanguínea pelo trato genital através das compressas;

4.35. Posicione o RN que nasce bem sobre o abdômen materno para estimular o contato pele- a- pele;

4.36. Não oriente a amamentação neste primeiro momento. O RN poderá receber o aleitamento materno dentro da 1h de nascimento (podendo ocorrer no ambiente intra-hospitalar após realização de exames necessários);

4.37. Utilize protocolo especifico para RN que nasce mal (POP 068 Intervenções em Atendimento Pré-Hospitalar – Assistência ao Recém-Nascido que Não Apresenta Boa Vitalidade);

4.38. Atente-se para não tracionar o cordão;

4.39. Realize o corte do cordão umbilical do RN com boa vitalidade em até 3 minutos ou após cessar a pulsação, utilizando a seguinte técnica:

4.39.1. Coloque e trave o 1º clamp umbilical na distância de 15 a 20 cm do abdome do RN;

4.39.2. Trave o 2º clamp umbilical em uma distância de 5 cm do 1º clamp;

4.39.3. Corte o cordão umbilical com bisturi de baixo para cima entre os dois clamps.

ATENÇÃO!

4.40. A equipe não deve atrasar o transporte para a unidade de saúde em detrimento da dequitação da placenta;

4.41. Após a dequitação, acondicione a placenta em saco plástico identificado com nome da puérpera;

4.42. Encaminhe a placenta junto com a mãe e o RN;

4.43. Mantenha a mãe deitada na maca em posição confortável;

4.44. Identifique o RN e a mãe com as pulseiras de identificação;

4.45. Preencha a mesma ficha de atendimento para a mãe e para o RN;

4.46. Registre as condições do parto (presença ou não de mecônio) e as condições do nascimento;

4.47. Realize contato com a Regulação Médica para a passagem sistematizada das informações;

4.48. Siga as orientações do médico regulador (MR) para procedimentos e/ou transporte para unidade de saúde de destino;

4.49. Reavalie a puérpera e o RN durante o transporte;

4.50. Transporte o binômio à unidade de saúde indicada pelo MR.

PROCEDIMENTOS EM CASO DE DISTÓCIAS

Circular de cordão

4.51. Na saída do polo cefálico, observe a presença da circular de cordão:

4.52. Avalie a pulsação do cordão;

4.53. Afrouxe o cordão por cima da cabeça;

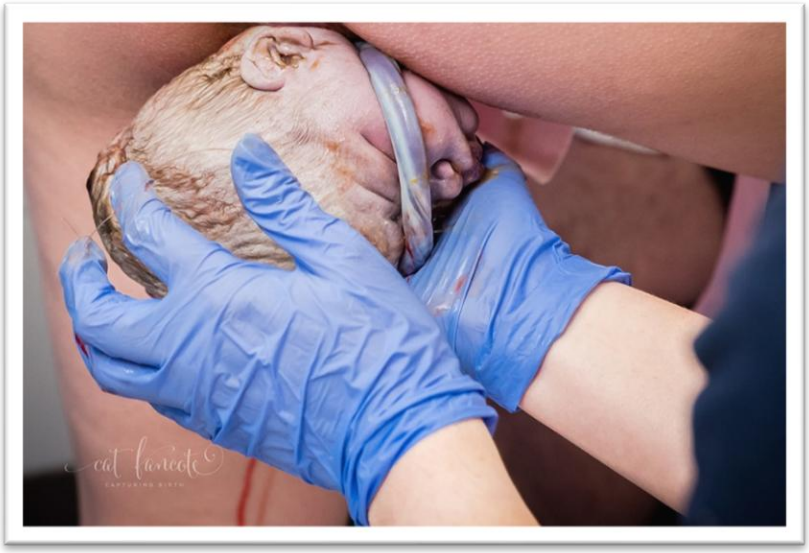
4.54. Libere o cordão por cima da cabeça, usando o dedo indicador;

4.55. Proceda a assistência ao RN conforme protocolo específico;

4.56. Caso não consiga afrouxar/ liberar ou se observada a presença de mais de uma circular de cordão, comunique o caso ao MR e aguarde orientação;

4.57. Solicite apoio do SAV e siga as orientações do MR;

4.58. Mantenha a parturiente em posição ginecológica;



Fonte: https://clinicaconcept.com.br/circular-de-cordao/

Apresentação pélvica

4.59. Solicite apoio do SAV e siga as orientações do MR;

4.60. Não estimule a ocorrência do parto na cena ou na ambulância;

4.61. Mantenha a parturiente em posição ginecológica;

4.62. Caso ocorra o desprendimento espontâneo do RN, garanta o apoio em sua saída;

4.63. Proceda a assistência ao RN conforme protocolo específico;

4.64. Prepara-se para possível reanimação neonatal.

Fonte: https://me.med.br/apresentacao-fetal/

Apresentação transversa

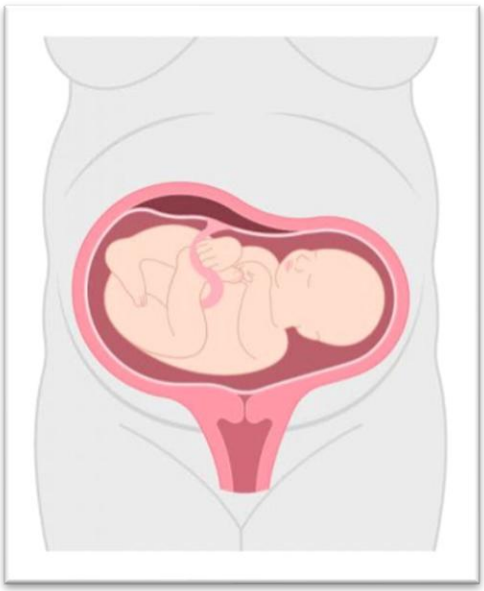
4.65. Solicite apoio do SAV e siga as orientações do MR;

4.66. Não estimule a ocorrência do parto na cena ou na ambulância;

4.67. Mantenha a parturiente em DLE;

4.68. Administre oxigênio por máscara de 10 a 15 l/min, se saturação < 94%;

4.69. Transporte a gestante para unidade de saúde indicada.



Fonte: https://me.med.br/apresentacao-fetal/

Prolapso do cordão

4.70. Solicite apoio do SAV e siga as orientações do MR;

4.71. Não estimule a ocorrência do parto na cena ou na ambulância;

4.72. Mantenha a gestante em posição ginecológica elevando a pelve com a mochila ou cobertores dobrados para diminuir a pressão pélvica sobre o cordão umbilical;

4.73. Utilize o dedo indicador e médio para apoiar a cabeça, liberando a pressão sobre o cordão, mantendo a pulsação do cordão;

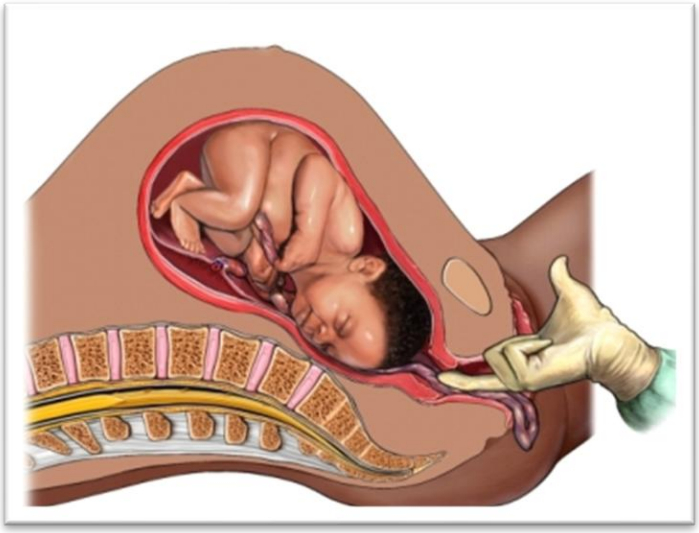
4.74. Envolva o cordão exposto em gaze umedecida com SF 0,9%;

4.75. Administre oxigênio por máscara de 10 a 15 l/min, se saturação < 94%;

4.76. Realize o transporte da gestante à unidade de saúde indicada pelo MR com cautela, a fim de manter a descompressão do cordão durante todo o trajeto.

4.77. Monitore continuamente a presença de pulsação do cordão;

4.78. Não retire a mão da posição até a chegada no Centro Obstétrico;



Fonte: https://estudamelania.blogspot.com/2012/08/prolapso-de-cordao-por-amniotomia.html

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não é permitida a realização do toque vaginal por profissionais do APH;

5.2. Na presença do enfermeiro, utilize a Regra de Naegele para o cálculo da DPP (Data Provável do Parto):

5.2.1. Some 7 dias ao dia da última menstruação (DUM);

5.2.2. Subtraia 3 meses e adicione 1 ano.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP 068 Intervenções em Atendimento Pré-Hospitalar – Assistência ao Recém-Nascido que Não Apresenta Boa Vitalidade.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. ALSO. Suporte Avançado de Vida em Obstetrícia, 2019.

9.2. Protocolo de Atendimento Pré-Hospitalar: Suporte Intermediário de Vida. São Paulo: Secretaria Municipal de Saúde – SAMU, 2014.4ª. Edição 112 p.

9.3. PALS. Suporte Avançado de Vida em Pediatria Editora Elsevier. 5ª Edição. 2020. 528 páginas.

9.4. DIRETRIZ NACIONAL DE ASSISTÊNCIA AO PARTO NORMAL, Ministério da Saúde 2022.119 p.

9.5. Diretrizes consolidadas para prevenção, diagnóstico e tratamento de hemorragia pós-parto, Organização Mundial da Saúde 2025

9.6. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Programáticas. Manual de gestação de alto risco [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Programáticas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2022. 692 p.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Atualização das definições e conceitos de trabalho de parto. 2. Inclusão de diretrizes gerais de atendimento com foco em segurança, acolhimento, comunicação humanizada e preservação da privacidade. 3. Reorganização do atendimento ao parto não iminente, com avaliação clínica sistematizada, monitorização, critérios para oxigenoterapia e comunicação estruturada com a Regulação Médica. 4. Padronização e detalhamento do atendimento ao parto iminente, com atualização dos sinais clínicos, uso adequado de EPIs e descrição sequencial das condutas. 5. Inclusão de cuidados no pós-parto imediato. 6. Reorganização e ampliação das condutas frente às distócias obstétricas, com maior detalhamento técnico e alinhamento à Regulação Médica

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Celina H.H. Vasconcelos Daiane M.F. de Souza José Caruso Lydia Manhães Wesley Almeida Santos	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. Em relação a idade gestacional, o RN é definido como:

1.1.1. RN pré-termo (prematuro): idade gestacional < 37 semanas;

1.1.2. RN a termo: idade gestacional entre 37 e 41 semanas;

1.1.3. RN pós-termo: idade gestacional ≥ 42 semanas.

1.2. Para avaliação e identificação do RN que nasce bem é preciso responder aos seguintes questionamentos:

1.2.1. Idade gestacional ≥ 34 semanas ou < 34 semanas?

1.2.2. RN está com respiração regular ou chorando?

1.2.3. RN apresenta tônus muscular em flexão e movimentos ativos?

1.3. Considera-se boa vitalidade quando o RN respira de forma regular ou chora, e apresenta tônus muscular em flexão após o nascimento, independente do aspecto do líquido amniótico.

2. OBJETIVOS

2.1. Descrever os passos da assistência ao recém-nascido que apresenta boa vitalidade em ambiente pré-hospitalar.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E e Central de Regulação.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

Manejo e condutas ao RN a termo (entre 37 a 41 semanas) com boa vitalidade

4.1. Realize a avaliação da segurança de cena;

4.2. Utilize os EPIs adequados;

4.3. Posicione o RN sobre o abdome da mãe, mantendo contato pele a pele, sem tracionar o cordão umbilical (se não for possível, apoiar o RN na cama ou outra superfície sobre o campo estéril);

4.4. Envolva-o com o campo estéril, inclusive a cabeça (exceto a face);

4.5. Seque o corpo e a cabeça e troque o campo úmido por outro seco;

4.6. Coloque a touca de algodão;

4.7. Realize o clampeamento do cordão umbilical em até 3 minutos ou após cessar a pulsação;

4.8. Coloque o primeiro *cord* clamp cerca de 10 a 15 cm a partir do abdome do RN e o segundo, cerca de 3 a 4 cm do primeiro;

4.9. Corte o cordão umbilical com lâmina de bisturi estéril (de baixo para cima) entre os dois *cord* clamps;

4.10. Posicione a cabeça do RN em leve extensão (pode ser necessária a utilização de um coxim sob os ombros para facilitar a abertura das vias aéreas e o correto posicionamento da cabeça);

4.11. Aspire boca a nariz (com sonda nº 8) somente se houver excesso de secreção. Caso haja necessidade, o procedimento deve ser realizado com muita cautela para evitar resposta vagal (bradicardia e apneia) e lesões;

4.12. Avalie o padrão respiratório (deve estar rápido e regular) e a frequência cardíaca, a partir da ausculta do precórdio (ausculte 6 segundos e multiplique por 10 para ter a frequência cardíaca em 1 minuto);

4.13. Identifique a mãe e o RN com as pulseiras (Figura 1);

4.14. Apresente o RN para a mãe, referindo o sexo (homem ou mulher) para um melhor entendimento;

4.15. Não estimule o aleitamento materno antes da chegada no hospital devido a necessidade de realização dos testes sorológicos;

4.15.1. Caso a mãe já esteja amamentando, oriente e anote na Ficha de Atendimento;

4.16. Realize contato com a Regulação Médica para a passagem sistematizado das informações;

4.17. Siga as orientações da Regulação Médica para procedimentos, abordagem medicamentosa e/ou transporte para a unidade de saúde de destino;

4.18. Mantenha as portas e as janelas da ambulância fechadas, evitando corrente de ar, e não utilize ar-condicionado durante o transporte.

Figura 1: Pulseiras de identificação para mãe e RN.

Manejo e condutas ao RN a pré-termo (< 37 semanas) com boa vitalidade

4.19. Realize a avaliação da segurança de cena;

4.20. Utilize os EPIs adequados;

4.21. Posicione o RN sobre o abdome da mãe, mantendo contato pele a pele, sem tracionar o cordão umbilical (se não for possível, apoiar o RN na cama ou outra superfície sobre o campo estéril);

4.22. Envolva-o com o campo estéril, inclusive a cabeça (exceto a face);

4.23. Se RN < 34 semanas, envolva-o em saco plástico transparente;

4.24. Seque o corpo e a cabeça e troque o campo úmido por outro seco;

4.25. Coloque a touca de algodão;

4.26. Realize o clampeamento do cordão umbilical entre 30 e 60 segundos;

4.27. Coloque o primeiro *cord* clamp cerca de 10 a 15 cm a partir do abdome do RN e o segundo, cerca de 3 a 4 cm do primeiro;

4.28. Corte o cordão umbilical com lâmina de bisturi estéril (de baixo para cima) entre os dois *cord* clamps;

4.29. Posicione a cabeça do RN em leve extensão (pode ser necessária a utilização de um coxim sob os ombros para facilitar a abertura das vias aéreas e o correto posicionamento da cabeça);

4.30. Aspire boca a nariz (com sonda nº 8) somente se houver excesso de secreção. Caso haja necessidade, o procedimento deve ser realizado com muita cautela para evitar resposta vagal (bradicardia e apneia) e lesões;

4.31. Avalie o padrão respiratório (deve estar rápido e regular) e a frequência cardíaca, a partir da ausculta do precórdio (ausculte 6 segundos e multiplique por 10 para ter a frequência cardíaca em 1 minuto);

4.32. Identifique a mãe e o RN com as pulseiras

4.33. Apresente o RN para a mãe, referindo o sexo (homem ou mulher) para um melhor entendimento;

4.34. Realize contato com a Regulação Médica para a passagem sistematizado das informações;

4.35. Siga as orientações da Regulação Médica para procedimentos, abordagem medicamentosa e/ou transporte para a unidade de saúde de destino;

4.36. Mantenha as portas e as janelas da ambulância fechadas, evitando corrente de ar, e não utilize ar-condicionado durante o transporte.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. O contato pele a pele entre mãe e bebê ao nascimento, favorece o início precoce da amamentação e aumenta a chance de sucesso do aleitamento materno exclusivo nos primeiros meses de vida. Por isso, sempre que possível, o RN deve ser posicionado no abdome materno até a finalização do clampeamento do cordão, sempre provendo calor (cobrindo-o), mantendo as vias aéreas pérvias e avaliando continuamente sua vitalidade.

5.2. Profissional enfermeiro deverá aplicar índice de APGAR no primeiro e no quinto minuto após o nascimento e registrar na ficha de atendimento.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADA

9.1. Almeida MFB, Guinsburg R; Coordenadores Estaduais e Grupo Executivo PRN-SBP; Conselho Científico Departamento Neonatologia SBP. Reanimação do recém-nascido ≥34 semanas em sala de parto: diretrizes 2022 da Sociedade Brasileira de Pediatria. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pediatria; 2022. https://doi.org/10.25060/PRNSBP-2022-2. Disponível em: *https://www.sbp.com.br/especiais/reanimacao/* Acesso em: 16/06 2025

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
01	02/02/2026	Elaboração

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Bárbara de Souza	Luis Cássio Carneiro Leão Ivone Fernandes Alves Flávia Guedes Araújo Daiane Campos de Moraes Carla Cristine A. Bezerra	Mateus D. Miachon Lia Midori Straceri	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. Em relação a idade gestacional, o RN é definido como:

1.1.1. RN pré-termo (prematuro): idade gestacional < 37 semanas;

1.1.2. RN a termo: idade gestacional entre 37 e 41 semanas;

1.1.3. RN pós-termo: idade gestacional ≥ 42 semanas.

1.2. O RN, não apresenta boa vitalidade se, após o nascimento:

1.2.1. Não estiver respirando ou chorando

1.2.2. Não iniciar movimentos respiratórios regulares, e/ou

1.2.3. Apresentar tônus muscular flácido

2. OBJETIVOS

2.1. Descrever os passos da assistência ao recém-nascido que NÃO apresenta boa vitalidade em ambiente pré-hospitalar.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E e Central de Regulação

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

Manejo e condutas ao RN que NÃO apresenta boa vitalidade, independentemente da idade gestacional

4.1. Realize a avaliação da segurança de cena;

4.2. Utilize os EPIs adequados;

4.3. Realize o estímulo tátil no dorso, de modo delicado e no máximo de 2 vezes, para ajudar a iniciar a respiração;

4.4. Realize o clampeamento IMEDIATO do cordão umbilical;

4.5. Coloque o primeiro *cord* clamp cerca de 10 a 15 cm a partir do abdome do RN e o segundo, cerca de 3 a 4 cm do primeiro;

4.6. Corte o cordão umbilical com lâmina de bisturi estéril (de baixo para cima) entre os dois *cord* clamps;

4.7. Mantenha o RN envolvido em campo estéril, inclusive a cabeça (exceto a face), coloque a touca de algodão e posicione-o sobre uma superfície plana;

4.8. Se **RN < 34 semanas** envolva-o em saco plástico transparente, inclusive a cabeça (exceto a face), coloque a touca de algodão por cima do plástico, sem secá-lo;

4.9. Posicione a cabeça do RN em leve extensão (pode ser necessária a utilização de um coxim sob os ombros para facilitar a abertura das vias aéreas e o correto posicionamento da cabeça);

4.10. Aspire boca e nariz (com sonda nº 6 ou 8) somente se houver excesso de secreção. Caso haja necessidade, o procedimento deve ser realizado com muita cautela para evitar resposta vagal (bradicardia e apneia) e lesões;

4.11. Avalie simultaneamente a respiração e a frequência cardíaca, a partir da ausculta do precórdio (ausculte 6 segundos e multiplique por 10 para ter a frequência cardíaca em 1 minuto);

4.12. Se o RN apresentar apneia, respiração irregular e/ou frequência cardíaca < 100 bpm, inicie a ventilação com pressão positiva (VPP) em ar ambiente nos primeiros 60 segundos (reavaliando a cada 30 segundos);

4.13. Realize as ventilações com bolsa-válvula-máscara, na frequência de 40 a 60 insuflações por minuto, seguindo a mnemônica: "aperta...solta...solta";

4.14. Solicite apoio do SAV;

4.15. Se após 30 segundos de VPP com ar ambiente, o RN apresentar frequência cardíaca > 100 bpm e respiração espontânea e regular, suspender o procedimento e manter os cuidados conforme Protocolo "Assistência ao Recém-nascido que nasce bem";

4.16. Se após 30 segundos de VPP com ar ambiente o RN não melhorar, reavaliar, corrigir a técnica da VPP e ventilar por mais 30 segundos em ar ambiente;

4.17. Se após a correção da técnica da VPP em ar ambiente o RN não melhorar, realize mais 30 segundo de VPP com O_2 a 5L por minuto;

4.18. Se a **frequência cardíaca for < 60 bpm,** iniciar as compressões torácicas (Figura 1);

4.19. Sincronize compressão e ventilação na proporção de 03 compressões para 01 ventilação (3:1) com O_2 a 5L/min;

4.20. Comprima na profundidade de 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax, permitindo a retorno pleno do tórax após cada compressão;

4.21. Utilize preferencialmente a técnica dos polegares sobrepostos sobre o terço inferior do esterno (logo abaixo da linha intermamilar) e as mãos envolvendo o tórax do RN (Figura 1);

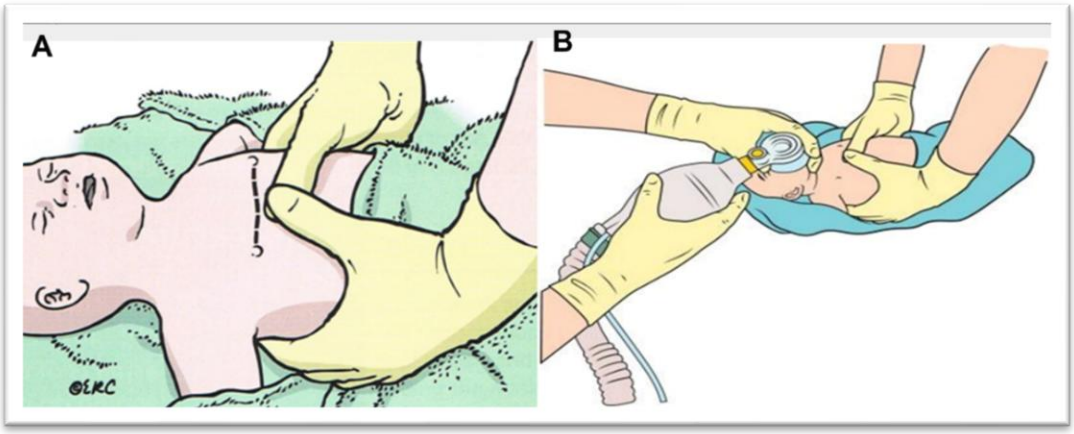


Figura 1: Técnica dos polegares sobrepostos para realização de compressões torácicas no RN (A); Posicionamento dos profissionais para reanimação neonatal (B).

4.22. Se a **frequência cardíaca for > 60 bpm,** interrompa as compressões torácicas e mantenha a VPP até frequência cardíaca > 100 bpm e respiração regular

4.23. Realize contato com a Regulação Médica para a passagem sistematizado de informações;

4.24. Siga as orientações da Regulação Médica para procedimentos, abordagem medicamentosa e/ou transporte para a unidade de saúde de destino;

4.25. Realize o transporte para a unidade de saúde de destino indicada pela Regulação Médica;

4.26. O RN que passou por reanimação deve ser transportado na maca, entre as pernas da mãe, sob observação contínua do profissional.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Profissional enfermeiro deverá aplicar índice de APGAR no primeiro e no quinto minuto após o nascimento e registrar na ficha de atendimento.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

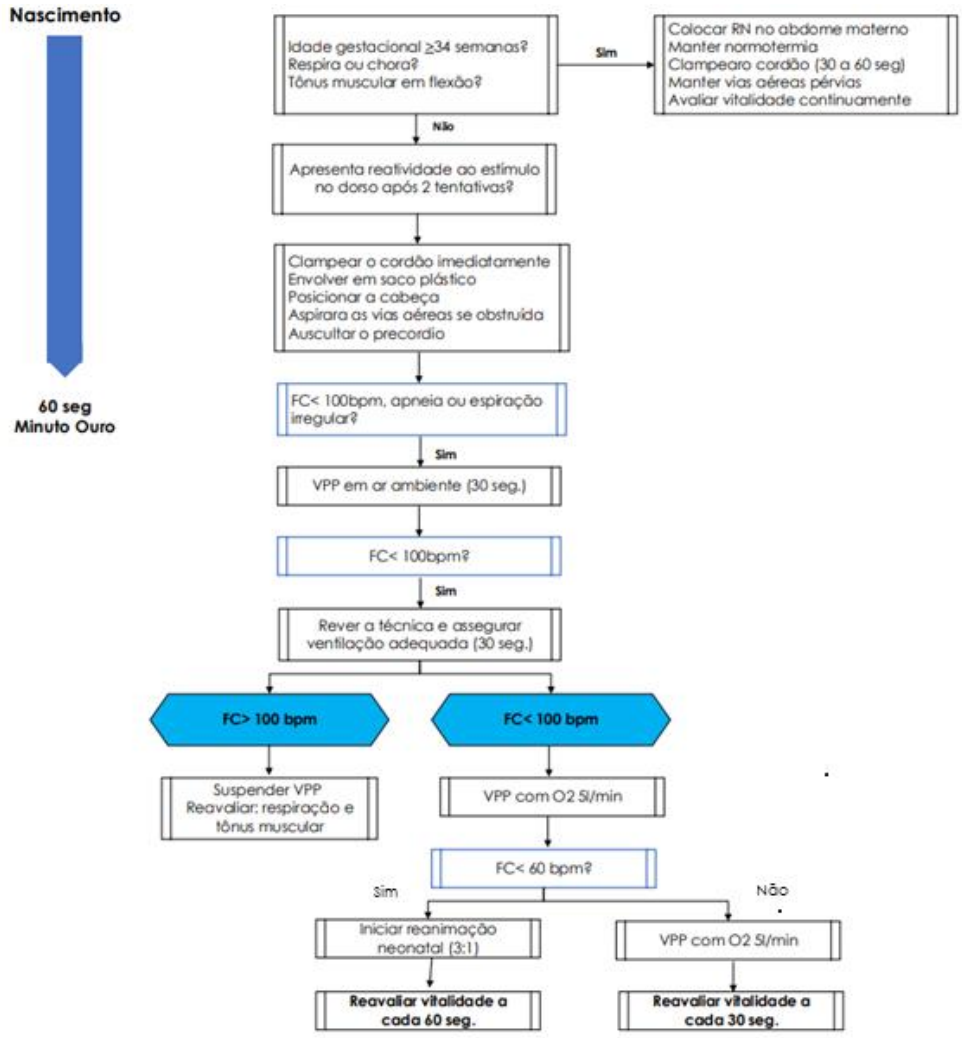
6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Fluxograma protocolo 064 – Assistência ao recém-nascido (RN) que não apresenta boa vitalidade



9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. Almeida MFB, Guinsburg R; Coordenadores Estaduais e Grupo Executivo PRN-SBP; Conselho Científico Departamento Neonatologia SBP. Reanimação do recém-nascido ≥34 semanas em sala de parto: diretrizes 2022 da Sociedade Brasileira de Pediatria. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pediatria; 2022. https://doi.org/10.25060/PRNSBP-2022-2. Disponível em: *https://www.sbp.com.br/especiais/reanimacao/* Acesso em 16/ 06/ 25.

9.2. Guinsburg R, Almeida MFB; Coordenadores Estaduais e Grupo Executivo PRN-SBP; Conselho Científico Departamento Neonatologia SBP. Reanimação do recém-nascido <34 semanas em sala de parto: diretrizes 2022 da Sociedade Brasileira de Pediatria. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pediatria; 2022. https://doi.org/10.25060/PRNSBP-2022-1. Disponível em: *https://www.sbp.com.br/especiais/reanimacao/* Acesso em 16/ 06/ 25.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
01	02/02/2026	Elaboração

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Bárbara de Souza	Carla Cristine A. Bezerra Daiane Campos de Moraes Flávia Guedes Araújo Ivone Fernandes Alves Luis Cássio Carneiro Leão	Mateus D. Miachon Lia Midori Straceri	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. O trauma na gestante pode envolver mecanismos contusos, penetrantes, térmicos, elétricos ou químicos, além de situações de quedas, acidentes automobilísticos e violência física.

1.2. Por envolver duas vítimas (mãe e feto), o trauma na gestante exige abordagem específica, pois as alterações gravídicas podem mascarar sinais de gravidade, além de modificar a resposta ao trauma e aumentar o risco de complicações.

1.3. As principais complicações decorrentes do trauma na gestante são:

- Descolamento prematuro de placenta;
- Rotura uterina;
- Parto prematuro;
- Sofrimento fetal;
- Hemorragia materna;
- Lesões abdominais e pélvicas.

2. OBJETIVOS

2.1. Descrever a abordagem pré-hospitalar realizada pela equipe do SAMU à gestante vítima de trauma.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e Central de Regulação.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Realize a avaliação da segurança de cena;

4.2. Realize a avaliação primária e intervenha conforme achados:

4.2.1. Identifique as lesões exsanguinantes e controle a hemorragia;

4.2.2. Mantenha a permeabilidade das VA e imobilize a coluna cervical;

4.2.3. Administre oxigênio de 10 a 15l/min por máscara não reinalante independente da saturação;

4.2.4. Avalie a qualidade da respiração: gestantes podem apresentar taquipneia fisiológica, porém atente-se para a presença de lesão torácica (POP IAPH SBV e SBV-E 052- Trauma de tórax);

4.2.5. Observe e anote: perdas vaginais, sangramentos, líquido amniótico, presença de contração uterina intensa e movimento fetal;

4.2.6. Avalie pele, pulso e perfusão;

4.2.7. Imobilize a pelve e/ou ossos longos se identificado instabilidade e/ou fratura – POP IAPH 094 –Imobilização da Pelve e 095 Imobilização de Extremidades;

4.2.8. Aplique a Escala de Glasgow e avalie as pupilas;

4.2.9. Exponha a vítima com critério, evitando perda de temperatura;

4.2.10. Utilize manta aluminizada;

4.3. Realize a avaliação secundária com ênfase em:

4.3.1. Monitore sinais vitais e saturação;

4.3.2. Realize o SAMPLER direcionado para as condições obstétricas;

4.3.3. Fique atento aos sinais de náuseas e presença de vômitos;

4.3.4. Realize contato com a Regulação Médica para passagem sistematizada das informações;

4.3.5. Siga as orientações da Regulação Médica para procedimentos, abordagem medicamentosa e/ou transporte para unidade de saúde;

4.4. **<u>Abordagem medicamentosa apenas na presença do enfermeiro (SBVE/ URAM):</u>**

4.4.1. Puncione acesso venoso periférico;

4.4.2. Instale solução isotônica (Ringer Lactato ou SF 0,9%) EV, para manter PAS igual ou maior 90 mmHg;

4.4.3. Administre Ácido Tranexâmico 1g diluído em 100 ml de SF 0,9%, EV, para correr em 10 minutos;

4.4.3.1. Se não houver melhora, após 30 minutos, repetir a dose do Ácido tranexâmico 1g, diluído em 100ml de SF 0,9% EV, para correr em 10 minutos (independente da origem do sangramento).

4.5. **<u>Manejo da dor apenas na presença do enfermeiro (SBV-E/ URAM):</u>**

4.5.1 Avalie intensidade da dor e medique conforme POP- IAPH SBV e SBV-E 045– Avaliação e Manejo da Dor e Vômitos;

4.6. **Em caso de náuseas e vômitos, na presença do enfermeiro em SBV-E/URAM:**

4.6.1. Administre antiemético conforme protocolo específico. (POP- IAPH SBV e SBV-E 045– Avaliação e Manejo da Dor e Vômitos);

4.6.2. Realize o transporte para unidade de saúde de destino indicada pela Regulação Médica;

4.6.3. Registre os achados e procedimentos realizados na Ficha de Atendimento.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

Vítimas encontradas em:

5.1. Decúbito dorsal: imobilize manualmente a coluna, e continue avaliação primária;

5.2. Decúbito ventral ou lateral: imobilize manualmente a coluna, realize o rolamento diretamente na prancha e proceda a avaliação;

5.3. Para gestantes acima de 20 semanas, se houver condições, mantenha-a em DLE e coloque um coxim sob o lado direito da prancha ou desloque o útero manualmente à esquerda.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP IAPH SBV e SBV-E 045 - Avaliação e Manejo da Dor e Vômitos;

6.2. POP IAPH SBV e SBV-E 052 - Trauma de tórax;

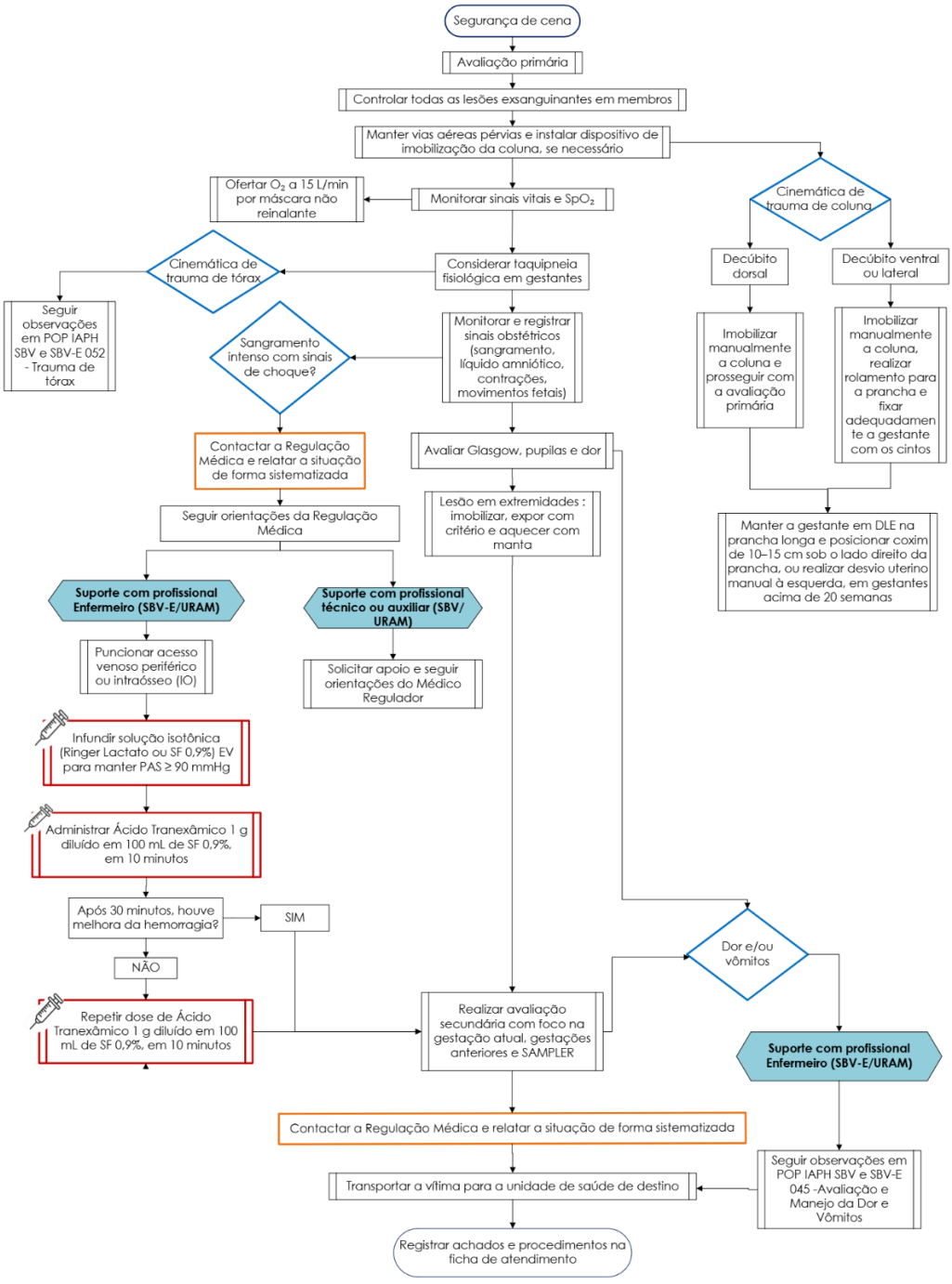
6.3. POP IAPH SBV e SBV-E 094 – Imobilização da Pelve;

6.4. POP IAPH SBV e SBV-E 095 – Imobilização de Extremidades.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA - Trauma em gestante:



9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. ALSO. Suporte Avançado de Vida em Obstetrícia, 2019.

9.2. PHTLS. Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado. National Association of Emergency Medical Technician (NAEMT), 2025. 10ª edição. 836 páginas

9.3. PHTLS. Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado. National Association of Emergency Medical Technician, 2021. 9ª edição. 762 páginas. Protocolo de Atendimento Pré-Hospitalar: Suporte Intermediário de Vida. São Paulo: Secretaria Municipal de Saúde – SAMU, 2014.4ª. Edição 112 p.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Atualização e ampliação da definição de trauma em gestante. 2. Revisão do objetivo. 3. Ampliação das áreas/equipes envolvidas, incluindo SBV, SBV-E e URAM. 4. Padronização da abordagem inicial. 5. Organização do atendimento conforme ABCDE do trauma. 6. Inclusão de referência a POPs institucionais para imobilização, trauma de tórax, manejo da dor e vômitos. 7. Atualização da abordagem medicamentosa, com critérios para acesso venoso, reposição volêmica e uso de ácido tranexâmico. 8. Reforço das orientações sobre posicionamento da gestante (DLE) e prevenção de hipotermia.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Celina H.H. Vasconcelos Edna Barbosa da Silva	Celina H. H. Vasconcelos Daiane C. de Moraes Elaine C.S.M. Machado Lydia Manhães	Bárbara de Souza Matheus D. Miachon Lia Midori Straceri	Nádia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. Pré-eclâmpsia: condição específica da gestação caracterizada pelo aumento da pressão arterial após a 20ª semana de gravidez, associado à proteinúria e/ou a sinais de disfunção de órgãos-alvo, manifestando-se por cefaleia intensa, escotomas visuais, confusão mental, dor torácica, dor no quadrante superior direito, epigastralgia, dispneia e sudorese fria; trata-se de uma condição potencialmente grave que pode evoluir para eclâmpsia, caracterizada pela ocorrência de convulsões, com risco significativo para a saúde materna e fetal;

1.2. Sinais de Pré-Eclâmpsia: Edema generalizado, PA > ou igual 140/ 90mmHg e Proteinúria (não detectável no APH);

1.3. Eclâmpsia: complicação grave da gravidez caracterizada por convulsões em mulheres com pré-eclâmpsia, resultantes de alterações no sistema nervoso central. É uma emergência obstétrica que exige tratamento imediato para evitar riscos à mãe e ao bebê.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever as ações no atendimento à gestante vítima de doença hipertensiva específica da gestação.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e Central de Regulação.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADE

4.1. Realize a avaliação da segurança de cena;

4.2. Realize a avaliação primária e secundária e intervenha conforme os achados;

4.3. Instale oxigênio por máscara não reinalante 15 l/min, independente de saturação;

4.4. Verifique os sinais vitais e a saturação;

4.5. Realize a anamnese a partir do SAMPLER: sinais e sintomas, alergias conhecidas, medicamentos em uso, histórico de hipertensão ou outras doenças na gravidez, última refeição, eventos relacionados ao problema atual;

4.6. Posicione a gestante DLE a fim de facilitar o retorno venoso;

4.7. Realize contato com a Regulação Médica para passagem sistematizada das informações;

4.8. Realize o transporte para a unidade de saúde de destino indicada pela Regulação Médica;

4.9. Atente-se para os sinais e sintomas de iminência de eclampsia.

Conduta no caso da Eclampsia

4.10. **Abordagem na presença de convulsão ao SBV:**

4.11. Realize os cuidados específicos durante a convulsão (POP IAPH SBV E SBV-E 039 Crise convulsiva no adulto).

4.12. Mantenha a gestante em DLE;

4.13. Realize contato com a Regulação Médica para passagem sistematizada das informações;

4.14. Solicite apoio SBV-E/SAV;

4.15. Realize o transporte para a unidade de saúde de destino indicada pela Regulação Médica;

Abordagem medicamentosa, na presença de convulsão, apenas na presença do enfermeiro (SBV-E):

4.16. Entre em contato com o MR e solicite autorização para abordagem medicamentosa;

4.17. Caso autorizado, puncione acesso venoso periférico ou IO;

4.18. Administre Sulfato de Magnésico segundo a apresentação disponível:

4.18.1. **Sulfato de Magnésio 10%:** administrar 4 g (ou seja, 40 ml) diluídos em 200 ml SG5%, EV em 15 minutos **OU**

4.18.2. **Sulfato de Magnésio 50%:** administrar 4 g (ou seja, 08 ml) diluídos em 200 ml SG5%, EV em 15 minutos.

4.19. Substitua o SG 5% por SF0,9% em caso de paciente diabética;

Atenção:

4.20. Se infusão do Sulfato de Magnésio for menor que 10 minutos pode haver **depressão respiratória e PCR;**

4.20.1. Em casos de evolução para depressão respiratória, Administre **Gluconato de cálcio 1g EV** (ampola 10ml à 10%), diluída em 100ml de SF 0,9% lentamente.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não administre Diazepam em gestante!

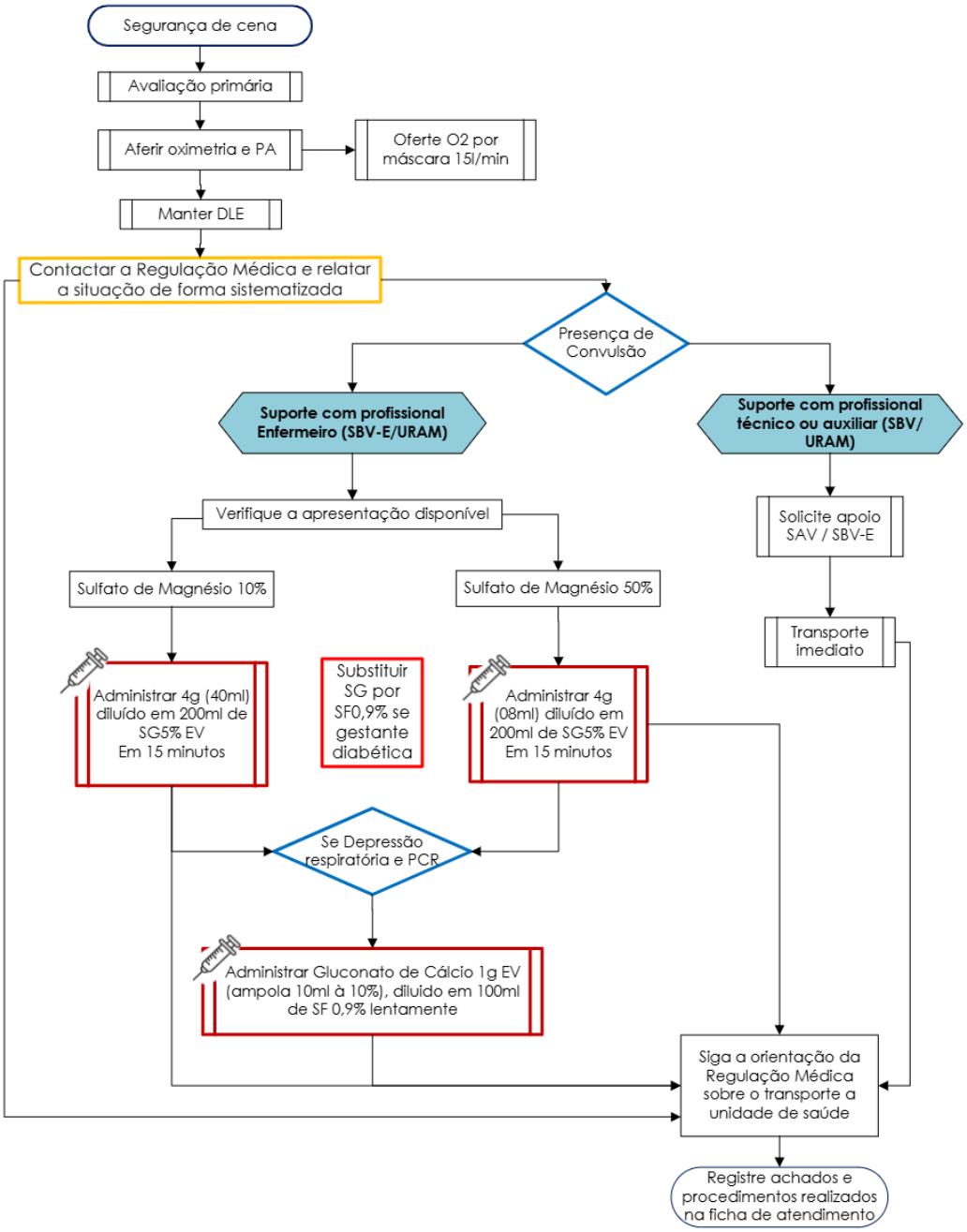
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA - Doença hipertensiva específica da gestação.



9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. ALSO. Suporte Avançado de Vida em Obstetrícia, 2019.

9.2. Karkes HÁ, Ramos JGL, de Oliveira LG, Sass N, Peraçoli JC, Cavalli RC, Martins-Costa SH, de Souza FLP, Cunha Filho EV, Mesquita MRS, Corrêa Jr MD, Araujo ACPF, Zaconeta ACM, Freire CHE, Rocha Filho EAP, Costa ML. Pré-eclampsia – Protocolo 2025. Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez (RBEHG), 2025.

9.3. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Programáticas. Manual de gestação de alto risco [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Programáticas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Alteração do nome do protocolo, de Síndrome Hipertensiva na Gestante para Doença Hipertensiva Específica da Gestação. 2. Ampliação e padronização das definições clínicas. 3. Reorganização do objetivo, mantendo o foco assistencial, porém com redação mais abrangente e atual. 4. Detalhamento das etapas de avaliação primária e secundária, incluindo segurança de cena, verificação sistemática de sinais vitais e uso do método SAMPLER. 5. Maior clareza no fluxo de comunicação com a Regulação Médica, com ênfase na passagem sistematizada de informações. 6. Estratificação das condutas na eclâmpsia conforme o nível de suporte (SBV, SBV-E), delimitando responsabilidades assistenciais. 7. Manutenção da terapêutica com Sulfato de Magnésio, sem alteração de dose, diluição ou tempo de infusão, apenas com melhor organização do texto. 8. Inclusão da conduta com Gluconato de Cálcio em caso de depressão respiratória, reforçando a segurança do paciente. 9. Inserção de recomendações de segurança, como a contraindicação do uso de Diazepam em gestantes.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Celina H.H. Vasconcelos Daiane M.F. de Souza José Caruso Lydia Manhães Wesley Almeida Santos	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nádia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. Hemorragia na gestação: qualquer sangramento que ocorre durante a gravidez, seja no início (primeiro trimestre), no meio ou no final da gestação. Ela pode variar desde pequenos sangramentos vaginais, como na implantação embrionária, até perdas sanguíneas intensas que colocam em risco a vida da mãe e do bebê, como no descolamento prematuro de placenta ou placenta prévia.

1.2. Os sinais de instabilidade hemodinâmica incluem: frequência cardíaca (FC) > 100 bpm, pressão arterial sistólica (PAS) < 100 mmHg, pressão arterial diastólica (PAD) < 60 mmHg ou índice de choque ≥ 0,9. O índice de choque é calculado pela divisão da frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica; valores superiores a 1 indicam instabilidade hemodinâmica importante.

1.3. Fatores de risco para hemorragia na gestação: hipertensão gestacional, hemorragia em gestações anteriores, tabagismo, gestantes muito jovens ou acima de 35 anos, gestação múltipla e alterações placentárias como placenta prévia, descolamento prematuro, macrossomia, polidrâmnio e grande multiparidade. Além disso, a presença de cesarianas anteriores aumenta o risco de problemas na implantação placentária, contribuindo para episódios hemorrágicos ao longo da gravidez.

1.4. Hemorragia pós-parto: definida como a perda sanguínea, após o parto, igual ou acima de 500 ml ou ≥ 300 ml acompanhada de qualquer alteração nos sinais vitais: FC > 100 bpm; índice de choque maior que 1; PAS < 100 mmHg ou PAD < 60 mmHg.

1.5. Fatores de risco no pós-parto: trabalho de parto prolongado, rotura uterina, lacerações perineais de 3º e 4º graus, placenta prévia, placenta acreta e retenção placentária.

1.6. Principais causas de hemorragia pós-parto, utilizando o mnemônico **"4 Ts":**

Tônus: causado pela atonia uterina;

Trauma: trauma no trato genital;

Tecido: retenção do tecido placentário;

Trombina: Anormalidades da coagulação.

2. OBJETIVOS

2.1. Descrever as ações no atendimento à gestante e puérpera que apresentam síndrome hemorrágica.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e Central de Regulação.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Realize a avaliação da segurança de cena;

4.2. Realize avaliação primária e intervenha nos achados;

4.3. Monitore sinais vitais e saturação;

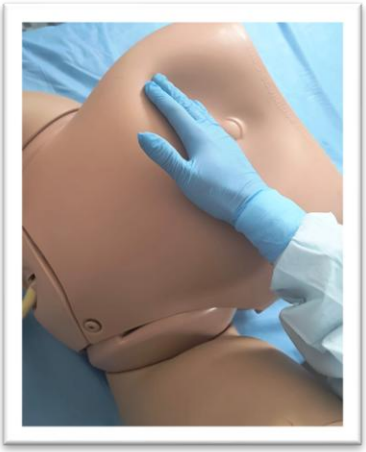
4.4. Administre O_2 15 litros/minuto por máscara não-reinalante, se saturação < 94%;

4.5. Avalie a quantidade de perda sanguínea no trato genital;

Se síndrome hemorrágica pós-parto (HPP):

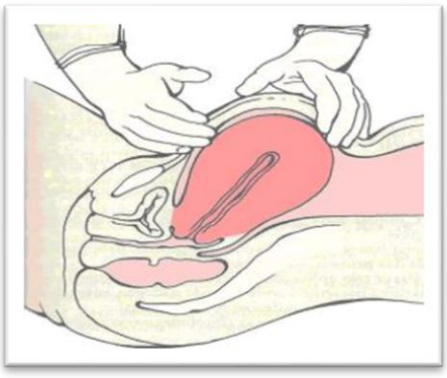
4.6. Avalie se houve a dequitação da placenta;

4.7. Palpe o fundo uterino, avaliando tônus uterino abdominal (involução uterina);



4.8. Se identificado atonia uterina, realize massagem externa no fundo uterino com o objetivo de estimular o globo de segurança de Pinard;

4.8.1. A massagem uterina como medida terapêutica é definida como a fricção do útero por meio de massagem manual do abdômen;



Se síndrome hemorrágica na gestação ou no pós-parto (HPP):

4.9. Passe o caso para o MR;

Abordagem medicamentosa apenas na presença do enfermeiro (SBV-E/ URAM):

4.9.1. Puncione acesso venoso periférico;

4.9.2. Instale solução isotônica (Ringer Lactato ou SF 0,9%) EV, para manter PAS igual ou maior 90 mmHg;

4.9.3. Administre Ácido Tranexâmico 1g diluído em 100 ml de SF 0,9%, EV, para correr em 10 minutos;

4.9.3.1. Se não houver melhora, após 30 minutos, repetir a dose do Ácido tranexâmico 1g, diluído em 100ml de SF 0,9% EV, para correr em 10 minutos (independente da origem do sangramento).

4.10. Realize o SAMPLER com ênfase no histórico obstétrico, que deve ser objetivo, direcionado e rápido, focando elementos que influenciam o risco materno e fetal, bem como a conduta pré-hospitalar. Questione:

4.10.1. Idade gestacional (semanas), ou data do parto (se pós-parto);

4.10.2. Tipo de gestação – única ou gemelar;

4.10.3. Início do sangramento -quando começou, se foi súbito ou gradual, se aumentou com o tempo;

4.10.4. Quantidade e características do sangramento – sangue vivo/vermelho brilhante ou escuro, se há presença de coágulos.

4.10.5. Dor associada – se há dor abdominal, a localização da dor, se é uma dor constante ou tipo cólica;

4.10.6. Atividade uterina – Contrações sim ou não, qual a frequência;

4.10.7. Percepção fetal – se percebeu o bebê mexer hoje, se houve diminuição;

4.10.8. História obstétrica prévia - número de gestações anteriores, abortos prévios, partos cesáreos (importante para risco de placenta acreta ou ruptura uterina). Se houve hemorragia em gestação anterior;

4.10.9. Complicações nesta gestação – se Placenta prévia diagnosticada, risco de placenta acreta, hipertensão, uso de coagulantes;

4.10.10. Traumas recentes - queda, acidente, agressão, pancada no abdome.

4.10.11. Perdas de líquido – suspeita de ruptura de bolsa – data e horário do início da perda de líquido, cor e odor do líquido.

4.10.12. Outros sintomas associados – tontura, síncope, palidez, sinais de choque. Náuseas, sudorese.

4.10.13. Grupo sanguíneo (se souber) – Importante para transfusão e risco Rh.

4.11. Evite hipotermia utilizando manta aluminizada.

4.12. Transporte para a unidade de saúde segundo orientação do MR.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Em casos de aborto, todo o produto expelido deverá ser identificado, acondicionado em saco branco leitoso e encaminhado à unidade de saúde;

5.2. A quantificação da perda sanguínea pode ser feita pelo peso das compressas, por esse motivo não despreze as compressas com sangue.

5.3. Armazene em saco plástico e entregue na unidade de saúde na passagem do caso.

5.4. O tamponamento com gazes ou com agentes hemostáticos não são recomendados para o tratamento da hemorragia em gestante ou pós-parto.

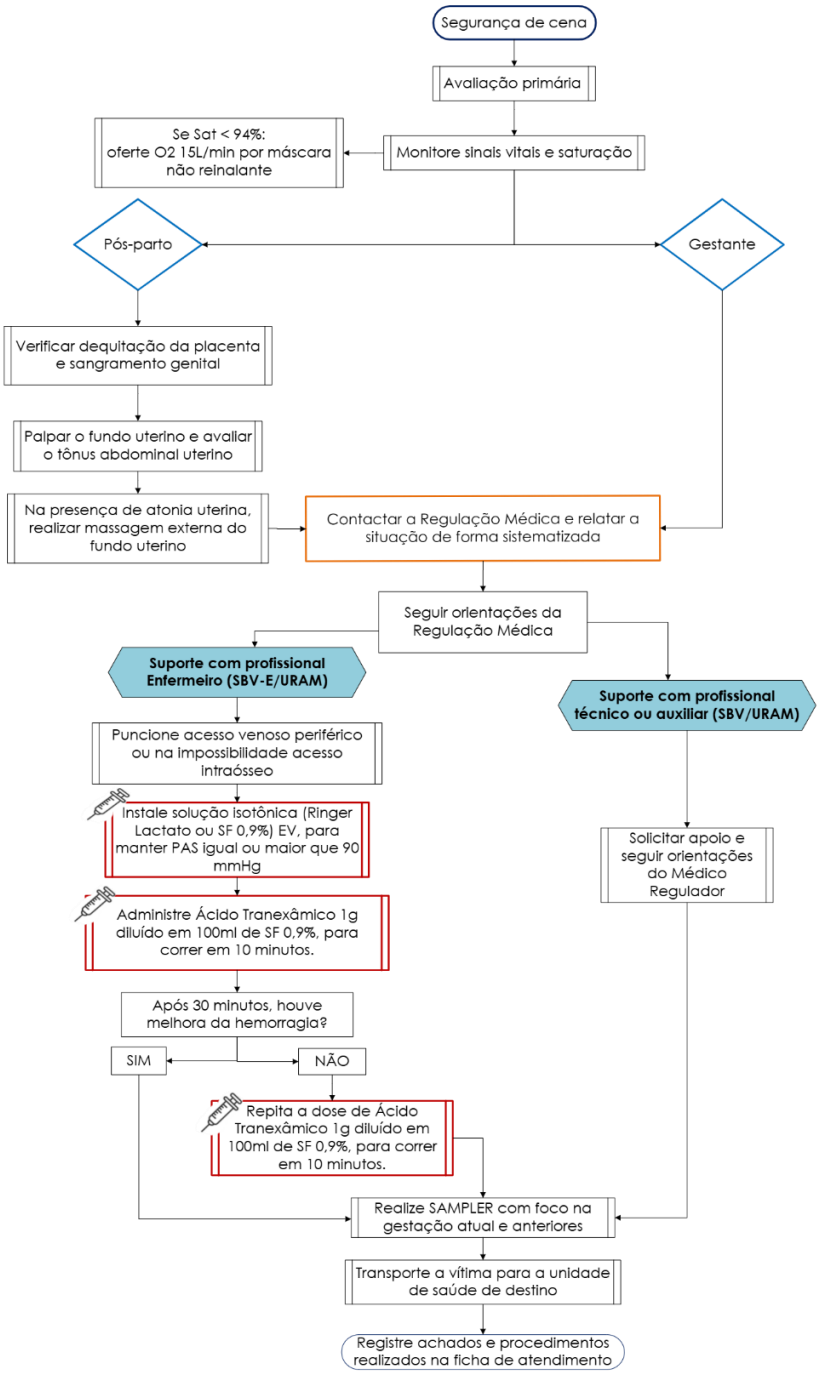
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA -Síndrome hemorrágica na gestação ou pós-parto



9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. ALSO. Suporte Avançado de Vida em Obstetrícia, 2019.

9.2. OMS. Recomendações da Organização Mundial da Saúde para a prevenção e o tratamento da hemorragia pós-parto. Genebra: Organização Mundial da Saúde, 2012. Disponível em: https://www.who.int/pt/publications/i/item/9789241548502

9.3. ALVES, Álvaro Luiz Lage; FRANCISCO, Adriana Amorim; OSANAN, Gabriel Costa; VIEIRA, Laíses Braga. Postpartum hemorrhage: prevention, diagnosis and non-surgical management. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, v. 42, n. 11, 2020. DOI: 10.1055/s-0040-1721882.

9.4. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Programáticas. Manual de gestação de alto risco [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Programáticas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2022. 692 p.: il.

9.5. Diretrizes consolidadas para prevenção, diagnóstico e tratamento de hemorragia pós-parto, Organização Mundial da Saúde 2025

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização: 1. Unificação dos protocolos de SBV e SIV 2. Ampliação e atualização das definições clínicas 3. Incorporação de critérios objetivos de instabilidade hemodinâmica 4. Inclusão de fatores de risco na gestação e no pós-parto 5. Padronização das causas de hemorragia pós-parto pelo mnemônico "4 Ts" 6. Revisão e ampliação do objetivo do protocolo 7. Atualização das áreas e estruturas operacionais envolvidas 8. Reestruturação e detalhamento dos procedimentos assistenciais 9. Inclusão de avaliação específica do tônus uterino e dequitação placentária 10. Incorporação da massagem uterina como conduta terapêutica 11. Inclusão de abordagem medicamentosa com Ácido Tranexâmico ao SBV-E 12. Padronização da abordagem de acesso venoso e reposição volêmica 13. Estruturação da anamnese pelo método SAMPLER com foco obstétrico 14. Ampliação das medidas de suporte e prevenção de hipotermia 15. Atualização das orientações para comunicação e regulação médica 16. Inclusão de observações e recomendações técnicas finais

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Celina H.H. Vasconcelos	Celina Hiromi H. Vasconcelos Lydia Manhães Luis Cássio Carneiro Leão Simone Cedano Ramos	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nádia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. Emergências Psiquiátricas no pré-hospitalar: situações em que o paciente apresenta alterações comportamentais e/ou mentais agudas que colocam em risco sua própria vida ou a de terceiros, ou que impossibilitam o autocuidado imediato. No contexto do atendimento pré-hospitalar, essas emergências incluem, mas não se limitam a: tentativas de suicídio, automutilação, crises de agitação psicomotora, episódios psicóticos agudos, intoxicações associadas a comportamento agressivo e manifestações de ansiedade ou depressão severas que comprometem a segurança do paciente ou de terceiros.

1.2. Contenção física: é o emprego de meios físicos externos que interfiram na liberdade de movimentos corporais do paciente, com a finalidade de impedir que pratique ato violento de heteroagressão ou autoagressão, utilizada em vítimas que estejam em quadro de agitação psicomotora e deve ter como objetivo primordial sua proteção, de outras pessoas, incluindo a equipe.

2. OBJETIVOS

2.1. Descrever as ações da equipe do SAMU 192 São Paulo no atendimento a vítima acometida de transtornos mentais leves, moderados e graves.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, SAV, URAM e Central de Regulação

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Durante o trajeto, certifique-se com a Central de Regulação sobre a necessidade de apoio do policiamento ou Corpo de Bombeiros;

4.2. Ao chegar ao local certifique-se que a cena está segura e peça apoio nas seguintes situações:

4.2.1. Risco para equipe, paciente, família ou circundantes;

4.2.2. Vítima agressiva ou portando algum tipo de arma;

4.2.3. Vítima atentando contra a própria vida.

4.3. Utilize o mnemônico **ACENA**

4.3.1. **A** – Arredores: considere todo um cenário ambiental, incluindo artefato que possa se transformar em arma contra si ou contra terceiros;

4.3.2. **C** – Conflitos: que possam existir com os familiares e ambiente social, dificultando sua aproximação e a realização dos procedimentos;

4.3.3. **E** – Expectativa: atente-se quanto às expectativas da família/paciente, que possam interferir no atendimento;

4.3.4. **N** – Nível de consciência: avalie o estado mental/ comportamento.

Considerar a avaliação das alterações:

- Afeto: embotamento, distanciamento, empobrecimento, labilidade afetiva, exaltação afetiva;

- Atenção: hipoprosexia (diminuição da atenção da capacidade de atenção), distração;
- Linguagem: acelerada (logorreia), repetição dos sons emitidos (ecolalia), criação de linguagem (neologismo);
- Pensamento: ideias delirantes (persecutória),
- Senso percepção: ilusão, alucinação, despersonalização ou estado de fuga (esquece sua identidade);
- Vontade: ausência (abulia), diminuição (hipobulia) e exacerbação (hiperbulia);
- Entre outros: alteração no senso ético moral; hipercinesia, estereotipia (ações desprovidas de finalidade) e estupor.

ATENÇÃO

As alterações das funções mentais estão correlacionadas umas com as outras.

Lembre-se que as alterações podem ser por fatores orgânicos e psíquicos.

4.3.5. **A** – Agressividade e agitação psicomotora, como elementos das alterações comportamentais (atente-se para vítimas jovens e usuários de substâncias químicas).

4.4. Realize a investigação direcionada aos familiares ou pessoas presentes para a pesquisa de:

4.4.1. Doença psiquiátrica;

4.4.2. Uso de medicamentos;

4.4.3. Uso de álcool ou drogas e/ou abstinência com comportamento agressivo/violento;

4.4.4. Tratamentos realizados;

4.4.5. Comportamento nos últimos dias;

4.5. Realize aproximação cautelosa, identifique-se e diga que quer ajudá-lo;

4.6. Utilize o mnemônico **AEIOU** para situações de crises e primeiros socorros psicossociais:

4.6.1. **A**: Apoio/ajuda: estabeleça uma relação de confiança e construção de vínculo;

4.6.2. **E**: Escute as expressões de pensamentos e sentimentos do paciente: busque compreender as necessidades e preocupações, validando seus sentimentos e deixando-o falar sem pressionar;

4.6.3. **I**: Identifique fatores de risco: situações que aumentem a probabilidade de agravo no problema encontrado e fatores de proteção que possam aumentar a sensação de proteção para a pessoa, verifique o que pode ajudar a vítima a perceber-se protegida ao invés de ameaçada, por exemplo: estar com família;

4.6.4. **O**: Oriente: apresente elementos que possam orientar a pessoa quanto a diminuir agravantes da situação vivida em questão;

4.6.5. **U**: Ultimize o que foi e está sendo realizado com a vítima: apresente um resumo de tudo o que foi feito, mostrando que a vítima foi respeitada, ouvida e que a assistência prestada é para seu benefício, garantindo uma finalização segura no atendimento;

4.7. Mantenha contato visual;

4.8. Mantenha postura calma, empática e acolhedora;

4.9. Tente direcionar a vítima para um local calmo e com privacidade;

4.10. Respeite pausas silenciosas;

4.11. Não complete frases;

4.12. Estimule elaboração das ideias;

4.13. Faça perguntas abertas, favorecendo a fala (sem pressionamentos);

4.14. Não dê conselhos e evite emitir opinião pessoal;

4.15. Não permita que a vítima se torne "entrevistador";

4.16. Utilize frases curtas e se necessário, repetidas;

4.17. Não julgue;

4.18. Após estabelecer o vínculo e a vítima estiver calma, encaminhe-a para a ambulância e coloque-a na maca, utilizando os 03 cintos;

4.18.1. Caso não haja formação de vínculo e a vítima estiver agressiva, comunique a família e aplique contenção física utilizando material adequado (Kit de contenção);

4.19. Avalie sempre a vítima durante o transporte e caso ocorra alteração do comportamento de vítima calma para agressiva, comunique a família, pare a ambulância e realize a contenção;

4.20. Indicação de contenção física:

4.20.1. Abordagem verbal inviável ou pouco efetiva;

4.20.2. Auto/hetero agressividade;

4.20.3. Possibilidade de evasão do local;

4.20.4. Vítima em um ambiente de risco.

ATENÇÃO

4.21. Técnica para realização da contenção física está descrita no POP IAPH SBV e SBV-E- 098 - Contenção física e mecânica;

4.22. Solicite autorização da família para realizar a contenção;

4.23. Caso a família não autorize a contenção, comunique ao médico regulador (MR) e solicite apoio do SAV;

4.24. Após autorização da família, realize a contenção utilizando o Kit apropriado, evitando comprometer a circulação do membro;

4.25. Passe o caso para o MR;

4.26. Transporte para a unidade de saúde conforme orientação do MR;

4.27. Evite uso de sirene durante o transporte.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não há.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP IAPH SBV e SBV-E- 098 -Contenção física e mecânica;

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. MANTOVANI, C.; MIGON, M. N.; ALHEIRA, V. Manejo de paciente agitado ou agressivo. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, v. 32, supl. 2, p. 96-103, 2010.

9.2. BRASIL. Ministério da Saúde; Governo do Distrito Federal. *Atendimento pré-hospitalar em saúde mental: noções das urgências e emergências em saúde mental*. Brasília, DF, 2021. 1. ed.

9.3. SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal de Saúde – SAMU. *Protocolo de Atendimento Pré-Hospitalar: Suporte Intermediário de Vida*. 4. ed. São Paulo, 2014. 112 p.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Unificação dos protocolos de SBV e SIV 2. Atualização do escopo clínico e conceitual 3. Ampliação e detalhamento das definições de emergências psiquiátricas no pré-hospitalar 4. Padronização e formalização do conceito de contenção física 5. Revisão e ampliação do objetivo do protocolo 6. Reorganização e maior detalhamento dos procedimentos assistenciais 7. Estruturação da avaliação de cena e segurança 8. Manutenção e aprimoramento do uso do mnemônico ACENA 9. Ampliação das orientações sobre avaliação das funções mentais 10. Reestruturação e detalhamento do uso do mnemônico AEIOU 11. Ampliação das diretrizes de comunicação terapêutica 12. Detalhamento das condutas de manejo comportamental e ambiental 13. Padronização das indicações de contenção física 14. Vinculação da técnica de contenção a POP institucional específico 15. Reforço das orientações éticas e legais para autorização familiar

Última validação	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Marcos A Campoy	Carla C. A. Bezerra Daiane C. de Moraes Raquel Jacobs de Lima	Amanda de Ornelas Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Rosa Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. Comunicação de óbito: Informação formal e clara sobre a morte da vítima a familiares ou responsáveis;

1.2. Familiares diretos: Parentes de primeiro grau ou pessoas próximas no local do evento.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever as ações do enfermeiro no atendimento aos familiares e/ou responsáveis da vítima em morte óbvia.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e Central de Regulação

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADE

4.1. Após a verificação de morte óbvia (POP IAPH SBV e SBV-E 023 – Evidência de Morte Óbvia no Local da Ocorrência), registre horário e condições constatadas;

4.2. Defina quem fará a comunicação

4.2.1. Em equipe de SBV-E preferencialmente o enfermeiro;

4.3. Escolha local reservado, preferencialmente afastado de curiosos e da vítima.

4.4. Mantenha postura calma e respeitosa.

4.5. Apresente-se novamente ao familiar com nome e função.

4.6. Informe sobre o atendimento prestado.

4.7. Comunique a morte de forma clara e direta: "Infelizmente, apesar de todos os procedimentos realizados, [nome] não resistiu e faleceu."

4.8. Faça pausa e permita a reação emocional.

4.9. Acolha com empatia, escute sem interromper.

4.10. Use frases de apoio simples, sem prometer o que não pode cumprir.

4.11. Oriente sobre os próximos passos (IML, hospital, polícia).

4.12. Registre nome do familiar informado, horário e reação.

4.13. Reforce a segurança da equipe diante de possíveis reações agressivas.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não há.

6. DOCUMENTO RELACIONADO

6.1. POP IAPH SBV e SBV-E 023 – Evidência de Morte Óbvia no Local da Ocorrência

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. CAMPOS, Daniela. Comunicação de más notícias em contexto de morte súbita no serviço de urgência. 2020. Dissertação (Mestrado) – INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE, ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE, 12 out. 2020. Scoping Review e desenvolvimento de intervenção formativa sobre comunicação de más notícias no contexto de morte súbita em serviço de urgência.

9.2. Atendimento pré-hospitalar em saúde mental: noções das urgências e emergências em saúde mental. Ministério da Saúde. 1° edição. Brasília, D.F. 2021.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
02	02/02/2026	Atualização 1. Alteração do nome do protocolo, de "Comunicação de Má Notícia" por "Comunicação de Óbito". 2. Delimitação clara do escopo do procedimento, direcionado exclusivamente à comunicação de morte óbvia. 3. Alinhamento com os protocolos operacionais do IAPH, incluindo referência ao POP de Evidência de Morte Óbvia. 4. Reforço da postura profissional, comunicação clara e empática com familiares e responsáveis. 5. Inclusão de orientações sobre registro formal da comunicação, identificação do familiar informado e horário. 6. Ênfase na segurança da equipe diante de possíveis reações emocionais ou agressivas.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes	Daiane C. de Moraes Lilian Maria de Oliveira Jaqueline Flor da França Fabiana Amparo Ferraz	Bárbara de Souza Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. Desinfecção: é o processo físico ou químico que elimina microrganismos patogênicos de objetos e superfícies, exceto esporos bacterianos. É realizada após a limpeza de superfícies com material biológico utilizando solução desinfetante em serviços de saúde.

1.2. Material biológico: todas as secreções orgânicas potencialmente contaminadas, como: sangue, vômito, urina, fezes, entre outros.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever as ações da equipe de intervenção para limpeza da superfície da ambulância na presença de material biológico.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E e SAV

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADE

4.1. Realize a higienização da AM imediatamente após a condução do caso, ainda nas dependências da unidade de saúde;

4.2. Use EPI para a tarefa a ser executada (luvas, máscara, avental e óculos);

4.3. Reúna os materiais e produtos necessários para executar a limpeza:

4.3.1. Pano de limpeza;

4.3.2. Borrifador com produto saneante hospitalar para superfícies fixas (produto já pronto para o uso, que efetua limpeza e desinfecção simultaneamente).

4.4. Retire o excesso de material biológico com auxílio de pano de limpeza seco e despreze no lixo branco;

4.5. Espalhe o produto sobre a superfície aplicando a solução, com jatos de spray ou sobre o pano (para limpeza de equipamentos) e aguarde o tempo indicado pelo fabricante;

4.6. Repita a operação se necessário;

4.7. Não seque;

4.8. Descarte o pano de limpeza no lixo apropriado;

4.9. Proceda a limpeza concorrente (protocolo específico);

4.10. Após término da limpeza, antes de deixar a unidade de saúde, comunique a central de regulação sobre QAP/QRV.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. A realização da limpeza da ambulância é uma ação coletiva e de responsabilidade de TODOS os componentes da equipe. Sua realização de forma coordenada minimiza o tempo consumido e agiliza a disponibilização da equipe para atendimentos

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo de Suporte Básico de Vida. Brasília: Ministério da Saúde, [s.d.]. Disponível em: *https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_suporte_basico_vida.pdf*. Acesso em: 28 ago. 2025.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Padronização conceitual e técnica da limpeza/desinfecção 2. Atualização do fluxo e momento da higienização da ambulância 3. Atualização de materiais, produtos e uso de EPI 4. Reorganização das responsabilidades da equipe 5. Padronização da comunicação com a Central de Regulaçã

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia O. Lopes	Camila M. Okiyama Dermival O. Xavier Fabiana Lima Ribeiro Fernanda Vaz Toste Márcia Cristina L Barreiros Maria Carolina Tufolo Renan de S. M. Gonçalves Simone Cedano Ramos	Amanda de Ornelas Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nádia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. Limpeza concorrente: é a manutenção diária da limpeza de superfícies, visando diminuir risco de infecção, devendo ser realizada no início do plantão e após cada atendimento, recolhendo resíduos conforme a classificação e identificando eventuais falta de materiais ou equipamentos com falhas.

1.2. Desinfecção: é o processo físico ou químico que elimina microrganismos patogênicos de objetos e superfícies, exceto esporos bacterianos. É realizada após a limpeza de superfícies com matéria orgânica, como sangue, fluidos corporais, fezes, urina, vômito ou escarro, utilizando solução desinfetante em serviços de saúde.

1.3. Saneantes de uso profissional: são produtos destinados à limpeza e desinfecção em locais que exigem maior rigor, como hospitais, clínicas, laboratórios e indústrias, não sendo de venda livre ao público em geral. Seu uso requer capacitação, pois possuem ação antimicrobiana ou fórmulas mais potentes, enquadrando-se na ANVISA como produtos de Risco 2.

2. OBJETIVOS

2.1. Descrever a limpeza e desinfecção que deverá ser efetuada na AM a cada início de plantão, após atendimento, e sempre que necessário.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV e SBV-E, SAV e VIR

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADE

4.1. A limpeza concorrente deve ser realizada diariamente no início de cada plantão e/ou após cada paciente transportado;

4.2. Use EPI para a tarefa a ser executada (luvas, máscara e óculos);

4.3. Reúna os materiais e produtos necessários para executar a limpeza:

4.3.1. Pano de limpeza

4.3.2. Borrifador com produto saneante hospitalar para superfícies fixas (produto já pronto para o uso, que efetua limpeza e desinfecção simultaneamente).

4.4. Inicie a limpeza pela dianteira do salão em direção à porta traseira, e no sentido do teto em direção ao chão;

4.5. Inicie a limpeza aplicando a solução, com jatos de spray, preferencialmente sobre o pano, espalhe a espuma sobre a superfície, deixando agir por 10 minutos;

4.6. Deixe secar naturalmente;

4.7. Sempre que houver presença de matéria orgânica em superfície, realize a desinfecção;

4.8. Comunique a central de operações antes de iniciar a desinfecção, mantendo-se em QAP;

4.9. Proceda a limpeza da maca fora da AM;

4.10. Coloque novo lençol descartável na maca ao final da limpeza;

4.11. Após término da desinfecção, comunique a central de operações QAP/QRV.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Na presença de matéria orgânica, siga o POP 073 – Intervenções em atendimento Pré-hospitalar – Limpeza de superfície com presença de material biológico.

5.2. A realização da limpeza da ambulância é uma ação coletiva e de responsabilidade de TODOS os componentes da equipe. Sua realização de forma coordenada minimiza o tempo consumido e agiliza a disponibilização da equipe para atendimentos.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP 073 – Intervenções em atendimento Pré-hospitalar – Limpeza de superfície com presença de material biológico.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Manual de limpeza e desinfecção de superfícies. Brasília: ANVISA, 2020. Disponível em: *https://www.gov.br/anvisa/pt- br/centraisdeconteudo/ publicações/serviços de* saude/publicacoes/manual-de-limpeza-e-desinfeccao-de-superficies.pdf. Acesso em: 04 set. 2025.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Atualização e ampliação das definições, diferenciando limpeza concorrente, desinfecção e uso de saneantes hospitalares. 2. Expansão das áreas envolvidas, contemplando SBV, SBV-E, SAV e VIR. 3. Padronização da rotina de limpeza concorrente diária, com critérios objetivos de quando realizar limpeza e desinfecção. 4. Atualização dos EPIs e materiais, alinhados às práticas atuais de biossegurança. 5. Detalhamento do fluxo de comunicação com a Central, incluindo momentos específicos de QAP/QRV. 6. Reforço da responsabilidade coletiva da equipe na execução da limpeza, visando agilidade e segurança.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cássia Oliveira Lopes	Aline Braga da Silva Camila Mayumi Okiyama Eline Prisca da Silva Lidinaide Maria da Costa Maíra Costa Renan M. de S. Gonçalves Viviane Soares de Freitas	Amanda de Ornelas Bárbara de Souza Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. Limpeza Terminal: Processo de limpeza e desinfecção realizada na parte interna, mobiliário e equipamentos da ambulância, incluindo as superfícies horizontais e verticais realizado de forma periódica e/ou sempre que necessário nos casos de suspeita de doença infectocontagiosa ou excessiva sujeira, como material biológico;

1.2. Limpeza: Processo de remover a sujidade e matéria orgânica de qualquer superfície ou objeto. No atendimento pré-hospitalar, é realizada por meio fricção mecânica, com água e sabão. É facultado o uso de limpador de superfície sob fricção em substituição à água e ao sabão.

1.3. Desinfecção: Processo químico ou físico que elimina micro-organismos patogênicos na forma vegetativa presentes em superfícies inertes, exceto os esporulados.

2. OBJETIVO

2.1. Padronizar a rotina de limpeza terminal dos veículos de emergência do SAMU 192 São Paulo.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, SAV e Central de Regulação e VIR

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. A frequência de limpeza terminal deve ser, ao menos, 1 (uma) vez por semana e sempre que houver contaminação visível, derramamento de fluidos, ou transporte de paciente com doença infectocontagiosa;

4.2. As escalas fixas de limpeza terminal devem ser enviadas por e-mail para a Central de Regulação, com até 2 (dois) dias de antecedência (Anexo 1);

4.3. Cada coordenadoria regional é responsável pela elaboração da escala de rotina, de acordo com as particularidades da região e das equipes, no entanto esta deve ser pautada respeitando os horários: no período diurno, deve ter início até às 9:00. A programação de limpeza terminal no período noturno, deve ser realizada após às 23:00;

4.4. A limpeza terminal de rotina deve ser realizada, respeitando dia e turno conforme programado em escala (Anexo 1).

4.5. Consulte a escala de limpeza terminal da ambulância e solicite ao CORE autorização para iniciar a limpeza terminal. Com a permissão concedida, a ambulância será colocada no sistema temporariamente como indisponível pelo período de 01 (uma) hora;

4.6. Use EPI para a tarefa a ser executada (luvas de borracha, máscara, avental e óculos);

4.7. Reúna os materiais e produtos necessários para executar a limpeza:

4.7.1. Pano de limpeza descartável;

4.7.2. Borrifador com desinfetante de uso em estabelecimentos de saúde, para superfícies fixas (produto já pronto para o uso);

4.8. Retirar equipamentos e materiais de dentro da ambulância: maca, cadeira de rodas, mochilas, materiais do armário, coletor de resíduos infectantes e perfurocortantes. Não retirar cilindros de oxigênio;

4.8.1. A retirada deve ser feita por compartimentos, não retirando tudo de uma vez, para garantir prontidão em casos de acionamento prioritário.

4.9. A limpeza e desinfecção deve ser realizada em todas as superfícies horizontais e verticais, internas e externas, além de equipamentos médico-hospitalares, com atenção aos locais que contenham matéria orgânica e aos mobiliários que podem constituir risco de contaminação para pacientes e equipe;

4.10. Proceda a limpeza da maca fora da AM;

4.11. Aplique a solução com jatos de spray, preferencialmente sobre o pano e espalhe a espuma, deixando permanecer na superfície pelo tempo especificado de acordo com o fabricante;

4.12. Iniciar a limpeza das estruturas fixas do salão da ambulância, da cabine ao fundo do salão, em direção à porta traseira, e de cima para baixo, incluindo teto, paredes laterais, armários e por fim o piso (inclui luminárias, armário vertical, suportes, gavetas, baú, gaveta de lixo, vidros, telefone, tablet, maçanetas, painel de gases, grades de ar condicionado e superfície dos cilindros de oxigênio, entre outros;

4.12.1. A limpeza do piso e do teto deve ser realizada com movimentos em sentido unidirecional;

4.13. No piso: realizar 'varredura úmida' (com uso de rodo e pano) antes de iniciar o procedimento de limpeza;

4.14. Deixar secar naturalmente;

4.15. Coloque novo lençol descartável na maca ao final da limpeza;

4.16. Não deve ser utilizada água em excesso e/ou diretamente no piso, sob risco de infiltração e dano à estrutura do veículo.

4.17. Realizar a limpeza externa da ambulância utilizando balde com água e sabão e enxaguar rápido.

4.18. Assinar e carimbar o impresso "Controle de Limpeza Terminal" (Anexo 2);

4.19. Informar a Central de Regulação o término da limpeza terminal.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. A não realização da limpeza conforme escala de rotina deve ser registrada em impresso fixo na base e comunicada ao gerente, para que seja programada a limpeza o quanto antes;

5.2. Caso tenha alguma ocorrência prioritária no momento que a equipe solicitar a realização da limpeza terminal, os mesmos devem dirigir-se para o atendimento e realizar a limpeza posteriormente;

5.3. Em situações especiais de intensa sujidade devido ao tipo de atendimento, a limpeza terminal poderá ser realizada fora da rotina estabelecida, devendo ser acordada juntamente com o CORE;

5.4. Na presença de material biológico, seguir POP 073 – Intervenções em atendimento Pré-hospitalar – Limpeza de superfície com presença de material biológico.

5.5. A limpeza terminal deve ser feita em todos os recursos, incluindo as reservas.

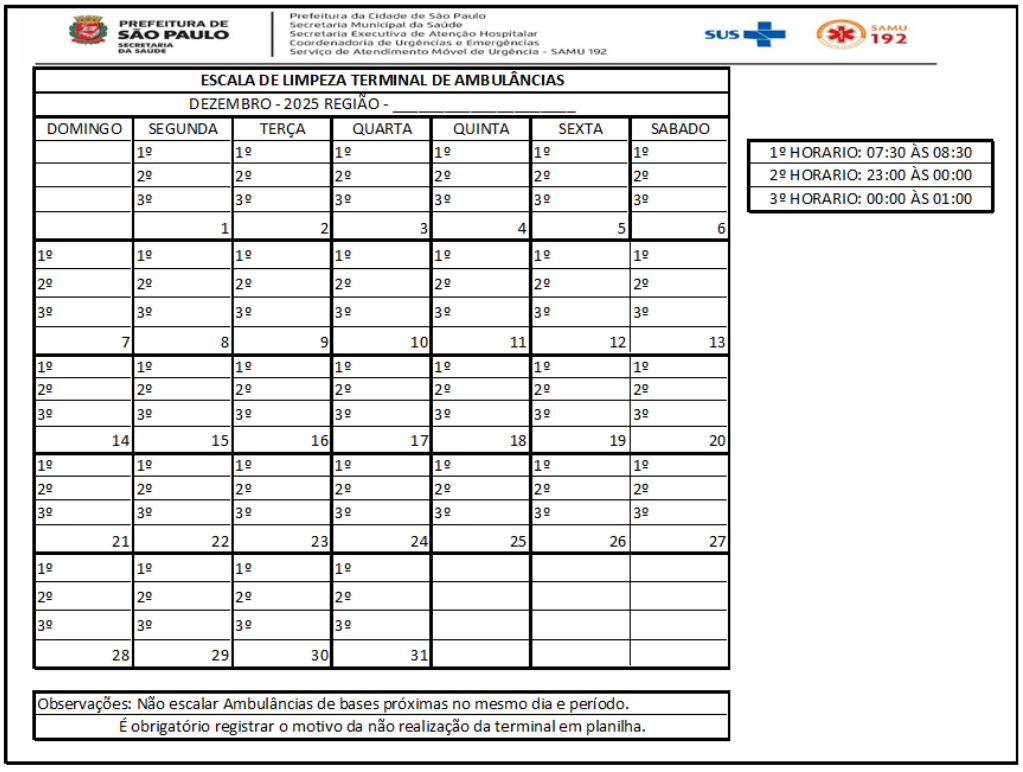
5.6. A limpeza terminal deve ser realizada, preferencialmente, na base.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP 073 – Intervenções em atendimento Pré-hospitalar – Limpeza de superfície com presença de material biológico.

7. ANEXOS

7.1. Exemplo de escala de Limpeza Terminal:



PREFEITURA DE SÃO PAULO SECRETARIA DA SAÚDE | Prefeitura da Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Executiva de Atenção Hospitalar, Coordenadoria de Urgências e Emergências, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | SUS | SAMU 192

ESCALA DE LIMPEZA TERMINAL DE AMBULÂNCIAS

DEZEMBRO - 2025 REGIÃO - _____

DOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO
	1º	1º	1º	1º	1º	1º
	2º	2º	2º	2º	2º	2º
	3º	3º	3º	3º	3º	3º
	1	2	3	4	5	6
1º	1º	1º	1º	1º	1º	1º
2º	2º	2º	2º	2º	2º	2º
3º	3º	3º	3º	3º	3º	3º
7	8	9	10	11	12	13
1º	1º	1º	1º	1º	1º	1º
2º	2º	2º	2º	2º	2º	2º
3º	3º	3º	3º	3º	3º	3º
14	15	16	17	18	19	20
1º	1º	1º	1º	1º	1º	1º
2º	2º	2º	2º	2º	2º	2º
3º	3º	3º	3º	3º	3º	3º
21	22	23	24	25	26	27
1º	1º	1º	1º			
2º	2º	2º	2º			
3º	3º	3º	3º			
28	29	30	31			

1º HORARIO: 07:30 ÀS 08:30
2º HORARIO: 23:00 ÀS 00:00
3º HORARIO: 00:00 ÀS 01:00

Observações: Não escalar Ambulâncias de bases próximas no mesmo dia e período.
É obrigatório registrar o motivo da não realização da terminal em planilha.

7.2. Controle de Limpeza Terminal:

PREFEITURA DE SÃO PAULO | Prefeitura da Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Executiva de Atenção Hospitalar, Coordenadoria de Urgências e Emergências, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | SUS | SAMU 192

BASE

CONTROLE DAS LIMPEZAS TERMINAIS DAS AMBULÂNCIAS

DATA	AMBULÂNCIA	FOI REALIZADA	MOTIVO DA NÃO REALIZAÇÃO	REMANEJAMENTO	OBSERVAÇÕES	EQUIPE
		( ) SIM ( ) NÃO	( ) EM QAP NO MOMENTO ( ) FALTA DE MATERIAL Qual?_____ ( ) SEM EQUIPE ( ) NÃO AUTORIZADO PELO CORE ( ) OUTROS_____	( ) REMANEJADA TERMINAL PARA O DIA ____/____/_____ E TURNO_____		
		( ) SIM ( ) NÃO	( ) EM QAP NO MOMENTO ( ) FALTA DE MATERIAL Qual?_____ ( ) SEM EQUIPE ( ) NÃO AUTORIZADO PELO CORE ( ) OUTROS_____	( ) REMANEJADA TERMINAL PARA O DIA ____/____/_____ E TURNO_____		
		( ) SIM ( ) NÃO	( ) EM QAP NO MOMENTO ( ) FALTA DE MATERIAL Qual?_____ ( ) SEM EQUIPE ( ) NÃO AUTORIZADO PELO CORE ( ) OUTROS_____	( ) REMANEJADA TERMINAL PARA O DIA ____/____/_____ E TURNO_____		
		( ) SIM ( ) NÃO	( ) EM QAP NO MOMENTO ( ) FALTA DE MATERIAL Qual?_____ ( ) SEM EQUIPE ( ) NÃO AUTORIZADO PELO CORE ( ) OUTROS_____	( ) REMANEJADA TERMINAL PARA O DIA ____/____/_____ E TURNO_____		
		( ) SIM ( ) NÃO	( ) EM QAP NO MOMENTO ( ) FALTA DE MATERIAL Qual?_____ ( ) SEM EQUIPE ( ) NÃO AUTORIZADO PELO CORE ( ) OUTROS_____	( ) REMANEJADA TERMINAL PARA O DIA ____/____/_____ E TURNO_____		
		( ) SIM ( ) NÃO	( ) EM QAP NO MOMENTO ( ) FALTA DE MATERIAL Qual?_____ ( ) SEM EQUIPE ( ) NÃO AUTORIZADO PELO CORE ( ) OUTROS_____	( ) REMANEJADA TERMINAL PARA O DIA ____/____/_____ E TURNO_____		
		( ) SIM ( ) NÃO	( ) EM QAP NO MOMENTO ( ) FALTA DE MATERIAL Qual?_____ ( ) SEM EQUIPE ( ) NÃO AUTORIZADO PELO CORE ( ) OUTROS_____	( ) REMANEJADA TERMINAL PARA O DIA ____/____/_____ E TURNO_____		
		( ) SIM ( ) NÃO	( ) EM QAP NO MOMENTO ( ) FALTA DE MATERIAL Qual?_____ ( ) SEM EQUIPE ( ) NÃO AUTORIZADO PELO CORE ( ) OUTROS_____	( ) REMANEJADA TERMINAL PARA O DIA ____/____/_____ E TURNO_____		
		( ) SIM ( ) NÃO	( ) EM QAP NO MOMENTO ( ) FALTA DE MATERIAL Qual?_____ ( ) SEM EQUIPE ( ) NÃO AUTORIZADO PELO CORE ( ) OUTROS_____	( ) REMANEJADA TERMINAL PARA O DIA ____/____/_____ E TURNO_____		
		( ) SIM ( ) NÃO	( ) EM QAP NO MOMENTO ( ) FALTA DE MATERIAL Qual?_____ ( ) SEM EQUIPE ( ) NÃO AUTORIZADO PELO CORE ( ) OUTROS_____	( ) REMANEJADA TERMINAL PARA O DIA ____/____/_____ E TURNO_____		
		( ) SIM ( ) NÃO	( ) EM QAP NO MOMENTO ( ) FALTA DE MATERIAL Qual?_____ ( ) SEM EQUIPE ( ) NÃO AUTORIZADO PELO CORE ( ) OUTROS_____	( ) REMANEJADA TERMINAL PARA O DIA ____/____/_____ E TURNO_____		
		( ) SIM ( ) NÃO	( ) EM QAP NO MOMENTO ( ) FALTA DE MATERIAL Qual?_____ ( ) SEM EQUIPE ( ) NÃO AUTORIZADO PELO CORE ( ) OUTROS_____	( ) REMANEJADA TERMINAL PARA O DIA ____/____/_____ E TURNO_____		
SUPERVISOR/ INTERLOCUTOR (CARIMBO)		**RF/MATRÍCULA:** **DATA:** ____ / _____ / _____				

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies/Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília: Anvisa, 2010. 116 p.

9.2. BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo de Suporte Básico de Vida. Brasília: Ministério da Saúde, [s.d.]. Disponível em: *https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_suporte_basico_vida.pdf*. Acesso em: 28 ago. 2025.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
06	02/02/2026	Atualização 1. Ampliação e padronização das definições de limpeza, desinfecção e limpeza terminal. 2. Atualização da frequência, critérios e situações especiais para realização da limpeza terminal. 3. Expansão das áreas envolvidas, contemplando todos os tipos de viaturas. 4. Detalhamento e padronização do fluxo operacional. 5. Inclusão de registros formais, controle documental e comunicação obrigatória à Central de Regulação. 6. Alinhamento com protocolos vigentes, biossegurança e prevenção de riscos à equipe e aos pacientes.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cássia Oliveira Lopes	Aline Braga da Silva Camila Mayumi Okiyama Eline Prisca da Silva Lidinaide Maria da Costa Maíra Costa Renan M. de S. Gonçalves Viviane Soares de Freitas	Amanda de Ornelas Bárbara de Souza Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. A Abertura de vias aéreas no paciente vítima de trauma consiste no conjunto de manobras e intervenções utilizadas para garantir a livre passagem de ar até os pulmões, preservando simultaneamente o alinhamento da coluna cervical.

1.2. Essa abordagem prioriza a manutenção da imobilização manual da coluna cervical e a abertura das vias aéreas sem extensão ou flexão do pescoço.

1.3. No trauma a manobra de escolha é a elevação da mandíbula (Jaw Thrust), pois permite afastar a língua da parede posterior da faringe sem movimentar a coluna cervical.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever a técnica de abertura de vias aéreas nas vítimas de trauma inconscientes ou com rebaixamento do nível de consciência.

3. EQUIPES ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e Central de Regulação

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Posicione-se atrás da cabeça do paciente;

4.2. Realize imobilização manual da cabeça e, ao mesmo tempo, coloque os dedos indicadores e médios atrás dos ângulos da mandíbula (Figura 1);

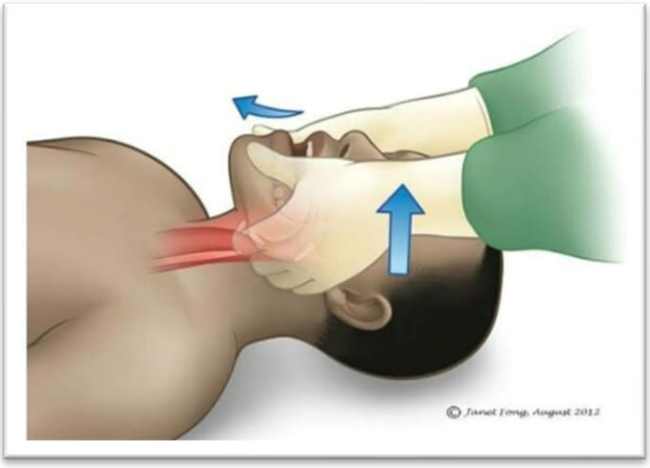
4.3. Aplique uma força para tracionar a mandíbula para frente;

4.4. Utilize os polegares para abrir levemente a boca;

4.5. Se indicado, solicite ao segundo membro da equipe que instale a cânula orofaríngea para prevenir a queda da língua sobre a parede posterior da faringe (POP IAPH SBV e SBV –E 079 Técnica Para Uso Da Cânula Orofaríngea).

4.6. Registre o procedimento na ficha de atendimento.

Figura 1: Manobra Jaw Thrust (tração da mandíbula)



5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não há.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP IAPH SBV e SBV –E 079 Técnica Para Uso Da Cânula Orofaríngea

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. Gentile JK, Himuro HS, Ordinola Rojas SS, et al. Condutas no paciente com trauma cranioencefálico. Bras. Clinica Médica. 2011; 09(1): 75.

9.2. PHTLS. Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado. National Association of Emergency Medical Technician, 2026. 10ª edição. 801 páginas.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Unificação dos protocolos de SBV e SIV 2. Padronização da Jaw Thrust como técnica de escolha 3. Atualização conceitual e do objetivo 4. Reorganização do procedimento 5. Ampliação das equipes envolvidas 6. Inclusão de registro e POP de apoio

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Carla C. A. Bezerra Celina H. H. Vasconcelos Daiane C. de Moraes Elaine C.S. Melo Machado	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. A abertura das vias aéreas no paciente clínico consiste no conjunto de manobras e intervenções realizadas para garantir a livre passagem de ar até os pulmões, prevenindo ou corrigindo obstruções que possam comprometer a ventilação e oxigenação, na ausência de suspeita de trauma cervical.

1.2. A abertura das vias aéreas faz parte da avaliação primária, especialmente em pacientes inconscientes ou com rebaixamento do nível de consciência, e consiste no posicionamento adequado da cabeça, por meio da manobra de inclinação da cabeça e elevação do mento, que afasta a língua da parede posterior da faringe.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever a técnica de abertura das vias aéreas nas vítimas inconscientes ou com rebaixamento de nível de consciência, na ausência da suspeita de trauma.

3. EQUIPES ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e Central de Regulação.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADE

4.1. Posicione uma das mãos na região frontal (testa) do paciente promovendo leve inclinação da cabeça para trás (Figura 1);

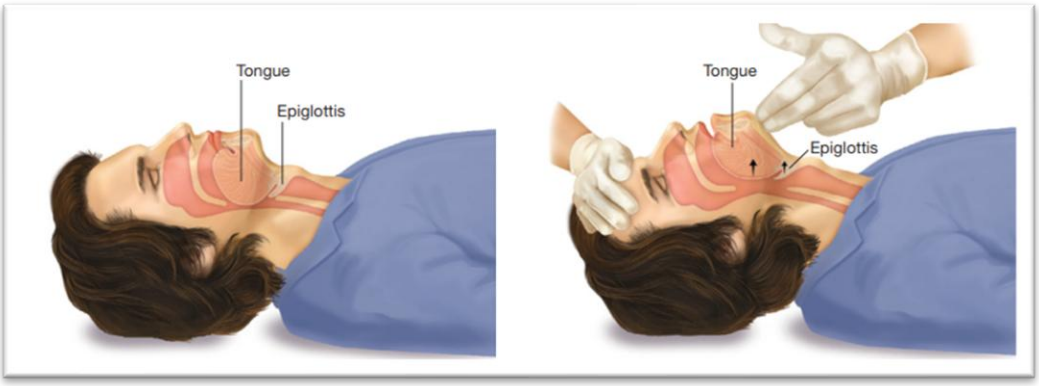
4.2. Com os dedos da outra mão, eleve o queixo, apoiando na parte óssea da mandíbula (Figura1);

4.3. Evite pressionar os tecidos moles sob o queixo para não obstruir ainda mais as vias aéreas;

4.4. Se indicado, instale cânula orofaríngea para prevenir a queda da língua sobre a parede posterior da faringe (POP IAPH SBV e SBV –E 079 Técnica Para Uso Da Cânula Orofaríngea);

4.5. Registre o procedimento na ficha de atendimento.

Figura 1: Manobra Chin Lift (elevação do queixo)



Fonte: https://www.pearsonhighered.com/assets/samplechapter/0/1/3/5/0135074800.pdf

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não há.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP IAPH SBV e SBV –E 079 Técnica Para Uso Da Cânula Orofaríngea

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. PHTLS. Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado. National Association of Emergency Medical Technician, 2025. 10ª edição.

10. CONTROLE DE REVISÕES CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Unificação dos protocolos de SBV e SIV 2. Alteração e padronização do nome do protocolo 3. Atualização da definição e do objetivo 4. Padronização e detalhamento do procedimento 5. Inclusão de cuidados técnicos adicionais 6. Previsão de uso de cânula orofaríngea

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia O. Lopes Edna B da Silva	Celina H. H. Vasconcelos Elaine C. S. Melo Machado	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. Aspiração de vias aéreas superiores: procedimento invasivo destinado a remover secreções acumuladas na cavidade oral, orofaringe e nasofaringe, quando o paciente não é capaz de eliminá-las adequadamente por meios fisiológicos, como a tosse ou deglutição. Esse procedimento visa manter a via aérea pérvia, prevenir obstrução, reduzir risco de broncoaspiração e melhorar o padrão respiratório;

1.2. Aspiração de vias aéreas inferiores: procedimento invasivo realizado para remover secreções presentes na traqueia e brônquios, quando o paciente não é capaz de eliminá-las adequadamente pela tosse. É realizada mediante a introdução de uma sonda de aspiração estéril através da cavidade oral, nasal ou de um dispositivo artificial (como cânula orotraqueal ou traqueostomia), conectada a um sistema de vácuo. Esse procedimento é privativo do enfermeiro e requer técnica asséptica rigorosa, monitorização contínua e tempo de aspiração limitado para evitar hipóxia, broncoespasmo e trauma da mucosa traqueobrônquica.

2. OBJETIVOS

2.1. Descrever a técnica utilizada para aspiração de secreções nas vias aéreas superiores e inferiores.

2.2. Descrever como realizar a aspiração utilizando o cilindro de oxigênio, na ausência do aspirador.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e SAV

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

Materiais necessários
EPIs (luvas de procedimento, máscara, óculos)
Luva estéril (para aspiração de vias aéreas inferiores)
Pacote de gazes
Soro Fisiológico 0,9% - ampola de 10 ml
Aspirador portátil / fonte de vácuo
Extensor de silicone
Cateter de aspiração do tamanho apropriado
Oxímetro de pulso

Materiais adicionais necessários na ausência do aspirador
Frasco rígido
Cilindro de oxigênio

Aspiração de vias aéreas superiores:

4.1. Após a avaliação primária, se identificada a necessidade de aspiração das vias aéreas, comunique a vítima sobre o procedimento;

4.2. Abra parcialmente o invólucro do cateter de aspiração;

4.3. Conecte o cateter ao extensor mantendo-a dentro do invólucro;

4.4. Calce luva de procedimento;

4.5. Retire o cateter do invólucro;

4.6. Segure a extremidade do cateter com uma gaze;

4.7. Ligue o aspirador;

4.8. Para a aspiração com o frasco rígido e cilindro de oxigênio:

4.8.1. Conecte o frasco rígido à saída da rede de O_2;

4.8.2. Ajuste o fluxo de oxigênio conforme necessidade;

4.8.3. Permita que o fluxo de O_2 passe pelo adaptador para gerar o vácuo (sucção);

4.8.4. Conecte a sonda de aspiração ao frasco rígido.

Execução da aspiração – vias aéreas superiores:

4.9. Introduza o cateter em uma das narinas, cerca de 5 cm no adulto, com a válvula aberta, evitando lesão no tecido;

4.10. Oclua a válvula e retire o cateter em movimentos circulares;

4.11. Realize a limpeza do cateter de aspiração utilizando soro fisiológico, se necessário;

4.12. Repita até a liberação das vias aéreas;

4.13. Despreze o cateter de aspiração e as luvas em saco de lixo infectante;

4.14. Registre o procedimento, quantidade e aspecto da secreção na ficha de atendimento.

Execução da aspiração – vias aéreas inferiores

Procedimento permitido somente ao Enfermeiro.

4.15. Após a avaliação primária, explique o procedimento ao paciente;

4.16. Abra parcialmente o invólucro do cateter estéril;

4.17. Conecte o cateter ao extensor, mantendo-o dentro do invólucro;

4.18. Calce luva estéril;

4.19. Retire o cateter do invólucro com técnica asséptica;

4.20. Ligue o aspirador (rede de vácuo ou Venturi).

4.21. Para a aspiração com o frasco rígido e cilindro de oxigênio:

4.21.1. Conecte o frasco rígido à saída da rede de O_2;

4.21.2. Ajuste o fluxo de oxigênio conforme necessidade;

4.21.3. Permita que o fluxo de O_2 passe pelo adaptador para gerar o vácuo (sucção);

4.21.4. Conecte a sonda de aspiração ao frasco rígido.

4.22. Introduza o cateter pela cavidade oral/nasal ou por dispositivo artificial (TOT/traqueostomia);

4.23. Não aplique sucção na introdução para evitar lesão de mucosa;

4.24. Oclua o orifício de aspiração e retire o cateter lentamente com movimentos rotatórios;

4.25. Limite a aspiração a 10–15 segundos por passagem;

4.26. Aguarde 20–30 segundos entre as passagens, se necessário;

4.27. Repita até a desobstrução;

4.28. Descarte o cateter e os materiais conforme protocolo;

4.29. Registre o procedimento, resposta do paciente e características das secreções.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. O saco coletor do frasco de aspiração automático (flovac – figura 1) devem ser descartados junto com a secreção;

5.2. O frasco rígido (figura 2) deve ser encaminhado ao CME para desinfecção química de alto-nível.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Figura 1 – Frasco Flovac

7.2. Figura 2 – Frasco rígido

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. POTTER, Patricia A.; PERRY, Anne Griffin. **Fundamentos de enfermagem.** 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2022.

9.2. Souza, A. L. T; Sousa B. O. P. Manual de Procedimentos Básicos de Enfermagem. Faculdades Integradas do Vale do Ribeira. Registro, 2017.

9.3. (NAEMT), National Association of Emergency Medical Technicians. PHTLS: Prehospital Trauma Life Support: Suporte de vida pré-hospitalar em trauma. 10ª edição 2023.

9.4. (NAEMT), National Association of Emergency Medical Technicians. AMLS: Advanced Medical Life Support: Atendimento Pré-Hospitalar às Emergências Clínicas. Porto Alegre: Artmed, 2022. Ebook.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
02	02/02/2026	Atualização 1. Ampliação e detalhamento da definição. 2. Inclusão da aspiração de vias aéreas inferiores, com delimitação de procedimento privativo do enfermeiro 3. Atualização do objetivo, contemplando também aspiração na ausência de aspirador (uso de cilindro de O_2) 4. Reorganização e detalhamento dos materiais necessários 5. Padronização do passo a passo do procedimento 6. Inclusão de procedimento específico para aspiração com frasco rígido e cilindro de oxigênio 7. Criação de seção específica para aspiração de vias aéreas inferiores, com técnica asséptica, tempo limite e intervalos 8. Inclusão de orientações de segurança 9. Reforço da obrigatoriedade de registro 10. Inclusão de observações sobre descarte e processamento de materiais 11. Inclusão de anexos ilustrativos para padronização dos dispositivos utilizados

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Daniela G. Moreira	Amanda de Fátima P. Rocha Elaine C. S. M. Machado Flávia Guedes Araújo Roselandia de S. Beserra Wesley Almeida Santos	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Cânula orofaríngea: dispositivo rígido em formato de "J", utilizado para manter a permeabilidade das vias aéreas superiores em pacientes inconscientes ou com rebaixamento do nível de consciência, evitando a obstrução causada pelo relaxamento da língua. Ela facilita a ventilação com bolsa-válvula-máscara, previne a oclusão da orofaringe e deve ser utilizada apenas quando não há reflexo de vômito presente.

2. OBJETIVOS

2.1. Descrever a técnica para uso de cânula orofaríngea.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E e URAM

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

Materiais necessários
EPIs (luvas de procedimento, máscara, óculos)
Cânula Orofaríngea (COF) de tamanhos variados para adultos e crianças.

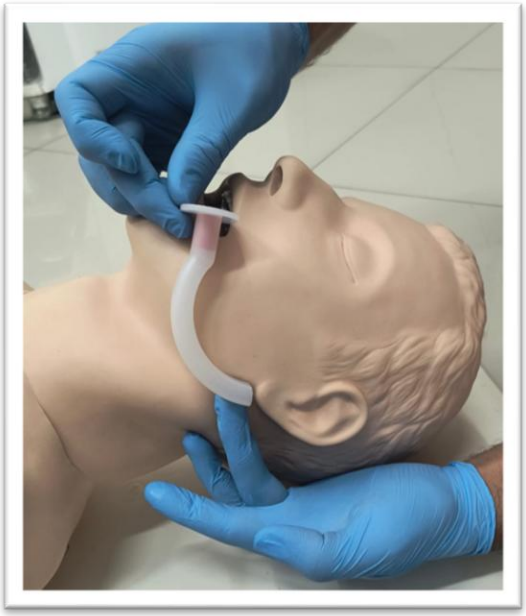
Procedimento

4.1. Use EPIs;

4.2. Selecione o tamanho adequado da COF;

4.3. Posicione a COF lateralmente à face da vítima;

4.4. Realize a medida da distância entre a comissura labial e o ângulo da mandíbula;



ATENÇÃO

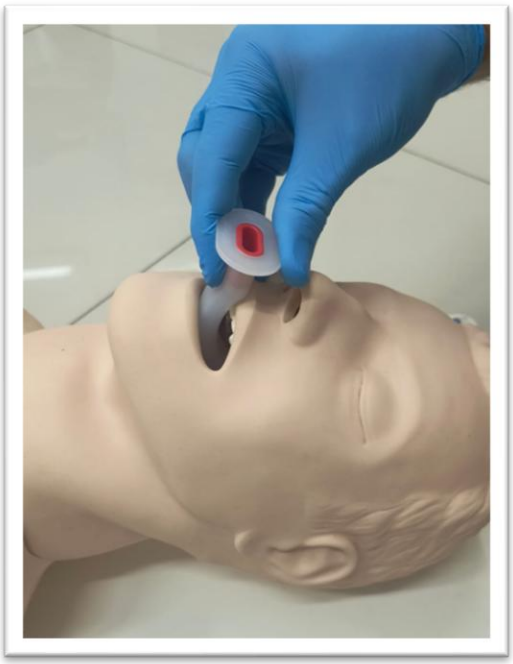
4.5. Caso a vítima seja suspeita de trauma, esta técnica necessitará de 2 profissionais;

4.5.1. Um profissional de manter o controle da cervical, com a cabeça e o pescoço alinhados, enquanto o outro profissional faz a abertura da boca e introdução da cânula.

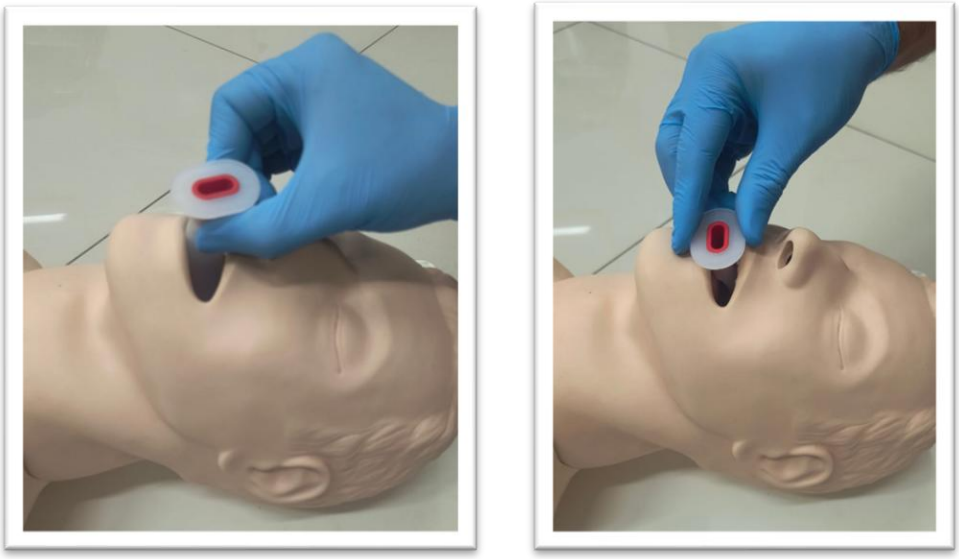
4.6. Remova secreções ou sangue da boca e faringe por meio da aspiração, se necessário;

ADULTO

4.7. Insira a COF com a concavidade voltada para o palato duro;



4.8. Realize a rotação da cânula em um angulo de 180°, encaixando a COF nos contornos anatômicos da base da língua da vítima;



4.9. Registre o procedimento na ficha de atendimento.

CRIANÇA

4.10. Selecione o tamanho adequado da COF;

4.11. Posicione a COF lateralmente à face da vítima;

4.12. Realize a medida da distância entre a comissura labial e o ângulo da mandíbula;

4.13. Insira a COF com a concavidade voltada para baixo (língua);

4.14. Utilize preferencialmente uma espátula para apoiar a língua antes da introdução da COF, auxiliando na entrada;

4.15. Registre o procedimento na ficha de atendimento.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não há.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. PHTLS. Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado. National Association of Emergency Medical Technician, 2021. 9ª edição. 762 páginas.

9.2. AMERICAN HEART ASSOCIATION. Suporte Básico de Vida: Diretrizes da American Heart Association para Ressuscitação Cardiopulmonar e Atendimento Cardiovascular de Emergência. 2020. Dallas: AHA, 2020.

9.3. AMLS: Atendimento Pré-Hospitalar às Emergências Clínicas/ Tradução Maria Esmene G. Comenale *et al.* 1ª edição. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2017. 545 páginas.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
02	02/02/2026	Atualização 1. Atualização e ampliação da definição 2. Padronização da mensuração do tamanho da cânula 3. Atualização do procedimento

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Adriana Carla F. da Silva Amanda de Fátima Portugal Elaine C.S.M. Machado Lucélia F. dos Santos Roselandia de S. Beserra	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Os dispositivos supraglóticos, também chamados de dispositivos extraglóticos, são utilizados no manejo avançado das vias aéreas, pois facilitam a oxigenação e a ventilação do paciente sem a necessidade de intubação traqueal, sendo especialmente úteis em situações de emergência, quando há falha na intubação ou a intubação não pode ser realizada naquele momento;

1.2. Vantagens da utilização dos dispositivos supraglóticos:

1.2.1. Podem ser utilizados por enfermeiros devidamente treinados e capacitados, mesmo na ausência do médico;

1.2.2. Inserção rápida e simples, com menor complexidade técnica quando comparada à intubação traqueal;

1.2.3. Menor necessidade de manipulação da coluna cervical;

1.2.4. Alternativa eficaz em situações de via aérea difícil ou falha na intubação orotraqueal;

1.2.5. Permitem ventilação eficaz com bolsa-válvula-máscara, garantindo adequada oxigenação;

2. OBJETIVO

2.1. Descrever a técnica para a passagem do dispositivo supraglótico no manejo avançado da via aérea.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV-E e Central de Regulação

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADE

Materiais necessários
EPIs (luvas de procedimento, máscara e óculos)
Dispositivo supraglótico (máscara laríngea) do tamanho adequado
Seringa de 20 ml
Espátula (especialmente para criança)
Lubrificante a base de água ou lidocaína gel
Dispositivo bolsa-válvula-máscara conectado a fonte de O_2
Sonda gástrica nº 14 e saco coletor
Fixador para o dispositivo (cadarço, fita adesiva, etc.)

Procedimento

4.1. Em uso de EPI;

4.2. Posicione a vítima em decúbito dorsal horizontal e realize a manobra para abertura da via aérea (atentar-se aos casos de trauma);

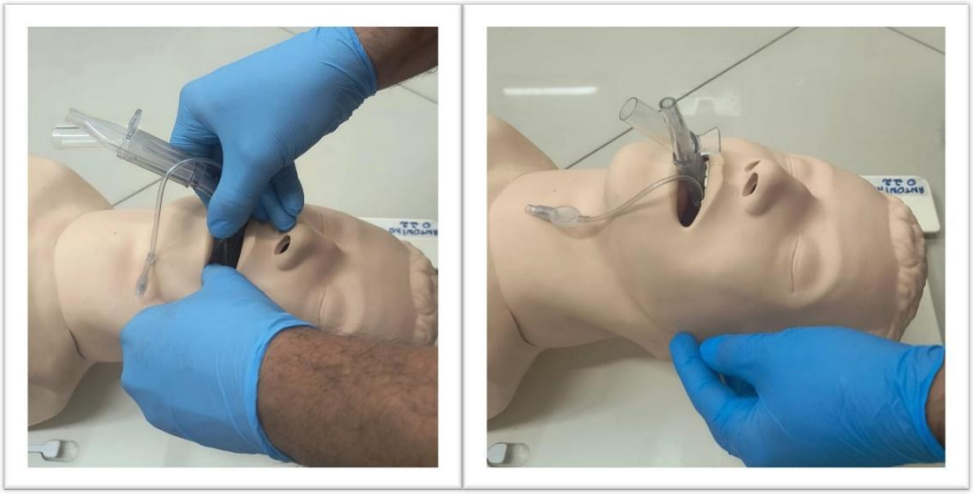
4.3. Faça o teste do cuff do dispositivo supraglótico, utilizando uma seringa de 20 ml, respeitando o volume de ar recomendado pelo fabricante. Não esqueça de desinflar antes de iniciar o procedimento;

4.4. Lubrifique o dispositivo supraglótico com o lubrificante a base de água ou lidocaína gel;

4.5. Segure o dispositivo como se estivesse pegando em uma caneta;

4.6. Com a mão não dominante segure o mento juntamente com a língua, mantendo a abertura da via aérea;

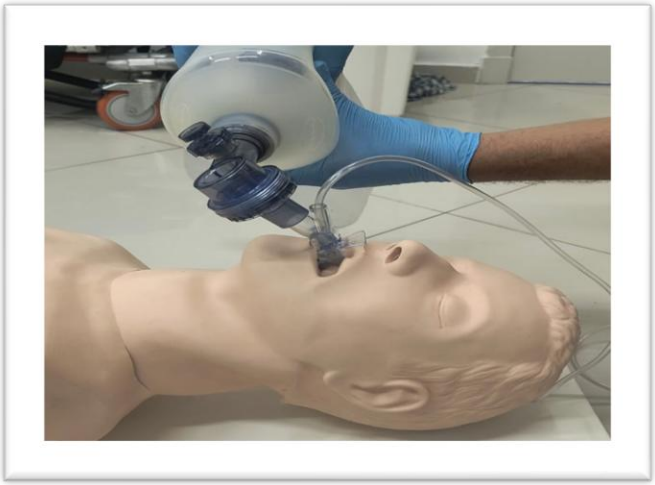
4.7. Insira o dispositivo até encontrar resistência compatível com base da língua e glote;



4.8. Insufle o cuff com a quantidade de ar recomendada pelo fabricante;

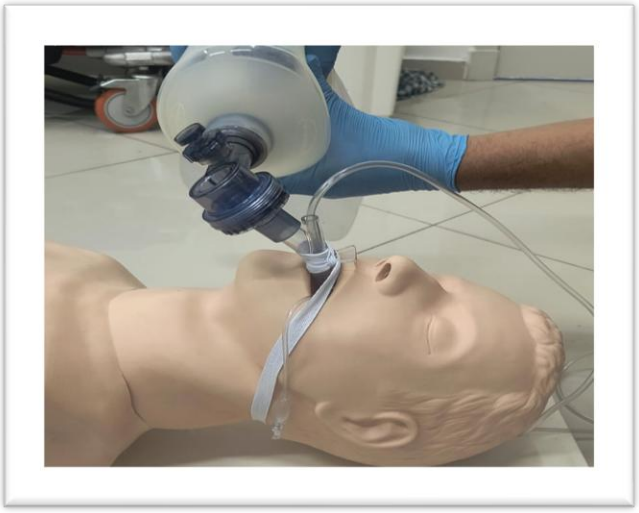
4.9. Introduza a sonda gástrica nº 14 no lúmen adjacente e conecte o saco coletor para drenagem do conteúdo gástrico;

4.10. Conecte o dispositivo à bolsa-valva-máscara com suplementação de oxigênio e inicie as ventilações;



4.11. Verifique a presença de expansão torácica efetiva;

4.12. Realize a fixação do dispositivo com cadarço ou atadura fina;



4.13. Registre o procedimento na ficha de atendimento.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Atente-se a pressão máxima de 60 cmH_2O (equivalente a 40 mmHg) recomendada para insuflação do cuff da máscara laríngea;

5.2. Utilize um medidor de pressão de cuff quando disponível;

5.3. Pressões excessivas podem aumentar o risco de isquemia e necrose tecidual na via aérea;

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. PHTLS. Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado. National Association of Emergency Medical Technician, 2021. 9ª edição. 762 páginas.

9.2. NAEMT, National Association of Emergency Medical Technicians. AMLS: Advanced Medical Life Support. Atendimento Pré-hospitalar às Emergências Clínicas. Porto Alegre: ArtMed, 2022; 3ª Edição. 596 p

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
02	02/02/2026	Atualização 1. Reorganização e ampliação da definição do dispositivo supraglótico como estratégia de manejo avançado de vias aéreas. 2. Inclusão das vantagens do dispositivo supraglótico, com ênfase na rapidez de inserção e menor manipulação cervical. 3. Padronização dos materiais necessários, com inclusão de sonda gástrica e sistema de drenagem. 4. Organização do procedimento em etapas sequenciais, com linguagem técnica e objetiva. 5. Reforço da verificação da eficácia ventilatória por expansão torácica. 6. Inclusão de recomendações de segurança relacionadas à pressão do cuff, visando à prevenção de lesões de via aérea. 7. Manutenção da obrigatoriedade de registro do procedimento na ficha de atendimento.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes	Adriana Carla F. da Silva Amanda de F. Portugal Elaine C.S.M. Machado	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nádia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Cateter nasal (tipo óculos): é um dispositivo para oxigenoterapia, indicado para vítimas conscientes, que necessitam de um baixo a médio fluxo de oxigênio (1 a 6l/min).

2. OBJETIVO

2.1. Descrever a técnica para instalação e uso do cateter nasal.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E e URAM.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

Materiais necessários
EPIs (luvas de procedimento, máscara, óculos)
Cateter nasal tipo óculos
Fluxômetro
Fonte de oxigênio
Extensor (cânula de conexão)

4.1. Após a avaliação primária e secundária, se identificada a necessidade de oxigenioterapia, comunique a vítima/acompanhante sobre o procedimento;

4.2. Adapte o extensor ao fluxômetro que deverá estar conectado a fonte de oxigênio;

4.3. Conecte o cateter nasal ao extensor e abra o fluxômetro até o volume necessário (de 1 até o máximo de 6 litros de O_2 por minuto);

4.4. Ajuste o cateter confortavelmente nas narinas da vítima e passe a extensão por trás dos pavilhões auriculares;

4.5. Posicione a vítima em decúbito elevado;

4.6. Registre o procedimento na ficha de atendimento.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não há.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. Souza, A. L. T; Sousa B. O. P. Manual de Procedimentos Básicos de Enfermagem. Faculdades Integradas do Vale do Ribeira. Registro, 2017.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
02	02/02/2026	Atualização 1. Atualização da definição do cateter nasal, incluindo baixo a médio fluxo (1 a 6 L/min); 2. Alteração do objetivo, passando a incluir instalação e uso do dispositivo; 3. Inclusão da indicação após avaliação primária e secundária; 4. Reorganização e simplificação da sequência do procedimento;

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Elaine C. S. M. Machado Victor Bezerra de Souza Lucélia F. dos Santos Márcia Rosa de S. Lopes Roselandia de S. Beserra	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. A máscara não reinalante com reservatório é um dispositivo utilizado para administração de oxigênio em alta concentração (fluxo de 10 a 15l/min), e está indicada para vítimas de trauma e em situações de urgência/ emergência clínica, que apresentam hipoxemia moderada a grave, porém sem indicação de intubação ou ventilação não invasiva.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever a técnica para instalação e uso da máscara não reinalante com reservatório.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E e URAM.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

Materiais necessários
EPIs (luvas de procedimento, máscara, óculos)
Máscara não reinalante com reservatório
Fluxômetro
Fonte de oxigênio
Extensor (cânula de conexão)

4.1. Após a avaliação primária e secundária, se identificada a necessidade de oxigenioterapia sob alto fluxo, comunique a vítima sobre o procedimento;

4.2. Adapte o extensor ao fluxômetro que deverá estar conectado a fonte de oxigênio;

4.3. Conecte a máscara não reinalante com reservatório ao extensor e abra o fluxômetro até o volume necessário (de 10 a 15 litros de O_2 por minuto);

4.4. Ajuste a máscara confortavelmente na face da vítima;

4.5. Posicione a vítima em decúbito elevado;

4.6. Registre o procedimento na ficha de atendimento.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não há.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. Souza, A. L. T; Sousa B. O. P. Manual de Procedimentos Básicos de Enfermagem. Faculdades Integradas do Vale do Ribeira. Registro, 2017.

9.2. (NAEMT), National Association of Emergency Medical Technicians. AMLS: Advanced Medical Life Support: Atendimento Pré-Hospitalar às Emergências Clínicas. Porto Alegre: Artmed, 2022. Ebook.

9.3. (NAEMT), National Association of Emergency Medical Technicians. PHTLS: Prehospital Trauma Life Support: Suporte de vida pré-hospitalar em trauma. 10ª edição 2023.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
02	02/02/2026	Atualização 1. Atualização e padronização do título do protocolo. 2. Revisão da definição. 3. Ampliação do objetivo. 4. Atualização das áreas envolvidas, contemplando SBV, SBV-E e URAM. 5. Reorganização do procedimento. 6. Melhoria da clareza e sequenciamento das etapas operacionais.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Daniela G. Moreira	Carlos Odercio Zanquetta Luís Cássio Carneiro Leão Naiane Clara Clemento Patrícia C. Alves de Sousa	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Oximetria de pulso: método não invasivo que mensura, em tempo real, a saturação periférica de oxigênio (SpO_2) no sangue, por meio de um sensor que utiliza a emissão e detecção de luz para identificar a porcentagem de hemoglobina oxigenada. Os valores apresentados pelo oxímetro indicam a saturação de oxigênio no sangue e a frequência cardíaca.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever a técnica para aferição da oximetria de pulso.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E e URAM

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADE

Materiais necessários
EPIs (luvas de procedimento, máscara, óculos)
Oxímetro portátil com sensor adequado
Gaze e álcool 70%

Procedimento

4.1. Utilize os EPIs;

4.2. Comunique a vítima/acompanhante sobre o procedimento;

4.3. Escolha a região em que será colocado o sensor:

4.3.1. Adulto: dedo indicador de MMSS;

4.3.2. Criança: dedo indicador de MMSS, porém, na ausência do sensor infantil coloque o sensor adulto na palma da mão ou planta do pé.

4.4. Caso haja má perfusão periférica (adulto ou criança), o sensor pode ser colocado no lóbulo da orelha;

4.5. Ligue o dispositivo;

4.6. Aguarde o medidor fornecer a leitura digital do valor (cerca de 30 segundos);

4.7. Limpe o sensor com gaze embebida em álcool 70%;

4.8. Registre o valor encontrado na ficha de atendimento.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não há.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. NAEMT, National Association of Emergency Medical Technicians. AMLS: Advanced Medical Life Support. Atendimento Pré-hospitalar às Emergências Clínicas. Porto Alegre: ArtMed, 2022; 3ª Edição. 596 p.

9.2. AMERICAN HEART ASSOCIATION. Suporte Básico de Vida: Diretrizes da American Heart Association para Ressuscitação Cardiopulmonar e Atendimento Cardiovascular de Emergência. Dallas: AHA, 2020.

9.3. PHTLS. Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado. National Association of Emergency Medical Technician, 2021. 9ª edição. 762 páginas.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
02	02/02/2026	Atualização 1. Padronização do texto conforme novo modelo de POP. 2. Atualização e harmonização da definição e do objetivo do procedimento. 3. Organização e padronização dos materiais e etapas do procedimento. 4. Melhor estruturação do fluxo de execução e registro do procedimento.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Daniela G. Moreira	Elaine C.S. M. Machado Karen Gisele da S. Guerreiro Lucélia F. dos Santos Patrícia C. Alves de Sousa Roselandia de S. Beserra	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Procedimento realizado na avaliação secundária com auxílio de um esfigmomanômetro juntamente com um estetoscópio, para aferir os valores de pressão arterial sistólica e diastólica.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever a técnica para aferição da pressão arterial.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e Central de Regulação

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

Materiais necessários
EPIs (luvas de procedimento, máscara, óculos)
Estetoscópio
Gaze e álcool 70%
Esfigmomanômetro com manguito

Procedimento

4.1. Utilize os EPIs;

4.2. Explique o procedimento a vítima/ acompanhante;

4.3. Posicione o braço apoiado com a palma da mão para cima, o cotovelo levemente fletido e à altura do coração;

4.4. Instale a braçadeira do esfigmomanômetro;

4.5. Exponha o membro a ser aferido evitando compressão pelas vestes, que preferencialmente devem ser retiradas;

4.6. Localize a artéria braquial por palpação para determinar o local correto do manguito;

4.7. Instale o manguito 2 a 3 cm acima da fossa cubital, sem deixar folga, centralizando-o sobre a artéria braquial;

4.8. Método auscultatório:

4.8.1. Posicione a campânula do estetoscópio suavemente sobre a artéria braquial (não comprimir em excesso)

4.8.2. Insufle o manguito até o momento em que desaparecer o pulso;

4.8.3. Registre mentalmente o valor;

4.8.4. Infle rapidamente até ultrapassar em 20 a 30 mmHg o nível estimado da pressão sistólica;

4.8.5. Proceda à deflação lentamente (velocidade de 2 mmHg por segundo);

4.8.6. Determine a pressão sistólica pela ausculta do primeiro som (geralmente fraco seguido de batidas regulares);

4.8.7. Determine a pressão diastólica no desaparecimento dos sons;

4.8.8. Ausculte cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último som para confirmar seu desaparecimento e depois proceder à deflação rápida e completa;

4.9. Se os batimentos persistirem até o nível zero, determine a pressão diastólica no abafamento dos sons;

4.10. Limpe o estetoscópio e as olivas com gaze embebida em álcool a 70%;

4.11. Registre os valores na ficha de atendimento.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não há.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. AMLS: Atendimento Pré-Hospitalar às Emergências Clínicas. Porto Alegre: ArtMed, 2022; 3ªedição. 596 páginas.

9.2. PHTLS. Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado. National Association of Emergency Medical Technician, 2021. 9ª edição. 762 páginas.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
02	02/02/2026	Atualização 1. Adequação da linguagem técnica e padronização dos termos utilizados. 2. Organização do procedimento em etapas numeradas, facilitando a leitura e a execução. 3. Manutenção da técnica auscultatória, com melhor detalhamento operacional. 4. Reforço da orientação sobre registro correto dos valores na ficha de atendimento.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cássia O. Lopes Daniela G. Moreira	Amanda de Fatima P. Rocha Carlos Odercio Zanquetta Elaine C. M. Machado	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Verificação da frequência cardíaca: consiste na mensuração do número de batimentos cardíacos por minuto, realizada por meio da palpação de pulsos periféricos ou centrais, ausculta cardíaca ou dispositivos eletrônicos. Esse procedimento permite avaliar o funcionamento do sistema cardiovascular, identificar alterações como taquicardia, bradicardia ou irregularidades do ritmo, e orientar condutas clínicas em situações de rotina ou emergência.

2. OBJETIVOS

2.1. Descrever a técnica para aferição da frequência cardíaca.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E e URAM

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADE

Materiais necessários
EPIs (luvas de procedimento, máscara, óculos)
Relógio
Oxímetro de pulso

Procedimento

4.1. Utilize os EPIs;

4.2. Explique o procedimento a vítima/acompanhante;

4.3. Coloque a vítima em posição confortável com o braço apoiado;

4.4. Posicione a polpa digital dos dedos indicador e médio sobre a artéria radial, fazendo leve pressão, o suficiente para sentir a pulsação;

4.5. Coloque o oxímetro de pulso. Siga as instruções de POP IAPH 083-Oximetria de pulso;

4.6. Se pulso rítmico, considere o valor informado pelo oxímetro de pulso;

4.7. Se pulso arrítmico, realize a contagem durante 1 minuto.

ATENÇÃO

4.8. Caso não seja possível a verificação na artéria radial; em **adultos** pode-se optar pela artéria braquial e carótida; em **crianças** (< 01 ano) pela artéria braquial.

4.9. Observe também ritmo e qualidade (forte e cheio ou fraco e fino);

4.10. Registre o valor encontrado na ficha de atendimento.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não há.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP IAPH SBV E EBV-E 083 Oximetria de Pulso.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. AMLS: Atendimento Pré-Hospitalar às Emergências Clínicas. Porto Alegre: ArtMed, 2022; 3ª Edição. 596 páginas.

9.2. PHTLS. Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado. National Association of Emergency Medical Technician, 2021. 9ª edição. 762 páginas.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
02	02/02/2026	Atualização 1. Atualização e ampliação da definição de frequência cardíaca; 2. Inclusão de diferentes métodos de mensuração (palpação, ausculta e dispositivos eletrônicos); 3. Inclusão do oxímetro de pulso como recurso complementar; 4. Diferenciação da conduta conforme pulso rítmico ou arrítmico; 5. Manutenção das orientações sobre locais alternativos de aferição do pulso; 6. Registro obrigatório do valor aferido na ficha de atendimento.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Ana Midori Harada Elaine C. S. M. Machado Flávia Guedes Araújo Lucélia F. dos Santos Roselandia de S. Beserra	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Procedimento que quantifica a frequência respiratória da vítima, através da visualização da caixa torácica durante os movimentos do diafragma e músculos intercostais.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever a técnica para aferição da frequência respiratória

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E e URAM

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

Materiais necessários
EPIs (luvas de procedimento, máscara, óculos)
Relógio

Procedimento

4.1. Utilize os EPI;

4.2. A explicação do procedimento poderá alterar a frequência respiratória;

4.3. Coloque a vítima em posição confortável, se possível;

4.4. Observe os movimentos torácicos de expansão e retração (incursões respiratórias);

4.5. Realize a contagem dos movimentos torácicos de expansão por 15 segundos e multiplicar por 04.

4.6. Se a respiração estiver arrítmica contar durante 1 minuto.

4.7. O lactente poderá apresentar pausa respiratória fisiológica, por isso conte durante 1 minuto sempre.

4.8. Registre o valor na ficha de atendimento.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não há.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. AMLS: Atendimento Pré-Hospitalar às Emergências Clínicas. Porto Alegre: ArtMed, 2022; 3ª Edição. 596 páginas.

9.2. PHTLS. Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado. National Association of Emergency Medical Technician, 2021. 9ª edição. 762 páginas.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
02	02/02/2026	Atualização 1. Manutenção da técnica de observação da expansibilidade torácica; 2. Padronização da contagem em 15 segundos com multiplicação por 4 quando respiração rítmica; 3. Definição clara da contagem por 1 minuto em respiração arrítmica; 4. Inclusão da obrigatoriedade de contagem por 1 minuto em lactentes; 5. Padronização do registro do valor aferido na ficha de atendimento.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Elaine C.M Machado Lucélia F. dos Santos Luis Cássio Carneiro Leão Roselandia de S. Beserra	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Procedimento de verificação da glicemia capilar: técnica utilizada para medir, de forma rápida e minimamente invasiva, a concentração de glicose no sangue por meio de uma gota obtida da polpa digital. Este método utiliza aparelho glicosímetro e tiras reagentes específicas, permitindo o monitoramento imediato da glicemia.

2. OBJETIVOS

2.1. Descrever a técnica para verificação da glicemia capilar.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E e URAM.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADE

Indicação para vítimas, que mesmo sem diagnóstico prévio, apresentem:

4.1. Alteração do nível de consciência;

4.2. Convulsão;

4.3. História pregressa de patologia metabólica (diabetes, hipoglicemia, hiperglicemia) com ou sem uso de insulina;

4.4. Sinais e sintomas compatíveis com hipoglicemia ou hiperglicemia: sudorese fria, tremores, palidez, taquicardia;

4.5. Trauma em paciente diabético;

4.6. Desconforto torácico.

Materiais necessários
EPIs (luvas de procedimento, máscara, óculos)
Swab de álcool 70% para antissepsia da pele
Glicosímetro padronizado no serviço
Lancetas estéreis
Fitas reagentes compatíveis com o modelo de glicosímetro disponível
Caixa para descarte de perfurocortante

Procedimento

4.7. Utilize os EPIs;

4.8. Separe o material adequado;

4.9. Oriente a vítima quanto à realização do procedimento;

4.10. Escolha o local para punção (dar preferência à lateral da extremidade das polpas digitais);

4.11. Realize antissepsia da área com gaze embebida em álcool 70% e aguarde a secagem;

4.12. Ligue o aparelho e posicione a fita reagente no local indicado;

4.13. Realize leve pressão na ponta do dedo;

4.14. Puncione com a lanceta na borda lateral da polpa digital;

4.15. Preencha o campo reagente da fita;

4.16. Após absorção da gota, pressione o local da punção com gaze;

4.17. Aguarde a leitura digital do valor da glicose sanguínea;

4.18. Despreze a lanceta no coletor de resíduos perfurocortantes e demais materiais no lixo infectante;

4.19. Realize a desinfecção do glicosímetro com gaze e álcool a 70%;

4.20. Registre o valor encontrado na ficha de atendimento.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Antes do uso das tiras reagentes, deve-se verificar a compatibilidade com o glicosímetro disponível, incluindo a conferência do número do lote cadastrado no equipamento. Também é importante observar as condições de armazenamento das tiras, que devem permanecer bem vedadas para evitar a entrada de umidade ou exposição à luz;

5.2. O uso de álcool 70% na polpa digital é permitido, mas se usado, deve-se aguardar secar totalmente, pois o álcool úmido pode diluir a gota de sangue e interferir no resultado;

5.3. A pele deve estar limpa e seca antes da punção.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. POTTER, Patricia A.; PERRY, Anne Griffin. **Fundamentos de enfermagem.** 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2022.

9.2. AMLS: Atendimento Pré-Hospitalar às Emergências Clínicas. Porto Alegre: ArtMed, 2022; 3ª Edição. 596 páginas.

9.3. PHTLS. Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado. National Association of Emergency Medical Technician, 2021. 9ª edição. 762 páginas.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
02	02/02/2026	Atualização 1. Revisão e ampliação dos critérios de indicação do procedimento. 2. Padronização e detalhamento dos materiais utilizados, com foco em biossegurança. 3. Organização do passo a passo do procedimento

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes	Dumara Maria D. H. de Lima Elaine C. S. M. Machado Karen Gisele da S. Guerreiro Victor Bezerra de Souza Wanderson S. Rosa	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. O dimensionamento e a aplicação do colar cervical consistem em selecionar o tamanho apropriado do dispositivo de acordo com a anatomia do paciente e em posicioná-lo corretamente, visando à adequada estabilização da coluna cervical.

2. OBJETIVOS

2.1. Descrever a técnica de dimensionamento e aplicação do colar cervical, assegurando a proteção da coluna cervical da vítima e prevenindo a piora de possíveis lesões durante o atendimento.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E e URAM

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADE

Materiais necessários
EPIs (luvas de procedimento, máscara, óculos);
Colar cervical do tamanho adequado ou ajustável;

Procedimento

4.1. O procedimento deverá ser realizado por dois profissionais.

4.2. Em uso de EPI;

4.3. Separe o material adequado;

4.4. Oriente a vítima quanto à realização do procedimento;

4.5. **Profissional 1:** posicione-se atrás da cabeça da vítima com joelhos no chão, mantendo as mãos espalmadas sobre as orelhas, e realize o alinhamento e estabilização manual da coluna cervical;

4.6. **Profissional 2:** posicione-se paralelamente à vítima e mensure o tamanho do colar cervical, utilizando os dedos entre o ângulo da mandíbula até a inserção do músculo trapézio;

4.7. **Profissional 2:** pegue o colar cervical e desprenda os botões paralelos e os feixes para ajustá-lo de acordo com o tamanho verificado. Com a mão que realizou a mensuração, coloque na linha horizontal lateral ao colar e ajuste conforme o tamanho; trave os botões e feixes; monte o colar, virando a aba (apoio para o queixo) para a parte anterior;

4.8. **Profissional 1:** continue mantendo a estabilização manual da cabeça;

4.9. **Profissional 2:** inicie a colocação do colar, primeiramente abaixo da coluna cervical e após na região anterior do pescoço; alinhe o botão da aba com o mento do paciente e realize o fechamento do colar com velcro;

4.10. Se o paciente estiver consciente, peça para abrir a boca, para verificar acesso à via aérea, caso seja necessário aspirar ou colocar cânula orofaríngea;

4.11. Mantenha o espaço de um dedo entre o colar e o paciente, para maior conforto e prevenção de lesões por fricção e pressão local;

4.12. **Profissional 1:** mantenha a estabilização manual da cabeça até que vítima seja colocada na prancha com headblock.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não há.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. PHTLS. Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado. National Association of Emergency Medical Technician, 2021. 9ª edição. 762 páginas.

9.2. (NAEMT), National Association of Emergency Medical Technicians. AMLS: Advanced Medical Life Support: Atendimento Pré-Hospitalar às Emergências Clínicas. Porto Alegre: Artmed, 2022. Ebook.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Revisão e ampliação da definição. 2. Ajuste do objetivo. 3. Ampliação das áreas envolvidas, incluindo SBV, SBV-E e URAM. 4. Padronização dos materiais necessários, com detalhamento dos EPIs. 5. Organização do procedimento em etapas mais detalhadas. 6. Inclusão de orientações para pacientes conscientes, visando segurança da via aérea.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Celina H. H. Vasconcelos Elaine C. S. M. Machado Luis Cássio Carneiro Leão Patrícia Caroline A. de Sousa	Bárbara de Souza Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. É a técnica utilizada para retirar o capacete de forma a não instabilizar uma possível fratura na coluna cervical da vítima de trauma.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever a técnica de remoção de capacete nas vítimas de trauma.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E e URAM.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADE

Materiais necessários
EPIs (luvas de procedimento, máscara, óculos);
Colar cervical do tamanho adequado ou ajustável;

Procedimento

4.1. Em uso de EPI;

4.2. Explique o procedimento para a vítima;

4.3. Realize o procedimento conforme descrito:

4.4. **Profissional 1:** ajoelhe-se atrás da cabeça da vítima com os cotovelos apoiados no chão e as mãos espalmadas estabilizando o capacete.

4.5. **Profissional 2:** ajoelhe-se ao lado da vítima, apoie o cotovelo no chão, abra a viseira – figura 1- e solte (ou corte) a tira de fixação do capacete (cinta jugular) – figura 2.

Figura 1: Abra a viseira:

Figura 2: Solte a fivela

4.6. **Profissional 2:** com um dos braços apoiado no chão coloque a mão na região occipital da vítima e com o outro braço apoiado no tórax, posicione a mão na região cervical anterior, mantendo a estabilidade da coluna;

4.7. **Profissional 1:** retire o capacete posicionando os dedos das mãos na parte interna do capacete e, com movimentos firmes, tipo balanço inicie a liberação do nariz e do occipito, repetindo até a liberação total do capacete;

ATENÇÃO

4.8. Os movimentos devem ser lentos e controlados.

4.9. **Profissional 2:** mantenha a cabeça em posição neutra após a retirada do capacete, não deixe que a região occipital vá o solo;

4.10. **Profissional 1:** assuma a cabeça;

4.11. **Profissional 2:** Coloque o colar cervical (POP IAPH SBV E SBV-E 088 – Dimensionamento e colocação do colar cervical);

4.12. Ambos os profissionais, lenta e cuidadosamente, colocam a cabeça da vítima encostada no solo.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não há.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP IAPH SBV E SBV-E 088 – Dimensionamento e colocação do colar cervical.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não há.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. (NAEMT), National Association of Emergency Medical Technicians. AMLS: Advanced Medical Life Support: Atendimento Pré-Hospitalar às Emergências Clínicas. Porto Alegre: Artmed, 2022. Ebook.

9.2. PHTLS. Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado. National Association of Emergency Medical Technician, 2021. 9ª edição. 762 páginas.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
06	02/02/2026	Atualização 1. Revisão e padronização da definição e do objetivo. 2. Ampliação das áreas envolvidas, incluindo SBV, SBV-E e URAM. 3. Reorganização das etapas do procedimento. 4. Inclusão de orientações mais objetivas. 5. Reforço das recomendações de segurança.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Ana Midori Harada Celina H. H. Vasconcelos Elaine C. S. M. Machado	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. As etapas na abordagem da hemorragia externa na cena incluem:

1.1.1. Compressão manual direta;

1.1.2. Preenchimento e curativo compressivo com cobertura da ferida e agentes hemostáticos se disponível;

1.1.3. Torniquete.

1.2. Preenchimento: é a colocação de agentes hemostáticos e/ou compressas no interior das lesões com sangramento ativo, para aumentar a coagulação de hemorragias potencialmente fatais, e que não podem ser interrompidas apenas com a compressão direta em áreas do corpo sem condições de colocação do torniquete.

2. OBJETIVOS

2.1. Descrever a técnica para controle de hemorragias exsanguinantes.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e Central de Regulação

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

Materiais necessários
EPIs (luvas de procedimento, máscara, óculos)
Compressa algodonada estéril (zobec)
Bandagem triangular ou atadura de crepe (10 a 15 cm)
Torniquete de membros fornecido pela instituição.
Fita Crepe ou Esparadrapo

Procedimento

4.1. Em uso de EPI;

4.2. Informe o procedimento à vítima;

4.3. Exponha a ferida;

4.4. Remova delicadamente o excesso de sangue, preservando coágulos formados;

4.5. Localize a fonte de sangramento ativo e realize compressão direta;

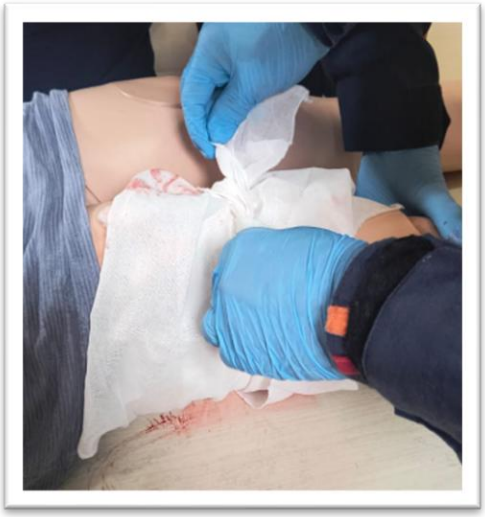
4.6. Preencha o interior da ferida diretamente sobre o ponto de sangramento mais ativo com a compressa algodonada estéril;

4.7. Aplique compressão direta e firme sobre a ferida por pelo menos 10 minutos;

4.8. Reavalie se o sangramento cessou;

4.9. Insira novo preenchimento na ferida se houver necessidade de controlar um sangramento contínuo;

4.10. Realize uma cobertura local compressiva com atadura crepe ou bandagem triangular para fixar o curativo quando o sangramento estiver controlado;



4.11. Finalize com fita crepe ou esparadrapo;

4.12. Caso o sangramento não cesse com as medidas aplicadas, opte pelo uso do torniquete;

4.13. Nas lesões localizadas em membros superiores, o torniquete deve ser instalado na região mais próxima da axila e nas lesões localizadas em membros inferiores, na região mais próxima da virilha;

4.14. Independentemente da localização da lesão exsanguinante, o torniquete deve ser instalado sempre o mais proximal possível da raiz do membro afetado;

4.15. Envolva firmemente o membro afetado com o torniquete, com aplicação primária próximo a virilha ou axila;

4.16. Fixe o velcro;

4.17. Gire a haste ao mesmo tempo em que palpa o pulso distal do membro;

4.18. Quando parar de sentir o pulso e/ou cessar a hemorragia, pare de girar a haste;

4.19. Fixe a haste na trava;

4.20. Anote no local próprio: horário da aplicação do torniquete e o membro no qual ele foi colocado;

4.21. Se um torniquete não interromper completamente a hemorragia, deve ser aplicado outro próximo ao primeiro;

ATENÇÃO

4.22. A equipe de atendimento pré-hospitalar deverá comunicar à equipe da unidade de saúde o horário de instalação do torniquete, bem como registrar em ficha de atendimento;

4.23. Se sinais de choque hemorrágico (pulso rápido, pele fria, alteração mental) devem ser seguidas as orientações do protocolo de choque hemorrágico POP IAPH SBV/SBV-E 048 – Choque hemorrágico.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não aplicar torniquetes sobre áreas de articulação;

5.2. Tempo máximo recomendado para permanência do torniquete no membro: 150 minutos;

5.3. O torniquete deve ser aplicado de maneira suficientemente apertada para que bloqueie o fluxo arterial e oclua o pulso distal;

5.4. Na presença do enfermeiro considere a analgesia (POP IAPH SBV/SBV-E 045 – Avaliação e Manejo da Dor e Vômitos).

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP IAPH SBV/SBV-E 048 – Choque hemorrágico;

6.2. POP IAPH SBV/SBV-E 045 – Avaliação e Manejo da Dor, Hipertermia e Vômitos.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. (NAEMT), National Association of Emergency Medical Technicians. AMLS: Advanced Medical Life Support: Atendimento Pré-Hospitalar às Emergências Clínicas. Porto Alegre: Artmed, 2022. Ebook.

9.2. PHTLS. Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado. National Association of Emergency Medical Technician, 2021. 9ª edição. 762 páginas.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Unificação dos protocolos antigos de empacotamento e torniquete em um único protocolo 2. Ampliação da definição, organizando a abordagem em etapas: compressão direta, preenchimento/curativo compressivo e torniquete 3. Atualização do objetivo, focado no controle de hemorragias exsanguinantes 4. Padronização e atualização dos materiais, com inclusão do torniquete institucional 5. Reorganização do passo a passo 6. Padronização do preenchimento da ferida com compressa algodonada estéril e tempo mínimo de compressão 7. Atualização da técnica de aplicação do torniquete 8. Inclusão de referência cruzada ao protocolo de choque hemorrágico 9. Inclusão de recomendação de analgesia, quando houver presença do enfermeiro

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Ana Midori Harada Dumara Maria D. H. de Lima Marcus Vinicius da Rocha Elaine C. S. M. Machado	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. É a técnica utilizada para retirada rápida da vítima de trauma que se encontra sentada no veículo ou em circunstância similar, obedecendo ao princípio de imobilidade da coluna vertebral após avaliação e identificação de gravidade com risco de morte.

2. OBJETIVOS

2.1. Descrever a técnica de retirada rápida da vítima de trauma encontrada sentada em veículo ou em circunstância similar.

3. EQUIPES ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e Central de Regulação.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADE

Materiais necessários
EPIs
Colar cervical
Estetoscópio
Máscara de oxigênio não reinalante
Cilindro de oxigênio portátil
Prancha longa
Três cintos de segurança ou dispositivo similar (cinto aranha)

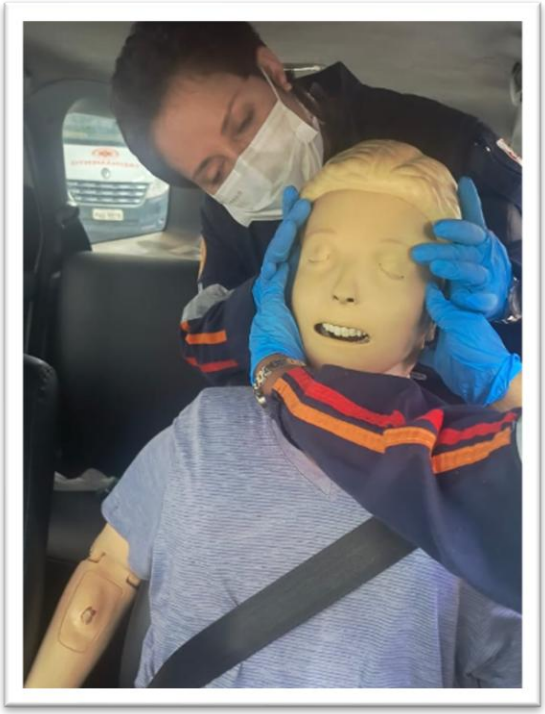
Procedimento

4.1. Em uso de EPI, confirmação da cena segura e portando materiais para o atendimento;

4.2. Verifique se a vítima não está presa nos pedais, ferragens ou outro obstáculo;

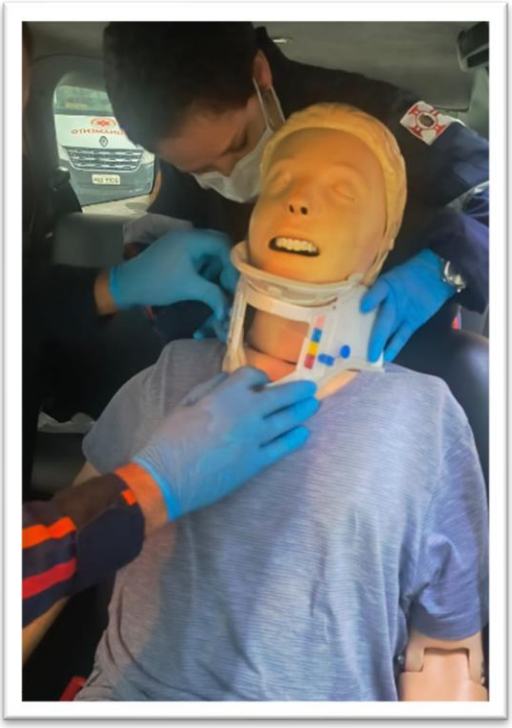
4.3. **Profissional 2** (enfermagem) faz a abordagem da vítima pela janela estabilizando a coluna cervical;

4.4. **Profissional 1** entra e se posiciona atrás da vítima (se possível, no banco traseiro), colocando as mãos espalmadas sobre as orelhas substituindo o **profissional 2;**

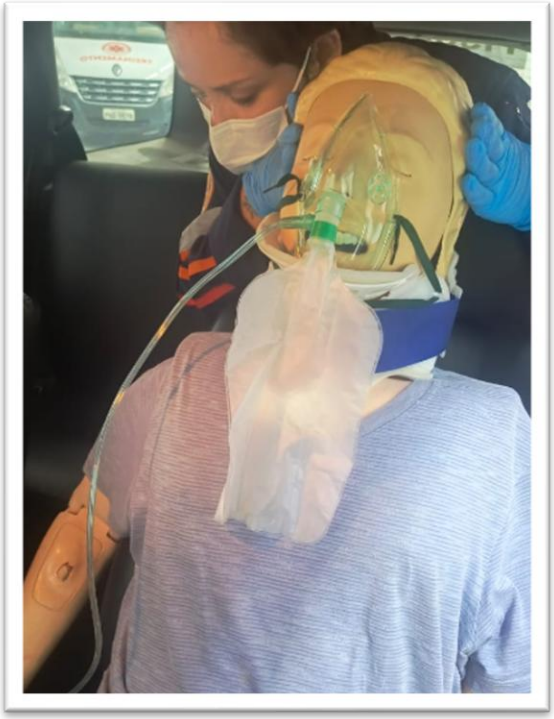


4.5. **Profissional 2** coloca as mãos no tórax anterior e posterior e aguarda o comando do **profissional 1** para encostar a vítima no banco;

4.6. **Profissional 3** se posiciona no banco do passageiro, realiza a medição e instalação do colar, solicitando que o **profissional 2** feche o dispositivo;

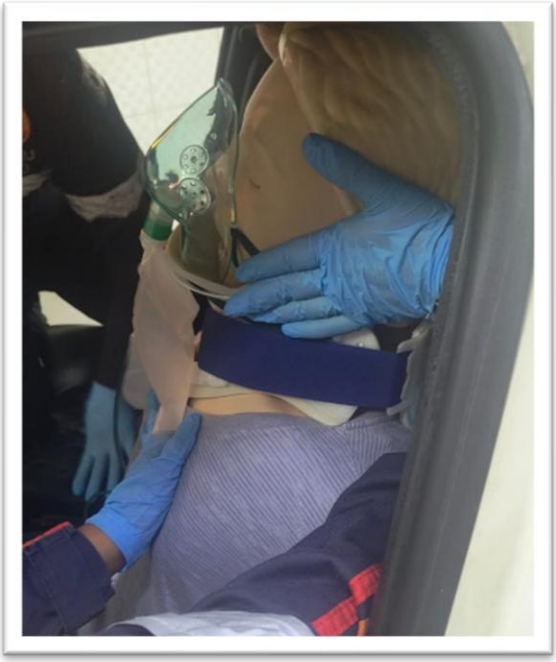


4.7. **Profissional 2** inicia a avaliação primária até encontrar indícios de gravidade (dificuldade para respirar, instabilidade hemodinâmica, rebaixamento de nível de consciência) e comunica a equipe da necessidade de retirada a rápida;

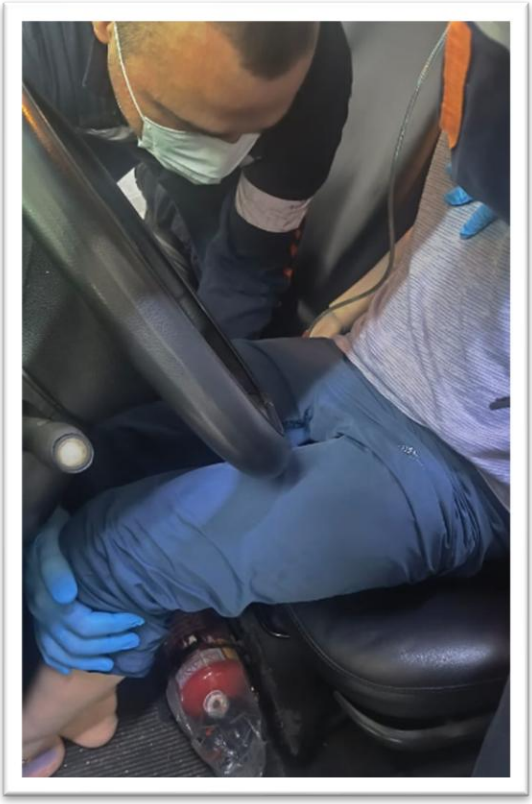


4.8. **Profissional 3** segura na alavanca para iniciar a movimentação do banco que vai ser feita após o comando do profissional 1 que dá ordem: "banco para trás e/ou frente, contando até 3: 1...2...3" (o banco deve estar alinhado com a coluna do carro);

4.9. **Profissional 1** mantem a estabilidade da coluna, enquanto o **profissional 2** mantem as mãos no tórax anterior e posterior, e sob o comando do **profissional 1** que dá a ordem: "tronco da vítima para frente, contando até 3: 1...2...3" (essa posição permite que possa ser iniciado a movimentação da vítima em bloco);



4.10. **Profissional 3** coloca uma das mãos até a altura do seu cotovelo sob as pernas da vítima na região poplítea, com a outra mão ele se apoia no banco e/ou painel. Nessa posição ele aguarda o comando para iniciar o primeiro giro sem elevar os membros;



4.11. **Profissional 1** da ordem: "vamos girar a vítima aproximadamente 45º, contando até 3: 1...2...3";

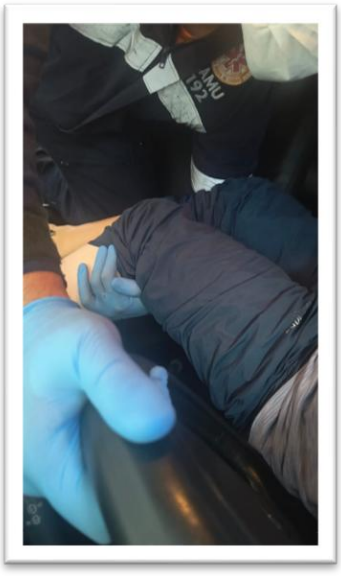
4.12. **Profissional 2** se mantem estabilizando a coluna torácica anterior e posterior até a retirada da vítima;

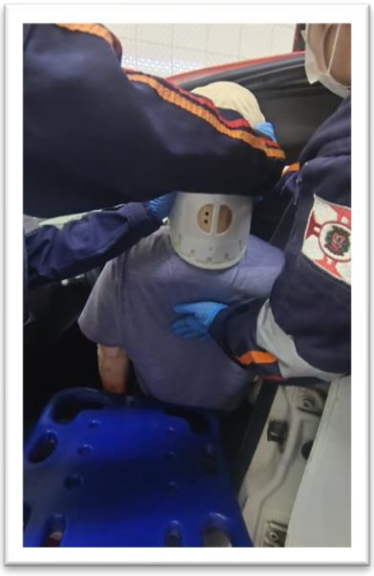
4.13. **Profissional 4**, após o primeiro giro assume a cabeça com as mãos espalmadas lateralmente sobre as orelhas ordenando: "cabeça é minha", liberando o **profissional 1** para pegar a prancha e a maca da ambulância, mantendo-a próxima;

4.14. **Profissional 3** libera uma perna de cada vez passando sobre o câmbio do veículo, posicionando novamente sua mão sob as pernas;

4.15. Todos os movimentos só devem ser realizados com sincronismo e após o comando do **profissional 1** com o objetivo de manter a coluna alinhada;

4.16. **Profissional 4** dá ordem: "vamos girar 45º, contando até 3: 1...2...3". Após o giro, a vítima estará na posição sentada (90º do início do atendimento), sendo estabilizada pelo **profissional 4** na cabeça, **profissional 2** no tórax e **profissional 3** nos membros inferiores;





4.17. **Profissional 1** apoia uma extremidade da prancha longa entre o banco e a região glútea da vítima, posicionando a outra extremidade da prancha (com a base do head block) nas suas coxas, mantendo as mãos livres para assumir a cabeça;

4.18. **Profissional 4** da ordem: "vamos descer a vítima na prancha, contando até 3: 1...2...3";

4.19. **Profissional 2** retira as mãos do tórax e posiciona nos ombros, o **profissional 3** mantem suas mãos sob as pernas flexionadas e o **profissional 4** com as mãos espalmadas na cabeça, dar o comando: "vítima para cima, contando 1...2...3". Essa manobra pode ser repetida mais uma ou duas vezes, a depender do alcance das mãos do **profissional 1**;

4.20. **Profissional 1** assume a cabeça, **profissional 4** assume os ombros e **profissional 2** assume a pelve, enquanto o **profissional 3** se mantem na mesma posição;

4.21. **Profissional 1** da ordem: "vítima para cima, contando até 3: 1...2...3". Essa manobra pode ser repetida até que a cabeça esteja posicionada na base do head block. Após o **profissional 1** assumir a cabeça, o restante da equipe deve IMEDIATAMENTE assumir a alça da prancha: **Profissional 4** assume as alças do lado direito da vítima, **profissional 2** assume as alças do seu lado esquerdo da vítima e o **profissional 3** assume a prancha na extremidade dos pés, levando-a para a maca da ambulância.

ATENÇÃO

4.22. Profissional 1 após assumir a cabeça não poderá solta-la em hipótese nenhuma.

4.23. O peso da vítima encontra totalmente sobre a coxa do profissional 1, por esse motivo a equipe deve imediatamente aliviar o peso segurando na alça.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. A retirada rápida é uma indicação de acordo com a identificação de gravidade: instabilidade da vítima, identificada durante avaliação primária; cena segura que pode se tornar insegura; paciente que precisa ser movido rapidamente para acesso a outro paciente mais grave.

5.1.1. Não deve ser realizada com base nas preferências pessoais.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. (NAEMT), National Association of Emergency Medical Technicians. AMLS: Advanced Medical Life Support: Atendimento Pré-Hospitalar às Emergências Clínicas. Porto Alegre: Artmed, 2022. Ebook.

9.2. PHTLS. Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado. National Association of Emergency Medical Technician, 2021. 9ª edição. 762 páginas.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2025	Atualização 1. Reorganização das definições e objetivos. 2. Padronização dos materiais necessários. 3. Detalhamento da avaliação primária como critério formal para indicação da retirada rápida, com explicitação de sinais de gravidade. 4. Padronização das atribuições dos profissionais durante o procedimento. 5. Reforço do sincronismo da equipe e da manutenção do alinhamento da coluna vertebral durante todas as fases da retirada. 6. Inclusão de orientações de segurança adicionais ao final do procedimento.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Celina H. H. Vasconcelos Elaine C. M. Machado	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Rosa Mateus D. Miachon	Nádia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. KED (Kendrick Extrication Device): dispositivo utilizado para retirada da vítima de trauma que se encontra sentada, sem gravidade.

2. OBJETIVOS

2.1. Descrever a técnica de uso do KED.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, SAV, URAM, Frota e Central de Regulação

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADE

Materiais necessários
EPIs
KED
Colar cervical
Prancha longa
Protetor lateral de cabeça
Bandagem triangular ou similar

Procedimento (mínimo 3 profissionais)

4.1. Em uso de EPI, confirmação da cena segura e portando materiais para o atendimento;

4.2. Verifique se a vítima não está presa nos pedais, ferragens ou outro obstáculo;

4.3. **Profissional 2** (enfermagem) faz a abordagem da vítima pela janela estabilizando a coluna cervical.

4.4. **Profissional 1** entra e se posiciona atrás da vítima, colocando as mãos espalmadas sobre as orelhas substituindo o **profissional 2**.

4.5. **Profissional 2** coloca as mãos no tórax anterior e posterior e aguarda o comando do **profissional 1** para encostar a vítima no banco;

4.6. **Profissional 3** se posiciona no banco do passageiro, realiza a medição e instalação do colar, solicitando que o **profissional 2** feche o dispositivo;

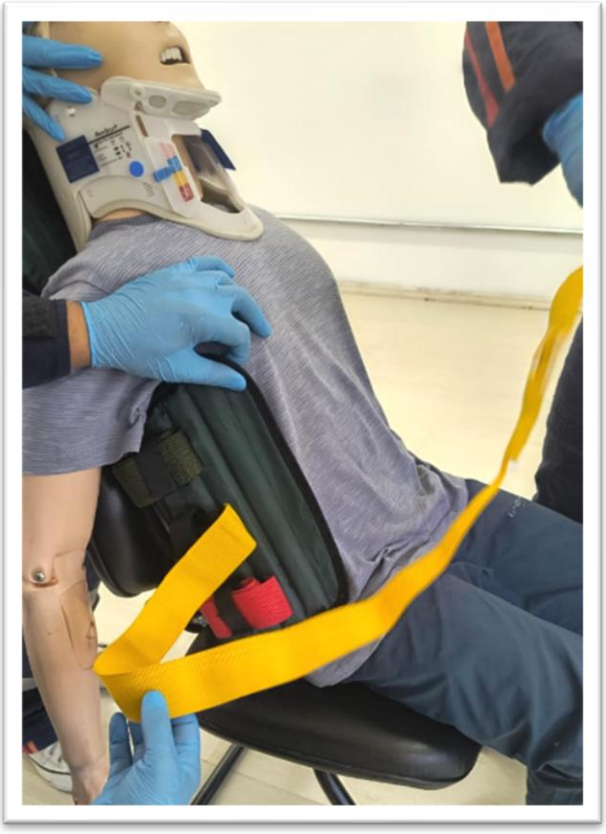
4.7. **Profissional 2** realiza a avaliação e após verificar que vítima se encontra estável, informa a equipe a equipe da necessidade de colocação do KED;

4.8. **Profissional 3** sai do veículo para pegar o KED, soltando os tirantes longos (virilha) e colocando atrás do dispositivo;

ATENÇÃO

4.9. Ao pegar o KED, o profissional deve conferir se esse dispositivo contém todos os complementos de imobilização (tirantes da testa, queixo e almofada).

4.10. **Profissional 1** mantendo a estabilização da cabeça, dá ordem para o **profissional 2** que está estabilizando a região torácica anterior e posterior: "movimentar a vítima para frente, contando até 3: 1...2...3" (apenas o suficiente para que o colete imobilizador seja posicionado entre a vítima e o encosto);



4.11. **Profissional 3** posiciona o colete imobilizador entre o encosto do banco e a vítima, ajusta as abas laterais do dispositivo abaixo das axilas;

4.12. **Profissionais 2 e 3** realizam o afivelamento dos tirantes iniciando torácico médio (amarelo), seguido do tirante torácico inferior (vermelho) e o tirante torácico superior (verde), que não deve ser apertado nesse momento;

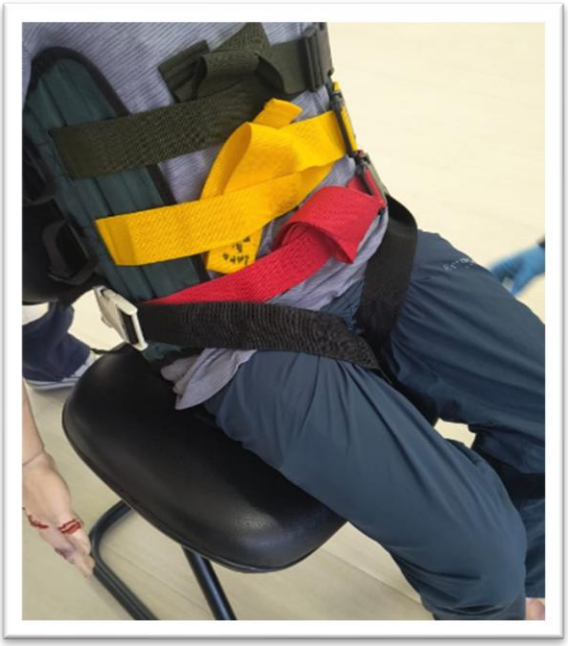
4.13. **Profissional 3** sobre o banco do passageiro, posiciona o colete imobilizador entre a vítima e o encosto do banco, enquanto a estabilização da cabeça é mantida pelo **profissional 1** e da região torácica anterior e posterior pelo **profissional 2;**

ATENÇÃO

4.14. O tirante verde deve ser mantido frouxo até que o paciente esteja pronto para ser retirado, quando então será ajustado como os demais.

4.15. Os tirantes longos da virilha que já estavam soltos, devem passar sob coxa, serem ajustados sob cada membro inferior e conectados ao dispositivo do mesmo lado;

4.16. Nesse momento é necessário revisar e ajustar os tirantes do tronco, exceto o superior (verde);



ATENÇÃO

4.17. Analisar se é necessário o uso da almofada para preencher o espaço entre a cabeça e o colete, mantendo o alinhamento neutro.

4.18. **Profissional 2** coloca os tirantes de fixação na região frontal (testa) da vítima, prendendo as tiras no velcro do dispositivo;

4.19. **Profissional 3** coloca os tirantes de fixação da região do mento (queixo) da vítima, prendendo as tiras no velcro do dispositivo;

4.20. **Profissional 1** já pode sair do veículo;

ATENÇÃO

4.21. Os dois antebraços do paciente devem ser posicionados um sobre o outro e imobilizados com a ajuda de bandagens triangulares.

4.22. Uma extremidade da prancha longa é posicionada sob as nádegas da vítima e apoiada no assento, enquanto a outra é apoiada pelo profissional;

4.23. **Profissional 2 e 3** deverão proceder à remoção segurando pelas alças do colete enquanto giram, levantam e movimentam a vítima para a prancha em movimentos curtos e sincronizados;

4.24. **Profissional 3** mantem os membros inferiores elevados durante a movimentação de retirada;

4.25. Manter os membros inferiores elevados até que os tirantes (pretos) da virilha sejam soltos, para que não haja compressão da circulação;

4.26. Após a retirada da vítima, os tirantes superiores do tórax podem ser afrouxados;

4.27. O dispositivo deverá ser mantido na vítima até a sua avaliação na unidade de saúde.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não há.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não há.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. PHTLS. Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado. National Association of Emergency Medical Technician, 2021. 9ª edição. 762 páginas.

10. CONTROLE DE REVISÕES CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Reorganização e padronização do conteúdo e da numeração do protocolo. 2. Ampliação das equipes envolvidas no procedimento. 3. Maior clareza na indicação, sequência e responsabilidades da equipe. 4. Reforço das orientações de segurança e alinhamento da coluna. 5. Padronização da colocação, ajuste e retirada do KED.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Celina H H Vasconcelos Elaine Melo	Bárbara de Souza Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. É a técnica utilizada em casos confirmados ou suspeitos de fraturas pélvicas, com objetivo de estabilizar a lesão e reduzir o sangramento e a dor.

2. OBJETIVOS

2.1. Descrever a técnica de imobilização da pelve.

3. EQUIPES ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e Central de Regulação.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADE

Materiais necessários
EPIs (luvas de procedimento, máscara, óculos)
Cinta pélvica do tamanho adequado (P, M, G)
Bandagem triangular ou atadura de crepe (10 a 15 cm)

Procedimento

4.1. Em uso de EPI;

4.2. Explique o procedimento à vítima;

4.3. A palpação da pelve deve ser feita na vítima hemodinamicamente instável confirmado no MNEMÔNICO "C" (após avaliar pele, pulso e perfusão), se até esta etapa a causa da instabilidade não tiver sido identificada;

4.4. **Profissional 1** ao palpar a pelve e identificar alterações como: instabilidade, crepitação e reação dolorosa, não deve mais retirar as mãos dessa região, solicitando a imobilização imediata;

4.5. A palpação da pelve deve ser realizada através das seguintes manobras: o profissional posiciona as mãos na crista ilíaca bilateralmente, exercendo uma pressão para dentro (fechamento);

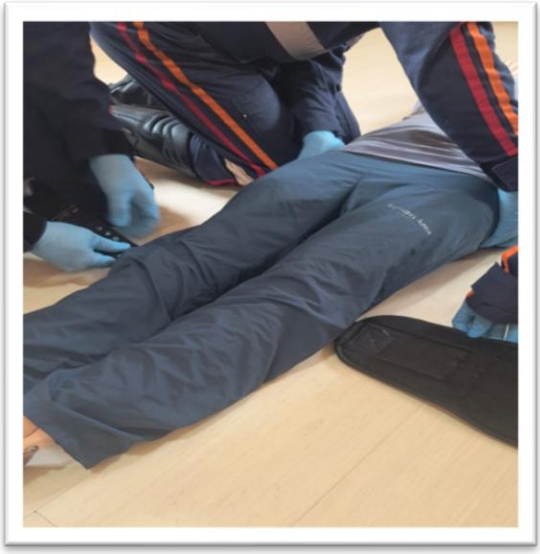
ATENÇÃO

4.6. O profissional, ao perceber instabilidade pélvica e/ou reação dolorosa da vítima ao fazer a manobra, deve interromper o exame, manter a estabilização manual e solicitar a imobilização imediata.

4.7. Na presença de deformidade pélvica e/ou referência de dor nessa região, a imobilização estará indicada sem a necessidade do exame dessa estrutura.

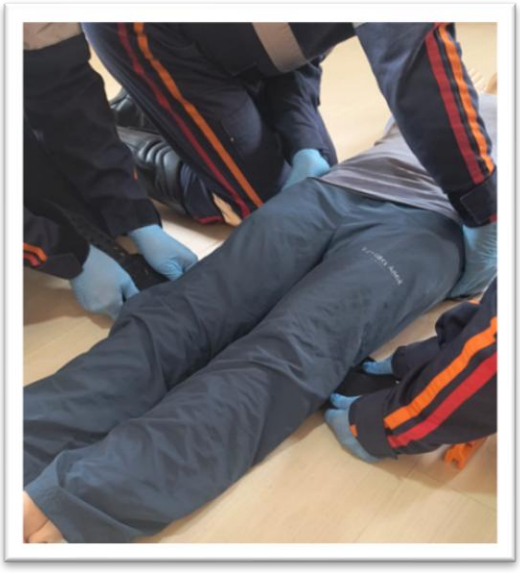
4.8. **Profissional 2** pega a cinta pélvica de tamanho adequado à vítima e solicita apoio do profissional 3;

4.9. **Profissional 1** mantém a estabilização manual da pelve, enquanto o profissional 2 se posiciona de um lado da vítima e passa a cinta no vão do joelho;

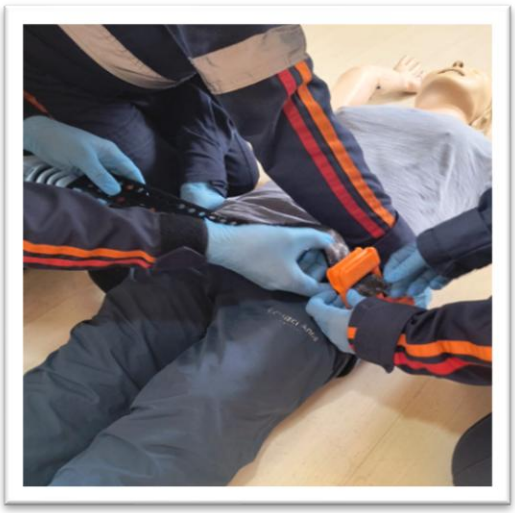


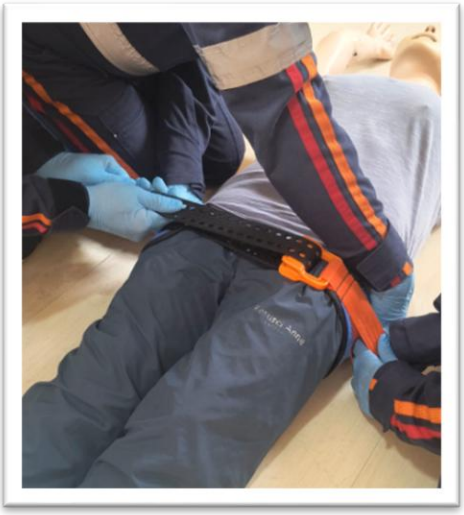
4.10. **Profissional 3** do lado contralateral, pega a outra extremidade da cinta;

4.11. **Profissional 2** e **3** iniciam movimento de serra em direção a região trocantérica e encaixam a parte de velcro da cinta na alça rígida;



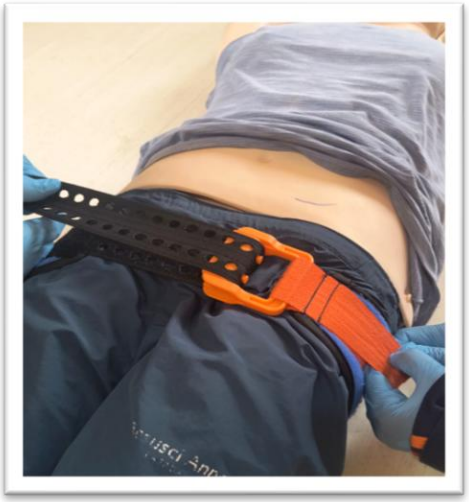
4.12. Os dois profissionais seguram a cinta: um deles segura pelo velcro e o outro pela alça de tecido, puxando para as extremidades, até que o mecanismo de trava da cinta seja acionado;





4.13. **Profissional 1** pode retirar a mão da pelve da vítima assim que as alças forem puxadas para as extremidades.

4.14. Por fim os membros inferiores devem ser mantidos unidos para evitar a adução e piora da lesão.



5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não coloque nenhum dispositivo (coxim) para manter a abdução entre os membros inferiores da vítima.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. PHTLS. Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado. National Association of Emergency Medical Technician, 2021. 9ª edição. 762 páginas.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
02	02/02/2026	Atualização 1. Revisão da definição. 2. Atualização das equipes envolvidas. 3. Padronização dos materiais, priorizando o uso de cinta pélvica específica em substituição a métodos improvisados. 4. Reorganização e simplificação das etapas do procedimento, garantindo maior segurança e efetividade na aplicação. 5. Inclusão de recomendações finais para evitar agravamento da lesão e garantir alinhamento dos membros inferiores.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Ana Midori Harada Celina H. Hoshino Vasconcelos Elaine C. M. Machado	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nádia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Imobilização de extremidades: técnica utilizada para reduzir o risco de novas lesões, hemorragias e minimizar a dor em vítimas com trauma de extremidade.

2. OBJETIVOS

2.1. Descrever a técnica de imobilização nas lesões de extremidades.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E e URAM.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADE

Materiais necessários
EPIs (luvas de procedimento, máscara, óculos);
Talas de vários tamanhos;
Bandagem triangular;
Atadura de crepe (10 a 15 cm);

Procedimento

4.1. Em uso de EPI;

4.2. Explique o procedimento à vítima;

4.3. Retire adornos, calçados e corte as roupas dos membros a serem avaliados;

4.4. Avalie pulso, perfusão, sensibilidade e motricidade do membro lesionado;

4.5. Na ausência de pulso, tentar realinhar até a restauração do fluxo sanguíneo ou a presença do enchimento capilar, respeitando o limiar de dor da vítima;

4.6. Realize o alinhamento da extremidade óssea lesionada em posição anatômica;

4.7. Realize a remoção de toda sujidade em excesso com soro fisiológico e mantenha a lesão coberta;

4.8. Apoie o membro lesionado em tala;

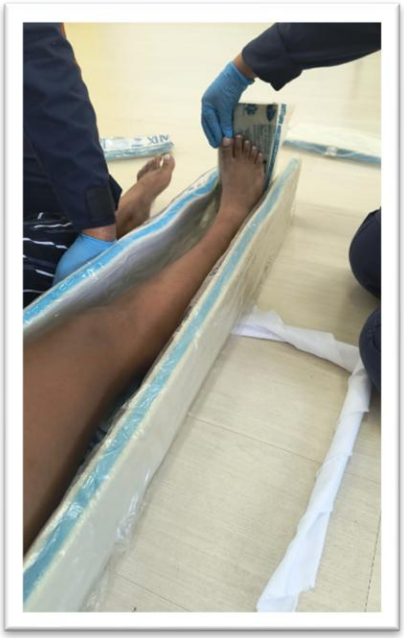
4.9. Estabilize manualmente o membro lesionado até que os procedimentos com a lesão e a imobilização tenham sido finalizados;

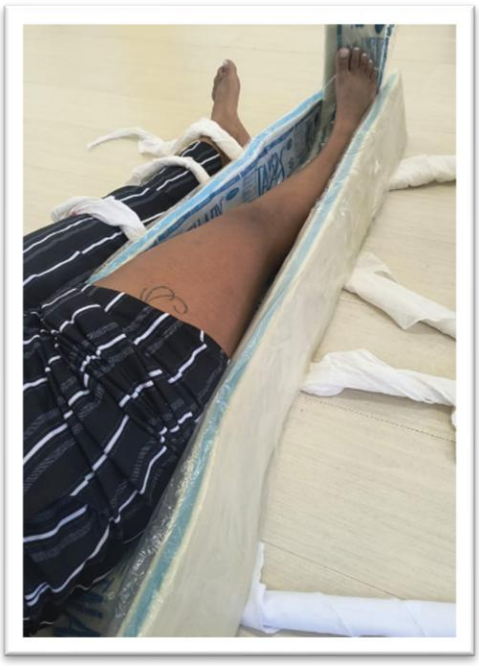
4.10. Reavalie a extremidade após a imobilização em relação à perfusão e sensibilidade.

Imagens:

4.11. Sequência de imobilização de extremidade com uma tala, para evitar a perda de tempo – paciente instável:

4.12. Sequência de imobilização de extremidade tipo caixote, para paciente estável:





ATENÇÃO

4.13. Realize a imobilização com bandagem triangular na suspeita de lesões: escapular, ombro e úmero, conforme ilustração abaixo.

SEQUÊNCIA 01

SEQUÊNCIA 02

SEQUÊNCIA 03

SEQUÊNCIA 04

SEQUÊNCIA 05

SEQUÊNCIA 06

SEQUÊNCIA 07

SEQUÊNCIA 08

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não há.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. PHTLS. Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado. National Association of Emergency Medical Technician, 2021. 9ª edição. 762 páginas.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
02	02/02/2026	Atualização 1. Atualização e detalhamento dos materiais, com especificação dos EPIs. 2. Padronização do procedimento em etapas numeradas, facilitando a aplicação prática. 3. Reforço da avaliação neurovascular antes e após a imobilização. 4. Inclusão de orientações específicas para pacientes instáveis e estáveis, com diferenciação por meio de sequências ilustrativas.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Celina H. H. Vasconcelos Elaine Melo	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. O rolamento em bloco é a técnica utilizada para mudar a posição do paciente de forma segura e controlada, mantendo o alinhamento do corpo e protegendo a coluna vertebral;

1.2. **Rolamento 90º:** consiste em girar o paciente parcialmente, até cerca de 90 graus, geralmente do decúbito dorsal para a posição lateral. Essa técnica permite a inspeção do dorso, a colocação da prancha longa e a prevenção de aspiração em paciente com vômito ou secreções;

1.3. **Rolamento 180º:** consiste em girar o paciente completamente, em torno de 180 graus, mudando de decúbito dorsal para decúbito ventral, ou vice-versa.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever a técnica de mobilização segura do paciente vítima de trauma, a fim de minimizar o risco de lesões secundárias, principalmente da coluna vertebral.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, SAV, URAM

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADE

Materiais necessários
EPIs (luvas de procedimento, máscara, óculos);
Colar cervical
Imobilizador lateral de cabeça com tirantes
Prancha longa
Três cintos de segurança ou dispositivo similar (“cinto aranha”)

Procedimento

4.1. Em uso dos EPIs;

4.2. Explique o procedimento ao paciente/ acompanhante;

4.3. Realize o procedimento conforme descrito:

4.4. **Profissional 1:** apoie os joelhos no chão, coloque a mão esquerda espalmada sobre a orelha esquerda e a mão direita espalmada sobre a orelha direita da vítima para o controle manual da cabeça, antes de iniciar o rolamento.

ATENÇÃO!

4.5. A vítima deve ser mobilizada para o lado oposto à direção a que seu rosto aponta inicialmente.

4.6. Os membros superiores da vítima devem ser mantidos em posição "nadador" antes de iniciar o rolamento. Se a face da vítima estiver virada para o lado direito, o braço esquerdo da vítima deve ser elevado para apoiar a cabeça, e o braço direito estendido ao longo do corpo, ou vice-versa;

4.7. Os membros inferiores devem ser alinhados em posição anatômica para o rolamento, mesmo na presença de lesões.

4.8. Antes de realizar o giro, o profissional de enfermagem deve avaliar o dorso da vítima;

4.9. **Profissional 2:** posicione a prancha rígida perpendicularmente à vítima, mantendo um vão aproximado de 20 cm; apoie os joelhos sobre a prancha e posicione as mãos, respectivamente, no ombro e na pelve da vítima;

4.10. **Profissional 3:** apoie os joelhos sobre a prancha, ao lado do profissional 2 e posicione uma mão na pelve da vítima, com cruzamento dos braços entre os profissionais. Posicione a outra mão, respectivamente, na região tibial anterior da vítima;

4.11. Na presença do **profissional 4:** segure os membros inferiores para maior estabilidade durante a movimentação;

4.12. O rolamento deve ser realizado em 02 tempos:

4.13. **1º tempo:** o **profissional 1** confirma o posicionamento dos demais membros da equipe e efetua a contagem para o rolamento 90º da vítima;

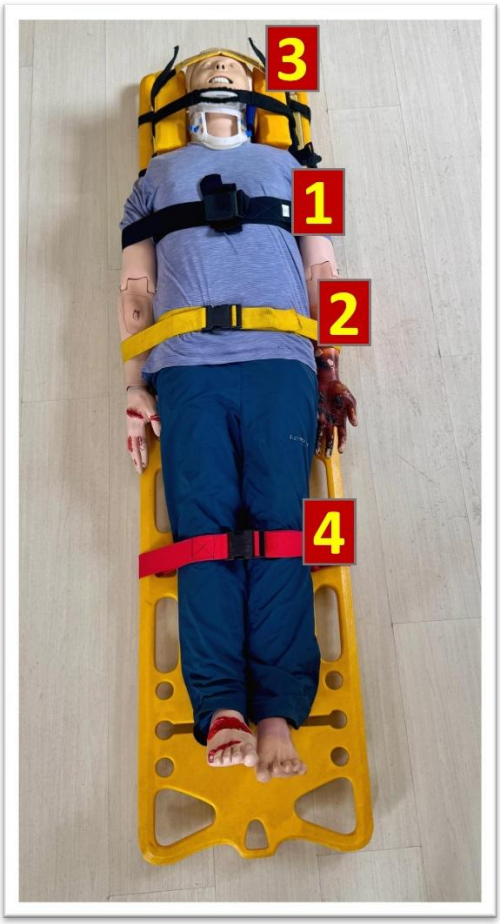
4.14. O **Profissional 1** dá a ordem: "vamos girar a vítima 90º, contando no 3: 1...2...3", mas não acompanha a movimentação da vítima, permanecendo com a cabeça na mesma posição;

4.15. **2º tempo:** com a vítima à 90º, o **profissional 1** confirma o posicionamento dos demais e efetua a contagem para mais um giro 90º e posicionamento na prancha;

4.16. O **Profissional 1** dá a ordem: "vamos girar mais 90º, contando no 3: 1...2...3", e acompanha a movimentação da vítima até a prancha, mantendo a imobilização manual da cabeça até a colocação do imobilizador lateral e fixação com os tirantes;

4.17. O **Profissional 2** posiciona as mãos nos ombros e o **profissional 3** posiciona as mãos na pelve, para ajustar a vítima na prancha através de movimentos em "serrote", para baixo e para cima;

4.18. Com a vítima em decúbito dorsal horizontal, já centralizada na prancha, o **profissional 1** mantém a estabilização da coluna, enquanto os **profissionais 2 e 3** colocam os tirantes na seguinte ordem: tórax, pelve, imobilizador lateral de cabeça (*head block*) e membros inferiores;



ATENÇÃO!

4.19. Vítimas em uso de capacete que estejam em decúbito ventral, devem ser mobilizadas para posição anatômica antes da retirada do capacete.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. A mobilização da vítima de trauma deve ser realizada por equipe treinada de forma sincronizada;

5.2. O alinhamento da coluna deve ser mantido durante todo o procedimento;

5.3. O comando deve partir sempre do profissional que controla a cabeça.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. PHTLS. Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado. National Association of Emergency Medical Technician, 2021. 9ª edição. 762 páginas.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
02	02/02/2025	Atualização 1. Aprimoramento do objetivo, com foco na mobilização segura do paciente e na prevenção de lesões secundárias, especialmente da coluna vertebral. 2. Padronização do posicionamento dos membros superiores e inferiores antes do rolamento. 3. Inclusão explícita da avaliação do dorso da vítima antes da mobilização, reforçando a inspeção clínica. 4. Detalhamento da execução do rolamento em dois tempos. 5. Previsão da atuação de um quarto profissional, quando disponível, para maior estabilidade durante a movimentação. 6. Definição da ordem correta de fixação da vítima na prancha longa, reduzindo riscos durante a imobilização.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Celina H. H. Vasconcelos Elaine C. M. Machado	Bárbara de Souza Mateus D. Miachon	Nádia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. OBJETIVOS

1.1. Descrever a técnica de contenção física e mecânica para as vítimas com alterações de origem psíquicas, a fim de prevenir dano imediato ou iminente ao paciente ou aos demais.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Contenção física: o emprego de meios físicos externos que interfirem na liberdade de movimentos corporais do paciente, com a finalidade de impedir que este pratique ato violento de hetero ou autoagressão. É utilizada em pacientes que estejam em quadro de agitação psicomotora e deve ter como objetivo primordial sua proteção, a de outros presentes na cena e a da equipe envolvida no atendimento (QUEVEDO; CARVALHO, 2013). É inapropriado e ilegal o uso de restrições para a punição, retaliação, intimidação ou conveniência da equipe.

2.2. Contenção física pela enfermagem: o Conselho Federal de Enfermagem, conforme Resolução 746/2024, estabelece que os profissionais que atuam no Serviço de Atendimento Pré-hospitalar Móvel, poderão realizar a contenção mecânica de maneira segura, utilizando no mínimo de 05 (cinco) pessoas para realização do procedimento. O monitoramento do paciente em contenção mecânica é de responsabilidade da equipe de Enfermagem, com o objetivo de promover a segurança e prevenir danos e eventos adversos. Além disso, em todos os procedimentos de contenção mecânica de

pacientes, as razões para a realização, sua duração, avaliações e ocorrência de eventos adversos, assim como os detalhes relativos ao monitoramento clínico, devem ser registrados. A contenção de pacientes será realizada quando for o único meio disponível para prevenir dano imediato ou iminente ao paciente ou aos demais.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, SAV, URAM e Central de Regulação

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADE

Avaliação de risco

4.1. Avaliação da cena: Mnemônico ACENA**.** Deve-se obter informações das pessoas que testemunharam a ocorrência e observar o que pode estar associado a um aumento do risco de violência como familiares, desconhecidos, multidões, influência de álcool ou drogas, existência de traumatismos, possíveis razões para hostilidade, suspeita de doenças ou causas orgânicas.

4.2. Sinais de risco de agressividade: Postura/comportamento da vítima; discurso ameaçador, conteúdo agressivo; atividade motora: agitação, inquietação; linguagem corporal: postura tensa e rígida, punhos cerrados, musculatura tensa, evitação de contato visual ou olhar penetrante.

4.3. Cuidados com o ambiente: Certifique-se da existência de possíveis rotas de fuga do paciente; observe os movimentos das mãos do paciente; identifique objetos que possam ser utilizados como armas; promova a manutenção de um ambiente organizado, calmo e sem fatores estimulantes; sempre que possível, dê preferência a posicionar o paciente com as costas voltadas para uma parede; busque garantir acesso facilitado ao local para equipes de apoio suplementares.

4.4. A equipe deve se manter afastada, em local seguro e solicitar apoio de autoridade policial em situações de cena hostil, possibilidade de violência contra a equipe e necessidade de desarmamento.

4.5. Deve-se solicitar apoio do COBOM em situações de risco elevado de lesões graves ou à morte relacionados ao ambiente.

Estratégias de Abordagem

Abordagem Verbal

4.6. Desescalonamento verbal: o profissional deve procurar utilizar-se sempre de um tom de voz baixo e de ritmo lento na fala, trazendo tranquilidade, o que provoca uma reação semelhante no indivíduo agitado;

4.7. Validação: afirmações empáticas podem deixar a pessoa agitada mais à vontade, quando as declarações são feitas em um contexto de preocupação genuína.

4.8. Não confronto: o profissional não deve debater, ou julgar, ou dizer que a pessoa está errada ou que o que está sentindo "é coisa da cabeça dela".

Contenção Física

Recomendações Gerais

4.9. Deve haver pelo menos cinco pessoas para realizar a contenção: uma para cada membro e o coordenador para tórax e fronte.

4.10. O coordenador deve ter uma frase/senha previamente combinada (não muito curta nem muito longa e dentro do contexto do atendimento);

4.11. O profissional deve conter o paciente sempre nas articulações;

4.12. Deve haver material para contenção já posicionado e de fácil acesso;

4.13. Deve haver distância segura de aproximadamente 1 braço e meio;

4.14. O profissional deve manter posição de semicírculo, "encurralando o paciente" (mensagem de limite);

4.15. O profissional deve procurar deixar o paciente com as costas para uma parede, a fim de evitar sua fuga;

4.16. O profissional deve observar qualquer objeto que possa tornar-se uma arma, como vidros, louças, itens pesados ou pontiagudos e não permitir que o paciente acesse esses objetos;

4.17. O profissional deve observar os sinais não verbais;

4.18. O profissional deve ser tranquilo e empático, pois o seu comportamento irá influenciar o comportamento do paciente;

4.19. Caso não haja cinco pessoas para a contenção do paciente, a recomendação é solicitar apoio a outra equipe, para que não se coloquem os profissionais, o próprio paciente e as demais pessoas na cena em risco.

Execução

4.20. Designiação dos profissionais para contenção Os profissionais vão realizar a contenção dos membros de acordo com sua posição no semicírculo: Linha de cintura – membros superiores; Linha diagonal – membros inferiores; e Centro/coordenador – tórax e fronte do paciente. Após o comando do profissional coordenador (frase/senha chave) os 5 profissionais realizarão a imobilização da vítima;

4.21. Membros superiores**:** O profissional deve segurar os membros com ambas as mãos. Deve segurar o punho, girar o seu corpo para ficar lateralizado, colocar a articulação do cotovelo do paciente debaixo de sua axila e prendê-la juntamente a seu tórax, mantendo o membro estendido.

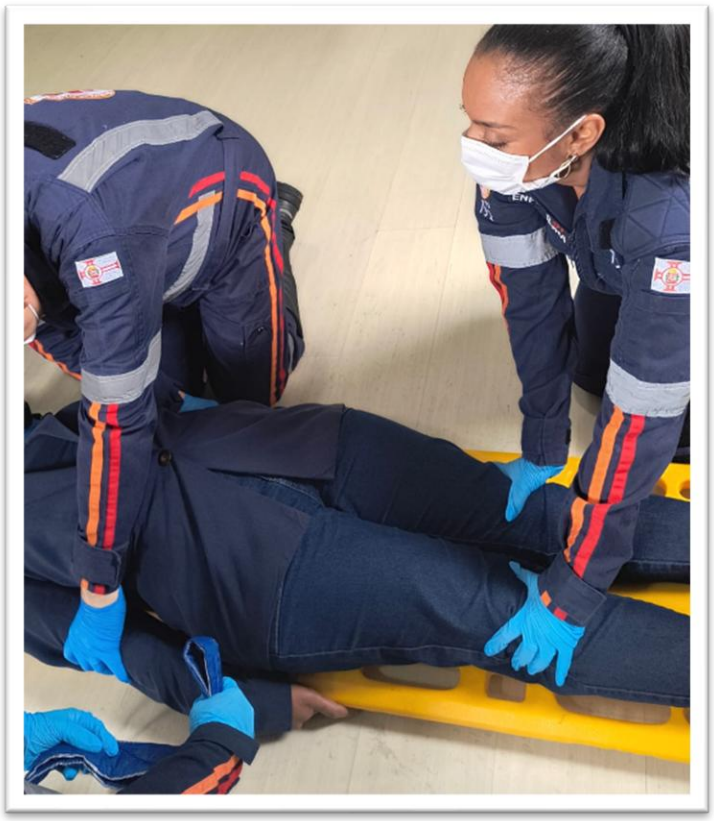
4.22. Membros inferiores: O profissional deve posicionar-se agachado e lateralizado. Um dos seus joelhos deve permanecer dobrado e em contato com o solo, e o outro, firmado ao chão. Deve-se abraçar e segurar o joelho com uma mão e o tornozelo com a outra, mantendo o membro estendido. Não se deve aproximar o rosto do joelho.

4.23. Tórax e Fronte**:** O profissional deve passar um braço sobre o tórax, firmando-o, e o outro braço sobre a testa. O peso do paciente será apoiado por sobre o corpo do profissional, com a maior área corporal possível em contato. Esse posicionamento é fundamental, pois, quando o paciente for desequilibrado por meio da elevação de seus membros inferiores, o profissional será o que vai receber maior impacto do peso a ser transportado para a prancha ou para a maca.

4.24. Pontos de contenção: Joelho e tornozelo, punho e ombro. Observe todos os pontos de contenção na foto abaixo;

4.25. Ao comando do profissional coordenador (comunicação em alça fechada) a equipe devera promover o desequilíbrio do paciente, erguendo-o pelos membros inferiores. O peso do paciente recai sobre o profissional que se encontra posicionado atrás dele, por isso ele deve posicionar seu corpo de forma que tenha o maior contato possível.

4.26. Transporte e posicionamento na maca/prancha – com os membros suspensos e seguros, o tórax e a cabeça apoiados do profissional coordenador, posicionar a vítima sobre a maca/prancha, mantendo a na posição anatômica (DDH): Membros inferiores afastados (fixar joelho e tornozelo); e membros superiores ao longo do tronco, com as palmas das mãos para cima (fixar punhos).



Contenção mecânica

Recomendações Gerais

4.27. Inicia-se a contenção pelo membro que está mais agitado e que apresenta maior risco de se soltar ou pelo membro que apresentar maior dificuldade de mobilização.

4.28. Para se realizar a fixação, deve-se utilizar kit de contenção (materiais acolchoados/próprios).

4.29. Não garrotear os membros.

4.30. O paciente NUNCA deve ser contido ou transportado em decúbito ventral dado o risco de depressão respiratória e morte.

Membros superiores e inferiores

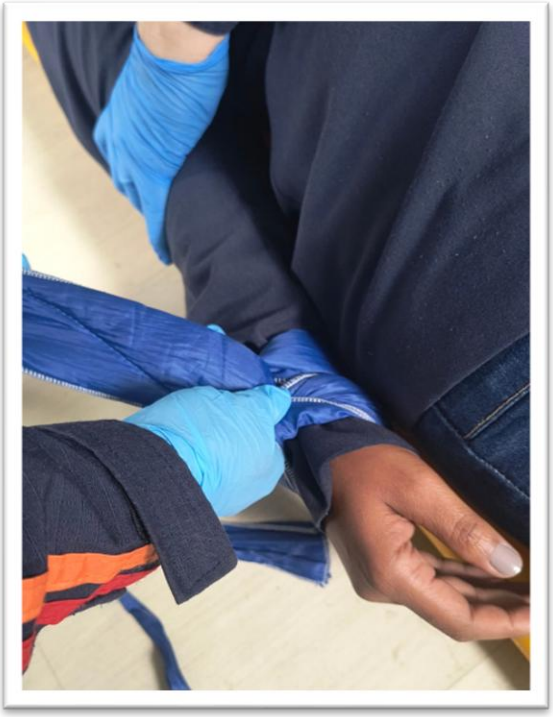
4.31. Nos membros superiores a faixa deve envolver os punhos e nos membros inferiores deve envolver os tornozelos.

4.32. Passar a faixa por baixo da articulação, com nó na parte anterior.

4.33. Amarrar a faixa na lateral da maca/prancha.

4.34. Caso a vítima consiga liberar ambos os braços ou ambas as pernas, deve-se contê-los juntos, imediatamente, para, depois de controlada a situação, separá-los e proceder conforme a técnica;

4.35. Observar pele e perfusão para identificar eventual ocorrência de garroteamentos e lesões locais ou nos membros contidos da vítima. Há necessidade de monitoramento clínico do nível de consciência, de dados vitais e de condições de pele e circulação nos locais e membros contidos da vítima



Tórax

4.36. A faixa torácica possui maior largura e deve ser posicionada na altura do tórax.

4.37. Fixar a faixa de contenção nas laterais da maca/prancha.

4.38. Evitar compressão de tórax e nunca comprimir abdómen.

4.39. O coordenador deve manter a restrição física do tórax da vítima até que todos os membros e tórax estejam contidos mecanicamente.

4.40. Caso vítima muito agitada solicitar apoio SAV (contenção química).

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. O uso dessas medidas de forma inadequada pode acarretar injúria ao paciente como ferimentos, hipertermia, rabdomiólise, aumento da agitação, edema, necrose, ruptura da pele, dano neurovascular e até mesmo a sua morte.

5.2. No caso de vítimas graves, permanência ou piora do quadro de agitação mesmo após esgotadas estratégias de abordagem com possível comprometimento da segurança da equipe durante transporte da vítima solicitar apoio SAV.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP Intervenções em Atendimento Pré-Hospitalar 071 -emergências psiquiátricas;

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). Resolução Cofen nº 746, de 20 de março de 2024. Dispõe sobre as atribuições da equipe de enfermagem na assistência ao paciente. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 20 mar. 2024.

9.2. QUEVEDO, J.; CARVALHO, A. F. (org.). Emergências Psiquiátricas. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 336 p.

9.3. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Governo do Distrito Federal. Atendimento pré-hospitalar em saúde mental: noções das urgências e emergências em saúde mental. Brasília DF. 2021. 1º Edição.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
02	02/02/2026	Atualização 1. Alteração da nomenclatura do protocolo, de "Imobilização e Contenção Física" para "Contenção Física e Mecânica". 2. Atualização do objetivo, com foco na proteção da vítima, da equipe e de terceiros. 3. Adequação às normas éticas e legais, com inclusão da Resolução COFEN nº 746/2024 e proibição do uso punitivo da contenção. 4. Ampliação das áreas envolvidas, incluindo a URAM. 5. Estruturação da avaliação inicial de risco e padronização dos cuidados com o ambiente. 6. Fortalecimento das estratégias de desescalonamento verbal antes da contenção física. 7. Definição de critérios mínimos para contenção, com exigência de cinco profissionais e organização prévia da equipe. 8. Padronização da técnica de execução, com divisão de funções e pontos anatômicos definidos. 9. Atualização das orientações para posicionamento e transporte, vedando o decúbito ventral. 10. Revisão da contenção mecânica, com uso de materiais adequados e prevenção de lesões.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes	Elaine C. S. M. Machado Luis Cássio Carneiro Leão Patrícia Caroline A. de Sousa	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nádia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Punção venosa periférica: procedimento de inserção de um cateter venoso periférico em uma veia superficial, com a finalidade de permitir a administração de soluções intravenosas, medicamentos, hemoderivados, ou para coleta de sangue.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever a técnica para punção e estabelecimento de um acesso venoso periférico.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV, SBV-E, URAM e SAV

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

Materiais necessários
EPIs (luvas de procedimento, máscara, óculos)
Swab de álcool 70% para antissepsia da pele
Clorexidina - solução aquosa 2% almotolia
Garrote
Adesivo para fixação do cateter (esparadrapo ou similar)
Cateter intravenoso (diversos calibres)
Equipo/ seringa
Solução fisiológica
Caixa para descarte de perfurocortante

4.1. Explique o procedimento à vítima;

4.2. Selecione o membro e local para punção;

4.3. Selecione o tipo de dispositivo e calibre, levando em consideração idade e condição da rede venosa;

4.4. Visualize a veia, garroteie 10 a 15 cm acima do local de inserção proposto;

4.5. Calce as luvas de procedimento e utilize máscara e óculos de proteção;

4.6. Realize a assepsia do local com swab de álcool 70%, friccionando por pelo menos 30 segundos, com movimentos circulares do centro para a periferia, lembrando de não tocar no local a ser puncionado após a assepsia;

4.6.1. Se a pele estiver com muita sujidade, faça a limpeza usando solução aquosa de clorexidina a 2%. Aplique a solução e passe gaze para ajudar na limpeza;

4.7. Tracione a pele com o polegar abaixo do local a ser puncionado para minimizar a mobilidade da veia;

4.8. Introduza o cateter venoso na pele, com o bisel voltado para cima, a um ângulo de 15° a 30°, até a cateterização do vaso;

4.9. Ao visualizar o refluxo sanguíneo na câmara, reduza o ângulo e introduza o cateter enquanto retira gradualmente do mandril;

4.10. Solte o garrote;

4.11. Despreze agulha-guia no coletor de resíduos perfuro cortantes;

4.12. Estabilize e fixe o cateter utilizando fita adesiva hipoalergênica estéril ou película transparente;

4.13. Conecte o equipo e fixe o dispositivo;

4.14. Identifique o acesso com data e hora;

4.15. Registre o procedimento na ficha de atendimento, intercorrências, bem como o calibre do dispositivo utilizado.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. A presença de hematoma, extravasamento, oclusão e/ou dor indica que a veia foi transfixada ou a agulha está fora da veia. Neste caso retire o dispositivo, pressione o local com algodão e realize uma nova punção em outro local;

5.2. Após duas tentativas de acesso sem sucesso, comunique o médico regulador.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1 Não há

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. POTTER, Patricia A.; PERRY, Anne Griffin. Fundamentos de enfermagem. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2022.

9.2. Craven, R. F.; Hirnle, C. J. Fundamentos de Enfermagem: saúde e função humanas. 4. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.

9.3. BARROS, A. L. B. L; LOPES, J. L.; MORAIS, S. C. R. V. Procedimentos de enfermagem para a prática clínica. 1º edição, Porto Alegre: Artmed, 2019.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
02	02/02/2025	Atualização 1. Padronização e detalhamento dos materiais necessários, com inclusão de EPIs completos e antissépticos adequados. 2. Atualização da técnica de assepsia, com padronização do uso de álcool 70% e clorexidina aquosa a 2% em casos de sujidade. 3. Organização do procedimento em etapas sequenciais numeradas, facilitando a execução segura. 4. Padronização do descarte de materiais perfurocortantes e da fixação do cateter. 5. Inclusão de orientações claras para identificação do acesso (data e hora). 6. Inclusão de recomendações de segurança frente a falhas de punção e limite de tentativas, com comunicação à Regulação Médica.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia Oliveira Lopes Edna B da Silva	Dumara Maria D. H. de Lima Karen Gisele da S. Guerreiro Wanderson S. Rosa Elaine C. S. M. Machado Victor Bezerra de Souza	Bárbara de Souza Lia Midori Straceri Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Punção intraóssea: procedimento de emergência utilizado para acessar rapidamente a circulação sistêmica por meio da inserção de uma agulha especial na cavidade medular de ossos longos (geralmente tíbia proximal ou úmero), permitindo administração de fluidos e medicamentos quando o acesso venoso periférico é difícil ou impossível, especialmente em situações críticas como choque, parada cardiorrespiratória e trauma grave;

1.2. A técnica deverá ser realizada por profissionais enfemeiros devidamente capacitados pela instituição, com respaldo pela resolução COFEN 648/2020.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever a técnica para obtenção do acesso vascular intraósseo para o profissional Enfermeiro que compõe a equipe do SAMU 192 São Paulo.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. SBV-E, URAM e Central de Regulação

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

Indicações

4.1. Após 3 tentativas de acesso venoso periférico sem sucesso ou 90 segundos de tentativas.

Materiais necessários
EPIs (luvas de procedimento, máscara, óculos)
Swab de álcool 70% para antissepsia da pele
Dispositivo intraósseo fornecido pela instituição
Uso infantil: seringa 5 ml; Uso adulto: seringa: 20 ml;
Soro Fisiológico 0,9% 10 ml (2 ampolas);
Caixa para descarte de perfurocortante
Polifix 02 vias;
Soro para administração;
Gaze e álcool 70%;
Esparadrapo ou micropore

Procedimento

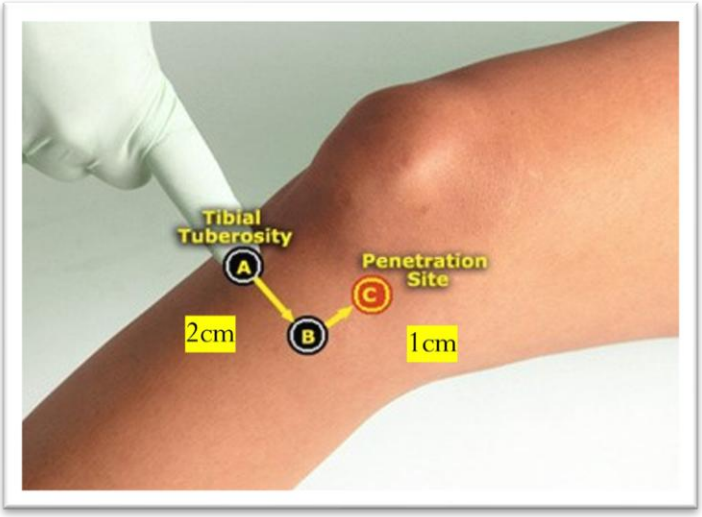
4.2. Em uso dos EPIs, explique o procedimento à vítima/ acompanhante;

4.3. Posicione a vítima em decúbito dorsal;

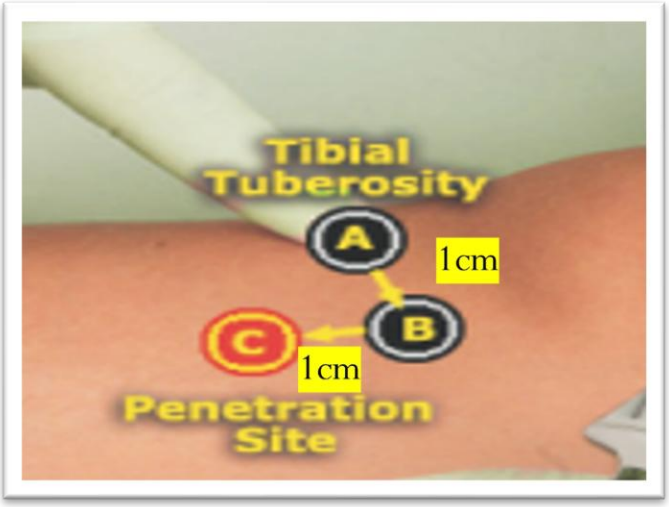
4.4. Escolha o sítio de inserção da agulha intraóssea:

Tíbia Proximal

4.5. Adulto: localize a tuberosidade tibial (abaixo da patela), deslize 2 cm para região medial e 1 cm para cima (proximal).



4.6. Criança: localize a tuberosidade tibial, deslize 1 cm para região medial e 1 cm para baixo (distal), evitando a placa de crescimento.



Tíbia Distal

4.7. Adultos e crianças maiores de 1 ano: palpe o ponto mais proeminente do maléolo medial, bem como as bordas anterior e posterior da tíbia; deslize 2 a 3 cm acima (no sentido proximal) ao centro da superfície plana do osso.

Úmero

4.8. Adulto: com o cotovelo dobrado e a mão da vítima sobre o abdômen, palpe o colo cirúrgico do úmero para localizar a tuberosidade maior. O local de inserção é aproximadamente 1 cm acima do colo e 2-3 cm lateral ao tendão do bíceps.

Referência

4.9. Coloque a palma de uma das mãos na frente do ombro da vítima, e a outra contra lateralmente sobre axila.

4.10. Posicione os polegares juntos sobre o braço, identificando a linha vertical de inserção no úmero proximal.

4.11. Palpe profundamente o úmero até localizar a tuberosidade maior; o local de inserção é cerca de 1cm acima do colo e 2-3 cm lateral do tendão do bíceps.

<u>Inserção:</u>

4.12. Remova o dispositivo de sua embalagem;

4.13. Escolha o tamanho da agulha (15mm, 25mm ou 45mm) de acordo com o local de inserção, a idade e a fisiologia do paciente;

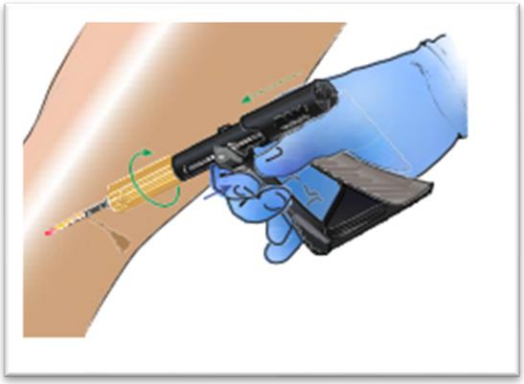
4.14. Prepare o conjunto de infusão;

4.15. Acople a agulha no driver;

4.16. Remova a tampa de segurança da agulha;

4.17. Realize a antissepsia da pele no local da punção;

4.18. Introduza a agulha no local escolhido para a punção e faça uma leve pressão para que a mesma penetre na pele;

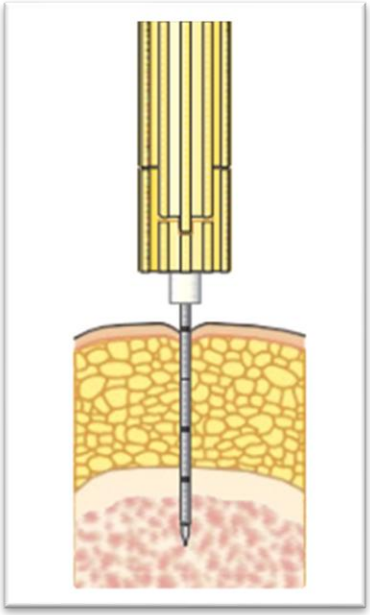


4.19. Continue introduzindo até que sinta a ponta da agulha tocar a superfície óssea;

4.20. Aperte o gatilho, fazendo uma pequena pressão constante para baixo;

4.21. Acione o gatilho de forma contínua até que a agulha atinja o periósteo (será "sentida" uma leve resistência);

4.22. Deixe um espaço entre a pele e o bisel da agulha, para fixação do estabilizador;



4.23. Apoie a mão na base colorida da agulha e retire o "driver";

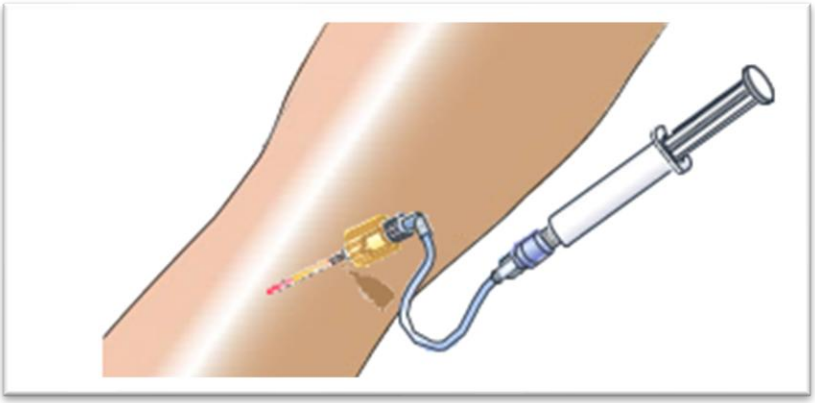
4.24. Conecte a agulha no dispositivo desconectador para descarte;

4.25. A agulha é de uso único;

4.26. Acople o conjunto de extensão (polifix) e use a seringa para confirmar a localização da punção;

4.27. Aspire a seringa para verificar se há retorno de sangue/medula;

4.28. Lave o acesso com 20 ml de solução fisiológica, verificando infiltração.



4.29. Realize o curativo de fixação do dispositivo sobre a base estabilizadora;

4.30. Atenção – Contraindicações para punção

4.30.1. Osso fraturado;

4.30.2. Osteomielite;

4.30.3. Osteoporose;

4.30.4. Cirurgia ortopédica anterior no membro;

4.30.5. Tentativa de punção intraóssea anterior;

4.30.6. Celulite local;

4.30.7. Síndrome compartimental

4.30.8. Tecido excessivo local ou ausência de marcos anatômicos.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Para higienização do dispositivo após o uso, friccione o Driver com toalha descartável umedecida em álcool 70%.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. Lane, JC; Guimaraes, HP. Acesso venoso pela via intraóssea em urgências médicas. Rev. Bras. Terapia Intensa, 2008; 20 (1): 63-7.

9.2. Sam-IO® . Manual do fabricante. SAM Medical, EUA.

9.3. PHTLS. Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado. National Association of Emergency Medical Technician, 2021. 9ª edição. 762 páginas.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
02	02/02/2026	Atualização 1. Padronização das indicações para acesso intraósseo, após tentativas frustradas de acesso venoso periférico. 2. Organização e simplificação da lista de materiais necessários. 3. Detalhamento e padronização dos sítios de punção (tíbia proximal, tíbia distal e úmero). 4. Atualização da técnica de inserção, com definição do uso de agulhas conforme idade e biotipo. 5. Reforço da checagem de posicionamento e permeabilidade do acesso. 6. Ampliação e clareza das contraindicações. 7. Inclusão de orientações de segurança, descarte e higienização do dispositivo.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia O. Lopes Daniela G. Moreira	Elaine C S M. Machado Lia Midori Straceri	Bárbara de Souza Mateus D. Miachon	Nádia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Unidade Rápida de Atendimento por Motociclista - URAM: equipe formada por duas motolâncias, cada uma conduzida por um profissional de enfermagem, auxiliar/técnico de enfermagem ou enfermeiro, com treinamento específico para a função.

2. OBJETIVOS

2.1. Descrever as atribuições e responsabilidades complementares do condutor da URAM do SAMU 192 São Paulo.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. URAM e Central de Regulação.

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADE

4.1. Ao chegar no plantão informe à Central de Regulação via rádio a base, nome, RF, matrícula, e número da URAM que irá tripular;

4.2. Realize o checklist seguindo POP Intervenções em Atendimento Pré-Hospitalar 020 – Checklist;

4.3. Atente-se para a integridade dos equipamentos individuais do profissional da URAM:

4.3.1. Capacete e viseira fechados;

4.3.2. Colete confeccionado em laranja e com fitas reflexivas (ou outro uniforme fornecido pelo SAMU 192 São Paulo);

4.3.3. Destrave o mecanismo de segurança do *airbag* da jaqueta;

4.3.4. Mantenha as antenas de proteção dianteiras sempre elevadas e cruzadas;

4.4. Em caso de chamado com prioridade imediata, realize o checklist rápido (TOP 5) das motos 1 e 2, priorizando os itens críticos.

TOP 5 URAM:

TOP FIVE – SBV – MOTO 2		
Assistência ventilatória, circulatória, abordagem do trauma, segurança da viatura	1	Desfibrilador/DEA e eletrodo adesivo/pás;
	2	Máscara de O2, ambú e cilindro de oxigênio;
	3	Luvas, gazes e ataduras;
	4	Colar cervical;
	5	Moto: Pneu (cheio), combustível (1/4 do tanque) e Luzes (Sirene e Giroflex)

4.5. Após a finalização da ocorrência, retome e conclua o checklist completo, garantindo que todos os sistemas e equipamentos estejam em condições adequadas de uso.

4.6. Realize a checagem dos itens **PCLOC** e inspecione:

4.7. **P**NEUS

4.7.1. Índice de desgaste de pneus-TWI;

4.7.2. Pressão;

4.7.3. Presença de amassados nas rodas;

4.7.4. Tensão dos raios e folgas de rolamentos e parafusos;

4.7.5. Desgaste de pastilha de freios.

4.8. **C**ABOS

4.8.1. Embreagem: presença de folga mínima exigida conforme manual do fabricante e regular de acordo com a sua utilização. Lubrifique S/N.

4.8.2. Freios: teste funcional de freios dianteiros e traseiros.

4.8.3. Acelerador: aceleração, folga do cabo, suavidade na posição neutra do guidão e batente à direita e à esquerda.

4.9. **L**UZES E SISTEMA ELÉTRICO

4.9.1. Luzes de freio manual e pedal, piscas dianteiros e traseiros, farol alto e baixo, sinalizadores ópticos, sinais sonoros em todas as fases;

4.10. Inicie partida e verificar auto teste no painel.

4.11. **Ó**LEOS E FLUÍDOS

4.11.1. Óleo do motor (antes de conduzir a motocicleta): conforme manual do fabricante.

4.11.2. Fluídos de freios: Nível do reservatório.

4.11.3. Combustível: Nível no marcador do painel e no tanque.

4.12. **C**ORRENTE E TRANSMISSÃO

4.12.1. Folga da corrente conforme manual do fabricante;

4.12.2. Limpeza e lubrificação, sempre que necessário, conforme manual do fabricante.

4.13. Observe durante o trajeto alterações como ruídos, peças soltas, entre outros;

4.14. Comunique ao CORE a necessidade de avalição mecânica ou qualquer reparo/manutenção e após relate a coordenação de frota;

4.15. Tenha junto a você o rádio móvel (HT) e o celular ligados durante o trajeto;

4.16. Utilize o HT e o celular somente em segurança;

4.17. Utilize o farol baixo durante todo o trajeto (dia e noite);

4.18. Utilize a sinalização sonora, iluminação de emergência (giroflex) quando em ocorrência;

4.19. Utilize a iluminação de emergência (giroflex) em qualquer trajeto;

4.20. Respeite a legislação vigente do CTB e CONTRAN;

4.21. Siga as regras gerais de condução/estacionamento de veículo de urgência e emergência;

4.22. O acionamento das equipes de URAM será realizado pelo MR nas ocorrências em que este julgar necessário o atendimento inicial em melhor tempo resposta, e pelo RO em casos de parada cardiorrespiratória (POP Central de Regulação e Intervenção 5-008 MR-Acionamento, despacho e liberação das URAMs);

4.23. Informe ao CORE qualquer situação que inviabilize o uso das URAM;

4.24. Abra a OSE e preencha com todas as informações das ocorrências, contemplando todos os deslocamentos da URAM durante o plantão.

4.24.1. Para o preenchimento de OSE consulte POP Central de Regulação e Intervenção 7-005 Frota- Preenchimento da ordem de serviço externo;

4.25. Mantenha-se em prontidão para o recebimento de ocorrências.

4.26. Durante uma ocorrência realize a passagem de caso ao MR, sempre informando sobre a necessidade de encaminhamento ou não de uma Ambulância para remoção da vítima;

4.27. Em atendimentos da URAM com procedimentos de suporte avançado (como por exemplo introdução de máscara laríngea), será acionado SAV ou SBV-e para apoio e transporte. No entanto, na impossibilidade do SAV ou SBV-e será acionado SBV ou OD. Neste caso, o enfermeiro da URAM deverá tripular a AM até a unidade hospitalar.

4.27.1. Se for necessário ao profissional da URAM acompanhar a vítima até a unidade hospitalar, o colega de dupla deve aguardar no local da cena para preservar as motos até o retorno do outro componente, se a cena estiver segura;

4.27.2. Neste caso a equipe SBV ou OD retorna ao local da cena após a passagem do caso, para que o enfermeiro da URAM conduza sua moto;

4.27.3. Se a cena estiver insegura, comunique a Central de Regulação e ambos devem acompanhar a ambulância, parando sempre que necessário para prestar os atendimentos.

4.28. Realize a atualização de status e encerramento da ocorrência sempre em tempo oportuno.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Não há.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. POP Central de Regulação e Intervenção 7-005 Frota- Preenchimento da ordem de serviço externo;

6.2. POP Central de Regulação e Intervenção 5-008 MR- Acionamento, despacho e liberação das URAMs;

6.3. POP Intervenções em Atendimento Pré-Hospitalar 020 – Checklist.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 2048, de 5 de novembro de 2002. Aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. Diário Oficial da União, Brasília, 12 nov. 2002. Seção 1, p. 32-54.

9.2. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa Mínimo para Implantação das Motolâncias na Rede SAMU 192. Brasília, DF: Coordenação-Geral de Urgência e Emergência,

9.3. BRASIL. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Código de Trânsito Brasileiro. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 set. 1997. Art. 29, inciso VII. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm. Acesso em: 20 ago. 2025.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
02	02/02/2026	Atualização 1. Inclusão de definições e melhor organização das responsabilidades do condutor da URAM. 2. Padronização do checklist operacional, com inclusão do checklist rápido (TOP 5). 3. Detalhamento das rotinas de início de plantão, deslocamento e pós-ocorrência. 4. Ajuste dos fluxos de comunicação com a Central de Regulação, CORE e frota. 5. Alinhamento das condutas com os protocolos operacionais vigentes e integração com outras equipes.

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Cassia O. Lopes Daniela G. Moreira	Bruno Luiz da Silva Leonardo Santos da Silva Sérgio José da Silva Sidnei Couto Silva Simone Cedano Ramos	Amanda de Ornelas Bárbara de Souza Mateus D. Miachon	Nádia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÃO

1.1. Limpeza Terminal: Processo de limpeza e desinfecção completa da motolância, incluindo o interior do baú e todos os compartimentos, realizado de forma periódica e programada, visando à manutenção das condições higiênico-sanitárias adequadas e à prevenção da disseminação de microrganismos.

2. OBJETIVO

2.1. Padronizar o procedimento de limpeza terminal das motolâncias, assegurando a higienização e desinfecção adequadas dos veículos, de modo a garantir condições seguras de trabalho, prevenir contaminações e manter a integridade dos materiais e equipamentos.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. Equipe das URAMs e Central de regulação

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. A frequência de limpeza terminal deve ser a cada 15 dias e sempre que houver contaminação visível;

4.2. As escalas fixas da limpeza terminal devem ser enviadas por e-mail para a Central de Regulação, com até 02 dias de antecedência;

4.3. O coordenador das URAMs é responsável pela elaboração da escala de rotina, de acordo com as particularidades da região e das equipes. No entanto esta deve ser realizada no início do plantão, após o QAP;

4.4. Realize limpeza terminal das motolâncias respeitando dia e turno conforme programado em escala (Anexo1);

4.5. Solicite ao CORE autorização para iniciar a limpeza terminal. Com a permissão concedida, as motolâncias serão colocadas no sistema temporariamente como indisponível pelo período de até 01 (uma) hora;

4.6. Reúna os materiais e produtos necessários para executar a limpeza:

4.6.1. Água e sabão neutro

4.6.2. Pano de limpeza descartável;

4.6.3. Borrifador com desinfetantes para superfícies de uso hospitalar;

4.6.4. Luva de látex ou borracha;

4.7. Esvazie o baú e retire os suportes móveis da motolância

4.8. Posicione a motolância em local adequado, de preferência, de fácil escoamento de água;

4.9. Inicie a lavagem aplicando água com sabão neutro;

4.10. Realizar a limpeza com movimentos firmes em toda a extensão da moto com pano de limpeza iniciando pela parte superior até a inferior, sempre umedecendo na solução de água e sabão neutro;

4.11. Aplicar água limpa de forma a enxaguar e retirar todo o sabão;

4.12. Seque todas as regiões da moto;

4.13. No interior do baú, borrife o desinfetante de superfície disponível no pano absorvente seguindo a técnica de direção única;

4.14. Deixe agir o desinfetante de acordo com a especificação do fabricante;

4.15. Assinar e carimbar o impresso "Controle de Limpeza Terminal" (Anexo 2);

4.16. Informar a Central de Regulação o término da limpeza terminal.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. A lavagem da motolância deverá ser feita nos locais pré-definidos de cada região a cada 15 (quinze) dias ou sempre que necessário;

5.2. A não realização da limpeza conforme escala de rotina deve ser e registrada em impresso fixo na base e comunicada ao supervisor de base, para que seja programada a limpeza o quanto antes;

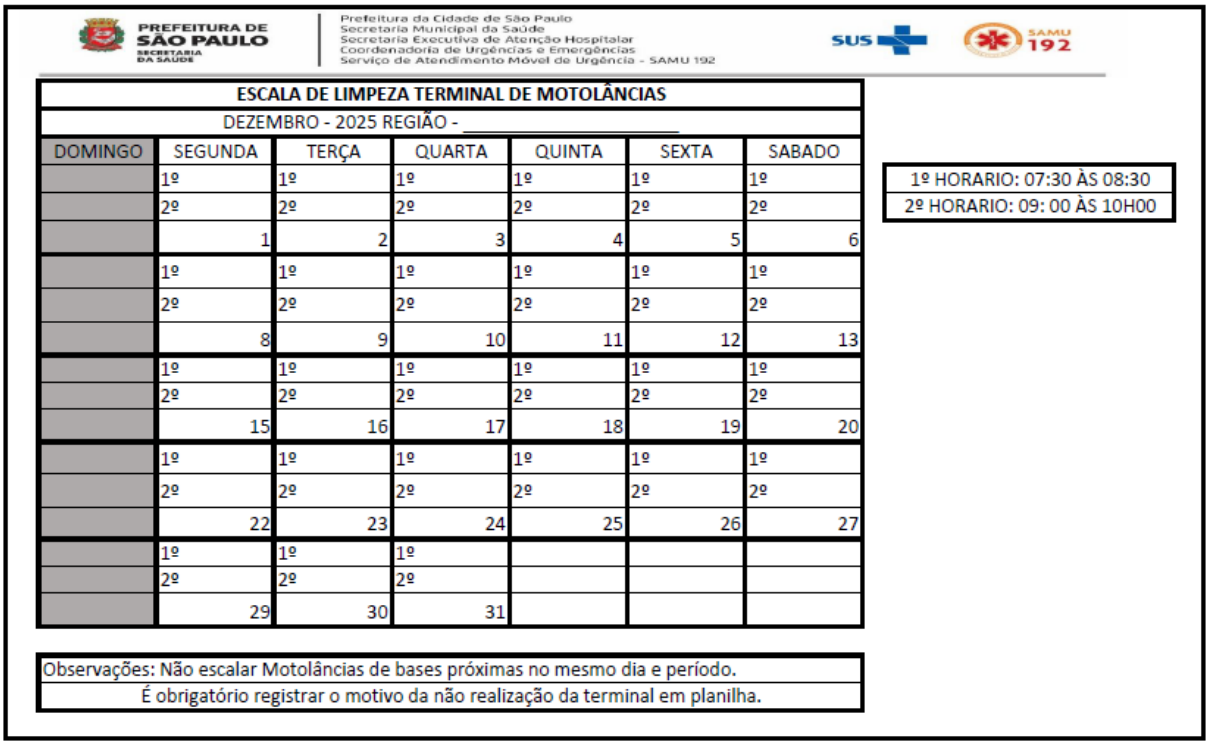
5.3. Caso tenha alguma ocorrência prioritária no momento que a equipe solicitar a realização da limpeza terminal, os mesmos devem dirigir-se para o atendimento e realizar a limpeza posteriormente;

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Exemplo de Escala de Limpeza Terminal URAM



PREFEITURA DE SÃO PAULO SECRETARIA DA SAÚDE

Prefeitura da Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Secretaria Executiva de Atenção Hospitalar
Coordenadoria de Urgências e Emergências
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192

SUS

SAMU 192

ESCALA DE LIMPEZA TERMINAL DE MOTOLÂNCIAS

DEZEMBRO - 2025 REGIÃO - _____

DOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO
	1º	1º	1º	1º	1º	1º
	2º	2º	2º	2º	2º	2º
	1	2	3	4	5	6
	1º	1º	1º	1º	1º	1º
	2º	2º	2º	2º	2º	2º
	8	9	10	11	12	13
	1º	1º	1º	1º	1º	1º
	2º	2º	2º	2º	2º	2º
	15	16	17	18	19	20
	1º	1º	1º	1º	1º	1º
	2º	2º	2º	2º	2º	2º
	22	23	24	25	26	27
	1º	1º	1º			
	2º	2º	2º			
	29	30	31			

1º HORARIO: 07:30 ÀS 08:30
2º HORARIO: 09: 00 ÀS 10H00

Observações: Não escalar Motolâncias de bases próximas no mesmo dia e período.
É obrigatório registrar o motivo da não realização da terminal em planilha.

7.2. Modelo de Controle de Limpeza Terminal – URAM

BASE

CONTROLE DAS LIMPEZAS TERMINAIS DAS UNIDADE RAPÁDIA POR MOTOCICLISTA-URAM

DATA	MOTOLÂNCIA	FOI REALIZADA	MOTIVO DA NÃO REALIZAÇÃO	REMANEJAMENTO	OBSERVAÇÕES	EQUIPE
		( ) SIM ( ) NÃO	( ) EM GAP NO MOMENTO ( ) FALTA DE MATERIAL Qual?_____ ( ) SEM EQUIPE ( ) NÃO AUTORIZADO PELO CORE ( ) OUTROS_____	( ) REMANEJADA TERMINAL PARA O DIA ___/___/____		
		( ) SIM ( ) NÃO	( ) EM GAP NO MOMENTO ( ) FALTA DE MATERIAL Qual?_____ ( ) SEM EQUIPE ( ) NÃO AUTORIZADO PELO CORE ( ) OUTROS_____	( ) REMANEJADA TERMINAL PARA O DIA ___/___/____		
		( ) SIM ( ) NÃO	( ) EM GAP NO MOMENTO ( ) FALTA DE MATERIAL Qual?_____ ( ) SEM EQUIPE ( ) NÃO AUTORIZADO PELO CORE ( ) OUTROS_____	( ) REMANEJADA TERMINAL PARA O DIA ___/___/____		
		( ) SIM ( ) NÃO	( ) EM GAP NO MOMENTO ( ) FALTA DE MATERIAL Qual?_____ ( ) SEM EQUIPE ( ) NÃO AUTORIZADO PELO CORE ( ) OUTROS_____	( ) REMANEJADA TERMINAL PARA O DIA ___/___/____		
		( ) SIM ( ) NÃO	( ) EM GAP NO MOMENTO ( ) FALTA DE MATERIAL Qual?_____ ( ) SEM EQUIPE ( ) NÃO AUTORIZADO PELO CORE ( ) OUTROS_____	( ) REMANEJADA TERMINAL PARA O DIA ___/___/____		
		( ) SIM ( ) NÃO	( ) EM GAP NO MOMENTO ( ) FALTA DE MATERIAL Qual?_____ ( ) SEM EQUIPE ( ) NÃO AUTORIZADO PELO CORE ( ) OUTROS_____	( ) REMANEJADA TERMINAL PARA O DIA ___/___/____		
		( ) SIM ( ) NÃO	( ) EM GAP NO MOMENTO ( ) FALTA DE MATERIAL Qual?_____ ( ) SEM EQUIPE ( ) NÃO AUTORIZADO PELO CORE ( ) OUTROS_____	( ) REMANEJADA TERMINAL PARA O DIA ___/___/____		
		( ) SIM ( ) NÃO	( ) EM GAP NO MOMENTO ( ) FALTA DE MATERIAL Qual?_____ ( ) SEM EQUIPE ( ) NÃO AUTORIZADO PELO CORE ( ) OUTROS_____	( ) REMANEJADA TERMINAL PARA O DIA ___/___/____		
		( ) SIM ( ) NÃO	( ) EM GAP NO MOMENTO ( ) FALTA DE MATERIAL Qual?_____ ( ) SEM EQUIPE ( ) NÃO AUTORIZADO PELO CORE ( ) OUTROS_____	( ) REMANEJADA TERMINAL PARA O DIA ___/___/____		
		( ) SIM ( ) NÃO	( ) EM GAP NO MOMENTO ( ) FALTA DE MATERIAL Qual?_____ ( ) SEM EQUIPE ( ) NÃO AUTORIZADO PELO CORE ( ) OUTROS_____	( ) REMANEJADA TERMINAL PARA O DIA ___/___/____		
		( ) SIM ( ) NÃO	( ) EM GAP NO MOMENTO ( ) FALTA DE MATERIAL Qual?_____ ( ) SEM EQUIPE ( ) NÃO AUTORIZADO PELO CORE ( ) OUTROS_____	( ) REMANEJADA TERMINAL PARA O DIA ___/___/____		
		( ) SIM ( ) NÃO	( ) EM GAP NO MOMENTO ( ) FALTA DE MATERIAL Qual?_____ ( ) SEM EQUIPE ( ) NÃO AUTORIZADO PELO CORE ( ) OUTROS_____	( ) REMANEJADA TERMINAL PARA O DIA ___/___/____		
SUPERVISOR/ INTERLOCUTOR (CARIMBO)		**RF/MATRÍCULA:** **DATA:** ___/___/___				

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies/Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília: Anvisa, 2010. 116 p.

9.2. Protocolos de atendimento pré-hospitalar: suporte avançado à vida. / Claus Robert Zeefried. -- São Paulo, Secretaria Municipal da Saúde, 2012. 110 p.

9.3. Protocolo de Atendimento Pré-Hospitalar: Suporte Básico de Vida. São Paulo: Secretaria Municipal de Saúde – SAMU-192, 2022. 322 p.

9.4. Protocolo de Atendimento Pré-Hospitalar: Práticas Avançadas do Enfermeiro. Suporte Intermediário de Vida. São Paulo: Secretaria Municipal de Saúde - SAMU, 2022. 376 p.

9.5. BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo de Suporte Básico de Vida. Brasília: Ministério da Saúde, [s.d.]. Disponível em: *https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_suporte_basico_vida.pdf*. Acesso em: 28 ago. 2025.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
01	02/02/2026	Elaboração

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Sérgio José da Silva	Simone Cedano Ramos	Amanda de Ornelas Bárbara de Souza Mateus D. Miachon	Nádia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. Segurança: condição alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades;

1.2. *Airbag:* dispositivo de segurança, que infla rapidamente durante uma colisão para proteger os ocupantes, amortecendo o impacto e reduzindo o risco de ferimentos graves;

1.3. Retentor de CO_2: É um dispositivo que armazena o gás comprimido necessário para inflar o airbag;

1.4. Cabo espiral: componente do sistema que envolve o acionamento do airbag.

2. OBJETIVO

2.1. Descrever as regras voltadas à prevenção e à proteção do trabalhador da Unidade de Rápida de Atendimento por Motociclista (URAM), bem como da vítima, minimizando riscos inerentes ao atendimento no Atendimento Pré-Hospitalar (APH), com foco na correta utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

3.1. Unidade de Rápida de Atendimento por Motocicleta (URAM) e Frota

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Ao condutor da URAM compete adicionalmente a NR 005 (Regras Gerais de Biossegurança SAMU 192 São Paulo):

Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios para Motolância:

4.2. O condutor da URAM deve utilizar os EPIs padronizados e fornecidos pelo SAMU 192 São Paulo:

- 4.2.1. Capacete
- 4.2.2. Jaqueta com protetores de coluna, ombro e cotovelo e sistema de *airbag* integrado
- 4.2.3. Camiseta de manga longa com proteção UV e conforto térmico
- 4.2.4. Macacão padrão com joelheira
- 4.2.5. Luvas com proteção de borracha
- 4.2.6. Botas apropriadas para condução e proteção

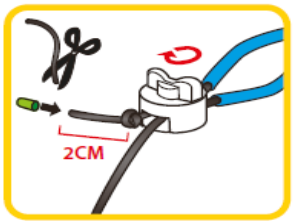
<u>Regras de Uso do Sistema de *Airbag*</u>

4.3. Verifique o equipamento de segurança (airbag) antes do uso;

4.4. O retentor de CO2 deve estar sempre para cima (destravado) quando o airbag estiver em uso. Se o retentor estiver travado, o equipamento estará inoperante.

4.5. Ao subir na motocicleta, assegure-se de que o cabo espiral esteja devidamente conectado ao gatilho de acionamento da jaqueta.

4.6. Para determinar o comprimento do cabo espiral, fique de pé esticando totalmente o cabo espiral



4.7. Fixe o cabo firmemente com a presilha e efetue um nó. Deixe uma sobra de 2 cm, corte a parte final e coloque a tampa de proteção do cabo.

4.8. A fixação do cabo espiral deve sempre estar fixo no quadro da moto conforme solicitação do fabricante

4.9. Ao descer da motocicleta, desconecte o cabo espiral do sistema de acionamento e fixe-o no banco ou outra parte segura, evitando o contato com partes aquecidas da moto.

4.10. O gatilho será acionado automaticamente quando houver tração suficiente no cabo espiral, perfurando o cilindro de CO_2 e inflando as bolsas de airbag.

ÁREAS DE PROTEÇÃO

4.11. Após a ativação, as bolsas de airbag desinflam lentamente pela válvula de segurança. As trocas dos cilindros devem ser realizadas se houver sinais de corrosão ou em caso de acionamento;

4.12. Não manusear as partes internas do Sistema de Amortecimento de Impactos. Isso compromete a integridade do sistema.

4.13. Sempre utilize cilindros de CO_2 fornecidos pelo fabricante, observando o tamanho e conteúdo corretos.

4.14. Realize a troca dos cilindros utilizados pelos cheios nos polos de cada região.

Regras Específicas do Capacete:

4.15. Verifique as viseiras (escudo e catraca).

4.16. As viseiras devem estar sempre limpas para garantir visibilidade.

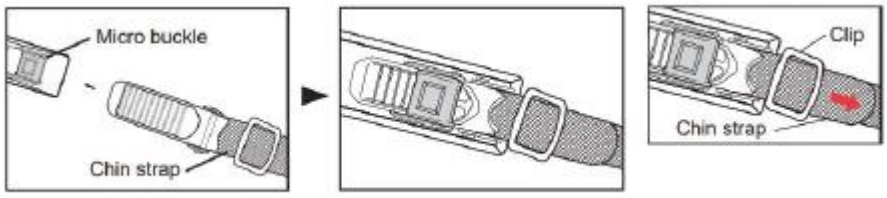
4.17. Inspecione o capacete para danos visíveis e desgaste. Comunique a chefia se houver danos;

4.18. Confira o sistema de retenção (tira de queixo) quanto a possíveis danos.

4.19. Certifique-se de que todas as almofadas internas estejam corretamente posicionadas.

4.20. Ajuste a cinta de queixo firmemente sob a mandíbula, sem desconforto.

4.21. Segure o clipe e ajuste conforme indicado para garantir fixação segura.



4.22. Não ajuste acessórios do capacete durante a condução.

4.23. Nunca coloque objetos entre a cabeça e o capacete, exceto o intercomunicador, se houver.

4.24. Mantenha a viseira travada durante a pilotagem.

4.25. Fique atento aos sons do ambiente, pois o capacete pode atenuar sons;

4.26. Mantenha a proteção de queixo sempre fechada durante a condução.

4.27. Capacetes articulados devem ser utilizados com a viseira e tira de queixo abaixadas e travadas durante a condução.

5. OBSERVAÇÕES / RECOMENDAÇÕES

5.1. É proibido utilizar EPIs não padronizados pelo SAMU 192 São Paulo.

5.2. É vedada a customização dos equipamentos ou da logomarca do SAMU 192 São Paulo.

5.3. É proibido o uso de cintas para fixação de rádio que não sejam padronizadas, pois podem interferir no funcionamento do sistema de airbag.

5.4. Os EPIs devem ser utilizados exclusivamente durante o exercício das atividades profissionais.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Biossegurança: conceitos e definições**. Disponível em: *http://antigo.anvisa.gov.br/*. Acesso em: 12 dez. 2021.

9.2. ELTO INDUSTRIAL CONFECÇÃO LTDA. **Manual Inflajack: instruções de uso e manutenção**. Cotia. 1. ed.

9.3. BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo de suporte básico de vida**. Disponível em: *https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_suporte_basico_vida.pdf*

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
09	02/02/2026	Atualização 1. Atualização do título, ampliando o escopo de biossegurança para segurança operacional e uso de EPIs. 2. Ampliação do conteúdo conceitual, com inclusão de definições técnicas relacionadas à segurança, sistema de airbag, retentor de CO_2 e cabo espiral, inexistentes na versão anterior. 3. Adequação do objetivo, reforçando a prevenção de riscos ocupacionais no APH com ênfase no uso correto dos EPIs. 4. Padronização e detalhamento dos EPIs obrigatórios para motolância, com especificação técnica de cada item. 5. Inclusão de regras específicas para uso, verificação, acionamento e manutenção do sistema de airbag. 6. Ampliação das regras de segurança para uso do capacete, com critérios de inspeção, ajuste e condução segura. 7. Inclusão de observações e recomendações, reforçando a padronização institucional, a proibição de customizações e o uso exclusivo dos EPIs em serviço

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Colaboradores da 5ºedição	Bruno Luiz da Silva Leonardo Santos da Silva Sérgio José da Silva Sidnei Couto Silva Simone Cedano Ramos	Amanda de Ornelas Bárbara de Souza Mateus D. Miachon	Nádia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

1. DEFINIÇÕES

1.1. As regras de deslocamento descritas servem de base para nortear o condutor da URAM na execução de seu deslocamento, de acordo com lei local, protocolo institucional e segurança.

2. OBJETIVOS

2.1. Descrever as regras gerais para deslocamentos da URAM SAMU 192-São Paulo.

3. EQUIPES ENVOLVIDAS

3.1. URAM

4. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADE

Aspectos fundamentais

4.1. Utilize EPI específico (protocolo específico);

4.2. Realize o deslocamento respeitando as normas descritas na NR 001, NR 003 e NR 005 desse protocolo.

Condução defensiva

4.3. Considere as diretrizes da regra PIPDE:

P	**PROCURAR/PESQUISAR**
	Atentar para o que está ao redor
I	**IDENTIFICAR**
	Situações que possam gerar riscos
P	**PREVER/ PREVENIR**
	Observar mudanças de cenário
D	**DECIDIR**
	Escolher a menor situação de risco frente uma adversidade
E	**EXECUTAR**
	Manobra adequada com destreza e rapidez frente a adversidade

Durante o deslocamento até o local da ocorrência

4.4. Ao condutor da URAM compete adicionalmente ao protocolo de atribuições e responsabilidades específicas, as atividades a seguir:

4.4.1. Desloque-se em formação de "coluna por uma alternada".

4.4.2. Mantenha distância de seguimento de três segundos em velocidade de até 70km/h e de cinco segundos em velocidade acima de 70km/h.

4.5. Desloque-se sempre em dupla obrigatoriamente

Ressalvas:

4.6. A obrigatoriedade do deslocamento em dupla poderá ser excepcionalmente dispensada nas seguintes situações:

4.6.1. Quando uma das motolâncias apresentar pane mecânica ou avaria que exija remoção por guincho;

4.6.2. Quando houver solicitação do CORE para remanejamento operacional de uma das motolâncias.

Em ultrapassagens

4.7. Realize sempre pela esquerda do veículo na via;

4.8. Execute obrigatoriamente o mesmo trajeto pelas duas motolâncias ("onde passa a primeira, passa a segunda").

4.9. Não abandone a dupla de URAM

Na passagem por corredor

4.10. Sinalize antecipadamente, respeitando o tempo de 3 segundos entre as motolâncias;

4.11. Reduza a velocidade para no máximo 40 km/h.

Na passagem por via coletora

4.12. Utilize a técnica de passagem tática com fechamento faixa a faixa, com um motociclista à esquerda e outro à direita, respeitando a distância lateral entre guias.

4.13. Evite o ponto cego dos veículos, mantenha-se visível para os demais condutores.

Deslocamento na chuva

4.14. Em dias de chuva, não é expressamente proibida a atuação da URAM, mas a segurança dos profissionais deve ser soberana, podendo a equipe ser baixada. A decisão de baixar ou não o recurso nesta situação será da equipe de URAM;

4.14.1. Caso a dupla avalie que a intensidade da chuva excede a possibilidade segura de atuação, o líder da equipe deverá comunicar ao CORE de sua região a ocorrência de chuva intensa e a necessidade de baixa da viatura.

4.15. A baixa deverá ser realizada antes do empenho da equipe, não sendo permitido solicitar a baixa após a designação para ocorrência.

4.15.1. Ao decidir baixar pela condição climáticas, a dupla poderá ser remanejada para outro recurso condizente com sua função. Esse remanejamento poderá perdurar até o término do plantão, não sendo, necessariamente, revertido em caso de melhora ou cessação da chuva.

4.16. Caso a equipe opte por permanecer em operação, não será permitido postergar, retardar ou procrastinar atendimentos, devendo a decisão ser mantida até que haja condição segura para a continuidade das atividades;

4.17. Em caso de início de chuva durante o atendimento, o condutor deverá reduzir a velocidade da motolância;

4.18. Deverão ser atenuados os riscos decorrentes da combinação de água e sujeira no asfalto, que torna o piso escorregadio, mantendo atenção redobrada durante o deslocamento.

4.19. Comunique ao CORE se cena insegura ou chuva forte para prosseguir e procure lugar seguro para se abrigar;

ATENÇÃO

DESLOCAMENTO COM NEBLINA E BAIXA LUMINOSIDADE

4.20. Ajuste a velocidade à condição de segurança proporcionada pela pista.

4.21. Aumente a distância entre a motolância e os veículos.

DESLOCAMENTO EM SITUAÇÕES DE BAIXA ADERÊNCIA

4.22. Utilize os cuidados descritos acima e adicionalmente:

4.23. Em aclives, desloque o corpo para frente, e declive, desloque o corpo para trás, mantendo as pernas flexionadas, os pés firmes nas pedaleiras e os joelhos pressionados contra o tanque, para manter a tração das rodas respeitando a inclinação da motocicleta. Em transposição de obstáculos, mantenha-se sempre em pé, utilizando sempre ângulo de 90°.

<u>No local da ocorrência</u>

4.24. Siga sempre as normas do protocolo;

4.25. Posicione as motolâncias de forma a facilitar o fluxo de veículos na via;

4.26. Estacione as motolâncias com distância de 1(um) metro entre elas e perpendicular ao meio-fio, mantendo alinhamento entre elas;

4.27. Em vias públicas, sem sinalização de outros veículos ou serviços:

4.27.1. Posicione a motolância de forma a garantir a adequada sinalização da cena: uma motolância antes e outra à frente do incidente com a sinalização voltada para o fluxo de veículos observando o posicionamento do farol em direção oposta ao fluxo, obedecendo ao limite de distância conforme a velocidade da via;

4.28. Em vias públicas, com sinalização de outros veículos ou serviços:

4.28.1. Posicione a motolância após o evento, desde que não haja nenhum impedimento para o deslocamento até essa posição. Se houver, posicione-se antes ou no melhor local possível e revise as sinalizações já existentes para a garantia das distâncias de segurança.

<u>Estacionamento da motolância</u>

4.29. Estacione as motocicletas com distância de 1(um) metro entre elas e perpendicular ao meio-fio, mantendo alinhamento.

<u>No retorno para base</u>

4.30. Realize o deslocamento de acordo com NR 001,004,005 e protocolos específicos de responsabilidades, competência e biossegurança

PRERROGATIVAS e PRIVILÉGIOS DAS URAMs EM <u>ATENDIMENTO DE EFETIVA PRESTAÇÃO DE URGÊNCIA</u>

4.31. Ultrapasse um semáforo vermelho, desde que garantidas todas as questões de segurança e os dispositivos regulamentares – alarmes sonoros e iluminação acionados (CTB artigo 29, VIII);

4.32. Trafegue na contramão, desde que garantidas todas as questões de segurança (CTB artigo 29, VIII);

4.33. Estacione em local proibido, desde que garantidas todas as questões de segurança (CTB artigo 29, VIII).

<u>IMPEDIMENTOS</u>

4.34. Não ultrapasse o limite de velocidade máxima estabelecida para uma via.

5. OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

5.1. Acidentes com a URAM envolvendo vítima ou não, siga protocolo institucional;

5.2. Durante o atendimento caso um dos componentes da motolância precise tripular a ambulância devido à complexidade do caso, o outro componente da moto deve-se manter no local aguardando, desde que seguro para permanência.

5.3. Não é permitido para a URAM realizar ações conhecidas como **"batedor"** ou **"escolta"**, que consistem em trafegar à frente dos demais veículos de emergência com o intuito de abrir espaço no trânsito.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Não há.

7. ANEXOS

7.1. Não há.

8. FLUXOGRAMA

8.1. Não se aplica.

9. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

9.1. BRASIL. Ministério da Saúde**.** Programa mínimo para implantação das motolâncias na rede do SAMU 192**.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022. Atualizado em: 18 jul. 2022.

9.2. BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo de Suporte Básico de Vida [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: *https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_suporte_basico_vida.pdf*.

10. CONTROLE DE REVISÕES/ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição/Motivo da Alteração
02	02/02/2026	Atualização 1. Reforço da obrigatoriedade de deslocamento em dupla, com definição clara das exceções (pane mecânica e remanejamento pelo CORE) 2. Aprimoramento das regras de deslocamento, ultrapassagens, corredor e vias coletoras 3. Inclusão específica de orientações para deslocamento em chuva 4. Aprimoramento das orientações para neblina, baixa luminosidade e baixa aderência, com ajustes de postura corporal 5. Reorganização e detalhamento do posicionamento das motolâncias no local da ocorrência 6. Manutenção e reorganização das prerrogativas legais 7. Inclusão explícita da vedação à atuação como "batedor" ou escolta 8. Inclusão de orientação operacional quando um integrante da URAM precisar tripular a ambulância

Elaboração	Revisão	Validação	Aprovação
Carlos E. de Paula Cassia O. Lopes	Bruno Luiz da Silva Leonardo Santos da Silva Sérgio José da Silva Sidnei Couto Silva Simone Cedano Ramos	Amanda de Ornelas Bárbara de Souza Mateus D. Miachon	Nadia Afif F. Wassef Admilson M. dos Santos Justino Pedro da Silva

- Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte –

JUSTIFICATIVA PARA ALTERAÇÃO E EXCLUSÃO DE PROTOCOLOS OPERACIONAIS

Durante o processo de revisão e atualização deste manual, foi realizada análise técnica, com o objetivo de garantir alinhamento às diretrizes, às boas práticas assistenciais e à segurança dos profissionais e usuários.

Em decorrência dessa avaliação, alguns protocolos foram excluídos, incorporados ou reformulados, conforme justificativas a seguir:

Dispensa de Vítima na Cena

O protocolo "Dispensa de Vítima na Cena" foi removido, pois as equipes de Suporte Básico de Vida (SBV) e Suporte Básico de Vida com Enfermeiro (SBV-E) não possuem respaldo legal para realizar, de forma autônoma, a dispensa do paciente no local da ocorrência. Essa conduta deve ser realizada com avaliação e autorização médica.

Solicitação de Apoio de Suporte Avançado de Vida

Este protocolo foi retirado, uma vez que as orientações para solicitação de apoio do Suporte Avançado de Vida (SAV) passaram a constar nos demais protocolos, de forma integrada, evitando repetição de informações.

Síndrome de Abstinência Alcoólica

As orientações para o atendimento da Síndrome de Abstinência Alcoólica foram incorporadas ao protocolo de Hipoglicemia, considerando a semelhança entre os quadros clínicos e a abordagem inicial.

Cólica Nefrética

O protocolo específico de Cólica Nefrética foi removido, pois as orientações para o manejo da dor passaram a ser contempladas no protocolo de Avaliação e Manejo da Dor.

Crise Álgica da Anemia Falciforme

Da mesma forma, o protocolo da Crise Álgica da Anemia Falciforme foi incorporado ao protocolo de Avaliação e Manejo da Dor, seguindo os mesmos critérios de padronização.

Empacotamento e Torniquete

Os protocolos de Empacotamento e Torniquete foram retirados como documentos independentes, pois suas orientações passaram a integrar o protocolo de Controle de Hemorragia Externa.

Pranchamento em Pé

O procedimento de Pranchamento em Pé foi excluído, pois atualmente não é mais recomendado pelas diretrizes técnicas, devido aos riscos envolvidos e à falta de evidências de benefício.

Incidentes com Múltiplas Vítimas

O protocolo sobre Incidentes com Múltiplas Vítimas foi retirado deste manual, uma vez que as orientações específicas para esse tipo de ocorrência serão apresentadas em manual próprio, que está em fase de revisão.

Carta de Sinais para Deslocamento da URAM

Este protocolo foi removido, pois a função de batedor não é permitida aos profissionais da URAM, conforme as normas institucionais.

Regras Gerais para Deslocamento de Motolâncias em Comboio

O protocolo foi cancelado como documento independente, pois suas orientações foram incluídas no protocolo "Regras de Deslocamento da URAM", facilitando a padronização dos procedimentos.

GLOSSÁRIO DE TERMOS INSTITUCIONAIS

ACOLHIMENTO

Postura ética e humanizada baseada na escuta qualificada, responsabilização e encaminhamento adequado às necessidades do usuário.

AGRAVO À SAÚDE

Qualquer dano ou alteração do estado de saúde que demande avaliação ou intervenção assistencial.

APOIO OPERACIONAL

Suporte logístico prestado à equipe assistencial, incluindo segurança, organização da cena e manejo de equipamentos.

APOIO TÁTICO

Suporte adicional solicitado em ocorrências de maior complexidade, risco ou necessidade de múltiplos recursos.

APH – Atendimento Pré-Hospitalar

Assistência prestada fora do ambiente hospitalar, no local da ocorrência e durante o transporte, com o objetivo de estabilização inicial e preservação da vida.

ATENDIMENTO HUMANIZADO

Prática assistencial baseada no respeito, empatia, ética e garantia de direitos do paciente.

BASE OPERACIONAL

Estrutura física destinada ao apoio das equipes, guarda de viaturas e organização logística do serviço.

BIOSSEGURANÇA

Conjunto de medidas destinadas à prevenção de riscos biológicos e proteção dos profissionais e pacientes.

CÉLULA DE ATENDIMENTO

Conjunto de profissionais que compõem a equipe de uma unidade móvel.

CENA SEGURA

Condição em que o ambiente da ocorrência foi avaliado e apresenta segurança para atuação da equipe.

CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA DAS URGÊNCIAS (CRMU)

Estrutura responsável pelo recebimento das chamadas pelo número 192, classificação da ocorrência e despacho das unidades móveis.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Processo de avaliação que determina a prioridade do atendimento com base na gravidade do quadro.

COMANDO DE CENA

Organização e coordenação das ações no local da ocorrência, especialmente em situações complexas ou com múltiplas vítimas.

CONDUTOR DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA (CVE)

Profissional habilitado para condução da viatura e apoio logístico à equipe assistencial.

DESFECHO

Resultado clínico e assistencial do atendimento prestado.

DESPACHO

Envio da unidade móvel para atendimento de ocorrência, conforme decisão da Regulação Médica.

EDUCAÇÃO PERMANENTE

Processo contínuo de capacitação e atualização profissional no ambiente de trabalho.

EQUIPE ASSISTENCIAL

Profissionais responsáveis pela assistência direta ao paciente.

EQUIPE DE APH

Conjunto de profissionais que compõem a unidade móvel de atendimento pré-hospitalar.

ESTABILIZAÇÃO

Intervenções realizadas com o objetivo de manter ou restabelecer funções vitais.

FLUXO ASSISTENCIAL

Sequência organizada de ações e encaminhamentos no atendimento ao paciente.

HUMANIZAÇÃO

Princípio que orienta a prática assistencial com foco na dignidade e respeito ao usuário.

INCIDENTE COM MÚLTIPLAS VÍTIMAS (IMV)

Ocorrência que envolve número de vítimas superior à capacidade inicial de resposta da equipe presente.

INDICADORES DE DESEMPENHO

Parâmetros utilizados para monitorar qualidade, eficiência e efetividade do serviço.

INTERCORRÊNCIA

Evento inesperado que altera o curso previsto do atendimento.

MÉDICO REGULADOR

Profissional responsável pela classificação, orientação e definição do recurso mais adequado para cada ocorrência.

NEPP – Núcleo de Educação Permanente e Pesquisa

Setor responsável pela capacitação e atualização técnica dos profissionais.

NÚCLEO DE QUALIDADE

Setor responsável pela padronização de processos e melhoria contínua do serviço.

OCORRÊNCIA

Evento que demanda acionamento do serviço de urgência.

OCORRÊNCIA PRIMÁRIA

Atendimento realizado diretamente no local do evento.

OCORRÊNCIA SECUNDÁRIA (TRANSFERÊNCIA INTER-HOSPITALAR)

Remoção regulada entre unidades de saúde.

PADRONIZAÇÃO

Estabelecimento de condutas uniformes para garantir segurança e qualidade assistencial.

PROTOCOLO INSTITUCIONAL

Documento que define diretrizes e condutas para atuação das equipes.

RAU – Rede de Atenção às Urgências

Conjunto de serviços articulados para atendimento integral às urgências.

REGULAÇÃO MÉDICA

Processo técnico de classificação e direcionamento das ocorrências.

RESOLUTIVIDADE

Capacidade do serviço de atender e solucionar as demandas apresentadas.

SAV – Suporte Avançado de Vida

Modalidade composta por condutor, enfermeiro e médico.

SBV – Suporte Básico de Vida

Modalidade de atendimento composta por condutor e profissional de enfermagem.

SBV-E – Suporte Básico de Vida com Enfermeiro

Modalidade composta por condutor e enfermeiro, com maior autonomia técnica.

SEGURANÇA DO PACIENTE

Ações voltadas à redução de riscos e danos evitáveis.

TEMPO CENA

Intervalo entre chegada ao local e saída para transporte.

TEMPO RESPOSTA

Intervalo entre acionamento e chegada ao local.

TRANSFERÊNCIA INTER-HOSPITALAR

Remoção de paciente entre unidades para continuidade assistencial.

UNIDADE DE REFERÊNCIA

Estabelecimento definido para recebimento do paciente.

UNIDADE MÓVEL

Viatura equipada para atendimento pré-hospitalar.

VIATURA

Veículo destinado ao atendimento de urgência e emergência.

Atualização realizada em 10 de março de 2026:

Foram incluídas observações referentes à administração de medicamentos sujeitos a controle especial, conforme regulamentação da Portaria nº 344/1998, nos seguintes protocolos assistenciais:

- 039 – Crise convulsiva no adulto
- 045 – Avaliação e manejo da dor e vômitos
- 046 – Intoxicações agudas

Adicionalmente, foram incluídas orientações referentes à administração de Sulfato de Magnésio e ao uso de Gluconato de cálcio, no protocolo:

- 069 – Doença hipertensiva específica da gestação

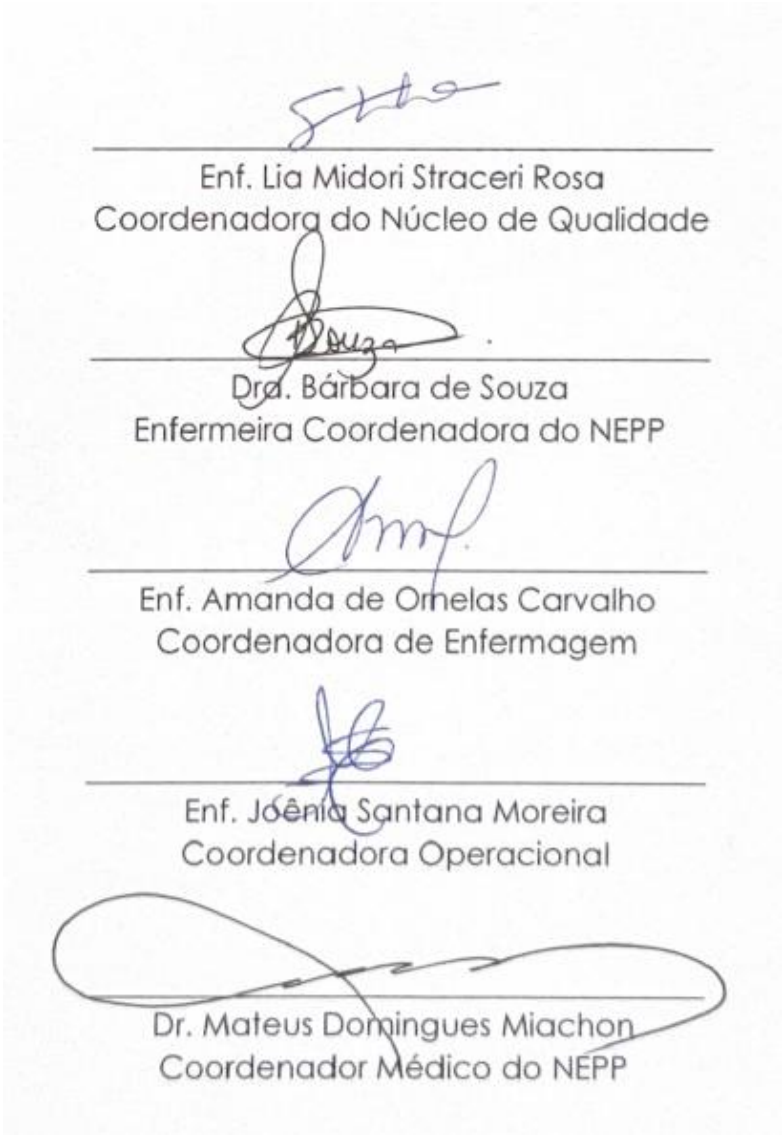
VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO

O presente Manual foi analisado, revisado e validado pelas instâncias técnicas competentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 São Paulo, sendo posteriormente aprovado pelas autoridades institucionais responsáveis.

Este documento passa a vigorar a partir da data de sua publicação oficial, constituindo referência normativa institucional obrigatória para a execução dos atendimentos, procedimentos e rotinas nele descritos.

Sua aplicação é vinculante a todos os profissionais e setores envolvidos nas atividades assistenciais e operacionais do serviço.

Após análise técnica, declaram estar de acordo com o conteúdo apresentado:



APROVAÇÃO INSTITUCIONAL

Homologam o presente Manual para aplicação no âmbito do SAMU 192 São Paulo: